СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ IV РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

«МЕДИЦИНА И ОБРАЗОВАНИЕ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ И АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»

«Опыт проведения научных исследований в рамках подготовки специалистов по лечебному делу и сестринскому делу»

«Новые подходы и инновации в обучении будущих медицинских специалистов»

«Исследование проблемных аспектов этики и деонтологии в профессиональном общении»

«Актуальные вопросы исследований в медицине»

КГП на ПХВ «Государственный высший медицинский колледж им. Д.Калматаева» УЗ ОА

Контакты:
8(7222) 56-35-00
Почта
info@gsmk.kz

УДК 61
ББК 5
М42

Редакционная коллегия:
Танатаров С.З., и.о. директора КГП на ПХВ «Государственный высший медицинский колледж им.Д.Калматаева» УЗ ОА, доктор медицинских наук, профессор
Нургалиева Г.Т., заместитель директора по учебной части КГП на ПХВ «Государственный высший медицинский колледж им.Д.Калматаева» УЗ ОА, магистр экономики и бизнеса
Ульбауова А.М., заместитель директора по учебно-производственной работе КГП на ПХВ «Государственный высший медицинский колледж им.Д.Калматаева» УЗ ОА магистр педагогических наук
Бокин Д.С., заведующий паллиативного отделения Хосписа, магистр медицинских наук
Медетова Г.Е., методист отдела научно-методической работы КГП на ПХВ «Государственный высший медицинский колледж им.Д.Калматаева» УЗ ОА, магистр педагогических наук

Медицина и образование: новые подходы и актуальные исследования: материалы Республиканской научно-практической конференции.

Семей: КГП на ПХВ «Государственной высший медицинский колледж им.Д.Калматаева» УЗ ОА 28.11.2024г.

ISBN 978-601-08-0758-7

В сборник включены доклады, представленные на Республиканской научно-практической конференции с международным участием «Медицина и образование: новые подходы и актуальные исследования» от 28 ноября 2024 года.

Материалы сборника предназначены для студентов, магистрантов, а также для специалистов, занимающихся исследовательской деятельностью по медицинским наукам.

ISBN 978-601-08-0758-7

СОДЕРЖАНИЕ

СЕКЦИЯ №1: ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЛЕЧЕБНОМУ ДЕЛУ.

Ирисметов Д.И.
БРОШЮРА ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ТЕМУ: «САХАРНЫЙ ДИАБЕТ»....3
Бектас Әсем Мақсатқызы
ДИГИТАЛЬДЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ НЕСЕПТАС АУРУЫНЫҢ ДИАГНОСТИКАСЫНДА ҚОЛДАНЫЛУЫ....8
Ғабдуллин Ақыл Жомартұлы
ЕРЛЕР БЕЛСІЗДІГІНІҢ ДАМУЫНА ӘКЕЛЕТІН ҚАУІП ФАКТОРЛАРЫНЫҢ КЕЗДЕСУ ЖИІЛІГІНЕ ШЕТЕЛДІК ЗЕРТТЕУЛЕРДЕН ТАЛДАУ....13
Вон К.С.
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ....18
Гудименко В.А.
ОЦЕНКА РОЛИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ КОЛЛЕДЖЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО....21
Юричев Тимофей Андреевич, Жунусова Мансия Маратовна
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФЕЛЬДШЕРА СКОРОЙ ПОМОЩИ С ДЕТЬМИ С РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА ИСЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА....24
Идрисов Р.М.
ДӘСТҮРЛІ ОҚЫТУ МЕН НЕЙРОЖЕЛІЛІК ӘДІСТЕРДІҢ САЛЫСТЫРМАЛЫ ТИІМДІЛІГІ: СТУДЕНТТЕРДІҢ КЛИНИКАЛЫҚ ОЙЛАУ ДАҒДЫЛАРЫ....27
Кубашова Ксения Зайдулловна, Меренков Данил Владимирович
CAR-ТЕРАПИЯ ПРИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ....32
Кусайнова М.Ж.
МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ МАҚСАТЫНДА АЙМАҚТАРДА (УЧАСТОК) ХАЛЫҚҚА СКРИНИНГ ЖҮРГІЗУДЕ МЕЙІРГЕРЛЕР ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ.... 36
Қайролдина Назым Мақсатқызы
МЕЙІРБИКЕЛІК БІЛІМ ЖӘНЕ МЕЙІРБИКЕЛІК ЗЕРТТЕУЛЕР....40
Қамешова З., Ануарбаева А.
«ЕРТЕ ЖАСТАҒЫ ЖҮКТІЛІКТІҢ АНА МЕН БАЛА ҮШІН ҚАУІПТІЛІГІ ЖӘНЕ ОНЫҢ АЛДЫН АЛУ»....45
Нуртазина Малика Дидаровна
МЕДИЦИНА ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ АРАСЫНДАҒЫ ЭТИКА ЖӘНЕ ДЕОНТОЛОГИЯ....49
Sabyrzhan K.K.
CHALLENGES IN SCIENTIFIC RESEARCH AMONG STUDENTS OF PAVLODAR MEDICAL HIGHER COLLEGE AND THEIR SOLUTIONS....54
Сансызбаева А.М.
ШЫЛЫМ ШЕГУ БҮГІНГІ ТАҢНЫҢ ӘДЕТІ МЕ ӘЛДЕ СӘНІ МЕ?....58
Коломеец С.В.
РОЛЬ ФЕЛЬДШЕРА В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ....61
Дубатовская Александра Алексеевна
ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ И ПРИКОРМ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА, КАК ПРОФИЛАКТИКА МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА....65
Тұрысбай Думан
ХИРУРГИЯЛЫҚ ДИАГНОСТИКА ЖӘНЕ ЕМДЕУДІҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘДІСТЕРІ....69
Уахитова Ә.Е.
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МӘСЕЛЕСІНДЕГІ ЗАМАНАУИ ТӘСІЛДЕР....72
Хамитова Зарина Евгеньевна, Мурадимова Мейрамгуль Владимировна
ФЕЛЬДШЕРСКАЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНА: НОВЫЙ ПОДХОД К ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ. ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ РАБОТЫ ФЕЛЬДШЕРОВ ОСОБЕННО В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННЫХ РЕСУРСОВ....77

ISBN 978-601-08-0758-7

СЕКЦИЯ №2: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В МЕДИЦИНЕ.

Азбай Данияр Сейльханұлы
ҚЫЗБАСЫ, ЭТИОЛОГИЯСЫ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯСЫ, ПАТОГЕНІ, КЛИНИКАСЫ, ДИАГНОСТИКАСЫ.....82
Бақыткерей Ақниет
МИКОЗ АУРУЫНДА САҢЫРАУҚҰЛАҚТАРМЕН ЗАҚЫМДАЛҒАН МАТЕРИАЛДАРДЫ ЗЕРТТЕУЛЕРДІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ.....87
Балгобаева В.У., Бартусевич Ю.А.
ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ КАК ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ.....92
Болатова Балым
БҮЙРЕК ТАС АУРУЛАРЫ. БҮЙРЕК ЖЕТКІЛІКСІЗДІГІ.....97
Даулетбек Ж.К.
СТУДЕНТТІК УАҚЫТТА ПСИХОДИАГНОСТИКА ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ БОЛАШАҚ МЕДИЦИНАЛЫҚ МАМАН БОЛУҒА ӘСЕРІ.....99
Штаненко Владислав
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА: ОСОБЕННОСТИ УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ В УЧЕБНУЮ И СОЦИАЛЬНУЮ СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА.....105
Есенбекова Талшын Мұқағалиқызы
НЕВРОЗ.....110
Әлімжанқызы Т.
ЖАСӨСПІРІМДЕР АРАСЫНДАҒЫ АРТЫҚ ДЕНЕ САЛМАҒЫН ЖӘНЕ СЕМІЗДІКТІҢ АЛДЫН АЛУ МӘСЕЛЕЛЕРІ.....116
Исаева Аружан
ОНКОЛОГИЯДАҒЫ ИММУНОТЕРАПИЯ.....121
Ізбасарова А.Ж, Ерланқызы Г.
СТУДЕНТТЕР МЕН ДӘРІГЕРЛЕР АРАСЫНДАҒЫ КОУЧИНГ: ТИІМДІЛІГІ МЕН НӘТИЖЕЛЕРІ.....124
Құрманбек Інжу Мамырғалиқызы
КОНГО – ҚЫРЫМ ГЕМОРРАГИЯЛЫҚ ҚЫЗБАСЫ, ДИАГНОСТИКАСЫ, ЕМІ, ПРОФИЛАКТИКАСЫ.....130
Сәрсенбаева Дильназ Болатқызы
ЖАСТАРДЫҢ КОНТАКТІЛІ ЛИНЗАЛАРДЫ КИЮ ЖӘНЕ КҮТУ ЕРЕЖЕЛЕРІН БҰЗҒАН КЕЗДЕ ТУЫНДАЙТЫН АСҚЫНУЛАРЫН ТАЛДАУ.....135
Маркелова Алина Александровна
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В МЕДИЦИНЕ.....139
Мирманова Р.
ОЦЕНКА И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫСШЕГО СЕСТРИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН.....144
Ршаева Алина Әмірханқызы
МЕДИЦИНАДАҒЫ ЗЕРТТЕУЛЕРДІҢ ӨЗЕКТІЛІГІ.....149
Сарбасова А.С., Кеңгесбай А.М.
СТУДЕНТТЕРДІҢ ЖҮРЕК - ҚАН ТАМЫРЛАРЫ АУРУЛАРЫНЫҢ ҚАУІП ФАКТОРЛАРЫН АНЫҚТАУ.....154
Серік Камила
ПНЕВМОНИЯ АУРУДЫҢ ЕМДЕУ ЖОЛДАРЫ.....156
Слямғазиева А.А.
БІЛІМ БЕРУ ҮРДІСІНДЕГІ ДУАЛЬДЫ ОҚЫТУ ЖҮЙЕСІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ.....159
Сухорукова Юлия, Шахова Екатерина
ЭКГ. ТЕХНИКА СНЯТИЯ ЭКГ. ПРОСТОЕ ПОНИМАНИЕ ЭКГ.....165
Сүйеш Жанайым
ПСИХОЭМОЦИОНАЛДЫҚ ЖАҒДАЙ ЖӘНЕ ТЕРІ АУРУЛАРЫ.....168

ISBN 978-601-08-0758-7

Tlektes Dariya, Saleem Abdulrauf
HIGH-FLOW CEREBRAL BYPASS: A REVOLUTION IN MINIMALLY INVASIVE TREATMENT OF INTRACRANIAL ANEURYSMS....171
Турсынова Аружан Жанатқызы
ҚУАТ КӨЗІ МЕ, ҚАУІП ПЕ?....175
Шаншарбек Ақерке
ӘЙЕЛ АЗАМАТТАРЫНЫҢ РЕПРОДУКТИВТІ ДЕНСАУЛЫҚ ЖАҒДАЙЫНЫҢ, ТУЫЛМАҒАН БАЛАНЫҢ ДЕНСАУЛЫҒЫНА ӘСЕРІ....180
Яритик Д.Б.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В МЕДИЦИНЕ, ОЦЕНКА НАВЫКОВ САМО-МЕНЕДЖМЕТА У ПАЦИЕНТОВ С ИНСУЛЬТОМ....184
Поликанова Елена Антоновна
ПРОЦЕСС АДАПТАЦИИ У СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖЕЙ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ....190
Мухаметжанова Гульсан Рысбековна
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У МОЛОДЕЖИ....194

СЕКЦИЯ №3: НОВЫЕ ПОДХОДЫ И ИННОВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ БУДУЩИХ МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ.

Абдрахманова Г.С.
БОЛАШАҚ МЕДИЦИНА МАМАНДАРЫН ОҚЫТУДАҒЫ ЖАҢА ТӘСІЛДЕР МЕН ИННОВАЦИЯЛАР....196
Дастан Азамат Асылханұлы
ЖАСТАР АРАСЫНДА ТҰТЫНАТЫН ЭЛЕКТРОНДЫ ТЕМЕКІНІҢ АДАМ ОРГАНИЗМІНЕ ӘСЕРІН БАҒАЛАУ ТУРАЛЫ МЕЙІРГЕРДІҢ РӨЛІ....199
Айтбаева А.О.
БОЛАШАҚ МЕДИЦИНА МАМАНДАРЫН ОҚЫТУДЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ....204
Акбергенова Жанна Калибековна , Жиеналина Бакыт Аиповна
LESSONS STUDY ӘДІСІНІҢ ЗЕРТТЕУ ӘДІСІ РЕТІНДЕ КЕМШІЛІКТЕРІ МЕН АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ АРНАЙЫ ПӘНДЕР САБАҒЫНДА....208
Андакулова Куралай Тлеулесовна, Сайлаубаева Назерке Нұрланқызы
«МЕДИЦИНАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДІ ЖАҢАРТУДАҒЫ ЖАҢА ТӘСІЛДЕР МЕН ИННОВАЦИЯЛАР»....211
Досхожаева А.К.
НОВЫЕ ПОДХОДЫ И ИННОВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ БУДУЩИХ МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ....216
Асанбаев Д.К., Кенбаева А.А.
МЕДИЦИНАДА ЖЕКЕЛЕНДІРІЛГЕН ОҚЫТУ: МАМАНДАРДЫ ДАЯРЛАУҒА АРНАЛҒАН ТӘСІЛДЕР МЕН МЫСАЛДАР....221
Ахметова А.К., Абеуова Ж.Б.
МЕДИЦИНА МАМАНДАРЫН ДАЙЫНДАУДАҒЫ ТӘСІЛДЕР МЕН ИННОВАЦИЯЛАР: МЕДИЦИНАДА КЕЙС-СТАДИ ТӘСІЛІМЕН ОҚЫТУ....226
Ахметова Арайлым Тойлыбековна
БОЛАШАҚ МЕДИЦИНА МАМАНДАРЫН ОҚЫТУДАҒЫ ЖАҢА ТӘСІЛДЕР МЕН ИННОВАЦИЯЛАР....230
Байсов Ғ.Т.
МЕЙІРГЕРЛІК ҚЫЗМЕТТЕ КӘСІБИ БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ МЕН БІЛІМ БЕРУ СТРАТЕГИЯЛАРЫ....232
Боранова Т.Т., Кунакбева Ж.Б.
ЗАМАН ТАЛАБЫНА САЙ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ ҚОЛДАНЫЛУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ....235

ISBN 978-601-08-0758-7

Ерболатова Ә.Е., Амантаева Т.Ш.
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫНЫҢ БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ОЙЛАУ ҚАБІЛЕТТЕРІН ДАМЫТУҒА ӘСЕРІ....241
Көшкінбаева Мөлдір Талғатқызы
БОЛАШАҚ МЕЙІРГЕР МАМАНДАРЫН ОҚЫТУДАҒЫ ЖАҢА ТӘСІЛДЕР МЕН ИННОВАЦИЯЛАР....246
Пиржанова Айтры Алмасовна
ЕГДЕ ЖАСТАҒЫ ПАЦИЕНТТЕРДЕГІ ОҢАЛТУ....251
Мусаева Гульмира Кудайбергеновна
НОВЫЕ ПОДХОДЫ И ИННОВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ БУДУЩИХ МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ....255
Дементиевская Н.В.
ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ СИММУЛЯЦИОННОГО ЗАНЯТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КВЕСТ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭЛЕМЕНТАМИ CASE STADY....259
Таңат Ғалия Жомартқызы, Байназарова Айзада Асылбекқызы
ЦИФРЛЫҚ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖӘНЕ ОНЫҢ ӨМІР МЕН БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНЕ ӘСЕРІ....262
Бахытжан Ұ.М.
МЕЙІРГЕРЛІК ІС ПЕН ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТТІҢ ИНТЕГРАЦИЯСЫ: МҮМКІНДІКТЕР МЕН ҚИЫНДЫҚТАР. ӘДЕБИ ШОЛУ....265
Жармахан Толқынай Талғатқызы
ОНКОЛОГИЯЛЫҚ НАУҚАСТАРҒА МЕЙІРБИКЕЛІК КҮТІМ ЖАСАУ....269
Махмут Қылышбек Жеткергенұлы
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕ МЕЙІРГЕР ІСІНІҢ РӨЛІ....275
Сейілханова Айгерім Әкімтайқызы
МЕЙІРГЕРЛЕРДЕ ЭМОЦИОНАЛДЫ КҮЙЗЕЛІС ӘСЕРІНЕН ПАЙДА БОЛҒАН СТРЕССТІ ТӨМЕНДЕТУДЕГІ ЖАТТЫҒУДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ....280
Сейтжапарова М.С.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ СИМУЛЯТОРОВ И РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЕКТА (AI) В ОБУЧЕНИИ МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ: АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ....286
Толекова Сайраш Зейнелевна
МЕДИЦИНАЛЫҚ ОҚЫТУДЫҢ ҚЫЗЫҚТЫ ӘЛЕМІ....294
Чаркова Зарина Владимировна, Цой Виталий Антонович
ОПЫТ ВВЕДЕНИЯ РАСШИРЕННОЙ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ В ПРОГРАММУ ОБУЧЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ВЫСШЕГО СЕСТРИНСКОГО КОЛЛЕДЖА....298
Шамсутдинова Э.М.
ОРГАНИЗАЦИЯСОВМЕСТНОЙНАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ПРЕПДАВАТЕЛЕЙ АКТЮБИНСКОГО ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГОСОЮЗА МАНШУК МАМЕТОВОЙ....302
Кутлиева Т.Т., Шеметова О.В.
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ СЕСТРИНСКОМУ УХОДУ В ГЕРИАТРИИ В ОМК....307
Садыгулов Е.Д.
ЖЕДЕЛ МЕДИЦИНАЛЫҚ ЖӘРДЕМ ОРТАЛЫҒЫНДАҒЫ ОРТА МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ ҚЫЗМЕТІНЕ НАУҚАСТАРДЫҢ ҚАНАҒАТТАНАРЛЫҒЫН БАҒАЛАУ....311
Конирова Салима Калабаевна, Өтесін Махмутсұлтанғали Асқаруұлы ЕГДЕ ЖАСТАҒЫ РОЛЬ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР В СОВРЕМЕННОЙ РЕАБИЛИТОЛОГИИ....314
Майжанова Галия Токтаровна
БОЛАШАҚ МЕДИЦИНА МАМАНДАРЫН ОҚЫТУДАҒЫ ЖАҢА ТӘСІЛДЕР МЕН ИННОВАЦИЯЛАР....317
Қойшыбаева С.Т., Тұрдығазина І.С.
ЭТИЧНЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ....323

ISBN 978-601-08-0758-7

Ульбауова А.М.
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ.....326
Сериккалиева Динара Сериккалиевна
"БЛУМ КУБИГІ" ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ ӘДІСІ РЕТІНДЕ.....330
Төлегенова Ләйлім Қайратқызы
БОЛАШАҚ МЕДИЦИНА МАМАНДАРЫН ОҚЫТУДАҒЫ ЖАҢА ТӘСІЛДЕР МЕН ИННОВАЦИЯЛАР.....333
Әбдірәсіл А.Н., Ибраимова Жамиля Джумадиловна, Әшім Дәния Әділбекқызы
МЕЙІРБИКЕ ІСІНДЕ ТЕЛЕМЕДИЦИНАНЫ ҚОЛДАНУ: МҮМКІНДІКТЕРІ МЕН ШЕКТЕУЛЕРІ.....336
Сұлтанов Мейірбек Әлібекұлы, Абдукасымова Замза Анафиевна, Ерматова Перизат Ниязбековна
НОВЫЕ ПОДХОДЫ И ИННОВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ БУДУЩИХ МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ.....341
Қалданова Назерке Оразайқызы, Орынбасар Ботагөз Кенжебекқызы
МЕДИЦИНАДАҒЫ ЗЕРТТЕУЛЕРДІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ.....347
Мухамбетжанова А.С., Кусанова А.М.
МЕДИЦИНАЛЫҚ СТУДЕНТТЕРДІҢ ПСИХИКАЛЫҚ ДЕНСАУЛЫҒЫН ҚОЛДАУ: СТРЕССТІ БАСҚАРУ ЖӘНЕ РЕЛАКСАЦИЯ МЕН МЕДИТАЦИЯ ӘДІСТЕРІНІҢ ТИІМДІЛІГІ.....352
Рахимбаева Марал Женискалиевна
МЕЙІРГЕРЛІК БІЛІМ БЕРУДЕГІ ПРАКТИКАЛЫҚ ОҚЫТУ МЕН ТӘЛІМГЕРЛІКТІҢ РӨЛІ.....364
Кенес Құралай Дүсіпханқызы
ТЕМІР ЖЕТІСПЕУШІЛІК АНЕМИЯ. ТЕМІР ЖЕТІСПЕУШІЛІК АНЕМИЯНЫ ЕМДЕУДІҢ НЕГІЗГІ ПРИНЦИПТЕРІ.....367
Баймулдинова Найля Касымхановна
СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ФОРМИРОВАНИЯ КЛИНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У ФЕЛЬДШЕРОВ.....371
Окен Данияр Нурланович, Нурахметов Берик Серикович
ИННОВАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ФЕЛЬДШЕРОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ.....374
Касымжанов Е.А., Алшынгазин Н.Н.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В РАБОТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ.....376

СЕКЦИЯ №4: СЕСТРИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И СЕСТРИНСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.
Абдиназар Д.А.
№1 ҚАЛАЛЫҚ КЛИНИКАЛЫҚ АУРУХАНАСЫНДА АРТЕРИАЛДЫ ГИПЕРТЕНЗИЯСЫ БАР НАУҚАСТАРҒА МЕЙІРГЕРЛІК КҮТІМДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ.....379
Адильжанұлы Сабыржан
МЕЙІРБИКЕЛІК БІЛІМ ЖӘНЕ МЕЙІРБИКЕЛІК ЗЕРТТЕУЛЕР.....385
Азат Ұлдана
МЕЙІРБИКЕ МЕН НАУҚАСПЕН АРАСЫНДАҒЫ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСЫНЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ.....389
Асимжанова Д.А.
РАЗВИТИЕ НАУЧНОГО ОБРАЗА МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ ПРИКЛАДНОГО БАКАЛАВРИАТА ЗА СЧЕТ КАЧЕСТВЕННОГО ПОДХОДА К ИЗУЧЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА.....393
Бердіш Б.Қ.
ТЫНЫС АЛУ АУРУЛАРЫ БАР НАУҚАСТАР АРАСЫНДА ҰЙЫМДАСТЫРЫЛҒАН «ДЕНСАУЛЫҚ МЕКТЕБІНІҢ» ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ.....398
Дукумбаева Эрика Амантаевна
ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО В ЗДРАВООХРАНЕНИИ.....401
Дүйсембек Д.Қ.
МЕДИЦИНАЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРДІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ.....407
Есенбекова Г.М.
МЕЙІРГЕР ІСІНДЕГІ ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ.....411

ISBN 978-601-08-0758-7

Жапашова И.А.
МЕЙІРБИКЕЛІК БІЛІМ ЖӘНЕ МЕЙІРБИКЕЛІК ЗЕРТТЕУЛЕР.....416
Жармахан Толқынай Талғатқызы
ОНКОЛОГИЯЛЫҚ НАУҚАСТАРҒА МЕЙІРБИКЕЛІК КҮТІМ ЖАСАУ.....421
Жумагулова К.К.
УЧАСТИЕ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА.....427
Калиханова А.Қ.
МЕЙІРБИКЕЛІК БІЛІМ ЖӘНЕ МЕЙІРБИКЕЛІК ЗЕРТТЕУЛЕР.....431
Канатханова Диана
РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВИЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ И ВЫХАЖИВАНИИ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ.....435
Қалихан А.Қ.
БҮЙРЕК ЖЕТІСПЕУШІЛІГІ БАР НАУҚАСТАРМЕН ЖҰМЫС КЕЗІНДЕГІ МЕЙІРБИКЕЛІК КҮТІМ....442
Қындыбай Айгерім Ерболқызы
ГЕРИАТРИЯЛЫҚ ПАЦИЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН МЕЙІРГЕРЛІК КҮТІМ.....446
Медетбай Д.Ж., Яхып Қ.Қ., Төлеген Г.Б.
ҚАНТ ДИАБЕТІНЕ БЕЙІМДІЛІКТІ АНЫҚТАУ.....450
Қырғызбаева К.
БРОНХ ДЕМІКПЕСІ БАР НАУҚАСТАРДЫҢ ӨМІР СҮРУ САПАСЫН ЖАҚСАРТУДАҒЫ МЕЙІРГЕРДІҢ РОЛІ.....452
Милиярова Б.З.
МЕЙІРГЕРЛІК БІЛІМ ЖӘНЕ МЕЙІРГЕРЛІК ЗЕРТТЕУЛЕР.....456
Ниязбекова А.Ж.
МЕЙІРБИКЕЛІК БІЛІМ ЖӘНЕ МЕЙІРБИКЕЛІК ЗЕРТТЕУЛЕР.....461
Нурлибаева Аяулым Ерланқызы
МЕЙІРГЕРЛЕР АРАСЫНДАҒЫ КҮЙЗЕЛІС ДЕҢГЕЙІН АНЫҚТАУ АСПЕКТІСІ.....465
Өмірзақова Диана Өмірғалиқызы
ЖЕТІЛІП ЖӘНЕ ШАЛА ТУҒАН НӘРЕСТЕЛЕРДІҢ АНАТОМИЯЛЫҚ – ФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ.....469
Раимкулова Н.И.
КӨШБАСШЫЛЫҚ МЕЙІРГЕРЛІК БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕ ЖӘНЕ МЕЙІРГЕРЛІК ТӘЖІРИБИЕДЕ.....473
Рахманберді Р.Ж.
МИОКАРД ИНФАРКТІСІ БАР НАУҚАСТАРДЫҢ ӨМІР САПАСЫН ЖАҚСАРТУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ.....477
Самат Гүлбақыт, Серікқызы Диана
МЕЙІРБИКЕЛІК БІЛІМ ЖӘНЕ МЕЙІРБИКЕЛІК ЗЕРТТЕУЛЕР.....480
Серёдкина Е.А.
РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ТРАВМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА.....484
Алдабергенова Айман Сагынтаевна
АРНАУЛЫ ӘЛЕУМЕТТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫНА ӘЛЕУМЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІҢ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРІ.....491
Уласканова А.Г.
МЕЙІРГЕРЛІК БІЛІМ ЖӘНЕ МЕЙІРГЕРЛІК ЗЕРТТЕУЛЕР.....497
Стратула Р.
СЕСТРИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И СЕСТРИНСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.....501
Эрназарова А.
АУРУЛАРДЫ БАСҚАРУ БАҒДАРЛАМАСЫ АЯСЫНДА МЕЙІРГЕРДІҢ РӨЛІ.....505
Валиева Гулфира Касимжановна
МЕДИЦИНАДАҒЫ ЗЕРТТЕУЛЕРДІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ.....509

ISBN 978-601-08-0758-7

СЕКЦИЯ №1: ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЛЕЧЕБНОМУ ДЕЛУ.

БРОШЮРА ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ТЕМУ: «САХАРНЫЙ ДИАБЕТ»

Ирисметов Д.И., 3 курс Специальность «Лечебное дело»
КГП на ПХВ “Усть-Каменогорский высший медицинский колледж”
Научный руководитель: Папышева Г.К.

Аннотация: *В данной работе рассматривается сахарный диабет как системное заболевание, связанное с патологией поджелудочной железы. Описаны основные типы диабета: абсолютная и относительная. Описаны их симптомы, методы диагностики и патогенез. Работа также затрагивает современные подходы к лечению, включая инсулинотерапию и сахаропонижающие препараты, а также осложнения сахарного диабета и способы их предотвращения. Особое внимание уделено на графические составляющие, которые доходчиво объясняют механизмы действия: рисунки, схемы. Также особое внимание уделено практическим аспектам диагностики, что делает данную работу крайне полезной для студентов, которые стремятся получить комплексное понимание данного заболевания.*

Актуальность: сахарный диабет – одно из самых распространённых хронических заболеваний в мире, которое затрагивает миллионы людей и имеет серьёзные последствия для здоровья человека. Для будущих медицинских работников крайне важно иметь хорошее понимание этого заболевания, поскольку они будут регулярно сталкиваться с пациентами, страдающими диабетом. Актуальность темы обусловлена необходимостью ясного доступного изложения сложных механизмов патогенеза и лечения сахарного диабета, что позволит студентам эффективно применять полученные знания в клинической практике.

Цели: главная цель данной работы – обеспечить будущих медицинских работников общими и структурированными знаниями о сахарном диабете, для правильного диагностирования и предотвращения осложнений. Важно донести основные принципы патофизиологии и диагностики сахарного диабета с акцентом на применение этих знаний в практической деятельности.

Задачи:

1) Описать основные типы сахарного диабета, их этиологию и патофизиологию.
2) Разъяснить основные методы диагностики сахарного диабета, включая гликированный гемоглобин и Глюкотолерантный тест.
3) Представить случаи из клинической практики для лучшего понимания патогенеза и подходов профилактики сахарного диабета.

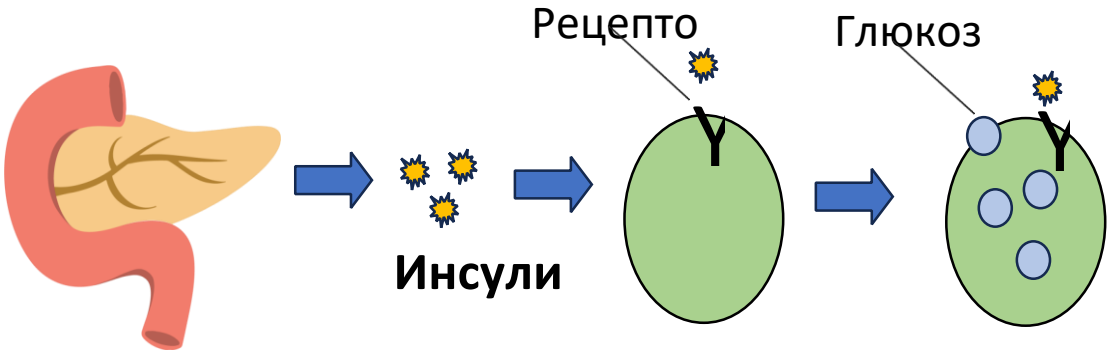
САХАРНЫЙ ДИАБЕТ

ISBN 978-601-08-0758-7

Системное заболевание, обусловленное патологией поджелудочной железы.

Распространённые причины сахарного диабета:

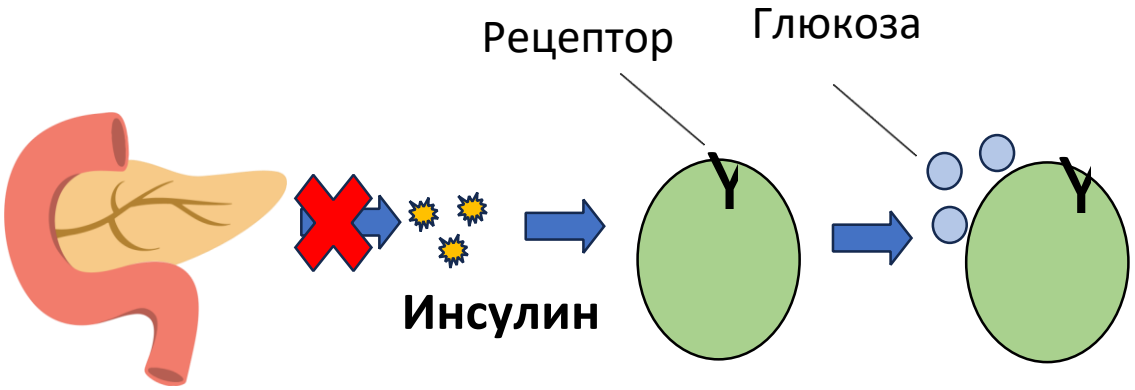
- Сбой в работе иммунной системы, из-за которого она атакует клетки поджелудочной железы
- Генетические нарушения
- Вирусные инфекции
- Хронические заболевания, при которых поражается поджелудочная железа
- Эндокринные заболевания — синдром Кушинга, акромегалия
- Особенности питания — избыток жиров и простых углеводов в рационе может привести к ожирению и снижению чувствительности клеток к инсулину
- Лекарственные препараты — некоторые гормональные средства (в частности, глюкокортикостероиды), отдельные лекарства для лечения заболеваний сердца и нервной системы, препараты витаминов группы В (при чрезмерном употреблении)



Сахарный диабет I типа (СД I типа):

Абсолютно инсулинозависимый диабет. Основным диагностическим признаком которого является хроническая гипергликемия – повышенный уровень сахара в крови. У пациента полиурия, неутолимая жажда, потеря веса, снижение аппетита, возможные боли в эпигастральной области. Таким пациентам назначается инсулинотерапия, которая включает в себя применение инсулина короткого действия (перед приемом пищи) и длительного (утром и перед сном). Чаще болеют молодые.

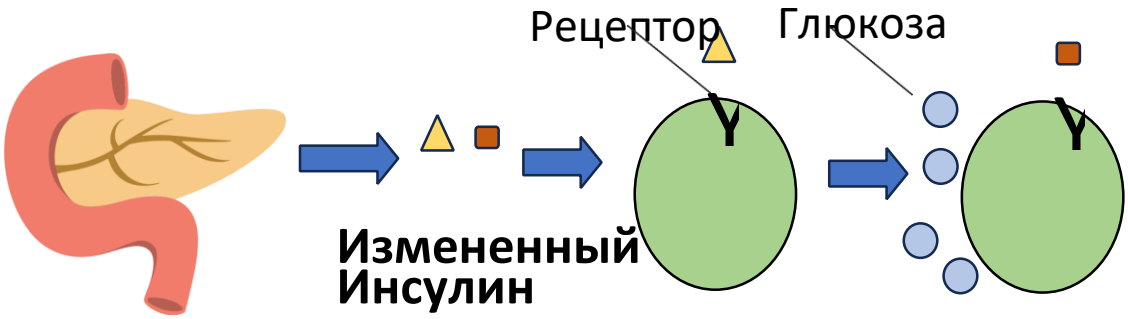
ISBN 978-601-08-0758-7



СД Iтип

Сахарный диабет II типа (СД II типа):

В отличии от СД I типа, при сахарном диабете II типа, инсулин будет синтезироваться в поджелудочной железе. Но этот инсулин измененный и не будет распознаваться рецептарами клеток организма. И поэтому также глюкоза не будет усваиваться. У пациента полиурия, жажда, сухость кожи, фурункулез, зуд. Также люди, страдающие СД II типа, имеют избыточный вес. Чаще болеют люди старше 40 лет. Пациентам назначаются сахаропонижающие препараты.



СД II тип

Основные симптомы при СД:

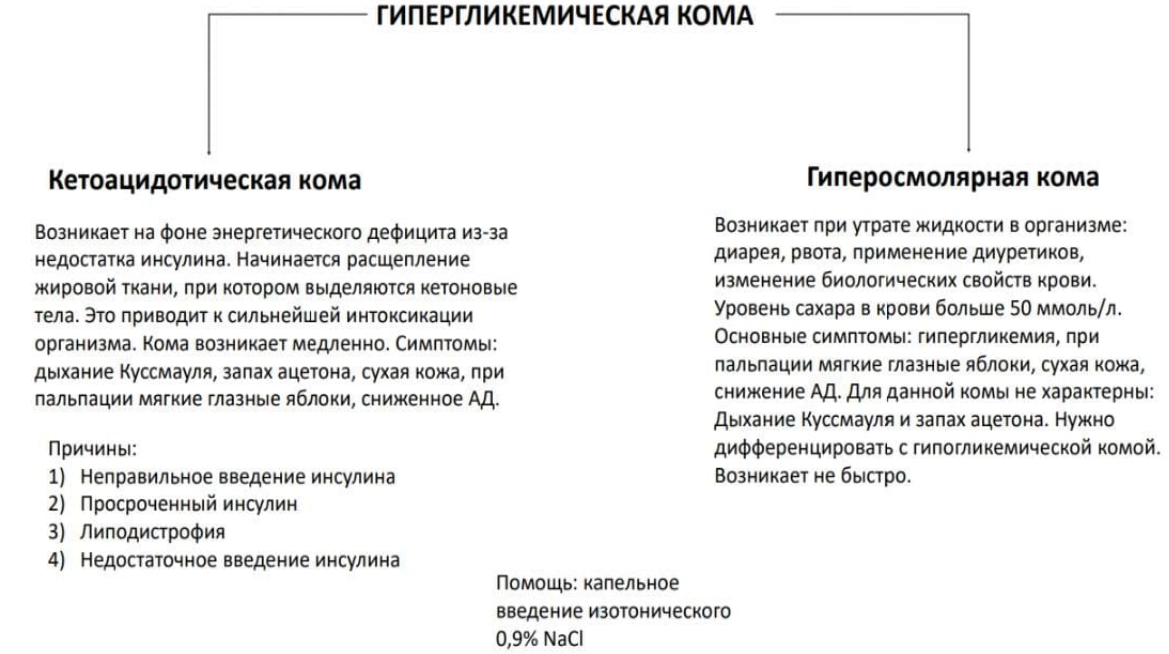
1. Гипергликемия
2. Гипогликемия
3. Полидепсия
4. Полиурия
5. Раздражительность
6. Снижение аппетита
7. Полифагия
8. Зуд кожи

Осложнения СД:

1. Гипергликемическая кома

ISBN 978-601-08-0758-7

2. Гипогликемическая кома
3. Нефропатия
4. Макроангиопатия
5. Микроангиопатия ретинопатия
6. Гепатопатия
7. Синдром диабетической стопы
8. Поражение периферических нервов - Нейропатия



Гипогликемическая кома

Возникает резко при снижении уровня глюкозы до 2,2 – 2,8 ммоль/л. Характерны судороги, повышенные рефлексы, при пальпации глазные яблоки твердые, кожа влажная, АД повышенное, головокружение, слабость.

Причины:

1) Передозировка инсулином
2) Физические нагрузки
3) Эмоциональные стрессы

Помощь: в/в введение 40% глюкозы



ISBN 978-601-08-0758-7

Вывод: Сахарный диабет – это одно из наиболее распространённых и серьёзных хронических заболеваний, затрагивающих здоровье миллионов людей по всему миру. В этой работе подробно рассмотрены патогенез, этиология, основные клинические проявления и диагностические методы, которые необходимы для глубокого понимания заболевания. Описаны различия между диабетом I и II типа, их особенности, симптомы и современные методы лечения, включая инсулинотерапию и сахаропонижающие препараты.

Будущим медицинским работникам крайне важно обладать этими знаниями, чтобы уметь правильно диагностировать сахарный диабет, вовремя предотвращать его осложнения и эффективно помогать пациентам. Практические аспекты работы, такие как методы диагностики и применения полученных знаний, делают данное пособие полезным инструментом для обучения студентов. Знание этих ключевых принципов позволит будущим специалистам вносить вклад в эффективное лечение и профилактику сахарного диабета, что особенно важно в условиях роста числа пациентов с этим заболеванием.

Список литературы:

1. Dedov, I.I., Shestakova, M.V., and Galstyan, G.R. (2019). **Diabetes Mellitus: National Guidelines**. Moscow: GEOTAR-Media. – Подробное руководство, охватывающее патогенез, клинические проявления и лечение сахарного диабета с акцентом на современные методы диагностики и терапии.

2. Петунин А.В., Полушина Е.Ю. (2021). **Эпидемиология и профилактика сахарного диабета 2 типа**. – Журнал клинической эндокринологии, 67(4), 293-300. – Рассматриваются факторы риска и современные подходы к профилактике СД 2 типа.

ISBN 978-601-08-0758-7

ДИГИТАЛЬДЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ НЕСЕПТАС АУРУЫНЫҢ ДИАГНОСТИКАСЫНДА ҚОЛДАНЫЛУЫ

Бектас Әсем Мақсатқызы, 4 курс «Емдеу ісі» мамандығы
ЖШС «Кентау колледжі»
Ғылыми жетекшісі: Аширбаева Жанар Маратовна, арнайы пән оқытушысы, бірінші дәрежелі маман

Аннотация: *Дигитальді зерттеу әдістеріне негізделе отырып, 243 несептас ауруы бар науқасқа нақты емдеу әдістері анықталды (эндоскопиялық ота, консервативті ем, ашық ота).*

Дигитальды технологияларды несептас ауруының диагностикасында қолданылуы. Несептас ауруы бар науқастың диагностикасында ең маңызды 5 сұрақтарға келесілер жатады:

1. Конкременттің: Саны. Локализациясы. Көлемі. Пішіні;
2. Конкремент(тер) бүйрек паренхимасында туғызған өзгерістер және олардың дәрежесі.
3. Конкремент(тер) бүйректің функциясын бұзу дәрежесі.
4. Конкремент(тер) туғызған асқынуларға баға беру.
5. Қарама - қарсы бүйректің функциясына баға беру. Осы сұрақтарға жауап беру мақсатында келесі дигитальді зерттеу әдістері қолданылады:

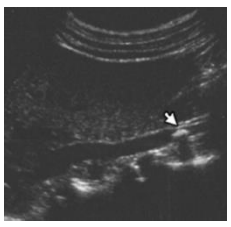
Төменде әрбір дигитальді зерттеу әдісінің артықшылықтары атап көрсетіледі:

1. Ультрадыбыстық сонография әдісі.

УДЗ кезінде анықталатын тастардың жанама белгілеріне келесілер жатады:

- зәр шығару жолдарының кедергіден жоғары кеңеюі,
- несепағар қабырғасының жергілікті қалыңдауы,
- периуретеральды ісіну,
- несепағар ішіндегісінің бұзылуы,
- бүйрек паренхимасының ісінуі.
- тостағанша- астауша жүйесінің деформациялануы.

Дигитальді зерттеу әдісінің маңызды артықшылығы - рентгенонегативті конкременттерді бейнелеу мүмкіндігі. Өйткені бүйректегі конкремент акустикалық көлеңкесі бар гиперэхогендік дөңгелек форма түрінде көрінеді.



Соно-грамма. Несепағардың ортаңғы бөлігінде орналасқан, көлемі 0,5*1,0 см бұршақ тәрізді конкремент.

ISBN 978-601-08-0758-7

Соно-грамма. Несепағардың төменгі бөлімінің тасы. Несепағардың тастан жоғарғы бөлімінің айқын дилатациясы анықталады.

Сонограмма. Несепағардың интрамуральды бөлімінің ұсақ конкременттері.



2. Компьютерлік томографияның артықшылықтары:

1) Бүйрек паренхимасының қалыңдығы, тостағанша-астауша жүйесінің жағдайы анықталады;

2) Әрбір бүйректің функциялық қабілетіне жеке баға беріледі;

3) Жоғарғы несеп жолдарының уродинамикасы бағаланады.

4) Конкременттің тығыздығы анықталады.

Алынған нәтижелердің негізінде несептас ауруы асқынуларының (гидронефроз, бүйректің атрофиясы, пионефроз және т.б.) алдын алу емдік іс-шаралар алгоритмін құрастыруға болады.

КТ –грамма



Несептас ауруы. Бүйректердің маржан тәрізді тастары. Сол бүйректің атрофиясы.



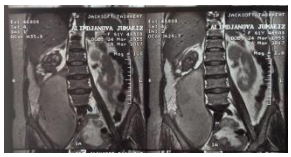
Несептас ауруы. Оң бүйректің маржан тәрізді тастары.



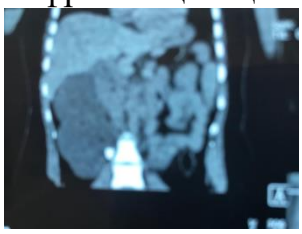


Несептас ауруы. Оң бүйректің көптеген тастары. КТ грамма

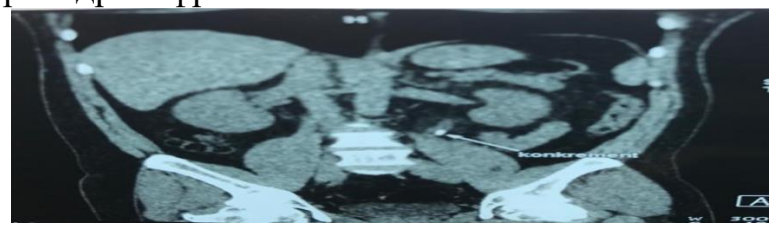
ISBN 978-601-08-0758-7



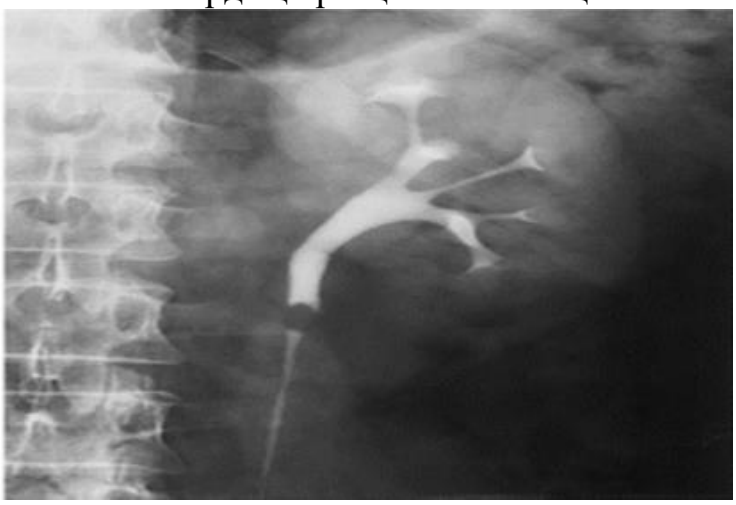
Несептас ауруы. Оң бүйректің көптеген тастары. Асқынуы: Калькулезді іріңді пиелонефрит. Оң жақтама төменгі паранефральді абсцесс.



Несептас ауруы. Оң несепағардың жоғарғы бөлімінің тасы. Асқынуы: уретерогидронефроз III сатысы



Сол несепағардың ортаңғы бөлімінің тасы. Асқынуы: уретерогидро- нефроз



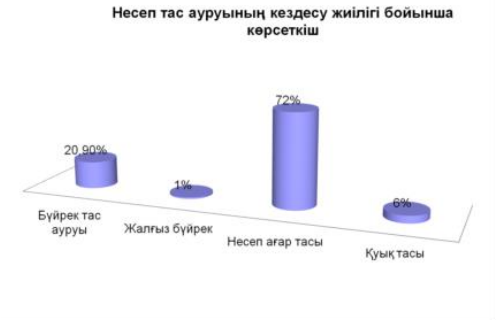


Несептас ауруы. Сол несепағардың жоғарғы бөлімінің тасы.

Алынған нәтижелерге сүйене отырып біз 243 науқасқа несептас ауруы диагнозын қоюға мүмкіндік алдық

ISBN 978-601-08-0758-7









ISBN 978-601-08-0758-7



Қорытынды: Дигитальді зерттеу әдістеріне негізделе отырып, 243 несептас ауруы бар науқасқа нақты емдеу әдістері анықталды (эндоскопиялық ота, консервативті ем, ашық ота).

Әдебиеттер тізімі:

1. 2014ж. Ред басқармасы. М.С.Асқаров

Web сайттар:

1. https://www.sciencedirect.com/book/9782294738388/strabisme

ISBN 978-601-08-0758-7

ЕРЛЕР БЕЛСІЗДІГІНІҢ ДАМУЫНА ӘКЕЛЕТІН ҚАУІП ФАКТОРЛАРЫНЫҢ КЕЗДЕСУ ЖИІЛІГІНЕ ШЕТЕЛДІК ЗЕРТТЕУЛЕРДЕН ТАЛДАУ

***Ғабдуллин Ақыл Жомартұлы,* 3курс, «Емдеу ісі» мамандығы**
Қызылорда медициналық жоғары колледжі
Ғылыми жетекшілері: Жумашева С.А., Колдеева Ф.Н, арнайы пән оқытушылары, магистр

Аннотация: *Бұл мақала да қазіргі таңда мәселесі өзекті болып тұрған ер адам бедеулігінің статистикалық көрсеткіші мен алып келетін факторлары туралы көрсеткен. Бедеулік ересек тұрғындардың шамамен 17,5% немесе бүкіл әлем бойынша шамамен әрбір алты адамның біреуіне әсер етеді. Әлемдегі ерлер белсіздігінің белең алуы ерлер белсіздігінің дамуына әкелетін қауіп факторларының кездесу жиілігін шетелдік зерттеулерден талдады.*

Жастардың арасында бедеулік пен белсіздік неліктен соншалықты белең алып бара жатқаны дүйім жұртты алаңдатып отырған сұрақ. Дәрігерлер бұрын әйелдер бедеулігі жиі кездессе, қазір ерлердің белсіздігі де өзекті проблемаға айналды деп отыр. Сондай-ақ бедеуліктің жасы да кішірейіп бара жатыр деп дабыл қағуда. [1.2]

Ерлердің бедеулігі проблемасы медициналық көмек деңгейі жоғары дамыған елдердің тұрғындарына қатысты. Осылайша, ер бедеулігінің ең жоғары таралуы Орталық және Шығыс Еуропада (8-12%), Австралияда (8-9%) байқалды; Солтүстік Америкада бұл көрсеткіштің мәні 2,5–12,0% жалпы ауытқуымен 4,5–6,0% құрады.Соңғы онжылдықтарда ерлердегі сперматозоидтардың саны мен сапасының айтарлықтай төмендеуін көрсететін зерттеу нәтижелері жарияланғаннан кейін ер бедеулігі мәселесіне ерекше назар аударылды. [3.4]

Көптеген жылдар бойы жүргізілген зерттеулердің деректеріне сүйене отырып, ер бедеулігі негізінен генетикалық негізде және несеп-жыныс инфекциялары, иммундық және эндокриндік аурулар, реактивті оттегі түрлерінің шамадан тыс өндірілуі сияқты бедеулікті тудыратын себептердің болуы, көп факторлы ауру екендігі туралы идея тұжырымдалған. т.б. [3.4]

Ерлердегі бедеулік жағдайларының 30%-дан астамы этиологиясы белгісіз идиопатиялық бұзылыстарға жатады.

- ✓ 2020 жылы Халықаралық репродуктивті биомедицина журналы бедеулік Америка Құрама Штаттардағы ажырасудың басты себептерінің бірі екенін көрсететін деректерді жариялады.Бедеу адамдардың 60% -ы олардың проблемасы ауыр психоэмоционалдық бұзылуларға әкелетінін атап өтеді, олар жиі алаңдаушылық пен депрессиядан зардап шегеді. [3.4]

ISBN 978-601-08-0758-7

✓ Ресей Федерациясында жалпы әйелдер бедеулігінің үлесі шамамен 90% құрайды және бедеулік жағдайларының тек 10% -ында ер адамдар «кінәлі» болып табылады. Мәскеуде 2021 жылғы зерттеулерге сәйкес, әйелдер бедеулігінің үлесі 98% құрайды; тиісінше, ерлердің үлесі небәрі 2% құрайды. [3.4]

✓ Қазақстанда бедеулікке қатысты ресми статистика өсуде. 2021 жылы мұндай диагнозбен тіркелген қазақстандықтардың саны 21,8 пайызға өсіп, 21,4 мың адамға жеткен. Жалпы ресми көрсеткіштерге әйелдер ең көп үлес қосты – кезеңнің қорытындысы бойынша еліміздің медициналық мекемелерінде денсаулығына байланысты жүкті бола алмаған 19,9 мың қазақстандық әйелдер тіркелген (2,8%) [3.4]

Ерлер белсіздігінің дамуына әкелетін қауіп факторларының кездесу жиілігін шетелдік зерттеулерге талдау жүргізілді:

«Эксперименттік және клиникалық медицина ғылыми-зерттеу институты» мақаласы Ресей, Новосибирск репродуктивті медицина орталығында жүргізілген зерттеу. Эякуляция параметрлері дұрыс емес бедеу жұптардан 917 ер адам тексерілді. Орташа жасы 34,1±6,3 жасты, бедеуліктің орташа кезеңі 4,6±3,9 жасты құрады. Медициналық құжаттарды ретроспективті талдау, клиникалық тексеру, бедеуліктің дамуының қауіп факторларын анықтауға арналған сауалнама, дене салмағы мен бойын өлшеу арқылы антропометриялық зерттеу жүргізілді. Дене салмағының индексі <24,9 кг/м2 қалыпты, дене салмағы 25,0-29,9 кг/м2 артық салмақ, ал дене салмағы >30 кг/м2 семіздік деп танылды. Бедеуліктің дамуының қауіп факторларын анықтау кезінде 3 топтастырылған 24 қауіп факторы анықталды: 1-ші – қоршаған орта факторлары және кәсіптік қауіптер, 2-ші –туа біткен және жүре пайда болған патологиялар, 3 - әлеуметтік факторлар және өмір салты факторлары; бұл кластерге сонымен қатар анамнезде және/немесе тексеру кезінде туберкулездің, жыныстық жолмен берілетін инфекциялардың және басқа да «әлеуметтік» аурулардың, атап айтқанда гепатиттің болуы туралы ақпарат енгізілген. Одан әрі жалпы үлгіден зерттеу кезінде соматикалық патологиясы және «әлеуметтік» аурулары, сондай-ақ репродуктивті бұзылулармен байланысты генетикалық ауытқулары жоқ ерлер таңдалды. Оның ішінде 2 топ құрылды: дене салмағы қалыпты және артық салмағы бар ерлер. Әрбір топта бедеуліктің жоғарыда аталған қауіп факторларының жиілігі, сонымен қатар ақыл-ой және дене еңбегінің қосымша жиілігі есептелді. [5,6]

Нәтижелері: Жалпы іріктеуде кәсіптік қауіпті және қоршаған орта факторларын қоса алғанда, бедеуліктің қауіп факторларының жиілігі <20%, туа біткен және жүре пайда болған патологиялар – 1-39% құрады. Тәуекел факторларының пайда болу жиілігі 3-ші кластерде байқалды. Олардың ішінде 1-орында алкогольді ішу (75%), одан кейін жыныстық жолмен берілетін инфекциялардың болуы (59%), эмоционалдық стресс (44%) және
темекі шегу (42%). Артық салмақ 40%, семіздік 34% құрады. Анамнездегі есірткіні қолдану эпизодтары туралы сауалнамадағы көрсеткіштер, сондай-ақ гепатит, туберкулез және АИТВ-инфекциясының жиілігі <20% құрады. Бедеуліктің көп факторлы генезисі зерттелген ерлердің жартысынан көбінде (57,9%) бедеуліктің 3-5

ISBN 978-601-08-0758-7

қауіп факторы, ал ерлердің тек 12,4% -ында тек 1 немесе 1-ден астам қауіп факторлары бар екендігі көрсетілген. Дене салмағы қалыпты ерлерде жұмыста химиялық фактордың болуының жоғары жиілігі физикалық еңбектің жоғары жиілігімен үйлеседі. Семіздікке шалдыққан ерлерде алкогольді тұрақты тұтыну жағдайларының жоғары үлесі (83,7%) ақыл-ой еңбегінің жоғары жиілігімен біріктірілді. Семіздікке шалдыққан ерлер тобындағы созылмалы простатиттің жиілігі 65,1% құрады, бұл ерлердің жалпы іріктеуіндегі осы көрсеткіштің мәнімен (37%) салыстырғанда айтарлықтай жоғары (p<0,001). Олардың эмоционалды күйзеліс жиілігі >40% құрады. [5,6]

Қорытынды. Ерлердің бедеулігінің дамуына ең маңызды үлес бедеуліктің медициналық және әлеуметтік қауіп факторлары болып табылады. Сонымен қатар, қазіргі заманғы ер адамдар арасында бедеуліктің даму қауіпі жоғары адамдардың әлеуметтік тобы пайда болды - бұл семіздіктің дамуы бар 30-40 жас аралығындағы ер адамдар, созылмалы аурулардың жоғары жиілігімен бірге жүреді. [5,6]

"Ерлердің бедеулігінің дамуының экзогендік қауіп факторлары"

Автор: Маслюков И.А., Коновалова Ю.М. Мәскеу, Ресей Федерациясы

Зерттеу материалдары мен әдістері: 29 бен 47 жас аралығындағы 30 ер адамды зерттеген. (орташа жас аралығы 38+50 жас). Барлық науқастарды міндетті клиникалық тексерудің көлеміне мыналар кіреді: ауру тарихы (өмір салтына ерекше назар аударылды, зиянды әдеттердің болуы), стандартты клиникалық және зертханалық әдістер, гормоналды профильді анықтау, емдеуге дейін және емдеуден кейін эякуляцияны қосарлы тексеру. (шәуеттердің қалыпты формаларының концентрациясы, қозғалғыштығы және үлесі анықталды), антисперматикалық антиденелермен жабылған сперматозоидтардың пайыздық мөлшерін анықтау үшін MAR әдісі қолданылды. Материалды статистикалық өңдеу «EXCEL» электрондық кестелері мен «STATISTICA 6.0» бағдарламасы арқылы жүзеге асырылды. Сандық көрсеткіштер арасындағы айырмашылықтардың маңыздылығы Манн-Уитни тесті арқылы бағаланды. Сапалық параметрлерді салыстыру үшін Фишердің нақты сынағы немесе x2 пайдаланылды. Айырмашылықтар p <0,05 мәнінде маңызды деп саналды. [7]

Нәтижелер. Біз науқастардың көпшілігінде біріншілік бедеулікті – 22 (73,3%), ал қалғандарында – 8 (26,7%) екіншілік бедеулікті анықтадық. Анамнезінен 8 (26,6%) ер адамның алкогольді белсенді түрде пайдаланатынын анықтадық (аптасына 1-2 реттен көп). Науқастардың басым бөлігі – 19 (63,3%) аптасына бір рет ішімдік ішкен. 3 (10%) адам мереке күндері және басқа да жағдайларда ішімдік ішкен. Тексерілген науқастардың басым көпшілігі күніне 23 (76,6%) 1 қорап немесе одан да көп темекі шегеді. Қалған 7 (23,4%) ер адам күніне бір қораптан аз темекі шегеді. Сондай-ақ анамнезінен 4% эрекцияны ынталандыратын (мысалы, силденафил) сперматогенезді тежейтін препараттарды қолданғаны анықталды. Тексерілген пациенттердің 21 (70%) тұрақты жұмысы болды, оның ішінде 9 (42,8%) цемент, бояу, кірпіш шаңы, мәрмәр және т.б. байланысты қауіпті өндірістерде жұмыс істеді. Барлық пациенттердің (n=30) жұмыс уақыты тұрақты емесжәне күніне 8-10 сағаттан артық жұмыс істеді.

ISBN 978-601-08-0758-7

Қорытынды: ерлер бедеулігінің ең маңызды экзогендік қауіп факторлары темекі шегу, алкоголь, кәсіптік қауіптер, стимуляторларды қолдану және стресс екенін көрсетті. [7]

"Қабыну және ер белсіздігі " автор: Н.Г. Кульченко Мәскеу, Ресей

Зерттеудің материалдары мен әдістері. 18 бен 46 (32±14) жас аралығындағы 44 адам тексерілді. Оның ішінде 24 (54,5%) ер адам жұбайының 12 айдан астам жүкті болмағанына шағымданған. Бұл науқастар бірінші зерттеу тобын құрады. Екінші зерттеу тобына 20 (45,5%) дені сау ер еріктілер кірді.

Науқастарды зерттеуге қосу критерийлері: пациенттің жасы 46 жасқа дейін, контрацепциясыз бедеуліктің анықталған фактісі, жыныстық серіктес тарапынан патологияның болмауы, анамнезінде аналық бездің екі жақты зақымдануының болмауы, екі жақта да аталық бездің гипоплазиясының болмауы.

Зерттеуге бедеуліктің обструктивті түрімен, жыныстық жолмен берілетін аурулары бар, варикоцелемен ауыратын, бедеуліктің генетикалық және эндокриндік факторлары анықталған, тексеру кезінде ауыр ілеспелі патологиясы бар науқастар қамтылған жоқ.

Нәтижелер. Әріптесінің 12 айдан астам жүкті болмағанына шағымданған 24 адамның барлығында спермограмма нәтижесі обструктивті емес азооспермияны анықтады. Науқастардың өмір тарихы ауыртпалықсыз болды, ерлер жарақаттар, эпидемиялық паротит немесе жыныс мүшелеріне хирургиялық араласудан бас тартты. Клиникалық зерттеу нәтижелері нормадан өрескел ауытқуларды анықтаған жоқ: перифериялық қан лейкоциттерінің жалпы саны 6,4 ± 1,2 * 109/л, бактериурия жоқ, лейкоспермия тіркелген жоқ. Ұрық сүйегінің мүшелерінің УДЗ құрылымдық патологиясы анықталмады (аталық бездің эхогенділігі орташа, ондағы гипо- және гиперэхоикалық аймақтар жоқ, оң және сол сперматозоидтық тамырлардың диаметрі 2 мм, вальсальва бар. маневр 3 мм-ге дейін, қан ағымының бағытын өзгерту белгілері жоқ). Зерттеу тобындағы барлық пациенттерге идиопатиялық обструктивті емес азооспермия диагнозы қойылды. [8,9]

Қорытынды:

«Әлемдегі ерлер белсіздігінің белең алуы ерлер белсіздігінің дамуына әкелетін қауіп факторларының кездесу жиілігіне талдау» тақырыбында зерттеу жұмысын зерттеу мақсатында шетелдік зерттеу жұмысы қолданылды және қорытынды жасалды:

1. ерлер бедеулігінің ең маңызды экзогендік қауіп факторлары темекі шегу, алкоголь, кәсіптік қауіптер, стимуляторларды қолдану және стресс екенін көрсетті.
2. қазіргі заманғы ер адамдар арасында бедеуліктің даму қауіпі жоғары адамдардың әлеуметтік тобы пайда болды - бұл семіздіктің дамуы бар 30-40 жас аралығындағы ер адамдар, созылмалы аурулардың жоғары жиілігімен бірге жүреді.
3. 3. Обструктивті емес азооспермия, яғни сперматогенездің патологиялық бұзылуы себептерінің бірі тотығу стрессін тудыратын созылмалы қабыну болып табылады.

ISBN 978-601-08-0758-7

Әдебиеттер тізімі:

1.Е.А. Епанчинцева, В.Г. Селятицкая, М.А. Свиридова, Ю.В. Лутов «Эксперименттік және клиникалық медицина ғылыми-зерттеу институты»

2. Н.Г. Кульченко Мәскеу, Ресей Зерттеудің материалдары мен әдістері.

4.https://www.who.int/ru/news/item/04-04-2023-1-in-6-people-globally-affected-by-infertility

5.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29371820/

6.https://ranking.kz/reviews/socium/kazhdaya-shestaya-semeynaya-para-v-kazahstane-besplodna-i-eto-tolko-verhushka-aysberga.html

7. Чалый М.Е., Ахведиани Н.Д., Харчилава Р.Р. Мужское бесплодие.

8. Kleisch S. Diagnosis of male infertility: diagnostic work-up of the infertile man. Eur Urol Suppl 2014; 13:73-82. doi: 10.1016/j.eursup.2014.08.002.

9. Krausz C, Riera-Escamilla A. Genetics of male infertility. Nat Rev Urol 2018; 15(6):369-84. doi: 10.1038/s41585-018-0003-3.

ISBN 978-601-08-0758-7

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Вон К.С., 4 курс, специальность "Лечебное дело"
ГКП «Актюбинский Высший медицинский колледж имени Героя Советского Союза Маншук Маметовой»
Научные руководители: Гудзь Л. А., Акбаева Г. А, преподаватели специальных дисциплин

Аннотация: *Данная статья рассматривает медицинские исследования, которые постоянно меняются в ответ на новые проблемы, возникающие в результате глобальных изменений и развития технологий*.

Исследования в области медицины могут помочь улучшить качество жизни и продлить жизнь, поскольку медицина находится на переднем крае научных открытий и технологических инноваций. В последние десятилетия стало очевидно, что медицинские исследования не только стремятся лечить болезни, но и предотвращать их появление. Они также стремятся понять сложные взаимосвязи между генетикой, средой и образом жизни человека.

Цель этой работы состоит в том, чтобы изучить самые актуальные направления медицинских исследований и определить, как они могут помочь улучшить глобальное здравоохранение.

1. Персонализированные медицинские услуги

Генетический анализ

Персонализированная медицина зависит от индивидуальных особенностей каждого пациента, а также от его генетического профиля, образа жизни и окружающей среды. Технологии секвенирования генома делают возможным исследование генетических предрасположенностей к различным заболеваниям. Это позволяет не только диагностировать болезни на ранних стадиях, но и разрабатывать персонализированные программы лечения.

Примером может служить онкология, в которой генетические тесты могут выявить мутации, они могут определить реакцию пациента на определенные лекарства. Это позволяет врачам выбирать наиболее эффективные методы лечения, избегая дорогостоящих и неэффективных методов, из за чего они могут привести к побочным эффектам.

Влияние эпигенетики и окружающей среды

Эпигенетика изучает изменения в экспрессии генов, которые могут передаваться по наследству, но не влияют на последовательность ДНК. Такие вещи, как питание, стресс и воздействие вредных веществ, могут привести к этим изменениям. Исследования в этой области помогают нам лучше понять, как образ жизни и окружающая среда влияют на здоровье человека, и открывают новые способы предотвращения заболеваний.

ISBN 978-601-08-0758-7

2. Разработка новых медицинских препаратов и методов лечения

Машинное обучение и искусственный интеллект

Медицина использует машинное обучение и искусственный интеллект (ИИ) для улучшения диагностики и разработки новых лекарств. Современные алгоритмы могут анализировать огромные объемы данных и обнаруживать закономерности, которые люди не всегда могут понять. Это особенно полезно при поиске новых лекарственных молекул и прогнозировании того, насколько хорошо лекарства работают с определенными пациентами.

В области медицинских изображений ИИ также набирает обороты: автоматизированный анализ снимков МРТ и КТ может использовать алгоритмы машинного обучения для значительно повышения точности диагностики таких заболеваний, как онкология.

Биопечать и органоиды

Использование органоидов, миниатюрных аналогов человеческих органов, и биопринтинг являются важными областями исследований для разработки новых методов лечения. 3D-печать тканей и органов из клеток пациента позволяет производить уникальные трансплантаты, что снижает вероятность отторжения и облегчает процесс восстановления.

Органоиды на основе стволовых клеток позволяют исследовать развитие заболеваний и тестировать лекарства в условиях, максимально приближенных к тканям человека. Это повышает скорость и точность разработки лекарств.

3. Инфекции и глобальное здравоохранение

Исследование антимикробной резистентности

Устойчивость бактерий к антибиотикам является одной из наиболее сложных проблем, существующих в настоящее время. Основным направлением исследований является разработка новых антибиотиков и альтернативных методов лечения, таких как бактериофаги или иммунотерапия. ВОЗ предупреждает, что к 2050 году инфекции, вызванные устойчивыми к антибиотикам бактериями, могут стать основной причиной смерти во всем мире.

Управление пандемиями и эпидемиология

Пандемия COVID-19 продемонстрировала важность изучения вирусных инфекций и методов их предотвращения. Важнейшими направлениями медицинских исследований стали вакцинология, мониторинг мутаций вирусов и создание методов раннего предупреждения о вспышках заболеваний. Особое внимание уделяется разработке универсальных вакцин против различных штаммов вирусов и способов предотвращения осложнений.

4. Цифровая медицина и телемедицина

Внедрение цифровой медицины открыло новые возможности для лечения и профилактики заболеваний. Использование телемедицины, мобильных приложений для мониторинга здоровья и носимых устройств позволяет пациентам отслеживать свое состояние в режиме реального времени и своевременно получать помощь.

Большое количество данных и анализ медицинских данных

ISBN 978-601-08-0758-7

Анализ больших данных помогает прогнозировать вспышки заболеваний, определять факторы риска и создавать методы их минимизации. Электронные медицинские карты могут помочь в диагностике, лечении и профилактике многих заболеваний.

5. Нейронауки и ментальное здоровье

В последнее время проблема психического здоровья становится все более актуальной. Эта тенденция только усилилась в результате пандемии COVID-19, которая вызвала рост случаев депрессий, тревожных расстройств и других психических заболеваний.

Исследования мозга и разработка лекарств

Новые методы лечения психических расстройств могут быть изучены с помощью современных технологий, таких как функциональная магнитно-резонансная томография (МРТ) и нейромодуляция. Например, глубокая стимуляция мозга уже используется для лечения таких заболеваний, как болезнь Паркинсона, и может также использоваться для лечения обсессивно-компульсивных расстройств и депрессии.

Развитие технологий VR и AR

Виртуальная реальность (VR) и дополненная реальность (AR) используются для лечения фобий, посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и других психических расстройств. Они позволяют создавать контролируемые, безопасные места, где пациенты могут безопасно обрабатывать свои тревоги и страхи под наблюдением квалифицированных специалистов.

Выводы: Современные медицинские исследования охватывают множество направлений, каждое из которых имеет решающее значение для улучшения здоровья и благополучия людей. Будущее медицины зависит от инновационных технологий, ментального здоровья и персонализированной медицины. Создание новых решений, которые не только излечивают болезни, но и предотвращают их развитие, улучшает качество жизни людей по всему миру, возможно благодаря интеграции науки, технологий и междисциплинарных подходов.

Список литературы:

1. Возрастающая угроза развития антимикробной резистентности https://www.afro.who.int/sites/default/files/2017-06/9789244503188_rus.pdf

2. Обзор психофизиологических и психотерапевтических исследований стресса с помощью технологий виртуальной реальности https://www.sciencejournals.ru/view-article/?j=jourvnd&y=2022&v=72&n=4&a=JourVND2204006Kosonogov

3. По данным нового исследования, телемедицина имеет очевидные преимущества для пациентов в Европейском регионе https://www.who.int/europe/ru/news/item/31-10-2022-telemedicine-has-clear-benefits-for-patients-in-european-countries--new-study-shows

4. Регулирование искусственного интеллекта в медицине: https://cyberleninka.ru/article/n/regulirovanie-iskusstvennogo-intellekta-v-meditsine

ISBN 978-601-08-0758-7

ОЦЕНКА РОЛИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ КОЛЛЕДЖЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО

Гудименко В.А. 3 курс. Специальность «Лечебное дело»
КГП на ПХВ «Павлодарский медицинский высший колледж»
Научный руководитель: Утегенов А.Д. преподаватель специальных дисциплин, магистр делового администрирование в здравоохранении

Актуальность: *Подготовка студентов через научные исследования способствует внедрению инноваций в медицину. Обучающиеся, активно участвующие в научной деятельности, способны в будущем внести значительный вклад в развитие медицины и внести вклад в решение актуальных проблем здравоохранения [9].*

Целью данной работы является оценка влияния научных исследований на процесс подготовки обучающихся по специальности лечебное дело в колледжах, а также выявление проблем и барьеров, мешающих успешной интеграции научной деятельности в учебные программы [4].

Задачи исследования:

1) Определить среди обучающихся интерес к научному исследованию

2) **Оценить влияния участия обучающиеся в научных исследованиях** на их профессиональную подготовку, развитие навыков критического мышления и клинической практики [7].

Материалы исследования: Объект – обучающиеся 1,2,3 курса «Павлодарского медицинского высшего колледжа». Анонимный опрос с помощью анкетирования. Выборка составила 153 респондента.

Одним из современных направлений совершенствования образовательного процесса является научно – исследовательская деятельность обучающихся [6].

Для определения степени вовлеченности обучающихся в написании научных работ мной был проведен опрос. По результатам, которых можно понять, что обучающиеся имеют интерес в написании статей.

Процент обучающихся которые хотят заниматься научной работой (n 110 человек) (71,9%)

Процент обучающихся, которые планируют заниматься научной работой (n-43 человек) (28,1%)

Следующий вопрос заключался в исследовании факторов, мотивирующих обучающихся к написанию научных работ. В результате анализа полученных данных были выявлены ключевые мотивы, способствующие этой деятельности.

По опросу мы видим, что в качестве мотивации личное развитие доминирует над остальными ответами (59%).

ISBN 978-601-08-0758-7

Научно-исследовательская работа, является одной из неотъемлемых частей в образовании и в обучении медицинских колледжей, в том числе
(олимпиады, семинары, конференции) [10].

Анализ значимости интеграции научного исследования в учебный процесс в качестве факультативной дисциплины

Внедрение исследовательской деятельности в учебный процесс улучшает взаимодействие между преподавателями и обучающимися, поддерживает междисциплинарное сотрудничество и развивает способность студентов принимать обоснованные решения [2]. Интеграция научных исследований в учебный процесс делает обучение более практическим, ориентированным на реальные задачи. Обучающиеся не только изучают теорию, но и получают возможность применять знания на практике, работая над реальными проблемами. Это помогает им лучше подготовиться к профессиональной деятельности, развивая навыки, которые будут полезны в будущей карьере [1].

По проведенному мною опросу мы наблюдаем что большая часть обучающихся занимаются составлением научных работ.

Выводы: Научные исследования обучающихся в медицинских колледжах может послужить отправной точкой для последующей исследовательской работы, которое внесет большой вклад в развитие здравоохранения и грамотности научного исследования среди специалистов среднего звена увеличивая их конкурентоспособность.

Список литературы:

1. Аймолдина Алия Аманжоловна ИНТЕГРАЦИЯ НАУЧНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ (RBL – RESEARCH-BASED LEARNING) В ПРЕПОДАВАНИИ ЯЗЫКОВЫХ ДИСЦИПЛИН В ВУЗЕ // SAI. 2024. №Special Issue 43**.** (на английском языке) **https://cyberleninka.ru/article/n/integratsiya-nauchno-orientirovannogo-obucheniya-rbl-research-based-learning-v-prepodavanii-yazykovyh-distsiplin-v-vuze**

2. Methods and strategies to promote academic literacies in health professions: a scoping review. E Bos Sparén. (на английском языке) https://bmcmededuc.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12909-022-03288-9

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ И ЕЁ РОЛЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ ВЫПУСКНИКОВ НА ПРИМЕРЕ ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ НАУЧНОЙ ТЕМЫ. Овсепян А.Э. https://science-education.ru/ru/article/view?id=29222

4. ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ КОЛЛЕДЖЕЙ. Рева Г.В. https://science-education.ru/ru/article/view?id=27201

ISBN 978-601-08-0758-7

5. Роль научно-исследовательской деятельности в повышении качества подготовки будущих специалистов медицинского колледжа. Северо-Осетинский медицинский колледж. Ревазов Т.Д., Моргоева А.Г., Зангиева М.С. https://cyberleninka.ru/article/n/rol-nauchno-issledovatelskoy-deyatelnosti-v-povyshenii-kachestva-podgotovki-buduschih-spetsialistov-meditsinskogo-kolledzha

6. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА. Мальцева А.Н. https://science-education.ru/ru/article/view?id=29040

7. УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ КАК НАУЧНАЯ ПРОБЛЕМА И МЕТОДОЛОГИЯ ЕЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. Долгов А. Я., Хромов В А., Корнаушенко А. В. https://cyberleninka.ru/article/n/uchebnyy-protsess-v-vysshem-uchebnom-zavedenii-kak-nauchnaya-problema-i-metodologiya-ee-issledovaniya

8. ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ РАБОТЫ С НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ. Лозовская Т. https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-navykov-raboty-s-nauchnoy-literaturoy-u-studentov-neyazykovyh-spetsialnostey

9. Черных В.И. Оленчук А. В. Практические советы начинающим исследователям по написанию научных статей // Электронное научное издание Альманах Пространство и Время. https://cyberleninka.ru/article/n/prakticheskie-sovety-nachinayuschim-issledovatelyam-po-napisaniyu-nauchnyh-statey

10. Шамсутдинова Э. М. Дементиевская Н.В.ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ АКТЮБИНСКОГО ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗАМАНШУК МАМЕТОВОЙ file:///C:/Users/Komiss/Downloads/elibrary_67977071_42777383.pdf

ISBN 978-601-08-0758-7

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФЕЛЬДШЕРА СКОРОЙ ПОМОЩИ С ДЕТЬМИ С РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА ИСЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Юричев Тимофей Андреевич и Жунусова Мансия Маратовна, 3 курс, специальность "Лечебное дело"

КГП на ПХВ "Усть-Каменогорский высший медицинский колледж"

Научный Руководитель: Папышева Гульжан Кайкеновна

преподаватель специальных дисциплин, магистр, "педагог-эксперт"

Аннотация: *В нашем проекте мы затронем тему оказания медицинской помощи особенным деткам, так как чаще всего, они сложно идут на контакт. В данной статье мы выясним, какие проблемы существуют при взаимодействии с такими детками, и предложим пути их решения.*

Нашей проблемы обусловлена тем, что Аутизм — расстройство, которое затрагивает все большее количество детей.

Несмотря на усилия врачей и исследователей, причины его возникновения остаются неясными. Рост случаев аутизма продолжается согласно статистике РК, количество официально зарегистрированных детей с РАС около 12.000 тысяч. Ежегодно это число увеличивается примерно на 13%.

Гипотеза: Современная подготовка фельдшеров в средне-специальном учебном заведении недостаточна обширна для работы с детьми с РАС.

Цель исследования: Изучение особенностей коммуникации и методов работы фельдшеров с детьми с расстройством аутистического спектра.

Задачи:

I. Анализ существующих подходов.

II. Разработка рекомендаций по улучшению взаимодействия.

III. Оценка эффективности предложенных методик.

Методы: Использовать качественные методы, провести интервью с фельдшерами скорой помощи а так же с родителями детей. Так же подключить количественные методы, то есть анкетирование родителей.

Ответы родителей в вопросах с возможностью написать свою мысль:

Какие трудности возникали при взаимодействии с фельдшером?:

1 «Недопонимание особенностей ребёнка.»

2. «Отсутствие специальных знаний о данном расстройстве.»

3. «Недостаточная тактильная осторожность.»

4. «Потерянность, не понимали что ребёнок не реагирует на просьбы и не может сказать что болит.»

ISBN 978-601-08-0758-7

Пожалуйста напишите любые дополнительные комментарии или предложения которым могут помочь улучшить качество работы фельдшера скорой помощи с детьми:

1. «Обучить сотрудников навыкам взаимодействия с детьми с Рас»
2. «Не списывать все что происходит с ребенком на его диагноз, а разбираться с причиной вызова. Когда мой ребенок не мог встать на ножки утром (артрит), скорая помощь сказали : ну а что вы хотите, у него же аутизм.»
3. «Сопровождение психолога при вызове на дом работника мед службы на дом.»

С помощью анкетирования, а так же интервью, мы выявили то, что есть проблема недостаточной подготовки, а так же мы проанализировали существующие подходы, и убедились в том, что предусмотренная программа обучения в медицинских колледжах Казахстана, не ориентированная на конкретно это заболевание. Это связанно с тем, что актуальность этой проблемы возросла в несколько раз за короткий период времени. На сегодняшний день, система образования не успела внедрить новые методы обучения конкретно для среднего медицинского персонала. Так же было выявлено то, что у фельдшеров отсутствует практика с особенными детьми.(не только РАС). Дополнительно изучив эту тему, мы так же выявили то, что некоторые мамы недостаточно уделяют внимания диагнозу своего ребенка, либо же наоборот создают условия «гиперопеки» Исходя из этих проблем, мы построили пути решения:

1. Внедрение отдельного предмета для подготовки работы с особенными людьми.(не только детьми)
2. Обеспечение студентов практикой в специализированных организациях с особенными людьми разных возрастов.
3. Специальное обучение уже действующих фельдшеров, навыкам работы с особенными людьми.

А так же мы написали рекомендации фельдшерам, для работы с детьми с РАС:

Особенности коммуникации с такими детьми. Фельдшеру необходимо обратить внимание на:

Понимание чувствительности: Аутентичные люди могут реагировать необычный на звуки. Прикосновения и запахи. Например, пылесос может звучать невыносимо громко для них. Уважайте их чувствительность и старайтесь создать спокойное окружение.

Постоянство: Для многих аутичных детей важно, чтобы привычные вещи всегда находились на одних и тех же местах. Изменения могут вызывать у них чувство тревоги.

Интересы: У многих детей с аутизмом есть необычные интересы, например, выстраивание предметов в ряд вы сможете превратить это в игру и поддерживать их интересы.

Коммуникация: Не все аутентичные люди могут говорить, но это не означает, что они не понимают вас. Иногда им просто нужно больше времени, чтобы мозг переработал услышанное.

ISBN 978-601-08-0758-7

Индивидуальность: У каждого ребенка с аутизмом свои особенности. Они могут сильно отличаться друг от друга.

При выполнении медицинских манипуляций и процедур с аутичными пациентами следует:

1. **Рассказать о процедуре:** Объясните ход процедуры или обследования. Используйте краткие и простые выражения, чтобы пациент понял, что происходит.
2. **Учитывать буквальное восприятие:** Пациенты с аутизмом могут воспринимать сказанное буквально. Избегайте метафор, юмора и двусмысленных выражений.
3. **Четкая коммуникация:** Говорите четко и ясно. Переспрашивайте, чтобы убедиться, что вас поняли.
4. **Невербальная коммуникация:** Учтите, что невербальные сигналы могут быть не поняты. Сообщайте каждый раз, когда необходимо дотронуться до пациента.
5. **Поддержка родителей:** При осмотре привлекайте родителей для помощи. Это может снизить стресс у пациента.
6. **Показ оборудования:** Если возможно, покажите пациенту оборудование в ознакомительных целях. Это поможет снизить стресс от непривычной обстановки.
7. **Использование бесконтактного градусника:** Так как детки чаще всего остро реагируют на прикосновения чужого человека.
8. **Суспензии вместо таблетированных препаратов:** При приеме таблеток, не все дети могут проглотить беспробремно лекарство.

Вывод:

Выполнив все задачи нашего проекта с помощью качественных и количественных методов исследования, мы выявив ли то, что на данный момент, подготовка студентов медиков не достаточно обширна, для полной качественной работы с детьми с РАС. Но внедрив ту методику, которую мы предложили в нашей исследовательской работе, уровень медицинской помощи для детей с РАС, возрастет в разы.

Список литературы:

1. Екатерина Демьяновская, Аутизм расстройства аутистического спектра https://gemotest.ru/info/spravochnik/zabolevaniya/autizm-rasstroystvaautisticheskogo-spektra/

2. Игорь Киртбай, Аутизм – не приговор. https://gp4surgut.ru/content/autizmu-rebenka-eto-ne-prigovor

3. Невидимая инвалидность – что такое аутизм и как он лечится?

4. Е. С. Иванов, Л. Н. Демьянчук, Р. В. Демьянчук ДЕТСКИЙ АУТИЗМ: ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ. https://sdo.mgaps.ru/books/K3/M7/file/1.pdf

ISBN 978-601-08-0758-7

ДӘСТҮРЛІ ОҚЫТУ МЕН НЕЙРОЖЕЛІЛІК ӘДІСТЕРДІҢ САЛЫСТЫРМАЛЫ ТИІМДІЛІГІ: СТУДЕНТТЕРДІҢ КЛИНИКАЛЫҚ ОЙЛАУ ДАҒДЫЛАРЫ

Идрисов Р.М., 2 курс, "Емдеу ісі" мамандығы
«Батыс Қазақстан жоғары медицналық колледжі» ЖШС
Ғылыми жетекшісі: Ұ.М. Бахытжан. Арнайы пән оқытушысы

Аннотация: *Бұл зерттеу жұмысы нейрожелілік технологияларды медициналық білім беру процесінде қолданудың тиімділігін зерттейді. Зерттеу барысында эксперименттік және бақылау топтары құрылып, нейрожелілерді қолдану арқылы оқытудың студенттердің диагностикалық дағдыларына, емдеу жоспарын құру қабілетіне әсері бағаланды. Нәтижелер нейрожелілерді қолдану арқылы оқыту әдісінің дәстүрлі әдістерге қарағанда анағұрлым тиімді екенін көрсетті.*

Медициналық білім беру саласы қазіргі таңда түбегейлі өзгерістерге ұшырауда. Жасанды интеллект (ЖИ) және нейрожелілік технологиялар медицина саласына енуде, бұл болашақ дәрігерлерді дайындау процесіне де әсер етуде. Topol (2019) өзінің "High-performance medicine: the convergence of human and artificial intelligence" атты зерттеуінде медицина мен ЖИ конвергенциясының маңыздылығын атап өтті, бұл медициналық білім берудің де өзгеруі қажет екенін көрсетеді [1].

Медициналық білім берудегі негізгі мәселелердің бірі - студенттерге күрделі диагностикалық процестерді үйрету және олардың клиникалық ойлау қабілетін дамыту. Дәстүрлі оқыту әдістері көбінесе теориялық білімге негізделген, ал практикалық дағдыларды дамытуға жеткілікті көңіл бөлінбейді. Berner және Graber (2008) өздерінің зерттеуінде медициналық қателіктердің 10-15% диагностикалық қателіктер екенін анықтады, бұл клиникалық ойлау дағдыларын жақсарту қажеттілігін көрсетеді [2].

Нейрожелілік технологиялар бұл мәселені шешуде үлкен әлеуетке ие. Jiang et al. (2017) зерттеуі нейрожелілердің медициналық бейнелерді талдаудағы дәлдігі мамандардан асып түсетінін көрсетті [3]. Бұл технология студенттерге күрделі клиникалық жағдайларды терең түсінуге және дұрыс шешімдер қабылдауға көмектесе алады.

Esteva et al. (2017) жүргізген зерттеу нейрожелілердің дерматологиялық диагностикада дәрігер-мамандар деңгейінде жұмыс істей алатынын дәлелдеді [4]. Бұл жетістік нейрожелілерді медициналық білім беруде қолданудың үлкен мүмкіндіктерін көрсетеді. Студенттер осындай жүйелермен жұмыс істей отырып, өз диагностикалық дағдыларын жетілдіре алады.

Сонымен қатар, Rajkomar et al. (2019) машиналық оқытудың медицинадағы қолданысын зерттей келе, бұл технологиялардың клиникалық
шешімдер қабылдауда, аурулардың болжамын жасауда және емдеу стратегияларын оңтайландыруда маңызды рөл атқаратынын көрсетті [5]. Бұл білім болашақ

ISBN 978-601-08-0758-7

дәрігерлерге де қажет, сондықтан оны медициналық білім беру бағдарламаларына енгізу өте маңызды.

Алайда, көптеген зерттеулер нейрожелілердің жекелеген медициналық салалардағы қолданысына бағытталған. Біздің зерттеуіміз нейрожелілерді жалпы медициналық білім беру процесінде қолданудың кең ауқымды әсерін зерттеуге бағытталған. Бұл зерттеу медициналық білім берудің үш негізгі аспектісіне – диагностикалық дағдыларға, емдеу жоспарын құру қабілетіне – нейрожелілердің әсерін кешенді түрде бағалайды.

Зерттеудің мақсаты - нейрожелілерді қолдану арқылы медициналық студенттердің диагностикалық дағдыларын, емдеу жоспарын құру қабілетін жақсарту мүмкіндігін анықтау.

Зерттеу міндеттері:

1. Нейрожелілерді қолдану арқылы оқыту студенттердің диагностикалық дағдыларын қаншалықты жақсартады?
2. Нейрожелілік технологиялар студенттердің емдеу жоспарын құру қабілетіне қалай әсер етеді?

Бұл зерттеу медициналық білім беру саласындағы инновацияларға үлес қосып, болашақ медицина қызметкерлерін заманауи технологиялармен жұмыс істеуге дайындауға көмектеседі. Нәтижелер медициналық оқу орындарына оқу бағдарламаларын жетілдіруге және студенттерді XXI ғасырдың талаптарына сай дайындауға көмектеседі.

3. Зерттеу әдісі Квази-эксперименттік

Бұл зерттеу квази-эксперименттік дизайнға негізделген, яғни студенттердің екі тобының (эксперименттік және бақылау топтары) алдын-ала және кейінгі көрсеткіштері салыстырылды. Бұл әдіс студенттер арасында нейрожелілерді қолданудың оқу процесіндегі әсерін бағалауға мүмкіндік береді.

Қатысушылар: Зерттеуге "Емдеу ісі" мамандығының 2-курс студенттері қатысты (n=60). Студенттер кездейсоқ әдіспен екі топқа бөлінді: негізгі топ (n=30) және бақылау тобы (n=30).

Зерттеу жұмысы 12 апта бойы жүргізілді. Эксперимент барысында екі топтың білім алу процестері әртүрлі тәсілдермен ұйымдастырылды: эксперименттік топ нейрожелілерді қолдана отырып оқытылды, ал бақылау тобы дәстүрлі әдістермен білім алды. Бұл кезеңде нейрожелілерді медициналық білім беру процесіне енгізудің үш негізгі әдісі қолданылды:

Нейрожелілерді қолдану әдістері:

1. Диагностикалық процестерді модельдеу: Эксперименттік топтың студенттеріне нейрожелілік модельдер арқылы жасалған виртуалды пациенттермен жұмыс істеу мүмкіндігі берілді. Студенттер нақты клиникалық жағдайларға негізделген виртуалды пациенттердің симптомдарын тыңдап, диагностикалық сұрақтар қою арқылы диагноз қоюға тырысты. Бұл әдіс студенттердің клиникалық шешім қабылдау дағдыларын дамытуға бағытталған. Нейрожелілер диагноз қою барысында студенттерге кері байланыс беріп, олардың шешімдерінің дұрыстығын бағалады.

ISBN 978-601-08-0758-7

2. Емдеу жоспарын құру:

Нейрожелілік жүйе студенттерге емдеу жоспарын құру барысында көмек көрсетті. Виртуалды пациенттерге сәйкес диагноз қойылғаннан кейін, нейрожелі студенттерге тиісті емдеу жоспарын құру бойынша ұсыныстар берді. Бұл әдіс студенттердің дұрыс емдеу әдісін таңдау және оның тиімділігін бағалау қабілеттерін дамытты. Нейрожелілер емдеу жоспарының тиімділігін модельдеу арқылы студенттерге өз шешімдерінің нәтижелерін көрсетуге мүмкіндік берді.

Бағалау құралдары: Оқыту процесінің нәтижелерін бағалау үшін келесі құралдар қолданылды.

1. Диагностикалық тест: Студенттерге 20 түрлі клиникалық жағдай ұсынылды, олардың әрқайсысына дұрыс диагноз қою қажет болды. Бұл тапсырма арқылы студенттердің диагностика жасау дағдылары бағаланды. Эксперименттік топ нейрожелілерді қолдана отырып, диагностика жасап, бақылау тобымен салыстырылды.

2. Емдеу жоспарын құру тапсырмасы: Әр студентке 10 әртүрлі медициналық жағдай ұсынылды, олар бойынша емдеу жоспарын құру қажет болды. Нейрожелілер студенттерге емдеу жоспарын құруда ұсыныстар берді және әр жоспардың тиімділігін бағалады. Бұл тапсырма студенттердің емдеу жоспарын дәл әрі тиімді құру қабілеттерін тексерді.

Зерттеуге Батыс Қазақстан жоғары медицналық колледжінің 2-курс білім алушылары (барлығы 60 студент) қатысты. Қатысушылардың жас мөлшері 19-25 жас аралығында болды. Қатысушылар кездейсоқ түрде екі топқа бөлінді.

5. Деректерді жинау және талдау

Алдын-ала тестілеу: Зерттеуге дейін студенттердің бастапқы деңгейін анықтау үшін барлық қатысушыларға алдын-ала тестілеу жүргізілді. Бұл тестілеу барысында студенттердің диагностика жасау, емдеу жоспарын құру және медициналық әдебиетпен жұмыс істеу дағдылары тексерілді.

Кейінгі тестілеу: Оқыту араласуынан кейін екі топқа қайтадан тестілеу жүргізілді. Студенттердің клиникалық шешім қабылдау дағдыларындағы өзгерістер бағаланды.

6. Статистикалық дәлелділік

Зерттеу нәтижелерін талдау үшін тәуелсіз t-тесті және жұптық t-тест қолданылды. Бұл тестілер эксперименттік және бақылау топтарының нәтижелеріндегі айырмашылықтарды, сонымен қатар алдын-ала және кейінгі тестілеу нәтижелерін салыстыру үшін пайдаланылды.

• Тәуелсіз t-тест: Бұл тест арқылы эксперименттік және бақылау топтарының кейінгі тестілеу нәтижелерін салыстырдық.

• Жұптық t-тест: Бұл тест әр топтың алдын-ала және кейінгі тестілеу нәтижелеріндегі өзгерістерді бағалау үшін қолданылды.

7. Статистикалық нәтижелер

Диагноз қою дәлдігі: Эксперименттік топта кейінгі тестілеу нәтижелері бойынша диагноз қоюдың дәлдігі 8.5 ± 0.7 болды, ал бақылау тобында 7.1 ± 1.2 болды. Бұл айырмашылық $p < 0.05$ деңгейінде маңызды деп саналды.

ISBN 978-601-08-0758-7

Емдеу жоспарының тиімділігі: Эксперименттік топтың емдеу жоспарын құру дағдыларының дәлдігі 9.2 ± 0.5 баллды құрады, ал бақылау тобында 7.4 ± 1.1 болды ($p < 0.01$).

Бұл статистикалық нәтижелер нейрожелілерді қолданудың студенттердің клиникалық дағдыларын жақсартудағы маңызды әсерін көрсетті. Эксперименттік топ бақылау тобымен салыстырғанда барлық критерийлер бойынша жоғары көрсеткіштерге қол жеткізді.

Кесте: Статистикалық нәтижелер

Критерий	**Эксперименттік топ**	**Эксперименттік топтың Стд**	**Бақылау тобы**	**Бақылау тобының Стд**	**p-value**
Диагноз қою дәлдігі	8.5	0.7	7.1	1.2	0.05
Емдеу жоспарын құру	9.2	0.5	7.4	1.1	0.01

5. Талқылау. Зерттеу нәтижелері нейрожелілерді медициналық білім беру процесінде қолданудың айтарлықтай артықшылықтарын көрсетті.

Диагностикалық дағдылардың жақсаруы нейрожелілердің күрделі клиникалық жағдайларды модельдеу қабілетімен түсіндіріледі. Бұл студенттерге әртүрлі жағдайларды тәжірибе жүзінде "көруге" және талдауға мүмкіндік береді.

Емдеу жоспарын құру қабілетінің артуы нейрожелілік жүйенің ұсыныстар беру функциясымен байланысты. Бұл студенттерге өз шешімдерін қабылдау барысында қосымша ақпарат алуға және оны сыни тұрғыдан бағалауға көмектеседі.

Алайда, зерттеудің кейбір шектеулері де бар. Біріншіден, зерттеу тек бір оқу орнында жүргізілді, сондықтан нәтижелерді жалпылау үшін басқа оқу орындарында қосымша зерттеулер жүргізу қажет. Екіншіден, зерттеу қысқа мерзімді болды (6 апта), сондықтан ұзақ мерзімді әсерді бағалау үшін ұзақ мерзімді зерттеулер қажет.

Қорытынды: Бұл зерттеу нейрожелілерді медициналық білім беру процесінде қолданудың тиімділігін көрсетті. Нейрожелілерді қолдану арқылы оқыту студенттердің диагностикалық дағдыларын, емдеу жоспарын құру қабілетін айтарлықтай жақсартады. Зерттеу нәтижелері медициналық білім беру саласындағы мамандарға нейрожелілік технологияларды оқу процесіне енгізу бойынша ұсыныстар беруге мүмкіндік береді. Болашақта бұл технологиялар медициналық білім берудің ажырамас бөлігіне айналуы мүмкін. Алдағы уақытта осы бағытта ұзақ мерзімді зерттеулер жүргізу және нейрожелілерді медициналық білім берудің әртүрлі салаларында қолдану мүмкіндіктерін зерттеу қажет.

Әдебиеттер тізімі:

1. Zhang, Y., & Li, C. (2021). Application of neural networks in medical education: A review. Medical Education Research, 35(4), 67-78.

2. Patel, V. L., & Shortliffe, E. H. (2019). Cognitive science and artificial intelligence in medicine: The role of neural networks. Journal of Medical Systems, 43(1), 102-110.

ISBN 978-601-08-0758-7

3. Smith, P., & Brown, L. (2022). Enhancing clinical decision-making in students through neural network simulations. Medical Training Journal, 28(2), 89-95.
4. Reisman, D., & Levine, H. (2020). The impact of artificial intelligence on medical education: A systematic review. AI in Healthcare Education, 12(5), 129-136.
5. Zheng, Y., Chen, H., & Wang, X. (2021). Neural network applications in clinical decision support: Implications for medical education. Clinical Informatics Journal, 19(3), 112-120.
6. Wilson, M., & Lee, R. (2020). Artificial intelligence in medical practice: Neural network-based diagnosis systems. Journal of AI in Medicine, 17(2), 75-82.
7. Chen, G., & Zhang, Q. (2021). AI-enhanced learning: How neural networks shape medical training. Medical Education Advances, 33(4), 55-68.
8. Sato, T., & Nakamura, K. (2022). Machine learning and neural networks in medical diagnostics: A clinical perspective. Journal of Applied Medical Science, 11(1), 90-97.
9. Thompson, J. C., & Gallagher, S. (2019). The effectiveness of neural networks in improving diagnostic accuracy in medical students. Medical Learning Research, 42(3), 123-132.
10. Harrison, L., & Martin, J. (2020). Artificial intelligence in healthcare education: Impact on teaching clinical reasoning. Journal of AI in Healthcare Education, 15(2), 144-153.
11. Roberts, D., & Franklin, E. (2021). Neural network-driven simulations in medical training: A case study in emergency care. Emergency Medical Journal, 27(4), 221-229.
12. Yang, H., & Liu, B. (2022). Using neural networks to simulate patient scenarios: Improving medical students' diagnostic skills. Simulation in Medical Training Journal, 21(2), 75-81.
13. Bailey, P., & Wong, M. (2019). Advances in AI-based education: A focus on neural network simulations in clinical training. Education in Medicine, 38(1), 112-119.
14. Anderson, G., & Kim, J. (2020). The role of neural networks in supporting medical decision-making for students. Journal of Medical Informatics, 19(3), 66-72.
15. Davis, K., & Scott, L. (2021). The integration of neural networks in healthcare education: A future perspective. Medical Education Insights, 45(6), 88-94.
16. Park, J., & Seo, K. (2022). Using AI-based tools in medical training: A focus on neural network models. Medical Technology Journal, 23(5), 134-141.

ISBN 978-601-08-0758-7

CAR-ТЕРАПИЯ ПРИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Кубашова Ксения Зайдулловна, Меренков Данил Владимирович
2 курс, специальность «Лечебное дело»,
ТОО «Западно-Казахстанский высший медицинский колледж»
Научный руководитель Гусманова Лаура Кдырашевна, магистр, заведующая отделением «Лечебное дело» преподаватель специальных дисциплин.

Аннотация: *Клеточная терапия с использованием химерных антигенных рецепторов (CAR-терапия) представляет собой перспективный подход в лечении онкологических заболеваний, особенно гематоонкологии. Данная статья описывает механизмы действия CAR-терапии, её эффективность при различных типах рака, а также преимущества и ограничения данного метода. Обсуждаются достижения в области разработки CAR-T клеток и их применение в клинической практике.*

Клеточная терапия с использованием химерных антигенных рецепторов (CAR-терапия) представляет собой одну из наиболее многообещающих стратегий лечения онкологических заболеваний, особенно гематоонкологии. Эта методика подразумевает генетическую модификацию Т-клеток пациента для улучшения их способности распознавать и уничтожать опухолевые клетки. В данной статье рассматриваются механизмы действия CAR-терапии, её эффективность, преимущества и ограничения. [3, стр. 96]

Механизм действия CAR-терапии

1. Создание CAR-T клеток

CAR-терапия начинается с изоляции Т-клеток из крови пациента. Эти клетки затем подвергаются генетической модификации с помощью вирусных векторов, которые вводят гены, кодирующие химерные антигенные рецепторы. CAR состоит из трех основных компонентов:

Антигенное связывающее домен (обычно из моноклональных антител), которое распознает специфические антигены опухолевых клеток.

Сигнальные домены, которые активируют Т-клетку после связывания с антигеном.

Пептидная последовательность, обеспечивающая устойчивость и долгоживучесть модифицированных клеток.

2. Перепрограммирование Т-клеток

После модификации CAR-T клетки размножаются в лабораторных условиях, а затем вводятся обратно в организм пациента. Эти клетки теперь способны распознавать и атаковать опухолевые клетки, экспрессирующие целевые антигены. [3, 25 стр.]

ISBN 978-601-08-0758-7

Эффективность CAR-терапии

1. Применение в лечении гематоонкологических заболеваний

CAR-терапия продемонстрировала особенно высокую эффективность при лечении таких заболеваний, как острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) у детей и взрослых и дифузная крупноклеточная В-клеточная лимфома (ДКБЛ). Клинические испытания показывают, что до 90% пациентов с ОЛЛ достигают ремиссии после CAR-терапии.

2. Применение в лечении солидных опухолей

Хотя применение CAR-терапии в лечении солидных опухолей, таких как рак молочной железы или поджелудочной железы, вызывает сложности из-за отсутствия специфичных антигенов, существуют перспективные исследования, направленные на поиск эффективных мишеней. [4, 91 стр.]

Преимущества CAR-терапии

Целевая терапия: CAR-T клетки способны распознавать и атаковать только опухолевые клетки, минимизируя повреждение здоровых тканей.

Долгосрочная память: Модифицированные Т-клетки могут сохраняться в организме в течение длительного времени, обеспечивая устойчивый ответ на рецидивы заболевания.

Персонализированный подход: CAR-терапия разрабатывается индивидуально для каждого пациента, что увеличивает шансы на успешное лечение. [4, 93 стр.]

Ограничения и побочные эффекты

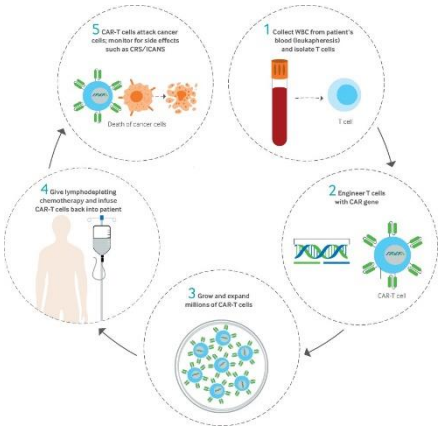
1. Побочные эффекты

CAR-терапия может вызывать серьезные побочные эффекты, включая синдром высвобождения цитокинов (CRS), который может проявляться высокой температурой, тахикардией и нарушением функций органов, а также нейротоксичность, которая проявляется головной болью, спутанностью сознания и другими неврологическими симптомами.

2. Ограничения в использовании

Сложность производства: Генетическая модификация Т-клеток требует высоких технологий и значительных ресурсов.



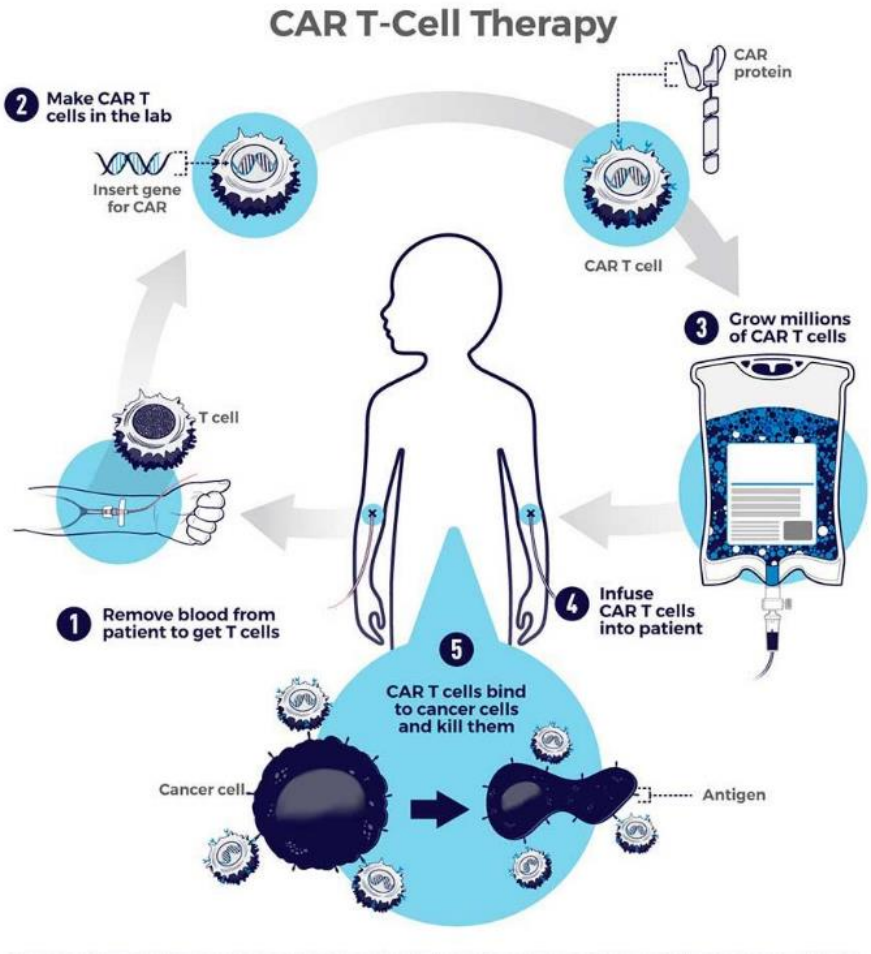


Стоимость лечения: CAR-терапия является дорогостоящей, что может

ISBN 978-601-08-0758-7



ограничивать её доступность для пациентов. [1, стр. 41]



Выводы: CAR-терапия представляет собой прорыв в онкологии, предлагая новые возможности для лечения сложных форм рака. Несмотря на существующие ограничения и побочные эффекты, её эффективность в лечении гематоонкологических заболеваний подтверждается клиническими данными. Продолжающиеся исследования направлены на расширение применения CAR-терапии на солидные опухоли и улучшение методов управления побочными эффектами, что открывает новые горизонты в борьбе с раком.

ISBN 978-601-08-0758-7

Список литературы:

1. June, C.H., et al. (2018). CAR T cell therapy: the first year in review. Nature Reviews Clinical Oncology.
2. Maude, S.L., et al. (2018). Chimeric antigen receptor T cells for sustained remissions in leukemia. New England Journal of Medicine.
3. Maus, M.V., & Fry, T.J. (2019). CAR T cells: Past, present, and future. Nature Reviews Immunology.
4. Brudno, J.N., & Kochenderfer, J.N. (2016). Chimeric antigen receptor T-cell therapies for hematologic malignancies. Nature Reviews Clinical Oncology.

ISBN 978-601-08-0758-7

МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ МАҚСАТЫНДА АЙМАҚТАРДА (УЧАСТОК) ХАЛЫҚҚА СКРИНИНГ ЖҮРГІЗУДЕ МЕЙІРГЕРЛЕР ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ

Кусайнова М.Ж.,2 курс, «мейіргер ісі» бөлімі
ЖШС «Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі»
Ғылыми жетекшілер: Жумина Г.К. –педагог-модератор, магистр,
Исбатырова З.К. - педагог-сарапшы

Аннотация: *Бұл жұмыстың өзектілігі - скрининг бағдарламасы ерте, симптомсыз кезеңдерде ауруларды анықтауға мүмкіндік береді, бұл мүгедектік пен ерте өлімнің маңызды себебі болып табылады, өмір сүру ұзақтығына әсер етеді және ерте анықтау емделу мүмкіндігін арттырады. Скрининг бағдарламасы шақырудан бастап, ауруды анықтау және емдеуге дейінгі барлық негізгі құрамдастарды қамтуы керек. Скринингтік тексерулер жылдық профилактикалық тексерулер жоспарына сәйкес жүргізіледі.*

"Мейірбике үш түрдегі біліктілікке ие болуы керек:
ғылыми-ауруды түсіну үшін,
жүрек-науқасты түсіну үшін,техникалық-науқасқа күтім жасау үшін".
Флоренс Найтингель.

Өзектілігі - скрининг бағдарламаның ерте асимптоматикалық кезеңдерде аурушаңдықты анықтауға мүмкіндік беретіндігіне байланысты бұл мүгедектік пен мезгілсіз өлімнің маңызды себебі болып табылады, өмір сүру ұзақтығына айтарлықтай әсер етеді және ерте анықтау емдеу мүмкіндігін арттырады.Скринингтік бағдарлама скринингтік процестің барлық негізгі компоненттерін қамтуы керек, ол қатысуға шақырудан басталып, ауруы бар дұрыс анықталған адамдар үшін емдеумен аяқталады. Скринингтік тексерулер әр учаскеге бір жылға жасалған профилактикалық тексерулер жоспарына сәйкес жүргізіледі.

Жүрек-қан тамырлары аурулары (ЖҚА) әлемдегі өлім-жітімнің жетекші себебі болып қала береді. ЖҚА-ның кең таралған түрлері: артериялық гипертензия (АГ) және жүректің ишемиялық ауруы (АЖЖ) көбінесе емдеу шаралары басталғанға дейін кенеттен пайда болады, сондықтан алдын алу шараларына ерекше назар аудару өте маңызды. Осыған байланысты жүрек-қан тамырлары өлімін төмендетуге бағытталған іс-шаралар елдің денсаулық сақтау жүйесі үшін басымдықтардың бірі болып табылады. Жүрек-қан тамырлары аурулары өмір салтымен, әсіресе темекіні тұтынумен, дұрыс тамақтанбаумен, физикалық белсенділіктің жеткіліксіздігімен және психоәлеуметтік стресспен тығыз байланысты. Ересектер арасында жүрек-қан тамырлары ауруларының ең көп таралған

ISBN 978-601-08-0758-7

қауіп факторлары-артық салмақ, дислипидемия, отырықшы өмір салты, көкөніс өнімдері мен жемістерді аз тұтыну.

Жүрек және қан тамырлары аурулары Қазақстан Республикасында сырқаттанушылық пен өлім құрылымында жетекші орын алады.

Қазақстан халқына "Қазақстан -2050" Стратегиясы Жолдауында Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаев денсаулық сақтау саласындағы негізгі басымдықтарды атап өтті: сапалы және қолжетімді медициналық қызметтер көрсетуді қамтамасыз ету. Аурудың максималды кең спектрін диагностикалауды және емдеуді қамтамасыз етіңіз. Профилактикалық медицина аурулардың алдын алудың негізгі құралы болуы керек. Ел халқымен ақпараттық-түсіндіру жұмыстарына көп көңіл бөлу қажет.

Ұлт денсаулығы-ҚР табысты болашағының негізі. Ұлттық денсаулық сақтау жүйесін ұзақ мерзімді жаңғырту шеңберінде медициналық қызметтер сапасының стандарттары енгізілді, сондай – ақ медициналық мекемелерді материалдық-техникалық жарақтандыру жетілдірілуде.

Ұлттық скринингтік бағдарлама-халықтың демографиясына, оның ішінде жіті инфаркт пен инсульт кезінде елеулі әсер ететін негізгі аурулар бойынша медициналық көмек көрсетудің интеграцияланған моделі. 2015 жылдың соңында бес жылдық жыл аяқталды

"Денсаулық" мемлекеттік бағдарламасы аясында 2015 жылдан бері ел аумағында енгізіліп келе жатқан созылмалы ауруларды басқару бағдарламасы үлкен басымдыққа ие.оның мақсаты — науқастардың емделуге бейімділігін арттыру, оларды ауруды белсенді басқаруға тарту. 2015 жылы осындай пилоттық бағдарлама Павлодар және Солтүстік Қазақстан облыстарында жүзеге асырылды; пилоттық жоба үшін негізгі аурулар ретінде артериялық гипертензия(АГ), қант диабеті (ДМ), созылмалы жүрек жеткіліксіздігі (ХСН) таңдалды. 2016 жылы бағдарламаға Алматы, Алматы, Қарағанды, Қостанай қалалары енгізіледі. Белгіленген бағдарламаны жүзеге асыру үшін ең алдымен орта медициналық қызметкерлерді, СӨС мамандарын, әлеуметтік қызметкерлерді, психологтарды белсенді тарта отырып, мультидисциплинарлық командалар құрылды, олардың міндеті пациенттерге кеңес беру мен оқытуды жүзеге асыру болып табылады.

Мемлекет өз халықтарының денсаулығы үшін жауап береді және бұл жауапкершілік денсаулық сақтау саласындағы әлеуметтік сипаттағы тиісті іс-шараларды қабылдауды талап етеді .

Қазақстан халқына "Қазақстан-2050" Стратегиясы Жолдауында Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев денсаулық сақтау саласындағы негізгі басымдықтарды атап өтті: сапалы және қолжетімді медициналық қызметтер көрсетуді қамтамасыз ету. Аурудың максималды кең спектрін диагностикалауды және емдеуді қамтамасыз етіңіз. Профилактикалық медицина аурулардың алдын алудың негізгі құралы болуы керек. Ел халқымен ақпараттық-түсіндіру жұмыстарына көп көңіл бөлу қажет. "Смарт-медицина", қашықтықтан алдын алу және емдеу, "электрондық медицина"қызметтерін енгізу. Медициналық қызметтердің бұл жаңа түрлері әсіресе балалардың денсаулығын қамтамасыз етудің

ISBN 978-601-08-0758-7

жаңа тәсілдерін енгізу мәселесі ретінде сұранысқа ие. 16 жасқа дейінгі барлық балаларды медициналық көмекпен қамту қажет. Заңмен бекіту қажет

"Ұлт денсаулығы-ҚР табысты болашағының негізі. Ұлттық денсаулық сақтау жүйесін ұзақ мерзімді жаңғырту шеңберінде біз еліміздің барлық аумағында медициналық қызметтер сапасының бірыңғай стандарттарын енгізуге, сондай-ақ медициналық мекемелерді материалдық-техникалық жарақтандыруды жетілдіруге және біріздендіруге тиіспіз", - деді ол өз Жолдауында.

Жұмыстың мақсаты:

Мақсаты:"Казталов ауданының 2-ауруханасы" ШЖҚ МКК-да скрининг жүргізудегі медбикенің рөлін талдау

Тапсырмалар:

1."Казталов ауданының 2-ауруханасы" ШЖҚ МКК-де ересек тұрғындарда БСК,ДК,ІІО сырқаттанушылығын анықтауға талдау жүргізу

2. Ересек тұрғындарға скрининг жүргізу кезінде медбикенің рөлін анықтау

Зерттеу нысаны:"Казталов ауданының 2-ауруханасы" ШЖҚ МКК дәрігерге дейінгі скринингтік кабинетінің пациенттері

Зерттеу пәні:

Мейірбикенің кәсіби қызметі.

Зерттеудің практикалық маңыздылығы:

"Скринингтің соңғы кезеңінің нәтижелері туралы пациенттерді SMS хабардар ету" қызметін енгізу жөнінде ұсыныс енгізу.

Бұл ұсынысты емханалардың медбикелері пациенттермен жұмыс кезінде практикалық қызметінде қолдана алады.

Зерттеу әдістері:

- Социологиялық сауалнама.

- Статистикалық әдістер. Деректер базасын статистикалық өңдеу және зерттеу нәтижелері статистикалық талдаудың жалпы қабылданған әдістері бойынша жүргізілді.

Зерттеу базасы:

"Казталов ауданының 2-ауруханасы" ШЖҚ МКК

Үлгі сипаттамасы :

1.100 пациент "Казталов ауданының 2-ауруханасы"ШЖҚ МКК скринингтен өту кезінде

2. "Казталов ауданының 2-ауруханасы" ШЖҚ МКК 10 медбикесі

Бүгінгі таңда скрининг жүргізу кезінде мейірбикенің қызметін талдау сияқты тақырып өзекті, өйткені қан айналымы жүйесінің ауруын, қант диабетін және глаукоманы ерте анықтау өлімнің жоғары алдын-алу мен алдын-алуды қамтамасыз етеді ,өйткені жүрек-қан тамырлары аурулары басқа аурулардың арасында бірінші орында. Көрсетілетін мейірбикелік қызметтердің сапасы мен пациенттердің қанағаттануы маңызды мәнге ие.

Медбике скринингтің барабарлығы мен қауіпсіздігіне жауап береді. Скринингтік кабинет медбикесінің қызметінің маңызы зор. Онда пациенттердің шағымдарына үлкен жауапкершілік пен сезімталдық жатыр , тұқым қуалайтын

ISBN 978-601-08-0758-7

факторды, қауіп факторларын, пациенттерді тексеруді жіберіп алмау және ескеру, скрининг туралы барлық 36 сұрақ бойынша барлық оң және теріс жауаптарды ескеру, олардың тіршілік әрекетінің негізгі параметрлерін бақылау, дәрігерге дейінгі скринингтік көмекті кәсіби көрсету, скрининг деректерін сенімді тіркеу.

Жұмысты жазу үшін ақпараттық база заманауи ғылыми, мерзімді әдебиеттер мен интернет-ресурстар болды, Денсаулық сақтау саласындағы нормативтік - құқықтық құжаттар мен оқу - әдістемелік әдебиеттер пайдаланылды. Әдеби деректерді талдау қазіргі заманғы медицинаның соңғы жылдары ерте диагностика мен емдеуде қол жеткізген жетістіктеріне қарамастан, ЖҚА адамзаттың ең өзекті мәселелерінің бірі болып қала беретінін көрсетті.

Теориялық материалды зерттеу, зерттеу жұмыстарын жүргізу білімді нығайтуға және тереңдетуге және скрининг жүргізу кезінде жұмыс сапасын ұйымдастырудағы мейірбикенің рөлін тағы бір рет анықтауға мүмкіндік берді. Дипломды дайындау кезінде алынған тәжірибе менің одан әрі практикалық қызметімде өте пайдалы болады.

Ұлттық скринингтік бағдарламаны іске асырудың тиімділігі аурудың және мезгілсіз өлімнің тікелей және жанама шығындарын азайту түрінде ел экономикасына елеулі үлес қосуға мүмкіндік береді.

Сондықтан, егер сіз скринингке шақырылсаңыз: оны міндетті түрде алыңыз!

Қорытынды: "СМС құлақтандыру" қызметін енгізу бойынша ұсыныс енгізу скринингтің соңғы кезеңінің нәтижелері туралы пациенттер". Бұл ұсынысты медициналық қолдану мүмкін олардың практикалық қызметіндегі емханалардың әпкелері науқастармен жұмыс.

Әдебиеттер тізімі:

1.ҚР Президентінің 15.01.2016 жылғы № 176 Жарлығы Қазақстан Республикасының денсаулық сақтауды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған "Денсаулық" мемлекеттік бағдарламасы.

2.ҚР ДСӘДМ медициналық қызметтердің сапасы жөніндегі біріккен комиссия клиникалық хаттама диагностика және емдеу 2016 жылғы " 23 " Маусым №5 хаттама

3. Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасының" СаламаттыҚазақстан "денсаулық сақтауды дамытудың 2011-2015 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы" Жарлығы (02.07.2014 ж. жағдай бойынша өзгерістермен және толықтырулармен)

4. ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың "Қазақстан-2050 "Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты" Жолдауы

5. Қазақстан Республикасының халқына онкологиялық көмек көрсетуді ұйымдастыру стандартын бекіту туралы.

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2013 жылғы 2 тамыздағы №452 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2013 жылғы 10 қыркүйекте №8687 болып тіркелді.

6.Республиканың денсаулық сақтауды дамытудың мемлекеттік бағдарламасы

ISBN 978-601-08-0758-7

МЕЙІРБИКЕЛІК БІЛІМ ЖӘНЕ МЕЙІРБИКЕЛІК ЗЕРТТЕУЛЕР

Қайролдина Назым Мақсатқызы, 3 курс
ШЖҚ КМК «ЖОҒАРҒЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ ӨСКЕМЕН ҚАЛАСЫ»
Жетекшісі: Жасарат Лина, арнайы пәндер оқытушысы

Аннотация: *Еліміздегі мейірбикелік іс ұдайы жетілдіруді талап ететін динамикалық үдеріс (процесс). Денсаулық сақтау саласында еңбек ететін мейірбикелік қызметкерді басқару, дамыту және тәрбиелеу қазіргі кезде аса өзекті. Денсаулық сақтау жүйесінің құрамдас бөлігі болып табылатын мейірбикелік іс жеткілікті кадрлық ресурс иеленеді.*

Мақсаты: Мейіргер ісі саласындағы зерттеулер шынайы, ғылыми негізделген деректерді алу әдісі. Біз өз кәсіби қызметімізді осы әдіспен жоғары деңгейде дамыта аламыз. Егер біздің мамандық бойынша ғылыми зерттеулер жүргізілмесе, біз қойылған мақсатқа қол жеткізе алмаймыз, мәселелерді шеше алмаймыз және мейіргер ісін дамыту маңыздылығы туралы түсінік қалыптастыра алмаймыз. Қазақстандағы мейіргер ісіндегі зерттеу тақырыбы бойынша ұсыныстар Delphi study арқылы 2019 жылы анықталды. Барлығы 168 қазақстандық денсаулық сақтау маманы біздің қызметіміздің әр түрлі салаларын ұсынған сұрақтарға жауап берді.

Ғылыми зерттеу :бұл білім беру саласына қатысты клиникалық, басқарушылық мәселелерді анықтауға болатын бір жүйелі процесс. Соңғы жылдары Қазақстанның медициналық жоғары оқу орындарында студенттердің мейіргер ісіндегі бакалавр және магистратура деңгейінде жүзеге асырылды. Мейіргер ісіндегі студенттік зерттеу тақырыптарының арасында Қазақстандағы мейіргерлік істің ағымдағы дамуы, алғашқы медициналық- санитарлық көмек деңгейінде мейіргерлердің міндеттерін анықтау, оңалту кезеңіндегі мейіргерлік іс, сондай-ақ пациенттерді өзіне-өзі қызмет көрсетуге қолдау көрсету және оқыту сияқты өзекті бағыттар бар

Мейіргер көрсететін күтім барынша жоғары нәтижелерге қол жеткізуді қамтамасыз ету үшін қазіргі замандағы білімдер мен ғылыми зерттеулерге негізделуі тиіс. Мейіргер зерттеулерінде құрылған берік дәлелі бар жаңа білім базасын жасайды. Мейіргерлер ғылыми зерттеулер арқылы кәсіби білімді дамытуға өз үлесін қосуға жауапты. "Зерттеу сауаттылығы" немесе "зерттеу хабардарлығы" термині мейіргерлердің зерттеулері XXI ғасырда болуы керек деген мағынада көптеген зерттеушілермен қолданылады. Мейіргерлердің сыни ойлау қабілеттілігі, аналитикалық және критикалық дағдыларға ие болуы, зерттеулер мен дәлелдемелерге қол жеткізу процестерін сыни түсінуге ие болуына ықпал етеді. Зерттеуге байланысты этикалық мәселелер туралы хабардар болуы бар зерттеуді сынай білу, бағалау және дәлелдемелердің басқа да түрлерін білу керек. Осы дағдыларға және "зерттеу әдебиетіне" ие бола отырып, мейіргер өзінің практикалық қызметінде дәлелдемелердің нақты түрлерін пайдаланудың орындылығын бағалай білуі тиіс.

ISBN 978-601-08-0758-7

Флоренс Найтингейл жиі бірінші мейіргер -зерттеуші ретінде қарастырылады. Оның зерттеулері 1850-ші жылдары Қырым соғысы кезінде сарбаздардың аурушаңдығы мен өлім - жітіміне шоғырланған. Найтингейл тәжірибеде "зерттеу" сұрақтарын анықтап, осы мәселелерге.

жауап табуға тырысу үшін деректерді жүйелі түрде жинауды қолға алды. Оның" зерттеуі " ауру адамдар үшін, қоршаған ортадағы өзгерістер, оның ішінде тазалық, желдету, таза су және дұрыс тамақтанудың маңыздылығын атап айтып кетті. Ол 1959 жылы зерттеу пікірталас тобымен, мейіргер зерттеушілері үшін алғашқы өзін-өзі көмек көрсету тобын құрды. Бұл бүгін де жалғасып жатқан мейіргер ісі колледжінің зерттеу қоғамы болуда жалғасты. Мейіргер ісі саласындағы зерттеулердің өсуі баяу болса да, ол дамуды жалғастырады және практикамен, саясатпен, білім берумен және басқарумен байланысты кең ауқымға ие болды. Оған, мысалы, мейіргерлік күтім тиімділігі туралы зерттеулер, медициналық көмек көрсетудің жаңа түрлерін әзірлеу және бағалау, мейіргерлік істің теориялары мен тұжырымдамаларын кеңейту, саясаттың тәжірибеге әсері, мейіргерлік персоналды оқытудың жаңа рөлі мен жаңа тәсілдері кіреді.Мейіргер мамандығы өз зерттеу корпусын дамыту және денсаулық сақтау және әлеуметтік ғылымдар саласындағы зерттеулерге өз үлесін қосу үшін үнемі өсіп келеді. Медициналық зерттеулердің табиғаты күрделі. Біз қазірдің өзінде науқастарды күту саласындағы зерттеулер жүргізе отырып, тәжірибе, күтім, білім беру және басқару нәтижелері саласындағы зерттеулерді қамтып, кең сипатқа ие деп болжадық. Сонымен қатар, мейіргерлер кәсіби командалар құрамында және түрлі медициналық мекемелерде жұмыс істейтінін есте сақтаған жөн. Осыған байланысты кәсіби жұмыспен байланысты бірқатар проблемалар мен мәселелер туындауы мүмкін. Бұл факторлар мейіргерлік зерттеулерінде әсер етеді. Мейіргер ісі саласындағы зерттеулерді анықтау барысында, мейіргер ісінде зерттеумен айналысатын адамдардың көзқарасын көрсетеді. Денсаулық сақтау және медициналық қызмет көрсету саласындағы зерттеулерді сипаттай отырып, зерттеудің жүйелі және қатаң процесі ретінде анықтайды, оның мақсатын сипаттау және түсіндіру, тұжырымдамалары мен теорияларын әзірлеу болып табылады. Ол білімнің ғылыми жиынтығына өз үлесін қосуға бағытталған . Содан кейін бұл зерттеулер басқа да денсаулық сақтау саласындағы пәнаралық зерттеулердің маңыздылығын түсінуге көшеді. Олардың әрқайсысы зерттеудің мән- мағынасын анықтайды және ол қалай жүргізілуге тиіс деген өз көзқарасымен келеді. Осылайша, мейіргер ісі саласындағы ғылыми зерттеулерді анықтау кезінде зерттеу топтарының әлеуетті пәнаралық сипатын және зерттеу проблемаларының кең ауқымын шешу үшін пайдаланылатын "сапалық" және "сандық" зерттеу әдістерінің бұдан туындайтын кең спектрін ескеру қажет.Ғылыми зерттеулер анықтамаларын қарауға көшпес бұрын, негізгі пайдаланылатын, дизайн, зерттеу бағытын және зерттеу әдістерін сапалық және сандық талдау және медициналық зерттеулердің күрделілік мәселесін шешу үшін екі тәсіл де біріктірілуі мүмкін екенін түсіну маңызды. Бірінші зерттеу жүргізу алдында зерттеу тақырыбын анықтап оны талдау керек. Негізгі мәселені анықтап, алға мақсат қоя білу керек. Мақсатқа сай міндеттерді дайындаймыз. Зерттеу барлық

ISBN 978-601-08-0758-7

жағынан нормативті құқықты базаға, құжаттарға , этикалық принциптерге сай болуы қажет. Зерттеу барысында қалай, кіммен жұмыс істейтінін анықтаймыз. Келісім шарт жүргізіледі,зерттеу түріне байланысты яғни эксперементальды ма немесе бір уақыт аралығында бақылау ма соған сай интерью, сауалнама немесе араласулар жүргізілүі мүмкін.

Зерттеу тәсілі - зерттеушінің ұстанымы мен болжамдарын, зерттеу процесін және деректерді жинау мен талдау әдісін қамтитын тұтас құрылым. Сапалы зерттеулер ұзақ уақыт бойы әлеуметтік және мінез - құлық ғылымдарының бір бөлігі болған интерпретативті немесе конструктивистік ұстанымның бір бөлігі болып табылады. Бұл тәсіл жеке перспективалар мен уайымдарды сипаттау және түсіну үшін қолданылады. Мысалы, сапалы зерттеулер пациенттің тәжірибесі немесе қызметкерлердің жаңа жұмыс тәсілдерін қабылдауы немесе мейіргерлік істе жаңа рөлдер туралы сұрақтарға жауап беру үшін пайдаланылуы мүмкін. Сапалы зерттеу, мысалы, ұлттық денсаулық сақтау қызметі, пациенттің тікелей бастан кешкен қандай мәселелерді зерттей алады? Пациент жергілікті денсаулық сақтау қызметтерінің дамуына қалай қарайды? Жеке көзқарастар мен уайымдар туралы ақпаратпен бірге қарау және бақылау, ақпарат жинау сияқты зерттеу әдістері қолданылады. Мейіргерлік іс зерттеулерінде сандық тәсілдер бір күтімнің басқаға қарағанда жақсы әсері бар ма екенін өлшеу үшін пайдаланылуы мүмкін. Мысалы, сандық құрылымдар сияқты зерттеу сұрақтарына жауап бере алады "А күтімі жақсыма Б күтімі ма?" Сандық зерттеулер сандық деректерді жинау мен талдауға формальды тәсілді қолданады.[6] Мейіргер ісі саласындағы зерттеулердің күрделі сипатын ескере отырып, олардың бірінде консенсусқа жеткен бір анықтаманы табу қиын. Алайда, зерттеудің көптеген анықтамаларында жүйелік процестің кейбір элементтері бар - жаңа білімді іздеу немесе жоспарлы және қисынды болып табылатын қызметті түсінуді тереңдету, сондай-ақ сұраққа жауап іздеу ж. т. б. Мейіргерлік тәжірибе, білім беру және саясат туралы жаңа білімді дамытып оны меңгеруге ұмтылудағы мәселелерге жауап беру және проблемаларды шешу мақсатында ақпаратты жинауда жүйелі тәсіләнде дәлелды тәжірібе маңызды орын алады.Дәлелді тәжірібе дегеніміз не? Пациенттерге мейіргерлік көмектің қандай түрін ұсыну туралы шешім қабылдау қиын емес. Алайда олардың нақты дәлелі бар түрін тәжірібеде қолдануы, нәтижесінің тиімділігін анықтау, бағалау өте маңызды. Себебі әр бір адам организмы жеке яғни индивидуалды болып келеді. Дәлелді тәжірибенің анықтамаларының бірі пациенттерге күтім жасау туралы шешім қабылдау кезінде ең жақсы нақты деректерді пайдалану болып табылады. Осы анықтамадан біз шешімнің ағымдағы үздік дәлелдемелерге, сондай-ақ мейіргерлердің жеке тәжірибесін пайдалануға негізделуі тиіс екенін және шешім анық жасалуы тиіс екенін көре аламыз. Бүгінгі күні пациенттің пікірі, жеке адамға медициналық көмек көрсету туралы қабылданатын кез келген шешім бірінші кезекте қарастырылады. Сондықтан дәлелді тәжірібенің үш айқын негізгі компоненті бар деп айтуға болады. Нақты пациентке күтім жасау туралы ғылыми негізделген шешімді қабылдай отырып, мейіргер қазіргі уақытта бар ең жақсы деректерді пайдалануы, нақты пациенттің қалауын ескеру, өз білімі мен тәжірибесін

ISBN 978-601-08-0758-7

шешім қабылдау үшін пайдалануы тиіс.[8] Пациентті қалай күту туралы шешім қабылдаған кезде мейіргер өз тәжірибесінде бар ең жақсы дәлелдемелерді іздеуі және пайдалануы тиіс, олар пациенттің талаптарын, құндылықтарын, мән-жайларын және қалауын ескеруі тиіс және олар өз кәсіби тәжірибесін, білімі мен пайымдауларын шешім қабылдаған кезде біріктіруі тиіс. Барлық үш элемент бірге пайдаланылуы тиіс, бірақ олардың әрқайсысының маңыздылығы әр түрлі жағдайларда әр түрлі. Басты принцип адам өмірінің сапасын барынша арттыру үшін неғұрлым тиімді күтім жасау болып табылады. Ғылыми негізделген практиканың өсуі денсаулық сақтаудың барлық салаларында сыншыларға ие және ғылыми негізделген практиканың құндылықтарына қатысты шектеулі консенсус бар. Дәлелдемелерге негізделген тәжірибені тиімді енгізу дәлелдемелердің иерархиясына кедергі келтіреді, ол дәлелдемелердің жоғары түрі ретінде рандомизацияланған бақылау сынақтарына ықпал етеді және ең үздік тәжірибені әзірлеу кезінде рефлексия құндылығын мойындауды елемейді.[9] Мейіргерлер өзінің кәсіби тобында да, жалпы медициналық және әлеуметтік қызметтерде де нақты деректерге негізделген практикамен байланысты пікірталастар туралы хабардар болуы тиіс. Денсаулық сақтаудың барлық аспектілерінде ғылыми негізделген, бірақ ішінара науқастарды күтуіндегі біраз шектеулер бар. Біріншіден, мейіргерлік істің кейбір салаларында зерттеулердің жетіспеуі бар, бұл мейіргерлік күтім тиімділігін анықтау үшін пайдалы. Олар клиника , теория немесе басқару жағынан болсын барлық жағынан мейіргер ісін дамытуға ұмтылады.Теорияны дамытпай біз практикаға үлес қоса алмаймыз, практикада жаңа технологияларды меңгере алмаймыз. Сол себептен бірінші оқу бағдарламасын өзгерткен кезінде барлық жағынан оны зерттеп, біздің елге сәйкестендіріп, жаңа технологияларды енгізу қажет.Қатысушымен жұмыс жасау барысында этикалық принциптерге негізделе жұмыс жасауымыз қажет.Зерттеу жүргізілу ережесімен қатысушыны таныстыру,келісімін алу, сұрақтарына жауап беру, оның құқықтарын атап айту. Қатысушыны толық ақпараттандыру зерттеушінің негізгі мақсатының бірі болып келеді.

Қорытындылай айтқанда мейіргер ісі салалары, оның бағыттары күрделі және оны дамыту үшін, зерттеулер көптеп жүргізілүі керек. Нақты дәлелденген ем-күтімді халыққа ұсынып, оның тиімділігін көрсете алу да күрделі жұмыс. Мейіргерлердің білімін дамыту қазіргі таңда өзекті мәселелердің бірі.Зерттеу жүргізу немесе оған қатысу арқылы мейіргер үлкен тәжірибе алады. Ізденіс барысында жаңа ақпарат жинайды.жаңа ақпаратты басқалар мен бөліседі.Сол арқылы мейіргер ісіндегі зерттеулер маңыздылығы, оның дамуының нәұқас күтіміне тиімділігін анық көрсете алады. Мейіргер ісін дамыту біздің қолымызда!

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1 Esther I. PhD Essential First Step in Research, Quality Improvement, and Implementation of Evidence-Based PracticeBernhofer, RN-BC // Journal for Nurses in Professional Development. – 2015. - №5. – P. 22-28.

ISBN 978-601-08-0758-7

2 Двойников С.И. Активизация научных исследований в сестринском деле - необходимое условие повышения качества медицинской помощи // Главная медицинская сестра. - 2004. - №7. – С. 88-93.

3 Касимовская Н. А., Шустикова Н.М., Фомина Е.В. Доказательная сестринская практика-перспективы развития сестринских клинических исследований. – М.: 2017. – 174 с.

4 Mikamanovich V.K. The role of nurse at the present stage of development of public health // Medical news. – Minsk: State Institute of management and social technologies of the Belarusian State University, 2015. - №12. - P. 68-70.

Полит Д.Ф., Бек К.Т. Основы сестринского исследования:

ISBN 978-601-08-0758-7

«ЕРТЕ ЖАСТАҒЫ ЖҮКТІЛІКТІҢ АНА МЕН БАЛА ҮШІН ҚАУІПТІЛІГІ ЖӘНЕ ОНЫҢ АЛДЫН АЛУ»

Қамешова З., Ануарбаева А. 2 курс «Емдеу ісі» мамандығы
Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі
Ғылыми жетекшісі: Кенжина Н.К. жоғары санатты дәрігер терапевт, магистр.

Аннотация: *Бұл мақалада жасөспірімдер арасындағы ерте жастағы жүктілік көрсеткіштерін төмендету үшін акушерлік бағдарламаларды кеңінен қолданудың өзектілігі қарастырылады.*

Қазіргі таңда соңғы 5 жылда елімізде тіркелген ресми деректерге сәйкес 29487 жасөспірім қыз жүкті болған. Ал 5792 қыз жасанды түсік жасатқан. Бұл тек ресми тіркелген жағдайлар ғана. Халық денсаулығы туралы кодекстың 150-бабына сәйкес қауіпсіз, медициналық түсік жасату үшін кәмелеттік жасқа толмаған қыз ата-анасының рұқсатын алуы керек. Жағдайын әке-шешесіне айтып жеткізе алмайтын отбасында өзекті мәселе болып отыр, медициналық тұрғыдан қарағанда денсаулығына қауіп төндіретін тұрмыстық түсік жасатып жатады.

Ерте жүктілік - бұл жасөспірім кезеңінде (18 жасқа дейін) жүкті болу жағдайы. Бұл тек медициналық қана емес, сонымен қатар әлеуметтік, психологиялық және экономикалық мәселелерге де әкеледі. Ерте жүктілік несімен қауіпті? Жасөспірім қыз баласының ағзасында 18 жасқа дейін өтпелі кезеңі басталып, организмде гормондық қайта құрылу процессі жүреді. Жас ана үшін ерте жүктіліктің жағымсыз әсерлері өте көп мысалы: Медициналық салдары физиологиялық жетілудің жеткіліксіздігі. Жасөспірімдердің ағзасы әлі толық қалыптаспаған және дамып жатқандықтан, ерте жүктілік кезінде физиологиялық қиындықтар туындауы мүмкін. Мұндай жағдайларда ананың организмі жүктілік пен босануға дайын болмай, бірқатар медициналық асқынуларға әкелуі мүмкін.

1.Гестациялық гипертензия – жасөспірімдерде жүктілік кезінде қан қысымының көтерілуі жиі кездеседі.

2.Теміртапшылық анемиясы – дұрыс тамақтанбаудан гемоглобин деңгейінің төмендеуі.

3.Плацентаның дұрыс орналаспауы – плацентаның төмен орналасуы босану кезінде қауіпті қан кетулерге әкелуі мүмкін.

4.Шала туылу – жасөспірімдерде толық жетілмеген жүктіліктің жиі кездесетін салдары.

Ал ананың құрсағындағы сәби денсаулығына әсері:

Ерте жүктілік кезінде туылған балалар көбіне дене салмағы аз болып дүниеге келеді, оларда физиологиялық немесе когнитивті дамуда артта қалушылық байқалуы мүмкін.

1.Шала туылған балалар – бұл балалардың иммундық жүйесі әлсіз болып, инфекцияларға сезімтал келеді.

2.Дамуындағы кідіріс – психикалық және физикалық дамуында кешігулер немесе мүгедектік қаупі жоғары.

ISBN 978-601-08-0758-7

3.Психологиялық салдары: Психологиялық стресс және депрессия. Жасөспірімдер үшін жүктілік күтпеген, стресстік жағдай болуы мүмкін. Бұл жүктілікке байланысты терең эмоционалдық ауыртпалықтар, өзін-өзі бағалаудың төмендеуі, күйзеліс және депрессияның дамуына алып келеді. Депрессия – әсіресе жасөспірімдер қолдау көрмесе, оларда депрессияның дамуы жиі кездеседі.

4.Кінә сезімі – жасөспірімдер көбінесе өзін кінәлі сезініп, әлеуметтік қысымның әсерінен оқшауланып қалуы мүмкін.

5.Жасөспірімдердің психикалық дайындығының жетіспеушілігі; Ата-аналық жауапкершілік жасөспірімдер үшін күрделі болуы мүмкін. Көптеген жасөспірімдер эмоционалдық және психологиялық тұрғыда бала тәрбиесіне дайын емес, бұл болашақта ананың және баланың психикалық денсаулығына кері әсерін тигізуі мүмкін.

6.Әлеуметтік салдары: Қоғамда өзінің ойы бар тұлға болып қалыптасу үшін жасөспірімдер мектеп қабырғасында білім алады, ал ерте жастағы жүктілік жағдайында білім алу мен маман болу мүмкіндіктері шектеледі. Ерте жүктілік көбінесе жасөспірімнің оқуын тастап кетуіне немесе оның білім алуына кедергі келтіреді. Бұл жас ананың болашақта жоғары білім алуына және жақсы жұмысқа орналасуына қиындық тудырады.

7.Мектепті аяқтамау – жас аналар оқуларын аяқтауда қиындықтарға тап болып, мектептен шығып қалу қаупі артады.

8.Жұмысқа орналасу мүмкіндіктерінің шектелуі – білім деңгейінің төмендеуі жасөспірімнің жақсы жұмысқа орналасу мүмкіндіктерін азайтады, бұл экономикалық қиындықтарға әкеледі.

9.Қарым-қатынас және қоғамдағы орын - Ерте жүктілік жасөспірімдерге әлеуметтік тұрғыдан да әсер етеді. Оларға қоғамның теріс көзқарасы, сыны және қысымы қатты әсер етеді.

10.Отбасы мен достар арасындағы қиындықтар – жақындары жасөспірімді қолдамаса, ол эмоционалдық жағынан оқшауланып, психологиялық қиындықтарға тап болуы мүмкін.

11.Әлеуметтік стигма – ерте жүктілікке байланысты жасөспірімге қоғамнан теріс көзқарас болуы мүмкін.

12.Тағыда бір қоғамның өзекті салдары - Экономикалық, яғни, қаржылық тұрақсыздық ерте жүктілік жас ананың экономикалық жағынан тәуелсіз болуына үлкен кедергі келтіреді. Жасөспірімдердің көбі ата-анасына немесе әлеуметтік көмекке тәуелді болады. Бұл экономикалық тұрғыдан тұрақсыздыққа әкеледі.

Ерте жүктіліктің әлем бойынша таралуы:

Сахараның оңтүстігіндегі Африка: Бұл аймақта жасөспірімдер арасындағы жүктілік ең жоғары деңгейде. Әрбір мың жасөспірім қызға шаққанда орта есеппен 100-ден 200-ге дейін жүктілік тіркеледі.

1.Нигерия, Мали, Ангола сияқты елдерде бұл көрсеткіштер өте жоғары.

2.Оңтүстік және Оңтүстік-Шығыс Азия: Бұл аймақта жасөспірімдер арасындағы жүктілік айтарлықтай жоғары. Әсіресе, Үндістан мен Бангладеште жасөспірімдердің босану көрсеткіші жоғары болып қала береді.

ISBN 978-601-08-0758-7

3.Үндістанда жасөспірім қыздардың 8%-ы 18 жасқа дейін ана болады.

4.Оңтүстік Азияда жыл сайын шамамен 3,6 миллион жасөспірім қыз босанады.

5.Шығыс Еуропа елдерінде (мысалы, Болгария, Румыния) жасөспірімдер жүктілігінің көрсеткіші жоғарырақ, 1000 қызға шаққанда 30-50 жүктілікке дейін жетеді.

6.Батыс Еуропа елдерінде бұл көрсеткіш төмен (Норвегия, Нидерланды, Германияда мың қызға 5-10 жүктілік тіркеледі).

7.Солтүстік Америка: АҚШ жасөспірімдер арасындағы жүктілік деңгейі бойынша дамыған елдер арасында ең жоғары көрсеткішке ие.

8.Таяу Шығыс және Солтүстік Африкада жасөспірімдер арасындағы жүктілік мәселесі өзекті. Жастар арасында ерте некелесу мәдениеті бар елдерде, мысалы Йемен және Судан сияқты мемлекеттерде, жасөспірімдердің ана болуының көрсеткіштері жоғары.

Осы себептер мен көрсеткіштерге сүйене отыра жасөспірімдер арасында ерте жүктіліктің алдын алу шараларын белсенді жүргізу қажет. Алдын алу шаралары жасөспірімдер арасында жүктілікті болдырмауға және олардың өмірлік жоспарларын іске асыруға көмектеседі. Алдын алу шаралары:

1.Жыныстық және репродуктивтік денсаулықты оқыту, жыныстық тәрбие беру: Мектептерде және қоғамда жыныстық тәрбие беру бағдарламалары енгізіліп, жасөспірімдерге жыныстық денсаулықты сақтау және контрацепция туралы білім беріледі. Жыныстық тәрбие жүктілік және жыныстық жолмен берілетін инфекциялардың алдын алуға көмектеседі.

2.Контрацептивтер туралы ақпарат беру: Жасөспірімдерге контрацептивтерді қолданудың артықшылықтары туралы кеңестер беру және оларды дұрыс қолдануды үйрету маңызды.

Отбасы жоспарлау бағдарламалары: Отбасын жоспарлау бағдарламалары жасөспірімдерге жоспарланбаған жүктіліктің алдын алуға көмектеседі, қолжетімді контрацептивтер мен медициналық кеңестер ұсынады.

3.Контрацепцияға қолжетімділікті арттыру: Жасөспірімдерге тегін немесе арзан контрацептивтерді ұсыну, оларды дұрыс қолдануды үйрету, отбасын жоспарлау туралы ақпарат беру арқылы ерте жүктіліктің алдын алу мақсаттары жүзеге асырылады.

4.Ұзақ мерзімді контрацептивтерді қолдану: кейбір бағдарламалар жасөспірімдерге ұзақ мерзімді контрацептивтер (мысалы, ішкі спиральдар, гормоналды имплanттар) ұсынуға бағытталған, өйткені олар жүктіліктің алдын алуда тиімдірек.

5.Жүктілік кезіндегі қолдау және күтім: Ерте жүктілік жағдайында жасөспірімдерге толыққанды медициналық бақылау мен қолдау көрсету өте маңызды. Бұл қолдау ананың және баланың денсаулығын қорғауға және жүктілік кезінде болатын асқынуларды азайтуға көмектеседі.

6.Медициналық тексерулер және бақылау: Жасөспірімдерге тұрақты түрде медициналық тексерулер жүргізу арқылы олардың денсаулық жағдайын қадағалап

ISBN 978-601-08-0758-7

отыру қажет. Бұл асқынуларды ерте кезеңдерде анықтап, қажет болған жағдайда қажетті емдеу шараларын қолдануға мүмкіндік береді.

7.Тамақтану және дене күтімі: Жасөспірімдерге дұрыс тамақтану туралы кеңестер беру және олардың дене салмағын бақылауда ұстау босану кезінде кездесетін қиындықтарды азайтуға көмектеседі.

Осы шараларды әлемдегі елдер белсенді қолдануда:

АҚШ-тағы жасөспірімдер арасындағы жүктіліктің алдын алу және қолдау көрсетуге бағытталған ұлттық ұйым. Ол жасөспірімдердің жыныстық денсаулығын жақсарту бойынша кеңестер беріп, қолдау бағдарламаларын ұсынады.

1."The National Campaignto Prevent Teenand Unplanned Pregnancy" – бұл бағдарлама жоспарланбаған және ерте жүктіліктің алдын алу бойынша түрлі ақпараттық шаралар ұйымдастырады.

2."Healthy Teen Network"- жасөспірімдер арасындағы жүктіліктің алдын алу және қолдау көрсетуге бағытталған ұлттық ұйым. Ол жасөспірімдердің жыныстық денсаулығын жақсарту бойынша кеңестер беріп, қолдау бағдарламаларын ұсынады.

3.Африкадағы бағдарламалар: Кения мен Оңтүстік Африкада "Adolescent Sexualand Reproductive Health" бағдарламалары жүзеге асырылады, олар жасөспірімдерге жыныстық тәрбие беру және контрацепцияға қол жеткізу бойынша көмек көрсетеді.

Қорытынды: Электрондық базалардағы ақпараттардан, әлем бойынша жасөспірімдер арасындағы жүктілік көрсеткіштерін төмендету үшін жүргізілген ғылыми зерттеулерге жүйелі шолу жасау арқылы, осы тәжірибені ерте жастағы және жоспарланбаған жүктіліктің алдын алуда акушерлік бағдарламалар арқылы жыныстық тәрбие берудің, контрацептивтерге қолжетімділікті арттыру шараларымен өзекті мәселенің шешімін табуға болады деп ойлаймыз.

Әдебиеттертізімі:

1. Sully EA, Biddlecom A, Daroch J, Riley T, Ashford L, Lince-Deroche N et al., Adding It Up: Investing in Sexual and Reproductive Health 2019. New York: Guttmacher Institute; 2020.

2. Darroch J, Woog V, Bankole A, Ashford LS. Adding it up: Costs and benefits of meeting the contraceptive needs of adolescents. New York: Guttmacher Institute; 2016.

3. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects 2022 - Special Aggregates, Online Edition; 2022.

4. Zambia Statistics Agency, Ministry of Health (MOH) Zambia, and ICF. Zambia Demographic and Health Survey 2018. Lusaka, Zambia, and Rockville, Maryland, USA: Zambia Statistics Agency, Ministry; 2018.

5. Philippine Statistics Authority (PSA) and ICF. Philippines National Demographic and Health Survey 2017. Quezon City, Philippines, and Rockville, Maryland, USA: PSA and CF; 2018.

6. Chung, W.H, Kim, ME., Lee, J. Comprehensive understanding of risk and protective factors related to adolescent pregnancy in low- and middle-income countries: A systematic review. Journal of Adolescence. 2018; 69: 180-188.

ISBN 978-601-08-0758-7

МЕДИЦИНА ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ АРАСЫНДАҒЫ ЭТИКА ЖӘНЕ ДЕОНТОЛОГИЯ

Нуртазина Малика Дидаровна, 4 курс, «Емдеу ісі» мамандығы
«Дүйсенбі Қалматаев атындағы мемлекеттік жоғары медицина колледжі» ШЖҚ КМК
Кенес Құралай Дүсіпханқызы, арнайы пәндер оқытушысы

Аннотация: *Бұл зерттеу жұмысы этика және деонтология мәселелеріне, әсіресе медициналық қызметтің этикалық аспектілеріне арналған. Этика адамның мінез-құлқының нормалары мен принциптерін зерделейтін ғылым ретінде сипатталып, нормативті және дескриптивті бағыттары атап көрсетілді. Деонтология, әсіресе медициналық қызметте, әрбір іс-әрекеттің ниеті мен міндеттемесінің маңыздылығын атап өтеді. Медициналық этикадағы негізгі қағидаттар — қайырымдылық, автономия, әділеттілік және толыққанды медициналық көмек көрсету — медициналық қызметкерлердің пациенттермен және әріптестерімен қарым-қатынастарын реттейтін негіз ретінде сипатталды. Жұмыс медициналық колледждің білім алушыларының этикалық, психологиялық және кәсіби дағдыларын дамытуға бағытталған тәсілдер мен тәжірибелік жұмыстарды қамтиды.*

Этика — мораль философиясы, адамның мінез-құлық нормаларын, құндылықтарын және принциптерін зерттейтін сала. Ол жақсы мен жаман, әділеттілік, жауапкершілік және еркіндік мәселелерін қарастырады. Этиканың негізгі бағыттары нормативті этика, моральдық нормаларды белгілейтін және дескриптивті этика, моральдық тәжірибелерді зерттейтін бағыттарды қамтиды. Қазіргі зерттеулерде технологиялардың, әлеуметтік әділеттіліктің және экологиялық тұрақтылықтың этикалық мәселелері ерекше назарда. Этика адамның қоғамдағы орны мен әрекеттерінің жауапкершілігін түсінуге көмектеседі.

Деонтология – этиканың бір саласы, моральдық әрекеттердің ережелері мен міндеттерін зерттейді. Бұл бағытта моральдық міндеттемелер мен құқықтардың маңызы ерекше. Деонтологияның негізін қалаушы Иммануил Кант, ол моральдық әрекеттердің негізі ретінде жалпы заңдарға және этикалық принциптерге сүйенуді ұсынған. Деонтологиялық көзқарас бойынша, әрекеттің моральдық құндылығы оның нәтижесіне емес, адамның ниеті мен міндеттемесіне байланысты. Бұл теория кәсіби этика, құқық, медицина сияқты салаларда кеңінен қолданылады, себебі адамдардың жауапкершілігін, адалдықты және әділдікті сақтау қажеттілігін баса көрсетеді.

Медициналық қызмет этикасы.

Медициналық этика (лат. ethica, грек тілінен алғанда ethice – адамгершілікті зерделеу), немесе медициналық деонтология (греч. deon – парыз; «деонтология» термині соңғы жылдардағы отандық әдебиетте кеңінен қолданылуда), бұл – медициналық қызметкерлердің кәсіби міндеттерін орындау барысындағы этикалық

ISBN 978-601-08-0758-7

нормалар мен қағидаттар жиынтығы. Қазіргі заманғы түсінік бойынша, медициналық этикаға келесі аспектілер кіреді:

- ғылыми – медициналық қызметкерлердің жұмысының этикалық және адамгершілік аспектілерін зерттейтін медициналық ғылым тарауы;
- практикалық – кәсіби медициналық қызмет барысында этикалық нормалар мен ережелерді қалыптастыру және қолдану міндеті болып табылатын медициналық тәжірибие саласы.

Медициналық этика үш негізгі бағыт бойынша тұлғаралық қарым-қатынастардың әртүрлі мәселелерін зерделейді және шешеді:

- медициналық қызметкер – емделуші,
- медициналық қызметкер – емделушінің туысқандары,
- медициналық қызметкер – медициналық қызметкер.

Төрт этикалық қағидаттар: қайырымдылық, автономия, әділеттілік және толыққанды медициналық көмек. Қағидаттардың күнделікті қолданылуын талқыламас бұрын әрбіреуіне жеке сипаттама берген жөн:

- Қайырымдылық қағидаты: «Мен емделушіге мейіріммен қараймын немесе ең болмағанда зиян келтірмеймін» Қайырымдылық түсінігі -емделушіге саналы және мейірімді көзқараспен қару, науқас денсаулық жағдайының күрделігімен барабар емдеудің сапалы әдістерін таңдау, емделушінің медициналық көмекке дайындығы және қабілеттілігі. Ең бастысы, медициналық қызметкердің кез келген әрекеті нақты емделушінің жағдайын жақсартуға бағытталуы шарт!
- Автономия қағидаты: кез-келген емделушіге және оның қабылдаған шешімдеріне сыйластықпен қарауды талап етеді. Әрбір адам мақсат ретінде қарастырылғанымен, қойылған мақсатқа жеткізетін құрал ретінде қарастырылмайды. Медициналық көмек құпиялылықты, медициналық көмекке мұқтаж адамның мәдениетін, дінін, саяси және өзге де көзқарастарын сыйлау, медициналық шараларға ақпаратты келісім беру, күтімді бірлесіп жоспарлау және оны жүзеге асыру, сонымен бірге, емделушінің өзіндік шешім қабылдауы, немесе осы емделушінің заңды өкілінің шешім қабылдауы сияқты аспектілері автономия қағидатымен байланысты.
- Әділдік қағидаты немесе зиян келтірмеу қағидаты - медицина қызметкерлерінің мәртебесіне, әлеуметтік жағдайына, мамандығына және сыртқы ахуалдарға қарамастан барлық емделушілерге бірдей қарау және барша көмекке мұқтаж жандарға бірдей көмек көрсету. Бұл қағидат, сондай - ақ, медициналық қызметкер қандай да бір көмек көрсетсе де, оның әрекеттері емделушіге және өзге тұлғаларға зиян тигізбеуі керек.

Емделуші мен оның туған - туыстары немесе өзге де медицина қызметкерлері арасындағы қарама-қайшылық пайда болған жағдайда, осы қағидатты негіз ете отырып, біздер емделушінің құқығын қорғауымыз қажет.

- Толыққанды медициналық көмек көрсету қағидаты емделушіге шебер медициналық көмекті және кәсіби көзқарасты, сапалы диагностикалау және емдеу жүргізу үшін денсаулық сақтаудың барлық мүмкіндігін қолдануды, профилактикалық іс-шараларды және паллиативті көмек көрсетуді көздейді. Аталған

ISBN 978-601-08-0758-7

қағидат денсаулық сақтау саласына қатысты барлық заңнамалық нормалардың сақталуын, сонымен қатар этикалық кодекстің барлық ережелерінің сақталуын тұспалдайды. Медицина қызметкерінің рухани жауапкершілігі оның медициналық этиканың барлық қағидаттарын сақтауын талап етеді.

«Медбике - емделуші» арасындағы қарым-қатынастар:

Медбике емделушімен сабырлы, ашық жарқын сөйлесуге міндетті. Дөрекі, қатал немесе тым ресми сөйлесуге тыйым салынады. Науқастарға «Сіз» деп және аты мен әкесінің атын атап әңгімелескен жөн.

Науқастың қасында тұрып оның диагнозын, емдеу жоспарын талқылауға, палатадағы өзге науқастардың денсаулығы туралы ақпаратты басқа тұлғаларға әңгімелеуге тыйым салынады.

Күрделі және ауырсындыратын емшараларды бастамас бұрын медбике осы емшаралардың мәнін, мағынасын және қажеттілігін түсінікті түрде науқасқа түсіндіруі және тыныштандыруы қажет. Науқастың келісімін алған соң медициналық көмекті жүзеге асыруға болады.

«Медбике – емделушінің туысқандары (және жақындары)» арасындағы қарым-қатынастар:

Медбике әрқашан, қандай жағдай болмасын - ұстамдылықты, сабырлықты, тыныштықты және әдептілікті сақтауы қажет;

Күрделі науқастарды күтушілерге емшара мен манипуляцияларды дұрыс орындау тәртібін түсіндіруі тиіс;

Тек өз құзыреті шеңберінде сұхбаттасуы (науқастың сырқаты, болжамы жөнінде әңгімелемей, дәрігерге жолдауы) тиіс;

Қойылған сұрақтарға сабырлы жауап беруі қажет, күрделі науқастарды дұрыс күте білу ережелерін науқастың туыстарына шыдамдылықпен үйретуі тиіс.

«Медбике - дәрігер» арасындағы қарым-қатынастар:

Сұхбаттасу кезінде дөрекі сөйлесуге тыйым салынады;

Дәрігерлік тағайындаулар уақытында нақты және кәсіби орындалуы тиіс;

Науқастың денсаулық жағдайындағы кенеттен болған өзгерістер туралы дәрігерге жедел хабар берілуі тис;

Тағайындалған дәрігерлік емді қолдану барысында күмән туындаған жағдайда , науқас жоқ болған кезде, сыпайы түрде, осы жөнінде дәрігермен мән-жайды талқылауы қажет.

«Медбике - медбике» арасындағы қарым-қатынастар:

Өз ұжымдастарымен жұмыс істеу барысында дөрекілікке, тұрпайылыққа жол берілмеуі тиіс;

Қандай да бір ескертулер, науқас болмаған уақытта, әдепті түрде айтылуы тиіс;

Тәжірибиелері мол медбикелер жас мамандарға тәлімгерлік көмек көрсетулері қажет;

Қиын жағдайларда бір-біріне көмектесулері тиіс.

«Медбике-кіші медицина қызметкері» арасындағы қарым-қатынастар:

ISBN 978-601-08-0758-7

Өзара сыйластықты сақтаулары тиіс; кіші медицина қызметкерінің жұмысын сыпайы түрде бақылауы қажет;

Әдепсіздікке, дөрекілікке, тәкаппарлыққа жол беруге болмайды;

Науқастар мен келушілердің көзінше ескертулер жасауға болмайды.

Емдеу жұмыстары барысындағы дәрігер мен науқастын өзара қарым-қатынасының моральді-этикалық мәселелері деонтологияның маңызды тармағы болып табылады. Емдеу мекемесі туралы алғашқы әсердің жағымды, не жағымсыз болуы медицина қызметкеріне, осы жердегі жұмыс тәртібі мен жай-ахуалға байланысты қалыптасады. Емдеу мекемесіндегі орта мен ахуал науқастардың көңіл-күйіне, сайып келгенде, емдеу ісіне зор ықпалын тигізеді. Бөлімшедегі жалпы жай ахуалдың да маңызы зор. Егер науқас ұқыпты да, мұқият жұмыс істеп отырған медицина қызметкерін көрсе, көңілі орнығып, табалдырықтан сеніммен аттайды. Егер де, науқас тек жоғары білікті маманды ғана емес, сонымен қатар жаны жайсаң, жүрегі ізгі жанды көрсе, қамкор пейілін сезінсе, онымен бүкпесіз байланыс жасайды, ал мұның өзі емнің шипалы болуына септігін тигізеді.

Мейірбикенің моральдық және кәсіби міндеті - пациентке дәрігер тағайындаған емдеу бағдарламасын орындауға көмектесу. Мейірбикенің жоғары кәсібилігі - мейірбике мен дәрігердің жолдастық, алқалық өзара қарым-қатынасының маңызды моральдық факторы. Егер медбике дәрігердің емдік ұсыныстарының орындылығына күмәнданса, ол бұл жағдайды алдымен дәрігердің өзімен, ал одан кейін күмән туындаған жағдайда жоғары басшылықпен мұқият талқылауы керек.

«Дүйсенбі Қалматаев атындағы мемлекеттік жоғарғы мединина колледжінде» «Мейірбике ісі» және «Емдеу ісі» мамандықтары бойынша білім алушылар білім алады. Білім алушылар өздерінің күнділікті оқу барысында психология, коммуникативтік дағдылар, мейірбике ісі негіздері пәндерінен науқастармен сөйлесу, қарым-қатынас орнату, вербалды және вербалды емес қатынас орнату әдістерін оқып үйренеді, тәжірибелік дағдыларын қалыптастырады. Болашақта жұмыс барысында пайда болатын мәселерге дайындық ретінде практикалық жұмыс беріледі. Адамгершілік және этикалық негіздер білім алушыларда сабақ барысында өзін-өзі тану пәні ұстаздардының білім нәрін сусынатып, берген білімдері мен студенттерінің жеке қасиеттері арқасында, уақыт өткен сайын жақсара түсуде. Тәжірибелік дағдылар білім алатын студенттермен сөйлесу, рөлдерді ойнау, психологиялық ойындар мен имитациялар арқылы болашаққа арқа сүйер, кәсіби шеберлігі бар тұлғаларды қалыптастыру мақсаты қойылған. Іс –әрекет алгоритмдерін, манипуляциларды жүргізу мен орындау сапасы жоғары болса, әрі науқаспен байланыс орнатудың заманауи әдістерін қолдану болашаққа бастама бастаудың кілті.

Қорытынды: Бұл зерттеу этика және деонтологияның, әсіресе медициналық қызметте, науқастармен қарым-қатынас орнату, моральдық жауапкершілікке бейімділік қалыптастыру және кәсіби дағдыларды арттырудағы рөлін ашып көрсетеді. Медициналық қызметкерлердің науқасқа деген құрмет пен ізгілік танытуы, құпиялылықты сақтауы және әділдікті қамтамасыз етуі — сапалы

ISBN 978-601-08-0758-7

медициналық қызметтің негізі болып табылады. Медициналық колледжде білім алушыларға этика мен деонтология қағидаттарын үйрету арқылы болашақ мамандардың кәсіби дайындық деңгейін көтеруге және гуманистік құндылықтарды дамытуға ықпал жасалады.

Әдебиеттер тізімдері:

1.Асимов М.А. «Коммуникативтік дағдылар» Алматы, 2016.

2. В.Ф. Матвеев «Медициналық психологиядағы этика және деонтология негіздері».

3. Г. А Оразбекова, А. Н. Сексенали «Дәрігердің коммуникативтік дағдылары»

ISBN 978-601-08-0758-7

CHALLENGES IN SCIENTIFIC RESEARCH AMONG STUDENTS OF PAVLODAR MEDICAL HIGHER COLLEGE AND THEIR SOLUTIONS

Author: Sabyrzhan K.K., 3rd year, "General Medicine"
MSE on REM Pavlodar Medical Higher College
Scientific Supervisor: A.D. Utegenov, Lecturer of Special Disciplines, Master of Business Administration in Healthcare

Abstract*: This article examines the challenges faced by medical college students in conducting scientific research. The main issues identified include limited resources, lack of methodological knowledge, insufficient time, and motivational difficulties. Solutions are proposed to improve the quality of training for future professionals.*

Relevance of the Research: Relevance of the Research: With the increasing demands on mid-level healthcare professionals, there is a clear need for enhanced training that incorporates scientific advancements in medicine [6]. To cultivate a professional identity, medical schools must focus on involving students in research early in their education, allowing them to develop essential skills such as writing research proposals, collecting and analyzing data, conducting literature reviews, and disseminating findings [1]. Many studies have shown that early participation in research fosters a lifelong commitment to scientific inquiry [4].

Contemporary research highlights the importance of adapting students to research through active participation in conferences, publications, and projects. Such involvement not only deepens their professional knowledge but also contributes significantly to their future careers. Having diplomas, certificates, and publications improves graduates' employability and competitiveness in the job market [5].

Research Objective: The aim of this study is to identify and analyze the challenges that students of Pavlodar Medical Higher College encounter in conducting scientific research. The research focuses on:

1. Assessing the impact of these problems on students' ability to conduct research.
2. Developing practical solutions to overcome these challenges, including:
3. Recommendations for improving research training.

1) Enhancing access to educational materials and resources.
2) Time management and motivational strategies for students.
3) The study specifically addresses issues such as lack of methodological knowledge, time constraints, and limited access to resources.

Materials and Methods: A retrospective analysis was conducted at Pavlodar Medical Higher College. The study involved 327 respondents who voluntarily participated. A questionnaire consisting of 10 questions was developed to identify students' challenges in scientific writing.

Results and Discussion: The survey results yielded the following data:

a. 40% of students (n=131) would consider writing a scientific paper if the topic were suitable.

ISBN 978-601-08-0758-7

b. 26% (n=85) expressed interest in future scientific work, while 20% (n=65) do not plan to engage in research.
c. 14% (n=46) prefer practical work.
d. The most significant difficulty students face is in finding literature, affecting 34% (n=111). Data collection and analysis are challenging for 30% (n=98), while writing the main body of the work troubles 20% (n=65). Defining the topic and research objectives is difficult for 10% (n=33), and formatting the work poses a challenge for only 6% (n=20).
e. Half of the respondents—50% (n=164)—feel confident in their scientific writing skills. In contrast, 30% (n=98) are unsure of their abilities, while 10% (n=33) feel very confident, and another 10% (n=32) feel very unconfident.
f. The primary issues in literature search are a lack of available sources (28%, n=91), limited access to necessary sources (35%, n=115), and difficulty finding relevant studies (37%, n=121).
g. Regarding formatting, 55% (n=180) find it relatively easy to meet the requirements, while 35% (n=115) encounter difficulties. Only 10% (n=32) find formatting very easy, with no one finding it "very difficult."
h. Concerning consultations, 45% (n=147) of students regularly consult their supervisors at least once a week. 35% (n=115) seek help 1-2 times a month, 15% (n=49) do so very rarely (every 2-3 months), and 5% (n=16) do not consult their supervisors at all.
i. The most valuable support, according to 45% (n=147) of respondents, comes from consultations with supervisors. Approximately 30% (n=98) value courses on scientific writing, 20% (n=65) find examples of completed research helpful, and 5% (n=17) consider peer support the most beneficial.
j. In terms of time management, 50% (n=164) report that writing a paper takes them one to two weeks. About 20% (n=66) require over a month, 20% (n=65) take around a month, and 10% (n=32) finish in less than a week.
k. Procrastination affects 50% (n=164) of students occasionally, while 35% (n=115) frequently delay writing. Only 15% (n=49) have never experienced procrastination, with no one reporting constant procrastination.
l. For 50% (n=164) of respondents, access to scientific databases is the most crucial resource. Approximately 35% (n=115) need more detailed guidance from their supervisors, and 10% (n=33) emphasize the importance of courses or workshops on academic writing. Only 5% (n=15) believe that increasing the time allotted for writing would be beneficial.

Data Analysis and Interpretation: The current study reported that about 40% of students are willing to engage in research if a suitable topic is available, but 20% do not plan to pursue scientific work, indicating a need for more active student involvement in research. And many studies said that the early participation in the research will promotes a tendency to keep going research in their later life

The primary challenge identified is access to scientific literature, with 34% of students facing difficulties. Addressing this issue through improved access to scientific

ISBN 978-601-08-0758-7

databases and training on information retrieval methods is crucial for enhancing the quality of students' research.

Half of the students feel confident in their research writing skills, but 30% doubt their abilities. Challenges with data analysis and writing the main body of work highlight the need for courses on research methodology and academic writing to enhance students' methodological and practical skills.

Procrastination and time management issues also warrant attention. Implementing time management practices and improving self-organization can help student's complete tasks more efficiently, preventing burnout.

Another major barrier we have identified among students is a lack of sufficient time and procrastination. This barrier has been observed in numerous prior studies and has been reported at significantly higher rates [2, 3].

Conclusion: This study focuses on the obstacles to scientific research among students of Pavlodar Medical Higher College. The survey results indicate that students value support from supervisors and access to scientific databases most when writing research papers.

The most common barriers include a lack of methodological knowledge, limited access to scientific databases, and student motivation. To encourage student participation in research, these barriers must be minimized through the integration of research activities into the curriculum, mentorship programs, and access to financial resources for research projects.

References

1. Abusamak, M., AlQato, S., Alrfooh, H.H. et al. Knowledge, attitudes, practices and barriers of medical research among undergraduate medical students in Jordan: a cross-sectional survey. BMC Med Educ 24, 23 (2024). https://doi.org/10.1186/s12909-023-05002-9

2. Abu-Helalah M. A. et al. Research participation among medical students in Jordan: rates, attitudes, and barriers //Int J Acad Res. – 2015. – Т. 7. – №. 02. – С. 14-19.

3. Anbari Z, Mohammadbeigi A, Jadidi R. Barriers and challenges in researches by Iranian students of medical universities. Perspect Clin Res. (2015) 6:98–103. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25878955/

4. Assar, A., Matar, S.G., Hasabo, E.A. et al. Knowledge, attitudes, practices and perceived barriers towards research in undergraduate medical students of six Arab countries. BMC Med Educ 22, 44 (2022).https://doi.org/10.1186/s12909-022-03121-3

5. Организация совместной научно-исследовательской деятельности студентов и преподавателей Актюбинского высшего медицинского колледжа имени героя советского Союза Дементиевская, Н. В., Маншук Маметовой / Н. В. Дементиевская, Э. М. Шамсутдинова // Наука. Медицина. Транспорт. Инновации: сохраняя прошлое - создаем будущее : Материалы III Международной молодежной научно-практической конференции, Оренбург, 07–08 февраля 2024 года. – Оренбург: Самарский государственный университет путей сообщения, 2024. – С. 31-34. (на русском языке).

ISBN 978-601-08-0758-7

6. Опыт организации и привлечения к научно-исследовательской работе студентов медицинских колледжей рева г.в.// Современные проблемы науки и образования. – 2017. – № 6. ; (на русском языке) URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=27201

ISBN 978-601-08-0758-7

ШЫЛЫМ ШЕГУ БҮГІНГІ ТАҢНЫҢ ӘДЕТІ МЕ ӘЛДЕ СӘНІ МЕ?

Сансызбаева А.М., 4 курс , «Емдеу ісі» мамандығы
«Семей» медициналық колледжі
Ғылыми-жетекшісі: Жумашева Г.Б., арнайы пәндер оқытушысы

Шылым шегу бүгінгі таңда ең өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Темекі қашан жастық та , жыныстық та ерекшеліктерімен таңдалмайтын жағдайға жеткен. Ол адам ағзасына, қоршаған ортаға , болашақ ұрпаққа зиянды. Біздің зерттеуге алған тақырыбымыз: "Темекі шегу: сән, әдет, ауру?". Бұл өте ауқымды тақырып. Бұл тақырыптың өзектілігін түсіне отырып, біз зерттеуді экологиямен және денсаулықпен, салауатты өмір салтын насихаттаумен ұштастыра отырып зерттеуді шештік.

Салауатты өмір салты үшін күрес халық арасында темекіні тастау қажеттілігі туралы үнемі түсіндіру жұмыстарын жүргізбейінше табысты бола алмайды. Бұл жағдайда медицина қызметкерлері халыққа үлгі болулары керек. Өкінішке орай, дәрігерлер арасында да, студенттер арасында да бұл әдеттің үлкен қауіптілігін анық біліп, оны тастай алмайтын дәрігерлер аз емес. «Егер дәрігер шылым шексе, неге қалғандары бұл әдетті тоқтату керек?» деген сауал туындайды.

Темекі індетінің салдары адамдардың денсаулығы үшін өте зиянды және барлық елдерде қарсы іс-қимылды талап етеді. Темекі шегуге байланысты аурулардан жыл сайын бес миллион адам өледі, әрбір алты секунд сайын бір адамнан өледі. Қазіргі уақытта темекі шегумен байланысты 25-тен астам ауру түрі белгілі, олардың арасында жүрек – қан тамырлары, бронх-өкпе және онкологиялық аурулар алдыңғы қатарда. Темекі індетінің құрбандары еңбекке қабілетті 30-55 жастағы ер адамдар және ұрпақты 15-49 жастағы әйелдер болып табылады. Сонымен қатар, жастар мен жасөспірімдердің шылым шегуге ерте қызығуы ерекше алаңдаушылық туғызады. Осы тұрғыда "Темекінің зияны" тақырыбы - бүгінгі күннің өзекті тақырыбы деп айтуға болады. Қазіргі уақытта темекі шегу көптеген адамдар арасында үлкен проблема болып отыр. Бұл зиянды әдет халықтың көп бөлігін, соның ішінде жасөспірімдер мен жастарды қамтиды. Елімізде темекі шегетіндердің саны жыл сайын 10% - ға артып келеді, олардың көпшілігі жасөспірімдер. Көптеген елдерде 15 жастағы балалардың 1/3-і темекі шегеді, көбі 7-10 жас аралығында темекі шегуді бастаған.

Жастардың шылым шегуі өте өзекті тақырып. Сол себепті осы мәселеге байланысты көптеген зерттеулер бар. Бірақ біздің зерттеуіміз ерекше деп ойлаймыз. Себебі, бұрын сонды медицина мамандығының студенттерінің шылым шегуі жайлы зерттеулерді біз кездестірмедік. Әрине, шылымның зиянды екенін барлық адамдар біледі. Бірақ медицина тандаған және оқып жүрген студенттер қарапайым адамдарға қарағанда шылымның зияны, қандай ауруға әкелетіні жайлы 10 есе көп мәлімет біледі. Осынын бәрін біле тұра «Неге болашақ дәрігерлердің көбі шылым шегуден бас тарта алмайды?» деген сұрақ бізді мазалайды.

ISBN 978-601-08-0758-7

Зерттеудің мақсаты: «Семей медицина университеті» ҚеАҚ 3-5 курс студенттері арасында шылым шегудің таралуын, олардың шылымды тастауға дайындығын және осы мәселе бойынша жалпы білімін анықтау.

Зерттеуде колданылатын әдістер мен материалдар: Зерттеу жұмысын жүргізу үшін социологиялық әдіс қолданылады. Зерттеу дизайны көлденең бірмезгілді болады. Себебі, Семей медицина университетінің 19-25 жас аралығындағы студенттер арасында сауалнама жүргізілді. Сауалнамада 12 сұрақ. Сауалнама анонимді түрде Google Forms қосымшасы арқылы жүргізілді.

Зерттеудегі қосу критерийлері:

1. Семей медицина университетінің 3-5 курс студенттері
2. Ер адамдар мен әйел адамдар
3. 18-28 жастағы адамдар

Зерттеудегі алып тастау критерийлері:

1. 18 жастан кіші студенттер
2. Зерттеуден бас тартқан студенттер

Зерттеу нәтижесі: Семей медицина университетінің 3-5 курс студенттері арасыда 119 адам анонимді сауалнаманы өтті. Осының ішінде 94 әйел адам 79%, 25 ер адам 21%. Шылым шегетін студенттер 12,6% құраса, ал шылым шекпейтін студенттер 87,4% құрады. Шылым шегуді тастауға тырысқандар- 6,7%, тырыспаған студенттер- 5,9%, қалған 87,4% студенттер шылым шекпейді. Шылым шегудің зияны туралы білетін студенттер- 95,8%, ал білмейтін студенттер -3,4%. Студенттер мен интерндер арасында «шылым шегумен күресудің мағынасы бар» деп- 46,6%, ал күресудің «мағынасы жоқ» дегендер 13,6 % құраса, қалғаны «мүмкін» деп жауап бергендер 39,8% құрады. Шылым шегуді жақын арада тастағысы келетіндер 7,6%, ал тастағысы келетіндер, бірақ қазір емес 3,4% және мүлдем тастағысы келмейтіндер 2,5% құрады. «Сіздің ойыңызша шылым шегу бүгінгі таңның әдеті ме, әлде сәні ме» деген ойға қосылатындар- 26,9%, бұл ойға қосылмайтындар - 16,8% және «мүмкін» деп ойлайтындар- 56,3% құрады. «Егерде сіз шылым шекпес бұрын шылым жайлы барлығын білсеңіз, шылымға тәуелді болушы ма едіңіз?»- деген сауалға «Иә» деп жауап бергендер -4,2%, «Жоқ» деп жауап бергендер- 11,8% және «Мүмкін» деп жауап қайтарғандар- 6,7%-ды құрады, калған студенттердің 77,3%-ы «Шылым шекпеймін» деп жауап берді.

Қорытынды: Жүргізген сауалнама және статистикалық мәліметтер бойынша «Семей медицина университеті» ҚеАҚ 3-5 курс студенттері арасында шылым шегудің таралуын, олардың шылымды тастауға дайындығын және осы мәселе бойынша жалпы білімі тексерілді. Шылым шегетін студенттерге қарағанда шылым шекпейтін студенттердің саны көп екеніне көз жеткіздік. Шылым шегетін студенттер арасында осы жаман әдетті тастауға ниеті бар студенттердің саны көп екендігі және осы әдетпен күресудің маңызы бар екендігін анықтадық.

Әдебиеттер тізімі:

1. Пер. с болг., Генкова Л.Л., Славков Н.Б. Почему это опасно. - М.: Просвещение, 1989.

ISBN 978-601-08-0758-7

2. Лоранский Д.Н., Лукьянов В.С. Азбука здоровья: Книга для молодежи. - М.: Профиздат, 1990.
3. Деларю В.В. Губительная сигарета. - М.: Медицина, 1987.
4. Ягодинский В.Н. О вреде никотина и алкоголя. - М.: Просвещение, 1986.
5. РД. Все о здоровом образе жизни, Ридерз Дайджест, 1998.
6. Электронная газета «Правда.ру» http://news.pravda.ru/health/2004/04/17/62139.html
7. Журнал "Здоровье". № 1, 2004 год

ISBN 978-601-08-0758-7

РОЛЬ ФЕЛЬДШЕРА В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Коломеец С.В., 3 курс , специальность «Лечебное дело»
ГКП «Актюбинский высший медицинский колледж имени героя Советского Союза Маншук Маметовой» на ПХВ
Научный руководитель Шамсутдинова Э.М., преподаватель специальных дисциплин

Аннотация: *Данная статья рассматривает участие фельдшера в ранней диагностике онкологических заболеваний.Онкологические заболевания остаются одной из ведущих причин смертности во всём мире. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рак уносит около 9,6 миллионов жизней ежегодно, и, по прогнозам, количество заболеваний продолжит расти [1, стр.21]. В условиях современного здравоохранения важнейшую роль играет ранняя диагностика рака, которая существенно повышает шансы на успешное лечение. Фельдшера, особенно в сельских и удалённых районах, играют ключевую роль в выявлении ранних признаков раковых заболеваний и направлении пациентов на специализированные обследования. Их знания и навыки становятся критически важными для предотвращения поздней диагностики, которая значительно усложняет процесс лечения и снижает шансы на выздоровление.*

Рак является заболеванием, которое требует внимательного наблюдения и быстрой реакции. Поздняя диагностика остаётся одной из главных причин высокой смертности от онкологических заболеваний. По данным ВОЗ, в развивающихся странах около 70% пациентов обращаются за медицинской помощью уже на III или IV стадии болезни [2, стр.41]. Ранняя диагностика значительно улучшает прогнозы на успешное лечение и повышает качество жизни пациентов.Особенно важна роль фельдшеров в сельских районах, где отсутствует доступ к узкопрофильным специалистам и современному оборудованию. Основная проблема — недостаток подготовки и навыков у фельдшеров для своевременного выявления симптомов рака. В связи с этим, актуальность проблемы состоит в необходимости повышения уровня осведомленности и навыков медицинских работников среднего звена.

Цель исследования — оценить роль фельдшеров в ранней диагностике рака и предложить пути улучшения их подготовки в данном направлении.

Задачи исследования:

Оценить уровень знаний фельдшеров о симптомах ранних стадий рака.

Изучить случаи ранней и поздней диагностики рака, проведённые фельдшерами.

ISBN 978-601-08-0758-7

Разработать рекомендации для повышения эффективности работы фельдшеров в ранней диагностике рака.

Материалы и методы

Для проведения исследования использовались следующие методы:

Анкетирование фельдшеров. Было проведено анкетирование среди 50 фельдшеров из сельских районов Республики Казахстан. Анкета включала вопросы о знаниях ранних симптомов рака, алгоритме действий при подозрении на онкологическое заболевание и навыках работы с пациентами.

Анализ клинических случаев.

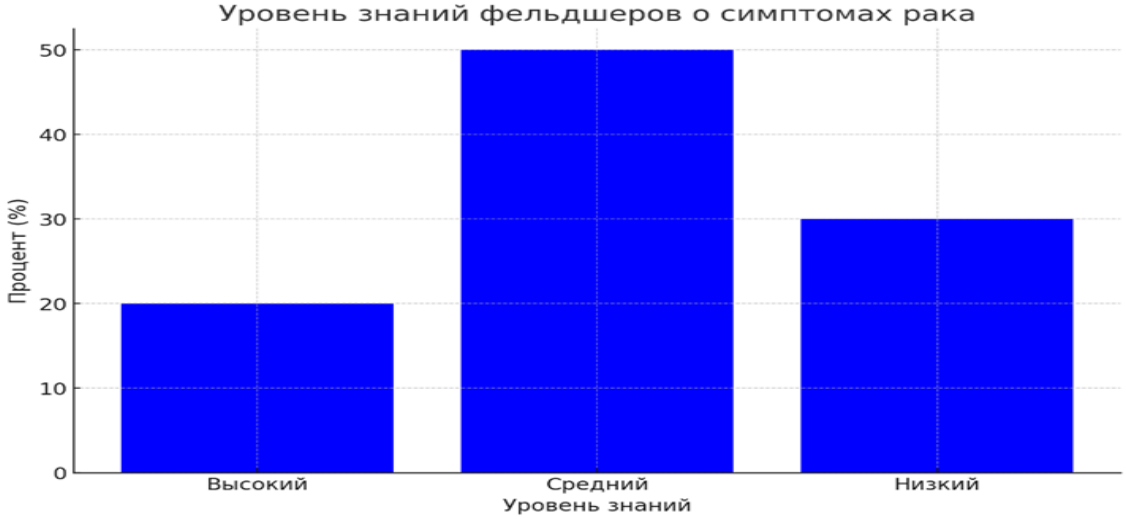
Были проанализированы 25 историй болезни пациентов с диагнозом «рак», чтобы выяснить, на какой стадии было выявлено заболевание и какова была роль фельдшера в процессе диагностики.

Интервью с фельдшерами. Проведено 10 интервью с фельдшерами для более глубокого понимания их подходов к диагностике рака, с акцентом на выявление ранних признаков заболевания.

Результаты исследования

Результаты анкетирования показали, что 20% фельдшеров имеют высокий уровень знаний о ранних симптомах рака, 50% — средний уровень, и 30% — низкий. Большинство фельдшеров сталкивались с пациентами, у которых впоследствии был диагностирован рак, но лишь 40% таких случаев были выявлены на ранней стадии.

Рисунок 1: Уровень знаний фельдшеров о симптомах рака



Анализ клинических случаев показал, что 60% заболеваний были выявлены на поздних стадиях, что значительно снижает вероятность успешного лечения. Ранняя диагностика наблюдалась в 40% случаев, что подчёркивает необходимость повышения квалификации фельдшеров.

Рисунок 2: Соотношение ранней и поздней диагностики рака

ISBN 978-601-08-0758-7



Обсуждение

Результаты исследования показывают, что уровень знаний фельдшеров о ранних симптомах рака оставляет желать лучшего. Только 20% из опрошенных фельдшеров обладают достаточными знаниями для своевременного выявления симптомов рака, что подтверждает необходимость разработки образовательных программ и проведения тренингов для медицинских работников среднего звена.

Фельдшеры в сельской местности часто являются единственными медицинскими специалистами, с которыми контактируют пациенты на начальной стадии заболевания. [3, стр. 210]

Недостаточная подготовка и отсутствие чётких алгоритмов действий в отношении онкологических заболеваний могут приводить к значительным задержкам в диагностике, что снижает шансы на успешное лечение. [3, стр. 210]

Рекомендации

1.Повышение квалификации фельдшеров. Необходимо разработать специальные обучающие программы, направленные на раннюю диагностику раковых заболеваний, с акцентом на выявление типичных симптомов на ранних стадиях.

2.**Введение чётких алгоритмов действий.** Фельдшерам следует предоставить подробные инструкции и алгоритмы диагностики рака, которые помогут им быстрее и эффективнее направлять пациентов на дальнейшее обследование.

3.Информирование населения. Важно проводить просветительские кампании среди населения, направленные на раннее выявление рака, с акцентом на необходимость регулярных осмотров и внимания к симптомам.

Выводы: Роль фельдшеров в ранней диагностике рака крайне важна, особенно в сельских районах, где доступ к специализированной помощи ограничен.

1. Уровень знаний фельдшеров о симптомах ранних стадий рака требует значительного повышения через специальные обучающие программы.
2. Внедрение чётких алгоритмов и рекомендаций позволит повысить эффективность работы фельдшеров и улучшить раннюю диагностику рака, что снизит уровень смертности от этого заболевания.

ISBN 978-601-08-0758-7

Список литературы:

1. Всемирная организация здравоохранения. Борьба с онкологическими заболеваниями. — ВОЗ, 2021. [1, стр.21]
2. Иванов А.А. Ранняя диагностика онкологических заболеваний в сельской медицине. — Медицинская практика, 2020. [2, стр.41]
3. Сидоров В.И., Петрова О.В. Роль среднего медицинского персонала в профилактике рака. — Вестник здравоохранения, 2021. [3, стр.165, 210]

ISBN 978-601-08-0758-7

ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ И ПРИКОРМ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА, КАК ПРОФИЛАКТИКА МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА

Дубатовская Александра Алексеевна, студент 3 курса, специальности «Лечебное дело»

Учреждение Медицинский колледж «Семей»

Научный руководитель: Кенжина Н.Б. «Общая медицина-бакалавр здравоохранения», преподаватель специальных дисциплин

Актуальность: *В природе человека заложено, что после рождения ребенка следует грудное вскармливание. Кормление грудью – лучший способ вырастить здоровых новорожденных. С грудным молоком ребенок получает специфические и врожденные иммунные факторы, макро - и микронутриенты для поддердания роста и развития малыша. Существует ли связь между грудным вскармливанием и метаболическим синдромом, или это просто гипотеза?*

Грудное вскармливание для новорожденных и младенцев является лучшим питанием, что побудило Всемирную организацию здравоохранения рекомендовать его, как эксклюзивный продукт питания в течении первых шести месяцев жизни и до двух лет и более с добавлением здорового питания. Благодаря своему составу питательных веществ, трофических и иммуномодулирующих факторов, он также может защитить от ожирения и метаболического синдрома.

В этой области ограниченное количество исследовании взаимосвязи между грудным вскармливанием и развитием метаболического синдрома у детей и подростков. Кормление грудью может защищать от метаболического синдрома.

Ряд исследовании показал, что кормление грудью может защищать от более позднего ожирения связанных с ним заболеваний обмена веществ. Грудное вскармливание ассоцируется со сниженем риска избыточного веса, снижением уровня холестерина и артериального давления крови и снижением риска развития сахарного диабета 2 типа.

Метаболический синдром связан с высоким риском сердечно-сосудистых заболевании и определяется совпадением трех из пяти компонентов: абдоминальное ожирение, систолическая и диатолическая гипертония, гипертригицеридемия, низкий уровень холестерина высокой плотности и гипергликемия натощак.

Продолжительность и исключительность грудного вскармливания является важным фактором риска развития сахарного диабета. Считается, что в человеческом молоке содержатся вещества, способствующие созреванию иммунной системы, которые защищают от возникновения сахарного диабета 1-го типа. Кроме того, человеческое молоко содержит биологические активные вещества, которые способствуют насыщению энергетическому балансу, предотвращая избыточный вес в детском возрасте, тем самым защищая от развития сахарного диабета 2 типа.

Правильное введение прикорма в течении первых двух лет жизни имеет решающее значение для профилактки ожирения и метболического синдрома у

ISBN 978-601-08-0758-7

детец. Этот период жизни считается критическим окном для обеспечения оптимального роста, развития и хорошего здоровья.

По эти данным, чем больше ребенок находится на грудном вскармливании и в последующем правильно переходит на здоровый прикорм, тем надежнее он защищен от ожирения и метаболического синдрома. Это исследование нам позволит усилить профилактику метаболического синдрома и ожирения среди детей, который принесет пользу обществу и здравоохранению.

Цель работы: Изучить связь между историей грудного вскармливания и настоящим ожирением, метаболическим синдромом у детей

Материалы и методы исследования: Дизайном исследования явилось поперечное одномоментное исследование. Были изучены антропометрические данные 50 детей младшего подросткового возраста 12 - 13 лет. Измерения проводились босиком и в легкой одежде. Каждое измерение проводилось дважды, усредняя полученные данные. Рост измерялся на ростомере, вес на электронных весах. Превышения показателей Индекса массы тела интерпретировалось как наличие метаболического синдрома. Группа детей без метаболического синдрома рассматривалась как контрольная группа, дети с метаболическим синдромом как группа исследования. Кроме того были изучены паспортные данные и социальные параметры. Путем анкетирования родителей исследуемых детей выяснялись особенности питания исследуемых в младенческом возрасте, собиралась информация о здоровий матери. Все этапы статистического анализа выполнялись в программе SPSS 20 Windows.

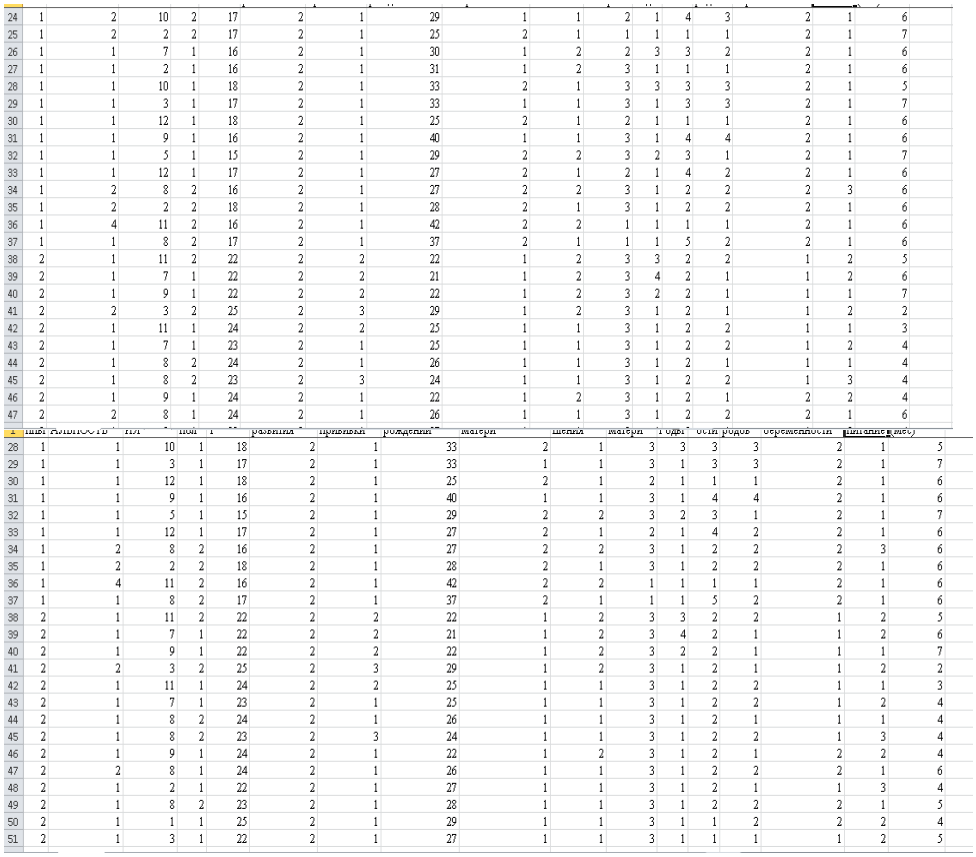
Результаты исследования:

Среди исследуемых количество детей с метаболическим синдромом составило 28% (n=14). В контрольной группе количество мальчиков составило 36,1% (n=13), девочек 63,9 % (n=23). В группе исследования 64,3 % (n=9) и 35,7% (n=5) соответственно. Средний показатель индекс массы тела в контрольной группе 16,56 (SD=0,97, p=0,001), в группе исследования 23,21 (SD=0,12, p=0,001).

Анализ данных, показывает, что выявлена статистически значимая положительная корреляция между индексом массы тела и особенностью питания (грудное, искусственное) исследуемых в младенческом возрасте (r=0,94, p=0,001)

1	группы	НАЦИОНАЛЬНОСТЬ	МЕСЯЦ РОЖДЕНИЯ	пол	Индекс Массы Т	порок развития	прививки	возраст матери при рождении	заболевания матери	способ родоразрешения	Образование матери	Роды	ет бере менности	паритет родов	прием препаратов во время беременности	питание	введение прикорма (мес)
7	1	1	6	2	18	2	1	30	2	1	3	1	1	3	2	1	6
8	1	1	9	2	16	2	1	21	1	1	3	1	1	1	2	1	6
9	1	1	8	2	18	2	1	30	1	1	3	1	2	2	2	2	6
10	1	3	9	2	17	2	1	33	2	1	3	1	5	3	2	1	6
11	1	1	9	2	17	2	1	36	1	1	1	1	1	1	2	1	6
12	1	2	12	1	17	2	1	27	1	1	1	1	1	1	2	1	6
13	1	2	9	2	16	2	1	36	1	1	1	1	4	4	2	1	6
14	1	2	7	1	16	2	1	34	2	1	3	1	1	1	2	1	6
15	1	1	4	1	18	2	1	24	2	1	2	1	2	2	2	1	6
16	1	1	8	2	16	2	2	36	2	2	3	3	3	1	2	2	6
17	1	1	11	2	17	2	1	37	2	1	2	1	5	4	2	1	6
18	1	1	9	2	17	2	1	32	2	3	2	1	2	2	2	1	6
19	1	1	1	2	16	2	1	24	2	1	3	1	2	2	1	1	6
20	1	1	10	2	17	2	1	27	2	1	1	1	2	2	2	1	5
21	1	1	12	1	18	2	1	29	2	1	2	1	3	3	2	1	6
22	1	1	7	2	16	2	1	23	2	2	1	3	2	2	1	1	6
23	1	1	1	2	15	2	2	26	2	1	2	1	3	2	2	1	6
24	1	2	10	2	17	2	1	29	1	1	2	1	4	3	2	1	6
25	1	2	2	2	17	2	1	25	2	1	1	1	1	1	2	1	7
26	1	1	7	1	16	2	1	30	1	2	2	3	3	2	2	1	6
27	1	1	2	1	16	2	1	31	1	2	3	1	1	1	2	1	6
28	1	1	10	1	18	2	1	33	2	1	3	3	3	3	2	1	5
29	1	1	3	1	17	2	1	33	1	1	3	1	3	3	2	1	7
30	1	1	12	1	18	2	1	25	2	1	2	1	1	1	2	1	6

ISBN 978-601-08-0758-7



24	1	2	10	2	17	2	1	29	1	1	2	1	4	3	2	1	6	
25	1	2	2	2	17	2	1	25	2	1	1	1	1	1	2	1	7	
26	1	1	7	1	16	2	1	30	1	2	2	3	3	2	2	1	6	
27	1	1	2	1	16	2	1	31	1	2	3	1	1	1	2	1	6	
28	1	1	10	1	18	2	1	33	2	1	3	3	3	3	2	1	5	
29	1	1	3	1	17	2	1	33	1	1	3	1	3	3	2	1	7	
30	1	1	12	1	18	2	1	25	2	1	2	1	1	1	2	1	6	
31	1	1	9	1	16	2	1	40	1	1	3	1	4	4	2	1	6	
32	1	1	5	1	15	2	1	29	2	2	3	2	3	1	2	1	7	
33	1	1	12	1	17	2	1	27	2	1	2	1	4	2	2	1	6	
34	1	2	8	2	16	2	1	27	2	2	3	1	2	2	2	3	6	
35	1	2	2	2	18	2	1	28	2	1	3	1	2	2	2	1	6	
36	1	4	11	2	16	2	1	42	2	2	1	1	1	1	2	1	6	
37	1	1	8	2	17	2	1	37	2	1	1	1	5	2	2	1	6	
38	2	1	11	2	22	2	2	22	1	2	3	3	2	2	1	2	5	
39	2	1	7	1	22	2	2	21	1	2	3	4	2	1	1	2	6	
40	2	1	9	1	22	2	2	22	1	2	3	2	2	1	1	1	7	
41	2	2	3	2	25	2	3	29	1	2	3	1	2	1	1	2	2	
42	2	1	11	1	24	2	2	25	1	1	3	1	2	2	1	1	3	
43	2	1	7	1	23	2	1	25	1	1	3	1	2	2	1	2	4	
44	2	1	8	2	24	2	1	26	1	1	3	1	2	1	1	1	4	
45	2	1	8	2	23	2	3	24	1	1	3	1	2	2	1	3	4	
46	2	1	9	1	24	2	1	22	1	2	3	1	2	1	2	2	4	
47	2	2	8	1	24	2	1	26	1	1	3	1	2	2	2	1	6	

28	1	1	10	1	18	2	1	33	2	1	3	3	3	3	2	1	5	
29	1	1	3	1	17	2	1	33	1	1	3	1	3	3	2	1	7	
30	1	1	12	1	18	2	1	25	2	1	2	1	1	1	2	1	6	
31	1	1	9	1	16	2	1	40	1	1	3	1	4	4	2	1	6	
32	1	1	5	1	15	2	1	29	2	2	3	2	3	1	2	1	7	
33	1	1	12	1	17	2	1	27	2	1	2	1	4	2	2	1	6	
34	1	2	8	2	16	2	1	27	2	2	3	1	2	2	2	3	6	
35	1	2	2	2	18	2	1	28	2	1	3	1	2	2	2	1	6	
36	1	4	11	2	16	2	1	42	2	2	1	1	1	1	2	1	6	
37	1	1	8	2	17	2	1	37	2	1	1	1	5	2	2	1	6	
38	2	1	11	2	22	2	2	22	1	2	3	3	2	2	1	2	5	
39	2	1	7	1	22	2	2	21	1	2	3	4	2	1	1	2	6	
40	2	1	9	1	22	2	2	22	1	2	3	2	2	1	1	1	7	
41	2	2	3	2	25	2	3	29	1	2	3	1	2	1	1	2	2	
42	2	1	11	1	24	2	2	25	1	1	3	1	2	2	1	1	3	
43	2	1	7	1	23	2	1	25	1	1	3	1	2	2	1	2	4	
44	2	1	8	2	24	2	1	26	1	1	3	1	2	1	1	1	4	
45	2	1	8	2	23	2	3	24	1	1	3	1	2	2	1	3	4	
46	2	1	9	1	24	2	1	22	1	2	3	1	2	1	2	2	4	
47	2	2	8	1	24	2	1	26	1	1	3	1	2	2	2	1	6	
48	2	1	2	1	22	2	1	27	1	1	3	1	2	1	1	3	4	
49	2	1	8	2	23	2	1	28	1	1	3	1	2	2	2	1	5	
50	2	1	1	1	25	2	1	29	1	1	3	1	1	2	2	2	4	
51	2	1	3	1	22	2	1	27	1	1	3	1	1	1	1	2	5	

Выводы: Поскольку метаболический синдром сопряжен с высоким риском нарушений здоровья, отдаленные прогнозы зависят от своевременности его диагностики, готовности ребенка и родителей перейти на здоровый образ жизни, соблюдать все врачебные рекомендации. Решающее значение имеет показатель массы тела: снижение веса всего на 8-10% от исходных значений сопровождается уменьшением процента висцерального жира, повышением чувствительности к инсулину. Грудное вскармливание является особым уровнем защиты от избыточного веса и ожирения у детей раннего подросткового возраста. Таким образом, грудное вскармливание играет важную роль в профилактике метаболитических нарушений у детей. Многие исследования показывают, что длительное грудное вскармливание способствует правильному развитию организма малышей и уменьшает риск развития таких заболеваний, как ожирение, диабет и метаболический синдром. Грудное молоко содержит все необходимые питательные вещества, гормоны и антибиотики, которые помогают укрепить иммунитет ребенка и обеспечить его нормальное физиологическое развитие. Благодаря уникальному составу молока, грудное вскармливание улучшает обмен веществ в организме малыша, помогает правильно сформировать метаболизм и предотвращает возможные нарушения в будущем. Поэтому, стимулирование и поддержка грудного вскармливания являются важными мерами по профилактике различных метаболических нарушений у детей. Важно помнить, что грудное молоко является оптимальным питанием для младенцев и способствует здоровому росту и развитию

ISBN 978-601-08-0758-7

ребенка. Вскармливание грудью – это не только способ питания, но и заботы, любви и защиты, которые так важны для правильного формирования здоровья малыша.

Списокок литературы:

1. Horta, B.L., de Mola, C.L., & Victora, C.G. (2015). **Long-term consequences of breastfeeding on cholesterol, obesity, systolic blood pressure, and type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis**. *Acta Paediatrica,* 104, 30-37. – Оценка долговременных последствий грудного вскармливания для метаболического здоровья.

2. Owen, C.G., Martin, R.M., Whincup, P.H., Smith, G.D., & Cook, D.G. (2005). **Effect of infant feeding on the risk of obesity across the life course: a quantitative review of published evidence**. *Pediatrics*, 115(5), 1367-1377. – Систематический обзор влияния грудного вскармливания на риск ожирения.

ISBN 978-601-08-0758-7

ХИРУРГИЯЛЫҚ ДИАГНОСТИКА ЖӘНЕ ЕМДЕУДІҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘДІСТЕРІ

Тұрысбай Думан, 3 курс, «Емдеу ісі» мамандығы
ҚДСБ ШЖҚ "Жоғары медициналық колледжі" КМК
Ғылыми жетекші: Жексенбек Н.А., №3 ЦӘК «Клиникалық пәндер» оқытушысы

Аннотация: *бұл мақала хирургиялық диагностика және емдеудің инновациялық әдістерін талдауға арналған. Жаңа технологиялар, оның ішінде жасанды интеллект, лапароскопия, роботтық хирургия және регенеративті медицина тәсілдері хирургиялық тәжірибеге кеңінен енгізілуде. Мақалада осы әдістердің қазіргі жағдайы, олардың артықшылықтары мен кемшіліктері, сондай-ақ болашақ перспективалары қарастырылады.*

Хирургиядағы заманауи инновациялық әдістер медицинадағы маңызды бағыттардың бірі болып табылады. Операциялық диагностика мен емдеуде қолданылатын жаңа технологиялар медициналық қызмет сапасын арттырып, науқастардың емдеу нәтижелерін жақсартуда. Бүгінгі таңда жасанды интеллект, лапароскопия, роботтық хирургия және регенеративті медицина сияқты әдістер кеңінен қолданылуда. Осы саладағы зерттеулердің маңыздылығы уақыт өте артуда, өйткені олар медициналық ғылымның дамуын айқындайды және хирургиялық әдістерді жетілдіреді.

Зерттеу мақсаты: хирургиялық диагностика мен емдеуде қолданылатын инновациялық әдістерді талдау, олардың тиімділігін талдау және инновациялық әдістерді қолданудағы қиындықтарды анықтау.

Зерттеу әдістері: хирургиялық диагностикадағы заманауи зерттеулер мен инновациялық технологиялар бойынша ғылыми әдебиеттер мен мақалаларға әдеби шолу жасау, салыстырмалы талдау жүргізу.

Хирургия – медицинадағы ең маңызды және дамып келе жатқан салалардың бірі. Жаңа технологиялар мен инновациялық әдістердің дамуы хирургиялық диагностикалау мен емдеу үдерісін түбегейлі өзгертіп келеді. Жасанды интеллект, молекулярлық диагностика, роботтық хирургия, және регенеративті медицина хирургиялық тәжірибеге терең еніп, жаңа деңгейге көтерді [1].

Диагностика хирургияның ең маңызды кезеңдерінің бірі болып табылады, себебі дұрыс диагноз – тиімді емдеудің кепілі. Соңғы жылдары диагностикалық құралдардың дәлдігі мен жылдамдығын арттыруға бағытталған инновациялар кең таралды [2].

Хирургиялық диагностиканың инновациялық әдістері:

ISBN 978-601-08-0758-7

Бейнелеу технологияларының дамуы: компьютерлік томография, магниттік-резонанстық томография және ультрадыбыстық зерттеулер секілді бейнелеу технологиялары хирургиялық диагностиканың негізін құрайды. Соңғы инновациялар ішінде жасанды интеллект бейнелеу анализі саласында ерекше орын алды. Жасанды интеллект алгоритмдері компьютерлік томография мен МРТ бейнелерін жылдам және дәл талдап, патологияларды ерте кезеңдерінде анықтауға көмектеседі [3].

Жасанды интеллект және машиналық оқыту: жасанды интеллект хирургиядағы диагностикаға маңызды үлес қосып жатыр. Машиналық оқыту жүйелері үлкен деректерді талдап, хирургия алдында нақты диагноз қоюға көмектеседі. Мысалы, ісік көлемі мен таралуын анықтауда ЖИ дәрігерлерге көмекші құрал ретінде қолданылады.

Молекулярлық диагностика: ДНҚ және РНҚ талдауларына негізделген молекулярлық диагностика әдістері хирургиялық емдеуде жеке емдеу жоспарын құруға мүмкіндік береді. Пациенттің генетикалық ерекшеліктеріне байланысты емдеу тәсілдерін таңдау персонализденген медицинаның дамуына ықпал етуде [2].

Хирургиялық емдеуде де көптеген жаңа технологиялар пайда болды. Бұл науқастардың қалпына келу уақытын қысқартып, хирургиялық араласулардың нәтижелілігін арттыруға бағытталған.

Лапароскопиялық және роботтық хирургия. Минималды инвазивті хирургия, соның ішінде лапароскопиялық және роботтық хирургия, заманауи хирургиядағы ең ірі жетістіктердің бірі болып табылады. Лапароскопиялық операциялар кішкентай тілік арқылы жүзеге асырылады, бұл тіндерге аз зақым келтіреді және науқастардың қалпына келу уақытын қысқартады. Роботталған жүйелер, мысалы, Да Винчи хирургиялық жүйесі, дәрігерлерге үлкен дәлдікпен және тұрақтылықпен операциялар жасауға мүмкіндік береді [4].

3D-басып шығару технологиялары хирургиялық дайындық пен операциялар алдында маңызды рөл атқарады. Науқастың анатомиялық құрылымын нақты басып шығару арқылы хирургтар операцияны егжей-тегжейлі жоспарлап, ықтимал асқынуларды алдын ала болжай алады.

Регенеративті медицина адам ағзасындағы тіндерді қалпына келтіруге бағытталған. Биоматериалдар мен дің жасушаларын қолдану арқылы зақымданған тіндерді қалпына келтіру, трансплантациялау мүмкіндіктері кеңеюде. Бұл әдіс, әсіресе, тері, сүйек және қан тамырларын қалпына келтіруде қолданылады.

Персонализденген хирургия – пациенттің жеке генетикалық және физиологиялық ерекшеліктеріне негізделген емдеу әдістерін қолдану. Бұл әдіс емдеудің дәлдігін арттырып, асқынулардың алдын алуға көмектеседі [3].

Алдағы жылдары хирургиядағы инновациялар жалғасады деп күтілуде. Жасанды интеллект, роботтар, және гендік инженерия технологияларының дамуымен хирургия толығымен өзгеруі мүмкін [5].

Жасанды интеллекттің хирургиялық процедураларды автоматтандыруы болашақта маңызды рөл атқарады. Мысалы, роботтық жүйелер жасанды интеллект көмегімен күрделі операцияларды дербес орындай алады. Биопринтинг арқылы тірі

ISBN 978-601-08-0758-7

тіндерді және ағзаларды басып шығару технологиясы орган трансплантациясындағы үлкен мәселені шешуге мүмкіндік береді. Бұл болашақта донор ағзасына деген қажеттілікті азайтады [4].

Инновациялық әдістерді қолданудағы қиындықтар:

1. Қаржылық және техникалық шектеулер: жаңа технологияларды енгізу үшін үлкен қаржы ресурстары мен арнайы дайындық қажет, бұл барлық медициналық мекемелерде қолжетімді бола бермейді.

2. Оқыту және хирургтардың дайындығы: инновациялық әдістерді тиімді қолдану үшін хирург мамандарды жаңа технологияларға сәйкес оқыту маңызды [5].

Қорытынды: хирургиядағы инновациялық әдістер медицинадағы ең маңызды өзгерістердің бірі болып отыр. Диагностика мен емдеудің жаңа тәсілдері дәрігерлерге пациенттерге жоғары сапалы және тиімді көмек көрсетуге мүмкіндік береді. Алдағы уақытта технологиялар мен ғылыми зерттеулердің дамуы хирургиялық практиканы одан әрі жетілдіріп, жаңа мүмкіндіктерге жол ашады.

Әдебиеттер тізімі:

1. Hashimoto, D. A., Rosman, G., Rus, D., & Meireles, O. R. (2018). Artificial intelligence in surgery: Promises and perils. Annals of Surgery, 268(1), 70-76.

2. Mazzucato, L., & Darnell, E. (2021). Regenerative medicine and bioprinting in modern surgery. Current Research in Biotechnology, 3, 101-108.

3. Nguyen, N. T., Hinojosa, M., Smith, B. R., & Reavis, K. M. (2013). Minimally invasive surgery: Past, present, and future. Surgical Innovation, 20(1), 6-10.

4. Breen, K. J., & Mayne, S. T. (2020). Molecular diagnostics and personalized surgical care. Nature Medicine, 26(7), 980-987.

5. Longo, W. E., & Ward, D. S. (2002). Surgical technology and the future of surgery. American Journal of Surgery, 184(3), 235-240.

ISBN 978-601-08-0758-7

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МӘСЕЛЕСІНДЕГІ ЗАМАНАУИ ТӘСІЛДЕР

Уахитова Ә.Е., 2 курс, «Емдеу ісі» мамандығы
«Д. Қалматаев атындағы мемлекеттік жоғарғы медицина колледжі» ШЖҚ КМК
Ғылыми жетекшісі Кокеева Д.Т., магистр, химия және биология пәнінің оқытушысы

Аннотация: *Бүгінгі күні ғылым мен медицина жүйрік қарқынмен дамып келетіндіктер зерттеу жүргіздік. Сондықтан денсаулық сақтау мәселесінің заманауи тәсілдерін анықтап, зерттедік. Баяндама өзектіліктен, мақсаты мен міндеттен, зерттеу бөлімі және қорытынды мен ұсыныстарды қамтыған. Негізгі бөлімі денсаулық сақтаудағы үздік заманауи тәсілдеріне және оның ерекшеліктеріне тоқталды. Зерттеу бөлімінде сауалнама және смарт, фитнес сағаттардың адам ағзасына кері әсерін зерттелінді. Қорытынды жасалып, ұсыныстар берілді.*

Бүгінгі күні ғылым мен медицина жүйрік қарқынмен дамып келеді. Қазіргі нарықта және жалпы денсаулық сақтау саласында не болып жатқанын білу үшін заманауи дәрігер осы саладағы соңғы жетістіктерді, соның ішінде әртүрлі әдеби көздерден ақпарат алуды, өз білімінің деңгейін үнемі арттыруды, заманауи әзірлемелерден хабардар болуды қажет етеді.

Зерттеу жұмысының мақсаты: денсаулық сақтау мәселесінің заманауи тәсілдерін анықтап, зерттеу.

Міндеттері:

1. Әдебиет көздері бойынша денсаулық сақтау мәселесінің заманауи тәсілдерін анықтау және зерттеу.
2. Әлеуметтік сауалнама негізінде халық арасында денсаулық сақтау мәселесінің заманауи тәсілдерінің танымал түрін анықтау.
3. Тәжірибе арқылы оның адам денсаулығына кері және оң әсеріне көз жеткізу.
4. Тәжірибе нәтижелерін көрсету және ұсыныстар жасау.

Денсаулық сақтау – қоғамның әлеуметтік өмірінің маңызды саласы. Бірнеше рет қайта құруларды басынан кешіріп алдағы уақытта дамуы жоспарланып отырған ұлт денсаулығы –еліміздің ұлттық саясатының басты бағыттарының бірі болып табылады[1].

Медицина да ғылыми-техникалық үрдіспен қатар дамып келе жатыр. Қазір таңда ғалымдар жаңа медициналық технологияларды жасауда. Осы арқылы дәрігерлер сәтті қадаммен диагностика мен емдеуді ертерек жүргізуге мүмкіндік алады. Өйткені бұл науқастардың ықтимал асқынулардың алдын алуға және өмірін жақсартуға көмектеседі.

ДДҰ-ның цифрлық денсаулық сақтаудың 2020-2025 жылдарға арналған жаһандық стратегиясы технологиялық медициналық көмек пациенттерге

ISBN 978-601-08-0758-7

қолжетімді болуы керек екенін атап өтті. Басымдықтар ретінде ақпараттың қауіпсіздігі мен құпиялылығы, деректерді өңдеудің ашықтығы және электрондық қызметтерге деген сенімді нығайту көрсетіледі. ДДҰ-ы технологиялық медицинаны денсаулық сақтаудағы жан-жақты қамтуды қамтамасыз ететін органикалық экожүйе ретінде дамуы керек деп санайды. Ұйым цифрландыру кезінде аз дамыған елдер кедергілерге тап болуы мүмкін екенін атап өтті. Оларды жеңу үшін инфрақұрылымды дамыту, адам әлеуетін арттыру және инвестиция тарту ұсынылады[2].

Денсаулық сақтаудағы үздік заманауи тәсілдері:

1. ***Жасанды интеллект*** (ЖИ) - бұл әртүрлі мәселелерді шешу үшін адамның логикасы мен ойлау процестерін компьютерге еліктеуі. Машиналық оқыту (МО) — ЖИ тармақтарының бірі — компьютер деректерді қабылдайтын және танитын процестерді қамтиды. Содан кейін машина анықталған тәуелділіктерге негізделген болжамдар жасайды. ЖИ-медицинаның әртүрлі салаларындағы ғалымдар мен дәрігерлердің көмекшісі болып табылады. Мысалы: электрондық медициналық деректерді басқару, аурулардың диагностикасы, медициналық және хирургиялық емдеуді жоспарлау, жеке медициналық көмек, денсаулық мониторингі, дәрі-дәрмектерді әзірлеу, виртуалды консультациялар өткізу. ЖИ денсаулық сақтау жүйесіне жүктемені азайтады. Қатерлі ісік, диабеттік ретинопатия, Альцгеймер ауруы, COVID-19 сияқты ауру түрлері — ертерек анықталады. Көптеген пациенттер уақтылы көмек алады және ауыр асқынуларға тап болмайды. ЖИ алгоритмдері күнделікті процестерді автоматтандырады және медициналық қызметкерлерге жүктемені азайтады[3].

2. ***Жеке чатбот: сөйлесу және ақпарат алу.*** Өкінішке орай, бүгінгі күні дәрігерден кеңес алу қиынға соғуы мүмкін, әсіресе егер бізге тар шеңберлі маманның кеңесі қажет болса. Жағдайды жеңілдету үшін чатбот - виртуалды онлайн-кеңесші, жасанды интеллект технологиясына негізделген сұхбаттасушы бағдарлама ойлап табылды, ол кейбір жағдайларда медициналық қызметкерді алмастыра алады. Мұндай бағдарламалар пациенттердің жауаптарын талдауға, нақтылайтын сұрақтар қоюға және нақты ұсыныстар беруге қабілетті. Мысалы, ***Your.MD*** бұл бүкіл әлемде жұмыс істейтін жасанды интеллект пен чатботқа негізделген жалғыз жеке медициналық көмекші. Жүйе әр пайдаланушының ерекше профиліне бейімделеді, оның белгілері туралы сұрақтар қоя алады және оның ауруы туралы оңай түсінікті ақпарат береді, сонымен қатар кәсіби дәрігерлердің қатысуымен жасалған кеңес береді. Your.MD пайдаланушы енгізген деректерді жақсы түсіну үшін табиғи тілді өңдеу алгоритмдерін, сондай-ақ диагнозды анықтау үшін желідегі ақпараттың үлкен көлемін талдау үшін машиналық оқыту алгоритмін қолданады[4].

3. ***Медициналық робототехника***. Робот медициналық операцияларды жасай ала ма? Ғалымдар бұл сұрақты 1970 жылдардан бері қойып келеді.

Хирургиядағы алғашқы медициналық роботтар ғарыштық және әскери жобалар ретінде пайда болды. Олар жетілдіріліп, операциялық бөлмелерге біртіндеп енгізілді. Роботтар күрделі хирургиялық оталар жасауға көмектеседі. Медицинада

ISBN 978-601-08-0758-7

роботтар не үшін қолданылады: грыжаны хирургиялық емдеуде, өт қабын алып тастауда, артық салмағы бар науқастарға көмектесу үшін бариартриялық хирургияда, ісіктен зардап шеккен несеп-жыныс мүшелерін алып тастауда, колоректальды және кардиоторакальды хирургияда, бас және мойын ісіктерін жоюда. Сонымен қатар, роботтар оңалту бағдарламаларына қатысады. Олар пациенттермен сөйлеседі және жағымды эмоционалды әсер ету арқылы оларды тыныштандырады. Роботтар ауруханада киім, тамақ және дәрі-дәрмектерді жеткізуге қатысады.

4. Ақыды сағаттар (Смарт сағаттар) - уақытты көрсетіп қана қоймай, сонымен қатар қадамдар санын өлшеуден бастап маңызды биологиялық көрсеткіштерді талдауға дейін көптеген басқа функцияларды орындайды. Соңғы жылдары смарт сағаттар медициналық зерттеулер аясында көбірек қолданыла бастады. Соның ішінде құрылғы пациенттердің жағдайын бақылауға көмектеседі:

- неврологиялық ауруларды. Паркинсон ауруы, Альцгеймер ауруы, эпилепсия және инсультпен ауыратын науқастарда бақылау жүргізеді. Құрылғы дауыс пен сөйлеудегі өзгерістерді, қозғалыс бұзылыстарын талдайды, құрысуларды тіркейді;
- жүрек-қан тамырлары ауруларымен. Жаттығудың болмауы кардиологиялық қауіп факторларының бірі болып табылады. Сондықтан бұл құрылғы күн ішінде жүріп өткен қашықтықты және физикалық белсенділікті объективті бағалауға көмектеседі. Бұл деректер пациент үшін өмір салтын өзгертудің күшті дәлелі болуы мүмкін. Құрылғы пайдаланушының жүрек соғу жиілігін бақылайды. Болашақта қан қысымы датчиктері, биохимиялық және биомеханикалық датчиктер одан да көп ақпарат береді. Өндірушілер оларды медицинада қолдану үшін жетілдіруде[5]. Сондай-ақ, смарт-сағат дәрі-дәрмек терапиясы мен диетаны ұстануды жақсартады. Құрылғы пациенттің жұту және шайнау кезіндегі қозғалысын бақылайды және оның қанша уақыт тамақ жегенін бағалайды. Смарт-сағат дәрі-дәрмекті қашан қабылдау керектігін еске салады.

Мониторинг саласындағы тағы бір жаңалық-патч түріндегі сенсорлар. Бұл теріге жабысатын кішкентай патчтар. Патчтар қан қысымын 24/7 режимінде өлшей алады, интракраниальды сұйықтық көлемінің ұлғаюын анықтай алады және тіпті ішкі ағзаларға ультрадыбыстық сканерлеу жасайды. Патч бір зерттегенде өмірлік маңызды функцияларды жүрек соғу, тыныс алу жиілігі және температураны қадағалайды.

5. ***Геномды талдау және өңдеу.*** Медицинада генетикалық кодты ашу үшін зертханалық әдіс қолданылады —ДНҚ секвенциясы. Ғалымдар ДНҚ тізбегін құрайтын химиялық қосылыстардың тізбегін — A, G, C және T нуклеотидтерін анықтайды. Портативті нанопора секвенері-бұл алаңға сәйкес келетін инновация. Шағын өлшемдердің артында қуатты секвенирлеу мүмкіндіктері жатыр. ДНҚ молекуласы құрылғының наноөлшемді ақуыз тесіктері арқылы өтеді және нақты уақыт режимінде оқылады. Геномды өңдеу жаңа жасуша сызықтарын немесе гендік модифицирленген жануарларды жасауға мүмкіндік береді.

6. Имплантацияланатын құрылғылар мен протездер. Медициналық импланттар-дененің ішіне немесе бетіне орналастырылған құрылғылар немесе

ISBN 978-601-08-0758-7

тіндер. Имплантанттар ұзақ уақыт бойы дене функцияларын бақылаудан бастап дененің жетіспейтін бөлігін ауыстыруға дейін медицинада әртүрлі мақсаттарда қолданылған. технологияның арқасында одан да көп инновациялық идеялар пайда болады. Имплантар ағзадағы процестер туралы ақпаратты компьютерге жібереді. Ортопедиялық протездер буынның қозғалысы туралы көбірек білу үшін қысым датчиктерін орналастырады. Жүрек-қан тамырлары көрсеткіштерін бағалау үшін имплантацияланатын датчиктерді жасалды. Нейрохирургияда мидың белсенділігі туралы деректерді Wi-Fi арқылы жіберетін прототиптер пайда болады.

7. Дәрі-дәрмектерді жеткізу жүйелері - бірнеше микрометрден аспайтын жаңа инновация түрі. Нанотехнология «курьер» бола алады. Зерттеушілер аурудың ошағына жеткізу үшін нанобөлшектерді — полимерлі, ақуызды, бейорганикалық — препараттың макромолекулаларымен жүктейді. Бұл жағдайда нанобөлшектердің физикалық және химиялық қасиеттері қажетті аймаққа бағытталатындай етіп өзгереді.

8. Биопринтинг - адамзаттың зақымданған немесе жоғалғанның орнына органдар мен тіндерді құру туралы көптен бергі арманының орындалуы. Инновацияның негізі-3D басып шығару әдістері. Басып шығару үшін арнайы сия мен қағаз қолданылады. Олар өміршең жасушалардан, биоматериалдан және биологиялық молекулалардан жасалады. Тіндердің немесе мүшелердің моделін жасау үшін пациенттің КТ және МРТ суреттері бағдарламаға жүктеледі. Содан кейін жасушалар оқшауланады, биоматериал таңдалады және био сияны жасайды. Басылған құрылым биореакторда жетіледі. Биопринтинг медицинаның бірнеше саласында трансплантацияда, дәрі-дәрмектерді табу және ғылыми зерттеулер жүргізу үшін қолданылады. Бұл әдіс көптеген дене жүйелері үшін тіндік құрылымдарды жасауға көмектеседі.

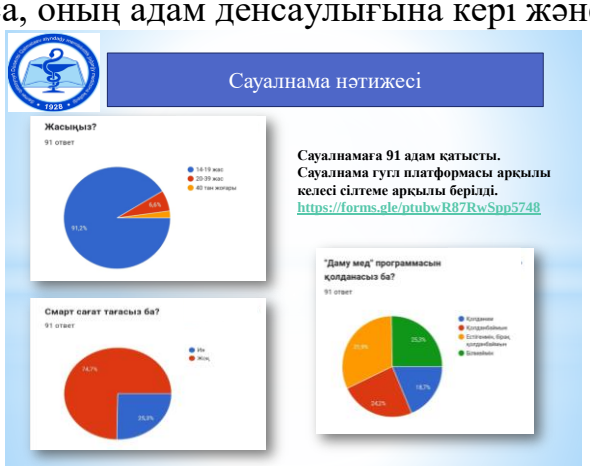
9. Жаңа вакциналар жасау. Рибонуклеин қышқылы (РНҚ) — ДНҚ-ға ұқсас бір тізбекті нуклеин қышқылы. РНҚ ақуыз синтезіне қатысады. Сондай-ақ, молекула кейбір вирустарда тұқым қуалайтын ақпарат қоймасы ретінде қызмет етеді. Вакциналардың жаңа түрі вирустық ақуыздың түзілуіне жауап беретін аРНҚ пайдаланады. аРНҚ негізіндегі вакциналар жеткілікті жылдам әзірленуде және ауқымды өндіріске жарамды. Бұл covid-19 пандемиясы кезінде денсаулық сақтау үшін маңызды болды.

10. Телемедицина - науқас бейнебайланыс бойынша дәрігермен кеңеседі. Телемедицина денсаулық сақтау мәселелерін шешу үшін телекоммуникация технологиясын қолданады: пациенттерді оқыту және кеңес беру; қашықтан бақылау; медициналық деректер мен суреттермен алмасу. Телемедицина шеңберінде консультациялар дәрігер-пациент және дәрігер-дәрігер телефон, электрондық пошта, бейне конференциялар немесе мобильді құрылғылар арқылы өткізіледі. Бұл жағдайда үйден кетудің қажеті жоқ-дәрігермен компьютер немесе смартфон арқылы байланысуға болады. Дәрігермен қашықтықтан сөйлесу кезінде пациент жұқтыру қаупін тудырмайды. Сондықтан COVID-19 пандемиясы кезінде телемедициналық қызметтерге жиі жүгінетін. Телемедицина емдеу мен диагностиканы қоса алғанда,

ISBN 978-601-08-0758-7

кешенді көмек көрсетуге және пациенттердің жағдайын қашықтан бақылауға көмектесті[3].

Зерттеу бөлімін әлеуметтік сауалнама негізінде халық арасында денсаулық сақтау мәселесінің заманауи тәсілдерінің танымал түрін анықтау. Ол үшін 7 сұрақтан тұратын сауалнама құрастырып гугл платформасы арқылы жүргізілді. Зерттеу нәтижесінде смарт-сағаттардың пайдалы тұстарын анықталды. Сонымен қоса, оның адам денсаулығына кері және оң әсеріне көз жеткізілді.





Қорытынды: Осылайша, заманауи технологиялар дәрігерлерге де, науқастарға да уақытты үнемдеуге көмектеседі және денсаулығына оң әсер етеді. Сонымен қатар, жаңа заманауи технологиялар мен ел тұрғындарын емдеуді ұйымдастыру тәсілдерін тәжірибеге енгізу кәсіби медициналық көмектің қолжетімділігін кеңейтуге және жақсартуға ықпал етеді.

Ғылыми жоба бойынша қорытынды ұсыныс:

- Денсаулық сақтаудағы үздік заманауи тәсілдерін пайдалану.
- Қарапайым халыққа заманауи тәсілдер туралы танымдық бейнероликтер түсірілсе.
- Пайдалы қызмет түрлерін қолдану.

Әдебиеттер тізімі:

1. https://ppt-online.org/261707
2. Global strategy on digital health 2020-2025. Geneva: World Health Organization; 2021. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
3. https://sbermed.ai/innovacii-v-medicine/
4. https://evercare.ru/news/top-8-samykh-perspektivnykh-tekhnologiy-v-zdravookhranenii
5. Болезни сердца и инсульт [Электронный ресурс]: CDC. URL:https://www.cdc.gov/chronicdisease/resources/publications/factsheets/heart-disease-stroke.htm.

ISBN 978-601-08-0758-7

ФЕЛЬДШЕРСКАЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНА: НОВЫЙ ПОДХОД К ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ. ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ РАБОТЫ ФЕЛЬДШЕРОВ ОСОБЕННО В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННЫХ РЕСУРСОВ

Хамитова Зарина Евгеньевна, Мурадимова Мейрамгуль Владимировна
3 курс, специальность «Лечебное дело»
ТОО «Западно-Казахстанский высший медицинский колледж»
Научный руководитель: Гусманова Лаура Кдырашевна
магистр, заведующая отделением «Лечебное дело» преподаватель специальных дисциплин.

***Аннотация**: Исследование направлено на необходимость для улучшения повышения качества и эффективности экстренной медицинской помощи. Для достижения поставленной цели было проведено интервью для выявления основных преимуществ и вызовов телемедицины с точки зрения фельдшеров скорой помощи.*

По определению ВОЗ, телемедицина – это предоставление услуг здравоохранении в условиях, когда расстояние является критическим фактором, работниками здравоохранения, использующими ИКТ для обмена необходимой информации в целях диагностики, лечения и профилактики заболеваний и травм, проведения исследований и оценок, а также для непрерывного образования медицинских работников в интересах улучшения здоровья населения. [3]

Скорая медицинская помощь (СМП) является одной из ключевых составляющих систем здравоохранения, предоставляя неотложную помощь пациентам в критических ситуациях. В условиях ограниченного доступа к медицинским учреждениям, особенно в отдаленных районах, возникают проблемы с оперативной диагностикой и координацией действий между СМП и больницами. Телемедицинские технологии предоставляют решение этих проблем, позволяя дистанционно консультировать специалистов, передавать данные о состоянии пациента и оптимизировать госпитализацию. [4]

Телемедицина в диагностике на до госпитальном этапе: позволяет ускорить процесс диагностики. С помощью мобильных устройств и телемедицинских платформ фельдшеры могут передавать жизненно важные показатели пациента, такие как ЭКГ, артериальное давление, насыщение кислородом и другие данные в режиме реального времени. Это дает возможность специалистам в стационаре оперативно консультировать бригаду скорой помощи, что особенно важно при подозрении на такие критические состояния, как инфаркт миокарда или инсульт. [2]

Улучшение координации с госпиталями: Телемедицинские технологии способствуют улучшению взаимодействия между бригадой скорой помощи и госпиталем. Например, возможность видеоконференцсвязи с врачами-специалистами позволяет оперативно получить консультацию и принять решение о транспортировке пациента в специализированное лечебное учреждение. Это

ISBN 978-601-08-0758-7

уменьшает время на определение оптимальной тактики лечения и подготовки к госпитализации.

Преимущества в отдаленных районах: Одним из важнейших преимуществ телемедицины является ее вклад в оказание медицинской помощи в удаленных районах. Фельдшеры могут получать помощь от специалистов, находящихся за сотки километров, что критически важно в ситуациях, когда каждый момент может спасти жизнь. Это особенно полезно при ограниченном количестве квалифицированных кадров в небольших населенных пунктах. Кроме того, телемедицинские технологии позволяют эффективно распределять ресурсы и избегать необоснованной госпитализации, что экономит средства и время.

Снижение временных затрат и увеличение шансов на успешное лечение: Благодаря телемедицинским консультациям, фельдшеры могут быстрее принимать решения о методах лечения, что сокращает время на до госпитальном этапе. Например, при подозрении на острое коронарное событие, врачи в режиме реального времени могут подтвердить диагноз и рекомендовать немедленное начало лечения до приезда в госпиталь. Это существенно увеличивает шансы на успешное лечение и выживание пациента. [1]

Технологические аспекты внедрения телемедицины в СМП: Для успешного применения телемедицины в работе скорой помощи необходимо наличие существующего оборудования и программного обеспечения и программного обеспечения. Наиболее распространенными решениями являются портативные устройства для мониторинга пациентов, мобильные приложения для передачи данных и специальные телемедицинские платформы для консультаций. Важно обеспечить доступность качественной связи, особенно в труднодоступных районах, что остается одной из ключевых задач.

Интервью с фельдшерами СМП:

1. Как вы понимаете концепцию телемедицины? Какие ее преимущества видите в вашей работе?
2. Используете ли вы телемедицинские технологии на практике?
3. Какие плюсы и минусы телемедицины вы можете выделить в контексте работы СМП?
4. Как на ваш взгляд телемедицина влияет на качество обслуживания пациента в экстренных ситуациях?
5. Как вы видите будущее телемедицины в СМП? Какие изменения по вашему мнению могут произойти в ближайшие годы?
6. Как телемедицина может улучшить доступ к медицинской помощи в удаленных или сельских районах?

Из интервью с фельдшерами СМП о телемедицине можно сделать несколько выводов:

1. Потенциал телемедицины: телемедицина имеет значительный потенциал для улучшения качества оказания экстренной медицинской помощи, позволяя быстрее получать консультации от специалистов и повышая эффективность работы бригад.

ISBN 978-601-08-0758-7

2. Проблемы и вызовы: несмотря на преимущества, существует и определенные вызовы, такие как технические сбои и необходимость личного общения с пациентами, что требует дальнейшего совершенствования технологии и подходов.

3. Обучение и адаптация: успех внедрения телемедицины во многом зависит от уровня подготовки медицинского персонала, что подчеркивает важность постоянного обучения и технической поддержки.

4. Будущее технологий: Ожидается, что телемедицина будет в дальнейшем развиваться, интегрируясь с новыми технологиями, что может значительно повысить ее эффективность и доступность.

Эти выводы подчеркивают необходимость дальнейших исследований и внедрения телемедицинских технологий в практику скорой медицинской помощи для достижения максимальной эффективности.

В таблице можно увидеть выводы из интервью с фельдшерами о телемедицине.

Категория	**Значимость (от 1 до 10)**	**Описание**
Потенциал телемедицины	9	Значительное улучшение качества экстренной помощи
Проблемы и вызовы	7	Технические сбои и необходимость личного общения
Обучение и адаптация	8	Важность подготовки и технической поддержки персонала
Будущее технологий	6	Ожидается развитие и интеграция с новыми технологиями в будущем
Важность обратной связи	7	Положительная реакция пациентов на телемедицинские услуги

Связь телемедицины с обучением можно рассмотреть в нескольких аспектах:

1. Образовательные платформы: использование телемедицинских технологий для создания онлайн курсов по медицинским дисциплинам, что позволяет студентам и врачам обучаться удаленно.

2. Дистанционное консультирование: студенты могут наблюдать за консультациями через видео-сессий, получая практически опыт и изучая взаимодействие с пациентами.

3. Симуляции и виртуальная реальность: интеграция телемедицинских технологий в симуляционные учебные программы для тренировки врачебных навыков в условиях, приближенных к реальным.

ISBN 978-601-08-0758-7

4. Междисциплинарное обучение: объединение специалистов различных областей (например, IT и медицины) для разработки новых решений в телемедицине, что требует совместного обучения и обмена знаниями.

5. Доступ к экспертизе: удаленные консультации позволяют студентам и врачам получать знания от ведущих экспертов, независимо от их местоположения.

Эти аспекты помогают развивать как профессиональные навыки, так и более широкий доступ к медицинскому образованию.

Выводы: в заключении хотим отметить, что телемедицина является важным инструментом в работе СМП, особенно в условиях ограниченного доступа к стационарным медицинским учреждениям. Ее использование позволяют улучшить диагностику, оптимизировать взаимодействие с госпиталями и существенно сократить время на до госпитальном этапе, что увеличивает шанс на успешное лечение пациентов. Внедрение телемедицинских технологий должно стать приоритетом в развитии системы СМП, особенно в отдаленных регионах.

Практические рекомендации:

1. Обучение персонала.

Регулярные тренинги: Проводите обучение по использованию телемедицинских технологий, включая работу с оборудованием и программным обеспечением.

Симуляции: организуйте симуляции экстренных случаев с использованием телемедицины для отработки навыков.

2. Техническая поддержка.

Круглосуточная поддержка: обеспечьте доступ к технической поддержке для быстрого решения проблем. На базе учреждении должны быть установлены мощные персональные компьютеры со специальным ПО для организации видео конференции. Нужно обратить внимание, что устаревшее оборудование не позволяет своевременно отслеживать состояние здоровья пациента, постоянно выходит из строя и «зависает» в самый неподходящий момент.

3. Учет потребностей пациентов.

Адаптация под пациентов: учитывайте предпочтения пациентов, например, в отношении формата общения (видео, аудио).

Результаты: Выявлены общие положительные отзывы о телемедицине от участников интервью, особенно по поводу удобства и эффективности.

Выводы: Телемедицина в скорой помощи имеет огромный потенциал для улучшения качества экстренного медицинского обслуживания. Тем не менее, для успешной интеграции требуется преодоление ряда вызовов, таких как доступность технологий, обучение персонала и соблюдение юридических норм. Будущее телемедицины в экстренной помощи зависит от дальнейших исследований и инноваций в этой области.

Список литературы:

1. Иванов А.А., Сидоров Б.Б. Телемедицина в экстренной медицинской помощи: перспективы и проблемы. Москва: Медицинская литература 2022 [1]

ISBN 978-601-08-0758-7

2. Петров В.В., Смирнов Г.Г. Применение телемедицинских технологий на догоспитальном этапе. Журнал скорой медицинской помощи 2021 №3. [2]

3. Телемедицина. Возможности и развития государствах членах ВОЗ. Доклад о результатах второго глобального обследования в области электронного здравоохранения. ВОЗ, 2010. Стр.93. [3]

4. World Health Organization. Telemedicine: opportunities and developments in member states. Report on the second global survey on eHealth. – Geneva: WHO, 2021 [4]

ISBN 978-601-08-0758-7

СЕКЦИЯ №2: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В МЕДИЦИНЕ.

ҚЫЗБАСЫ, ЭТИОЛОГИЯСЫ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯСЫ, ПАТОГЕНІ, КЛИНИКАСЫ, ДИАГНОСТИКАСЫ

Азбай Данияр Сейльханұлы, 3 курс «Емдеу ісі» мамандығы
ЖШС «Кентау колледжі»
Ғылыми жетекшісі: Пренов Нишанбек Меирбекович, арнайы пән оқытушысы, жоғары дәрежелі маман

Аннотация: *ҚҚГҚ – екі толқынды қызбамен, жалпы уыттанумен және айқын білінетін тромбогеммораргиялық синдроммен, өлім – жетімнің жоғары болуымен сипатталатын адамның жіті вирусты ауруы.*

Адам ауруды кенелер шаққан кезде, науқастың қаны мен қанды шығындылары арқылы, құрамында вирус бар материал теріге және сілемейлі қабықтарға түскен кезде, малды қырыққанда және оларды кенеледен қолмен тазартқан кезде кенелердің ішіндегісінің дененің ашық бөліктеріне түсуі нәтижесінде, ҚҚГҚ вирусымен зертханалық жағдайларда жұмыс істегенде, науқастарды күткенде және оларға медициналық көмек көрсету кезінде жұқтырады.

Этиологиясы. ҚҚГҚ қоздырғышы Bunyaviridae, Nairovirus тұқымдастығына жататын вирус болып табылады. Вирустың табиғаттағы негізгі резервуары мен инфекцияның көзі вирусты өзінің тұқымына трансовариалды немесе метаморфоза барысында беретін иксодты кенелердің (көбіне Hyalomma тектес) 27-ге жуық сан алуан түрлері мен шағын түрлері болып табылады. ҚҚҚҚ қоздырғышы Bonyaviridae род Nairovirus тектес вирус болып келеді [1]

Эпидемиологиясы. Вирустың уақытша резервуары - жануарлар (ірі қара мал, қойлар, ешкілер) болып табылады. ҚҚГҚ қоздырғышын негізгі тасымалдаушылар - Hyalomma asiaticum кенелері болып табылады. ҚҚГҚ эпидемиологиясында елеулі рөлді Қазақстанның оңтүстігінде тіршілік ететін Dermacentor niveus кенелері атқарады.Аурудың ошақтары көбіне климаты жылы және эндемиялық ошақтарының физикалық-географиялық ерекшеліктері бар шөл, шөлейт және далалы ландшафттарға ұштастырылған және осы аудандардағы жерді пайдалану үлгілерімен айқындалады. Тасымалдаушылардың белсенділігін кешігіп қайталайтын ауруға қатаң көктемгі-жазғы (сәуір, тамыз) маусымдылық тән. [2]

ҚҚҚҚ қоздырғышының негізгі тасымалдаушылары Hyaloma asiaticum кенелері. Ауру ошақтарының мекені: Шөлейт, Жартылай шөлейт, Далалық, Ландшафттар. Dermacentor niveus түрінің кенелерімен күресу үшін иыққа ілінетін шашыратқышпен бұталарды тозаңдату

Жұқтыру жолдары:

- Трансмиссивті кенелердің шағуы арқылы;
- Байланыстық науқастың жұқтырылған қанының кенені езу барысында теріге түсу барысында.

Таралуы: Қоздырғыштардың берілу жолдары трансмиссивті және контактілі.

ISBN 978-601-08-0758-7

Адам:

- иксодты кенелердің жабысуы нәтижесінде кененің шағуы арқылы;
- науқастың қаны мен қанды шығындылары арқылы
- ішінде вирус бар материал тері мен сілемейлі қабықшаларға түскен кезде
- -малды кенеден қолмен тазалағанда, малды қырыққанда дененің ашық жерлеріне кененің ішіндегі түскен кезде;
- -малды кенеден қолмен тазалағанда, малды
- қырыққанда дененің ашық жерлеріне кененің ішіндегі түскен кезде;

КҚГҚ-мен ауыратындар аурудың алғашқы күндері ішінде, әсіресе қан кету пайда болған сәттен бастап айналасындағылар үшін мейлінше қауіпті болады. КҚГҚ-мен ауыратын адамдардың отбасы мүшелері мен медицина қызметкерлері науқастарға алғашқы медициналық көмек көрсету процесінде және оларды күту кезінде жұқтырады. КҚГҚ вирусымен зертханалық жағдайларда жұмыс кезінде тамшы-респираторлық жолмен жұғуы мүмкін.

КҚГҚ кезінде сау адамдарда ұжымдық гуморальдық иммунитет деңгейі төмен болады. Сырқаттанғандарда антиденелер ауырғаннан кейін 3-5 жылдан астам сақталады. [4]

Тасымалдаушылар мен донор жануарлардың саны көбейген кезде ошақтардың эпизоотологиялық әлеуеті артады. Осы уақытта адамдардың бірлі-жарым және топтық жұқтыруы түрінде ошақтың эпидемиялық көрінісі байқалады.

Аурудың эпидемиологиясы ауылдық жерлерге ұштастырылған, сырқаттанғандардың кәсіптік құрамымен (шопандар, сауыншылар, мал шаруашылығы жұмысшылары және басқалар) айқындалатын жағдайлардың кездейсоқтығымен сипатталады. Адамдар жас шамасына қарамастан КҚГҚ-ны қабылдағыш болады, ауруға көбіне белсенді жұмыс істейтін жастағы (20-50 жас) адамдар шалдығады.

Классификациясы. Жалпы геморрагиялық қызбалар төмендегідей 3 топқа жіктеледі:

1. Масалық геморрагиялық қызба:
а) сары қызба
б) Денге геморрагиялық қызбасы
в) Рифт аңғарының қызбасы
2. Кенелік геморрагиялық қызбасы
а) Конго-Қырымдық геморрагиялық қызба
б) Омбы геморрагиялық қызбасы
3. Контагиозды геморрагиялық қызба
а) бүйрек синдромымен білінетін геморрагиялық қызба
в) Ласс қызбасы
г) Марбург қызбасы
д) Эбола қызбасы

Патогенезі. Аурудың дамуы қан тамырлардың қабырғасының өткізгіштігінің артуымен сипатталады. Вирусемия ауыр токсикоздан инфекциялық-токсиндік

ISBN 978-601-08-0758-7

шокқа апаруы мүмкін. Инфекцияның ену қақпасы кене шаққан орын болып табылады. Қан ұю жүйесінің бұзылыстары дамып, тамырішілік шашыранды қан ұю синдромы дамиды. Вирусемия сүйек миының зақымдануына алып келеді, соның салдарынан тромбоцитопения пайда болады.

Ауру ағымының клиникалық белгілері мен диагностикасы:

КҚГҚ кезінде инкубациялық кезең 2-7 күнге тең, сирек жағдайларда 12 күнге дейін созылады. Аурудың мынадай клиникалық кезеңдері бар:

1) бастапқы, 2) өршу кезеңі, 3) реконвалесценттік. [4]

Бастапқы кезең 1-3 күнге созылады. Аурудың басталуы жіті өтеді, науқастардың ауырған күнін ғана емес, сағатын да нақты көрсету керек. Продромальды кезең болмайды. Бас қатты ауырады, кенеттен әлсіздену, бұлшықеттер мен сүйектер, буындар, сирек жағдайда бел мен іш ауырады, ұйқының бұзылуы байқалады, тәбет нашарлайды, кейде тамақ ішуге байланысты емес жүрек айну және құсу байқалады. Дене қызуы 39-40 градус Цельсийге дейін жете отырып, тез көтеріледі және қалтыраумен кезектеседі. Науқасты қараған кезде бет, мойын және көкірек қуысының жоғарғы бөлігінің терісінің гиперемиясы анықталады. Конъюнктива гиперемияланған, ақ қабықтары инъекцияланған. Жұтқыншағы да гиперемияланған.

Перифериялық лимфатүйіндер ұлғаймаған. Жүрек шекаралары қалыпты, жүректің соғуы ақырын, ритмі дұрыс, салыстырмалы брадикардия (жүректің жиырылу жиілігінің дене температурасынан қалыс қалуы) байқалады. Артериялық қысым төмендейді. Өкпе жағынан физикалық деректер өзгерген. Тіл құрғақ, таза емес, кей жері қалыңдаған, тістің таңбалары бар. Іш жұмсақ, эпигастрияда және ішек жолдары бойында қолмен басып қарағанда ауырады. Пастернацкий симптомдары оң болуы мүмкін. Диурез бұзылмаған, нәжіс – іші қатады, кейде – іш өтеді. Дәл осы кезде геморрагиялық синдром кездеседі. Бастапқы кезеңнің геморрагиялық синдромы бөртпенің пайда болуымен, инъекция орындарында гематоманың пайда болуымен, мұрыннан қан кетумен сипатталады. Осы кезеңде жатыр, ішек және бүйрек сияқты қан кету түрлері жиі кездеседі. Жалпы қан анализінде ұйығандық – эритроциттер мен гемоглобиннің көбеюі, нейтрофилдердің формуласында солға жылжыған лейкопения, тромбоцитопения, эритроциттердің шөгуінің қалыпты немесе бірқалыпты жылдам жылдамдығы (бұдан әрі – СОЭ). Зәрде – альбуминурия, микрогематурия, кейде цилиндрурия кездеседі. [1]

Өршу кезеңі 4-7 күнге созылады және жалпы уыттанудың, геморрагиялық синдромның күшеюімен сипатталады. Осы кезеңде температура (көбіне 3-5 күнге) КҚГҚ-ға тән қос өркешті (дромодерлі) температуралық қисық түрінде байқалады. Температура геморрагиялық синдром басталар алдында немесе бірінші күні пайда болады. Бас ауруына, жалпы әлсізденуге, тәбеттің нашарлауына, жүректің айнуы мен құсуға шағымдану жалғасады. Сүйектегі, бұлшықеттердегі ауырсыну, ұйқы бұзылу азаяды. Науқастардың бет терісінің гиперемиясы, аққабықтар инъекциясы бар конъюктивтер сақталады.Өршу кезеңіндегі геморрагиялық синдром барынша ауыр, аурудың барынша тұрақты белгілерінің бірі болып табылады. Ол аурудың 2-5-

ISBN 978-601-08-0758-7

күні пайда болады және теріде, сілемейлі қабықшаларда геморрагиялық бөртпе, инъекция орындарында және басқа да жерлерде гематомалар түрінде, сондай-ақ әртүрлі ағзалардың қан кетулері түрінде білінеді. Бөртпелер көбіне петехиалды, кеудеде, дененің бүйір жақтарында, иықта орналасады. Ауыр түрде бөртпе ірі геморрагиялық, пішіні қисық, геморрагиялық жара түрінде болады. [2]

Қуыстан қан кетулерден көбіне науқастың өміріне қауіп төндіретін жатыр және асқазан-ішек қан кетулері кездеседі. Асқазанда «ыстық сезіміне» шағымдану көбіне асқазаннан молынан қан кетудің алдында болады, ол қан аралас немесе қан құсу түрінде клиникалық білінеді. КҚГҚ кезінде бүйректен молынан қан кету сирек кездеседі.

КҚГҚ-мен ауыратын науқастардың реконваленсценция кезеңі баяу өтеді. Осылайша, науқастардың 16%-ында аурудың 10-күнінен кейін де әлсіздік, бас ауруына шағымдану жалғасады. Науқастардың 8-10%-ында бет және мойын гиперемиясы бар сырты сипат сақталады. Дене температурасы жүйелі субфебрильді санға дейін көтеріледі, қысқа мерзімдік аздап мұрыннан қан кету қайталанады. Астеновегетативтік синдром, пульстың ауытқуы, гипотонияға бейімділік ұзақ уақыт сақталады[4]

Ауырлық дәрежесі бойынша аурудың жеңіл, ауырлығы орташа және ауыр түрлері ажыратылады.

Жеңіл түрі кезінде КҚГҚ ұзаққа созылмайтын қызбамен, әлсіздікпен, тәбеттің нашарлауымен, жалпы науқастанумен, бір қалыпты бас ауруымен өтеді. Мұрыннан қан кетеді. Терідегі бөртпе петехиалды, инъекция орындарында үлкен гематомалар байқалмайды. Бетте, мойында және кеуденің үстіңгі жағында тері гиперемиясы, ақ қабықтарының бір қалыпты инъекциясы мен ауыз жұтқыншақтың гиперемиясы үнемі болады. Қандағы өзгерістер – солға шамалы жылжыған бірқалыпты лейкопения, СОЭ жылдамдау үрдісі. Аурудың соңы жағымды, стационардан шыққаннан кейін бір ай ішінде еңбекке қабілеттілік толығымен қалпына келеді. [4]

Ауырлығы орташа түрде қызба кезеңі 4-7 апта созылады. Жалпы уыттану белгілері (сылбырлық, қатты бас ауруы, ұйқының бұзылуы, жүректің айнуы, кейде құсу, диарея) көрініп тұрады, геморрагиялық синдром айқын байқалады. Екі және одан артық ағзалардан жиі қан кетеді (500-600 мл). Геморрагиялық бөртпе неғұрлым ірі, гематомалар үлкен. Қандағы өзгерістер – шұғыл солға жылжыған лейкопения, анемия бар шамалы эритропения, СОЭ-ның жылдамдауы, тромбоцитопения, протромды индекстің төмендеуі. Қанның аурудың басынан бастап 4-5 аптадан кейін қалпына келуі. Науқастың жалпы жай-күйі 2 аптадан кейін жақсарады, бірақ еңбекке қабілеттілік аурудың басынан бастап 3 айдан кейін қалпына келеді.

Ауыр түр жалпы уыттылық белгілерінің қарқынды дамуымен сипатталады. Гипертермия аясында жалпы уыттану симптомдары артады (жоғарыда аталған белгілерге ақыл-ойдың бұзылуы, сандырақтау, мененгиалды және ошақтық симптомдар қосылады). Бірнеше ағзалардан молынан 1-2 литрға (бұдан әрі - л) дейін қан кетеді. Гематомалар көп, геморрагиялық пурпура. Шұғыл тромбоцитопениямен ДВС-синдромы дамиды. Коагулограммада протромбин индексінің, Б фибриноген санының төмендеуімен білінетін шұғыл өзгерістер. Сауығу баяу болады, ал еңбекке

ISBN 978-601-08-0758-7

қабілеттілік 6-12 айдан кейін қалпына келеді. КҚГҚ ауыр түрінің реконвалесценттері жұмысқа орналастыруды қажет етеді.КҚГҚ диагнозы клиникалық-эпидемиологиялық деректерге негізделуі тиіс. Анамнезде кененің шағуына, тойған кене қанының науқастың денесіне түсуіне, КҚГҚ-мен ауыратын науқастармен байланыста болуына, науқастың қанымен жанасуына назар аударылуы тиіс. Эпидемиялық кезеңде (көктем және жазғытұрым) КҚГҚ бойынша қолайсыз елді мекенде клиникасы ұқсас науқастар КҚГҚ-мен ауыратындар ретінде қадағалануға тиіс. Осындай жағдайларда оларды жұқпалы аурулар стационарына жатқызылғаннан кейін КҚГҚ кезіндегі ерекше режимді сақтай отырып, басқа аурулармен сараланған диагностиканы жүргізу керек. [3]

Ертерек диагностика геморрагиялық кезең алдындағы клиниканың есебіне негізделеді: тері, бет, мойын терісінің гиперемиясы, катаральды конъюктивит, склерит бар науқастардың өзіндік белгілері; жалпы уыттану, брадикардия, гипотония симптомдары бар қызбалар; фульгинозды тіл; кейде бауырдың ұлғаюы, перифериялық қанның (лейкопения, тромбоцитопения және басқалар) және зәрдің (бір қалыпты альбуминуриясы бар микроматурия, кейде цилиндрурия) өзіндік өзгерістері. [4]

Қорытынды: ҚҚГҚ дифференциальді диагностикасын менингококкты инфекциямен, тұмаумен, лептоспирозбен, тромбоцитопениялық пурпурамен (Верльгоф ауруы), геморрагиялық васкулит (Шенлейн-Генох ауруы), сепсис, сары қызбамен жүргізу керек. Науқастан эпид.анамнез дұрыс жиналуы ауруды ерте анықтауға көмегін тигізеді.

Әдебиеттер тізімі:

1. Инфекционные болезни Аликеева Г.К
2. Инфекционные болезни Шувалова Е.П
3. Инфекционные болезни Бегайдарова Р.Х
4. Емдік хаттама №60 29.03.2019ж.

ISBN 978-601-08-0758-7

МИКОЗ АУРУЫНДА САҢЫРАУҚҰЛАҚТАРМЕН ЗАҚЫМДАЛҒАН МАТЕРИАЛДАРДЫ ЗЕРТТЕУЛЕРДІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Бақытқерей Ақниет, 3 курс, «лабораториялық диагностика»мамандығы
Асқаров Сұлтан 3 курс, «Емдеу ісі»
Кеңес Одағының Батыры М.Мәметова атындағы Ақтөбе Жоғары медициналық колледжі
Ғылыми жетекшісі: Жулмагамбетова Н.К. педагог сарапшы , Тобажанова Р.Р.педагог сарапшы

Аннотация: *Бұл ғылыми жобада микоз ауруының 2022, 2023 және 2024 жылдардағы көрсеткіштері зерттелді. Жобаның мақсаты – микоз инфекцияларының динамикасын анықтап, жыл сайынғы өсу тенденцияларын талдау. Зерттеулер нәтижесінде микоз ауруларының 2022 жылдан бастап тұрақты өсім көрсеткені байқалды. Бұл саңырауқұлақ инфекцияларының денсаулық сақтау саласына ықпалының артып келе жатқанын және олардың таралуын бақылаудың маңыздылығын көрсетеді. Жоба барысында алынған мәліметтер медицинадағы диагностикалық және емдеу әдістерін жетілдіруге қажетті маңызды ақпарат береді.*

Соңғы жылдары жер бетіндеэкологиялық жағдайдың нашарлауы адам организміне кері әсерін тигізіп отыр. Осының себебінен адамның ауруға қарсы қабілеттілігі әлсіреп көптеген аурулар таралып барады, айта кетсек эндокринді жүйенің бұзылуы, гиповитаминоз, терінің микроциркуляциясының бұзылуы және тағы басқа факторлар әртүрлі тері ауруына әкеліп соқтырады, тері ауруларының ішіндегі кеңінен таралғаны және біздің елімізде көптеп кездесетін микоз ауруы.

Микоздарда жұқтыру көзі: ауру адам, жануарлар. Жұғу жолдары тікелей және тікелей емес жанасу. Жұқтыруға қолайлы факторлар экзогенді және эндогенді болып бөлінеді. Экзогенді факторларға қоздырғыштың вируленттілігі, тері қабатының жағдайы, жоғары температура, жоғары ph болуы жатады.

Эндогенді факторларға эндокринді бұзылулар, гиповитаминоз, терінің микроциркуляциясының бұзылуы, антибиотиктермен, глюкокортикоидтар, цитостатиктермен ұзақ уақыт емделу, қосалқы патологияның болуы жатады. Микоздардың негізгі белгілері мен симптомдары. Микозды абсолютты емделуінің күрделілігіне, кейін тап болатын салдарына қарай жеңіл дертке жатқызуға болмайды. Микоздарды идентификациялау тез және ең бастысы саңырауқұлақтар дертінен айғуға көмектеседі. Адамның жасы ұлғайған сайын микоздар анықталатыны дәлелденген, демек микоздарды 60 жастан асқан адамдардан жұқтыру мүмкіндігі жас адамдарға қарағанда әлде қайда жоғары екені анық. Микоздан қауіптену себептерін төменде келтірілген факторлар

ISBN 978-601-08-0758-7

тудырады: 1. терінің түлеуі (шелушение), 2. саусақтар арасындағы қабаттардың қышуының қозуы, 3. әртүрлі жарақаттардың пайда болуы, 4. аяқ ұшының қышып, терісінің түлеуі. 5. аяқтар ұшында ауырсынатын торсылдақтардың (пузырьки) пайда болуы. 6. тырнақтар құрылымының анық өзгеруі. 7. тырнақтарда дақтардың (көбінесе сары түсті) пайда болуы. 8. тырнақтардың қабыршақтанып түсуі. 9. микоздардың кейбір түрлерінің терінің терең қабаттарын сондайақ ішкі ағзаларды зақымдай алу қабілеттілігі. Осының барлығы иммунитеттің төмендеуінен, әртүрлі антибиот иктерді ұзақ уақыт қабылдағаннан, сондайақ созылмалы аурулар себебінен болады.





Микоздардың лабораториялық диагностикасы

Саңырауқұлақтар дерттерінің клиникасы полиморфты келеді, сол себепті диагноз әртүрлі жағдайда зертханалық зерттеу әдісімен анықталып қойылу керек. Микоздардың зертханалық диагностикасы үшін микроскопиялық, люминисцентті, культуралды, иммунологиялық (аллергологиялық және серологиялық) әдістер сондайақ жануарларға эксперименттер жүргізу қажет. Микоздардың лабораториялық диагностикасы бірнеше этаптардан тұрады. Қарапайым клиникалық практикада зақымдалған материалды микроскопиялық және культуралды әдістермен зерттеу қолданумен шектеледі.Қажетті жағдайда бұл әдістерге иммунологиялық, гистологиялық зерттеулер, эксперименттік жануарларға жұқтыру әдістері қосылады. Кейбір тері микоздарында диагностикада қосалқы зерттеу люминисцентті әдіс болып табылады.





ISBN 978-601-08-0758-7



Суретте: Ақтөбе тері-венерологиялық орталығының бактериологиялық, клиникалық зертханаларында науқастардан биоматериалдарды алу

Қабылдау кезінде дәрігер Рабаева Н. Т. науқастың тырнақтарының, терісінің, шырышты қабығының және шашының жағдайын бағалады. Дерматоскопия жасап, теріні үлкейту арқылы зерттеді. Тексерумен қатар дәрігер анамнез жинап, пациенттен оның өмір салты, тамақтану сапасы, тұрмыстық әдеттер мен күтім процедуралары туралы сұрады. Саңырауқұлақ инфекцияларын диагностикалау үшін микроскопиялық әдіспен теріні қырып алып зерттеді. 11 науқастан биоматериал алынды, микроскопиялық зерттеуге және посевке жіберілді. Посев немесе культуральды әдісі аурудың қоздырғышы туралы дәлірек ақпарат алуға мүмкіндік береді. Дәрігер микроскопиялық зерттеу және посевке жіберді. Зерттеу барысында 3 науқастан **саңырауқұлақтарының қоздырғыштары** табылды. Candida **саңырауқұлақтарының қоздырғышы,** дерматофит Trichophytonrubrum қоздырғышы және Epidermophytonfloccosum (қабыршақ тәрізді эпидермофитон) **қоздырғыштары** табылды. Осы натижелер бойынша диагноз қойылды.

Сонымен қатар Ақтөбе тері-венерологиялық орталығынан науқастардың саңырауқұлақтармен зақымдалу бойынша статистикалық мәліметтер алынды. Көбінесе антибиотиктерді көп қабылдағаннан әйелдердің цервикалды каналынан алынған материалдан кандида, сондайақ ота жасалғаннан кейінгі науқастардың ішперде сұйықтықтарынан да кандида анықталады. Соңғы кездері тамақтанда соның ішінде әртүрлі тоқаштарды артық қабылдағанда биоматериалдан (қан, несеп, асқазан сұйықтығы) саңырауқұлақтар анықталып отырады. Және зертханалық зерттеулер нәтижесімен арнаулы ем жүргізіледі. Диаграммада ауруханаңың бактериологиялық зертханасының соңғы 3 жыл ішінде (2021, 2022, 2023 жж) антибиотиктер мен тамақтар себебінен науқастардан алынған биоматериалдардан саңырауқұлақтар анықталып тіркелгені көрсетілген. 2021 жылы дәрілік препараттардан соның ішінде антибиотиктер, **глюкокортикоидтар, цитостатиктердің әсерінен 33 әйелде, 22 ер адамда, 2022 жылы 42 әйелде, 24 ер адамда, ал 2023 жылы 46 әйелде, 32 ер адамда биоматериалдан (қыннан бөлінді, ішперде сұйықтығы, қан) кандида анықталып тіркелген. Мұнда жыл сайын дәрілік препараттардың әсерінен кандиданың өсіп отырғаны**

ISBN 978-601-08-0758-7

байқалады. Бұл көрсеткіштер, дәріні науқастар өздігінше дәрігермен кеңеспей қабылдағанның айғағы.

Қорытынды: Оқу-зерттеу жұмысын аяқтай отырып үйірме мүшелері мынадай мәліметтерді анықтады:

1.Теориялық материалды зерттеу барысында біз паразиттік саңырауқұлақтар адам мен жануарлардың жұқпалы процестерінің себебі екенін анықтадық.

2. Студенттер арасындағы сауалнамалар студенттердің көпшілігі беткей микоздың алдын алу әдістері туралы хабардар екенін және оларды күнделікті өмірде сақтайтынын көрсетті.

3.Беткей микоздың алдын алу шаралары бойынша ұсыныстарды қолдана отырып, инфекцияның адамдар мен жануарларға таралуын болдырмауға болады.

Ауруханадағы науқастардың зертханалық зерттеуге алынған биологиялық материалдарды (шаш, тырнақ, жара бөліндісі, биопсия материалдары, қыннын бөлінді, ішперде сұйықтығы т.б.) зерттей отырып жоғарыда аталған саңырауқұлақтар тудыратын аурулардың келіп шығуын мына себептерге байланысты екені анықталған:

1. организмнің қорғаныс қызметі (иммунитет) төмендеуі:
2. эндокринді бұзылулар;
3. гиповитаминоз;
4. тері қабатының жағдайы;
5. қоздырғыштың вируленттілігі;
6. антибиотиктер, **глюкокортикоидтар,цитостатиктер препараттарымен ұзақ уақыт емделу;**
7. **қосалқы патологияның болуы**

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып микоз дертінің алдын алу үшін келесі шараларды ұсынады:

1. Организмнің қорғаныс қызметін нығайту, денені шынықтыру, спортпен айналысу (волейбол, жүгіру, бассейнде жүзу, баскетбол, шаңғы тебу).
2. Дұрыс және жүйелі түрде тамақтану (ашытқы қосылған нан-тоқаш тағамдары тамақ рационына көбірек жеміс, көк- өністерді, балық өнімдерін енгізу).
3. Демалуды дұрыс ұйымдастыру
4. Таза ауада көбірек серуендеу
5. Медициналық тексеруде жылына бір рет өтіп отыру
6. Антибиотиктер, **глюкокортикоидтар,цитостатиктерді өздігінше қабылдамай, олар мен дәрігер бақылауында емделіп, бұйырылған ем-домды бұлжытпай орындау**
7. Суық тиюден, стресс жағдайлардан сақтану
8. Теріні дұрыс күту.

ISBN 978-601-08-0758-7

Әдебиеттер тізімі:

1.Сергеев А. Ю., Бучинский О. И., Мокина Е. В., Жарикова Н. Е. Проект «Ахиллес»: эпидемиология стопы и онихомикозов в конце XX века // Российский журнал кожных и венерических болезней. 2002. № 5. С. 47–50.

2.Сергеев Ю. В., Баранова М. О., Савченко Н. В., Сергеев А. Ю. Аморолфин и современная практика лечения онихомикозов // Иммунопатология, аллергология, инфектология. 2016. № 1. С. 84–94.

3.Малярчук А. П. Использование метода скотч-проб для диагностики микозов стоп / Дерматовенерология и косметология: Синтез науки и практики, IV межрегиональный форум. 2016. С. 51.

4.Зачиняева А. В., Москалев А. В., Андреев В. А., Сбойчаков В. Б. Медицинская микология. Руководство для врачей. М., 2018.

ISBN 978-601-08-0758-7

ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ КАК ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ

Балгобаева В.У. 3 курс, специальность «Сестринское дело»
Бартусевич Ю.А., 3 курс, специальность «Лечебное дело»
КГП на ПХВ «Северо-Казахстанский высший медицинский колледж имени Жумагали Тлеулин» КГУ «УЗ акимата СКО»
Научный руководитель Байкенова М.Б., преподаватель специальных дисциплин

***Аннотация**: В данной статье представлен комплексный анализ язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Рассмотрены причины возникновения, симптомы, осложнения, а также современные подходы к профилактике заболевания. Кроме того, проведен анализ распространенности заболевания среди групп риска.*

Язвенная болезнь – хроническое воспаление слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки, сопровождающееся образованием язв. Это одно из наиболее распространенных заболеваний желудочно-кишечного тракта, которым страдает около 15% населения планеты, включая более 3 миллионов казахстанцев. Мужчины болеют чаще, особенно в возрасте 25-40 лет, а у женщин заболевание чаще проявляется после менопаузы. Главным виновником язвенной болезни считается бактерия Helicobacter pylori.

Другими немаловажными факторами являются: нарушение питания, длительный прием медикаментов, эмоциональный и физический стресс, вредные привычки (злоупотребление алкоголем, курение, применение наркотиков), нарушение обмена веществ, закрытая травма черепа.

Кроме того, при несвоевременном и неправильном лечении гепатита может образоваться язва. Поэтому язвенную болезнь можно рассматривать как «осложнение» гепатита.

У язвенной болезни характерные симптомы, по которым можно распознать данное заболевание.

Боль — это основной симптом. Боль будет локализоваться в подложечной области, возможна иррадиация в левую половину грудной клетки. Возникновение боли связано с приемом пищи. Принято различать: ранние боли через 0.5-1 часа после еды; поздние боли через 2-3 часа после еды; «голодные» боли, возникающие натощак; ночные боли. Встречается усиление боли во вторую половину дня.

Для язвенной болезни характерна сезонная периодичность, т.е. усиление боли в осенне-зимний период.

Изжога. Ранний симптом, может быть кислой, пустой. Возникает из-за слабости кардиального сфинктера.

Запоры. Возникает из-за диеты, которой придерживаются больные.

Отрыжка, тошнота и рвота. Встречаются реже всех остальных симптомов язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Рвота приносит облегчение пациенту, а отрыжка может быть кислой и пустой.

ISBN 978-601-08-0758-7

Язвенная болезнь страшна не только симптомами и легкостью перехода в хроническую форму, но и осложнениями.

Кровотечения. Картина сосудистой недостаточности: бледность кожных покровов, снижения артериального давления, рвота «кофейной гущей», возможно кровь в кале, тахикардия, головокружение. При более тяжелых случаях обморочное состояние и возможен коллапс.

Перфорация язвы. Возникновение сквозной язвы с выходом содержимого желудка или кишечника в брюшную полость. Данное осложнение является абсолютным показателем к оперативному вмешательству. «Кинжальная боль», метеоризм, черты лица заостряются, многократная кровавая рвота.

Стеноз привратника. Происходит вследствие рубцевания язвы. В результате чего образуется препятствие на пути пищи из желудка в двенадцатиперстную кишку.

Первичная профилактика направлена на предупреждение возникновения заболевания. При небольшом усилии довольно легко ее придерживаться.

Она подразумевает: соблюдение личной гигиены, в особенности ротовой полости, лечение зубов и десен. Употребление в необходимом количестве витаминов и минералов, отказ от вредных привычек, рациональная физическая нагрузка, пользоваться индивидуальными элементами личной гигиены; принимать пищу ежедневно в одно и тоже время; ограничить употребление острой, соленой, копченой, жареной, очень горячей пищи, а также газированных напитков.

Вторичная профилактика предусматривает снижение риска обострений и осложнений заболевания.

Для предупреждения обострений необходимо строго соблюдать диету. Применять необходимые лекарственные препараты, назначенные врачом. Санация инфекционных заболеваний, а также рентгенологические исследования, диспансерное наблюдение.

В рамках КГП на ПХВ «Северо-Казахстанский высший медицинский колледж имени Жумагали Тлеулин» КГУ «УЗ акимата СКО» была проведена исследовательская работа на тему «Риск возникновения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки у студентов медицинского колледжа».

Цель исследования:

- оценить распространенность язвенной болезни среди студентов;
- выявить студентов, находящихся в зоне риска развития заболевания;
- определить процентное соотношение здоровых студентов, студентов с высоким риском и студентов с подозрением на язвенную болезнь.

Задачи:

1. провести опрос студентов Северо-Казахстанского высшего медицинского колледжа имени Жумагали Тлеулин;
2. составить актуальные рекомендации по профилактике язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки для студентов.

Для сбора информации о распространенности язвенной болезни среди студентов мы использовали метод онлайн-опроса. Опрос был создан в Google

ISBN 978-601-08-0758-7

Формах и разослан респондентам через мессенджер WhatsApp. Опросник включал 13 вопросов, состоящих из двух групп: 1 - «провоцирующие факторы развития язвенной болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки», 2 - «симптомы язвенной болезни».

К первой группе относятся следующие вопросы:

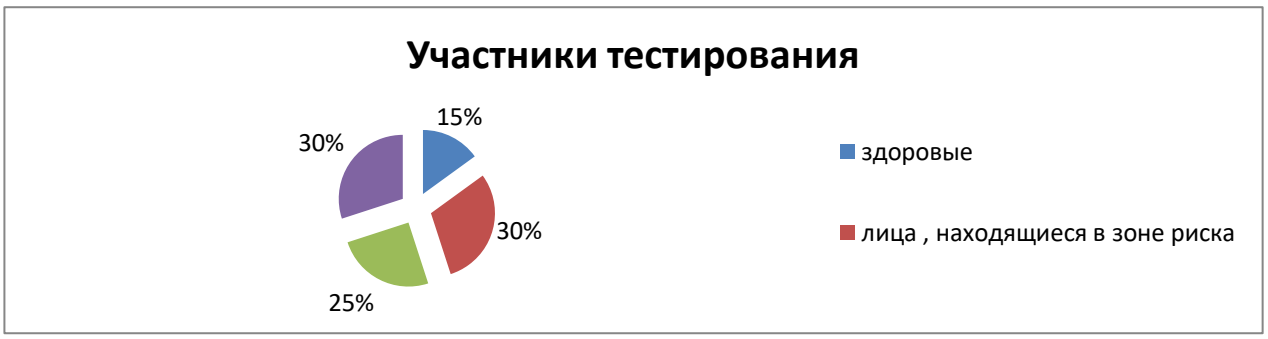
- Сколько раз в день Вы принимаете пищу? (самый популярный ответ: 3-4 раза в день – 49%)
- Какие блюда вы предпочитаете употреблять? (богатые жирами и быстрыми углеводами – 52%)
- Как часто вы употребляете алкоголь? (иногда – 27%)
- Вы часто испытываете эмоциональней и физический стресс? (иногда 42%)
- Занимаетесь ли вы самолечением (бесконтрольный прием лекарств)? (только при незначительных заболеваниях 66,6%)
- Как часто вы подвергаетесь инфекционным заболеванием? (1-2 раза в год – 50%)
- Как частот вы переедаете? (часто 70%)

Для формирования вопросов опроса мы опирались на распространенные причины возникновения язвенной болезни, которые часто связаны с неправильным питанием и стрессом. Поскольку студенческий образ жизни часто характеризуется нерегулярным питанием и эмоциональными нагрузками, мы предположили, что студенты медицинского колледжа могут быть подвержены повышенному риску развития этого заболевания. Опрос позволил нам проверить данную гипотезу.

Вторая группа была представлена такими вопросами:

- Бывают ли у вас боли в эпигастральной области? (нет 40%)
- Беспокоят ли вас запоры? (нет 60%)
- Вас беспокоит боль после приема пищи? (нет 50%)
- Как часто вас беспокоит изжога? (не беспокоит 60%)
- Как часто беспокоит отрыжка? (не беспокоит 58%)

Для создания опроса мы использовали информацию о наиболее распространенных симптомах язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Анализ результатов опроса позволит нам оценить, насколько часто эти симптомы встречаются среди опрошенных и сделать предварительные выводы о



состоянии их здоровья. Опрос был доступен в течение трех дней, и в нем приняли

ISBN 978-601-08-0758-7

участие 542 человека. Каждый участник выбирал один из четырех предложенных вариантов ответа.

Исходя из результатов тестирования, участники были распределены на 4 группы (1 - здоровые; 2 - в зоне риска; 3 - страдающие заболеванием; 4 - имеющие небольшие погрешности в образе жизни;) по следующим критериям:

1. Частота погрешности в режиме питания.
2. Наличие вредных привычек.
3. Частота возникновения нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта.
4. Подверженность эмоциональным стрессам.
5. Общее состояние здоровья.

1 группа - здоровые. Обучающиеся не имеют погрешностей в режиме питания, отсутствуют вредные привычки. Не подвергаются физическим и эмоциональным стрессам. Боли, отрыжка, изжога. тошнота и рвота не беспокоят. Лекарственные препараты принимают под контролем врача.

2 группа - лица с незначительными погрешностями в питании. Иногда позволяют себе употребить острую, жирную, пережаренную пищу, 1-2 раза в месяц переедают. В основном предпочитают разнообразие в еде. Принимают лекарственные препараты без назначения врача только при незначительных заболеваниях (насморк, боль в горле).

3 группа - лица, находящиеся в зоне риска. На постоянной основе переедают и употребляют острую, соленую, жирную, копченую пищу. Почти каждый день испытывают эмоциональный стресс. Регулярно употребляют алкоголь, беспокоят запоры. Занимаются самолечением.

4 группа - лица, вызывающие подозрения на наличие язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Постоянно возникают боли в эпигастральной области, они усиливаются после приема пищи. Беспокоит изжога и отрыжка несколько раз в день, а также страдают запорами. Очень часто испытывают эмоциональный стресс.

Проведенное исследование было направлено на оценку состояния студентов Северо-Казахстанского высшего медицинского колледжа имени Жумагали Тлеулин с целью выявления групп риска по развитию язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Была поставлена задача определить, какой процент обучающихся и сотрудников колледжа придерживается здорового питания, имеет незначительные отклонения в рационе или страдает от заболеваний желудочно-кишечного тракта. Полученные результаты исследования позволяют разработать персонализированные рекомендации по профилактике и лечению язвенной болезни, основанные на принципах здорового образа жизни, правильного питания и поддержания психического здоровья.

Проблема язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки остается актуальной в современном мире. Несмотря на то, что будущие медики обладают знаниями о здоровом образе жизни, они подвержены тем же рискам, что и их сверстники.

ISBN 978-601-08-0758-7

Согласно проведенному исследованию 45% опрошенных студентов колледжа придерживаются образа жизни, который может спровоцировать развитие этого заболевания. *Неправильное питание, бесконтрольный прием лекарственных препаратов и постоянные стрессы* – основные факторы риска, выявленные в ходе исследования.

Как снизить риск?

1. *сбалансированное питание:* включать в рацион больше свежих овощей и фруктов, цельнозерновых продуктов, нежирного мяса и рыбы. Ограничить потребление жирной, жареной и острой пищи, а также кофе и алкоголя;
2. *режим дня:* стараться ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, чтобы обеспечить организму полноценный отдых;
3. *управление стрессом:* найти для себя способы расслабления: йога, медитация, прогулки на свежем воздухе;
4. *регулярные медицинские осмотры:* не откладывать визит к врачу, если у вас появились подозрительные симптомы.

Нами разработаны несложные рекомендации, соблюдение которых поможет снизить риск развития язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.

Следует помнить, что профилактика язвенной болезни гораздо проще, чем ее лечение. Здоровый образ жизни и своевременное обращение к врачу помогут сохранить здоровье на долгие годы.

Список литературы:

1. Учебник Смолева Э.В. Аподиакос Е.Л. «Терапия с курсом первичной медико-санитарной помощи. [стр. 314]
2. Протокол МЗ РК «Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки»

ISBN 978-601-08-0758-7

БҮЙРЕК ТАС АУРУЛАРЫ. БҮЙРЕК ЖЕТКІЛІКСІЗДІГІ.

Болатова Балым, 2 курс, «Мейіргер ісі» мамандығы
Алматы қаласы ШЖҚ Жоғары медицина колледжі КМК
Ғылыми жетекшісі: Тажиев Ербол Елғондыұлы
Қазақ тілі мен әдебиеті пән оқытушысы

Аннотация: *Бүйрек тас ауруы, бүйрек жеткіліксіздігі, Литотрипсия(ультрадыбыспен ұсақтау), Ричарт Брайт, папаверин, рекорман, но-шпа, амоксициллин.*

Бүйрек ауруларының зерттелу тарихы медициналық маңызды бөлімдерінің бірі.Ежелгі бастап адамдар бүйрек ауруларының себептерін түсінуге және олардың емдеудеге тырысты.Бұл баяндамада бүйрек тас ауруы мен бүйрек жеткіліксіздігінің даму тарихы,зерттеу кезеңдері және қазіргі заманға медицинаның жетістіктері қарастырылған.

Бүйрек-ағзадағы қан құрамын тазалап, зәр арқылы қалдық заттарды шығаратын маңызды орган.Бүйрек ауруларының ішінде бүйрек тасы мен бүйре байк жеткіліксіздігі кең таралған .Бұл баяндамада аталған екі аурудың себептері,белгілері және емдеу жолдары қарастырылады**.**

Бүйрек тасы-бүйрек минералдар мен тұздардын пайда болатын қатты түзілімдер.

Тарихы:*Археалогиялық қазбалар нәтижесінде табылған ежелгі мумияларда бүйрек тастарының іздерін тапқан.Мысырлықтар бүйрек пен зәр шығару жолдарына назар аударған.*

Зерттегендер:Эбрес папирусыБ.З.Б.1550жыл сол заманда б8йрек ауруларын емдеу тәсілдері туралы мәліметтерді қамтиды.

Ежелгі Грецияда Гиппократ б.з.б. 460-370 жылдар және Рим дәрігері Гален несептің рөлін зеріттеп,зәр арқылы тастардың шығуын зерттейді

Әбу Әли ибн Сана оның «Дәрігерлік ғылым каноны» атты еңбегі бар.

Себептері:

1)Сұйықтықты жеткілікті тұтыну
2)Натрий және ақуызға бай тағамдарды шамадан тыс пайдалану
3)Зат алмасу бұзылыстары
4)Тұқым қуалаушылық

Белгілері:

1)Қатты бел ауыруы
2)Зәрден қан пайда болуы(гематурия)
3)Зәр шығару кезіндегі ауырсыну
4)Лоқсу және құсу

ISBN 978-601-08-0758-7

Диагностикасы:

1)Ультрадыбыстық зерттеу(УЗИ)

2)Компьютерлік томография(КТ)

3)Зәр және қан анализдері

Емдеу жолдары:

1)Дәрілік ем:Тастарды ерітетін немесе шығаруға көмектесетін дәрілер

2)Хирургиялық ем:Литотрипсия(ультрадыбыспен ұсақтау)немесе тасты алу операциясы

3)Диета:Сұйықтықты көбейту және тұзды азайту

Дәрілер:1)Зәр айдаушы дәрілер: Фуросемид

2)Спазмолитиктер: Папаверин,

Но-шпа

3)Антибиотиктер: Амоксициллин

Бүйрек жеткіліксіздігі-бүйректердің ағзаның қалдықтарын шығару функциясының бұзылуы

Тарихы:Бүйрек жеткіліксіздігі ежелгі уақытта толық түсінілмеген.зәр шығарудың бұзылуы және дененің ісінуі туралы деректер кездеседі.Бұл белгілер ауыр науқастың немесе уланудың салдары деп есептелген.

Зерттеген: Ричарт Брайт

Себептері:

1)Қант диабеті мен гипертензия

2)Созылмалы инфекциялар

3)Уытты заттардың әсері(дәрілер,алкоголь)

4)Жарақаттар немесе бүйрек қан айналымының бұзылуы

Белгілері:

1)Қан қысымының көтерілуі

2)Зәрдің азаюы немесе мүлде шықпауы

3)Аяқ-қолдың ісінуі

4)Тұрақты шаршағыштық және бас айналу

Диагностикасы:

1)Қандағы креатинин және несепнәр деңгейін анықтау

2)Зәр анализі

3)Бүйрек биопсиясы

Емдеу жолдары:

1)Дәрілік ем:Қан қысымын және қант деңгейін бақылау

2)Гемодиализ:Қан құрамындағы қалдықтарды аппарат арқылы тазарту

3)Трансплагтация:Бүйрек ауыстыру операциясы

Қорытынды :Бүйрек ауруларын дер кезінде анақтап ,

тиісті ем қолдану өте маңызды.Бүйрек тас ауруларының алдын алу үшін сұйықтықты жеткілікті мөлшерде ішу және диета сақтау керек.Ал бүйрек жеткіліксіздігіне шалдыққан жағдайда кешенді ем және дәрігердің тұрақты бақылауы қажет. **Дені сау бүйрек-ұзақ өмірдің кепілі!**

ISBN 978-601-08-0758-7

СТУДЕНТТІК УАҚЫТТА ПСИХОДИАГНОСТИКА ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ БОЛАШАҚ МЕДИЦИНАЛЫҚ МАМАН БОЛУҒА ӘСЕРІ

Даулетбек Ж.К., 3 курс, мамандық "Емдеу ісі"
Абай облысы денсаулық сақтау басқармасының «Дүйсенбі Қалматаев атындағы мемлекеттік жоғарғы медицина колледжі»
Ғылыми жетекші: Кадырбаева Н.К., жалпы кәсіби білім беретін пәндер оқытушысы

Аннотация: *Бұл мақалада медициналық студенттер үшін психодиогностиканың маңыздылығы қаралды.*

Қазіргі әлемде ақпараттық технологиялар мен интернет мүмкіндіктері саласында үлкен прогресс бар. Білім берудегі ғана емес, сонымен қатар кәсіби ортадағы жаһандық өзгерістерге байланысты болашақ маманның белгілі бір жағдайдағы білімін бағалау үшін өлшеу құралдарының қажеттіліктері артып келеді.

Мәселен, "жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы №600 бұйрығы негізінде жоғары медициналық колледждерге оқуға түсу үшін талапкер психометриялық тестілеуден өтуі тиіс. Тестілеу түсушінің эмпатиялық әлеуетінің қарқындылығын анықтауға бағытталған. Бұл жаңалық не үшін қажет? Ең алдымен, тест талапкердің психологиялық мүмкіндіктерін және оның адамдармен жұмыс істеу қабілетін бағалауға, адамгершілік, қарым-қатынас қабілеттері, оның стресске төзімділігі және үлкен физикалық еңбекке қабілеттілігі сияқты қасиеттерді бөліп көрсетуге арналған.

Тестілеудің бұл түрінің өзектілігі тек білім беру саласында ғана емес, сонымен қатар кадрларды іріктеу саласында да қолданылады.

Дәрігердің маңызды қасиеттері – бұл белгілі бір тұлғаға тән жеке, психологиялық, моральдық - этикалық, коммуникативті, эмпатикалық, интеллектуалды және эстетикалық қасиеттер мен ерекшеліктердің үлкен жиынтығы.

Зерттеу тақырыбы өзектілігі:Қазақстандағы студенттік уақытта психодиагностика қалыптастырудың болашақ медициналық маман болуға әсері өзекті тақырып болып табылады. Психодиагностика – бұл тұлғаның психологиялық жағдайын, мінез-құлқын және эмоцияларын зерттеу әдістері мен құралдарын қолдану. Болашақ медициналық мамандар үшін психодиагностика:

1. Науқаспен байланыс: Психологиялық аспектілерді түсіну, науқастармен тиімді қарым-қатынас орнатуға көмектеседі.
2. Диагностикалық дағдылар: Психикалық бұзылыстарды анықтау, емдеу жоспарларын жасау үшін маңызды.
3. Стресс пен күйзеліспен жұмыс: Медициналық ортада жиі кездесетін стресс жағдайларын басқару қабілетін арттырады.
4. Кәсіби этика: Психологиялық түсініктер кәсіби этика мен науқастардың құқықтарын сақтауға ықпал етеді.

ISBN 978-601-08-0758-7

5. Жеке даму: Студенттің өзін-өзі тану және жеке даму процесіне әсер етіп, кәсіби өсуіне жол ашады.

Осылайша, психодиагностика студенттердің кәсіби біліктілігін арттыруда, емдеу процесінде науқастардың психологиялық қажеттіліктерін ескере отырып, маңызды рөл атқарады.

Студенттік уақытта психодиагностика қалыптастырудың болашақ медициналық маман болуға әсері туралы зерттеулер мен статистикалық мәліметтер Еуропа елдерінде маңызды рөл атқарады. Еуропадағы медициналық білім берудің заманауи тенденциялары психологиялық даярлықты арттыруға бағытталған.

1. Психикалық денсаулық мәселелері: Еуропада психикалық денсаулыққа қатысты статистика алаңдатады. Мысалы, ЕО бойынша әрбір төртінші адам психикалық бұзылыстармен кездеседі. Бұл медициналық мамандардың психологиялық білімін арттыру қажеттілігін көрсетеді.

2. Білім беру бағдарламалары: Көптеген еуропалық университеттер психодиагностика курстарын енгізуде. Студенттердің 70%-дан астамы психологиялық аспектілерді оқыту бағдарламаларының маңызды бөлігі ретінде қарастырады.

3. Науқасқа күтім көрсету сапасы: Зерттеулер көрсеткендей, психодиагностика мен психологиялық даярлық деңгейі жоғары медициналық мамандар науқастармен тиімді байланыс орнату, диагностикалық процесті жетілдіру және емдеу нәтижелерін жақсарту бойынша жоғары нәтижелер көрсетеді.

4. Кәсіби burnout: Стресс деңгейі мен кәсіби күйзелісті төмендету үшін психологиялық білім мен дағдылар маңызды болып табылады. Статистика бойынша, медициналық қызметкерлердің 30%-дан астамы кәсіби күйзелістен зардап шегеді.

Осы факторлар студенттік уақытта психодиагностика қалыптастырудың болашақ медициналық маман болуына әсер етуін көрсетеді, сондай-ақ, медициналық білім берудің сапасын арттырудағы қажеттілікті дәлелдейді.

Зерттеу дәрігерлердің – болашақ жоғары білікті мамандардың құзыреттілік деңгейін анықтау мақсатында жүргізілді.

Осы мақсатқа жету үшін келесі міндеттерді орындау қажет болды:

1.психометриялық тестілеудің өзектілігі мен қолданылуының теориялық аспектілерін, оның қазіргі әлемдегі рөлін зерттеу;

2. Дүйсенбі Қалматаев жоғары медициналық колледжінің базасында "Мейіргер ісі" және “Емдеу ісі” мамандығында оқитын студенттер арасында сауалнама жүргізу;

3.болашақ жоғары білікті мамандарды қалыптастыру үшін жеке қасиеттерді жақсарту бойынша ұсыныстар әзірлеу.

Психодиагностика әдістерінің кешенін қолдану студенттердің кәсіби құзыреттілігін бақылауға және арттыруға мүмкіндік береді.

Материалдар мен әдістер. Тұлғаның психологиялық мүмкіндіктері мен тұлғалық ерекшеліктерін зерделеу мақсатында Дүйсенбі Қалматаев жоғары медициналық колледжінің студенттері арасында сауалнама жүргізілді. Сауалнама

ISBN 978-601-08-0758-7

Google Classroom платформасы арқылы жүзеге асырылды. Сауалнамаға 75 студент қатысты.

Респонденттерге сауалнаманың үш түрі берілді:

1.тұлғаның стресске төзімділігін анықтауға арналған тест;

2.негізгі құзыреттіліктерді дамытудың өзін-өзі бағалау тесті;

3.В. В. Бойконың эмпатикалық қабілет деңгейін диагностикалау сынағы.

Сауалнама жүргізер алдында әрбір респонденттен ақпараттандырылған келісім алынды, сондай-ақ әрбір респонденттерге анонимділік құқығы қалды.

Қатысушылар деректердің құпия түрде талданатынын және нәтижелер туралы белгілі бір адамды білу мүмкін болмайтындай етіп баяндалатынын білді.

Студенттердің жас және аумақтық тиесілігі ескерілмеді.

"Тұлғаның стресске төзімділігін анықтау" тесті стресске төзімділік деңгейін бағалауға мүмкіндік береді.

Нәтиже және талқылау. Жүргізілген зерттеу негізінде мыналар анықталды:

1. Респонденттердің 41% деңгейі бар стресске төзімділік орташадан сәл жоғары, 26% - орташадан жоғары, 25% - жоғары,

8% - өте жоғары.

Стресске төзімділіктің орташа деңгейі бар адам белгілі бір уақыттан кейін болса да, проблемалар мен қиындықтарға төтеп бере алады, бірақ қиын жағдайларды жібереді.

Стресске төзімділігі жоғары адам:

Өзін бағдарлай алады және сыни жағдайларда бірден шешім қабылдай алады;

басқалардың әрекеттерін қабылдауды біледі, сынды дұрыс қабылдайды;

Өзінде пайда болған эмоцияларды басқарады, ойларын ұтымды етуге және ақылға бағындыра алады.

Жоғарыда айтылғандардан студент-болашақ жоғары білікті медицина қызметкері стресске төзімділіктің жоғары деңгейіне ие болуы керектігін көре аламыз. Оқу барысында ол стресске төзімділік деңгейін жоғарылату дағдыларын үйренеді.

2. Респонденттердің 60% - жеке даму деңгейінде.

Сауалнаманың авторы бұл деңгейді қалай сипаттайды: адам жеке элементтер түрінде шектеулі құзыреттілікке ие. Құзыреттілік қарапайым немесе таныс жағдайларда көрінеді, ол бейтаныс, қиын жағдайларда көрінбейді.

Барлық құзыреттердің ішінде басқалармен ынтымақтастық, эмоционалды интеллект, тиімді жұмыс іздеу сияқты дағдылардың арасында салыстырмалы тәжірибе деңгейі (27%) бар.

Тәжірибе деңгейі: адам стандартты жұмыс міндеттерін шешу үшін өз құзыреттілігін сәтті пайдаланады. Жаңа, стандартты емес жағдайларда құзыреттілік жеке фрагменттер түрінде көрінеді, тұрақсыз. Өзінің және басқалардың мінез-құлқындағы құзыреттіліктің мінез-құлық көріністерін саналы түрде бақылайды.

Сонымен қатар, студент өзінің негізгі құзыреттерін дербес дамытуы керек. Жаңа білімді іс жүзінде қолдану, нәтижелерін бақылау және басқалардан кері байланыс сұрау. Дағдыларды игеруде серіктестер мен сарапшы тәлімгерлерді табу.

ISBN 978-601-08-0758-7

3. 61% - эмпатияның төмен деңгейі, 27% - өте төмен деңгей және 12% - орташа деңгей.

Студенттердің эмпатия деңгейін арттыру қажет. Негізгі құзыреттердегідей, эмпатия деңгейін дамыту үшін жағдай жасау үшін сауатты білім беру процесі қажет.

Қорытынды ретінде келесілерді ұсынамын:

1.Салауатты өмір салты. Дене шынықтырумен үнемі айналысу, дұрыс ұйықтау және дұрыс тамақтану стресске төзімділік деңгейін арттырады.

2.Жағдайды дұрыс бағалау және эмоциялардың шығуы. Кейбір жағдайлар өзімізге тәуелді емес екенін түсіну маңызды, өйткені оларды жүрекке тым жақын қабылдаудың қажеті жоқ. Жағымсыз эмоциялардың шашырауын таңдау оларды өзіңізде сақтамауға мүмкіндік береді.

3.Өзін-өзі тәрбиелеу және өз кәсібіне деген қызығушылықты арттыру. Өзін-өзі тәрбиелеу, білім берудің басқа түрлері сияқты, адамға өмірінде болып жатқан себеп – салдарлық байланыстарды жақсы түсінуге көмектеседі және ең бастысы-адамға ең аз сыртқы көмекпен қажетті теориялық және практикалық тәжірибе алуға мүмкіндік береді.

4.Тапсырмаларды орындауға шығармашылық көзқарас. Тапсырмаға механикалық дайындалу емес, әртүрлі әдістер мен тәсілдерді жан-жақты қолдану маңызды.

5.Теориялық база. Қосымша әдебиеттер мен мақалаларды үнемі зерделеу білімді тереңдетуге, сондай-ақ зерттелетін саладағы өзгерістер туралы түсінік алуға мүмкіндік береді.

6.Жиі қарым-қатынас және белсенді тыңдау мүмкіндігі. Осылайша сіз әлемге басқа адамның көзімен қарауды үйренесіз және эмпатия дағдыларыңызды жаттықтырасыз. Тәрбие процесіне қатысу, конкурстар, дөңгелек үстелдер, тренингтер және тәрбие процесінің басқа да түрлері арқылы қоғамда болуға ғана емес, сонымен қатар сыныптастарымен үнемі қарым-қатынас жасауға мүмкіндік береді.

Кесте 1.- Іс-шараларды өткізу бойынша ұсынымдар

	Бөлім	Іс - шара
	Салауатты өмір салты үйірмесі, онда негізгі принциптер түсініледі	1.Спорт секцияларының жұмысы. 2.Экологиялық клубты ұйымдастыру. 3.Жұмыс қабілеттілігін арттыру тәсілдерін зерделеу бойынша арнайы курстардың жұмысы (көзге, қолға, аяққа арналған гимнастика тәсілдерін, өзін-өзі массаждау және релаксация тәсілдерін оқыту). 4.Спорт залдарына, бассейндерге бару үшін жағдай жасау..
	Мамандарме н кездесу	1.Тақырыптық пікірталастар 2. Тақырыптық дөңгелек үстелдер
	Білім беру	1.Заманауи оқыту құралдарын пайдалану.

ISBN 978-601-08-0758-7

	процесіне белсенді қатысу	
	Ғылыми-зерттеу жұмысына қатысу	1.Секциялар бойынша ғылыми үйірмелер ұйымдастыру 2.Колледж ішіндегі конференцияларға, сондай-ақ қалалық, облыстық, халықаралық конференцияларға қатысу.
	Қарым-қатынас дағдыларын арттыру	1."Мейірімділік" үйірмесіне қатысу. 2. Қайырымдылық акцияларына қатысу. 3. Емхана базаларында еріктілік 4. Біліктілік деңгейін арттыру 5. Коммуникативтік дағдылар орталығында манипуляцияларды пысықтау
	Психологпен жұмыс	1.Тақырыптық тренингтер. 2. Жеке және топтық кеңес беру. 3.Студенттердің өмірлік мақсаттарымен және жеке өзін-өзі анықтауымен жұмыс.

Қорытынды. Студенттік уақытта психодиагностика қалыптастыру болашақ медициналық маман болуға үлкен әсер етеді. Бұл процесс кәсіби дағдыларды жетілдіруге, науқастармен тиімді байланыс орнатуға, стресс деңгейін төмендетуге және этикалық стандарттарды сақтауға көмектеседі. Психодиагностикалық білімдер медициналық қызметтердің сапасын арттыруға және пациенттермен жақсы қарым-қатынас орнатуға ықпал етеді. Осылайша, психодиагностика студенттердің кәсіби қалыптасуына және медициналық саладағы табыстылығына елеулі әсер етеді.

Әдебиеттер тізімі:

1. 2009-2015 жылдың қорытындысы бойынша "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау секторында технологияларды беру және институционалдық реформаны жүргізу" жобасын іске асыру туралы есебі.Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкі, Астана, 2015.

2.Васильева А. З. Инновационные методы подготовки специалистов. здравоохранения среднего звена для обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи // Главная медицинская сестра. – 2010. – N 9**.(қазақ тіліне аударылды)**

3.Основы проведения научных исследований в области сестринского дела: Методические рекомендации / Республиканский центр развития здравоохранения, 2018. **(қазақ тіліне аударылды)**

4.Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты: учеб. пособие. Самара: БАХРАХ, 1998. **(қазақ тіліне аударылды)**

5.Куликов, Л.В. Психологическая устойчивость личности / Л.В. Куликов // Психогигиена личности: вопросы психологической устойчивости и психопрофилактики. -СПб.: Питер, 2004. **(қазақ тіліне аударылды)**

ISBN 978-601-08-0758-7

6.Бойко В. В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других. М.: Филинъ, 1996. **(қазақ тіліне аударылды)**

7.Беребин М. А., Астаева А. В. «К вопросу о качественном и психометрическом подходах в современной нейропсихологической диагностике»/ «Психология. Психофизиология» №4, 2008. **(қазақ тіліне аударылды)**

ISBN 978-601-08-0758-7

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА: ОСОБЕННОСТИ УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ В УЧЕБНУЮ И СОЦИАЛЬНУЮ СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА.

КГП НА ПХВ "Усть-каменогорский высший медицинский колледж"
Выполнил исследовательскую работу: Штаненко Владислав
Руководитель исследовательской работы: Папышева Гульжан Кайкеновна

Аннотация: *Адаптация студентов в группе и в новом образовательном учреждении – самая главная проблема, которую необходимо преодолеть, как можно быстрее и, желательно, с положительным исходом.*

Колледж и его преподаватели в преодолении этой проблемы играют большую роль. Первокурсники при поступлении в первую очередь приобретают новую роль – студент, они методом проб и ошибок пытаются освоить ожидаемое от них поведение, на основе которого строят отношения со сверстниками, преподавателями. Большую роль в социальной адаптации играет формирование группы, чем быстрее она сформируется, тем быстрее студенты освоят свою новую роль.

Каждый год, как все учебные заведения, наш колледж гостеприимно распахивает двери для пополнения большого и дружного коллектива студентов, которые поступают из разных школ республики и не только, и становятся первокурсниками нашего учебного заведения. Переход из школы в колледж является для многих из них переломным моментом в жизни, потому что не каждый взрослеющий подросток самостоятельно, без поддержки взрослых может приспособиться к новым, важным для него условиям, а также безболезненно их пережить.

В момент адаптации у студентов происходит кардинальная смена деятельности и окружения, их внутренние установки претерпевают сильные изменения. Происходит переориентация ценностей, освоение новых социальных ролей, студенты по - другому начинают воспринимать себя и других. Успешная адаптация первокурсника к жизни в колледже является залогом дальнейшего развития каждого студента как личности и как будущего специалиста.

Актуальность: Адаптация к студенческой жизни является неотъемлемой частью для каждого студента. С момента поступления в колледж начинается процесс привыкания к новой среде, к общественному окружению, требованиям и порядкам.

Цель исследования: Определить уровень адаптации студентов первого курса, узнать мотив при выборе колледжа и специальности, оценить социально-психологическую адаптацию студентов первого курса к обучению в колледже, почему студенты поступили именно в наш колледж, Какие изменения студенты хотели бы ввести в колледж.

Задачи: Создания успешно благоприятные условия для развития личности студентов, свободного или полного раскрытия их способностей в условиях

ISBN 978-601-08-0758-7

колледжа, установление и поддержание социального статуса в новом коллективе, провести анкетирование, на основе сделанных выводов предложить рекомендации преподавателям

Объект исследования: особенности социально-психологической адаптации студентов – первокурсников к обучению в колледже.

Предмет исследования: студент первого курса как субъект психологической адаптации.

Практическая значимость: Разработаны практические рекомендации по организации обучения, ориентированного на адаптацию студентов первого курса к обучению в колледже.

Рекомендации для преподавателей:
Главная задача преподавателя, особенно в адаптационный период, раскрыть перед студентами широкое поле выбора, которое часто не открывается перед людьми юношеского возраста из-за их ограниченного жизненного опыта, недостатка знаний и не освоенности всего богатства культуры.
В связи с этим преподавателю необходимо:
- знать особенности состояния здоровья студентов, бытовых и семейных условийих жизнедеятельности;
- постоянно участвовать в жизни группы, обеспечивая защищенность интересов каждого;
- работать над созданием благоприятной атмосферы в группе, формированием коллектива, коммуникативных компетенций у студентов;
- постараться создать условия для максимального развития личности каждого студента;
- приобщать студентов к участию в творческой деятельности учебного заведения;
- способствовать формированию у студентов позитивного отношения к окружающей действительности

Вопросы анкетирования:

Для того чтобы студент хорошо учился, не пропускал занятия и правильно себя вел, нужно?

* Знал свои цели и поступал в колледж, осознанно.
* Изменить программу обучения давать интересней материал.
* Понятный объём информации на парах.
* Придумывать хорошую схему обучения по парам.
* Преподаватели относились с пониманием.
* Обучить студента правилам внутреннего распорядка.
* Не пропускать занятия и выполнять д/з
* Дистанционное обучение по субботам.
* Сделать больше практики.
* Создать комфортную атмосферу в колледже.
* Составить график дня.
* Быть дисциплинированным.
* Что бы преподаватель был заинтересован в своём предмете.

ISBN 978-601-08-0758-7

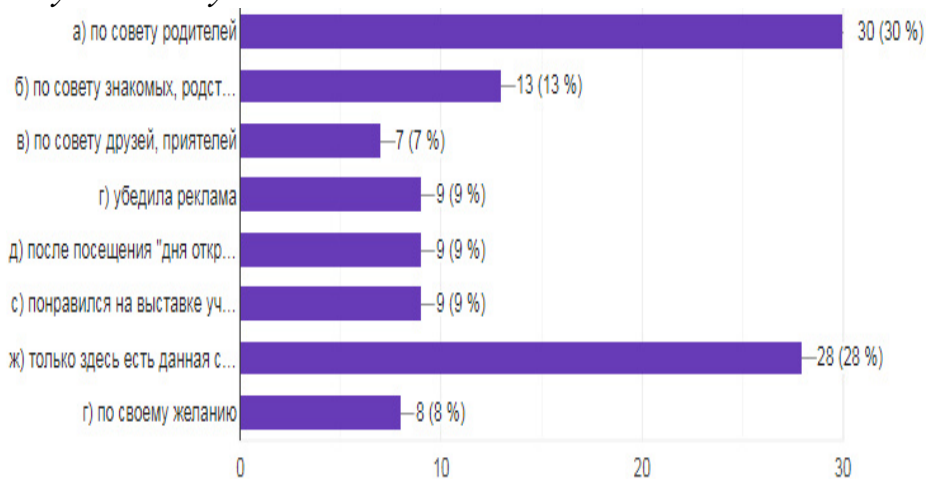
Примечания: Из за большого количества ответа были выбраны повторяющиеся и более значимые для нашего исследования.

Если мне будет трудность учиться?

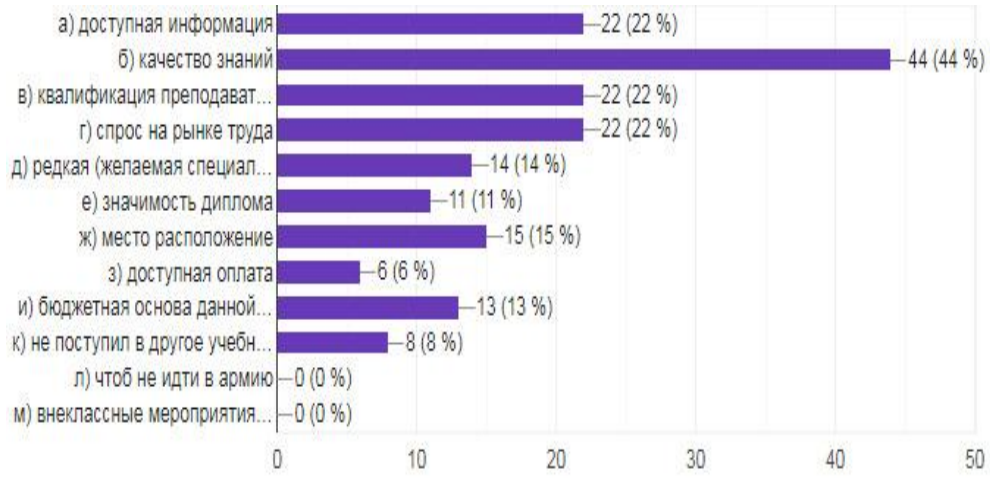
* Продолжу обучение с усилием.
* Буду стараться изучать дома.
* Попрошу преподавателей доп. Занятия.
* Попрошу помощи у куратора.
* Попрошу помощи у родных и друзей.
* Попрошу помощи у однокурсников.
* Буду мотивировать себя для обучения.
* Постараюсь не опускать руки.
* Постараюсь получить хотя бы 4.
* Покину колледж.

Примечания: из за большого количества ответов выбраны повторяющиеся и более значимые для нашего исследования.

3.Почему вы поступили в наш колледж?

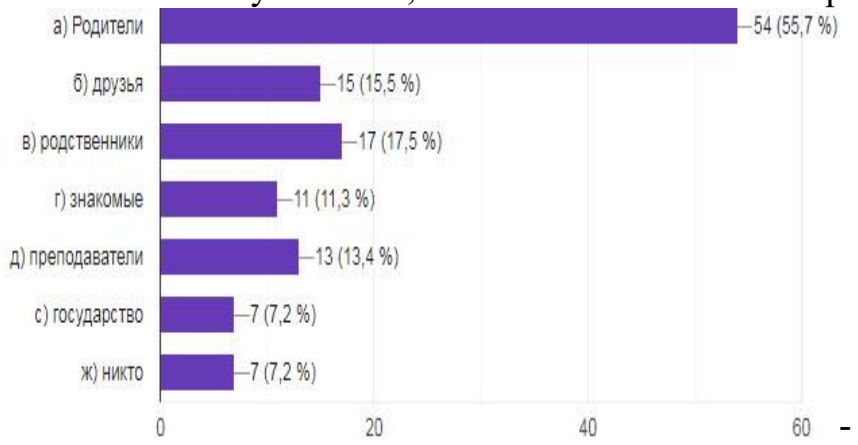


4. Какой основной мотив при выборе колледжа и специальности у тебя был?



ISBN 978-601-08-0758-7

5. Кто по вашему мнению, кто Вам может помочь в реализации своих целей?



Вывод: Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что адаптация молодежи к студенческой жизни – сложный и многогранный процесс, требующий вовлечения социальных и биологических резервов еще не до конца сформировавшегося организма.

Одной из значительных трудностей, с которыми сталкиваются абитуриенты в стенах колледжа – это необходимость адаптации к новым условиям жизнедеятельности, которые предполагают необходимость самостоятельной организации своей жизни, планирование, повышение личной ответственности, снижение внешнего контроля жизнедеятельности вчерашних школьников. Помимо этого, адаптация требуется к новым видам и формам деятельности.

Адаптация происходит на протяжении всех лет обучения. Но наиболее важным периодом, своеобразным фундаментом является период обучения на первом курсе.

Поэтому необходимо создать оптимальные условия для успешной адаптации студентов:

- подготовка и проведение разноплановых внеклассных мероприятий способствующие студентам вырабатывать в себе такие качества, как обязательность, ответственность, дисциплинированность;
- совместная творческая работа развивает в участниках дух коллективизма, здорового и позитивного патриотизма, которые основаны на объективной оценке их деятельности со стороны окружающих.
- чувство локтя, единства с товарищами приносит глубокое моральное удовлетворение, заслуженная и обоснованная гордость за результаты своего труда и труда своих товарищей значительно сказывается на чувстве собственного достоинства – немаловажный фактор для самоутверждения личности;
- главным в адаптации остается процесс психологической перестройки личности студента, его заинтересованности и здесь большую роль играет самостоятельная, творческая работа студента.

ISBN 978-601-08-0758-7

Список литературы:

1. https://zaochnik.ru/blog/adaptatsija-studentov-pervokursnikov-v-vuze-i-kolledzhe-problemy-osobennosti/
2. https://infourok.ru/adaptaciya_studentov-pervokursnikov_v_pervyy_god_obucheniya-521456.htm
3. https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2021/10/06/sotsialnaya-adaptatsiya-studentov-pervokursnikov
4. https://disshelp.ru/blog/osobennosti-adaptatsii-pervokursnikov/
5. https://moluch.ru/th/4/archive/74/2802/

ISBN 978-601-08-0758-7

НЕВРОЗ

Есенбекова Талшын Мұқағалиқызы
«Өркениет» медициналық колледжі
Ғылыми жетекшісі – Жұмабайқызы Альбина

Аннотация: *Бұл мақалада психикалық жарақаттың әсерінен пайда болатын невроз ауруларының жалпы сипаттамасы, этиологиясы мен патогенезі, клиникалық көріністері қарастырылған. Невроздың негізгі белгілері ретінде эмоционалды тұрақсыздық, үрей, ұйқы бұзылыстары және әртүрлі соматовегетативті функциялардың өзгерістері аталады. Невроз түрлерін (неврастения, жабысқақтық неврозы, истерия, ипохондриялық невроз, депрессивті невроз) сипаттап, олардың клиникалық ерекшеліктерін талдайды. Невроздың ең жиі кездесетін кезеңі — 25-40 жас, таралуы 5-15%-ды құрайды.*

НЕВРОЗ — ол психикалык жаракаттың әсерінен пайда болатын аурулар тобы, жалпы күйдің және әртүрлі соматовегетативті функциялардың бұзылуымен, эмоционалды тұраксыздыкпен, коршаған ортаға дұрыс баға берудің жеткілікті сакталуымен және өзінің дертті күйін түсінумен байланысты жүреді

НЕВРОЗДАРДЫҢ КЛИНИКАЛЫҚ КӨРІНІСТЕРІ

Алғаш «невроз» терминін 1776 ж. Шотландия психиатры В. Куллен ұсынды. Осы атаумен ол кызба жағдайы болмайтын сезім және козғалыс бұзылыстарын және осы функциялардың жергілікті немесе жалпы бұзылыстарымен байланыссыз ауруларды суреттеп жазды. Ары карай неврoздардың клиникасы және оларға ыкпал ететін факторлар анықтала түсті.

НЕВРОЗДЫҢ ЭТИОЛОГИЯСЫ ЖӘНЕ ПАТОГЕНЕЗІ

Невроздың пайда болуы психикалык жаракаттың болуына байланысты. Невроздардың дамуы психикалык жаракаттың сипаты мен тұлға типіне тәуелді патогенетикалык механизмдерге тікелей байланысты.

НАУҚАСТЫҢ КЛИНИКАСЫ

Негізсіз үреймен бірге өзін нашар сезіну, жоғары шаршағыштык, тұраксыз, көп жағдайда жабыркаулы көңіл-күй. Өзін сезінуі және көңіл-күйі таңертеңгі уакытта көңілтоларлык, ал кешке карай нашарлайтыны байкалады. Мұндай өзгерістерді наукас еңбекке кабілетті жағдайда да сезінеді. Олар физикалык және интеллектуалды жүктемеден тез шаршайды. Бірак демалғаннан кейін олар жұмыстарын жалғастыра алады. Барлык наукастарға ұйкы бұзылысы тән. Олар жиі денесіндегі жағымсыз сезімге, ішкі мүшелерінің функцияларының бұзылуына шағымдар айтады. Бұл сезімдер мен ауырсынулар сипаты соматикалык аурулардың белгілеріне ұксауы мүмкін.

- **Вегетативті бұзылыстар коркыныш**, үрей, ипохондриялык және фобиялык бұзылыстармен бірге жүріп отырады.
- **Жиі-жиі жүрек кызметінің бұзылуы байкалады:** кардиологиялык синдром және жүрек ритмінің өзгеруі.

ISBN 978-601-08-0758-7

- **Тыныс бұзылыстары:** тыныс алу ритмінің бұзылуы және ларингоспазм;
- **Асказан-ішектік бұзылыстар: аэрофагия** (ауаны жұтып, кекіру) құсу, гастралгия (ауырлық, керілу сезімі);
- **Жиі козғалыстық бұзылыстар байкалады:** оғаш позамен өтетін ұстамалар, астазия-абазия (жүріп-тұруы мүмкін емес), гиперкинездер (бүкіл дененің немесе бір бөліктерінің дірілдеуі); бет бұлшық еттерінің тиктары;
- **Дауыс байламаларының салы** (афония).
- **Сенсорлы бұзылыстар және сезімталдық бұзылыстары,** көру аймағының тарылуы, сокырлық және көрудің баска да бұзылыстары байкалады (диплопия, фотопсия және т.б.),
- **Есту бұзылысы** (саңыраулық), катты дыбыстарды көтере алмау;
- **Жағымсыз сезімдер** (жансыздану, құмырскалар жорғалағандай, ине шаншығандай және т.б.).
- **Жүйке-бұлшық еттік және жүйкелік**-кан тамырлық сипаттағы бас аурулары, психалгиялар («каска», «сакина» тәріздес кыскан ауру сезімдері) болуы мүмкін.

Невроздар әр түрлі жас кезеңінде пайда болуы мүмкін, бірак невроз пайда болуына аса тән жас кезеңі 25—40 жас. Невроздар психикалык бұзылыстардың ішінде жиі кездесетін түрі болып табылады. Олардың таралуы дамыған елдерде 5—15% құрайды, яғни, әрбір оныншы адам невроздан зардап шегеді

НЕВРОЗДЫҢ ТҮРЛЕРІ:

1. **НЕВРАСТЕНИЯ**
2. **ЖАБЫСҚАҚТЫҚ НЕВРОЗЫ**
3. **ИСТЕРИЯЛЫҚ НЕВРОЗ**
4. **ИПОХОНДРИЯЛЫҚ НЕВРОЗ**
5. **НЕВРОЗДЫ Қ ДЕПРЕССИЯ (ДЕПРЕССИВТІ НЕВРОЗ)**

НЕВРАСТЕНИЯ

Неврастенияны алғаш 1869 ж. Америка психиатры Дж. Бирд сипаттаған

1. Гиперстениялық сатысы: Наукастарда жоғары тітіркенгіштік, ұстамсыздык, шыдамсыздык, зейін бұзылысы байкалады. Сонымен қатар, өршу кезеңдерінде ментизм белгілері байкалады: ойлары ретсіз шатасады, хаосты, бірак жаттылык және еріктен тыс пайда болу сезімі болмайды

2. Гипостениялық сатысы: Интеллектуалды кажу, физикалык жұмыстарды орындау киындығы, жоғары ұйкышылдык, әлсіздік, кейде күнделікті жұмыстағы белсенділіктің күрт төмендеуімен көрінетін психикалык және физикалык астения симптомдары басым бола түседі.

ЖАБЫСҚАҚТЫҚ НЕВРОЗЫ

1. Обсессивті: Наукастар жабыскак естеліктерге (өз басынан өткен жағымсыз окиғалар) шағымданады. Ауру осы психикалык құбылыстардың бөтендігін түсінеді, бірак олардан арылуға дәрменсіз. Олар кандай да бір әрекетті толык орындауға кедергі жасайды, кажытады.

ISBN 978-601-08-0758-7

2. Фобиялық: Фобиялық нұскасының клиникалық көрінісінде басты рөл коркыныштарға тән. Олардың ішінде ең кең тарағаны — ауыр соматикалық және инфекциялық ауруларға шалдығу коркынышы. Наукас өз ойының дұрыс емес екенін түсінеді, бірақ олардан арыла алмайды және белгілі бір жағдайларда осы ойлар оны катты толкытады.

3. Жабыскак компульсивті: Жабыскактык невроздың жабыскакты-компульсивті түрінде жағдай контрасты идеялармен, әуестікпен және әрекеттермен аныкталады. Наукастың моральдык ұстанымдарына карама-кайшы әрекеттер жасауға күшті мотивсіз ойлар пайда болады.

ИСТЕРИЯЛЫҚ НЕВРОЗ

Истериялык ұстамалар көрінісі мен ағымы бойынша эпилепсиялык ұстамадан біркатар ерекшеліктерімен ажыратылады. Осы уакытта наукастар санасын жоғалтпайды, барлык рефлекстер сакталады. Қазіргі кезде истериялык невроздың клиникалык көрінісінде соматовегетативті бузылыстар үлкен орын алады. Олар айрыкша жүрек-кантамырлык бұзылыстармен, ас корыту, тыныс бұзылыстарымен көрінеді. Тыныс бұзылысымен, өңеш спазмдарымен ауыр жөтел ұстамаларына байланысты наукастарды жалпы профильдік ауруханаларға орналастырып коймай, оларға жиі оперативті көмек көрсетіледі. Истериялык невроздарда козғалыс пен сезшталдықтың бузылуы байкалады. Наукастар жүріп-тұра алмайды (астазия-абазия), Қабақ спазмдары, афония, аякколдың салдануы болады. Сезімталдыктың бұзылуы қолғап, шұлык, күртеше түрінде көрінеді. Наукастар жиі дененің әр бөлімдеріндегі және ішкі мүшелердегі ауру сезімдеріне шағым айтады.

ИПОХОНДРИЯЛЫҚ НЕВРОЗ

Наукастарда дерттің клиникалык сипаттамасында өз денсаулығына аса көңіл бөлу, мазасыздану басымдылык көрсетеді. Шын мәнінде жок дерт жөнінде ойлар оңай пайда болады, әр түрлі мамандарға каралып, емделгісі келеді. Олар жағымсыз сезімдерге көп көңіл бөледі, ауыр дерт жөнінде ойлар мазалайды.

НЕВРОЗДЫҚ ДЕПРЕССИЯ (ДЕПРЕССИВТІ НЕВРОЗ)

Аурудың бастапкы кезеңінде дистониялык сипаттағы вегетативті бұзылыстар байкалады, артынан жабыркаулы көңіл-күй, ұйкы бұзылысы, коркыныш-үрей пайда болады. Невроздык депрессияда тұракты вегетативті бұзылыстар байкалады, олар жиі гипотония, спастикалык колит және т.б. Тұлғаның невроздык дамуына өту кезеңінде кандай да бір ситуацияға байланыссыз жасаурағыштык бакыланады. Осы бұзылыс наукасты психиатрға көрінуге мәжбүрлейді.

ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫ ДИАГНОСТИКАСЫ

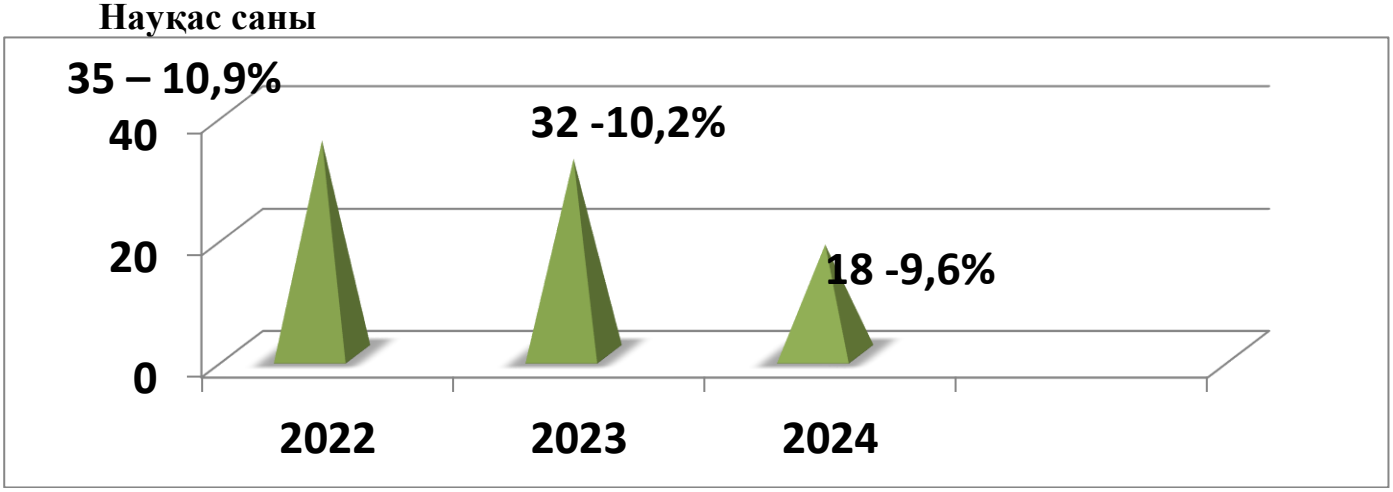
Невроздарды психоздардың психотикалык формасынан ажырату жеңіл. Невроздарға мынадай психикалык бұзылыстар тән емес: галлюцинация, сандырак, интелектуалды-мнестикалык, кататониялык және ауыр аффективті бұзылыстар. Әр түрлі невроздардың симптоматикасы өзіндік сезім және өз жағдайының дертті өзгеруін бейнелейді. Наукас өз жағдайына сын көзбен карап, өзінің наукас екендігін түсінеді.

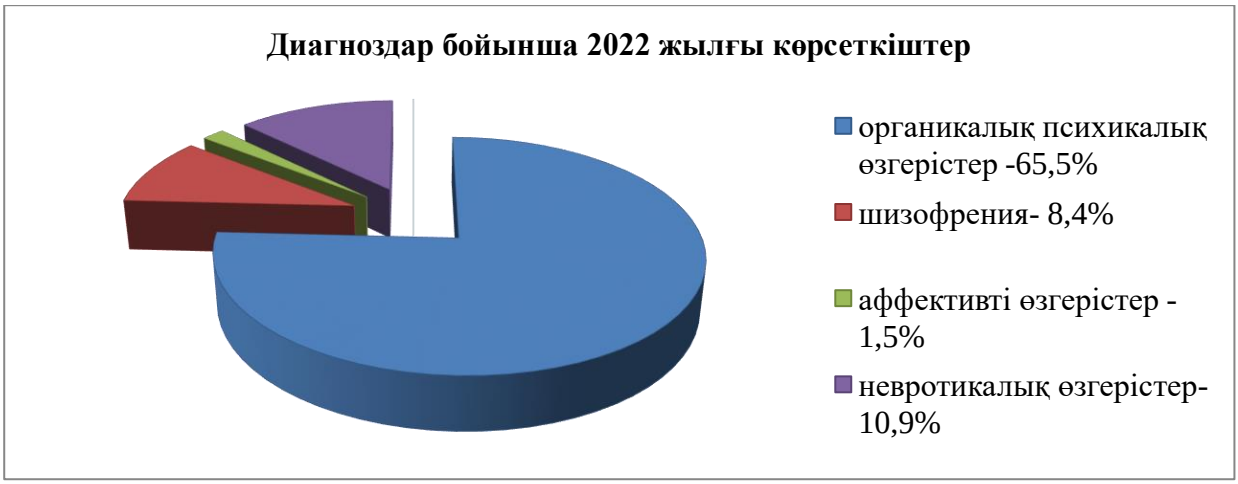
ЕМІ

ISBN 978-601-08-0758-7

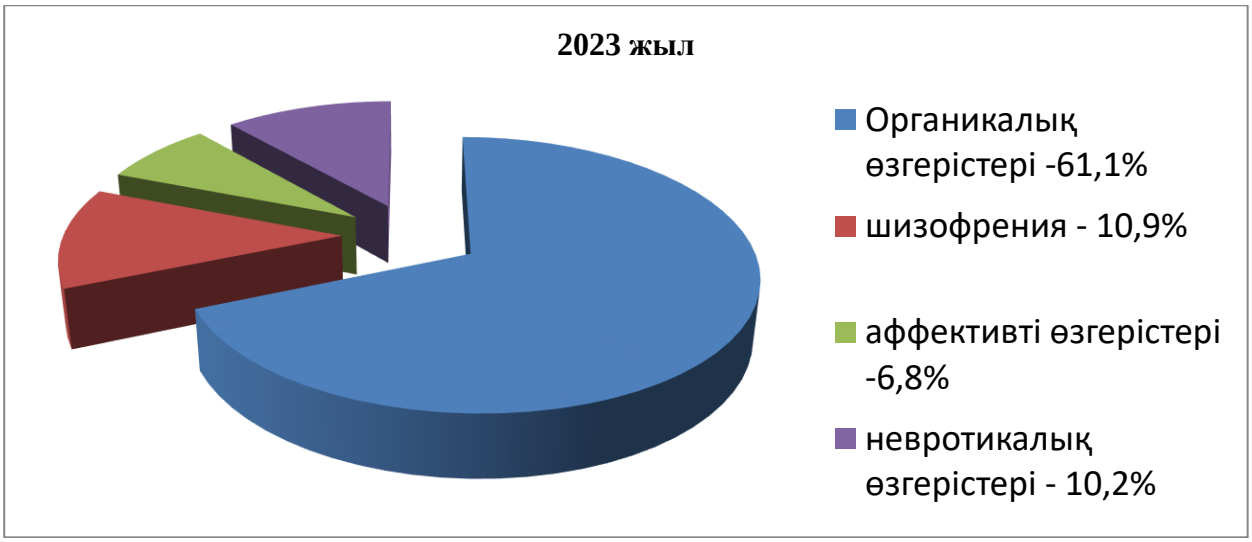
Ең алдымен, эмоционалды кернеліс пен үрейді басу керек. Бұл транквилизаторлар көмегімен іске асырылады. Депрессивті көріністер орын алғанда, антидепрессанттар тағайындалады. Неврозбен ауыратын наукастарда үнемі ұйқы бұзылысы болады, ол транквилизатормен калпына келтіріледі; егер транквилизаторлар көмектеспесе, онда, косымша, ұйықтар алдында ұйықтататын дәрі беру кажет. Физиотерапиялық емдеу тәсілдері де жаксы нәтиже береді: гидропроцедура, электроұйкы, ионофорез. Неврoздарды емдеуде психотерапияға үлкен рөл беріледі.

Соңғы 6 ай бойынша Психоневрологиялық ауруханаңың Неврoздар және шекаралық өзгерістер бөлімшесінде Невротикалық өзгерістермен түскен науқастардың салыстырмалы көрсеткіштері:





ISBN 978-601-08-0758-7



.



Қорытынды:

Жүйке ауруларының алдын алу жөнінде нені білген дұрыс?

- Кез келген ауру алдын алу шараларын қажет ететіндей, психикалық бұзылулар да сақтануды керек етеді. Адамның психикалық денсаулығын жақсарту үшін дененің әр түрлі соматикалық бұзылыстарын бақылап, түрлі жұқпалы аурулардан сақтанып, уақытылы ем-домдар жасап, тексерулерден өтіп тұру керек.
- Жақын адамдармен үнемі қарым-қатынаста болу керек. Тек осылай ғана бастапқы кезеңде ауытқулар мен бұзылуларды байқауға болады. Жанжал және стресстік жағдайлардан бойды неғұрлым аулақ ұстаған жөн. Ең бастысы, салауатты өмір салтын сақтап, жаман әдеттерден бас тартып, ұйқы режимін бұзбаған абзал.

ISBN 978-601-08-0758-7

Әдебиеттер тізімі:

- Н.М. Жариков, Л.Г. Урсова, Д.Ф. Хритинин, К.Т. Сарсембаев ПСИХИАТРИЯ Өнделген және толықтырылған 2-басылым. ООО «Издательство «Литтерра», 2016
- Неврология О. С.Левин, Д.Р. Штульман Справочник практического врача Мед-пресс Информ 2014г.
- https://cyberleninka.ru/article/n/tiki-u-detey
- https://diseases.medelement.com/disease/

ISBN 978-601-08-0758-7

ЖАСӨСПІРІМДЕР АРАСЫНДАҒЫ АРТЫҚ ДЕНЕ САЛМАҒЫН ЖӘНЕ СЕМІЗДІКТІҢ АЛДЫН АЛУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Әлімжанқызы Т. 3 курс,«мейіргер ісі» мамандығы
ШЖҚ «Кеңес Одағының Батыры М.Мәметова атындағы Ақтөбе Жоғары медициналық колледжі»МКК
Ғылыми жетекшісі: Игликова Г.Б.,Турсынгалиева Д.Т. Қайыржан Ғ.Қ. арнайы пән оқытушылары.

Аннотация: Семіздік 21 ғасырда кез келген жаста пайда болатын, негізінен май тінінің шамадан тыс жинақталуына байланысты дене салмағының шамадан тыс жоғарылауымен көрінетін, халықтың жалпы сырқаттанушылық пен өлім-жітім жағдайларының өсуімен бірге жүретін созылмалы метаболикалық ауру ретінде қарастырылады. . Өркениетті қоғамда семіздік аурушаңдығы генетикалық қордағы өзгерістердің жоқтығына қарамастан, яғни тұқым қуалайтын факторларға қарамастан күрт өсуде. Елімізде өлім-жітімнің 57,5 пайызы жүрек-қан тамырлары ауруларына байланысты. Бұл аурулар көбінесе артық салмақтан зардап шегеді.[2 - 190б.]

Америкада өз кезегінде 2021 жылы адамдардың шамамен 70%-ы артық салмақтан зардап шекті, оның ішінде 32,8%-ы семіздіктен зардап шекті 2025 жылға қарай әлем халқының 20% дерлік семіздікке шалдығатыны туралы зерттеу жарияланды.

Семіздіктің дамуы организмдегі энергияның сіңуі мен жұмсалуы арасындағы тепе-теңдіктің бұзылуы нәтижесінде пайда болады. Ағзадағы дене салмағының реттелуі организмнің энергетикалық жүйесін басқаратын өзара байланысты жүйелер кешенінің күрделі әрекеттесуі арқылы жүзеге асады. [2].

Сондықтан энергетикалық тепе-теңдікті сақтау үшін организм гормондардың деңгейін реттеуге, энергия шығындарын азайтуға, қоректік заттардың сіңу тиімділігін арттыруға жұмылдыруы керек.

Өзектілігі:

Бүгінде, статистикаға сүйенсек, қазақстандық балалардың,жасөспірімдердің 20 пайызы семіздіктен зардап шегеді. Семіздік деген қауіпті естілмегенімен, дәрігерлер бүгінде бұл мәселеге дабыл қағып жатыр. Дүниежүзілік Денсаулық Сақтау Ұйымының мәліметіне сенсек, 2025 жылға қарай семіздіктен зардап шеккен балалар Сдың саны әлем бойынша 70 миллион адамға жетуі мүмкін. Дәрігерлер мұны XXI ғасырдың дерті деп отыр.Семіздік мәселесінің өзектілігі сонымен қатар артық салмағы бар адамдар санының біртіндеп артып келе жатқанында. Бұл өсім әрбір 10 жыл сайын олардың бұрынғы санының 10% құрайды. Бұл үрдіс жалғаса беретін болса, келесі ғасырдың ортасына қарай экономикалық дамыған елдердің бүкіл халқы семіздік ауруынан зардап шегеді деген болжам бар.Сондықтан салауатты өмір салтын қалыптастыруға, дене белсенділігінің аздығына қарсы тұруға бағытталған профилактикалық жұмыстардың деңгейі көтерілді.

ISBN 978-601-08-0758-7

Қазіргі кезде семіздік мәселесі Қазақстан халқы үшін де назар аударарлық мәселеге айналып барады. Сондықтан осы мәселені шешу жолын анықтау жұмыстың өзектілігі болып табылады.

Зерттеу мақсаты:

Колледж студенттері арасындағы дененің артық салмағын және семіздік мәселесін жан жақты сараптай отырып, алдын алу

Зерттеу міндеттері:

-Зерттеу тақырыбы бойынша әдебиеттерге,мақалаларға шолу жасау.

-Колледж студенттері арасында зерттеу тақырыбымыз бойынша сауалнама жүргізу.

-Антропометриялық және дене салмағының индексін өлшеп есептеу жүргізу.

-Жүргізілген зерттеу нәтижелерін қорытындылау.

-Семіздіктің алдын-алу бойынша нұсқаулықты және тамақтану тәртібін ұйымдастыру бойынша жадынама әзірлеу, тарату. [3, 134-135б].

Семіздіктің этиологиясы және бейімділік факторлары

Семіздік – (лат. obesitas – толықтық, семіздік.) – майдың шөгуі, май тінінің әсерінен дене салмағының артуы. Май тіндері физиологиялық шөгінділер орындарында да, сүт бездері, жамбас және іш аймағында да жиналуы мүмкін.Семіздікке әкелетін үш негізгі себеп бар:

- алиментарлы, тағаммен бірге организм тұтынатыннан көп калория қабылдауға байланысты. Ол барлық семіздік жағдайларының 85-90% себебі болып табылады;

- эндокриндік, ішкі секреция бездерінің жеткіліксіз белсенділігіне байланысты (микседема, эвнухоидизм, постменопауза кезеңі). Барлық семіздік жағдайларының 12-13% осы себепке байланысты;

- аштық пен тәбет орталықтарының реттелуінің бұзылуынан туындаған церебральды, - семіздік жағдайларының 2-3%.

Семіздікке бейімділік факторлары

Аз қозғалу,қимылдау.

Генетикалық факторлар.

Кейбір аурулар, атап айтқанда, эндокриндік аурулар.

Стресске бейімділік.

Ұйқының бұзылуы.

Психотропты препараттар.

Ғалымдардың зертеуінің нәтижесіне сүйенсек семіздікке,артық дене салмағына әкеліп соқтыратын мынадай себептер екен:

1.Артық салмақпен туылу.

2. Ата-аналарында бар семіздік.

3. 10 сағаттан артық ұйықтау.

4. Үш жасқа дейін салмақтың артық болуы.

5. Мектеп жасына жетпей тері астында майдың пайда болуы.

6. Теледидар алдында тапжылмай отырып тамақ жеу.

Семіздіктің клиникалық көрінісі

ISBN 978-601-08-0758-7

Семіздік бірте-бірте дамиды. Көбіне дененің артық салмағы ауруларды эстетикалық тұрғыдан мазалайды. Бұдан басқа, науқастарды физикалық күш түскенде және тыныштықта ентігу , қан қысымының жоғарылауы, ұйықтағанда қорылдау , буындардағы ауруы, қозғалмалылығының шектелуі, әйелдерде етек кір циклінің бұзулуы және еркектердің қуатының төмендеуі кездеседі.

Семіздіктің 4 дәрежесі:

I семіздік дәрежесі:

- артық дене салмағы қалыптыдан 10-29%-ға асады.(20 кг);

II дәрежелі семіздік:- артық дене салмағы қалыптыдан 30-49%-ға асады.(31 кг);

III дәрежелі семіздік:- артық дене салмағы қалыптыдан 50-99% артық.(51 кг);

Семіздіктің IV дәрежесі:- артық дене салмағы қалыптыдан 100%-дан асады.

Семіздіктің диагностикасы

Науқастарды бастапқы тексеру кезінде анамнез жиналады (отбасылық, әлеуметтік, тағамға тәуелділік, физикалық белсенділік, тамақтану тәртібі, әлеуметтік жағдай, стресс). Анамнез жинау кезінде науқастың психикасы зерттеледі, онымен байланыс орнатылады.

Сонымен қатар, бұрынғы салмақ жоғалту әрекеттері мен әдістерін және салмақ жоғалтуға деген ұмтылыстың себебін білу маңызды. Семіздікті диагностикалау үшін дене салмағының индексі (ДСИ) есептеледі. Қарау кезінде бел шеңбері ,жамбас шеңбері анықталады.

Семіздіктің алдын алу

- Дене салмағын жүйелі түрде бағалау, ДСИ және бел шеңберін анықтау.
- Тамақтану түріжәнетамақтанутәртібініңсипатынбағалау.
- Науқастыңөмірсалтынжәнеқозғалысбелсенділігінбағалау.
- Тамақ тәртібін қалыпқакелтіру, жақсыұйқынықамтамасызету.
- Артықсалмаққосудыңзияныжәнеқатаржүретінсоматикалықаурулардыңқа упітуралыақпарат беру.
- Жылсайынғыдиспансерліктексеружәнедәрігердіңбақылауы

ЗЕРТТЕУ БӨЛІМ

Зерттеу«Кеңес Одағының Батыры М.Мәметова атындағы Ақтөбе Жоғары медициналық колледжінің» базасында жүргізілді.

Колледждеәр түрлікурстар мен бөлімдерденбарлығы 150 студент тексерілді. Жынысы бойынша бөлінуі (85 қыз,65 ұл)

Жас ерекшелігі бойынша: **15-16 жас:**46;**16-17жас:**55; **17-18 жас:**49

Сауалнамаға арналған сұрақтар:

1.Артық дене салмағы ,семіздік туралы не білесіз? 2.Жанұяда,ата,әжеліңде семіздік шалдыққан,толық адамдар бар ма 3.Семіздікпен,және басқа аурумен дәрігердің есебінде тұрасыз ба?

4.Сіз бойы мен дене салмағы индексін есептеп, салмағыңыздыбілесіз бе?

5.Сіз спорт залына барасыз ба?

6.Сіз көп қозғалыс жасап,серуендеген ұнатасыз ба?

ISBN 978-601-08-0758-7

7.Газдалған сусындарды,чипсы гамбург,фастфут және басқа өнімдерді жиі қолданасыз ба?

8.Дұрыс тамақтанбау кесірінен семіздікке шалдығатыныңызды білесіз бе? 9.Сіздің ойыңызша семіздік кесірінен пайда болатын ауруларды білесіз бе?

Антропометриялық, дене салмағының индексі өлшемі арқылы есептеу жүргізілуі нәтижесінде анықталды.

Оның ішінде:Артық дене салмағы (алдын-ала семіздік) - 20 адам,

I-дәрежелі семіздік– 9 адам.

II-дәрежелі семіздік – 2 адам.

Қалыпты дене салмағы – 119 адам.

Осы студенттерді зерттеуге алып, колледж студенттері арасында семіздікті анықтау мақсатында тексеру өткізілді. Ол үшін біз оларға диета тағайындадық, дене шынықтырумен айналысуын ұсындық. Бұл тексеруді өткізу барысында 10 студентті 01.10.2021-31.11.2022 айлар аралығында бақылауға алдық. Бақылаудың басында салмақтары төмендегідей болды:

Осы жүргізілген зерттеулердің нәтижесінде мынадай қорытындыға келдік:

7 –студент диетаны дұрыс сақтап, берілген нұсқауларды дұрыс орындады, сондықтан нәтиже оң мәнді болып тұр.

Қалған 3 студенттің салмағы өзгерген жоқ. Өйткені олар диетаны дұрыс сақтамай, берілген нұсқауларды уақытында орындамаған.

Тәжірибелік тарау бойынша қорытынды:

1. Колледжде 150 адам арасында сауалнама жүргізу нәтижесінде семіздіктің дамуына қауіп факторларының болуы анықталды.

2. Тұқым қуалайтын бейімділігі бар студенттердің денсаулығының нашарлауы, семіздіктің дамуы қауіп факторларының болуын арттырады: артық салмақ, I дәрежелі семіздік, теңгерімсіз тамақтану, физикалық белсенділіктің болмауы, темекі шегу, салмақты ұстауға түрткінің болмауы.

3. Семіздіктің қауіп факторларының дамуын болдырмау үшін студенттерге арналған жадынама әзірленді.

4. Дәрігер тағайындаған диетаны қатаңұстау;

5. Спорт секцияларына тарту арқылы студенттердің қозғалыс белсенділігін кеңейту;

Әдебиеттер тізімі:

1. Беюл Е. А., Оленева В. А., Шатерников В. А. Ожирение. М. Медицина, [2 - 190 б].

2.Егоров М. Н., Левитский Л. М. Ожирение. М. "Медицина" [2,306 б].

3.Гинзбург М.М., Козупица Г.С., Котельников Г. П. Ожирение как болезнь[3, 134-135б].

образа жизни. Современные аспекты профилактики и лечения. Изд-во СГМУ. Самара [2,48 б]

ISBN 978-601-08-0758-7

4.https://www.inform.kz/ru/detskoe-ozhirenie-pochti-20-kazahstanskih-shkol-nikov-stradayut-izbytochnym-vesom_a3508094

5.Дедов И.И.,Мельниченко Г.А.,Фадеев В.В «Эндокринология» Москва «ГЭОТАР-Медиа» [3,105 б].

6.Е.У.Тулемисов «Эндокринология» [2,96 б]. Алматы

7. https://a-center.ru/gotovye-raboty/ozhirenie-i-ego-profilaktika-1105895/

ISBN 978-601-08-0758-7

ОНКОЛОГИЯДАҒЫ ИММУНОТЕРАПИЯ

Исаева Аружан
БМ «Авиценна жоғары медициналық колледжі»
Ғылыми жетекшісі: Оралханова С.М. арнайы пәндер оқытушысы

Аннотация: *Иммунотерапия онкологияда рак клеткаларына қарсы күресуде адамның иммундық жүйесін белсендіру арқылы әсер ететін заманауи емдеу әдісі ретінде ерекше орын алады. Иммунотерапияның негізгі түрлеріне ингибиторлық бақылау нүктелері, цитокиндермен терапия және онкологиялық вакциналар жатады. Бұл әдістердің әрқайсысы иммундық жүйенің рак клеткаларын жою қабілетін күшейтуге бағытталған. Иммунотерапияның артықшылықтарына ұзақ мерзімді нәтиже, арнайы бағытталған әсер және кеңінен қолдану мүмкіндік береді.*

Иммунотерапия — онкологиялық ауруларды емдеудің заманауи және өте тиімді әдістерінің бірі. Бұл емдеу тәсілі адамның иммундық жүйесін белсендіру арқылы рак клеткаларына қарсы күресуге бағытталған. Соңғы жылдары иммунотерапия медицинада революциялық өзгерістерге себепші болып, көптеген ісік түрлерін емдеуде жаңа мүмкіндіктер ашты. Бұл мақалада онкологиядағы иммунотерапияның негізгі түрлері, артықшылықтары мен кемшіліктері, сондай-ақ оның дамуының негізгі мәселелері талқыланады.

Иммунотерапияның негізгі түрлері

Иммунотерапияның рак емдеуде қолданылатын бірнеше негізгі түрлері бар, олардың әрқайсысы әртүрлі механизмдерге негізделген:

1.Ингибиторлық бақылау нүктелерінің блокаторлары (Checkpoint Inhibitors)

Механизмі: Иммундық жүйе клеткалары рак клеткаларын басып-жаншуын болдырмау үшін PD-1, PD-L1 және CTLA-4 сияқты молекулаларды пайдаланады. Бұл молекулалар рак клеткаларына шабуыл жасауды тоқтатады.

Мысалдары: Ниволумаб (Opdivo), пембролизумаб (Keytruda) және ипилимумаб (Yervoy) сияқты препараттар осы молекулаларды блоктап, иммундық жауапты күшейтеді.

2. CAR-T жасушалық терапиясы (CAR-T Cell Therapy)

Механизмі: Пациенттің Т жасушалары генетикалық түрде өзгертіліп, рак клеткаларына шабуыл жасауға қабілетті арнайы рецепторлармен (CAR) жабдықталады.

Қолданылуы: Бұл әдіс көбінесе қан ректарын, мысалы, лейкемия мен лимфоманы емдеуде қолданылады.

3. Цитокиндермен терапия

Механизмі: Цитокиндер — иммундық жүйе жасушаларының белсенділігін арттыратын табиғи ақуыздар. Олар рак клеткаларына қарсы иммундық жауапты күшейтеді.

Мысалдары: Интерлейкин-2 (IL-2) және интерферон альфа (IFN-α) ракпен күресуде тиімділік көрсетуде.

ISBN 978-601-08-0758-7

4. Онкологиялық вакциналар

Механизмі: Онкологиялық вакциналар иммундық жүйені рак клеткаларының антигендерін тануға және оларға шабуыл жасауға үйретеді.

Қолданылуы: Қатерлі ісіктердің алдын алу немесе олардың қайталануын болдырмау мақсатында қолданылады

Иммунотерапияның артықшылықтары

Иммунотерапияның онкологиялық ауруларды емдеуде бірнеше артықшылықтары бар:

Ұзақ мерзімді нәтиже: Иммунотерапия организмнің иммундық жадысын белсендіру арқылы ұзақ уақыт бойы рак клеткаларына қарсы тұра алады.

Арнайы бағытталған әсер: Иммунотерапия рак клеткаларына нақты бағытталғандықтан, сау тіндерге зақым келтіру ықтималдығы төмен.

Әртүрлі ісік түрлеріне қолдану мүмкіндігі: Иммунотерапия бірнеше ісік түрлеріне, оның ішінде дәстүрлі емдеу әдістеріне төзімді рак түрлеріне де тиімді болып табылады.

Иммунотерапияның шектеулері мен кемшіліктері

Иммунотерапияның барлық артықшылықтарына қарамастан, оның қолданылуында бірнеше шектеулер бар:

Жеке реакцияның әртүрлілігі: Әрбір пациент иммунотерапияға әртүрлі жауап береді. Кейбір пациенттерде бұл емдеу әдісі жоғары тиімді болса, басқаларында әсері байқалмайды.

Жоғары құны: Иммунотерапияның бағасы өте жоғары, сондықтан ол көптеген пациенттер үшін қолжетімді емес.

Жанама әсерлер: Иммунотерапия кейбір жағдайларда иммундық жүйенің шамадан тыс белсенділігін тудыруы мүмкін, бұл ауыр қабыну реакцияларына әкеледі.

Иммунотерапияның қазіргі зерттеулері және болашағы

Иммунотерапияның тиімділігін арттыру және оны кеңінен қолдану мақсатында көптеген зерттеулер жүргізілуде:

1. Комбинациялық терапиялар: Иммунотерапияны басқа емдеу әдістерімен (химиотерапия, радиотерапия) біріктіру арқылы оның тиімділігін арттыруға бағытталған зерттеулер жалғасуда.

2. Жаңа биомаркерлерді іздеу: Иммунотерапияға жауапты болжай алатын биомаркерлерді анықтау маңызды мәселе болып табылады. Бұл пациенттерді дұрыс іріктеуге және жанама әсерлерді азайтуға көмектеседі.

3. Генетикалық зерттеулер: Пациенттердің генетикалық ерекшеліктерін ескере отырып, дербестендірілген иммунотерапия әдістерін әзірлеу болашақтың басты бағыттарының бірі болып отыр.

Қорытынды

Иммунотерапия онкологияда революциялық өзгерістер енгізген емдеу әдісі болып табылады. Оның тиімділігі мен ұзақ мерзімді әсері көптеген пациенттердің өмірін сақтап қалуға және ракқа қарсы күресте маңызды жетістіктерге жетуге

ISBN 978-601-08-0758-7

мүмкіндік береді. Дегенмен, иммунотерапияны қолданудағы қиындықтар мен шектеулерді жеңу үшін көпсалалы зерттеулер мен инновациялық технологиялардың дамуы қажет. Болашақта иммунотерапияның қолжетімділігі мен тиімділігін арттыру арқылы ракпен күресуде жаңа қадамдар жасалатынына үміт бар.

Әдебиеттер тізімі:

1. Ісік аурулары: Арзықұлов Ж.Є., Әбисатов Ќ.Є.,
2. Оқулыќ. – Алматы, 2009». – Том І. – С. 391-411.
3. Полякова В. А. Онкогинекология. Ісік аурулары: 2001.
4. Шакирова А.Ф., Байназарова А.А. Онкогинекология бойынша дәрістер циклы (оқулық құрал). – Қарағанды, 2007. – 66 б.
5. Ісік аурулары: В.И.Кулакова. – М., ГЭОТАР-Медиа, 2008.
6. Л.А. Лысак. Мейіргер ісіндегі онкология Феникс, 2004.-С 191-217.
7. И.К.Славянова Өкпе обыры 2004.-С 6-41, 251-316.

ISBN 978-601-08-0758-7

СТУДЕНТТЕР МЕН ДӘРІГЕРЛЕР АРАСЫНДАҒЫ КОУЧИНГ: ТИІМДІЛІГІ МЕН НӘТИЖЕЛЕРІ.

Ізбасарова А.Ж, Ерланқызы Г., «Емдеу ісі» мамандығы
ШЖҚ" Кеңес Одағының Батыры Мәншүк Мәметова атындағы Ақтөбе жоғары медициналық колледжі " МКК
Ғылыми жетекшісі; Байсов.Ғ.Т оқытушы, Жаңаберген Д.Ө оқытушы

***Аннотация**: Бұл зерттеу жұмысы студенттер мен дәрігерлер арасындағы коучингтің тиімділігін және нәтижелерін қарастырады. Медицина саласындағы білім беру мен тәжірибені жетілдіру мақсатында коучинг бағдарламаларының әсері зерттеледі. Зерттеу барысында сауалнамалар, интервьюлер және кейс-зерттеулер арқылы студенттер мен дәрігерлердің коучинг тәжірибелері жинақталады. Нәтижелер көрсеткендей, коучинг студенттердің білімін, кәсіби дағдыларын және стресске төзімділігін арттырады, ал дәрігерлер үшін жас әріптестердің біліктілігін жоғарылатуға және кәсіби байланыстарды нығайтуға мүмкіндік береді. Зерттеу қорытындысы коучинг бағдарламаларын білім беру жүйесіне интеграциялау қажеттілігін көрсетеді, осылайша студенттер мен дәрігерлер арасындағы байланыс пен кәсіби даму тиімділігін арттырады.*

Мәселенің өзектілігі

Медицина саласында студенттер мен тәжірибелі дәрігерлер арасындағы коучинг білім беру мен кәсіби дамуды жақсартуға бағытталған маңызды құрал болып табылады. Бұл зерттеу коучингтің студенттердің білімін, тәжірибесін және кәсіби дағдыларын дамытудағы рөлін қарастырады.Бүгінде медициналық білім беру жүйесі өзгеріп, дәстүрлі әдістерден заманауи тәсілдерге көшу қажеттілігі туындауда. Студенттердің оқу процесіне белсенді қатысуы, тәжірибелік дағдыларын жетілдіруі және кәсіби идентификациясы маңызды аспектілер болып табылады. Коучинг бағдарламалары студенттерге қажетті білім мен дағдыларды меңгеруге, сондай-ақ өздерінің күшті және әлсіз жақтарын тануға көмектеседі.Сонымен қатар, коучинг дәрігерлерге жас әріптестерімен тәжірибе алмасу, кәсіби байланыстарды нығайту және олардың кәсіби дамуына ықпал ету үшін пайдалы. Осылайша, коучинг студенттер мен дәрігерлер арасындағы қарым-қатынасты жақсартуға, білім мен тәжірибенің алмасуына, сондай-ақ медициналық қызмет сапасын арттыруға септігін тигізеді.Зерттеу нәтижелері медициналық білім беру мен практикада коучингтің тиімділігін көрсету арқылы, білім беру бағдарламаларын жаңарту мен студенттерді дайындау әдістерін дамыту үшін негіз болады. Осы мәселелердің өзектілігі медициналық білім беруді жақсартудың маңыздылығын, коучингтің әсерін және оның практикадағы рөлін тереңірек түсінуге мүмкіндік береді.

Коучинг — бұл жеке немесе топтық дамыту, оқыту және қолдау процесі. Ол адамға өз мақсаттарына жетуге, дағдыларын жетілдіруге, жеке әлеуетін ашуға және проблемаларды шешуге көмектеседі. Коучингтің негізінде тыңдау, сұрақ қою және конструктивті кері байланыс беру жатыр.

ISBN 978-601-08-0758-7

Коучинг медицина саласында студенттер мен дәрігерлердің кәсіби дамуын, білімін және дағдыларын жақсартуға бағытталған тиімді әдіс болып табылады. Оның негізгі аспектілері мыналар:

1. **Кәсіби даму**: Коучинг медицина қызметкерлеріне өздерінің кәсіби дағдыларын жетілдіруге, тәжірибелік білім алуға және жаңа ақпаратты меңгеруге мүмкіндік береді. Бұл дәрігерлер мен студенттерге заманауи медициналық практиканы меңгеруге көмектеседі.
2. **Студенттерді қолдау**: Студенттерге коучинг арқылы өздерінің білім алуында, стрессті басқаруда және кәсіби идентификацияда қолдау көрсетіледі. Коучтар студенттермен жұмыс істей отырып, олардың күшті және әлсіз жақтарын анықтайды, сондай-ақ мақсаттарын айқындауға көмектеседі.
3. **Клиникалық дағдыларды дамыту**: Коучинг практикалық дағдыларды дамытуға ықпал етеді. Дәрігерлер мен студенттер рөлдік ойындар, симуляциялар және басқа да интерактивті әдістер арқылы дағдыларын жетілдіреді.
4. **Командалық жұмыс**: Коучинг дәрігерлер мен студенттер арасында ынтымақтастықты нығайтуға көмектеседі. Командалық жұмысты дамыту, пікір алмасу және тәжірибе бөлісу арқылы медициналық қызметтің сапасы артады.
5. **Стресске төзімділік**: Медицина саласы стрессті талап етеді, сондықтан коучинг психологиялық қолдау мен стрессті басқару стратегияларын ұсына алады. Дәрігерлер мен студенттер өз эмоцияларымен жұмыс істеуді үйренеді.
6. **Кері байланыс**: Коучинг кезінде алынған конструктивті кері байланыс кәсіби даму мен өзін-өзі бағалау үшін маңызды. Дәрігерлер мен студенттер өз жетістіктері мен проблемаларын талқылайды, бұл кәсіби өсуге ықпал етеді.

Зерттеу әдістері: Колледж студенттері мен колледж студенттеріне сабақ беретін дәрігерлерден сауалнама алынды. Сауалнамаға 50 студент пен 25 дәрігер қатысты.

Сауалнама нәтижелері

1.Сұрақ: Сіз коучинг сессияларына қатысасыз ба?

Топ	Иә (%)	Жоқ (%)
Студенттер	76%	24%
Дәрігерлер	84%	16%

2.Сұрақ: Егер иә болса, коучинг сессияларына қанша рет қатысқансыз?

Топ	1-2 рет (%)	3-5 рет (%)	6-10 рет (%)	10-нан көп (%)
Студенттер	30 %	44%	20%	6%
Дәрігерлер	20 %	40%	28%	12%

ISBN 978-601-08-0758-7

3.Сұрақ: Сіз үшін коучингтің қай аспектілері маңызды?

Аспектілер	**Студенттер (%)**	**Дәрігерлер (%)**
Дағдыларды дамыту	58%	72%
Стрессті басқару	54%	60%
Кәсіби бағдар	46%	52%
Топтық ынтымақтастық	32%	40%
Басқа	10%	8%

4.Сұрақ: Коучинг сессияларының сіздің кәсіби дамуыңызға әсері қандай?

Топ	**Өте жоғары (%)**	**Жоғары (%)**	**Орташа (%)**	**Төмен (%)**	**Өте төмен (%)**
Студенттер	40%	36%	18%	4%	2%
Дәрігерлер	48%	32%	16%	4%	0%

5.Сұрақ: Студенттердің білім алуына коучингтің ықпалы туралы не ойлайсыз?

Топ	**Жақсарты (%)**	**Өзгертпеді (%)**	**Нашарлаты (%)**
Студенттер	70%	28%	2%
Дәрігерлер	76%	24%	0%

6.Сұрақ: Неге коучинг сессияларына қатысасыз?

Себептер	**Студенттер (%)**	**Дәрігерлер (%)**
Кәсіби дағдыларды дамыту	65%	70%
Стресспен күресу	50%	52%
Жаңа ақпарат алу	55%	60%
Топтық жұмыс тәжірибесі	30%	35%
Жеке тұлғалық даму	40%	48%

ISBN 978-601-08-0758-7

7.Сұрақ: Сіз үшін коучинг форматтарының қайсысы тиімді?

Формат	**Студенттер (%)**	**Дәрігерлер (%)**
Топтық сессия	65%	72%
Жеке сессия	30%	20%
Онлайн формат	25%	28%
Семинар/тренинг	40%	48%
Кездесулер	10%	8%

***8.*Сұрақ:** Сіздің ойыңызша, коучинг сессияларының оптималды ұзақтығы қанша уақыт болуы керек?

Ұзақтық	**Студенттер (%)**	**Дәрігерлер (%)**
30 минут	40%	32%
1 сағат	50%	56%
1,5 сағат	10%	12%
2 сағат	0%	0%

9.**Сұрақ:** Коучинг сессияларының сіздің кәсіби дамуыңызға әсері қандай?

Әсер	**Студенттер (%)**	**Дәрігерлер (%)**
Кәсіби біліктіліктің артуы	75%	80%
Стресстің төмендеуі	60%	65%
Топтық ынтымақтастықтың артуы	70%	75%
Жеке тұлғалық даму	55%	60%
Тиімді коммуникация дағдылары	65%	68%

ISBN 978-601-08-0758-7

10.Сұрақ: Сіз болашақта коучинг сессияларына қатысуды жоспарлайсыз ба?

Жауап	**Студенттер (%)**	**Дәрігерлер (%)**
Иә	85%	90%
Жоқ	5%	2%
Әлі де ойлануда	10%	8%

Қорытынды:Студенттер мен дәрігерлер арасындағы коучинг сессияларының кәсіби даму мен дағдыларды жетілдірудегі маңыздылығын айқын көрсетті.

1. **Коучинг сессияларына қатысу**: Студенттердің 76% және дәрігерлердің 84%-ы коучинг сессияларына қатысатындарын білдірді. Бұл көрсеткіш коучингтің кеңінен қабылданғанын және қажеттілігін көрсетеді.
2. **Қатысу жиілігі**: Студенттердің 44%-ы 3-5 рет коучингке қатысқан, ал дәрігерлер арасында 40%-ы да осы жиілікпен қатысқан. Бұл көрсеткіш коучингтің тиімділігін көрсетеді, себебі қатысушылар саны мен сессияларға қатысу жиілігі жоғары.
3. **Маңызды аспектілер**: Студенттер мен дәрігерлер үшін коучингтің дағдыларды дамыту аспектісі ең маңызды болып шықты (студенттер – 58%, дәрігерлер – 72%). Бұл кәсіби даму мен практикалық дағдылардың қажеттілігін білдіреді.
4. **Кәсіби дамуға әсері**: Студенттердің 40%-ы, ал дәрігерлердің 48%-ы коучинг сессияларының кәсіби дамуына «өте жоғары» әсер еткенін айтты. Бұл коучингтің тиімділігін растайды.
5. **Білім алу әсері**: Студенттердің 70%-ы мен дәрігерлердің 76%-ы коучингтің студенттердің білім алуына оң әсерін тигізгенін айтты. Бұл коучингтің білім беру процесіндегі маңызын көрсетеді.
6. **Қатысу себептері**: Кәсіби дағдыларды дамыту мен жаңа ақпарат алу себептері басым болды. Студенттердің 65%-ы мен дәрігерлердің 70%-ы коучинг сессияларына осы мақсатпен қатысады.
7. **Тиімді форматтар**: Топтық сессиялардың тиімділігі студенттер арасында 65%, дәрігерлер арасында 72% болып бағаланды. Бұл коучингтің әлеуметтік аспектісін атап көрсетеді.
8. **Оптималды ұзақтық**: Көптеген қатысушылар (студенттер – 50%, дәрігерлер – 56%) коучинг сессияларының оптималды ұзақтығы 1 сағат болуы керектігін айтты.
9. **Кәсіби біліктіліктің артуы**: Кәсіби біліктіліктің артуы студенттердің 75%-ы мен дәрігерлердің 80%-ы коучингтің әсері деп атады, бұл сессиялардың әсерінің айқындығын білдіреді.
10. **Болашақтағы жоспарлар**: Студенттердің 85%-ы және дәрігерлердің 90%-ы болашақта коучинг сессияларына қатысуды жоспарлап отыр. Бұл коучингтің сұранысы мен қажеттілігін тағы да растайды.

ISBN 978-601-08-0758-7

Әдебиеттер тізімі:

1. Баранов, В. А. *Медициналық білім беру жүйесіндегі коучингтің рөлі.* Медицина және білім журналы, 2021.

2. Исаева, Р. К., Мұратова, А. Т. *Медициналық білім берудегі кәсіби даму және коучинг.* Алматы: Білім баспасы, 2019.

3. Жұмағұлова, Н. С., Сайранова, М. Б. *Студенттерге медициналық коучингтің әсері.* Медицина ғылымдары, 2020.

4. Brown, J. K., & Smith, R. J. *Coaching in Medical Education: Techniques and Benefits.* Journal of Medical Education, 2020.

ISBN 978-601-08-0758-7

КОНГО – ҚЫРЫМ ГЕМОРРАГИЯЛЫҚ ҚЫЗБАСЫ, ДИАГНОСТИКАСЫ, ЕМІ, ПРОФИЛАКТИКАСЫ

Құрманбек Інжу Мамырғалиқызы, 3 курс «Емдеу ісі» мамандығы
ЖШС «Кентау колледжі»
Ғылыми жетекшісі: Пренов Нишанбек Меирбекович, арнайы пән оқытушысы, жоғары дәрежелі маман

Аннотация: *ККГҚ – екі толқынды қызбамен, жалпы уыттанумен және айқын білінетін тромбогеммoррагиялық синдроммен, өлім – жетімнің жоғары болуымен сипатталатын адамның жіті вирусты ауруы. ҚҚГҚ қатысты бұйрықтары.*

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 12 қарашадағы № 114 бұйрығымен бекітілген «Аса қауіпті инфекциялық аурулардың алдын алу бойынша санитариялық-эпидемияға қарсы (профилактикалық) іс-шараларды ұйымдастыруға және жүргізуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары.

Аннотация: ККГЛ - острое вирусное заболевание человека, характеризующееся двухволновой лихорадкой, общей интоксикацией и выраженным тромбогеммoррагическим синдромом, высокой смертностью.

Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению особо опасных инфекционных заболеваний», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 12 ноября 2021 года № 114.

Abstract: CCGL is an acute human viral disease characterized by two-wave fever, general intoxication and severe thrombohemmorrhagic syndrome, high mortality.

Kazakhstan Republikasy Densaulyk saқtau Minister of Agriculture 2021 zhyly 12 karashadagy No. 114 byrykymen bekitilgen "Asa kauipti infectiusylyk aurulardyk aldyn alu boyynsha sanitariylyk-epidemika karsy (prophylaxis) s-sharalardy uyymdastyruға zhune zhurgizuge koyylatyn sanitation-epidemiology talaptar" sanitation

Дифференциальды диагностика. ҚҚГҚ дифференциальді диагностикасын менингококкты инфекциямен, тұмаумен, лептоспирозбен, тромбоцитопениялық пурпурамен (Верльгоф ауруы), геморрагиялық васкулит (Шенлейн-Генох ауруы), сепсис, сары қызбамен жүргізу керек. Науқастан эпид.анамнез дұрыс жиналуы ауруды ерте анықтауға көмегін тигізеді.

Асқынулары.

- Ауыр асқазан-ішектен, мұрыннан, жатырдан (әйелдерде) қан кетулер;
- Тромбофлебит.
- Инфекциялық-токсиндік шок
- Ми ісінуі
- Бүйректің жедел шамасыздығы

ISBN 978-601-08-0758-7

- Өкпе ісінуі
- Бактериялық инфекция қосылған жағдайда
- Пневмония
- Сепсиске апаруы мүмкін

Емі. ҚҚГЛ науқас анықталған жағдайда оқшаулау керек. ҚҚГҚ күдік болғанда тез арада емді рибовериннен(100мг) бастау керек. Препаратты бірінші рет қабылдауда 2000мг, содан кейін әр 6 сағат сайын 1000мг 4 күннің ішінде, ары қарай әр 6 сағат сайын 500мг 5 күннің ішінде қабылдайды. Емнің ұзақтығы 10 күннен кем болмауы тиіс. Жүкті әйел болған жағдайда интерферон альфа 2b ректальді суппозиторий түрінде береміз.1 млн. ЕД дозада әр 12 сағат сайын с суппозиторийдан қолданылады. Айналымдағы қан көлемін толықтыру мақсатында су-тұз балансын коррекциялау керек.

• кристаллоидтаринфузиясы(0,9% раствор натрия хлорида, раствор Рингера, Трисоль и др.); [4]

• инфузиялық емнің эффективтілігінің критериі гематокрит көлемінің36-38% төмендеуі, гемодинамикалық көрсеткіштердің қалыпқа келуі.

Гемостаздық терапия:

• этамзилат 0,25 г 12,5% ерітіндісін в/в н-м б/е әр 6 сағ сайын.

Профилактикасы. ҚҚГҚ спецификалық алдын алу (вакцинация)-жоқ.ҚҚГҚ-мен ауыратын науқастарды белсенді, толық және уақтылы анықтау жүргізіледі. Науқастарды амбулаториялық қабылдауда анықтаудан басқа, үйге шақыру кезінде аулалық тексеру ұйымдастырылады. Бұл ретте мал жайылатын учаскелердің тұрғындарына көп көңіл бөлу керек.

Малшылар, ауыл механизаторлары, жүргізушілер, зоовет жұмыскерлер, мал шаруашылығы жұмысына уақытша тартылған адамдарға жұқтыру қаупі төнеді. Облыстық және аудандық мамандардың тарапынан ауылдық медқызметкерлерге консультациялық көмек көрсетіледі:



1. медициналық пункттерді толықтыру;
2. аурудың көтерілу кезеңінде жекелеген учаскелерге бару мақсатында қосымша медицина қызметкерлерінің бригадаларын ұйымдастыру;
3. 3) медицина қызметкерлерін даярлау, ҚҚГҚ-ға қатысты олардың сақ болуын арттыру. [1]

ҚҚГҚ-на күдіктену жағдайы анықталған кезде медицина қызметкері қорғаныш киімін киеді, геморрагиялық құбылыстар болған кезде ластанған жерлерді және қолдарын ағымдық өңдеуді жүргізеді, қабылдауда болған және науқаспен араласқан адамдардың, сондай-ақ олармен ілесіп жүрген адамдардың тізімін жасайды.

Науқас үйлерінде анықталған кезде медицина қызметкері тиісті көмек пен ағымдық дезинфекциялауды ұйымдастырады. Инфекциялық стационарда осы инфекция үшін бөлінген бокс жеке медициналық құрал-сайманмен, күту

ISBN 978-601-08-0758-7

заттарымен, персоналға арналған халаттармен қамтамасыз етіледі. Осы жерге ағымдық өңдеу жүргізуге арналған дезинфекциялау құралдарының ерітінділері бар бөшкелер, жинау мүкаммалы, хирургиялық типтегі немесе аяқпен басқарылатын қолжуғыш орнатылады.

Кенелермен байланыста болған кезіндегі инкубацияның барынша көп мерзімі 12 күн, ал науқастың қан бөлінділерімен байланыс болған кезде 9 күн. бақылау мақсатында 6 күннен кешіктірмей ауруханаға жатқызылады. [3]

Ошақта қорытынды дезинфекциялау жүргізіледі. Науқас болған тұрғын үйлер, бөлме хлораминнің 3%-дық ерітіндісімен өңделеді. Іш киімі хлораминнің 1%-дық ерітіндісіне салынады, кейіннен қайнатылады. Заттары дезинфекциялау камерасында өңделеді. Ошақта санитариялық-ағарту жұмыстары жүргізіледі. Ошақта жүргізілетін міндетті іс-шаралардың ішінде, сонымен қатар кенеге қарсы күрес іс-шаралары болып табылады.

Санитариялық-ағарту жұмысы тыңдаушылардың жергілікті ерекшелігіне және контингентіне байланысты нысаналы болуы тиіс. Санитариялық-ағарту жұмыстың түрлері сан алуан болуы мүмкін. Бұл дәрістер, әңгімелесулер, стендтерді, денсаулық бұрыштарын, газеттердегі мақалалар мен радиодағы әңгімелер, плакаттарды, санитариялық бюллетеньдерді, фотоальбомдарды ұйымдастыру. [1]



Денеге қадалған кене сондықтан оны уақытылы жұқтырудың алдын алу байланысты қадалған өзін – өзі немесе бірін – маңызды. Денеге қадалған дереу алып тастайды. денеге бірден қадалмайды, алып тастау ауру мүмкін. Осыған кенелерді анықтау үшін бірі қарап шыққан кене анықталған кезде, оны ДДСҰ және Американың Ауруларды бақылау және олардың алдын алу жөніндегі орталықтары кенені алып тастаудың мынадай қауіпсіз әдістемесін ұсынады, ол үшін бірнеше қарапайым қағидаларды сақтау қажет. Кенені жалаңаш қолмен ұстамаңыздар, өйткені жұқпалы ауру агенті шырышты қабықтар немесе терідегі зақымданған жерлер арқылы енуі мүмкін. Осындай сақтық әсіресе кенелерді үй жануарларынан алып тастайтын адамдар үшін қажет. Балалар және ауру жұқтырып алуға барынша ұшырағыш иммун тапшылығы бар адамдар кенелерді денеден аластауға тартылмауы тиіс.

Ұшы өткір пинцетті пайдаланыңыз немесе саусақтарыңызды резеңке қолғаптармен немесе қолғап болмаса, матамен қорғаңыздар. Кәдімгі пинцетпен оны теріге мүмкіндігінше жақындата отырып, онымен кенені іліп алу қажет. Пинцетті қатты қыспай (кенені мыжып тастамау үшін) шайқалтпай, ақырын және жұлқымай абайлап тарту керек, өйткені олай тартпау кененің ауыз бөлігінің бөлініп теріде қалып қоюына әкелуі мүмкін. Егер олай болса, ауыз бөлігін пинцетпен іліп, тартып шығару керек.

Кенені тартып алғаннан кейін шаққан жерді дезинфекциялайтын затпен (спиртпен, йодпен) өңдеңіз және қолыңызды сабындап жуыңыз.

ISBN 978-601-08-0758-7

Кененің денесін мыжғылап бұзбаңыз, өйткені ішінде және сұйықтығында патогендер болуы мүмкін. [2]

Алынған кенені ыдысқа салып, қақпақпен тығыздап жабу қажет. Кенеге керосин, май, ацетон немесе басқа да сұйық құюға, сондай-ақ оны теріден бөлу үшін кенені ысытуға болмайды. Сіздің міндетіңіз – оның өзі түсіп қалуын күтпей кенені мүмкіндігінше тезірек алып тастау. Ауру жұқтыру қаупін азайту үшін уақыттың маңызы зор.

Жұқтырылған аумақта жеке алдын алу шаралары ретінде қорғаныш киімін пайдалану, киімді, шатырларды, ұйықтарда киетін қаптарды репеллентермен өңдеу ұсынылады.

Киімді өңдеу үшін ерітінділер, репеллентердің су эмульсиялары қолданылады. Киім (комбинезон, шалбар) матаның 1 шаршы метріне репеллентті (бұдан әрі - ш.м.) 20-40 г есебінен сіңіреді, есеп таза препарат бойынша беріледі. Киімді ерітіндіге (эмульсия) 15 минут салады, содан соң сәл сығып, көлеңкеде кептіреді. 1 комбинезонға орташа алғанда 1,5 литр (бұдан әрі – л.) сұйықтық керек. Пайданалғаннан кейін комбинезонды полиэтилен қапта сақтайды, ол репеллентердің қолданылу мерзімін ұзартады. [3]



Ошақтарды эпизоотологиялық тексеру және эпидемиологияны зерделеу иксодты кенелердің, ККГҚ вирусының табиғи резервуарының түр құрамымен таралуымен және маусымдық санының динамикасымен танысу болып табылады.

Кенелерді жинау суға батырылған мақта тампонымен немесе сүзгі қағаздар жолақтарымен жүргізіледі. Кенелер бар тампондар мен қағаздар кертігі бар, сыйымдылығы 100-200 текше сантиметр банкілерге салынады. Кенелерді жинау сондай-ақ суы бар түтікшелерде акварельді қылқаламмен жүргізіледі. Егер кенелерді бактериологиялық зерттеуге дайындау алдында айқындау мүмкін болмаса, жиналғандардың 5-10%-ы 70% спиртте консервіленеді. Кенелерді жинау және зерттеу кезінде сақтық шараларын сақтау қажет. Жұмыс істегенде кенелердің жабысуының алдын алу үшін киім мен денені жиі қарап отыру қажет.

ҚҚГҚ қатысты бұйрықтары. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 12 қарашадағы № 114 бұйрығымен бекітілген «Аса қауіпті

ISBN 978-601-08-0758-7

инфекциялық аурулардың алдын алу бойынша санитариялық-эпидемияға қарсы (профилактикалық) іс-шараларды ұйымдастыруға және жүргізуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары. [4]

ҚР ДСМ 2013жлығы 28 наурыздағы «Жамбыл, Қызылорда, ОҚО – да

Конго – Қырым геморрагиялық қызбасын эпидемиологиялық қадағалау және оның алдын алу жүйесін жетілдіру туралы» № 84 хаттамасы.

ҚҚГҚ анықтамасы, этиалогиясы, патогенезі, клиникасы, диагностикасы, профилактикасы және ҚҚГҚ қатысты бұйрық. Қазақстан Республикасының Ұлттық Экономика министірлігінің 23.06.2015 жылғы маусымындағы №144 (Қазақстан Республикасы халқының арасында Конго-Қырым геморрагиялық қызбасының диагностикасы мен профилактикасын жетілдіру бойынша әдістемелік ұсынымдарды бекіту туралы) бұйрығы. [4]

Әдебиеттер тізімі:

1. Инфекционные болезни Аликеева Г.К
2. Инфекционные болезни Шувалова Е.П
3. Инфекционные болезни Бегайдарова Р.Х
4. Емдік хаттама №60 29.03.2019ж.

ISBN 978-601-08-0758-7

ЖАСТАРДЫҢ КОНТАКТІЛІ ЛИНЗАЛАРДЫ КИЮ ЖӘНЕ КҮТУ ЕРЕЖЕЛЕРІН БҰЗҒАН КЕЗДЕ ТУЫНДАЙТЫН АСҚЫНУЛАРЫН ТАЛДАУ

Сәрсенбаева Дильназ Болатқызы, 3 курс, « Мейіргер ісінің қолданбалы бакалавры» мамандығы.

Қызылорда медициналық жоғары колледжі.

Ғылыми жетекшілері: Кемелбаева Г.С, Абдраманова Г.Т «Арнайы мейіргер ісі негіздері» пәнінің оқытушылары,магистр,бөлім меңгерушілері.

Аннотация: *Бұл мақала қарастырады контактілі линзаларды әлемде шамамен 125 миллион адам киеді. Ал жұмсақ контактілі линзаларды бүкіл әлем бойынша пайдаланушылардың шамамен 90% киеді. Сонымен, соңғы жиырма жылға тән контактілі көруді түзетудің қарқынды өсуі өзекті мәселе болып отыр. 1970 жылы әлемде контактілі линзалардың 1-2 миллион пайдаланушысы болды, содан кейін 1986 жылы қазірдің өзінде 25 миллион адам болды, ал соңғы жылдары мұндай пациенттардың саны 80 миллионға дейін өсті. Жыл сайын әлемде көру қабілетін түзетудің басқа тәсілдерімен контактілі линзаларды ұнататын адамдар көбейіп келеді. Сарапшылар 2023 жылдың басында мұндай оптикалық өнімдерді қолданатын адамдардың шамамен 27% белсенді пайдаланады деп болжайды. Бүгінгі таңда оптометрлер көзілдірікпен салыстырғанда тұтынушылардың линзаларға деген сұранысының тұрақты өскендігін атап өтті.*

Статистикаға сүйенсек, соңғы 10 жылда тек АҚШ-та байланыс оптикасының жанкүйерлерінің саны 21% - ға өсті. Ұлыбританияда бұл көрсеткіш 18% жетеді. Линзадан гөрі көзілдірікті ұнататын адамдар санының өсуімен қатар, контактілі өнімдерді сату деңгейі де артып келеді. Статистика 2006 жылдан бері линзалардың орташа сатылымы 7% - ға, ал ұпайлар тек 0,8% - ға өскенін көрсетеді. Көруді контактілі түзету құралдарының ішінде, сарапшылардың пікірінше, пациенттер күнделікті ауыстырылатын линзаларды көбірек таңдайды, бұл олардың көз қауіпсіздігі мен қолданудың қарапайымдылығына байланысты.

Ағымдағы мәліметтерге сәйкес, пайдаланушылардың шамамен 40% - ы күндізгілерді жақсы көреді. Гонконгта, Норвегияда, АҚШ-та бұл көрсеткіш 50% - дан асады. Сонымен қатар, статистика бір күндік линзаларды сату деңгейі сатылған өнімнің жалпы көлеміне қатысты 3% - ға өскенін көрсетеді. Брендтер арасында жетекші орынды Johnson & Johnson компаниясының Acuvue сауда белгісі алады. Сарапшылар жыл сайын көзілдірікке контактілі линзаларды ұнататын адамдардың саны арта беретініне сенімді. Бұл, атап айтқанда, офтальмологиялық патологиялардың әлемде кең таралуына байланысты. Шамамен есептеулер бойынша, 2020 жылға қарай Жер бетінде 5 миллиардтан астам адам миопия мен алыстан көргіштіктен зардап шегеді.

Елордада көзілдірік немесе линзаны 39,5% және әйелдердің 51%, Санкт-Петербургте сәйкесінше 44% және 50,3% киеді. Жоғарыда айтылғандардың барлығы контактілі линзалардың үлкен танымалдылығын түсіндіру үшін жеткілікті. Контактілі линзалар АҚШ-та, Жапонияда, Еуропаның барлық дерлік елдерінде,

ISBN 978-601-08-0758-7

Таяу және Қиыр Шығыста өте танымал. Контактілі линзаларды киетіндердің шамамен 50% - ы 18 бен 25 жас аралығындағы жастар. Контактілі линзаларды бірінші рет киетіндердің арасында бұл жас тобы шамамен 80% құрайды. [6]

Зерттеу әдісінің мақсаты: Қызылорда медициналық жоғары колледжіндегі студенттердің контактілі линзаларды кию және күту ережелерін тиімді қолдануын бағалау. Осы мәселе бойынша студенттердің пікірін анықтау арқылы сұрақтарға жауап алуға және зерттеу міндеттеріне қол жеткізуге мүмкіндік береді.

Зерттеу объектісі: 2024 жылы қаңтар айында Қызылорда медициналық жоғары колледжінің 3 курс студенттерінен сауалнама алынды. Осы зерттеуді жүргізуде сауалнама онлайн түрде алынды. Зерттеу колледж студенттерінің 16-25 жас аралығын қамтыды. Зерттеуге жалпы 33 адам қатысты. Сауалнамада респонденттерге 20 сұрақ қойылды.

Зерттеу құралы: Сауалнама авторы Николаевна М.К, Ресейде Белгород қаласында жүргізілген сауалнамаға сүйене отырып жасалды. Мақала тақырыбы: «Көру қабілеті бұзылу кезіндегі медбикенің профилактикалық іс-әрекеті». Зерттеу Белгород облысындағы «Строитель №2 орта мектебі» коммуналдық бюджеттік білім беру мекемесінің базасында жүргізілді. Бұл мәселені шешу үшін мектеп оқушыларының медициналық құжаттарына талдау жасаған. 1-4 сынып оқушыларының барлығы 231 медициналық картасын өңдеген. 1-4 сынып оқушылары арасында да социологиялық сауалнама жүргізген. Сауалнамаға 231 оқушы қатысқан, олардан сауалнамаға жауап беру ұсынылған.

Респонденттерге қолайлы болуы мен сауалнама нәтижелерін жақсарту үшін студенттер үшін сауалнама екі тілде – қазақ және орыс тілдерінде дайындалды. Сауалнама арқылы студентке линзаларды кию және күту кезіндегі ережелерді сақтаудағы деңгейі бағаланады.

САУАЛНАМА ҚОРЫТЫНДЫСЫ

Қызылорда медициналық жоғары колледжі студенттерінің контактілі линзаларды кию және күту ережелерін бұзғанда болатын асқынуларды талдау деңгейін сауалнама арқылы анықтау нәтижесі келесі қорытындыларды көрсетті:

1. Сауалнамаға жауап беруші 46,8 % респонденттің жас мөлшері 20-25 жас, ал 43,5 % респондент 18-20 жас аралығындағылар, 9,7 % 16-18 жастағы студенттер.
2. 80,6 % респонденттің жынысы әйел адам екендігі, қалған 19,4 % респонденттің ер адам екендігі анықталды. Бұл ер адамға қарағанда әйел адамдардың көбірек контактілі линзаларды қолданатындығын білдіреді.
3. Сауалнамаға жауап беруші респонденттердің 77,4 % өздерінің көру қабілеттерінің жақсы екендерін, ал 22,6 % көздерінің нашар көретіндігін айтты.
4. Респонденттердің көп бөлігі яғни 70 % көздері жақсы көреді, ал 30 % жақыннан жақсы, алыстан нашар көретіндігін айтты.
5. 58,1 % респонденттердің ата анасының көздері жақсы көреді, 22,6 % анасының көзі жақсы, әкесінің көзі нашар болса, 6,4 % әкесінің көзі жақсы, анамның көзі нашар, ал 12,9 % екеуінікіде нашар екендігі анықталды.

ISBN 978-601-08-0758-7

6. Сауалнамаға жауап беруші респонденттердің 71 % көру режимін сақтаса, 19,4 % сирек орындайтындығын, ал 9,7 % респондент орындамайтындығын айтты. Бұл дегеніміз теледидардан алыс отырмай, көзге кітапты жақындатып оқитын студенттер саны.

7. 58,1 % респондент көз жаттығуларын жасайды, ал 41,9 % респондент көз жаттығуларын жасамайтындығын анықтадық.

8. Сауалнамаға жауап беруші респонденттің 93,5 % бөлмелері жақсы жарықтандырылған, ал 6,5 % респонденттің бөлмесі нашар жарықтандырылғандығы анықталды. Сонда респонденттердің көп бөлігінің бөлмелері жақсы жарықтандырылғаны – бұл жақсы көрсеткіш.

9. 77,4 % сауалнамаға жауап беруші респондент контактілі линзаларды қолданбайды, ал 22,6 % контактілі линза қолданатындығы жайлы жауап берді.

10. 12,9 % респондент линзаларды сәндік үшін қолданса, 9,7 % линзаларды көздері көрмегендіктен қолданатындығын, ал 77,4 % респондент мүлде линза қолданбайды.

11. Сауалнамға жауап беруші респонденттің 77,4 % линзаны қолданбаса, 9,7 % линзаларды дәрігердің көмегінсіз, қарапайым дүкеннен сатып алса, 12,9 % офтальмолог дәрігер көмегімен, арнайы дәріханадан алатындығы анықталды.

12. 58,1 % респондент өз бетінше таңдалған линзалардың зиян екендігін білсе, 41,9 % оны білмейді.

13. Сауалнамаға жауап беруші респонденттердің 80,6 % линзаларын салып қойса, 19,4 % салып қоюды ұмытып кетеді.

14. 43,8 % респондент линзаларды кию ережелерімен таныс болса, 56,3 % респондент таныс емес.

15. 78,1 % респондент мүлде линза кимесе, 18,8 % линзаларын суға түсерде шешіп қояды, ал 3,1 % шешіп қоюды ұмытып кетеді.

16. Сауалнамаға жауап беруші респонденттердің 78,1 % мүлде линза қолданбаса, 15,6 % линзаларды немесе контейнерді жуу үшін арнайы дезинфекциялық ерітінді қолданатындығын айтса, 6,3 % қолданбайтындығын айтты.

17. 37,5 % респондент контактілі линзаларды неғұрлым жиі ауыстырса, соғұрлым көзге қауіпі азаятындығын білсе, 62,5 % респондент оны білмейді. Сол үшін осы сауалнама арқылы респонденттерге түсіндіру жұмысы жасалды.

18. 18,8 % сауалнамаға жауап беруші респондент линзаларды алу және салу кезінде қолдарын жуатындығын айтса, 3,1 % респондент қолдарын жумай линза қолданады, ал 78,1 % респондент линзаны мүлде қолданбайды.

19. Сауалнамаға жауап беруші респонденттердің барлық дерлігі зақымдалған, мерзімі өткен линзаларды қолданбайтындығын анықтадық.

20. 40,6 % респондент көздерінде шағым болмаса да, жылына бір рет скринингтен өтіп тұрады, ал 59,4 % респондент скринингтен өтпейді.

Сауалнама қортындысын талдай келе Қызылорда медициналық жоғары колледжі студенттерінің контактілі линзаларды кию және күту ережелерін бұзғанда болатын асқынулар жайлы білім деңгейі 40% көрсетіп отыр. Осыған сәйкес келесі ұсыныстар берілді:

ISBN 978-601-08-0758-7

1. Колледж студенттеріне уақытылы скринингтен өтуге арнайы жадынамалар тарату.
2. Контактілі линзалардан болатын асқынулардың алдын-алу жайлы, ата-аналар және ортақ чаттарға видеороликтер жіберу.
3. Тик-ток, инстаграм желілеріне скринингтен өтудің пайдасы, уақытында өткен скринингтің көзге қатысты аурулардың қаншалықты алдын- алатыны жайлы видео түсіру.
4. Колледж қабырғаларына скриниг туралы арнайы хабарландырулар ілу.

Әдебиеттер тізімі

1. Антропова Г.А., Оконенко Т.И., Кононова С.В., Агаева А.А. Ассортимент контактных линз и средств по уходу за ними на российском фармацевтическом рынке // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований, 2016. – 541 с. [6]
2. Багиев Г.Л. Маркетинг: Учебник для вузов. 3-е изд. / под ред. Г.Л.Багиев, В.М. Тарасевич, Х. Анн. – СПб: Питер, 2019. – 736 с.[7]
3. Васнецова О.А. Медицинское и фармацевтическое товароведение /под ред. О.А. Васнецова. - Москва, ГЭОТАР-Медиа, 2018 – 607 с. [8]
4. Галкин Н.Н. Пособие по подбору очков / под ред. Н.Н. Галкина. Издательство: МЕДГИЗ, 2019 – 186 с.[9]
5. Дремова Н.Б. Медицинское и фармацевтическое товароведение:учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Фармация»под ред. Н.Б. Дремовой. – Курс: КГМУ, 2019 – 605 с. [10]
6. Егоров Е.А. Офтальмология / под ред. Е.А. Егоров, Ю.С. Астахов.М: ГЭОТАР-МЕД, 2018 – 464 с. [11]
7. Котлер Ф. Основы маркетинга / пер с англ. под ред. Е.М. Пеньковой.М.: Прогресс, 2017. – 511 с. [12]
8. Киваев А.А., Шапиро Е.И. Контактная коррекция зрения / под ред.А.А. Киваев, Е.И. Шапиро - Издательство ЛДМ-Сервис 2021. – 234 с. [13]
9. Минаева М.А. Защита зрения / под ред. М.А. Минаева -Издательство: Миклош, 2016 – 254 с. [14]
10. Орлова Г.С. Коррекция зрения / под ред. Г.С. Орлова, П.П. Осипов Издательство: Авторский тираж, 2018. – 233 с. [15]

ISBN 978-601-08-0758-7

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В МЕДИЦИНЕ

Маркелова Алина Александровна
Студентка 4 курса группы ЛД 208-22, специальности «Лечебное дело»
Учреждение образования КГП на ПХВ «Усть-Каменогорский высший медицинский колледж»
Папышева Гульжан Кайкеновна,
Преподаватель специальных дисциплин, педагог-эксперт

Аннотация. *В работе представлена таблица, которая основана на проведенном исследовании и отображает результаты распространённости факторов риска сахарного диабета (далее СД) среди населения города Усть-Каменогорск. Исследование проведено при помощи сайта https://forms.gle/Z2PbcRiYSR83GxoYA, среди жителей г. Усть-Каменогорск. Брались в обработку данные 230 опрошенных лиц. Таблица рассматривает и наглядно отображает процентное соотношение распространённости факторов риска по различным критериям: пол, возраст, образование.*

Впервые для получения дынных по социологическому исследованию использованы возможности интернет ресурсов - анкетирование при помощи сайта https://www.heartbeatrussia.ru

Актуальность: Актуальность избранной темы определяется задачами популяризации знаний о рисках сахарного диабета, здорового образа жизни. Ежегодно возрастающая смертность по данным ВОЗ от сахарного диабета вызвана возрастанием и изменением характера нагрузок на организм человека в связи с усложнением общественной жизни, увеличением рисков техногенного, экологического, психологического, политического и военного характеров, провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья.

Практическая значимость Изучение распространенности традиционных и других факторов риска, а также определение суммарного риска СД в случайной выборке популяции взрослого населения г. Усть-Каменогорск для целенаправленного проведения региональных профилактических программ.

Цель: Целью данного исследования является пропаганда здорового образа жизни (ЗОЖ) среди лиц конкретного региона проживания.

Задачи исследования: Определить процентное количество людей с факторами риска СД, составить процентное соотношение наиболее часто встречающихся факторов риска.

Эпидемиология

Проблема борьбы с сахарным диабетом (СД) из года в год становится всё более актуальной для современной медицины, в связи с повальным ростом заболеваемости во всём мире. Особенности условий и образа жизни людей в XXI веке, связанные с гипокинезией; употреблением продуктов с высоким содержанием углеводов, соли, жиров, синтетических добавок; частые стрессовые ситуации, вызванные ускорением темпов жизни; вредные привычки и многие другие факторы лежат в основе повышения массы тела, развития метаболического синдрома (МС) и

ISBN 978-601-08-0758-7

сахарного диабета второго типа (далее СД II типа). Немаловажное влияние оказывают также множественные генетические и экологические факторы, способствующие распространению данной патологии. На сегодняшний день СД является одним из наиболее распространённых неинфекционных заболеваний человека после сердечно-сосудистой и онкологической патологии, приводящим к инвалидности и, нередко, летальным исходам.

СД, часто называемый просто диабетом, представляет собой серьёзное хроническое прогрессирующее заболевание, характеризующееся повышенным уровнем глюкозы в сыворотке крови (гипергликемия), которое связано с различными сопутствующими состояниями, такими как ухудшение зрения, плохое заживление ран, эректильная дисфункция, почечная недостаточность, сердечные заболевания и т.д.

Основными факторами риска развития СД II типа у большинства людей являются пищевые привычки, связанные с употреблением большого количества высококалорийной и легко усвояемой пищи и напитков, физическая инертность или гипокинезия, повышенная масса тела или ожирение, повседневная бытовая и трудовая деятельность, сопряжённая с высоким риском психоэмоционального напряжения. Немаловажное значение имеют также широкое распространение вредных привычек, таких как курение и употребление алкоголя, бесконтрольное применение лекарственных препаратов синтетического происхождения, в особенности злоупотребление гормональными средствами и антибиотиками.

Таким образом, учитывая скорость развития научно-технического прогресса, оказывающего влияние, как на профессиональную деятельность, так и на бытовые условия жизнедеятельности, практически каждый человек подвергается риску развития СД.

Основная часть (методология, результаты)

Одними из рекомендаций, представленных на ежегодном собрании Европейской Ассоциации по изучению сахарного диабета (2-6.10.2023 г.), стали рекомендации по диагностике, лечению и профилактике сахарного диабета. Интересно, что с момента публикации прошлой версии документа прошел 1 год, однако за это время было выпущено не так много исследований, результаты которых существенно влияют на существующие концепции профилактики СД. В связи с этим большая часть изменений в новом документе касается упрощения и некоторого преобразования действующих алгоритмов профилактики СД.

В первую очередь экспертами Европейской Ассоциации по изучению сахарного диабета было разграничить два уровня вмешательств, направленных на профилактику СД.

Первый – индивидуальный уровень, целью которого является максимально возможная персонификация разработанных сегодня подходов.

Второй – популяционный, в основу которого должны лечь популяционные механизмы контроля факторов риска (популяционные методики, направленные на повышение физической активности, контроля уровня приема алкоголя, диеты,

ISBN 978-601-08-0758-7

курения, учет загрязнения окружающей среды и др.).

Основными факторами риска СД ожидаемо, названы: неправильное питание, физическая инертность, употребление табака и вредное употребление алкоголя.

Для выявления распространённости факторов риска СД среди населения города Усть-Каменогорск проведено онлайн-анкетирование при помощи интернет ресурса https://www.heartbeatrussia.ru., Полученные данные структурированы, систематизированы, при необходимости в индивидуальном порядке проведена личная беседа. Данные по анкетированию сведены для наглядности в диаграмму (диаграмма 1)

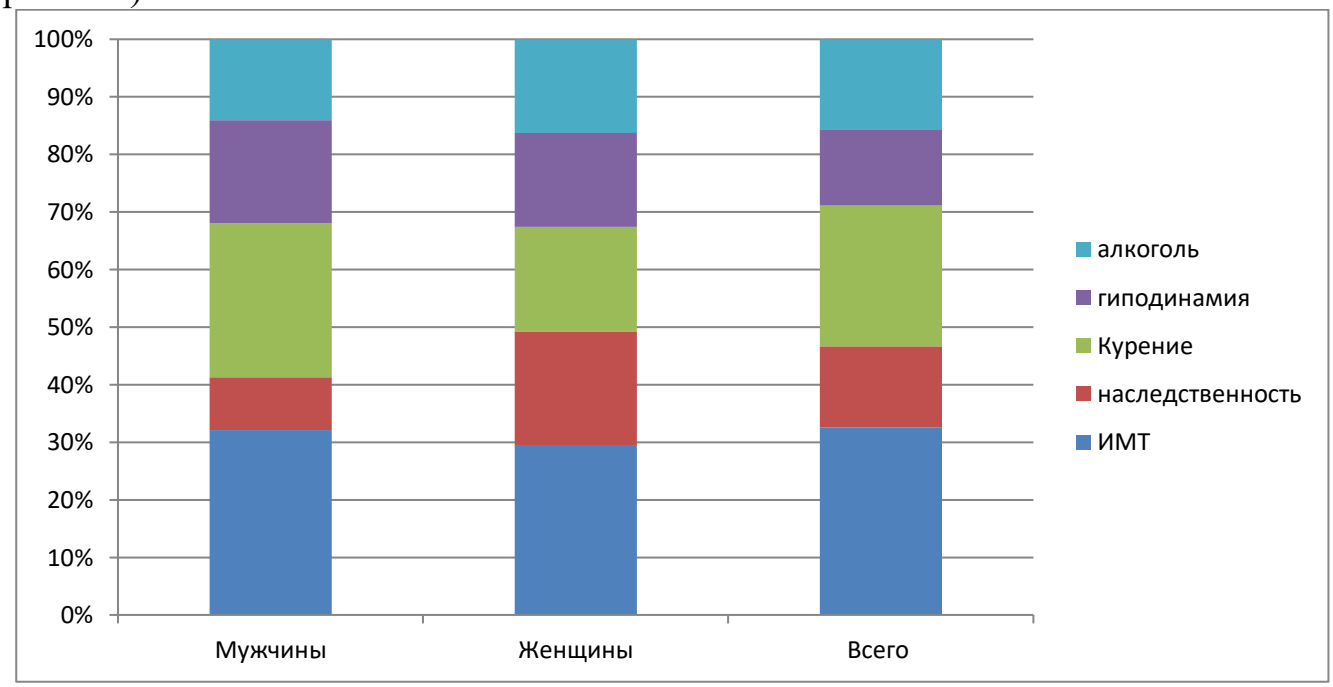


Диаграмма 1 Наиболее часто встречающиеся факторы риска в регионе г. Усть-Каменогорск

Результаты наблюдений показывают, что наиболее часто встречающимся фактором риска являются: лишний вес и курение. Также необходимо отметить, что лиц мужского пола, имеющих в арсенале хотя бы один фактор риска, больше. Ниже представлены примеры результатов анкетирования (рисунок 1)

ISBN 978-601-08-0758-7

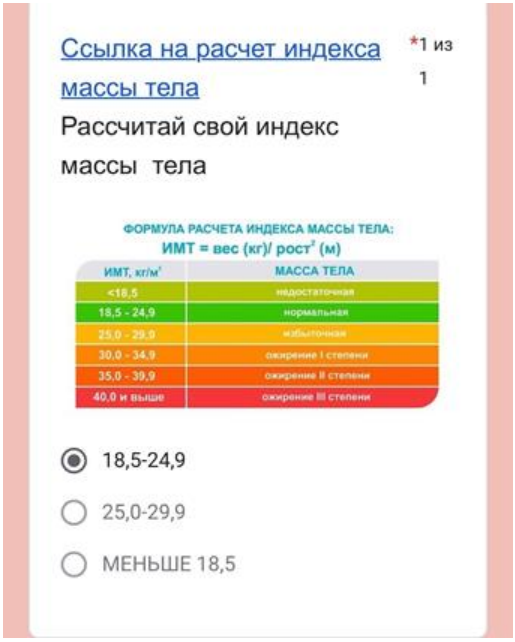


Рисунок 1 Пример результатов анкетирования

Помимо проведения анкетирования и сбора данных у лиц не состоящих на учете с СД, данным исследованием преследовалась цель – привлечение внимание индивида к своему образу жизни, тем более, что название общедоступного теста «Тестирование для оценки риска развития сахарного диабета» привлекает внимание, заставляя задуматься о последствиях наличия факторов риска.

В целях усиления мотивации людей в отношении выбора и поддержания здоровых форм поведения проведена работа по привлечению к анкетированию максимального количества лиц, не состоящих на учете с СД, одной из поликлиник города. (рисунок 1)

Выводы, рекомендации. **К**омплексный подход с учетом наиболее часто встречающихся факторов риска способен значительно снизить частоту случаев диабетических нарушений. Этот подход практически осуществим в условиях низкой обеспеченности ресурсами, включая использование неврачебного медицинского персонала.

При написании данной работы для нас было важно обозначить то, что мы можем сделать для того, чтобы привлечь внимание к данному заболеванию, а также к способам его избежать, ведь заболеваемость сахарным диабетом ежегодно стремительно растет. В наших силах объяснить окружающим, что изменяя образ жизни, они могут продлить и сохранить свою жизнь. Учитывая, что основной причиной возникновения сахарного диабета является неправильное питание, мы решили разработать рецепты, оформив их в книгу рецептов. Книга будет включать рецепты завтраков, обедов и ужинов. Особенность этих рецептов в том, что завтраки всегда белково-жировые, что дает человеку насыщение дольше, чем углеводные завтраки, при этом сахар в крови не поднимается до высоких цифр. При составлении данных рецептов учитываются рекомендаций эндокринологов-диетологов.

ISBN 978-601-08-0758-7

Также создан социальный ролик **«10 способов избежать сахарный диабет»** с помощью программы In Shot. Видео – ролик загружен на YouTube с доступом по ссылке https://youtu.be/vpCVAg7bF9E?si=OOgmk5-62-SPQtNd. Респонденты имеют возможность просматривать видео-ролик.

Необходимо, с учетом определяемых особенностей распространенности поведенческих факторов риска в каждом регионе (страна, город, село), проводить общую и индивидуальную оценку риска СД и соответственно этому разрабатывать индивидуальную программу профилактики СД.

Список литературы:

1. Лябах, Н. Н. – Сахарный диабет: мониторинг, моделирование, управление. [Текст]: электронный ресурс / Н. Н. Лябах. Ростов на Дону, 2015 – 102 с. 9.
2. Медведева, О. С. – Сахарный диабет, клиника, диагностика, поздние осложнения, лечение. [Текст]: учеб. метод. пособие / О. С. Медведева. – Мед. практика, Москва , 2017– 109 с
3. "Биологические активные добавки" Рисман М.
4. "Диабет: Вопросы и ответы" Бриско П.
5. "Диета при сахарном диабете" КогоутП, Павличкова Я.
6. "Как жить с диабетом: Советы для подростков с сахарным диабетом, а также для родителей больных детей"
7. "Инсулиннезависимый сахарный диабет: Основы патогенеза и терапии" Аметов А.С., Грановская-Цветкова А.М., Казей Н.С.

ISBN 978-601-08-0758-7

ОЦЕНКА И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫСШЕГО СЕСТРИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Мирманова Р., 3 курс, специальность «Сестринское дело»
ГКП «Актюбинский высший медицинский колледж
Имени Героя Советского Союза Маншук Маметовой» на ПХВ
Научный руководители: Тлеулесова Венера Исмаиловна, Бейшева Гульнур Саматова, магистры, преподаватели специальных дисциплинЦМК «Сестринское дело»

Аннотация: *Существенные изменений и реформ, происходящих в сфере сестринского дела в Республике Казахстан. Медицинский персонал, включая медсестер, составляет наибольшую категорию медицинских работников, и услуги, предоставляемые ими, считаются ценным ресурсом в секторе здравоохранения. Важно подчеркнуть, что это соответствует как национальным, так и международным стратегическим и программным инициативам в области здравоохранения, утвержденным правительством Казахстана.*

Цель дипломной работы *заключается в проведении анализа потенциальных возможностей профессионального развития выпускников, окончивших обучение по программам высшего медицинского образования, специализирующихся в медицинской сестринской сфере.*

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что сестринское дело становится ключевым элементом современной системы здравоохранения. Поэтому исследование продолжает актуальный дискурс в области медицинской практики и образования.

Существенные изменений и реформ, происходящих в сфере сестринского дела в Республике Казахстан. Медицинский персонал, включая медсестер, составляет наибольшую категорию медицинских работников, и услуги, предоставляемые ими, считаются ценным ресурсом в секторе здравоохранения. Важно подчеркнуть, что это соответствует как национальным, так и международным стратегическим и программным инициативам в области здравоохранения, утвержденным правительством Казахстана.

Система сестринского дела в Республике Казахстан проходит через комплексную реформу, которая включает научное обоснование сестринских практик и образования. Эти реформы стали частью стратегических и программных инициатив правительства в сфере здравоохранения. Следовательно, данное исследование имеет важное значение, поскольку оно направлено на анализ и оценку современных тенденций в развитии сестринского образования в Казахстане и выявление ключевых проблем и перспектив, которые могут послужить основой для дальнейших улучшений в данной области.

Цель дипломной работы заключается в проведении анализа потенциальных возможностей профессионального развития выпускников, окончивших обучение по

ISBN 978-601-08-0758-7

программам высшего медицинского образования, специализирующихся в медицинской сестринской сфере.

Задачи исследования:

- Разработать программу и методику исследования процесса интеграции сестринского образования и практического здравоохранения.
- Анализ процесса интеграции сестринского образования и практического здравоохранения с акцентом на изучение инновационных методов в базовом образовании. Исследовать развитие интеграции, ориентируясь на изучение инновационных подходов в повышенном, последипломном и высшем образовании
- Провести социологическое исследование, направленное на изучение отношения медицинских сестер, находящихся в профессиональной практике, к освоению высшего сестринского образования на разных уровнях их профессионального развития.

В данном исследовании был использован анализ литературы, результаты изучения мнения отечественных и зарубежных авторов (при написании работы использовано 39 отечественных и 15 зарубежных литературных источников), которые представляют собой обширный анализ существующих теорий, концепций и методологий в сфере сестринского дела. Этот анализ позволяет оценить текущее состояние исследований в данной области и выделить основные направления, важные для дальнейшего развития сестринской практики и образования.

Собственные исследования предоставляют детальные данные и результаты, полученные в рамках данной научно-исследовательской работы. Этот раздел включает в себя описание методологии исследования, характеристику выборки, а также представление собранных данных. Далее, результаты анализа данных детально обсуждаются и интерпретируются с учетом теоретического фреймворка, представленного в первом разделе. Это позволяет сделать выводы и сформулировать практические рекомендации, которые представлены в соответствующих разделах заключения и выводов.

В ходе проведенного опроса приняло участие 270 респондентов, из которых 149 человек (56%) были студентами, а 121 человек (44%) - выпускниками факультетов высшего сестринского образования. Следует отметить, что подавляющее большинство, а именно 97,3%, составляли представительницы женского пола. Этот факт подтверждает традиционное преобладание женщин в профессии медицинских сестер.

Возраст респондентов был классифицирован на несколько групп для последующего анализа. Наиболее широко представлены следующие возрастные категории респондентов:

- Группа в возрасте от 18 до 20 лет, составляет 36% от общего числа участников исследования.
- Возрастная категория от 20 до 29 лет составляет 15% от общего числа.
- Группа в возрасте от 30 до 39 лет составляет 26% от общего числа.
- Группа в возрасте от 40 до 49 лет составляя 19% от общего числа участников.

ISBN 978-601-08-0758-7

- Самая старшая группа в возрасте от 50 до 59 лет составляет 4% от общей выборки.

Главным мотивом выбора профессии медсестры было желание служить обществу и заботиться о нем, на что указали 129 человек (48%), затем последовали более широкие возможности заработка, на что указали 64 человека (24%). Среди других факторов влияния - желание родителей, 46 (17%), и социальный статус, 15 (5%). Лишь немногие студенты выразили внутренний интерес к профессии медсестры.

Мотивации студентов для поступления на факультет высшего сестринского образования включают желание получить высшее образование, самореализацию и профессиональный рост.

Эти данные указывают на то, что большинство выпускников факультета ВСО остаются в сфере здравоохранения и продолжают работать в соответствующей области после завершения обучения. Это свидетельствует о их прочной связи с медицинской профессией и стремлении применить полученные знания и навыки в данной сфере труда.

После анализа профессионального роста выпускников ВСО стало ясно, что многие из них продолжают свою карьеру как медицинские сестры, но также сохраняют амбиции на будущий карьерный рост. Из общего числа респондентов, 46% или 120 человек отметили, что достигли профессионального роста. Среди них:

- 72 человека (59%) заняли позиции в преподавательской деятельности.
- 27 человек (21%) стали главными медицинскими сестрами.
- 16 человек (12%) заняли должности старших медицинских сестер, управляющих отделениями.
- 11 человек (8%) работают в области медицинской профилактики и организации методической работы;

Из общего числа опрошенных, включая как студентов, так и выпускников, 48% или 130 человек работают в должностях, соответствующих их образованию, включая преподавательскую деятельность (13%), главных медицинских сестер (15%), и старших медицинских сестер, выполняющих функции менеджеров отделений (24%).

Среди опрошенных, 60% или 162 человека отмечают, что после окончания обучения на факультете высшего сестринского образования частично оправдались их ожидания. 23% или 62 человека говорят, что их надежды еще не полностью сбылись, либо они не приняли окончательного решения по этому вопросу. 17% или 46 респондентов считают, что они успешно реализовали себя после завершения обучения.

Анализ трудоустройства 91% существует ограниченный спрос на выпускников ВСО в практической сфере здравоохранения. 46% респондентов, пользуются недостаточным спросом, особенно из-за недостаточного интереса со стороны административных руководителей медицинских учреждений в организации сестринской практики, 34% респондентов отметили ограниченное распространение

ISBN 978-601-08-0758-7

информации о существовании и роли специалистов-менеджеров в сестринской сфере.

Результаты этого исследования показывают, что несоответствия в образовании медсестер все еще существуют, несмотря что Болонский процесс помог. Медсестрам необходимо приложить дополнительные усилия на политическом уровне для достижения согласия в отношении требований и стандартов для сестринского образования и преподавателей по всему Казахстану, чтобы можно было поощрять и расширять передвижение студентов и специалистов. Необходимы дополнительные исследования для более детального изучения этого вопроса.

ВЫВОДЫ

1. В современном контексте система здравоохранения оказывается недостаточно подготовленной для приема новых специалистов в сестринском деле. В то же время образование специалистов в сфере сестринского дела находится на более высоком уровне, чем потребность со стороны практической медицины в таких специалистах. Современные реформы и развитие сестринского образования опережают реформы в системе здравоохранения. Важно сосредоточить внимание на выравнивании данных двух процессов, чтобы обеспечить более эффективное взаимодействие сестринской практики и требований здравоохранения.
2. Оценка перспектив профессионального роста выпускников колледжа показала, что спрос на специалистов в области высшего сестринского дела в здравоохранения оказывается низким. Большинство выпускников продолжают работать на должностях медсестер, которые не соответствуют их полученному образованию. Это указывает на несоответствие между уровнем образования и требованиями рынка труда.
3. В целом, выводы этого исследования подчеркивают необходимость пересмотра и усовершенствования системы сестринского дела, а также адаптации образования специалистов к потребностям современного здравоохранения. Профессиональный рост и удовлетворенность собственной карьерой среди выпускников ВУЗов сестринского дела остаются актуальными вызовами. Это требует дальнейших исследований и реформ для обеспечения более успешной карьеры и улучшения здоровья специалистов сестринского дела.

Использованные литературы:

1. https://stud.kz/ru/referat/show/110619
2. https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39860292
3. http://proinca-nursing.kz/wp-content/uploads/2019/12/8-perspektivy-razvitiya-sestrinskogo-dela-v-respublike-kazahstan.pdf
4. https://edu.rvmc.kz/uploads/2017/05/kompleksnyy_plan_ru.pdf
5. Двойников С.И. Значение проведения научных исследований в сестринском деле для развития здравоохранения, //Ж. Главная медицинская сестра 2009, № 4 - с.84-86

ISBN 978-601-08-0758-7

6. Ибрагимов И.М., Асхабова Л.М. Опыт подготовки выпускников факультета высшего сестринского образования в годичной интернатуре по специальности “Управление сестринской деятельностью”//Ж. Главная медицинская сестра №5-2008, с. 37-40

6. Загороднова Г.А., Павлов Ю.И. Характеристика удовлетворенности трудом и производственная мотивация медицинских сестер//Ж. Главная медицинская сестра №3-2008 .

7. Соболева Н.И. Мнение студентов института сестринского образования О высшем сестринском образовании /Н.И.Соболева //Проблемы Городского здравоохранения Вып. 14: Сб. науч. тр./ Под редакцией проф. Н.И. Вишнякова, - СПб, 2009. - с. 403-405.

ISBN 978-601-08-0758-7

МЕДИЦИНАДАҒЫ ЗЕРТТЕУЛЕРДІҢ ӨЗЕКТІЛІГІ

Ршаева Алина Әмірханқызы., 3 курс «Емдеу ісі» мамандығы
Қызылорда медициналық жоғарғы колледжі ҚМЖК
Ғылыми жетекшісі Қалданова Назерке Оразайқызы., арнайы пән оқытушысы

Аннотация: *Қазіргі кезде аурудың алдын алу, емдеу, диагностикалау медицинаның шарықтау шеңіне жетті. Дегенмен де, қоғамда жаңаша ауруларда пайда болып жатыр. Осы орайда, аталмыш ауруларды анықтау және емдік шешімін табу үшін түрлі медициналық зерттеулер жүргізілуде. Осы ретте, зерттеулердің жаңа әдісін популяциялық деңгейде тәжірибеге енгізу үшін, сол әдістің тиімділігін тексеру кезінде қол жеткізген ғылыми фактілердің шынайылығын талдау нәтижелеріне жүгіну қажеттілігі айдан анық.*

Методиканың тиімділігі тек сенімді зерттеулерде дәлелденген – медицинасы дамыған шет елдердің тәжірибесіндегі аурудың алдын-алу, емдеу және диагностика әдістері қонданысқа енгізілуде.

Мәселен, Ұлыбритания, Швеция, Нидерланды, Канада, АҚШ-та жаңа медициналық технологияларды бағалайтын агенттік ұйымдастырылды. Бұл агенттіктердің міндеттері – диагностикалау мен емдеудің жаңа әдістері туралы бар ақпараттарды жанжақты зерттеп, сын көзбен бағалайды. Нәтижесінде сапалы жүйе қалыптасады.

Медицинадағы зерттеу иерархиясы – ұйымдастырылуына және орындалуына байланысты обсервациялық және эксперименттік болып екіге бөлінеді.

Обсервациялық зерттеу болып жатқан құбылыстарға ешқандай іс-әрекет жасамай, тек бақылау жүргізіледі . Мәселен:

Талдау (талдау) кейс-бақылау, когортты зерттеуді қамтиды. Этиология, себеп-салдарлық синтез және болжам зерттелді. Сол сияқты гипотезаны орындау мүмкіндігі қандай да бір әрекетсіз ауру барысын сырттай бақылау арқылы бағаланады.

Сипаттамаға бір жағдайды сипаттау, бірнеше жағдайды сипаттау, көлденең зерттеулер кіреді. Аурудың дамуына бақыланбайтын факторлардың әсері зерттелді. Әр түрлі гипотезалар жасалады [1].

Тәжірибелер зерттеушінің іс-әрекетіне байланысты бақыланатын және бақыланбайтын болып бөлінеді. Бұл ретте байқалатын түрі кездейсоқ және кездейсоқ емес болып келеді.

Барлық зерттеулер біріншілік және екіншілік болып бөлінеді:

Біріншілік зерттеулер – автор өзінің жүргізген зерттеу түрін және оның қорытындысын өзі сипаттайды, ол 3 категорияға бөлінеді:

1. **эксперименттер** – өзі келісім бергендерге немесе жануарларға тәжірибе жасалады.

2. **зерттеулер** – белгілі бір топтағы пациенттердің немесе кезкелген топтағы кісілердің денсаулығының көрсеткіші өлшенеді, анықталады.

ISBN 978-601-08-0758-7

3. **клиникалық сынау** – пациенттерге жасалады және олар тұрақты бақылауда болады [2].

Екіншілік зерттеулер – біріншілікті зерттеулердің нәтижелерін жинақтап, топтастырып және солардың негізінде қорытынды шығарылады.

Екіншілік зерттеулер де бірнеше түрлерге бөлінеді:

1. **шолу** – біріншілікті зерттеулердің қорытындысын топтастырып жинақтайды.

2. **клиникалық нұсқаулар** – дәрігерлердің іс-әрекетінің талаптарына қатысты біріншілікті зерттеулердің қорытындысын құрастырады.

3. **шешімді қабылдауға талдау жасау** – біріншілікті зерттеулер қорытындысының негізінде денсаулық сақтау жүйесін басқару , ресурстарды бөлу жөнінде мүмкін болатын жолды құру, дәрігерлердің , басшылардың емдеу әдісін таңдау және ресурстарды бөлу шешімдерін құрастыру.

4. **экономикалық талдау** – біріншілікті зерттеулердің нәтижесін пайдалана отырып, қолданылатын іс-әрекетке қаражатты дұрыс бөлу жөнінде шешім қабылдауға мүмкіндік береді [3].

Медициналық зерттеу жүргізу түріне байланысты 2-ге бөлінеді:

1) ашық – істелетін зерттеу жасырынсыз өтеді;

2) жасырын – істелетін зерттеу әр түрлі дәрежеде жасырын өтеді.

Медициналық зертеулерге қойылатын ең басты талаптар:

1. Дұрыс ұйымдастырылған тексерістер (дизайн) және математикалық санаққа негізделген рандомизация (іріктеу).

2. Тексерістерге еңгізілетін мен еңгізілмейтін көрсеткіштер көлемі нақты анықталады және сақталады.

3. Дерттің емнен кейінгі және ем жасалмағандағы ақыры (көрсеткіштері) дұрыс анықталған (белгіленген).

4. Зерттеудің өткізілетін орны.

5. Зерттеудің ұзақтылығы.

6. Алынған мағлұматтардың статистикалық өңделуінде санау әдістері ретімен қолданған [4].

Зерттеу дизайны түрлері:

1. Бір сатылы немесе көлденең тексеру – әрбір адам уақыт кезеңіне бір рет тексеріледі, ал аурудың сипаттамасы келтіріледі, бірақ даму процесі зерттелмейді. Зерттеудің мақсаты симптомдарды нақтылау, кейбір симптомдардың аурудың диагнозымен және ауырлық дәрежесімен байланысын анықтау болып табылады. Ауру диагнозының жиілігі, барысы және дәлдігі анықталады.

2. Жағдай бақылауға және ретроспективті зерттеулерге – талдауға (сараптамаға) жатады. Халық арасынан ауруы бар және ауруы жоқ адамдар іріктеледі: 1) зерттелетін ауруы бар эксперименттік топ 2) бақылау тобы немесе салыстыру тобында ауру болмайды, зерттеуге қатысушылар мұрағаттық материалдардан іріктеледі, содан кейін болжанған факторлардың салдарын, аурудың себебін ретроспективті түрде зерттейді. Бұл зерттеу аурудың этиологиясы туралы гипотезаны тексеруге көмектеседі [5].

ISBN 978-601-08-0758-7

Аурудың жай-күйін анықтайды (ауру диагнозы қойылған науқастарды іріктеу)

Қауіп факторы туралы ықтимал ретроспективті гипотеза анықталады: ауруы жоқ, бірақ басқа симптомдарға ұқсас бақыланатын науқастар тобын анықтау арқылы осы топтарда қауіп факторының бар-жоғы анықталады.

3. Когорттық зерттеу – аналитикалық (аналитикалық) проспектілер. Ол қауіп факторлары мен аурулар мен болжамдардың өзара байланысын зерттейді. Қауіп факторы - аурудың пайда болуына әсер ететін фактор. Мысалы: гипертония үшін қауіп факторлары - гиподинамия, гиперхолестеринемия, тұқым қуалау, темекі шегу және т.б.

а) тәуекел тобы

б) тәуекел коэффициенті әсер етпейтін топ

Бұл 2 топ ұзақ уақыт бойы зерделенеді және нәтижесі салыстырылады (нәтижелері бойынша) Ол үшін қажетті ақпарат күнге дейін анықталады және толық көлемде жиналады, содан кейін зерттеліп жатқан нәтижемен (аурумен) қандай қауіп факторы байланысты екені анықталады. Классикалық когортты зерттеу үшін әртүрлі қауіп факторлары бар екі немесе одан да көп когорт іріктеледі, бірнеше жыл бойы зерттеледі, жаңа клиникалық нәтижелер анықталады. Когорт — кейбір ортақ белгілермен біріктірілген топ. (мысалы, дені сау немесе аурудың белгілі бір сатысында тұрған адамдар).

Ерекшеліктері:

Ауруды үздіксіз бақылау процесінің қай жартысы дамығаны анықталады;

Қорытынды зерттеудің басында белгісіз болады;

тәуекел коэффициентінің әсеріне ұшыраған адамдар ағынын перспективалық зерттеу; Бір фактордың әсеріне байланысты бірнеше қорытынды жасауға болады. Кемшіліктері: уақытты қажет ету; Когорттанудың негізгі кемшілігі – сирек кездесетін қорытындыларды үйрену үшін үлкен топтарды ұзақ уақыт бойы ұстануы қажет; Бұл көп ақшаны қажет етеді, 100% бақылау мүмкін емес, себебі уақыт өте келе зерттелетін фактордың әрекеті мен сипаты өзгеруі мүмкін [6].

4. Рандомизирленген зерттеулер – «Ашық» және кездейсоқ сынақтар кезінде рандомизация аяқталғаннан кейін пациент пен дәрігер қандай ем қолданылатынын біледі.

«Біржақты жасырын» кездейсоқ сынақтар кезінде пациент қолданылатын ем түрін білмейді, бұл пациент зерттеуге келісім берген кезде түсіндіріледі.

«Екі жақты жасырын» зерттеу барысында науқас та, дәрігер де емдеудің қай әдісі қолданылатынын білмейді.

«Үш жақты құпия» зерттеу барысында науқас та, дәрігер де, зерттеу нәтижелерін статистикалық өңдеуді орындайтын зерттеуші де емдеудің қандай әдісі қолданылатынын білмейді.

Қазіргі уақытта «Алтын стандарт» « екі және үш жақты» құпия зерттеу болып табылады. Бұл зерттеулер: науқастың анатомиялық деректерін зерттеу;

Топтарды дәрігер құрады;

– Субъективтілік, топтар толық құрылмаған;
– Топтар арасындағы салыстыру нақты емес;

ISBN 978-601-08-0758-7

– Шешімді дәрігер қабылдайды.

Иерархияның шыңында екіншілікті зерттеулер – жүйені шолу және мета-талдау. Жүйелі шолу - қазіргі заманғы әдістерді қолдана отырып, барлық бастапқы зерттеулерді қарап, емдеу нәтижелері мен олардың сапасын қорытындылайтын зерттеу.

Бұл арнайы медициналық зерттеулердің нәтижелерін қорытатын ғылыми зерттеу. Жүйелі шолу зерттеулердің жаңа нәтижелерінің түсуіне қарай үнемі жаңартылып отырады. Жүйелі шолуда араласудың пайдасын немесе зиянын анықтайтын және оны қолдануға болатын-болмайтыны туралы ақпарат жиналады. Жүйені тексеру нәтижесінде теріс әсерлер анықталуына байланысты кейбір шараларды қолдануға болмайды [7].

Қорытындылай келе, медицинадағы зерттеулер – науқастарды негізгі (сынақ жүргізілетін) немесе бақылау (салыстыру) топтарға еңгізіп медициналық іс-әрекеттер мен клиникалық ақырының арасындағы себепті мен нәтижелік байланысын анықтауға арналған келешек бағытта (проспективті) жүргізілетін қандайда болмасын тексеріс *(медициналық журналдар редакторларының халықаралық ұйымының анықтамасы)*.

Қазіргі уақытта медициналық университеттерде, жоғары медициналық колледждерде, сондай-ақ клиникалық тәжірибеде мейіргер ісі саласында ақпарат жинауға және зерттеулер жүргізуге деген қызығушылық пен ынта-ықылас артып келеді деп айтуға болады. Сондай-ақ, мейіргерлердің рөлі мен мейіргер ісінің клиникалық тәжірибедегі маңызы туралы зерттеулер өсіп келе жатқанын атап өту керек. Қазақстанда жоғары сапалы дәлелдемелі денсаулық сақтауды дамытуға және зерттеулер арқылы медициналық қызметтерді ұйымдастырудың жаңа модельдерін құруға мотивация өсіп келе жатқанын ерекше айта кетken жөн.

Дегенмен де, білім беру мекемелері мен клиникалық практика арасында жоспарлы және тұрақты түрде зерттеулермен айналысу үшін көбірек мүмкіндіктер қалыптастыру қажет екенін назарларыңызға саламын.

Әдебиеттер тізімі:

1. Fischer, Jan, et al. -»Medical Augmented Reality based on Commercial Image Guided Surgery.»- EGVE. 2004.

2. Products. Rehabunculus (2018) / Iisci.http://www. iisci.ru/dobro-pozalovat/products

3. Баламетова Н.Г., Прошина И.А..- «Дополненная реальность в медицине» - «Физика и медицина: создавая будущее», 2018.

4. AR - Дополненная реальность // Habr: будущее здесь. 2006-2019. URL:https://habr.com/ru/ post/419437

5. Намиот Е.Д. «Дополненная реальность в медицине»-«International journal of open information technologies», 2019.

6. С.В. Стрелков, А.Л. Автюшенко, Н.В. Васильев, В.М. Иванов.- «Создание 3d модели сердца пациента на основе данных мрт и кт и визуализация с

ISBN 978-601-08-0758-7

помощью дополненной реальности» - «Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения», т. 10, ч. 2, 2015.

7. Vuforia Developer Portal | https://developer.vuforia.com/

ISBN 978-601-08-0758-7

СТУДЕНТТЕРДІҢ ЖҮРЕК - ҚАН ТАМЫРЛАРЫ АУРУЛАРЫНЫҢ ҚАУІП ФАКТОРЛАРЫН АНЫҚТАУ

Сарбасова А.С., 2курс, "емдеу ісі"мамандығы
Кеңгесбай А.М., 2курс, "мейіргер ісі" мамандығы
"Маңғыстау облыстық жоғарғы медициналық колледжі"
Ғылыми жетекшісі Сексенбай З. Н., магистр, Арнайы пәндер оқытушысы

Аннотация: *Бұл мақалада студенттердің жүрек қан тамыр жүйесінің ауруларына қауіп факторларын анықтау қарастырылды. Ол үшін респонденттерден сауалнама алу, антропометриялық көрсеткіштер (бой өлшемі, салмақ өлшемі, іш айналымын өлшеу) мен физиологилық көрсеткіштерін (АҚҚ, тыныс алу жиілігі) анықтау жұмыстары жүргізіліп, STATISTIC-10 бағдарламасы арқылы алынған мәліметтер статистикалық өңдеуден өтті.*

*Өзектілігі.*Мүгедектіктің кең таралуы мен ерте дамуына байланысты жүрек-қан тамыр жүйесі аурулары қазіргі медицинаның негізгі мәселесі болып табылады.Бұл аурулардың жас адамдарда жиі диагноз қойылатындығы алаңдатады.Қазіргі уақытта жастар арасында жүрек-қан тамырлары ауруларының таралу үлесінің артуына байланысты, жастар арасында жүрек-қан тамырлары ауруларының алдын-алу ерекше назар аударуды қажет етеді. Жүрек-қан тамырлары ауруларының пайда болу көздері әлі жас және жасөспірім жаста екенін ескере отырып,алдын-алу шараларын адамдардың бағытталған контингентіне(студенттер, оқушылар) байланысты жүргізген жөн.

Зерттеу мақсаты: Студенттерде жүрек-қан тамыр жүйесі ауруларының қауіп факторларын анықтау.

*Зерттеу материалдары мен әдістері.*Мағыстау облыстық жоғары медициналық колледжінің 1-4 курстарының 50 ер студентіне кешенді және клиникалық-аспаптық тексеру жүргізілді.Студенттердің дене салмақ индексі (ДСИ), бел шеңбері және тобық-иық индексі (ТИИ) анықталды. Алынған нәтижелерді статистикалық өңдеу STATISTICA10 статистикалық бағдарламалар пакетін қолдану арқылы жүргізілді. Сипаттамалық статистика сенімділік аралықтарын есептеумен жүргізілді.

*Зерттеу нәтижелері.*Тексерілушілердің орташа жасы 19,4 жасты құрады. Антропометриялық зерттеулердің нәтижелері келесідей болды:Биіктігі -176,2±1 см, салмағы– 72,4±2кг.ТИИ – бұл білек артерияларындағы систолалық қысымның иық артерияларындағы систолалық қысымның шамасына қатынасын көрсететін көрсеткіш. Дені сау адамдарда білектерге систолалық қысым әрқашан қолдарға қарағанда біршама жоғары болады. ТИИ қалыпты көрсеткіштері 1,1-1,29 болып саналады. Зерттеуде 81,5% - да бұл көрсеткіш қалыпты болды. Қалыпты критерийлердің төменгі шегі 1-1,09, зерттеуде 11% болды. 0,9-дан 0,99-ға дейінгі

ISBN 978-601-08-0758-7

көрсеткіштер шекаралық төмендеу болып саналады (5% - да), ал 0,9-ға дейінгі көрсеткіштер шеткергі артериялар ауруларының болуын көрсетеді (1,5%). ТИИ патологиялық деңгейі перифериялық артериялардың айқын өзгерістерін ғана емес, сонымен қатар жүрек-тамыр ауруларының дамуына әсер етуі мүмкін бастапқы өзгерістерді де көрсете алады. ДСИ анықтау зерттелгендердің 12% - ында салмақтың жетіспеушілігі, ал 21% - ында артық салмақ бар екенін көрсетті. 67% - да бұл көрсеткіш қалыпты болды. Сондай-ақ, іштің көлемін зерттеу кезінде аздап ауытқулар байқалды. Зерттелгендердің 8%-ында тері астындағы майдың арқасында іштің ұлғаюы анықталды.

Қорытынды.Бұл зерттеу Маңғыстау облыстық жоғары медициналық колледж студенттерінде жүрек-қан тамырлары ауруларының кейбір факторлары бар деген қорытындыға келді, олар әрі қарай зерттеуді қажет етеді. Респонденттерге салауатты өмір салтын ұстануды ұсындық.

Әдебиеттер тізімі:

1. Арыстанбекова, А. А., Сағындықова, Л. Т. Жүрек-қан тамырлары ауруларының эпидемиологиясы мен алдын алу шаралары. Қазақстанның кардиология журналы, 2022.
2. Ким, Н. В., Жумабаев, М. А. Антропометриялық көрсеткіштердің жүрек-қан тамыр ауруларымен байланысы. Алматы: Медицина баспасы, 2021.
3. Ахметова, Ж. К. Медициналық колледж студенттерінде жүрек-қан тамыр ауруларының алдын алу. Медицина және қоғам, 2023.

ISBN 978-601-08-0758-7

ПНЕВМОНИЯ АУРУДЫҢ ЕМДЕУ ЖОЛДАРЫ

Серік Камила, 1 курс, «Мейіргер ісі» мамандығы
Алматы қаласы ШЖҚ Жоғары медициналық колледжі КМК
Ғылыми жетекшісі: Тажиев Ербол Елғондыұлы, қазақ тілі мен әдебиеті пән оқытушысы

Аннотация: *Пневмония – тыныс алу жүйесінің қауіпті ауруы, өкпенің қабынуымен сипатталады. Бұл ауру ерте замандардан бері белгілі және Гиппократ пен Галеннің жазбаларында сипатталған. XIX ғасырда микробиологияның дамуы пневмонияның бактериалды табиғатын анықтауға мүмкіндік берді, ал антибиотиктердің енгізілуі пневмониядан өлім көрсеткішін айтарлықтай төмендетті. Аурудың негізгі белгілері жөтел, қызу көтерілу, кеуде ауырсынуы және тыныс алудың қиындауы болып табылады. Пневмонияны емдеу антибиотиктер, антивирустық және иммунитетті қолдайтын дәрілерді қолдануды қамтиды. Алдын алу шараларына вакцинация, дұрыс тамақтану, иммундық жүйені қолдау және суықтан сақтану жатады. Бұл жұмыста пневмонияның шығу тарихы, белгілері, түрлері, емдеу әдістері және алдын алу жолдары қарастырылған.*

Пневмонияның шығу тарихы өте ежелгі. Ол адамзаттың алғашқы медициналық жазбаларынан бері белгілі. Алғашқы медициналық еңбектерде пневмонияның белгілері мен себептері туралы сипаттама кездеседі. Мысалы, Гиппократ б.з.д. V ғасырда пневмонияны сипаттаған алғашқы дәрігерлердің бірі болған. Ол өкпенің қабынуын және оған байланысты дене қызуының көтерілуі, жөтел сияқты белгілерді жазып кеткен.

Римдік дәрігер Гален де пневмонияны зерттеген және оны емдеудің тәсілдерін іздеген. Орта ғасырларда пневмония өте қауіпті ауру болып есептеліп, оны "пісірілген өкпе" деп атаған.

Пневмонияның микробтық табиғаты XIX ғасырдың соңында анықталды. 1875 жылы неміс ғалымы Эдвин Клебс пневмонияға себеп болатын бактерияларды тапты. Кейінірек, 1881 жылы Луи Пастер мен Джордж Стернберг тәуелсіз түрде пневмонияның негізгі қоздырғышы – пневмококк бактериясын анықтады.

XX ғасырда антибиотиктердің пайда болуы пневмонияны емдеуде үлкен серпіліс жасады, әсіресе пенициллин 1940 жылдардан бастап қолданылғанда, пневмониядан өлім көрсеткіші күрт төмендеді. Алайда, бүгінгі күнге дейін пневмония әлемдегі басты денсаулық мәселелерінің бірі болып қалып отыр.

Ауру түрлері:

1. Имунның тапшылығы

ISBN 978-601-08-0758-7

2. Темекі тарту
3. Суыққа ұрыну
4. Алкоголизм
5.Жануарларды ұстау

Ауру белгілері:

1. Қызу көтерілуі
2. Тамаққа тәбеті болмауы
3. Тыныс алуы нашарлау
4. Жөтел
5. Кеуде қуысының ауырсынуы
6. Шаршаужәне ауырсыну
7. Жүрек соғысының жиілеуі
8. Бас ауыруы

Емдеу жолдары:

1. Антивирустық дәрілер
2. Иммунитетті көтеру
3. Дұрыс тамақтану
4. **Д витамині мен басқа да дәрумендерді қабылдау**
5. Вакцина алу
6. Қызуды түсіру
7. Қақырықты сұйылту
8. Антибиотиктер қолдану

Дәлел:

Пневмонияның негізгі белгілері мен дәлелдері мыналар болуы мүмкін:

1. Жөтел – жиі, құрғақ немесе қақырықты жөтел болуы мүмкін.

2. Дене қызуының көтерілуі – 38-39°C және одан жоғары температура.

3. Кеуде ауыруы – тыныс алу кезінде немесе жөтелгенде күшейетін кеуде қуысының ауыруы.

4. Тыныс алудың қиындауы – тыныс алу ауыр болып, ентігу пайда болуы мүмкін.

5. Шаршағыштық және әлсіздік – адам өзін шаршаған және әлсіз сезінуі мүмкін.

6. Терінің бозаруы немесе көгеруі – оттегінің жеткіліксіздігінен тері түсі өзгеруі мүмкін.

7. Жүрек соғысының жиілеуі – пневмония кезінде жүрек соғысы жиілейді.

8. Терлеу және дірілдеу – қатты терлеу және дененің дірілдеуі болуы мүмкін.

ISBN 978-601-08-0758-7

Пневмонияның ауыр жағдайларында әлсіздік күшейіп, ес-түсінің бұзылуы, тіпті жедел тыныс

Қорытынды:

Пневмониядан сақталудың бір жолы вакцинациялану.Атап айтқанда тұмауға қарсы вакциналар пневмонияны болдырмауға көмек береді.

Пневмония — өкпенің қабынуымен сипатталатын, тыныс алу жүйесінің ауыр ауруы. Бұл ауру бактериялар, вирустар немесе саңырауқұлақтар арқылы қозып, тыныс алуды қиындатып, қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін. Пневмонияның негізгі белгілеріне жөтел, қызу көтерілу, кеуде ауыруы және тыныс алудың қиындауы жатады. Дер кезінде диагноз қойылып, дұрыс ем жүргізілсе, пневмониядан жазылып шығуға болады. Антибиотиктер, антивирустық немесе саңырауқұлаққа қарсы дәрілер қолданылады. Пневмонияның алдын алу үшін вакцинация, дұрыс тамақтану, иммунитетті қолдау және суық тиюден сақтану маңызды рөл атқарады.

Әдебиеттер тізімі:

1. Гиппократ. Медицина негіздері. Б.з.д. V ғасыр.
2. Гален, К. Медициналық жазбалар. Б.з. II ғасыр.
3. Клебс, Э. Пневмонияның бактериялы себептері. Германия, 1875.
4. Пастер, Л., Стернберг, Дж. Пневмококк бактериясын анықтау. Париж, 1881.
5. Смит, Дж. Л., Браун, Э. Тыныс алу жүйесінің жұқпалы аурулары. Оксфорд университеті баспасы, 2005.
6. Davidson’s Principles and Practice of Medicine, 23rd edition, Elsevier, 2018.
7. Ким, А. Т., Төрегелді, Ж. М. Антибиотиктер және инфекциялық ауруларды емдеу. Алматы, 2019.

ISBN 978-601-08-0758-7

БІЛІМ БЕРУ ҮРДІСІНДЕГІ ДУАЛЬДЫ ОҚЫТУ ЖҮЙЕСІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Слямғазиева А. А., 3 курс, «Медбике ісінің қолданбалы бакалавры»
“Д Қалматаев атындағы мемлекеттік жоғары медицина колледжі” КМК ШЖҚ
Ғылыми жетекшісі Сәлімова И. Ф., педагог-модератор, МІН пәнінің оқытушысы

Аннотация: *Бүгінгі күннің болмысы, кәсіби білім жүйесі алдында еңбек нарығында бәсекеге қабілетті білікті мамандар даярлау, өз мамандықтарын жетік меңгерген, өз мамандығы бойынша тиімді жұмыс жасауға қабілетті, тұрақты кәсіби өсуге дайын, әлеуметтік және оңтайлы кадрларды даярлауды талап етеді. Сондықтан еліміздегі өндіріске қажетті мамандар әзірлеу деңгейін көтеру, әлеуметтік серіктестік және теория мен тәжірибенің үйлесімді болуы үшін дуалды білім беру жүйесін енгізу қажет.*

Дуальды оқыту жүйесі – теорияны өндіріспен ұштастыра оқыту технологиясы. Яғни, оқытудың теориялық бөлігі білім беру ұйымының базасында, ал практикалық бөлігі жұмыс орнында өтетін оқыту түрі.

Дуалды оқыту жүйесінің негізгі мақсаты – техникалық – кәсіптік оқу орындарының жұмыс беруші жеке сектордағы өндіріс, шаруашылық мекемелерімен серіктестік ретінде бірлесе отырып, нарық заманында бәсекелестікке төтеп бере алатын, жаңа инновациялық-технологиялық бағдарламаларды меңгеруге дайын, жұмысшы мамандар даярлау.

Дуальды оқыту жүйесі – алғаш рет Алманияда пайда болып, негізі қаланды. Мұнда студенттер уақытының үштен екі бөлігінде еңбек ете жүріп өндірістен қол үзбей оқиды, тек уақытының үшінші бөлігін теориялық оқуға, білімді ұйымдастыруға арнайды. Бұл жүйе әсіресе техникалық және кәсіптік білім беру салаларында кеңінен қолданылады.

Дуальды оқыту жүйесінің ең танымал үлгісі Германияда қалыптасқан. Германияның кәсіби білім беру жүйесінде студенттердің 70%-ы дуальды оқыту жүйесі арқылы білім алады. Дуальды жүйе бойынша жұмыс істейтін студенттердің шамамен 90%-ы оқуын аяқтаған соң жұмысқа орналасады.

Қазақстанда дуальды оқыту жүйесі 2010 жылдардан бастап енгізілді. 2022 жылғы мәліметтер бойынша, Қазақстанда дуальды білім беру бағдарламаларына 500-ден астам кәсіпорын және 140 білім беру мекемесі қатысуда. 2021 жылы осы

ISBN 978-601-08-0758-7

жүйемен оқыған студенттердің жұмысқа орналасу деңгейі 75%-дан асты. Швейцарияда 95%-дан жоғары.

Дуалды кәсіби білім берудің, білім саласында мамандар дайындаудағы маңызы, алатын орны ерекше. Қазіргі кезде әлемде оқыту жүйесінің бұл түрі– техникалық және кәсіптік мамандар даярлаудың ең тиімді жолдарының бірі болып табылады.

Бүгінгі таңда еңбек нарығында жоғары білікті мамандар тапшылығы ерекше орын алуда. Қалыптасқан жағдайдың негізгі себепшісі: білім беру үрдісін ұйымдастыру және жүйедегі мәселелер, яғни, жас маманның бойынан табылуға тиісті тәжірибелік дағдылардың болмауы, білім мен тәжірибені талап ететін нақты өндірістік жағдайлардан, теориялық білім берудің алшақтап кетуі болып табылады. Бұл жағдайда теория мен практиканың арасындағы алшақтықты жою мәселесімен жұмыс берушіге күресуге тура келеді, себебі білікті мамандармен қамтамасыз ету – бұл жетістікке қол жеткізудің кепілі. Осыған байланысты жас мамандардың оқу үрдісінде алған білімдерін жүзеге асыру жоспарланатын кәсіпорын қызметінің ерекшелігін ескере отырып, қосымша оқу, тәжірибеден өту, қайта даярлау қажеттілігі туындайды. Сондықтан қалыптасқан жағдайда білім беруді тек теориялық тұрғыдан ұйымдастыру жеткіліксіз, яғни жас маманның өндірістік машықтанудан толық кәсіптік деңгейге шығуына жағдай жасау өзекті мәселе.

Бүгінгі күннің болмысы, кәсіби білім жүйесі алдында еңбек нарығында бәсекеге қабілетті білікті мамандар даярлау, өз мамандықтарын жетік меңгерген, өз мамандығы бойынша тиімді жұмыс жасауға қабілетті, тұрақты кәсіби өсуге дайын, әлеуметтік және оңтайлы кадрларды даярлауды талап етеді. Осыған байланысты қойылған басты міндет - мемлекеттік құрылымдардың күшін біріктіру, жұмыс берушілер мен оқу орындарын облыстық кәсіпорындар мен өнеркәсіптерді білікті мамандармен қамтамасыз ету мәселесінде жұмылдыру. Бұл өзекті мәселені шешуде дуалды кәсіби білім беруді дамытудың маңызды екеніне назар аударуымыз қажет.

Дуалды жүйемен оқытудың тәжірибелік маңыздылығы:

Біріншіден, түлектердің жұмысқа орналасу көрсеткіші жоғары болады, себебі оқу барысында өндіріспен тығыз байланыста болған оқушы жұмыс берушінің айтқан талаптарын игеріп, меңгерген тәжірибесі бар маман болады.

Екіншіден, жақсы білімді, болашақ маман психологиялық жағынан жаңа ортаға бейімделген дайын маман болып шығады. Өндірісте өздігінен шешім қабылдай алады. Теория мен тәжірибені меңгеріп, бекітілген жұмысқа деген жауапкершілік сезімі жоғарылайды. Өндірісте болғандықтан ұжыммен жұмыс жүргізуге және өндірістегі жұмыстарды алып кетуге қабілетті.

ISBN 978-601-08-0758-7

Үшіншіден, «тәжірибеден теорияға» принципімен жұмыс жүреді, студент теориялық, яғни мәтінмен айтудан гөрі, өндірістегі жағдаяттарға сәйкес жұмыс жүргізеді. Теорияда қиындау келетін терминдер мен есептерді тәжірибе жүзінде шешеді.

Төртіншіден, студент тек теорияны ғана меңгермей, өндірістегі соңғы жаңалықтарды біліп, заманауи талаптарды меңгереді.

Дуальды оқытудың артықшылығы - ең алдымен жас мамандардың жұмысқа орналасуының жоғарғы пайзын көрсетеді. Өйткені олар жұмыс берушінің талаптарына толығымен жауап береді Дуалды білім беру процесі, ең алдымен жеке тұлғаға бағытталып, студенттің шығармашылық іскерлік сапаларын, коммуниактивтілігін, жұмысқа бейімділігін, рухани-адамгершілік мәдениетін және болашақ мамандардың сауаттылығын қалыптастырады. Дуалды білім беру жүйесі оқу үрдісінде кәсіптік техникалық колледждер базасында қалыптасып, жұмысшы мамандарды өндіріске бейімдеу қажет.

Осы мақсатта болашақ маман иелері өздері таңдаған мамандықтарды кәсіби тұрғыдан жан-жақты игеріп, қазіргі заманауи озық технологияны меңгеріп, әрі қарай дамытуы керек. Сондықтан еліміздегі өндіріске қажетті мамандар әзірлеу деңгейін көтеру, әлеуметтік серіктестік және теория мен тәжірибенің үйлесімді болуы үшін дуалды білім беру жүйесін енгізу қажет. Сондай-ақ бүгінгі таңда дуальды білім беруді жүзеге асырып келе жатқан мекемелерді ресурстық қамтамасыз ету де маңызды орын алады. Себебі, көптеген оқу орындарына қаржылық, ресурстық қолдаудың жеткіліксіз болуы теріс әсерін тигізіп, мүмкіндіктерден айырылуға, оқу жүйесінің сапасын тежеп, тоқтатуға мәжбүрлеуі мүмкін.

Оқу үрдісіне дуальды білім беру жүйесін сәтті енгізу көптеген мәселелерді шешуге мүмкіндік берді. Ол студенттердің қызығушылығы мен сұранысына қарай бағдарламалар, элективті (икемді) курстар әзірлеуге, мамандықты тереңірек және жетік түсінуге, өндіріске бейімдейтін біліктіліктің дамуына, еңбек дағдыларына, кәсіби білімге ие болып еңбек нарығында сұраныс деңгейінің жоғарылауына, бітірушілерді жұмысқа орналастыру мүмкіндігінің молайып, жұмыссыздықтың қысқаруына, сонымен қатар, білім беру мекемелерінің бәсекелестікке қабілеттілігін жоғарылатуға көмектеседі.

Осындай оқу орындарының бірі: “Абай облысы Семей қаласының Дүйсенбі Қалматаев атындағы мемлекеттік жоғарғы медициналық колледжі” бүгінгі таңда оқытудың дуальдық жүйесін қолданып, мемлекеттік тапсырманың қалыптасуында, өзекті мәселені шешуде, жалпы медицинаның замануи тұрғыда дамуына өзінің үлкен үлесін қосуда.

ISBN 978-601-08-0758-7

Абай облысы Денсаулық Сақтау басқармасының "Семей қаласының хосписі" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны Дүйсенбі Қалматаев атындағы мемлекеттік жоғарғы медициналық колледжінің клиникалық базасы болып табылады. Яғни, біздің студенттер осындай әлеуметтік серіктестермен теория мен тәжірбиені ұштастырып, өндірістік машықтану кезінде озат іс тәжірибелі мамандардан үйреніп, жаңа жабдықталған технологияны меңгереді және жұмыстар жасайды.

Хосписте - дамудың соңғы сатысындағы кез-келген ем қонбайтын созылмалы ауруларға, соның ішінде онкологиялық ауруларға шалдыққан науқастарға өмір сүру сапасын жақсартуға, ауырсынудың алдын алу және жеңілдетуге бағытталған іс-шаралар жүргізіледі. Сонымен қатар, ауруды және басқа да физикалық белгілерді ерте анықтау, мұқият бағалау, күтім көрсету жұмыстары, психоәлеуметтік және рухани қолдау көрсетіледі. Қысқаша айтқанда, хосписте- инкурабелді науқастарға паллиативті көмек көрсетіледі.

Яғни, студенттеріміз әртүрлі аурулары бар, психикалық бұзылыстары, ақыл-ес, сана деңгейіндегі күңгірттенуі кездесетін, көптеген қажеттіліктері бұзылған инкурабелді науқастармен, оның жақындарымен қарым-қатынас жасауды үйренеді. Науқасқа дұрым күтім көрсету, науқасты тамақтандыруды, ойылудың алдын алу мақсатында қалыптарды ауыстыруды, мейіргерлік этика және деонтолгияны дұрыс қолдануды іс жүзінде, тәжірибеде іске асырып, түрлі дағдыларды жетік меңгереді. Осы арқылы өздері таңдаған мамандықты кәсіби тұрғыдан жан-жақты игеріп, сұранысқа ие, сапалы білімі бар, теорияны тәжірибеге байланыстыра алатын, тиімді жұмыс жасауға қабілетті, тұрақты кәсіби өсуге дайын, кәсіби маманға айналады. Бұл студенттеріміздің болашақта жұмысқа орналасуы мүмкіндігінің айтарлықтай өсуіне де оң әсерін тигізетіні сөзсіз.

Дуальды оқыту жүйесі жайлы зерттеу жұмысы жүргізілді.

Зерттеу нысаны: “Абай облысы Семей қаласының Дүйсенбі Қалматаев атындағы мемлекеттік жоғарғы медициналық колледжі”

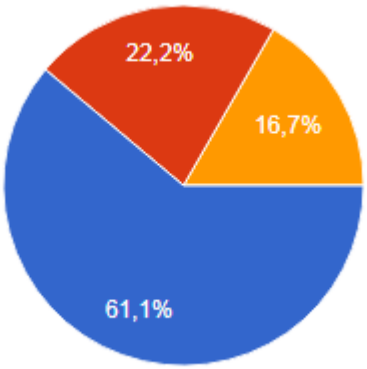
Респондент: 45 оқытушы

Зерттеу негізі: сауалнама жүргізу

Зерттеу мақсаты: “Абай облысы Семей қаласының Дүйсенбі Қалматаев атындағы мемлекеттік жоғарғы медициналық колледжінің” оқытушылары арасындағы дуальды оқыту жүйесі жайлы хабардарлығын анықтау, оқытудың бұл түріне байланысты ойларын білу, студенттердің біліміне және жалпы колледждің оқыту жүйесінің сапасына, жұмысына тигізетін әсері туралы сұрастыру; дуальды оқыту жүйесінің артықшылықтары, енгізілуіндегі, іске асырылудағы кездесетін қиындықтар немесе кедергілер жайлы ақпарат алу.

Жоғарыда айтылған зерттеу нәтижелері төмендегідей:

ISBN 978-601-08-0758-7



Зерттеу нәтижелері бойынша: 61,1% оқытушы дуальды оқыту жүйесі жайлы жалпы терең түсінігі бар және хабардар;

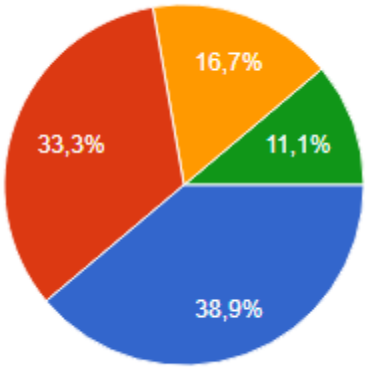
22,2% жартылай ғана біледі, түсінігі бар, бірақ толық емес;

ал 16,7% оқытушылар оқыту жүйесінің бұл түрімен таныс емес.

38,9% оқытушының ойы бойынша дуальды оқыту жүйесінің басты артықшылығы - студенттердің еңбек нарығына дайындығының артуы.

33,3% оқытушылардың ойы бойынша дуальды оқыту жүйесінің негізгі артықшылығы – практикалық дағдыларды тез игеру

16,7% оқытушылардың ойы бойынша дуальды оқыту жүйесінің негізгі артықшылығы - түлектердің жұмысқа орналасу мүмкіндіктерінің көбеюі.



11,1% оқытушылардың ойы бойынша дуальды оқыту жүйесінің негізгі артықшылығы – теориялық білімді практикамен бекіту.

ISBN 978-601-08-0758-7

Зерттеу жұмысы сауалнамасының қорытындысы бойынша “Абай облысы Семей қаласының Дүйсенбі Қалматаев атындағы мемлекеттік жоғарғы медициналық колледжі” оқытушыларының дуальды оқыту жүйесі жайлы ойы оң, хабардарлығы жоғары деп есептей аламыз.

Зерттеу жұмысы сауалнамасының қорытындысы бойынша “Абай облысы Семей қаласының Дүйсенбі Қалматаев атындағы мемлекеттік жоғарғы медициналық колледжі” оқытушыларының дуальды оқыту жүйесі жайлы ойы оң, хабардарлығы жоғары деуге болады.

Қорытындылар:

Қорытындылай келе, егер дуальдық жүйемен оқыту әдістемесі жетілдіріліп, заңды түрде күшіне енгізілсе, өте жақсы нәтиже береді деп есептеймін:

1. Дуалдық жүйе - оқытудың дәстүрлі түрлері мен әдістерінің негізгі кемшілігін, яғни теория мен тәжірибенің арасындағы алшақтықты жояды;
2. Техникалық және кәсіптік білім беру мекемелері бітіруші түлектерін кәсіпорындарға жұмысқа орналастыру үшін ынтымақтасады;
3. Жұмыс берушімен тығыз байланыста жұмыс жасайтын оқу орны, болашақ мамандарға қойылатын талаптарды ескеріп отырады;
4. Әлеуметтік серіктестіктер өндіріс талабына сай, білім алушыға қойылатын біліктілік талаптарды дайындауға, кәсіптік стандарттарды, дуальдық оқыту жүйесі бойынша өзгеретін модульдық бағдарламаны, оқу бағдарламасын дайындауға және оқытушыларды тағылымдамадан өткізуге қатысады;
5. Әлеуметтік серіктестіктер мамандар дайындау бойынша мемлекеттік тапсырманы қалыптастыруға қатысады;
6. Білім алушы дуальдық жүйемен оқыту нәтижесінде белгілі құзіреттерді меңгерген кәсіби дағдыға ие болады;
7. Оқу орнын бітіруші жұмысқа орналасу мүмкіндігіне ие болады.

Әдебиеттер тізімі:

1. Қазақстан Республикасының білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған бағдарламасы
2.Қазақстан республикасының «Білім туралы»Заңы
3.«.ТжКБ жүйесіне халықаралық тәжірибелерге негізделген оқытудың дуалды жүйесін енгізу перспективасы»
4. Қазақстан – 2050» стратегиясы –қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауы
5. Дуальды оқытуды ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 21 қаңтардағы № 50 бұйрығы.

ISBN 978-601-08-0758-7

ЭКГ. ТЕХНИКА СНЯТИЯ ЭКГ. ПРОСТОЕ ПОНИМАНИЕ ЭКГ

Сухорукова Юлия
Шахова Екатерина
студенты специальности «Лечебное дело», 4 курс
КГП на ПХВ «Усть-Каменогорский высший медицинский колледж»
Научный руководитель: Папышева Гульжан Кайкеновна
преподаватель специальных дисциплин, магистр, «педагог-эксперт»

Аннотация: *предоставить основные знания о технике снятия и простом понимании электрокардиографии (ЭКГ*)

Актуальность: Изучение и понимание электрокардиографии (ЭКГ) остается важным в медицинской практике, так как она является основным методом диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Умение проводить и анализировать ЭКГ помогает врачам быстро и точно выявлять различные патологии сердца, что необходимо для правильного назначения лечения и мониторинга состояния пациентов.

Задачи:

- Узнать что такое ЭКГ
- Научится правильно выполнять постановку ЭКГ
- Узнать при каких заболеваниях или жалобах необходима постановка ЭКГ
- Узнать что можно увидеть на ЭКГ
- Научится правильно читать ЭКГ
- Понять как определить Инфаркт Миокарда на ЭКГ

ЭКГ

Электрокардиография (ЭКГ) – метод регистрации электрических потенциалов сердца, позволяющий детально патологию камер сердца, проводить мониторинг заболевания, оценить эффективность проводимого лечения.

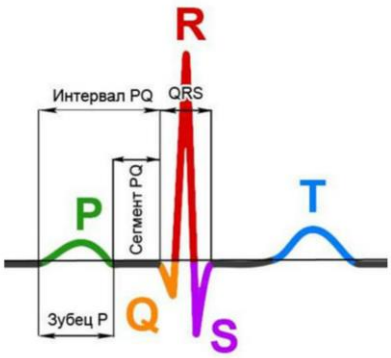


Рисунок 1 Зубцы ЭКГ

Электрокардиограмма поможет выявить такие заболевания и состояния, как:

- аритмии и блокады
- тахикардии и брадикардии;
- гипертрофия;
- дилатация предсердий (расширение полости предсердия);
- наличие или отсутствие ишемических областей;
- очаговые изменения сердца;

Техника снятия ЭКГ: алгоритм

Непосредственно перед плановой регистрацией ЭКГ пациент не должен принимать пищу, курить, употреблять возбуждающие напитки (чай, кофе, «энергетики»), нагружать организм физически.

ISBN 978-601-08-0758-7

Фиксируем в необходимой документации персональные данные пациента, номер истории болезни, дату и время снятия ЭКГ.

Укладываем пациента на кушетку в положение лежа на спине. Обезжириваем те участки кожи, куда будем накладывать электроды — протираем их салфеткой, смоченной в изотоническом растворе хлорида натрия (0,9%). Накладываем электроды: 4 пластинчатых — на нижние трети внутренней поверхности голеней и предплечий, а на грудь — грудные электроды, снабженные присосками-грушами. При одноканальной записи используют 1 грудной электрод, при многоканальной — несколько. К каждому электроду присоединяем провода определенного цвета, идущие от электрокардиографа.

Простое понимание ЭКГ. Его основные моменты и составляющие.

ЭКГ – это основной способ диагностики заболеваний сердца разной степени тяжести, начиная от аритмии заканчивая ИМ.

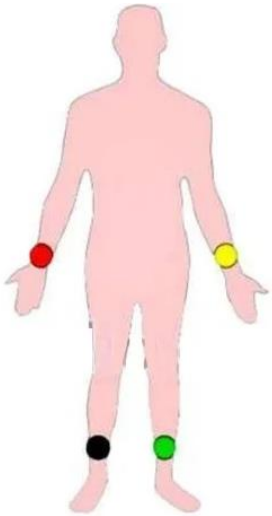


Рисунок 2 Положение электродов

Снятие ЭКГ производится при помощи электрокардиографа. Лучше всего читать ЭКГ сверху вниз, обращая внимание на изолинию и линии ЭКГ лежащие на ней для того, чтобы определить наличие кардиопатологий.

В качестве дополнительной информации мы можем предложить более легкий способ того, как запомнить расположение электродов.

Для наложения электродов на конечности была придумана легкая считалка, о которой, к сожалению, знают не все:

«Каждая Женщина Злее Черта» - простая, но очень эффективная считалка.

Счет начинается с правой руки и заканчивается правой ногой. При этом первая буква каждого слова указывает на цвет накладываемого электрода.

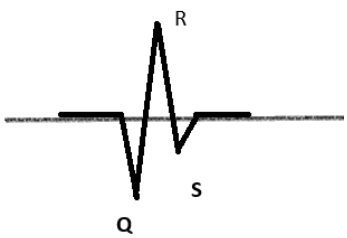
На диаграммной бумаге мы можем увидеть такие данные как: данные пациента, дата записи, скорость записи ЭКГ и самих показаний кардиографа.

Показания кардиографа принято делить на зубцы, сегменты, комплексы и интервалы. Так же выделяют изолинию – линию, на которой располагаются все составляющее. Сама бумага состоит из ячеек, которые делятся еще на 25 квадратиков. Эти ячейки необходимы для подсчета ЧСС и определения ритма работы сердца.

Теперь, зная эти основные моменты мы можем судить о патологии и как она будет выглядеть на ЭКГ.

Например, разберем ЭКГ при Инфаркте Миокарда.

Инфаркт Миокарда - заболевание, обусловленное некрозом сердечной мышцы из-за прекращения кровотока по крупной артерии сердца.



Инфаркт Миокарда на ЭКГ можно определить по 3-м основным отклонениям:

1. Появление патологического зубца Q

ISBN 978-601-08-0758-7

При нормальной работе сердца зубец Q не должен превышать ¼ от зубца R, в то время как при патологии он намного превышает это значение.

Из увеличения зубца Q следует начало некротического процесса.

Рисунок 3

2. Уменьшение амплитуды зубца R

Уменьшение зубца R будет свидетельствовать о нарушении сокращения желудочков сердца

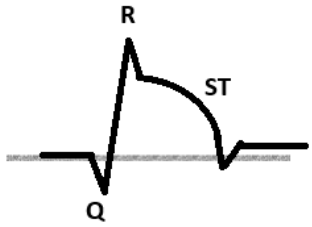
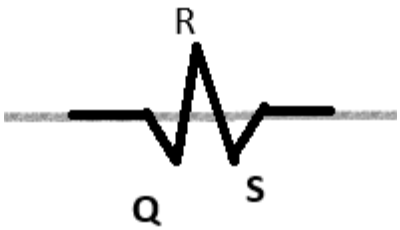


Рисунок 4



3. Элевация сегмента ST

Данное волнообразное изменение в зубцах QRS обычно называют «Кошачьей спинкой». Это изменение является признаком гипертрофии левого желудочка сердца.

Рисунок 5

Результат:

1. Описана техника снятия ЭКГ, включая подготовку пациента, размещение электродов и проведение процедуры.
2. Представлено простое понимание ЭКГ, включая его цель, основные компоненты и значение различных волн.
3. Обоснована актуальность изучения ЭКГ в медицинской практике, как ключевого метода диагностики сердечно-сосудистых заболеваний.

Выводы: понимание техники снятия ЭКГ и основных аспектов интерпретации его результатов является важным для медицинских специалистов, так как это позволяет быстро и точно диагностировать сердечно-сосудистые заболевания у пациентов.

Список литературы:

1. https://www.hospitalfts.ru
2. https://myclinic.ru/blog/elektrokardiografiya-ekg/
3. https://unclinic.ru/osnovnye-jelementy-jekg-chto-soderzhit-grafik-kardiogrammy/
4. https://mtdiagnostica.ru/readpage_technika-sniatiia-iekg.html
5. https://medsi.ru

ISBN 978-601-08-0758-7

ПСИХОЭМОЦИОНАЛДЫҚ ЖАҒДАЙ ЖӘНЕ ТЕРІ АУРУЛАРЫ

Сүйеш Жанайым, 4 курс «Мейіргер ісі» мамандығы
ҚДСБ ШЖҚ "Жоғары медициналық колледжі" КМК
Ғылыми жетекші: Кисанова Н.К. Денсаулық сақтау ісінің магистрі,
Нұрберген Д.Н. №3 ЦӘК «Клиникалық пәндер» оқытушысы

Аннотация: *бұл мақалада психоэмоционалдық жағдай мен тері аурулары арасындағы байланысты зерттеу қарастырылған. Психологиялық күйзеліс, стресс және эмоционалдық бұзылулар тері ауруларының, әсіресе псориаз, экзема, акне және дерматиттің пайда болуына және асқынуына ықпал етеді. Психоэмоционалдық жағдайды жақсарту әдістері, мысалы, психотерапия, дене белсенділігі, медитация және дұрыс тамақтану тері денсаулығын қолдауда маңызды рөл атқарады.*

Зерттеу өзектілігі: психоэмоционалдық жағдай мен тері аурулары арасындағы байланыс қазіргі медицина мен психологияда маңызды зерттеу тақырыбы болып табылады. Адамдардың өмір сүру сапасын төмендететін тері ауруларының санының артуы, сонымен қатар стресстің және психологиялық бұзылыстардың кең таралуы осы мәселелерді зерттеудің қажеттілігін туындатады.

Зерттеу мақсаты: психоэмоционалдық жағдайлардың зерттеу тері ауруларына әсерін анықтау, жүйелі мәліметтер қорын пайдалану.

Зерттеу әдістері: ғылыми әдебиеттерге шолу жасау, саралау.

Психоэмоционалдық жағдайдың тері ауруларына әсері стресс тері ауруларының дамуына әсер ететін негізгі факторлардың бірі. Ол иммундық жүйені әлсіретіп, теріде қабыну процестерін қоздыруы мүмкін. Стресс кезінде организмде кортизол гормонының деңгейі артады, бұл терінің күйіне теріс әсер етеді [1]. Депрессия тері ауруларының өршуіне ықпал етеді. Психологиялық ауыртпалық терінің табиғи қорғаныш қабатын бұзып, экзема немесе дерматит сияқты аурулардың асқынуына себеп болуы мүмкін. Үрейлі жағдайлар жағдайлар терінің сезімталдығын арттырады, бұл қышу, қызару және қабыну сияқты белгілердің пайда болуына әкеледі. Тревогаға ұшыраған науқастарда тері ауруларының симптомдары жиі күшейеді. Эмоционалдық күйзелістер терінің реакциясын өзгертіп, псориаз немесе акне сияқты аурулардың өршуіне себеп болуы мүмкін. Науқастар эмоционалдық қысым кезінде тері проблемаларын жиі сезінеді. Кейбір тері аурулары (мысалы, псориаз) психосоматикалық сипатта болады, яғни эмоционалдық күй мен физикалық симптомдар арасында тығыз байланыс бар. Стресс немесе психологиялық күйзеліс кезінде тері ауруларының белгілері нашарлауы мүмкін [2].

Психоэмоционалдық жағдай мен тері ауруларын зерттеуде кездесетін қиындықтар- көпфакторлы себептерге байланысты, тері ауруларының дамуы әртүрлі факторларға, соның ішінде генетикалық, экологиялық және психоэмоционалдық факторларға тәуелді. Психоэмоционалдық жағдайды тері ауруларының тек бір себебі ретінде қарастыру қиын [3].

ISBN 978-601-08-0758-7

Стандартталмаған өлшемдер - психоэмоционалдық жағдайды бағалау үшін қолданылатын сауалнамалар мен тестілердің стандарттары әртүрлі болуы мүмкін, бұл зерттеу нәтижелерінің салыстырмалылығын қиындатады.

Науқастардың қатысуы - науқастар психоэмоционалдық мәселелерін ашудан қашып, зерттеуге қатысудан бас тартуы мүмкін. Бұл психологиялық күйді объективті бағалауға кедергі келтіреді.

Бақылау әдістерінің шектеулілігі - психоэмоционалдық күйді бақылау және оның динамикасын зерттеу үшін шектеулі құралдар мен әдістер болуы мүмкін. Бұл зерттеу нәтижелерінің дәлдігіне әсер етеді [4].

Эмоционалдық тұрақсыздық - психоэмоционалдық жағдайдың өзгеруі зерттеу барысында уақыт бойынша әртүрлі болуы мүмкін, бұл зерттеудің нәтижелерін интерпретациялауды қиындатады [5].

Науқастардың әртүрлілігі - науқастардың жастары, жыныстары, әлеуметтік статустары мен аурулардың ауырлық дәрежесі зерттеу нәтижелеріне әсер етуі мүмкін. Бұл әртүрлілікті ескере отырып, деректерді талдау қиын болады. Клиникалық тәжірибемен байланыс - психоэмоционалдық жағдай мен тері аурулары арасындағы байланысты клиникалық практикада ескеру және психологиялық қолдау көрсету механизмдерін енгізу үшін жүйелік көзқарас қажет [6].

Тері ауруларының себептерін тек физикалық факторлармен шектемей, психоэмоционалдық жағдайды ескеру науқастарға кешенді емдеу тәсілдерін ұсынуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, психологиялық күйзелістердің тері ауруларының өршуіне әсер етуі адамдардың әлеуметтік және экономикалық өміріне теріс ықпал етеді, бұл мәселені шешу әлеуметтік денсаулық сақтау жүйесінің тиімділігін арттыруға ықпал етеді. Зерттеу нәтижелері дәрігерлер мен психотерапевттерге науқастарды емдеуде интегративті тәсілдерді қолдануға, сондай-ақ тері ауруларын психоэмоционалдық күймен байланыстыра отырып, жаңа емдеу стратегияларын әзірлеуге көмектеседі. Осы себепті, психоэмоционалдық жағдай мен тері ауруларының арасындағы байланысқа тереңірек зерттеу жүргізу өзекті әрі маңызды болып табылады [7].

Қорытынды: психоэмоционалдық жағдай мен тері аурулары арасындағы байланыс зерттеуде маңызды аспект болып табылады. Психологиялық күй, стресстің деңгейі, депрессия және тревога тері ауруларының пайда болуына және асқынуына әсер етеді. Зерттеулер көрсеткендей, эмоционалдық тұрақсыздық терінің табиғи қорғаныш механизмдерін әлсіретеді, бұл тері қабынулары мен басқа да проблемалардың өршуіне себеп болады. Психоэмоционалдық жағдайды жақсарту арқылы науқастардың тері ауруларын емдеу тиімділігін арттыруға болады. Сондықтан, науқастарға психологиялық қолдау көрсету, стресс-менеджмент әдістерін енгізу және психотерапияны қолдану тері ауруларын басқаруда маңызды рөл атқарады. Алайда, зерттеу барысында кездесетін қиындықтар, мысалы, көпфакторлы себептер мен науқастардың психоэмоционалдық күйінің өзгергіштігі, бұл байланысты терең түсінуге кедергі келтіруі мүмкін. Осы мәселелерді шешу үшін интеграцияланған зерттеу тәсілдері

ISBN 978-601-08-0758-7

қажет. Жалпы алғанда, психоэмоционалдық жағдай мен тері аурулары арасындағы байланысқа назар аудару клиникалық практикада науқастардың әл-ауқатын жақсартуға, емдеу стратегияларын тиімді етуге және денсаулық сақтау жүйесін дамытуға ықпал етеді.

Әдебиеттер тізімі:

1. Gonzalez, M. A., et al. (2018). "Psychological Factors in Dermatology: A Review." Journal of Dermatological Treatment.

2. Dalgard, F. J., et al. (2006). "The Relationship between Dermatological Disorders and Mental Health: A Review." Acta Dermato-Venereologica.

3. Chren, M. M., et al. (2005). "The Impact of Skin Disease on Quality of Life." Archives of Dermatology.

4. Lindsay, A. C., et al. (2011). "Psychosocial Impact of Skin Disease." Dermatologic Clinics.

5. Koo, J. Y., et al. (2001). "Psychosocial Issues in Dermatology: An Overview." International Journal of Dermatology.

6. Katz, J., et al. (2002). "The Psychosocial Impact of Acne." Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology.

7. Gulkesen, K. H., et al. (2019). "Mental Health and Skin Disorders: A Comprehensive Review." Psychodermatology.

ISBN 978-601-08-0758-7

HIGH-FLOW CEREBRAL BYPASS: A REVOLUTION IN MINIMALLY INVASIVE TREATMENT OF INTRACRANIAL ANEURYSMS

Authors:Tlektes Dariya/Saleem Abdulrauf
Zoya Galymovna Murzagulova Higher Medical College

Scientific Supervisor: Saleem Abdulrauf, Clinical Professor of Neurosurgery at George Washington University and Chief Neurosurgeon at the Abdulrauf Neurosurgical Institute

Current Issues in Medical Research

Tlektes D.B., 2nd year student , Nursing
Zoya Galymovna Murzagulova Higher Medical College
Scientific Supervisor: Saleem Abdulrauf
Position: Clinical Professor of Neurosurgery at George Washington University and Chief Neurosurgeon at the Abdulrauf Neurosurgical Institute.

Abstract: *This paper analyzes the latest method for treating intracranial aneurysms — high-flow cerebral bypass (HFB). This is an innovative and minimally invasive technique that reduces the risk of aneurysm rupture and improves blood supply to the brain. The article reviews the latest advances in this field and presents research results confirming the effectiveness of HFB in treating complex cases, as well as discusses potential risks and complications. Particular attention is paid to statistics from Kazakhstan, where this method is being actively implemented.Abstract:*

This paper analyzes the latest method for treating intracranial aneurysms — high-flow cerebral bypass (HFB). This is an innovative and minimally invasive technique that reduces the risk of aneurysm rupture and improves blood supply to the brain. The article reviews the latest advances in this field and presents research results confirming the effectiveness of HFB in treating complex cases, as well as discusses potential risks and complications. Particular attention is paid to statistics from Kazakhstan, where this method is being actively implemented.

Introduction:

An intracranial aneurysm is a pathological condition in which a weakened area of the artery wall in the brain expands and fills with blood. This condition can lead to a rupture of the vessel and a hemorrhage in the brain, which causes serious consequences, including death. Every year, thousands of patients face this threat, especially among middle-aged and elderly people. In Kazakhstan, according to the Ministry of Health, from 3 to 5% of the adult population have a risk of developing a brain aneurysm, which is due to age, heredity and other factors.

In recent years, methods for treating aneurysms have been actively developing. Previously, the main approaches were open surgical interventions and endovascular

ISBN 978-601-08-0758-7

procedures, such as clipping or coils. However, these methods were accompanied by a risk of complications, as well as a long recovery of the patient after surgery. In response to these challenges, a new approach was introduced in global medical practice - high-flow brain shunting, which minimizes trauma and increases patient survival.

Theoretical basis of the method:

High-flow bypass is a surgical procedure aimed at creating a bypass for blood in cases where a vessel is affected by an aneurysm or has other pathological changes. In this case, the patient's vessels (for example, the radial or femoral artery) are used, which are moved into the skull to provide blood supply to the affected area. The main feature of the method is the high throughput of the created shunt, which allows for significant improvement of cerebral blood flow without risk to the patient.

High-flow bypass differs from traditional treatment methods in that it minimizes the need for direct contact with the aneurysm itself, which reduces the risk of its rupture during surgery. This method is especially effective in the treatment of giant aneurysms or in cases where other methods have proven ineffective.

Modern achievements and statistics:

Recent studies conducted in Kazakhstan and other countries confirm the high efficiency of the HFS method. In particular, according to the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan, the number of successful brain bypass surgeries has increased by 35% over the past five years, and the number of complications has decreased by 15%.

In one of the largest hospitals in Almaty, specializing in neurosurgery, more than 150 surgeries were performed using the HFS method in 2023. Of these, 87% of cases were successful, and patients recovered within 2-4 weeks. The remaining 13% of cases had minimal complications, such as short-term ischemia, which was eliminated with medication. In comparison, with traditional treatment methods, the risk of complications was significantly higher - about 30%.

The data also show that high-flow bypass is becoming the preferred treatment for patients with recurrent aneurysms, due to its effectiveness in preventing relapses. In the United States and European countries, the procedure is also gaining popularity, especially in clinics specializing in complex neurosurgical interventions.

Comparison of treatment methods:

The table below provides comparative data on various methods of treating brain aneurysms based on studies conducted in Kazakhstan.

Treatment Method	Success Rate (%)	Complications (%)	Recovery Time (%)
Aneurysm Clipping	75	25	4-6

ISBN 978-601-08-0758-7

Endovascular Embolization	80	20	3-5
High Flow Bypass	87	13	2-4

These data indicate that VSM shows better results compared to traditional methods, especially in the case of complex and giant aneurysms.

Technical aspects of HFS

The high-flow bypass procedure requires a highly skilled surgeon and the use of modern equipment. The operation lasts from 4 to 6 hours, depending on the complexity of the case. Before the operation, the patient undergoes thorough preparation, including angiography and MRI, which allows for the precise location of the aneurysm and planning of the procedure. During the operation, the surgeon creates a new vascular pathway, connecting it to the arteries of the brain to bypass the affected area.

Complications and risks

Like any surgical operation, high-flow bypass surgery is associated with a number of risks, despite its minimal invasiveness. The main complications are thrombosis and ischemia. However, according to clinics in Almaty and Nur-Sultan, such complications occur in no more than 10-15% of cases and are usually corrected in the early postoperative period.

In addition, patients over 60 years of age with concomitant cardiovascular diseases are at higher risk of complications. However, thanks to the latest protocols for postoperative monitoring, most complications can be avoided.

Research results and recommendations

Based on the analysis, it can be concluded that high-flow bypass surgery is a promising direction in neurosurgery. The results show that in Kazakhstan this method has become an effective alternative to traditional approaches, especially for patients with a high risk of aneurysm rupture.

It is recommended to continue the implementation of high-flow bypass surgery in regional centers of Kazakhstan in order to increase the availability of highly qualified care for patients with aneurysms. To achieve this, it is necessary to provide training for young specialists and purchase modern equipment for performing surgeries.

Conclusion

High-flow brain shunting is a significant achievement in the field of neurosurgery, which helps to increase the survival of patients with intracranial aneurysms. In Kazakhstan, this method has already demonstrated high efficiency, and its further development and implementation can significantly improve the quality of medical care. The conducted studies emphasize the need for further study of methods for improving the quality of VSM and reducing complications for wider clinical practice.

ISBN 978-601-08-0758-7

List of references

1. Cohen-Gadol, A. (2024). *Cerebral Bypass Surgery*. Retrieved from www.aaroncohen-gadol.com.

2. Tleuzhanova, A. et al. (2023). *Outcomes of High-flow Bypass in Intracranial Aneurysms: A Study in Kazakhstan*. Neurosurgical Journal, 15(4), 123-135.

3. Kazakh Health Committee Report (2022). *Neurosurgical Advances in Intracranial Aneurysm Treatment*. Almaty: Ministry of Health.

ISBN 978-601-08-0758-7

ҚУАТ КӨЗІ МЕ, ҚАУІП ПЕ?

Турсынова Аружан Жанатқызы, 3 курс "Мейірбике ісі" мамандығы
"Д.Қалматаев атындағы мемлекеттік жоғарғы медицина колледжі "КМК ШЖҚ
Ғылыми жетекші: Қалидолда Арай Мұқитқанқызы

***Аннотация**: Жастар арасында энергетикалық сусындарды тұтыну жылдан жылға артып келеді. Оқу, жұмыс, сессия тапсыру және тіпті демалыс кезінде де энергетикалық сусындарсыз елестету мүмкін болмай барады. Зерттеу нәтижесінде біз студенттер тұтынатын энергетикалық сусындардың құрамын және көптеген ауруларға себеп екеніне көз жеткіздік, сауалнама арқылы студенттер арасында энергетик сусындарды қаншалықты жиі қолданатынын, оның әсерін анықтадық.*

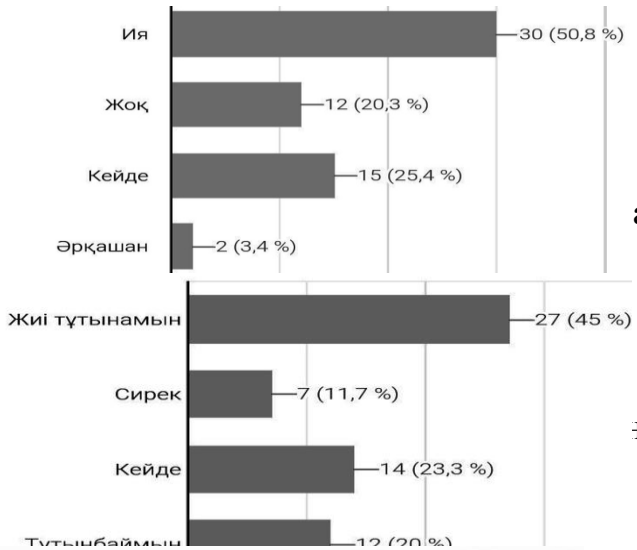
Кіріспе: Біздің өміріміздің қарқыны жыл сайын тездеп келеді. Күнделікті жоспарланған істердің барлығына үлгеру үшін кейде артық уақыт қажет болатыны белгілі. Демалыс пен ұйқы екінші орынға қойылып, студенттердің көбі энергетикалық сусындарды тұтынады.

Бүкіл әлем бойынша көптеген ауруларды туындататын себептердің бірі болған - энергетикалық сусындарды жастар арасында шамадан тыс тұтыну денсаулыққа орасан зор кері әсерін тигізіп, өлім-жітімге дейін әкелетінін ескерту және оның алдын алу мақсатында зерттеу жүргізілді.

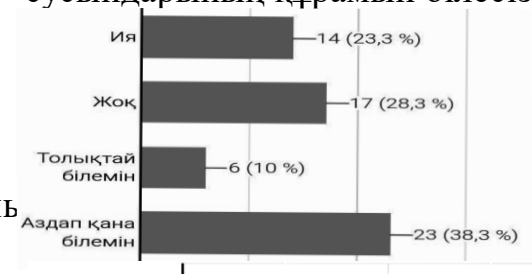
№ 1 зерттеу Сауалнама

Энергетикалық сусындардың қаншалықты сұранысқа ие екенін және олардың ағзаға әсерін анықтау үшін студенттер арасында сауалнама жүргіздік. Оған 3-4 курс студенттерінен тұратын 60 қатысушы қатысты. Нәтижелері бағаланды.

1. Сіз энергетик сусындарын тұтынасыз ба?



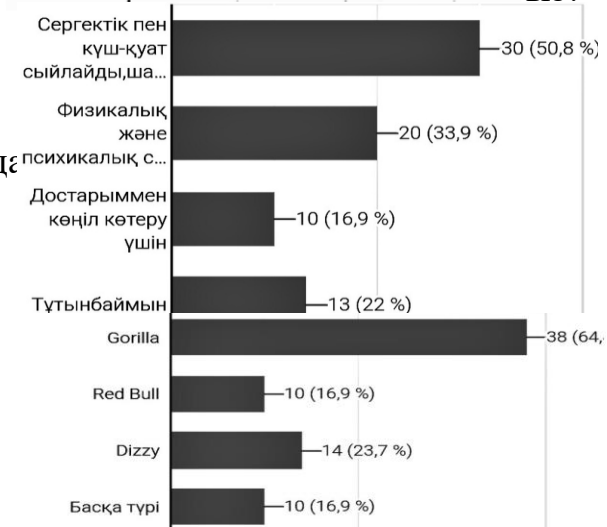
2. Сіз энергетик сусындарының құрамын білесіз бе?

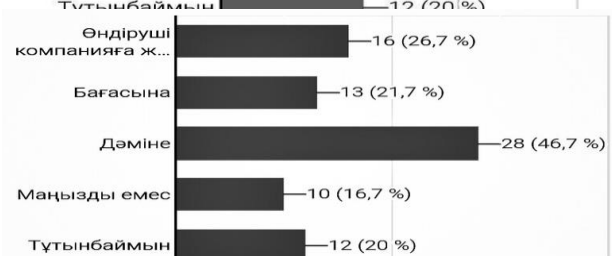


аншаль стен

ыз?

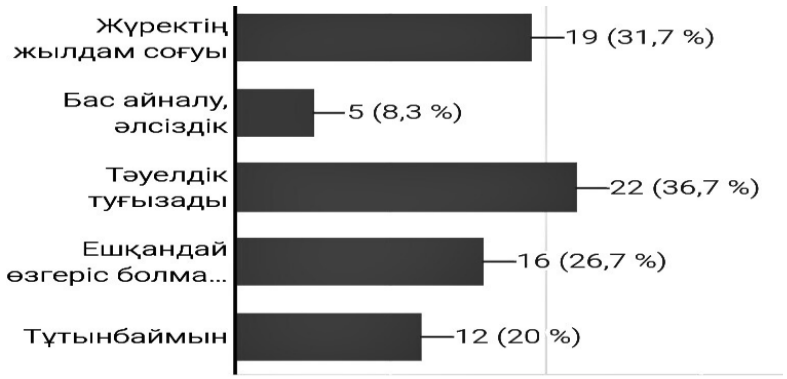
ңдағанда





ISBN 978-601-08-0758-7

7. Энергетик сусындары сізге қалай әсер етеді?



Қорытынды:

Зерттеу нәтижесінде студенттердің 79,6% энергетик сусындарын тұтынады, ал 20,3% мүлдем тұтынбайды екен. 36,7%-ында тәуелділік туғызатыны және 31,7% жүректің жылдам соғуына әкеп соқтыратыны белгілі болды. Бұл деген жастарды энергетикалық сусынсыз елестету мүмкін емес дегеннің дәлелі. Барлық аурулардың жасарып кеткенінің бірден бір себебі де осы.

№2 Gorilla-мен зерттеу

Екі студентке шырын мен Gorilla беру арқылы артериялық қан қысымына, қандағы глюкоза мөлшеріне, жүрек соғу жиілігіне әсері зерттелді. Ашқарында екі студенттің тыныс алу жиілігі, пульсі, артериялық қан қысымы, қандағы глюкоза мөлшері анықталды.

Бірінші студентте: ТАЖ – 16 рет/мин, Пульс - 75 рет/мин, АҚҚ -120/80 мм.сын.бағ., глюкоза - 5,1 ммоль/л.

Екінші студентте: ТАЖ – 19 рет/мин, Пульс- 77 рет/мин, АҚҚ -110/70 мм.сын.бағ., глюкоза - 4,8 ммоль/л.

30 мин кейін барлық көрсеткіш бойынша өлшедік. Нәтижесінде:

Шырын ішкен студентте: ТАЖ – 16 рет/мин, Пульс- 75 рет/мин, АҚҚ - 120/80мм.сын.бағ., глюкоза-5,4 ммоль/л.

Gorilla ішкен студентте: ТАЖ – 19 рет/мин, Пульс- 84 рет/мин, АҚҚ - 130/80 мм.сын.бағ., глюкоза -7,1 ммоль/л. Әлсіздік, іші батып ауырып, қыжылдау, бас айналу сияқты жанама әсерлері болды.

Қорытынды: Ашқарында Gorilla ішкен студенттің ағзасында өзгерістер болды және жанама әсерлер байқалды. Мысал ретінде ашқарында 3 жыл бойы Gorilla ішкен Отандық актер қазір қатерлі ісік ауруымен күресіп жатыр.

№ 3 зерттеу Сусын сатылымы

2024 жылы 8 шілдеде № 116-VIII бұйрығы бойынша 21 жасқа толмаған жастарға энергетикалық сусындар сатып алуға салынған тыйымның әлі өз күшіне толық еңбегенін білу мақсатында 14 жасар жасөспірімді 10 дүкенге жібердік. Нәтижесінде 7 дүкен энергетик сусынын сатылымға берді. Осылайша салынған тыйымның әлі күшіне еңбегеніне көзімізді жеткіздік.

Қорытынды: Осының салдарынан қазіргі таңда көптеген жастар емін - еркін энергетик сусындарын тұтынуда. Осыған байланысты өзімнің ұсынысымызды айтқымыз келеді. Зерттей келе, Литва, Норвегия, Латвия,

ISBN 978-601-08-0758-7

Исландия мемлекеттерінде энергетикалық сусындарын артериялық қан қысымы төмен түсіп кеткен жағдайда ғана дәріханаларда дәрігердің қатаң тағайындауымен сатылады. Біздің мемлекетте де осыны қарастырса екен дейміз.

Энергетикалық сусын (ЭС) – бұл газдалған немесе сәл газдалған, алкогольсіз немесе әлсіз алкогольді сусын, құрамында сергектік пен күш беретін заттар бар.Энергетик сусындар 14 түрлі аурудың бастамасы.

1. Жүрек-қан тамырлары аурулары. Гипертония (жоғары қан қысымы): Энергетикалық сусындар құрамындағы кофеин мен басқа стимуляторлар қан тамырларының өткізгіштігін арттырып, қан қысымын көтеріп, жүрек соғу жиілігін арттырады. Ол ары қарай гипертониялық кризге әкеледі. Жүрек ырғағының бұзылуы: Шамадан тыс кофеин жүрек соғысын жиілетеді немесе аритмияға себеп болады. Энергетикалық сусындар қан қысымын жоғарылатып, миға қан құйылу, соңы инсультке әкеледі.

2. Қант диабеті. Энергетикалық сусындардағы жоғары қант мөлшері инсулинге төзімділікті дамытып, 2- типті қант диабетінің дамуын туғызады.

3. Семіздік. Қант пен калория мөлшері артық салмақ жинауға және семіздікке әкеледі. Семіздік жүрек аурулары, қант диабеті және басқа да созылмалы аурулардың дамуына себепші болады.

4. Ұйқысыздық. Құрамындағы кофеин жүйке жүйесін шамадан тыс ынталандырып, ұйқының бұзылуына әкеледі. Бұл ұзақ мерзімде созылмалы ұйқысыздықты тудырып, психикалық және физикалық денсаулыққа кері әсер етеді.

5. Асқазанның қышқылдығы мен гастрит. Кофеин асқазан қышқылының мөлшерін арттырып, гастрит және асқазан жарасы сияқты асқазан-ішек ауруларын тудырады, сусындар асқазанның шырышты қабатын тітіркендіріп, асқазанның қабынуын күшейтеді.

6. Бүйрек аурулары. Жоғары қант пен басқа қоспалар бүйрекке салмақ түсіріп, созылмалы бүйрек ауруларының дамуына әкеледі.

7. Психикалық денсаулыққа қатысты мәселелер. Шамадан тыс кофеин тұтыну жүйке жүйесін шамадан тыс белсенділендіріп, мазасыздықты, үрей шабуылдарын және көңіл-күйдің тұрақсыздығына ықпал етеді.

8. Тіс эмалының бұзылуы. Құрамындағы қант пен қышқылдар тіс эмалінің бұзылуына әкеледі. Бұл тіс жегісінің дамуына және тістің сезімталдығының артуына себеп болады.

9. Бауырдың улануы. Стимуляторлар мен басқа да химиялық қоспалар бауырдың зақымдануына және бауыр жеткіліксіздігін тудырады.

10. Дегидратация. Кофеиннің диуретикалық әсері денеден артық сұйықтықты шығарып, дегидратацияға әкелуі мүмкін.

11. Мигрень. Шамадан тыс кофеин және стимуляторлар болуы бас ауруы мен мигреньнің дамуына себепші болады.

12. Бедеулік. Ер адамда –кофеиннің көп мөлшері сперматозоидтардың сапасының нашарлауына, қозғалғыштығының болмауына, санының мөлшері азаюына әсер етеді. Ал әйел адамда - жоғарғы кофеин мөлшері гормондарға әсер

ISBN 978-601-08-0758-7

етіп, овуляцияны бұзады, қанттың жоғарғы мөлшері гормондық тепе-теңдікті азайтады.

13. Нәрестенің шала туылуы. Жүкті әйелдерде кофеин бала жолдасы арқылы ұрыққа өтеді және түсік тастау, мерзімінен бұрын босану, баланың салмағы төмен болуына әкеп соғады. Анада преэклапсия, артерияльды қан қысымының жоғарылауы, гипертония асқынулары болады. Қанттың жоғарғы мөлшері анада гестациялық қант диабетінің болуына, сәбиде туа пайда болған қант диабеті ауру қауіпін туғызады.

14. Онкологиялық аурулар. Қанттың жоғарғы мөлшері семіздік, қанда глюкоза мөлшерінің артуы инсулин бұзылысына әсер етіп, ұйқы безі, бауыр, тоқ ішек, сүт безі обырларының даму қауіпін тудырады. Шамадан тыс энергетик сусының тұтыну иммундық жүйенің жұмысына әсер етіп, дененің рак жасушаларына қарсы табиғи қорғанысын әлсіретеді және қатерлі ісік ауруларына бейімділікті арттырады.

Әдетте сусын құрамында 10-15 шақты қоспа болады. Олар – глюкоза, матеин, мелатонин, таурин, гуарана, карнитин, кофеин, женьшень, рибоза, инозит, В тобының дәрумендері. Олардың әрқайсысы ағзаға қуат береді. Кейбір мамандар бұлардың барлығы туралы жазбаның сусын ыдысы сыртында сәндік үшін жазылғанын да айтады. Кез-келген сусынды ішуге болатын тәуліктік көлемдегі мерзімдері болады. Сол туралы жазылуы керек. Өйткені, бұл дәрумендерді басқа да тағамдардан алатынымызды ескерсек, шектен тыс қабылдауға болмайды. Өйткені зат алмасуды бұзып, жүрекке кері ықпалы тиеді.

Кофеин – түссіз және ақ түсті келетін ащы кристалдар. Психикаға қатты әсер еткендіктен, сұйықтыққа тәуелділік туындатады. Сол себепті бір ішкен соң қайта-қайта өзіне баурап тұрады. Кофеиннің мөлшері неғұрлым көп болған сайын, соғұрлым жүйке белсенді жұмыс істей бастайды, гипертония, асқазан жарасы, жүрек қағуы, мазасыздық, дірілдеу және жүрек соғысын жиілетіп, қан қысымын жоғарылатады. Қуатты кофеин әкелмейді. Ол – сіздің өз энергияңыз. Сусынның әсері бойыңыздан кеткеннен кейін, тез шаршайсыз. Әр адам кофеинді күніне 400 грамнан артық қолдануға болмайды.

Таурин — аминқышқылдарының бір түрі, оны адам ағзасы өздігінен аз мөлшерде синтездейді. Энергетикалық сусындардың құрамында таурин әдетте физикалық және ақыл-ой қызметін жақсартуға көмектесіп, ағзадағы энергия алмасу үрдістеріне қатысады және шаршауды азайтуға көмектеседі. Ал гуарана – орманды жерде өсетін өсімдік, оның тұқымдары жоғары мөлшердегі табиғи кофеиннің негізгі көзі. Энергетикалық сусындар мен қоспаларда гуарана сергіткіш ретінде қолданылады. Мұнда кофеин мөлшері кәдімгі кофеге қарағанда 2-3 есе көп және орталық жүйке жүйесін ынталандырады, бұл сергектікті арттырады және ұйқышылдықты басады, ұзақ уақыт бойы белсенділікке ұстап тұруға көмектеседі, шаршауды басады және зейін қою қабілетін жақсартады. Таурин мен гуарана сияқты стимуляторлар көп мөлшерде тұтынылса, жүйке жүйесін шамадан тыс ынталандырып, жүрек-қан тамырлары жүйесіне

ISBN 978-601-08-0758-7

ауыртпалық түсіруі мүмкін. Бұл жүрек ырғағының бұзылуына және қан қысымының күрт өзгеруіне әкеледі.

Қант әдетте жылдам энергия көзі ретінде қызмет етеді. Энергетикалық сусындарда жиі қолданылатын қант түрлері — сахароза, глюкоза және жоғары фруктозалы жүгері шәрбаты.

Қорытынды: Қазіргі таңда жастар арасында энергетикалық сусындарды шамадан тыс қолдану әртүрлі ағзаға қауіпті ауруларды тудырып, өлім – жітім жағдайына дейін жеткізіп отыр. Сондықтан да, энергетик сусындарының зияндылығы туралы халықты кеңінен ақпараттандыру және табиғи өнімдерді қолданып, сату мен жарнамалауға қатаң шектеулер қойып,мәдени өзгерістер енгізу қажет. Бұл шаралар адамдардың өз денсаулығына жауапкершілікпен қарауына мүмкіндік береді.

"Денсаулыққа салғырт қарама – ол сенің өмірің." – демекші, денсаулықты қорғау ең басты байлық екенін түсініп, зиянды әдеттерден бас тартып, салауатты өмірді таңдаған жөн. Энергетик сусындарды қолданудан бас тартып, денсаулығымызды сақтау – әркімнің өз қолында.

Пайдаланылған ақпарат көздері:

1. https://massaget.kz/Zdorove/energetikalyik-susyindardyin-paydasyi-men-ziyanyi-17905/
2. https://kaz.inform.kz/news/energetikalyk-susyndar-el-keleshegi-ushin-kauipti-me_a2239163/
3. https://baq.kz/uyqyny-ashatyn-energiya-sergite-me-alde-dertke-bastay-ma-335972/
4. https://kaz.zakon.kz/kogam-tynysy/6026812-energetikaly-susyndar-anshalyty-aupt-drgerler-zhauap-berd.html

ISBN 978-601-08-0758-7

ӘЙЕЛ АЗАМАТТАРЫНЫҢ РЕПРОДУКТИВТІ ДЕНСАУЛЫҚ ЖАҒДАЙЫНЫҢ, ТУЫЛМАҒАН БАЛАНЫҢ ДЕНСАУЛЫҒЫНА ӘСЕРІ

Шаншарбек Ақерке, «Акушерлік ісі» мамандығы
Астана қаласы ««Томирис» медициналық колледжі» ЖШС
Ғылыми жетекшісі: арнайы пәндері оқытушысы Жакипбаева Гульнар Ергабыловна

Аннотация: *Жыныстық өмірдің ерте басталуы, жыныстық жолмен берілетін аурулар (ЖЖБИ), соның ішінде АИТВ/ЖИТБ, жоспарланбаған жүктілік, түсік түсіру, репродуктивті саланың негізгі проблемалары болып табылады. Болашақ балаларымызға өз денсаулығы мен өмірін сақтауға көмектесу үшін ерік пен жігер таныту. Жасөспірімдерге қауіпсіз, соның ішінде жыныстық, мінез-құлық дағдыларын қалыптастыруға көмектесу. Оларды өз денсаулығын сақтауға ынталандыру, жыныстық қатынастан туатын аурулардан сақтану жолдарымен таныстырып, алдын алу шараларын үйрету.*

«Әйелдің репродуктивті денсаулығы дегеніміз не?» соған тоқталып өтейік. Репродуктивтік денсаулық бұл - жүкті болу, босану және сау бала туу мүмкіндігі. Әйелдің репродуктивті денсаулығының негіздері ерте жастан қалыптасады және генетикалық ерекшеліктерге, дененің әртүрлі мүшелері мен жүйелерінің патологиясының болуына, қоршаған орта факторларының әсеріне және т. б. байланысты.

Өз аймағымдағы репродуктивті әйелдердің жас ерекшеліктері 18-35 жас аралығын құрайды. Жастар арасында белен алып жатқан ауру түрі анемия, жыныс жолдары инфекциясы, бедеулік пен өздік түсік. Жыныстық жолдармен берілетін және жыныс мүшелерінің қабынуынан созылмалы аурулар пайда болады. (хламидиоз, микоплазмоз, гонорея, гениталдық герпес, сифилис және т. б). Жүктілік кезінде хламидиоз инфекциясын жұқтыратын жағдайлар болатын болса, ол құрсақтағы ұрыққа кері әсерін тигізеді, ұрықтың дұрыс жетілуіне кедергі жасайды. Жүктілік кезіндегі темірдің жетіспеушілігі, анемия – кең таралған ауру. Оның салдары құрсақтағы балаға да тиетіні сөзсіз.Темір жетіспеушілгін көпшілік тым арық, әлсіз, аурушаң адамдар ғана анемия болады деген пікірде. Бұл өте қате ұғым. Тау қопаратын азамат та, салмағы сексеннен асатын әйел кісі де анемия болуы мүмкін. Өйткені анемия салмақ, бой, дәреже таңдайтын ауру емес. Оған кез келгеніміз шалдығуымыз мүмкін. Мысалы оған етеккір кезінде қанның көп мөлшерде ағуы, гинеколог дәрігерге тексеріліп, себебін анықтамауы жатады. Бұл теміртапшылығына әкеледі. Жүкті кезіндегі темірдің тапшылығы өте қауіпті. Тіпті, қайғылы жағдайға әкелуі де мүмкін. Ананың саулығына кері әсерін тигізіп, түсік тастауы, баланың уақытынан бұрын туылуы, дені сау бала туылғанымен оның ары қарай дамуына кері әсерін тигізуі мүмкін. Анемия кезінде құрсақтағы бала толық оттегімен қамтамасыз етілмейді.Сондықтанда репродуктивті әйел анемиясы болатын болса міндетті түрде қан сараптамасы керек. Сараптама қанның көлемін, түсін және пішінін көрсетеді. Ферритин мен гемоглобиннің

ISBN 978-601-08-0758-7

деңгейін анықтап береді. Жүктілік кезіндегі анемияны емдеу кезінде өте сақ болған жөн. Өйткені жүкті анаға кез келген дәріні, екпені, дәрумендіқабылдауға болмайды. Тіпті, тағамды да талғаммен тұтынуы керек. Құрамы темір элементіне бай тағамдарды қабылдап, дұрыс тамақтанып, темір элементі бар дәрумендерді қабылдауы тиіс.

Менің аймағымдағы репродуктивті денсаулық жағдайының дұрыс болмауына байланысты, туылмаған балаға кері әсері тиген жүктіліктін бірін айтып өтейін. Жас шамасы 20ж Г-есімді жүкті әйелде 14-15 жасынан анемия белгілері болған. Анемияны емдеу жолын іздемей 18 жасында тұрымыс құрды. 19 жасында алғашқы жүктілікте дәрумендердің жетіспеуінен, жүкті өзін әлсіз сезінген.. Қаназдықтан нәресте оттегімен толық қамтамасыз етілмеді, соның әсерінен гипоксия пайда болған. Гипоксия ұрықтың жүрек жұмысын, тыныс алу жүйелерінің қызметін әлсіретіп, рефлекстерді төмендетеді. Анемияның әсерінен түсік болған, түсік барысында құрсақтың төменгі бөлігі тартып ауырып, кейін жағылып қан келгеннен кейін, біршама уақытта қан құйылып кете бастаған. Жедел жәрдеммен ауруханаға жеткізіліп, құрсақ ішіндегі 3 айлық ұрықты вакуумдық аспирациямен жатырын тазалаған. 6 айдан кейін 2-ші жүктілікті жоспарлаған. Алғашқы ұрықта түсік қаупі болғаннан кейін дәрігерлер бірден фолий қышқылын тағайындаған. Екінші жүктілікте түсік қаупіне байланысты,дәрігерлер дюфастон мен утрожестан тағайындаған. Қазіргі танда Г-есімді әйел анемиядан емделіп бір шама жақсарған.

Репродуктивті жастағы әйелдер көп жағдайда өз бетінше ем қабылдайды. Сондай жағдайдан өткен менің аймағымдағы репрадуктивті әйелдің бірі Ж-есімді әйел 22 жасында жүкті болған. 39 аптаға дейін жүктілік жалғасты. Жүтіліктің жалпы барысы жақсы дамыды. Босану уақыты таяғанда циститпен ауырған. Жүкті әйел циститтіжалған толғақпен шатастырып дәрігерге бармаған. Нәтижесінде қуық жолдары қабынып, несеп шығуы қиындап, қанды бөліністер шыға бастаған. Өткір ұстамалы ауырумен жедел жәрдем шақырып, перинаталды орталыққа жеткізілген. Цистит асқынып созылмалы пиелонефритке ұласып, уретрадан қынапқа инфекция түсіп, қынаптың қабынуы пайда болған. Жүкті әйел 7 күн перинаталды орталықта терапевт тағайындаған антибиотикпен ем алып, 39 аптада табиғи жолмен босанған. Босану кезеңі асқынусыз өтті. Апгар шкаласы бойынша 8 балдық көрсеткішпен салмағы 3.200гр нәресте дүниеге келді. Қазіргі таңда баланың денсаулығы жақсы.

Жасөспірім қыздары арасында бүйрек ауруымен ауыратын және уақытылы дәрігер кеңесін алып, тексерілмейтін жастар саны жеткілікті. Жүкті әйелдерде бүйрек ауруы 7-10% көрсеткішке ие. Жүкті репродуктивті әйелдер жүктілік кезінде аз мөлшерде сұйықтық қабылдап, бүйрек жұмысының баяулауына, зәр бөлінудің бұзылу белгілерінің пайда болуына әкеледі.

Менің аймағымдағы репродуктивті әйелдің бірі Қ-есімді әйел 19 жаста, алғашқы жүктілік кезеңінде. Жүктілік уақытында нормадан тым аз мөлшерде сұйықтық қабылдаған, соның есебінен бүйрек жұмысы баяулаған, зәр бөліну жұмысы бұзылған, зәр талдамасында бактериялар анықталған. Жүкті әйелге

ISBN 978-601-08-0758-7

уролог консультациясы тағайындалған. Уролог өз кезегінде фитопрепараттар канефрон жазып, қабылдауын ұсынған. Препараттарды қабылдау ұзақтығы 10 күнге жалғасты. Жүктілік қалыпты түрде жалғасуда. Уақытылы емделмеуі, несеп жүйесінің бұзылуы әсерінен ұрық даму кідірісі және перинаталды өлімге әкелу қауіпіне әкелуі мүмкін..

Көп жағдайларда жүкті әйелдерде туа біткені гормондық бұзылыстар кездеседі соның бірі гипотреоз. Іштегі нәрестенің 24-25 аптаға дейін қалқанша безі жұмыс істемейді, сәби анасының гормондарын алып отырады. Бала ортақтасқаннан кейін гормон әйелдердің өзіне жетпейді, сол кезде гормоналды дәрілер беріп жатады. Әйелдер жүкті болардың алдында 6 ай бұрын қалқанша безін тексертіп, жүктілікке дайын болуы керек. Осыған ұқсас репродуктивті 33 жастағы Г есімді жүкті әйел гинеколог қабылдауында болған. Ол жүктіліктің 12 аптасында гинеколог есебіне алынып, бастапқы жүктілік бәрі қалыпты басталды. Жүктіліктің 20 апталарында қан анализінен қандағы қант мөлшері 0,7 ммоль/л анық болған. Гинеколог жүкті әйелді эндокринолог маманның кеңесіне жолдамамен жіберген. Гинеколог анамнез жинау барысында жүкті әйелдің алғашқы екі жүктілігінде қалыпты өткенін сұрау арқылы анықтаған.

Эндокринолог маманы жүкті әйелге бастапқыда диета ұстауға кеңес берді, Қалқанша безінің гормондары Т3,Т4 анализдерін тапсыруды ұсынған. Эндокринолог дәрігер Эутирокс 25 мкг ішуін тағайындаған. Дәрігер жүкті әйелге осы дәріні босанғанға дейін ішу керек екенін түсіндірді. Жүкті әйел жүктіліктің 36-37 аптасында аяқ, бетінің қатты ісінуі байқалды. Оны стационарға жатқызды, бақылауға алынды. Бірақ 37апта- 5 күні АҚ 130/80 мм. сын. бағ көрсетті. Стационарда гинеколог дәрігерлер консилиум өткізді. Жүкті әйелге толғақ шақыратын дәрі егіп босандырып алу керектігін ұсынған. Жүкті әйел келісімін берген, бірақ толғақ шақыратын дәрі еккен кезде әйел өздігінен босана алмаған.Себебі қан қысымы 130/80 мм. сын. бағ. көрсетті. Оны дереу кесар тілігіне жатқызған. Жүктіліктің 38 аптасында кесар тілігімен босандырып алған.

Вирустық жағдай немесе қиын ауа-райы жағдайлары бар кездің нәтижесінде әйел ауырып қалуы мүмкін. Бұл сонымен қатар, жүктілікте иммунитеттің әлсіреуі және болашақ ананың вирустық ауруларға шалдықтырады.

Ж-есімді жүкті әйел 16 жаста. Жүктіліктің 8ші аптасы.Түскілік уақытта жүрек айнуы мен лоқсу, құсу симптомдары пайда болды. Жүктіде ерте токсикоз болмаған. Кешкілік уақытта құсықта қою, ірі іртікті қан түйіршіктерін байқаған. Жедел түрде жедел жәрдем қызметіне жүгінді. Медицина қызметкерлері жедел бронхитке күдіктеніп инфекциялық, оқшауланған аурухана жеткізді. Медицина қызметкерлері анамнез жинау барысында 3 аптадан бері жөтелдің бар екенін және 3-4 күннен бері дене температурасы 38.7ге дейін көтерілгенін мәлімдеді. Науқасқа рентген аппаратымен зерттеу жасау ұсынылған, науқас келіспеді. Бас тартуының себебін бастапқы мерзімдегі жүктілікпен ұштастырды. Науқас инфекциялық оқшауланған көпбейінді қалалық ауруханаға, торакальды хирург маманына жедел түрде жеткізілген. Дәрігер науқаспен сөйлесе келе әлсіздікті, тері бозаруын байкады. Зерттеу барысында күдік расталып, емдеу жүргізілген.

ISBN 978-601-08-0758-7

Емдеу уақтылы және дұрыс жүргізілсе, жүктінің тыныс жолдарының қабынуы ұрыққа қатерін туғызбайды.

Репродуктивтік денсаулық бұл - жүкті болу, босану және сау бала туу мүмкіндігі деп басында айтып кеткен болатынмын. Қорытындылай келе, әйелдің репродуктивті денсаулығының негіздері ерте жастан қалыптасады және генетикалық ерекшеліктерге, дененің әртүрлі мүшелері мен жүйелерінің патологиясының болуына, қоршаған орта факторларының әсеріне байланысты. Жыныстық қатынастың ерте басталуы бүгінгі күннің басты мәселесі! Әрбір репродуктивті әйел адам отбасын құрар алдында, жүктілікті жоспарлау алдында өзінің денсаулығына дұрыстап көңіл бөлгені дұрыс. Өз денсаулығына, іштегі туылмаған баланың денсаулығына кері әсерін тигізбес үшін, жүктілікті жоспарламас бұрын, толығымен ем алып, аурудың алдын алып, дәрумендерді қабылдаудың маңызы өте зор екенін түсіну керек. Себебі әйел саулығы - ұрпақ саулығы!

Әдебиеттер тізімі:

1. https://anamenbala.kz/enciklopediya/aieldin-reproduktivtik-juiesi/
2. https://stat.gov.kz/for_users/cluster/chapter4
3. https://komeco.edu.kz/news/kz/2088/
4. https://www.inform.kz/kz/ayeldin-reproduktivti-densaulygyn-bala-kezinen-kolga-alu-kerek-dariger_a3514670/amp

ISBN 978-601-08-0758-7

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В МЕДИЦИНЕ, ОЦЕНКА НАВЫКОВ САМО-МЕНЕДЖМЕТА У ПАЦИЕНТОВ С ИНСУЛЬТОМ

Яритик Д.Б., 2 курс, специальность «Лечебное дело»
ГККП «Аркалыкский медицинский колледж» Управление образования акимата Костанайской области.
Научный руководитель: Айтжанова Алия Муполяновна преподаватель специальных дисциплин

Аннотация: *Данная статья рассматривает научно -практическую работу посвященную изучению оценки основных навыков влияющих на самоуправлению заболеванием у пациентов с инсультом. Инсульты являются второй из наиболее частых причин смертности населения в мире на 2024 год (более частой является ишемическая болезнь сердца). От инсульта за год умирает около 6,2 миллиона человек (около 11 % от всех смертей). Около 10 миллионов человек перенесли инсульт в 2024 году. Около 31 миллионов человек ранее перенесли инсульт и оставались в живых в 2023 году. За период с 2014 по 2024 годы количество инсультов в развитых странах уменьшилось примерно на 15 %, а в развивающихся странах — увеличилось на 12 %. Повышенный риск смерти от инсульта наблюдается у жителей южной Азии, на них приходится около 40 % смертей от инсульта.*

Актуальность работы: Инсульт является основной причиной смерти и инвалидности во всем мире с потенциальными долгосрочными последствиями для человека, такими как социальная изоляция, длительная депрессия и тревога и увеличение физических нарушений. Восстановление после инсульта является сложным и многомерным, охватывающим биомедицинские, психологические и социологические элементы. Самоуправление - это стратегия, применяемая людьми для управления долгосрочным состоянием здоровья, и она потенциально важна для снижения заболеваемости и ухода за здоровьем человека. Самоуправление важно для восстановления и качества жизни людей после инсульта. Было разработано много вмешательств для поддержки самоуправления после инсульта,однако на сегоднешний день не существует надежного и валидного показателя результатов для поддержки их оценки. Способность человека принимать свои проблемы, связанные с инсультом, и адаптировать свое поведение и отношение, используя навыки активного принятия решений и самоконтроля, является центральным фактором социального участия после инсульта. Это вносит важный вклад в концептуальное понимание участия в жизни людей с инсультом.

Цель и задача исследования: Изучение уровня навыков самоуправления у пациентов с инсультом. Провести валидацию опросника на казахском и русском языках.Оценить основные навыки влияющие на само-менеджмента у пациентов с инсультом.Разработка практических предложений.

Методы исследования:Набор пациентов (N=100) был проведен на базе

ISBN 978-601-08-0758-7

ТОО «Жанұя» г.Аркалык.Для сбора данных использовался опросник.Статистическая обработка данных при помощи программы

Новизна исследования:В результате исследования был валидирован опросник для оценки уровня навыков само-менеджмента у пациентов с инсультом, что позволило сориентировать медицинских работников ПМСП в ведении данных пациентов.Была проведена оценка уровня навыков само-менеджмента у пациентов с инсультом, которая помогла в разработке обоснованной программы ведения пациентов с инсультом на уровне ПМСП.Были разработаны практические предложения по обучению навыкам самоменеджмента пациентов с инсультом.

Практическая значимость исследования: Материалы настоящего исследования позволяют рекомендовать всем работникам среднего медицинского звена, которые осуществляют уход за перенесшими инсульт пациентами изучить и применять на практике навыки само-менеджмента практические предложения предложенные по завершению окончания и сдачи научной работы. Сестринский персонал, испытывающий затруднения с данной категорией пациентов могут ознакомиться с обзором и результатами проведенного исследования для расширения своих знаний и получения дополнительных рекомендации.

Введение: Научно – практическая работа имеет логическую структуру и состоит из 3 глав. Каждая глава имеет свои разделы, с изложением исследуемого вопроса начиная от литературного обзора и заканчивая списком использованной литературы. Каждая глава логически структурирована, что дает возможность понять научную работу в целостности и ясности. Для более ясного понимания всех этапов исследования и статистического материала имеется отдельная глава с описание материалов и методов исследования. В этой работе очень четко и легко доступна, описана основная глава, которая отражает результаты проведенного исследования. В главе «результаты исследования» использованы 5 таблиц, что дает изучить материал в более наглядном формате.

Основная часть: **Инсу́льт**- *insultus* «наскок, нападение, удар», **апоплéксúя** «паралич» — острое нарушение кровоснабжения головного мозга (острое нарушение мозгового кровообращения, ОНМК), характеризующееся внезапным (в течение нескольких минут, часов) появлением очаговый и/или обще мозговой неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов или приводит к смерти больного в более короткий промежуток времени вследствие цереброваскулярной патологии. К инсультам относят инфаркт мозга, кровоизлияние в мозг и субарахноидальное кровоизлияние, имеющие этиопатогентические и клинические различия.С учётом времени регрессии неврологического дефицита особо выделяют преходящие нарушения мозгового кровообращения (неврологический дефицит регрессирует в течение 24 часов, в отличие от собственно инсульта) и малый инсульт (неврологический дефицит регрессирует в течение трёх недель после начала заболевания). Инсульт бывает двух основных видов: ишемический и геморрагический. Чаще всего бывает ишемический (более 80% случаев). Он

ISBN 978-601-08-0758-7

начинается из-за сужения и закупорки сосудов головного мозга. Нарушению кровообращения способствуют сгустки крови и инородные тела (в том числе пузырьки воздуха от инъекций), попавшие в кровоток. Недостаток кислорода и питания вызывает гибель клеток мозга. [1стр.4].Первым упоминанием об инсульте служат описания, сделанные Гиппократом в 467.годудо нашей эр, в которых говорится о потере сознания в результате заболевания головного мозга.В дальнейшем Гален описал симптомы, которые начинаются с внезапной потери сознания, и обозначил их термином, «удар». С тех пор термин «апоплексия» достаточно прочно и надолго входит в медицину, обозначая при этом как острое нарушение мозгового кровообращения, так и быстро развивающееся кровоизлияние в другие органы .Уильям Гарвей в 1628 году изучил, как движется кровь в организме, и определил функцию сердца как насосную, описав процесс циркуляции крови. Эти знания заложили основу изучения причин возникновения инсульта и роли сосудов в этом процессе. [1стр.17].Значительный вклад в понимание патогенеза инсульта сделал Рудольф Вирхов. Он предложил термины «тромбоз» и «эмболия». Данные термины до сих пор являются ключевыми в диагностике, лечении и профилактике инсульта. Позднее он также установил, что тромбоз артерий вызывается не воспалением, а жировым перерождением сосудистой стенки, и связал его с атеросклерозом. [2 стр.23] Среди всех видов инсульта преобладают ишемические поражения мозга. Хотя в обиходной речи инсульт часто называют **кровоизлиянием в мозг**, в действительности на кровоизлияния — на геморрагическую разновидность инсульта — приходится лишь 18—23 % случаев. Ишемические инсульты составляют 60—75 % случаев, нетравматические субарахноидальные кровоизлияния — 5 % случаев. [3 стр.35].Инсульт в настоящее время становится основной социально-медицинской проблемой неврологии [4 стр.16].В 2017 году приблизительно 6,5 миллиона человек перенесли ишемический инсульт, а 3,2 миллиона человек — геморрагический инсульт. В Казахстане, в частности, каждый год более 350 тыс. людей страдают от этой патологии, то есть каждые 1,5 минуты у кого-то развивается это заболевание. В мегаполисах Казахстана количество острых инсультов составляет от 80 до 90 в сутки.Инсульт в настоящее время является одной из основных причин инвалидизации населения. Инвалидами становятся 60—70 % выживших после инсульта, причём примерно 20—30 % из них нуждаются в постоянном постороннем уходе. [5 стр. 27].

В Казахстане тяжёлой инвалидности у перенёсших инсульт способствуют малое количество экстренно госпитализированных больных (не превышают 15—30 %), отсутствие палат интенсивной терапии в неврологических отделениях многих стационаров. Недостаточно учитывается необходимость активной реабилитации больных (в реабилитационные отделения и центры переводятся лишь 15—20 % перенёсших инсульт). Летальность у больных с инсультами во многом зависит от условий лечения в остром периоде. Ранняя 30-дневная летальность после инсульта составляет 30 %. В стационарах летальность составляет 23 %, а у лечившихся дома — 43 % . В течение года умирает около

ISBN 978-601-08-0758-7

45 % больных. Смертность у мужчин выше, чем у женщин. [6 стр. 55].Вероятность инсульта выше у тех, кто уже перенес это заболевание несколько лет назад. Повторные инсульты переносятся гораздо тяжелее.Особо среди факторов риска стоит назвать транзиторные ишемические атаки. В народе они больше известны как микроинсульт.Лучше не лечить такое сложное заболевание как инсульт, а предупредить его развитие.

Мероприятия методом анкетирования по навыкам самоуправления у пациентов с инсультом.В организации по навыкам самоуправления у пациентов с инсультом, исходя из этого исследование проводилось мною при помощи студентов 2 курса группы 291 Фрб специальность 09120100 «Лечебное дело» квалификация 4S09120101 «Фельдшер» анкетирование на базе ТОО «Жанұя » Затем был проведен опрос пациентов поликлиники на дому. В опросе на начальном этапе участвовали 150 респондентов в возрасте от 38 до 79 лет, из них умерло 32 респондентов (23 мужчин, 9 женщин), отказались 12 респондентов(7 женщин, 5 мужчин) 3 респондентов (1 женщина, 2 мужчин) не могли принять участия. На конечном этапе в опросе участвовали **103** респондентов из них 58 мужчин, 45 женщин. Участникам исследования в письменной форме было предложено ответить на 28 вопросов разработанной анкеты (см. прил.1). Цель: оценить эффективность уровня навыков самоуправления у пациентов с инсультом.



Выводы: Систематический обзор показал, что SMI, связанные с инсультом, оценивались путем измерения разнородных понятий, таких как физическая функция, качество жизни, само эффективность, удовлетворенность и настроение. В обзоре было выявлено 43 различных показателя результатов, из которых 21 показатель (49 %) продемонстрировал некоторые психометрические свойства в популяциях, перенесших инсульт. Это указывает на отсутствие консенсуса в отношении надлежащих мер по оказанию помощи в оценке SMI, связанных с инсультом, или признание того, что самоуправление охватывает целый ряд различных концепций .

Проанализировав случаи навыков по самоуправлению, можно сделать выводы: знание само менеджмента, активное участие в собственной реабилитации, принимая во внимание советы, которые помогут в восстановлении здоровья осуществлять, иметь возможность продолжать делать упражнения, программировать, принимая свое активное участие. Данные свидетельствуют о недостаточном информировании пациентов с инсультом о навыках само управления. Они не считали самоуправление частью своей помощи. Таким образом можно сделать выводы что, знание навыков по самоуправлению этой

ISBN 978-601-08-0758-7

группы населения мотивировать самих себя, лечить инсульт. Поэтому при нехватке ресурсов могут быть приняты технологические программы самоуправления под руководством медсестер. В настоящее время наиболее популярной темой является физическая активность, поскольку она широко известна среди пациентов, перенесших инсульт.

Заключение: На 1 этапе выполнен перевод исходной версии опросника на русский язык. Перевод проводился двумя профессиональными переводчиками, носителями родного языка, независимо друг от друга. В процессе перевода каждый из переводчиков произвел прямой перевод оригинального опросника, инструкции и вариантов ответов. После сравнения обеих версий перевода и согласования была создана объединенная выверенная версия – Версия 1.На 2 этапе создания русскоязычной версии проводилось тестирование созданной Версии 1 на пациентах. В конце опроса интервьюер также спрашивал, не было ли у опрашиваемого проблем в понимании анкеты и её заполнении.

Основные принципы успешной рекомендации: Ранее начало (первые дни после инсульта).Лечебная гимнастика,массаж,обучение ходьбе,самообслуживанию.Длительность(безперерывов),систематичность.Компле ктность (сочетание различных методов реабилитации),занятия с логопедом, «домашние занятия», медикаментозная терапия.Активное участие в реабилитации самого пациента и членов его семьи

Список литературы

1. Богер EJ, Demain SH, Latter SM. Самоконтроль после инсульта: исследование в фокус-группе для определения факторов, влияющих на самоконтроль после инсульта. *Международный журнал сестринских исследований* . 2015; 52 (1): 175–87. 10.1016 / j.ijnurstu.2014.05.006 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

2. Эллис-Хилл К., Робисон Дж., Уайлс Р., Макферсон К., Хайндман Д., Эшберн А. Возвращение домой, чтобы продолжить жизнь: опыт пациентов и лиц, осуществляющих уход, выписанных из больницы после инсульта. *Инвалидность и реабилитация* . 2009; 31 (2): 61–72. 10.1080 / 09638280701775289 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar

3. Лангхорн П., Бернхардт Дж., Кваккель Г. Реабилитация после инсульта . *Ланцет (Лондон, Англия).* 2011; 377 (9778): 1693–702. [PubMed] [Google Scholar]

4. Жусупова А.С. Организация деятельности региональных инсультных центров в РК. Материалы международной научно-практической конференции «Клинические аспекты инсультологии. От первых симптомов до реабилитации». Иссык-Куль; 2011;3-6.

5. Хасанова Д.Р., Данилов В.И., Сайхунов М.В. Инсульт. Современные подходы диагностики, лечения и профилактики. Методические рекомендации. Казанский государственный медицинский университет. Казань—Алматы; 2010. 3.

6. Иванова Г.Е., Гудкова В.В., Петрова Е.А. Система реабилитационных

ISBN 978-601-08-0758-7

мероприятий в острый период церебрального инсульта. Журнал Неврология. 2008;4:10-16. 4. Иванова Г.Е., Шкловский В.М., Петрова Е.А. Принципы организации ранней реабилитации больных с инсультом. Качество жизни Медицина. 2006;2(13):62-70.

ISBN 978-601-08-0758-7

ПРОЦЕСС АДАПТАЦИИ У СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖЕЙ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Поликанова Елена Антоновна, 3 курс, специальности «Лечебное дело»
Учреждение «Медицинский колледж «Семей»»,
Шынгаев Темирлан Саятулы, преподаватель специальных дисциплин

Актуальность: *Адаптация студентов первого года обучения – это сложный, неизбежный активный, многоступенчатый и многосторонний процесс преобразования привычного уклада жизни, полученных навыков и опыта, возможностей и привычек в соответствии с новыми условиями их применения [1]. По результатам исследований последних лет, удачная адаптация первокурсников к дальнейшей учебной и профессиональной деятельности обеспечивается в условиях образовательного процесса, ориентированного на развитие личности, предусматривающего такую взаимосвязь студентов и педагогов, при которой воссоздаются необходимые условия для выработки у субъектов образования способности к развитию самостоятельности, самообразованию, реализации себя и своего интеллектуального потенциала [2; 3].*

Цель: изучение ИФИ (индекса функциональных изменений) первокурсников как показателя адаптации к условиям образовательной среды в колледже на разных этапах обучения и исследование влияния на этот процесс преобладающего отдела вегетативной нервной системы. Определение студентов с напряжением адаптационных механизмов, с целью оказания психологической поддержки, ускорения и смягчание процесса адаптации.

Методы и материалы:

Дизайн исследования: поперечное исследование, так как планируется изучение одних и тех же лиц через определенные интервалы времени.

1. антропометрия (измерение роста, веса)
2. физические методы (пальпация пульса, измерение артериального давления)
3. формула для расчета ИФИ
4. формула для расчета вегетативного индекса Кердо

Применение валидных инструментов: в ходе исследования будет применена анкета для определения уровня адаптации. Для оценки вероятности систематической ошибки, будет проведена валидизация.

Генеральная совокупность исследования включает студентов 1 курса «Медицинский колледж «Семей».

Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью программы SPSS 23.0.

Результаты и их обсуждение: На первом этапе мы провели измерение антропометрических данных, тесты на определение тревожности, расчитали ИФИ и принадлежность к опредленной группу ВИ. По результатам из 100% исследуемых в сентрябре месяце у 37,7% наблюдалось напряжение адаптативных

ISBN 978-601-08-0758-7

механизмов. По таблицам сопряженности, в которых находили связь между ВИ, полом и группой ИФИ (данный метод приемлем, так как все переменные номинальные). В первом случае у группы ИФИ-1 (нормальная адаптация) следующее распределение: нормасимпатики- 31,3% с преобладанием парасимпатической- 11,5%, с преобладанием симпатической- 16,4% (в дальнейшем ВИ 1,2,3 соответсвтенно). В группе ИФИ-2 (напряжение адаптационных механизмов): ВИ-1- 24,6%, ВИ-2- 3,3%, ВИ-3- 9,8 (p=0,56). Во-втором случае у группы ИФИ-1 распределение по полу: Ж- 42,6%, М- 19,7%. Группа ИФИ-2 Ж- 9,8%, М- 27,9% (p=0,001). На втором этапе, который был проведен в марте, произведен аналогичный сбор данных, как в первом случае. По данным результатам, процент исследуемых с напряжением адаптативных механизмов снизился с 37,7% до 19,7%. Приводим данные таблицы сопряженности. В первом случае у группы ИФИ-1 следующее распределение: ВИ-1- 42,6%, ВИ-2- 14,7%, ВИ-3- 21,3%. В группе ИФИ-2: ВИ-1- 16.4%, ВИ-2- 0, ВИ-3- 4.9% (p=0,183). Во-втором случае у группы ИФИ-1 распределение по полу: Ж- 44.3%, М- 31.3%. Группа ИФИ-2 Ж- 8.2%, М- 13.1% (p=0,255).

Таблица 1

Распределение в сентябре

Показатель	Группа ИФИ-1	Группа ИФИ-2
ВИ-1	31,3%	24,6%
ВИ-2	11,5%	3,3%
ВИ-3	16,4%	9,8%
Мужчины	19,7%	27,9%
Женщины	42,6%	9,8%

Таблица 2

Распределение в марте

Показатель	Группа ИФИ-1	Группа ИФИ-2
ВИ-1	42,6%	16,4%
ВИ-2	14,7%	0%
ВИ-3	21,3%	4,9%
Мужчины	31,3%	13,1%
Женщины	44,3%	8,2%

ISBN 978-601-08-0758-7

График 1



Выводы: Безусловно, смена окружения, места жительства, учебной нагрузки сопровождается напряжением адаптационных механизмов, студенты испытывают стресс. По результатам полученных данных, нам не удалось установить связь между определенной группой ВИ и стресса, но прослеживается определенная тенденция к тому, что преобладание симпатической нервной системы ведет к быстрейшей адаптацией, по с равнению с остальными. Это объясняется тем, что физиологически, стресс является активацией симпато-адреналовой системы, соответственно преобладание симпатической нервной системы ведет к быстрейшей адаптации к стрессу.

Однако нам удалось установить связь между полом и стрессом. В исследовании, проведенном в сентябре, наблюдается следующее: из 100% студентов, у которых наблюдалось напряжение механизмов адаптации, 74% были представителями мужского пола. Это свидетельствует о том, что мужской пол оказался менее стрессоустойчивым, по сравнению с женским.

К всему вышеперечисленному можно добавить, что процесс адаптации в «Медицинском колледже «Семей»»проходит ступенчато, т.е если сравнивать процент студентов с напряжением адаптационных механизмов (37,7%) в сентябре с процентом в марте (19,7%), наблюдается снижение численности данных студентов.

Практические рекомендации: каждый новый учебный год, проводить исследование адаптационных механизмов у первокурсников, не ограничиваться простым анкетированием проводимым психологом организации. Вовлекать средний медицинский персонал с целью определения индекса функциональной возможности каждого студента. Проводить динамическое наблюдение в начале

ISBN 978-601-08-0758-7

второго семестра. Оценивать уровень адаптации, проводить работу с обучающимися, чей адаптационный период не завершился. Вводить корректировки в запланированный список мероприятий, в связи с полученными результатами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1 Дубовицкая Т.Д.,Крылова А.В. A methodology for studying the adaptation of students in a university [Электронный ресурс]. Психологическая наука и образование . 2010; (2). (In Rus.) Accessed Yanvar 9, 2014. URL: http://psyedu.ru/journal/2010/2/ Dubovitskaya_Krilova.phtml(дата обращения 17.03.2020)

2. Россошанская А.Ю.,Ермолаева Е.В.. Social partrait of a modern medical student // Bulletin of medical Internet conferences. 2016. T. 6. No. 1. P. 154.

3. Friedlander L., Reid G., Shupak N., Cribbie R. Social support, self-esteem, and stress as predictors of adjustment to university among first-year undergraduates // Journal of College Student Development. 2007. Vol. 48(3). P. 259-274.

ISBN 978-601-08-0758-7

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У МОЛОДЕЖИ

Мухаметжанова Гульсан Рысбековна
«Поликлиника №4 города Семей»

***Аннотация**: Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) остаются одной из главных причин смертности и инвалидизации во всем мире. В последние десятилетия наблюдается тревожная тенденция роста ССЗ среди молодежи. Данная статья посвящена анализу факторов риска, способствующих развитию ССЗ у молодых людей, а также рассмотрению современных методов профилактики и лечения. Важность ранней профилактики, правильного питания, отказа от вредных привычек и регулярной физической активности рассмотрены как ключевые элементы предотвращения данных заболеваний. Проводится анализ последних исследований в области терапии и профилактики ССЗ, включая фармакологические и поведенческие вмешательства. Особое внимание уделено актуальным рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и других авторитетных институтов, касающихся поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы у молодежи.*

На сегодняшний день сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) продолжают оставаться одной из основных угроз здоровью населения. ССЗ развиваются не только у пожилых людей, но и все чаще диагностируются у молодых, что требует незамедлительного принятия мер по профилактике и коррекции факторов риска в данной возрастной группе. Среди основных причин – малоподвижный образ жизни, неправильное питание, стресс и вредные привычки. Ранняя профилактика и выявление предрасположенности к ССЗ у молодежи позволяют не только снизить риск развития этих заболеваний, но и улучшить общее качество жизни.

Факторы риска развития ССЗ у молодежи

1. **Низкая физическая активность.** Современный образ жизни, включающий малоподвижные виды деятельности, способствует увеличению массы тела и развитию ожирения – одного из основных факторов риска ССЗ.
2. **Неправильное питание.** Употребление большого количества соли, жиров и сахара увеличивает риск развития гипертонии и атеросклероза.
3. **Стресс и эмоциональные перегрузки.** Хронический стресс приводит к повышению артериального давления и может ускорить развитие ишемической болезни сердца.
4. **Генетическая предрасположенность.** Наличие в семье случаев ССЗ увеличивает вероятность их появления у потомков, что делает необходимым регулярное обследование.

Современные методы профилактики ССЗ

Для профилактики ССЗ среди молодежи Всемирная организация здравоохранения и кардиологические ассоциации предлагают следующие подходы:

- **Регулярная физическая активность** – занятия спортом, пешие прогулки и физическая активность на свежем воздухе.

ISBN 978-601-08-0758-7

- **Здоровое питание** – уменьшение потребления трансжиров, сахара и соли, повышение доли овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов в рационе.
- **Снижение уровня стресса** – йога, медитация и психологическая поддержка оказывают положительное влияние на общее состояние здоровья.
- **Контроль за весом** и отказ от вредных привычек (курения и чрезмерного потребления алкоголя).

Современные подходы к лечению ССЗ

Современные фармакологические методы лечения включают:

- **Гипотензивные препараты**, такие как ингибиторы АПФ и блокаторы рецепторов ангиотензина, которые позволяют контролировать артериальное давление.
- **Статины** – для снижения уровня холестерина и профилактики атеросклероза.
- **Антиагреганты и антикоагулянты** – для снижения риска образования тромбов.

Кроме того, активно развиваются немедикаментозные методы, включая использование биологически активных добавок, диетотерапию и физиотерапевтические методы.

Выводы: Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний у молодежи – ключевой шаг к снижению смертности и повышению качества жизни. Разработка и реализация профилактических программ в образовательных учреждениях, поддержка здорового образа жизни на уровне государственных и частных организаций, а также повышение осведомленности молодежи о факторах риска и способах их снижения являются важнейшими компонентами борьбы с ССЗ. Важно внедрение современных методов лечения, которые обеспечат не только повышение эффективности терапии, но и минимизацию побочных эффектов.

Список литературы

1. Всемирная организация здравоохранения. *Сердечно-сосудистые заболевания: факты и профилактика.* ВОЗ, 2020.
2. Кузнецов, А. В., Романов, В. С. *Основы кардиологии.* М.: Медицина, 2019.
3. Johnson, L., & McLeod, G. *The Role of Diet and Exercise in Cardiovascular Health.* Journal of Cardiology, 2020.
4. American Heart Association. *Hypertension Guidelines for Youth.* Circulation, 2021.
5. Сергиенко, И. И. *Генетические аспекты сердечно-сосудистых заболеваний.* Российский кардиологический журнал, 2019.
6. Ульянов, Е. А., Николаева, Т. В. *Медицинская профилактика и здоровый образ жизни.* Санкт-Петербург, 2021.
7. Davidson’s Principles and Practice of Medicine, 23rd edition, Elsevier, 2018.

ISBN 978-601-08-0758-7

СЕКЦИЯ №3: НОВЫЕ ПОДХОДЫ И ИННОВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ БУДУЩИХ МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ.

БОЛАШАҚ МЕДИЦИНА МАМАНДАРЫН ОҚЫТУДАҒЫ ЖАҢА ТӘСІЛДЕР МЕН ИННОВАЦИЯЛАР

Абдрахманова Г.С., педагог-зерттеуші, арнайы пәндер оқытушысы
«Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжінің ЖШС»

Аннотация: *Бұл мақалада қарастырады медицина мамандарын оқытудағы жаңашыл тәсілдер мен инновациялар — болашақ медицина мамандарын оқытудағы жаңа тәсілдер мен инновацияларды қарастыру.*

Оқыту процесін жаңғырту, заманауи технологияларды енгізу, және оқу бағдарламаларын жетілдіру мәселелері талқыланады.

Жаңа педагогикалық әдістер мен оқу құралдары, студенттердің тәжірибелік дағдыларын дамыту жолдары, сондай-ақ білім беру жүйесіндегі цифрландыру және телемедицина аспектілері қарастырылады. Заманауи технологиялар мен педагогикалық әдістердің интеграциясы білім беру процесін жаңғыртып, медицина мамандарының біліктілігін арттыруға мүмкіндік береді.

Мақсаты

Бұл жұмыстың мақсаты — болашақ медицина мамандарын оқытудағы жаңа тәсілдер мен инновацияларды зерттеу, Қазақстандағы білім беру жүйесінің ерекшеліктерін және медициналық білім беру саласындағы қазіргі тенденцияларды анықтау.

Медицина саласы жылдам өзгеріп жатқан әлемде білім беру жүйесінің жаңаруы қажет. Заманауи технологиялар, әсіресе ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, медициналық білім беруді жаңа деңгейге көтеру мүмкіндігін береді. Білім беру жүйесіндегі жаңа бағыттарды талқылау, тәжірибе алмасу және болашақ мамандардың біліктілігін арттыру.

Міндеттері

Жаңа педагогикалық әдістерді зерттеу: Интерактивті оқыту, симуляциялық оқыту және проблемалық негізде оқыту әдістерін талдау.

Цифрландыру мен технологияларды енгізу: Телемедицина, онлайн оқу платформалары және мобильді қосымшалардың рөлін анықтау.

Студенттердің тәжірибелік дағдыларын дамыту

Клиникалық дағдыларды меңгеру: Симуляциялық орталықтар мен жаттығу залдары арқылы тәжірибелік дағдыларды дамыту. Студенттер нақты жағдайларды модельдеу арқылы дайындық алады.

Тәжірибелік базалар: Емдеу мекемелерінің база арасында ынтымақтастық орнату, студенттерді нақты клиникалық жағдайларда тәжірибе жинауға мүмкіндік беру.

Кәсіби этика мен коммуникация: Студенттердің медициналық этика және пациентпен коммуникация дағдыларын дамыту. Бұл болашақ дәрігерлердің пациенттермен қарым-қатынасының сапасын арттырады.

ISBN 978-601-08-0758-7

Жаңа педагогикалық әдістер:

Интерактивті оқыту технологиялары:

Студенттердің белсенді қатысуын ынталандыратын әдістер:

Оқу процесін қызықты ету үшін интерактивті әдістер (дискуссиялар, рөлдік ойындар) пайдалану, білімді тереңірек меңгеруге мүмкіндік береді. Студенттердің белсенді қатысуын ынталандыру.

Симуляциялық оқыту: Симуляторлар мен mannequins (модельдер) арқылы клиникалық дағдыларды меңгеру. Мысалы, жедел медициналық көмек көрсету дағдыларын дамыту үшін арнайы симуляторларды пайдалану.

Клиникалық дағдыларды меңгеру үшін симуляторларды пайдалану.

Шынайы медициналық жағдайларды модельдеу.

Цифрландыру мен телемедицина:

Онлайн оқу платформалары мен телемедицина технологиялары арқылы білім алуды жеңілдету. Деректерді жинау мен талдау.

Интерактивті оқыту технологиялары:

Проекттік оқыту: Студенттерді шынайы медициналық проблемаларды шешуге бағыттау, топтық жұмыстарды ұйымдастыру. Бұл әдіс студенттердің командалық жұмыс дағдыларын дамытуға ықпал етеді.

Цифрландыру мен телемедицина

Онлайн оқу платформалары: Coursera, edX сияқты платформалар арқылы медициналық білім алуға мүмкіндік береді. Студенттер әртүрлі курстарға қол жеткізе алады, сондай-ақ әлемдік деңгейдегі сарапшылардан дәріс тыңдайды.

Телемедицина: Алыстан консультация беру мен пациенттермен байланыс жасау. Бұл тәсіл дәрігерлер мен пациенттер арасындағы коммуникацияны жеңілдетеді, әсіресе шалғай аудандарда.

Деректерді жинау және талдау: Big Data технологияларының көмегімен медициналық зерттеулер мен диагноздарды жетілдіру. Пациенттердің медициналық тарихын талдау арқылы дәрігерлердің шешім қабылдауына көмектеседі.

Жаңа технологиялар

AR және VR технологиялары: Көру қабілетін арттыру үшін виртуалды және кеңейтілген шындық технологияларын пайдалану. Бұл студенттерге медициналық процедураларды үйренуге мүмкіндік береді.

Мобильді қосымшалар: Дәрігерлер мен студенттер үшін арнайы мобильді қосымшалар арқылы ақпарат алмасу мен оқыту. Мысалы, медициналық анықтамалықтар мен оқу құралдары.

Геймификация: Оқыту процесін ойын элементтерімен байыту. Студенттердің мотивациясын арттыру, білімді ойын арқылы меңгеруге ықпал етеді.

Инновациялық оқыту бағдарламалары

Интердисциплинарлық оқыту: Медицина, психология, әлеуметтік ғылымдар мен инженерияны біріктіретін оқу бағдарламалары. Бұл студенттердің кешенді көзқарас қалыптастыруына көмектеседі.

ISBN 978-601-08-0758-7

Клиникалық зерттеулер мен тәжірибелер: Студенттерге клиникалық зерттеулерге қатысу мүмкіндігін беру, ғылыми жұмыспен айналысуға ынталандыру.

Қорытынды: Медицина мамандарын оқытудағы жаңа тәсілдер мен инновациялар білім беру жүйесін жаңғыртуға, студенттердің тәжірибелік дағдыларын жетілдіруге, және медициналық білімнің сапасын арттыруға бағытталған. Интерактивті, практикалық, және технологиялық әдістерді қолдану — болашақ медицина мамандарының тиімді даярлығына ықпал етеді.

Бұл зерттеулер медицина мамандарын оқытудағы жаңашыл тәсілдер мен инновацияларға бағытталған. Олар заманауи білім беру әдістерін, технологияларды және интердисциплинарлық ынтымақтастықты қолданудың маңыздылығын атап өтеді. Осы ғылыми жұмыстар арқылы оқу процесінің тиімділігін арттыру және болашақ медицина мамандарын даярлау сапасын жақсарту мүмкіндіктері туралы қосымша мәліметтер алуға болады.

Болашақ медицина мамандарын оқытудағы жаңа тәсілдер мен инновациялар медициналық білім беру жүйесінің тиімділігін арттыруда маңызды рөл атқарады. Заманауи технологияларды енгізу, интерактивті және симуляциялық оқыту әдістерін қолдану, студенттердің практикалық дағдыларын дамыту — білім беру процесін жаңғырту мен сапасын арттырудың кілті болып табылады. Қазақстанда медициналық білім берудің болашағы осы инновациялық тәсілдерді тиімді пайдалану арқылы анықталады.

Инновациялық тәсілдер мен жаңа технологияларды енгізу, білім беру жүйесін жаңғырту, және студенттердің практикалық дағдыларын дамыту — бүгінгі күннің басты талаптары. Болашақта медицина мамандарының біліктілігін арттыру үшін бірігіп жұмыс жасау қажет.

Әдебиеттер тізмі:

1. Кузнецова, Н. И. (2022). Медицинадағы жаңа білім беру технологиялары. Алматы: Медицина.
2. Алексеев, П. В. (2021). Интерактивті оқыту: теория мен практика. Нұр-Сұлтан: Ғылым.
3. Багданова, Т. А. (2023). Цифрландыру және медицина. Астана: Білім.
4. Жұмаділова, С. К. (2020). Болашақ медицина мамандарын даярлаудағы инновациялар. Шымкент: Оқу баспасы.
5. Shulman, L. S. (2020). Teaching as community property: Essays on higher education. Jossey-Bass.
6. Cook, D. A., & Triola, M. M. (2021). Virtual patients: A critical literature review and a plea for a new generation of learning resources. Medical Education, 55(10), 1125-1135.
7. Bhargava, S., & Kaur, S. (2022). Innovations in medical education: A systematic review. Journal of Medical Education and Curricular Development, 9, 23821205211065715.
8. Thistlethwaite, J. E., et al. (2023). Interprofessional education: A review of the evidence. Medical Education, 57(4), 309-320.

ISBN 978-601-08-0758-7

ЖАСТАР АРАСЫНДА ТҰТЫНАТЫН ЭЛЕКТРОНДЫ ТЕМЕКІНІҢ АДАМ ОРГАНИЗМІНЕ ӘСЕРІН БАҒАЛАУ ТУРАЛЫ МЕЙІРГЕРДІҢ РӨЛІ

Дастан Азамат Асылханұлы
Қызылода медициналық жоғары колледжі, оқытушы

Аннотация: *Бұл мақалада электронды темекінің жастар арасында танымал болуының негізгі себептері, сондай-ақ оларды тұтынудың жас ұрпақтың физикалық және психикалық денсаулығына әсері қарастырылады. Сондай-ақ, қоғамдық денсаулықты қорғау мақсатында жастар арасында электронды темекінің таралуын тежеудің ықтимал стратегиялары мен шаралары талқыланады.*

Электронды темекіні жастар арасында қолдану XXI ғасырдағы әлемнің көптеген елдерінің денсаулық сақтау жүйесінің ең өзекті проблемасы болып табылады.Әлемдік статистикаға сәйкес, жастар арасында кеңінен таралып, қазіргі таңның өзекті мәселелерінің біріне айналған бұл өнімнің қаншалықты зиян екені көпшілікке мәлім болса да, оны қолдануды әліде тоқтата қоймады. Дүние жүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтері бойынша, темекі шегу салдарынан әлемде 8 миллион адам қаза табады, соның ішінде 7 миллионы темекі шегеттін немесе бұрын тасап кеткендер. Ал темекі өнімін қолданатындардың саны-1,2 миллион. 2019 жылы электронды темекі қолданатындарға зерттеу жүргізгенде 1% пайызға ғана төмендеген, айтта кететін бір жағдай, бұл ер азаматтар арасында қолдану азайған, керсінше әйелдер мен жасөспірімдер арасында электронды темекіні қолдану көбейген.[1]

АҚШ әлемдегі ең үлкен электронды темекіні қолданатын, нарықтың көзі болып табылады. Жастар арасында электронды темекіні пайдалану жиі кездеседі, пайдалану қарқыны 2011 жылы 1,5%-дан 2018 жылы 20,8%-ға дейін өсті. 2018 жылы Ішкі аурулар жылнамасына сәйкес, әрбір 20 американдық күн сайын электронды темекіні пайдаланды. Америка Құрама Штаттарында 2016 жылдан бастап 18 жасқа толмаған жасөспірімдерге сатуға тыйым салды, бірақ соған қарамастан,2020 жылғы зерттеуге сәйкес, 3,6 миллион мектеп оқушылары электронды темекіні тұрақты пайдаланушылыр болып табылды. Осындай көңіл көншітеттін статистикаға байланысты 2019 жылы сату жасы 21 жасқа дейін көтерілді. Сонда да АҚШ-та жастар арасында электронды темекіні кеңінен қолдануда.[2]

Темекі өндірісін жақсы қарқынмен дамытып отырған АҚШ-та темекі құмарлардың қатарынан. АҚШ аурулардың алдын алу және бақылау орталықтарының мәліметінше, еркектердің 25,6 миллионы (25,2%), әйелдердің 22,6 миллионы (20,7%) темекі өнімдерін қолданады.

ISBN 978-601-08-0758-7

Еуропада 2016 жылы зерттеуде Еуропалық Одақта 7,5 миллион электронды темекі тұтынушы болған. Еуропалық Одақтағы электронды темекінің айтарлықтай үлесі Ұлыбританияда шоғырланған. 2019 жылы тұрақты электронды темекі қолданушылар саны 3,6 миллионға жетті. 2018 жылы британдықтардың 2%-ы электронды темекіні күн сайын қолданған. 2014 жылы Францияда 1,1 миллионнан 1,9 миллионға дейін адам кем дегенде электронды темекіні күн сайын қолданған. Ал 2019 жылы 7,7 миллионнан 9,2 миллионға дейін адам кем дегенде бір рет қолданған. Францияда 90%-дан астамы шылым немесе электронды темекіні қолданады немесе қолданып көреді.[3]

Ресейде 2016 жылы жүргізілген зерттеулерге сәйкес, респонденттердің 3,5%-ы электронды темекіні үнемі қолданады. Электронды темекіні 24 жасқа дейінгі жастар арасында ерекше танымал болған, электронды темекіні пайдаланатындар 9,7% құрады. 2016 жыл мен 2022 жылдар аралығында салыстыру мен зерттеулерге сүйенсек 72,9%-ға өскен.[4]

Қазақстандажасөспірімдердің5,8%-ы электронды темекіні тұтынатындар. Әсіресе 13 жастан 15 жасқа дейінгі ер балалар. Қазір бұл көрсеткіш екі есеге өскен. 2018 жылы жүргізілген зерттеулерге қарағанда 2022 жылы ұлдармен қатар қыздар да жейі қолдана бастаған. 2018 жылға қарағанда 2022 жылы 1,2%-ға өскен жастар арасында электронды темекіні қолдану. Шылым шегу көрсеткіші бойынша Қазақстан әлем бойынша 127 елдің ішінде 41 орында тұр. Елімізде әрбір 10 әйелдің бірі және әрбір 10 ер адамның төртеуі шылым шегеді. Елімізде темекі қолданатын ер адамдардың қатары көп. Электронды темекі қолдану көрсеткіш бойынша Қазақстан 31 орында тұр. Темекі қолданатын әйелдердің көрсеткіші бойынша 61 орында. Яғни Қазақстандағы әйелдердің 9,3%-ы темекі өнімін қолданады. 2021 жылы қаңтар мен шілде аралығында Қазақстанда 8,7 миллиард сигарет, папирос, электронды темекі және темекі алмастырғыштар, өзгеде бұйымдар шығарылған. Ақшалай мәнде елімізде темекі өнімдерінің өндірісі 125,3 миллиард теңгені құрады. 2021 жылдан бастап Қазақстанда темекі бағасының жылдық динамиакасы 15,9%-ға өскен. Дүние жүзілік денсаулық сақтау ұйымы (ДДСҰ) мәліметі бойынша, жылына шылым шегу салдарынан әлемде 8 миллионнан астам адам көз жұмады. Бұл тізімде өзі шылым шекпеседе, жанындағы адамның темекісінің түтініне уланғандар да бар.[5]

Жұмыстың мақсаты: Қызылорда медициналық жоғары колледжінің студенттері арасында тұтынатын электронды темекінің адам организміне әсерін сауалнама жүргізу арқылы бағалау

Халықаралық тәжірибе.

2019 жылдың 9 тамызы мен 31 қазаны аралығында Миннесота денсаулық сақтау департаменті (MDH) 96 пациентті электронды темекі немесе темекі шегу, өнімді пайдаланумен байланысты өкпе жарақаты

ISBN 978-601-08-0758-7

(EVALI) ретінде жіктеді; басқа пациенттер жағдайды жіктеу және әсер ету үшін зерттелуде. Әңгімелескен 58 пациенттің 53-і (91%) құрамында тетрагидроканнабинол (THC) бар өнімдерді достар, отбасы мүшелері немесе жеке немесе онлайн дилерлер сияқты бейресми көздерден алғанын хабарлады.[6] Газ хроматографиясы-масса-спектрометриясын (GCMS) пайдалана отырып, MDH Қоғамдық денсаулық сақтау зертханасы (PHL) 12 EVALI пациентінен алынған THC бар 46 электронды темекіні немесе вапингті, әртүрлі ықтимал токсиканттарға, соның ішінде E витамині ацетатына талдау жасады. құрамында THC бар кейбір өнімдерде және EVALI пациенттерінің өкпе сұйықтығы үлгілерінде анықталған (1-4). E дәрумені ацетаты құрамында THC бар өнімдерге жақында қосылған компонент екенін анықтау үшін MDH 2018 жылы EVALI індеті басталғанға дейін құқық қорғау органдары тәркілеген он өнімді және 2019 жылы індет кезінде тәркіленген 20 өнімді сынады.[7] 2019 жылы 11 EVALI пациентінен алынған 24 өнімде E дәрумені ацетаты бар. MDH тексерген тәркіленген өнімдердің ішінде 2018 жылы тәркіленген ешбірінде E дәрумені ацетаты болған жоқ, дегенмен 2019 жылы тәркіленген құрамында THC бар барлық тексерілген өнімдерде E дәрумені ацетаты оң нәтиже берді. EVALI пациенттерінен алынған өнімдердің және заңсыз нарыққа арналған өнімдердің індет басталғанға дейін де, кезінде де EVALI індетінде E дәрумені ацетатының әлеуетті рөлін қолдайды; дегенмен, сыналған өнімдердің саны аз болды, және ингаляциялық E дәрумені ацетаты мен EVALI әсерінің арасындағы себепті байланысты анықтау үшін қосымша зерттеулер қажет.[8] EVALI індеті танылғанға дейін және індет кезінде айналымда болатын құрамында THC бар өнімдерді сипаттау үшін денсаулық сақтау юрисдикциялары мен құқық қорғау органдары арасындағы ынтымақтастық динамикалық нарық туралы құнды ақпарат бере алады. Бұл Миннесота нәтижелері бейресми көздерден алынған құрамында THC бар электрондық темекі немесе вапинг өнімдері туралы алаңдаушылықты көрсетеді.[9] Жергілікті жеткізу тізбегі мен саясат орталары әртүрлі болғандықтан, CDC құрамында THC бар электрондық темекіні немесе вапингті немесе бейресми көздерден алынған кез келген электронды темекіні немесе вапинг өнімдерін пайдаланбауды ұсынады. Электрондық темекі немесе вапинг өнімдерін жастар, жас ересектер немесе жүкті әйелдер ешқашан пайдаланбауы керек.[10]

Қорытынды

Көптеген адамдар электронды темекіні барлық жерде, тіпті темекі шегуге тыйым салынған жерлерде де қолдануға болатынына сенімді. Олардың дәлелі: бұл жай ғана зиянсыз бу, шәйнек сияқты, ол ешкімге зиян тигізбейді, бұл темекі түтіні емес. Бірақ олай емес. Естеріңізге сала кетейік, бу — бұл заттың газ күйі. Ал электронды темекі аэрозольді, яғни газдағы бөлшектердің суспензиясын шығарады. Және бұл үлкен айырмашылық. Аэрозольдің ұсақ бөлшектері әрдайым өкпені зақымдайды, альвеолалардың тітіркенуін, жөтелді және басқа тыныс алу проблемаларын тудыруы мүмкін.

ISBN 978-601-08-0758-7

Судан басқа, электронды темекі сұйықтығында пропиленгликоль немесе өсімдік глицерині, никотинге арналған сұйық тасымалдаушылар бар. Егер олар тамақ өндірісінде қолданылса, олар қауіпсіз деп танылады, бірақ оларды ешкім ингаляцияға қауіпсіз деп таппады. Темекі шегушінің жанында болу, егер адам дем шығаратын аэрозоль аймағына түссе, қауіпті болуы мүмкін.

Жастардың көпшілігі электронды темекінің олрдың денсаулығына кері әсерін біледі, дегенмен уақытша ләззат пен өзін-өзі көрсетуге деген ұмтылыс күшейеді, бұл мектептерден бастап жасөспірімнің денесіне электронды темекінің әсері туралы белсенді жаппай сауықтыру жұмыстарының қажеттілігін көрсетеді.

Ұсыныс

1. Колледж студенттері арасында арнай ағарту жұмыстарын жасау керек.

2. 18 жасқа толмаған балаларға электронды темекі сатуды қадағалау керек.

3.Ата-аналар арасында мектептерде, колледждерде жиналыс жасау керек.

4.Спорт және физикалық белсенділік.Физикалық белсенділікпен айналысу темекі шегуден бас тарту кезінде туындауы мүмкін стресс пен шиеліністі жеңуге көмектеседі.

5. 1-4 курстар арасында электронды темекі зияны жайлы ашақ сабақтар өту және оны бейне роликтертер арқылы көрсетіп, зиянды әдеттен аулақ болуға шақыру.

6.Қолдау көрсету. Егер темекі шегуді өз бетіңізше тастау қиын болса, мамандардың көмегіне жүгіну.

7. Салықтардың өсуін жоғарлату. Кейбір елдер электронды темекі мен вапинг сұйықтықтарын қол жетімді болмау және бақылауды күшейту үшін жоғары салық салады.

Әдебиеттер тізімі:

1. CD-ROM (MP3). Аутотренинг отказа от курения. - Москва: **Высшая школа**, **2018**. - **707** с.

2. Smoke: Всемирная история курения. - М.: Новое литературное обозрение, **2017**. - 544 с.

3. Бродач, М.М. Зоны для курения. Проектирование системы вентиляции / М.М. Бродач. - М.: АВОК-ПРЕСС, **2017**. - **960** с.

4. Воронин, А. Инструктор. Дело "Грязный табак" / А. Воронин. - М.: Современный литератор, **2018**. - **373** с.

5. Воронин, Андрей Инструктор. Дело "Грязный табак" / Андрей Воронин. - М.: Современный литератор, **2016**. - 416 с.

6. Гензель, П. Критика и библиография. М.И. Фридман: "Современные косвенные налоги на предметы потребления. Том I. Обложение спирта, сахара,

ISBN 978-601-08-0758-7

пива и табака в Германской империи" / П. Гензель. - Москва: **Гостехиздат**, **2021**. - **527** с.

7. Дальке, Рудигер Болезнь как язык души. Проблемы пищеварения. Психология курения (комплект из 3 книг) / Рудигер Дальке , Роберт Хесль , Маргит Дальке. - М.: ИГ "Весь", **2017**. - 656 с.

8. Дальке, Рудигер Болезнь как язык души. Психология курения. Через испытания (комплект из 3 книг) / Рудигер Дальке , Маргит Дальке. - М.: ИГ "Весь", **2015**. - 720 с.

9. Дальке, Рудигер Депрессия. Психология курения (комплект из 2 книг) / Рудигер Дальке , Маргит Дальке. - М.: ИГ "Весь", **2015**. - 480 с.

10. Дерво, Жан-Лу Как покончить с курением навсегда / Жан-Лу Дерво. - М.: АСТ, Астрель, **2016**. - 144 с.

11. Ермаков, С. А. Влияние интенсивности потребления табака на заработные платы в России / С.А. Ермаков. - М.: Синергия, **2020**. - **588** с.

12. Зайцев, С.Н. Зеркало для курильщика. Самоучитель отказа от курения / С.Н. Зайцев. - М.: Философская Книга, 2016. - **295** с.

13. Зиновьев, Н. Жизнь без алкоголя и табака / Н. Зиновьев. - М.: ИТРК, 2016. - **672** с.

14. Каспаревич, Андрей Верный способ избавиться от пьянства, курения, наркотиков / Андрей Каспаревич. - М.: Питер, **2019**. - 320 с.

15. Кельин, Л. Л. Как самостоятельно избавиться от курения / Л.Л. Кельин, Ю.Л. Мучник, М.С. Прусс. - М.: Нева, **2016**. - 128 с.

ISBN 978-601-08-0758-7

БОЛАШАҚ МЕДИЦИНА МАМАНДАРЫН ОҚЫТУДЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘДІСІ

Айтбаева А.О., арнайы пән оқытушысы, педагог-модератор

ШЖҚ «Түркістан жоғары медицина колледжі» МКК

Аннотация. *Бұл мақалада орта медициналық білім берудегі емдеу ісі мамандарын дайындауда оқытуда қолданылатын жаңа тәсілдер мен инновациялар қарастырылады. Жасанды интеллект пен цифрлық мүмкіндіктерді қолдана отырып, педагогтар үшін тиімді тұстарын көрсетіп, әдіс алмасуға септігімді тигізу. Жаңа әдіс-тәсілдерді қолданудың студенттер мен оқытушылар үшін артықшылықтарын талдау, саралау, қолдануға үйрету.*

Дәстүрлі форматқа қарағанда, сабақ барысында қолданылатын әдістер мен технологияларды, цифрлық техникалық құралдар көмегімен түрлендіре отырып оқытудың маңыздылығы өте жоғары.

Wix.com сайтының ерекшеліктерін қолдана отырып, сабақ жоспарына сәйкес бұл сайттың тиімділігін көрсету, дәлелдеу.

Болашақ медицина мамандарын оқытуда қазіргі тағда көптеген мүмкіндіктерге жол ашылған. Бұл мүмкіндіктер цифрлық технологиялар мен сандық білім беру жүйесінің, жасанды инлеллекттің қарқынды дамуына байланысты шарықтауда. Орта буын медицина мамандарының білімін, тәжірибесін, дағдылары мен шеберліктерін қалыптастыруда оқытушылар сабақ барысында түрлі әдіс-тәсілдерді, технологияларды қолдануда.

Жаңа әдіс-тәсілдерді қолданудың студенттер үшін тиімді тұстары:

- ✓ Студенттің пәнге деген қызығушылығын ояту;
- ✓ Әлеуметтік мәдени тәрбие қалыптастыру;
- ✓ Танымдық қабілеттерін қалыптастырады;
- ✓ Ізденушілік, зерттеушілікке баулыйды.

Жаңа әдіс-тәсілдерді қолданудың оқытушалар үшін берері:

- ✓ Оқытушының уақытын үнемдейді, қосымша ізденуге үйретеді;
- ✓ Оқу үрдісін тиімді ұйымдастыруға мүмкіндік береді;
- ✓ Барлық студенттерді оқытуға, бағалап үлгеруге мүмкіндіктер қарастырылады.
- ✓ Студенттердің қабілеттері, деңгейлеріне қарай тапсырмаларды даярлауға септігін тигізеді;
- ✓ Қосымша қашықтықтан оқытуға жағдай жасалады..

Сабақ барысында қолданылатын әдістер мен технологиялар:

• Small group learning (SGL) - шағын топтарда оқыту;

• Cased-based learning (CBL) - нақты жағдайлар әдісі;

• Team-based learning (TBL) - командада жұмыс істеуге негізделген оқыту әдісі;

ISBN 978-601-08-0758-7

• Problem-based learning (PBL) - проблемалық оқыту әдісі;
• Simulation training(ST) - симуляциялық оқыту;
• Clinical training (CT)- клиникалық оқыту;
• Training based on competence(TBC) - құзыреттілікке негізделген оқыту;
• Credit-modular training (CMT)- кредиттік-модульдік оқыту.

Жоғарыда аталған технологиялық әдістердің оқытудағы қолданылуы сабақтың өнімділігін арттырады.

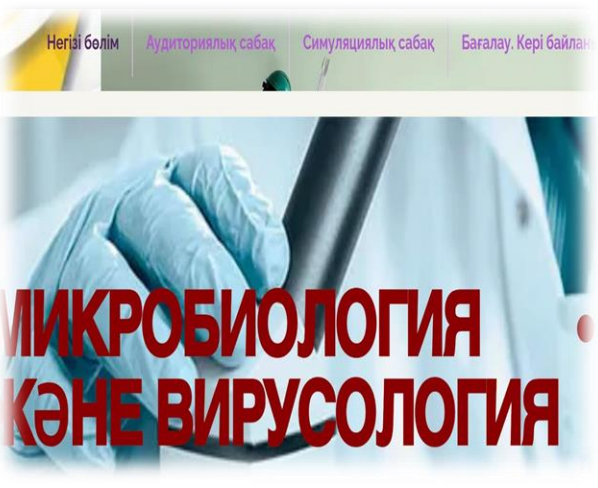
Оқытуда педагогтар үнемі ізденіс үстінде жүреді. Себебі, қазір цифрлық құрылымдар қарқынды дамуда. Студенттер де күнделікті гаджет, телефон, компьютерді тиімді тұстарына қарағанда, тиімсіз жақтарына қолдануларының үлесі басым болып отыр. Осы жайыттарды ескере отырып, түрлі платформалардың мүмкіндіктерін зерттедім. Соның нәтижесінде орта буынды медицина саласындағы емдеу ісі, мейіргер ісі мамандарын даярлауда арнайы пәндер бойынша сабақтарымды, жоспарынан бастап, барлық сабақ процесін арнайы wix.com сайтына жүктеп қойдым.

Wix.com -drag-and-drop құралдарын қолдана отырып, HTML5-те сайттар мен олардың мобильді нұсқаларын құруға мүмкіндік беретін интернет-жобаларды құру және дамыту үшін Scala - де жазылған халықаралық бұлтты платформа болып саналады. Қызмет 21 тілде қол жетімді. Wix freemium бизнес моделі бойынша жұмыс істейді, сайттарды ақысыз құруға және оларды дамытуға, пайдалы жақсартуларға қол жеткізуге мүмкіндік береді. Бизнес моделін медицина саласына бағыттау аса қиындық туындатпады. Керісінше студенттердің сабаққа деген қызығушылықтары, белсенділіктері артқандығы байқалады. Wix қолданбаларды, графиканы, видеоматериалдарды, сурет галереяларын, бейнелерді, қаріптерді және т.б. қамтитын drag-and-drop принципі бойынша жұмыс істейтін жүздеген шаблондады, веб-сайт үлгілерін және HTML5 редакторын ұсынады. Шаблондар арқылы: жаңа мүмкіндіктер мен медиалар қосылады, стиль, түстер, мәтіндер, фондық суреттер, түймелер және т. б жұмыс жасауға жол ашады. Сонымен қатар, пайдаланушылар өздерінің веб-сайттарын нөлден бастап құру мүмкіндігіне ие.

Негізгі сайтты қазіргі таңда орта буынды медицина мамандарын оқытуда өз мүмкіндігіме қарай қолданамын, себебі оқытуда сайттың тиімді тұстары мен артықшылықтары ұшан теңіз. Студенттерге тек сілтеме жіберіледі, бір ғана сілтеме арқылы жаңа тақырыпты сабақта меңгеріп шыға алады. Пәннің оқу жұмыс жоспары, күнтізбелік-тақырыптық жоспары, оқу сабағының жоспарлары, электронды түрдегі оқулық, презентациялар, видеороликтер, сабақ барысында орындалатын тапсырмаларды студенттер толығымен көруге, орындауға, жүктеп алуға мүмкіндік алады.

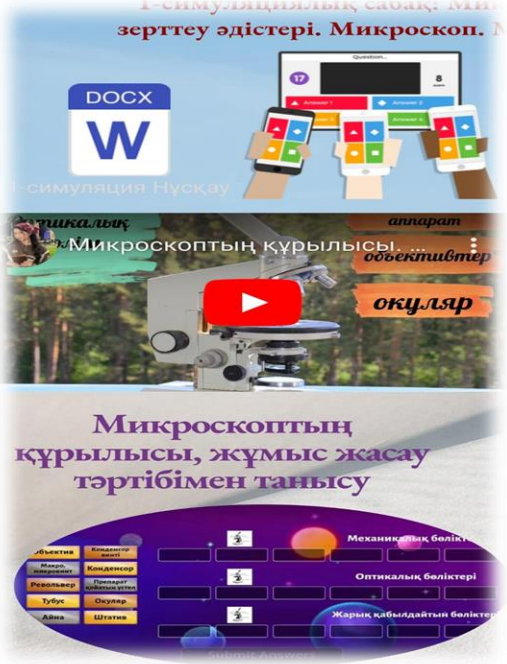
09120100 – "Емдеу ісі" мамандығы, 4S09120101 – "Фельдшер біліктілігі бойынша II курс студенттеріне ЖКП-02 инфексімен Микробиология және вирусологогия пәні өтіледі. Жоғарыдағы аталған пән бойынша сабаққа қажетті материалдарды Wix.com платформасына жүктеп қойғанмын. Назарларыңызға осы пән бойынша мүмкіндіктерді ұсынамын.

ISBN 978-601-08-0758-7





Халықаралық бұлтты платформаны қолданудағы мақсатым студенттердің пәнге деген қызығулықтарын арттыру, игерген дағдыларын бағалау талдап, саралауға икемдеу. Жағдаяттық тапсырмалар бойынша топтардың дайындығын қадағалау, іс-әрекет машықтарын көрсетеді, дағдыларды орындайды. Әрбір студенттің жұмыс нәтижелерін талқылап, оң және теріс жақтарын көрсетіледі. Тәжірибелік дағдылар мен тапсырмалардан кейін міндетті түрде бекіту тапсырмаларын орындатамын. Тапсырмалар Wordwall, learningapps.org, **joyteka.com, quizizz.com, Superkid.onlin,** Kahoot, lumio, google.forms, https://nearpod.com/ электронды платформаларында жасалады.





Студент оқу бағдарламасын аяқтағанда микробиологиялық зертханада сақтану, патологиялық зерттеу материалын жинау ережелерін білу, микроағзаларды дақылдау, таза дақылын алу, бояу әдістерін. макроденені микроденеден қорғау механизміне негізделген залалдандыру, зарарсыздандыру жұмыстарын жүргізуге, патогенді қоздырғышты бірегейлеуді, ҚР денсаулық

ISBN 978-601-08-0758-7

сақтау министрлігінен берілетін бұйрық, нұсқауларды қолдана білуді меңгеріп шығады.

Қорытынды: Бүгінде цифрландырудың жетістіктерінің арқасында әлем бейнесі өзгеруде, адамзат өмірінің барлық салалары қарқынды даму үстінде. Медицина саласында жаңа қызмет түрлері, жаңа технологиялар, түрлі сайттар мен платформалардың пайда болғандығы қазіргі орта буын студенттерін даярлауда өте тиімді болып отыр. Бұл өзгерістер, бір жағынан, оған қойылатын талаптарды белгілейді, ал екінші жағынан, білім беру үрдісінің үздіксіздігін қамтамасыз ететін дамудың қосымша мүмкіндіктерін ұсынып отыр.. Сабақ барысында тәжірибелік дағдыларды игере отырып, оқытудың жаңа тәсілдері арқылы студенттердің пәнге деген қызығушылығы, логикалық ой-өрісі, ғылыми ізденісі, дербес пікірін қалыптастыра отырып, кәсіби қабілеттері дамиды.

Жаңа технологияларды қолдану оқу процесін сапалы түрлендіруге, жаңашыл жобаларды енгізуге, оны тиімді басқаруға негіз болып, әрбір оқытушыға өзінің әдістемелік жүйесін құруға септігін тигізеді. Сондықтан қазіргі кезеңде оқытудың инновациялық технологияларын оқыту орындарының білім беру саласына ендіру- қоғам талабы.

Әдебиеттер тізімі:

1.Жаңа педагогикалық технология. Қ.Ж Бұзаубақова Алматы 2004 21-бет

2.Инновациялық технологияларды педагогикалық процесте пайдаланудың тиімділігі. Ш.О.Еспанбетова, Г.Т. Қожагелдиева.

3.«Мұғалімнің шығармашылық әлеуетін біліктілікті арттыру жағдайында дамыту: теория және тәжірибе». Б.А. Тұрғынбаева – Алматы, 2005.

4.Цифрлық технологиялар: сабаққа қажетті қолданбалы және онлайн сервистер.

ISBN 978-601-08-0758-7

LESSONS STUDY ӘДІСІНІҢ ЗЕРТТЕУ ӘДІСІ РЕТІНДЕ КЕМШІЛІКТЕРІ МЕН АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ АРНАЙЫ ПӘНДЕР САБАҒЫНДА

Акбергенова Жанна Калибековна , Жиеналина Бакыт Аиповна
Астана қаласы әкімдігінің« жоғары медициналық колледжі» ШЖҚ МКК

Аннотация: *Оқытушылардың жұмыстағы кәсіби дамуы тұрақты және медициналық колледждің моделін қажет етеді, бұл оларға әлеуетті арттыру мен педагогикалық жетілдіруді қолдайтын орта құруда ынтымақтастық жасауға мүмкіндік береді. Кәсіби дамудың бұл моделінде оқытушы оқу процесінде орталық болып саналады, бұл оларға өздерінің жетілдірілуін сыни бағалауға қатысуға мүмкіндік береді.*

Lessons study- бұл оқытушы мен студенттердің оқуы мен дамуы туралы жинаған дәлелдерін пайдалана отырып, зерттеу сабақтарын бірлесіп әзірлейтін және оқуды жақсартатын кәсіби дамудың бір түрі.

Мақсаты:Lessons study әдісінің кемшіліктері мен артықшылықтарын анықтау.

Кілт сөздер: Lessons study, Learning, Education, Teaching.

Зерттеу барысы: Lessons study жапондық "djugyou kenkyuu" терминінің аудармасы болып табылады және Жапония оқу орнындарының 90% - дан астамында қолданылатын кәсіби зерттеу әдісі болып табылады (National Education Policy Research Institute 2011). Сабақты зерттеу кейде бірінші кезекте сабақты жоспарлауға назар аудару ретінде қате түсіндірілгенімен, ол циклдік әрекеттің төрт кезеңінен тұрады. Жапонияда сабақты үйрену циклдары әдетте оқу орнындығы ынтымақтастық аясында өтеді. Оқу орнындағы сабақ топтары студенттердің ұзақ мерзімді мақсаттарын және осы мақсаттарға қалай жетуге болатыны туралы тексерілетін идеяларды көрсететін зерттеу тақырыбы бойынша білім құратын және алмасатын сабақтарды зерттеу (Takahashi and McDougal 2016). Кейбір көрнекті зерттеушілер сабақты зерттеудің алты кезеңін анықтайды (Fujii 2016; Takahashi and McDougal 2016), басынан бастап мақсат қоюға баса назар аудару және сабақтан кейінгі талқылау мен кейінгі оқу туралы ойлауды бөлу үшін, бірақ біз қарапайымдылықты таңдағанды жөн көреміз.

Сабақты жүзеге асырудағы жалпы кедергілер

Lessons study студенттерге тікелей пайда әкелетін кәсіби дамудың тиімді түрі болғанымен, оны қашан және қалай жүзеге асыру керектігі туралы шешім қабылдамас бұрын оқу орнының басшылары қарастыруы керек сабақтарды үйренудің кейбір қиындықтары бар. Жалпы проблемаларға мыналар жатады:

1. Оқытушылардың Ауыр Жұмыс Жүктемесі

Оқытушы мамандығы жоспарлау, бағалау, есеп жазу, сабақтан тыс жұмыстар және студенттерге рухани қолдау көрсетуді қамтитын жоғары жұмыс жүктемесімен танымал.

Сабақты үйрену оқытушының жұмыс жүктемесін сөзсіз арттырады және оны бір уақытта кем дегенде үш оқытушы жасайды. Әсіресе, оқу жылының ең

ISBN 978-601-08-0758-7

қарбалас кезеңдерінде оқытушылар мұны жұмыс жүктемесіне қосуға мүмкіндігі бар сияқты сезінбеуі мүмкін.

Уақыт шектеулері

Сабақты үйренудің бір циклін өткізуге кететін жалпы уақыт шамамен үш сағатты құрайды: жоспарлауға бір сағат, жеткізуге бір сағат және ойлануға бір сағат.

Дегенмен, әр сабаққа үш-бес қызметкер қатысады және олар қол жеткізген нәтижеге қанағаттанбас бұрын кем дегенде үш циклды аяқтауы мүмкін.

Әрбір қатысушы оқытушы сабаққа қатысуға кемінде 9 сағат жұмсайды деп күтуі мүмкін; көптеген оқытушылар үшін бұл уақыт міндеттемесі тым көп деп саналуы мүмкін.

Қаржылық салдары

Сабақты аяқтау үшін оқытушылар тобы құрылғаннан кейін оларға жоспарлау, бақылау және ойлау үшін бірге уақыт қажет болады.

Бұл әдетте бір немесе бірнеше оқытушылардан бүкіл командаңы бір уақытта еркін ұстау үшін сабақты қамтуды талап етеді.

Көптеген оқу орындарында сабақты қамтамасыз етуге немесе жабуға байланысты шығындар болады. Сабақты толық оқу үшін қажетті қамту көлемі бес оқытушыдан тұратын бір команда үшін оқу жылы ішінде 36 сағатқа дейін болуы мүмкін.

Басшылықтың қолдауы

Егер сабақты оқу процесін оқу мекемесінің басшылығы қолдамаса, оқытушылар іс-әрекетті зерттеу циклдерін сәтті жүргізе алмайды. Көшбасшылар қамтамасыз етуі керек:

- Зерттеуді қалай жүргізу керектігін алдын ала үйрету
- Жоспарлау және рефлексия жиналыстарын өткізу үшін басқа міндеттерден тыс уақыт
- Сабақтың мұқабасы, ал оқытушылар бір-бірін бақылай алуы
- Оқытушылар тобы анықтайтын ресурстар немесе жабдықтар
- Сабақты үйрену барысында туындайтын жаңа идеялар мен бастамаларды қолдауға дайын болу

Сабақты үйренудің артықшылықтары

Студенттерге арналған сабақтың артықшылықтарын тек бір сабақтан кейін көруге болады. Студенттерге бағытталған фокус жаңа оқу материалдары мен бірлескен оқыту тәсілі студенттердің үлгерімін өте тез жақсартатынын білдіреді.

Сабақ циклінің мақсаты оқытуды жақсарту болып табылады және үш-бес оқытушының ұжымдық білімін пайдалану оқытудың тиімділігіне үлкен әсер ету үшін сыныптағы тәжірибені шағын өзгертудің өте тиімді әдісі болып табылады.

Сабақтарды үйрену оқытушыларға салыстырмалы түрде аз уақыт жұмсай отырып, мағыналы кәсіптік білім беру арқылы пайдалы. Оқытушылардың кәсіби даму бастамаларына қатысты ең үлкен сындардың бірі-олар тиімді болу үшін тым жалпы.

ISBN 978-601-08-0758-7

Сабақты үйрену бұл сыннан зардап шекпейді, өйткені ол контекстке тән; бір мекемедегі әріптестер өздері анықтаған нақты мәселені шешу немесе оқушылардың белгілі бір тобын тарту үшін бірге жұмыс істейді.

Оқытушылар тобы құрған ұжымдық оқыту басқа шарттармен жақсы қарым-қатынас жасамауы мүмкін, бірақ бұл олардың нақты студенттер тобымен тәжірибесіне үлкен әсер етеді.

Әріптестер бір-бірімен ынтымақтаса отырып, олар өзін-өзі тиімдірек сезінеді, жаңа білім беру идеяларын жасайды және оқыту саласындағы бар сенімдерге қарсы тұрады.

Олар сондай-ақ зерттеу жүргізуді, өз тәжірибелері туралы ойлануды және сабақ циклдары аяқталғаннан кейін де әріптестерімен педагогикалық пікірталастар өткізуді үйренеді.

Студентке Бағытталған Фокус

Lessons study кереметтілігі-әр кезеңде ол студентке бағытталған. Бұл студенттердің қалаған оқу мақсаттарын анықтаудан, содан кейін ең қолайлы оқыту стратегияларын анықтаудан және соңында олардың студенттерге әсерін бақылаудан басталады.

Әрбір циклды бақылау кезеңінде мұғалімдер болашақ жоспарлау туралы хабардар ету үшін оқушылардың оқу дәлелдерін жинайды. Бұл студенттердің жауаптарын, студенттердің қатысуын және сабақтың соңына дейін жасалған жұмыс сапасын мұқият зерттеуді қамтиды.

Рефлексия кезеңі оқыту мен оқуды бағалау болады.

Lessons study студенттерге фокус-топтар, студенттік сауалнамалар және сұхбаттар арқылы студенттердің пікірлерін жинау арқылы студенттерге бағытталған болуы мүмкін. Олар сондай-ақ зерттеу циклдарын жоспарлау кезеңінде белсенді қатысушы бола алады немесе сабақтарды бақылау үшін оқытушымен ынтымақтаса алады.

Қорытынды: Бұл зерттеу LS-ті зерттеу әдісі ретінде артықшылықтары мен кемшіліктерінің мысалы болып табылады. Біз LS мұғалімдердің педагогикалық және дидактикалық білімі мен тәжірибесін және білім беру зерттеу қауымдастығының теориялық білімін біріктірудің перспективалық тәсілі деп санаймыз және осылайша теориялық зерттеулер мен білім беру практикасы арасындағы алшақтықты жоюға ықпал ете алады деп санаймыз.

Әдебиеттер тізімі:

1 Информационно-методический журнал Педагогический журнал №2 (4), 2013.

2 Пит Дадли. Lesson study: руководство. www.lessonstudy.co.uk

3 www.uwlax.edu

4 Шульман Л. Эффективное преподавание, 2007.

5 Булатбаева К.Н. Монография «Функционально-коммуникативная технология обучения русскому языку в казахской школе». -Павлодар: ПГУ, 2005.

ISBN 978-601-08-0758-7

«МЕДИЦИНАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДІ ЖАҢАРТУДАҒЫ ЖАҢА ТӘСІЛДЕР МЕН ИННОВАЦИЯЛАР».

Андакулова Куралай Тлеулесовна
директордың оқу-өндірістік жұмысы жөніндегі орынбасары
Сайлаубаева Назерке Нұрланқызы
«Мейіргер ісінің негіздері» пәнінің оқытушысы.
Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы «Жамбыл жоғары медициналық колледжі» ШЖҚ КМК

Аннотация: *Қазіргі уақытта Қазақстанда білім берудің өзіндік ұлттық үлгісі қалыптасуда. Заман ағысына сай технологияларды қолдану ауқымы, түрлері өзгеріп отырады. Бірақ ең бастысы технологияларды тиімді, жүйелі қолдану керек. Республикада оқыту мазмұны жаңартылып, жаңа буын оқулықтарының негізінде жасалған бағдарламалар оқытудың жаңа жүйеге көшуін, әрбір мұғалімнен жаңаша жұмыс істеуін, батыл шығармашалық ізденісін, студенттердің белсенділігі мен қызығушылығын арттыруды талап етеді. Сондықтан, мұғалім өз білімін жан-жақты жетілдіре отырып, студенттерді қызықтырып оқыту керек.*

«Елімізде жыл санап мемлекеттік медициналық мекемелердегі дәрігерлер мен орта буын медицина қызметкерлері саны өсуде. Бірақ, сонда да әлі күнге дейін маман тапшылығы байқалады. Медициналық білім беру саласы әрқашан қоғамда ерекше көңіл аударатын, маңызды әрі өте жауапты сала болып қала бермек. Қазақстан медицинасы жайлы сөз қозғағанда мамандарды дайындайтын медициналық кәсіптік орта және жоғары оқу орындары туралы сөз қозғамау мүмкін емес. Медицинаның дамуы, алға жылжуы – медициналық білімнің ілгері дамуымен тікелей байланысты. Медициналық оқу орындарының тарихы — еліміздің тарихының, Қазақстанның денсаулық сақтау саласының қалыптасу жолының айнасы болмақ.

Өзектілігі: Келер ұрпаққа қоғам талабына сай тәрбие мен білім беру үшін инновациялық іс-әрекеттің ғылыми-педагогикалық негіздерін қолданудың маңызы.

Қазіргі уақытта Қазақстанда білім берудің өзіндік ұлттық үлгісі қалыптасуда. Заман ағысына сай технологияларды қолдану ауқымы, түрлері өзгеріп отырады. Бірақ ең бастысы технологияларды тиімді, жүйелі қолдану керек. Республикада оқыту мазмұны жаңартылып, жаңа буын оқулықтарының негізінде жасалған бағдарламалар оқытудың жаңа жүйеге көшуін, әрбір мұғалімнен жаңаша жұмыс істеуін, батыл шығармашалық ізденісін, студенттердің белсенділігі мен қызығушылығын арттыруды талап етеді.

Мемлекеттік білім стандарт деңгейінде оқыту үрдісін ұйымдастыру жаңа педагогикалық технологияларды ендіруді міндеттейді.

ISBN 978-601-08-0758-7

Студенттерге нәтижелі үйрету үшін оны оқыту әдістемесін жетілдіру – бүгінгі күннің басты мәселесі.

Білім берудің инновациялық технологиясы – бірыңғай мақсатпеп біріккен және оқыту мен тәрбиелеудегі инновациялық технологияларды қамтыған, оқыту, тәрбиелеу және басқару түрлерінің, әдістері мен оқу құралдарының жиынтығы, оқытудың инновациялық технологиялары – нәтижесінде оқу процесіне деген ішкі себептің қатынасы анағұрлым жақсаратын, тұлғалық бағытталған, кіріктірілген, ақпараттық, қашықтықтық, дамытушылық, модульді дамытушылық технологиялар жетекші орын алады.

Бұл жүйенің басты компоненті – оқыту мақсаты. Ол мақсат өздігінен дамуға ұмтылатын жеке тұлғаны қалыптастыру, сондықтан оның өзіндік танымдық іс - әрекеті белгілі бір дәрежеде белсендірілуі қажет. Мұнда бірінші орында білім алушы тұрады және оның өз бетімен білім алудағы белсенділігіне баса назар аударылады. Оқытудың фронтальды түрі – бағыт беру, талқылау және түзету енгізуде ғана пайдаланылады. Технологияландыру процесін іс жүзінде модульдеп оқыту арқылы да жүзеге асыруға болады. Келер ұрпаққа қоғам талабына сай тәрбие мен білім беру үшін инновациялық іс-әрекеттің ғылыми-педагогикалық негіздерін меңгеру маңызды мәселе болып табылады. Келер ұрпаққа қоғам талабына сай тәрбие мен білім беру үшін инновациялық іс-әрекеттің ғылыми-педагогикалық негіздерін қолданудың маңызы зор.

Жамбыл жоғары медициналық колледжінде болашақ медицина мамандарын оқытудағы жаңа тәсілдер мен инновацияларды қолдану толықтай жүзеге асырылады. Колледж Жамбыл облысының денсаулық сақтау саласы тәжірибесінің сұранысын қанағаттандыра алатындай барлық мамандықтарды дайындауда облыстың әлеуметтік-экономикалық дамуына үлес қосып келеді.

Колледж педагогикалық ұжымының алға қойып, жұмыс жүргізген әдістемелік мәселелері: «Білім беру бағдарламаларын жүзеге асыруды ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету», «Оқу үрдісінің инновациялық технологияларын, әдістерін, түрлерін жетілдіру және жаңа технологияларды даярлау, енгізу», «Ұстаздың шығармашылық ойлау қабілетін дамыту, білім беру қызметкерлерінің біліктілігін көтеру және шеберлігін арттыру, педагогикалық ұжымының ғылыми-әдістемелік потенциалын жетілдіру» болып табылады.

Орта буын медицина мамандарын даярлауда, олардың кәсіби шеберліктерін шыңдап, біліктіліктерін арттыру мақсатында студенттерімізге сабақты әр түрлі құрал-жабдықтармен, манекендермен, муляждармен, фантомдармен, аппараттармен, стендтермен, плакаттармен қазіргі заман талабына сай жабдықталған кабинеттерде өтеміз.

Студенттерді ғылыми-зерттеулерге ынталандыру, олардың кәсіптік іскерліктерін дамыту, білімдері мен дағдыларын тәжірибеде қолдану мақсатында колледжде пән үйірмелері қызмет атқарады. Болашақ мамандығына деген сүйіспеншілікті арттыру мақсатында және диплом алды тәжірибеге дайындық ретінде колледжде жылда дәстүрлі «Үздік фельдшер», «Үздік акушер», «Үздік мейірбике» және «Үздік фармацевт» байқаулары жоғары деңгейде өткізіледі.

ISBN 978-601-08-0758-7

Студенттерді ғылыми-зерттеулерге, білімдері мен дағдыларын қолдануға, өз мамандығына қызығушылығын арттыру мақсатында колледжімізде елімізге еңбегі сіңген, тәжірибесі мол білікті мамандармен семинарлар мен кездесулер өткізіліп тұрады.

Келешек ұрпақтың сапалы білім алуы – олардың білім алып жатқан оқу орны мен сол жердегі ұстаздардың кәсіби шеберліктеріне тікелей байланысты. Сол себепті біздің колледж оқытушылары инновациялық оқыту әдістерін сабақ өткізу барысында үнемі қолданады. Инновациялық оқыту әдістері студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыруды, ситуациялық есептерді теориялық және тәжірибелік сабақтарда қолдануды, болашақ орта буын медициналық қызметкерлерінің шығармашылық қабілеттерін қалыптастыруды, оның білім алуға ынтасын оятуды арттыра түседі. Сабақта қолданған ақпараттық-коммуникациялық технологиялар студенттің өз мамандығына қызығушылығын оятып, мамандық сапасын арттырып, еңбек нарығында бәсекеге қабілетті мамандар даярлауды қалыптастырады.

Қазіргі таңда колледжде «Емдеу ісі» мамандығы бойынша біліктілігі «Фельдшер», «Акушер», «Мейірбике ісі» және «Фармация» және «Қолданбалы бакалавр» мамандықтарын даярлайды.

«Мейіргер ісі» бөлімінің алға қойған мақсаты – жаңа педагогикалық технологияларды оқу процесіне еңгізе отырып, мейірбикелік үрдісті ұйымдастыра білетін, сапалы білімді, саналы тәрбиелі, еңбек нарығына сәйкес бәсекеге қабілетті орта буын медицина мамандарын-медбикелерді даярлау.

«Мейіргер ісінің негіздері» пәні тәжірибелік дағдыларды үйретететін ең маңызды клиникалық пәндердің бірі.

Оқу кабинеттері санитарлық жабдықтау, техникалық қауіпсіздік талаптарына сай құрылып, оқу жоспарына сәйкестелінген. Клиникаға дейінгі және тәжірибе сабақтары өтетін кабинеттер(әлеуметтік оңалту, микробиология, оқу дәріханасы, фитобар, фармакогнозия зертханасы, паллиативті көмек, оқу-симуляциялық орталық, гинекологиялық зал, виртуалды кеңістікте тәжірибелік дағдыларды қабылдау кабинеті және т.б) көптеген медициналық манипуляцияларды орындауға арналған заманауи тренажёрлармен, медициналық аспаптармен, құралдармен және жаңа технологиялармен жабдықталған. Студенттердің теориялық білімдерін клиникалық тәжірибеде қолдана білуге және клиникалық ойлау қабілетін, зерделілік қасиеттерін жетілдіруге, науқаспен қарым-қатынас жасауда медициналық этика және деонтология қағидаларын сақтай отырып, коммуникативтік дағдыларды колдануды дамытады. Өз мамандығына сүйіспеншілік сезімдерін арттырады, өз ісіне тиянақты, ұқыпты және жауапкершілікпен қарауға, заман талабына сай жан-жақты дамыған маман иесі болуға теориялық білімдерін және тәжірибелік дағдыларды меңгеруін симуляциялық орталықта клиникалық есептерді қолданып, манекен және муляждарда парентеральды жолмен дәрі енгізулерді, мән-жайлық есептерді қолдану арқылы үйренеді.

ISBN 978-601-08-0758-7

Колледждің болашақ бітірушілері бүгінде жылдам өзгеріп отырған қоғамдық, ғылыми-тәжірибелік жаңалықтарға ілесе алатын, кәсіби біліктілік пен дағдыларды меңгеріп, оқу үдерісі барысында алған білімін кәсіби қызметінде пайдалана білетін маман ретінде дайындалуда. Студенттердің меңгеріп шыққан білімі мен тәжірибе дағдыларының сапасын анықтау мақсатында бағалау жүргізіледі.

Білімді және дағдыларды бағалау білім беру ұйымдарының жұмыс сапасын және білім алушылардың дайындығын бағалау болып табылады.

Білімді және дағдыларды бағалау екі кезеңнен тұрады: бірінші кезең теориялық тестілеу, екінші кезең тәжірибелік дағдылар. Тәжірибелік кезеңді тапсыру үшін студенттер 5 станцияда берілген тапсырмаларды орындайды:

1. Коммуникативтік дағдылар
2. Анафилаксиялық шок кезінде медициналық көмек көрсету (ауруханаға дейінгі)
3. Емшаралық дағдылар
4. Жүрек кенеттен тоқтаған кезде медициналық көмек көрсету (ауруханаға дейінгі)
5. Жарақаттарға (ауруханаға дейінгі) медициналық көмек көрсету

Колледж оқытушылары болашақ медицина мамандарын тәуелсіз бағалауға жаңа тәсілдер мен инновацияларды қолдана отырып дайындайды.

Болашақ медицина қызметкерлері жоғары тәжірибелі, науқастармен тиімді жұмыс атқаратын топ мүшелерімен сапалы медициналық көмек көрсете алатын мықты және болашағы бар салада жұмыс істейтін заманауи маман ретінде болуы керек.

Қорытынды: «Денсаулық сақтаудың ұлттық жүйесін ұзақ мерзімді жаңғырту аясында біз елдің барлық аумағында медициналық қызметтер сапасының бірыңғай стандарттарын енгізуге, сондай-ақ медицина мекемелерінің материалдық-техникалық жабдықталуын бірыңғайландыру тиіспіз» Денсаулық сақтау мамандарын дайындау озық дамуда болуы қажет. Денсаулық сақтаудың кадрлық ресурстарын дайындаудың басты постулаттарының бірі – «өмір бойы білім алу» болып табылады, бұл медицина қызметкерлерінің өз білімін үнемі жетілдіріп, жаңартып отыру қажеттілігін тудырады. Денсаулық сақтау саласы мамандарының да кәсіптік құзыреттілігіне қойылатын талаптардың артуы жағдайында білім беру процесіне басқару ұйымдарынан бастап білім алушыларға дейін қатысушылардың жауапкершілігі артып келеді. Жоғары медициналық білім берудегі құзыреттілік тұрғының қажеттілігі қазіргі замандағы қоғамды сипаттайтын әлеуметтік-экономикалық, саяси, рухани-адамгершілік өзгерістермен анықталады. Бұл өзгерістер білім берудің осы саласының соңғы нәтижесінің жаңа сапасы – жоғары медициналық білім беру ұйымдарындағы білім алушылардың кәсіптік құзыреттілігіне қол жеткізу талабын қойып отыр. Осы жағдайда құзыретті медицина мамандарын дайындау мәселесі өзекті мәселелердің бірі болып табылады, өйткені халық

ISBN 978-601-08-0758-7

денсаулығын қорғау еліміздің еңбек потенциалын сақтаудағы басты бағыттардың бірі болып табылады.

Еліміздің денсаулық сақтау саласы қарқынды даму кезеңін бастан өткеруде, жаңа клиникалар салынып, заманауи жабдықтар қолданысқа берілген. Дегенмен, медицина сапасын қамтамасыз етуде басты тұлға болып дәрігер, медбике, олардың кәсіби білімі мен білігі болып қалмақ.

Әдебиеттер тізімі:

1. http://zhardem.kz/news/6979-Бахрушина Л. А.\ 20.02.2020
2. Амиров Н. Медицинская газета, 19.11.2021.6.
3. http://bilim-all.kz/article/4510-Qazaqstandagy-meditsinalyq-universitetter-mektep-tulekterin-qabyldamauy-mumkin, Мусаев А. Е. 20.06.2019
4. http://primeminister.kz/kz/news/10/mezhdunarodnye-eksperty-obsudjat-perspektivy-nepreryvnogo-professionalnogo-obrazovanija-meditsinskih-kadrov-rk Усманова Г. М., 19.04. 2020
5. **«Клиническая медицина Казахстана»**, редактор А.К. Байгенжин, 2021 год, 30 стр. **kz**
6. http://dhmc.zhambyl.kz/

ISBN 978-601-08-0758-7

НОВЫЕ ПОДХОДЫ И ИННОВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ БУДУЩИХ МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Досхожаева А.К., преподаватель специальных дисциплин, педагог-модератор

ГККП «Аркалыкский медицинский колледж»

Аннотация: *в докладе рассматриваются современные методы и инновационные подходы в обучении будущих медицинских специалистов. В условиях стремительного развития медицинских технологий и изменяющихся требований к квалификации кадров, образовательные учреждения сталкиваются с необходимостью пересмотра традиционных методов преподавания и внедрения инновационных образовательных стратегий. Данный доклад анализирует актуальные тенденции в обучении медицинских специалистов, включая применение симуляционных технологий, развитие критического мышления у студентов, использование онлайн-ресурсов и интеграцию междисциплинарных знаний.*

Современная медицина требует от специалистов высокого уровня компетенции, адаптации к постоянным изменениям в науке и практике, а также готовности к постоянному самообразованию на протяжении всей профессиональной деятельности[2]. Важнейшей задачей образовательных учреждений, занимающихся подготовкой медицинских кадров, является внедрение новых образовательных подходов и технологий, которые способствуют развитию у студентов гибкости мышления, навыков самостоятельного поиска и анализа информации, а также умений применять полученные знания в практической деятельности.

В условиях стремительного развития медицинских технологий, цифровизации и изменения подходов к лечению и диагностике, перед будущими медицинскими специалистами ставятся задачи, требующие высокого уровня компетенции и готовности к постоянному обновлению знаний[1]. Поэтому традиционные методы преподавания должны быть дополнены инновационными подходами, позволяющими обучающимся развивать критическое мышление, формировать клиническое мышление и уверенность в собственных силах при выполнении профессиональных обязанностей.

В данном докладе рассматриваются наиболее актуальные подходы и инновации, применяемые в образовательной практике для подготовки квалифицированных медицинских специалистов.

Интеграция симуляционного обучения:

Симуляционное обучение представляет собой один из наиболее эффективных методов подготовки будущих медицинских специалистов[1]. Этот

ISBN 978-601-08-0758-7

метод позволяет студентам отрабатывать практические навыки в контролируемой и безопасной среде, моделируя реальные клинические ситуации. Внедрение симуляционного обучения в образовательный процесс предоставляет возможность для студентов не только освоить теоретические знания, но и развить навыки принятия решений, критического мышления и командного взаимодействия.

Использование различных видов симуляторов, таких как манекены-роботы, виртуальные пациенты и симуляционные программы, помогает студентам улучшить свои практические навыки, не подвергая риску пациентов. Например, с помощью симуляторов студенты могут отрабатывать процедуры сердечно-легочной реанимации, интубации, проведения катетеризации сосудов, а также диагностики и лечения различных заболеваний[3]. Симуляционные технологии дают возможность неоднократно повторять манипуляции, что способствует их закреплению и автоматизации.

Применение симуляционного обучения также способствует снижению уровня стресса у студентов при переходе к клинической практике. Знакомство с возможными ошибками и их корректировка в безопасной среде помогают учащимся обрести уверенность в своих действиях и лучше подготовиться к реальной работе. Это особенно важно в условиях, когда даже малейшая ошибка может привести к серьезным последствиям для здоровья пациента.

Внедрение симуляционного обучения требует создания специальных симуляционных центров, оснащенных современным оборудованием. Во многих медицинских колледжах активно используется симуляционное обучение для отработки различных медицинских манипуляций. Преподаватели колледжа проводят занятия в специально оборудованных аудиториях, оснащенных манекенами, электронными симуляторами и виртуальными программами, что позволяет максимально приблизить учебный процесс к реальной клинической практике[3].

Таким образом, интеграция симуляционного обучения в образовательный процесс подготовки медицинских специалистов позволяет значительно повысить качество подготовки студентов, развить у них навыки принятия решений в стрессовых ситуациях, а также снизить вероятность ошибок в реальной практике.

Активное обучение и кейс-методы:

Активное обучение и использование кейс-методов являются современными подходами, которые значительно усиливают процесс обучения будущих медицинских специалистов. Эти методики ориентированы на вовлечение студентов в учебный процесс, что способствует более глубокому усвоению материала и развитию критического мышления[2].

Активное обучение подразумевает использование интерактивных методов, которые стимулируют студентов активно участвовать в учебном процессе. Вместо традиционных лекций, где студенты выступают в роли пассивных слушателей, акцент смещается на взаимодействие, обсуждение и совместное решение проблем. Примеры активных методов обучения включают:

ISBN 978-601-08-0758-7

- Групповые дискуссии: Студенты работают в небольших группах, обсуждая ключевые аспекты тематики, что способствует обмену мнениями и расширению взглядов[2].

- Ролевые игры: Учащиеся принимают на себя роли медсестер, пациентов или других участников процесса, что позволяет лучше понять различные точки зрения и развить навыки коммуникации[1].

- Мозговые штурмы: Студенты генерируют идеи и решения по конкретным медицинским вопросам, что способствует творческому подходу к проблемам.

Кейс-методы представляют собой подход к обучению, основанный на анализе реальных клинических случаев. Этот метод позволяет студентам применять теоретические знания на практике, анализируя реальные ситуации, с которыми они могут столкнуться в своей профессиональной деятельности. Кейс-методы включают:

- Анализ клинических случаев: Студенты получают описание реальных пациентов и их симптомов, что позволяет им разрабатывать планы диагностики или лечения. Это не только углубляет понимание материала, но и развивает навыки принятия решений.

- Дискуссии о кейсах: Обсуждение случаев в группе помогает студентам обмениваться мнениями, учитывать различные подходы к лечению и находить оптимальные решения.

- Интердисциплинарные кейсы: Кейс-методы могут быть интегрированы с другими дисциплинами, что способствует более глубокому пониманию сложных медицинских ситуаций и необходимости междисциплинарного подхода.

Использование технологий дистанционного и онлайн-обучения:

В последние годы технологии дистанционного и онлайн-обучения стали неотъемлемой частью образовательного процесса, особенно в сфере медицины. Они предоставляют новые возможности для обучения будущих медицинских специалистов, позволяя адаптировать образовательный процесс к потребностям студентов и современным требованиям к квалификации кадров[1].

Дистанционное обучение позволяет студентам обучаться в удобное для них время и в комфортных условиях. Это особенно важно для тех, кто совмещает учебу с работой или другими обязательствами. Студенты могут получать доступ к учебным материалам, лекциям и заданиям в любое время, что способствует более глубокому усвоению информации.

Технологии онлайн-обучения позволяют использовать различные форматы учебных материалов, включая видеолекции, интерактивные модули, тесты и электронные учебники. Такие разнообразные форматы помогают учитывать разные стили обучения и обеспечивают более эффективное усвоение информации.

Современные онлайн-платформы предоставляют возможность для взаимодействия между студентами и преподавателями. Форумы, чаты и видеоконференции создают условия для активного обсуждения тем, обмена

ISBN 978-601-08-0758-7

опытом и совместного решения проблем. Это способствует созданию сообщества обучающихся, даже если они физически находятся в разных местах.

Онлайн-обучение также позволяет интегрировать симуляционные технологии, что является особенно актуальным для медицинского образования. Виртуальные симуляторы и программы, имитирующие клинические ситуации, дают студентам возможность развивать практические навыки и применять теоретические знания в безопасной среде.

Технологии дистанционного обучения позволяют легко отслеживать успеваемость студентов и проводить оценку их знаний. Автоматизированные системы оценки и обратной связи помогают преподавателям быстро выявлять слабые места и корректировать образовательный процесс.

Междисциплинарный подход:

Междисциплинарный подход в образовании становится все более актуальным в подготовке будущих медицинских специалистов. Современная медицина требует от специалистов не только глубоких знаний в своей специализации, но и умения интегрировать знания из различных областей, таких как биология, химия, информатика, психология и управление здравоохранением. Такой подход помогает формировать целостное понимание здоровья и болезни, а также развивает навыки критического мышления и принятия обоснованных решений[3].

1. Синергия знаний:

Междисциплинарный подход позволяет студентам объединять знания из разных дисциплин, что способствует более полному пониманию сложных медицинских проблем. Например, понимание биохимических процессов помогает лучше разобраться в фармакологии, а знание психологии – в аспектах взаимодействия с пациентами и их мотивацией к лечению и оказании помощи.

2. Развитие командной работы:

Медицинская практика требует от специалистов умения работать в команде с другими профессионалами, такими как врачи, фармацевты, социальные работники и специалисты по психическому здоровью. Обучение в междисциплинарной среде помогает развивать навыки коммуникации и взаимодействия, что является необходимым для обеспечения комплексного ухода за пациентом.

3. Решение комплексных задач:

Междисциплинарный подход обучает студентов анализировать и решать комплексные медицинские задачи, требующие участия различных специалистов[3].

4. Инновации в обучении:

Внедрение междисциплинарного подхода в образовательный процесс способствует развитию инновационных методов обучения. Например, проекты, требующие совместной работы студентов, позволяют интегрировать теоретические знания с практическими навыками, а также стимулируют креативное мышление и инновационные решения.

ISBN 978-601-08-0758-7

В условиях современного мира, где медицина продолжает развиваться с беспрецедентной скоростью, подготовка будущих медицинских специалистов требует внедрения новых подходов и инновационных технологий в образовательный процесс. Использование симуляционного обучения, активных методов, дистанционных и онлайн-технологий, а также междисциплинарного подхода становится необходимым для формирования высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов, способных успешно справляться с вызовами, возникающими в сфере здравоохранения.

Интеграция современных методов обучения позволяет студентам развивать не только теоретические знания, но и практические навыки, критическое мышление и умение работать в команде. Это, в свою очередь, способствует формированию уверенности в собственных силах и готовности к профессиональной деятельности.

Выводы: Таким образом, актуализация образовательного процесса и внедрение новых подходов и технологий в подготовку медицинских кадров являются важными шагами на пути к созданию эффективной системы здравоохранения, ориентированной на потребности общества и требования времени. Важно продолжать исследовать и адаптировать новшества в образовании, чтобы обеспечить успешное будущее для новых поколений медицинских специалистов.

Список литературы:

a. Иванов А.В., Петров К.Н. Современные методы обучения в медицинском образовании. — М.: Медицина, 2022.

b. Сидоров А.А. Инновационные технологии в медицинском образовании. — СПб.: Наука, 2021.

c. Шмидт Х.Г. Использование симуляционных технологий в медицинском образовании. — Журнал медицинского образования, 2020.

ISBN 978-601-08-0758-7

МЕДИЦИНАДА ЖЕКЕЛЕНДІРІЛГЕН ОҚЫТУ: МАМАНДАРДЫ ДАЯРЛАУҒА АРНАЛҒАН ТӘСІЛДЕР МЕН МЫСАЛДАР

Асанбаев Д.К., Кенбаева А.А., арнайы пәндер оқытушысы
Қарағанды жоғарғы медициналық интерколледж

Аннотация: *Мақалада жаңа буын мамандарын даярлауға бағытталған медицинада жеке оқытудың тәсілдері мен мысалдары қарастырылады. Зерттеудің мақсаты – теориялық білім мен практикалық дағдыларды тиімдірек игеруге ықпал ететін студенттердің жеке қажеттіліктеріне бейімделетін әдістерді зерттеу және талдау. Жұмыс барысында медициналық жоғары оқу орындарында дербестендірілген білім беру бағдарламаларын енгізудің сәтті мысалдары, сондай-ақ олардың студенттердің кәсіби дайындығы мен қанағаттануына әсері қарастырылады. Тәжірибелік дағдылардағы олқылықтарды анықтау құралы ретінде симуляциялық технологияларды пайдалануға баса назар аударылады. Зерттеу нәтижелері стресс деңгейін төмендететін және студенттердің мотивациясын арттыратын білім беру процесінің икемділігінің маңыздылығын көрсетеді, бұл медициналық кадрларды даярлауда жоғары нәтижелерге қол жеткізудің негізгі факторы болып табылады. Мақала медициналық жоғары оқу орындарының оқытушылары үшін де, білім беру процесіне инновациялық тәсілдерді енгізуге ұмтылатын білім беру мекемелерінің әкімшілері үшін де пайдалы болуы мүмкін.*

Қазіргі заманғы медициналық практика тез өзгеретін жағдайларға және пациенттердің өсіп келе жатқан үміттеріне бейімделе алатын мамандардан жоғары құзыреттілік пен икемділікті талап етеді. Технологиялық прогресс пен медициналық білім көлемінің артуы жағдайында дәстүрлі оқыту әдістері көбінесе осы қиындықтарды жеңе алатын дәрігерлерді даярлау үшін жеткіліксіз. Сондықтан медициналық жоғары оқу орындарында дербестендірілген оқытуды енгізу болашақ мамандарды даярлау сапасын арттырудың маңызды құралына айналуда. Бұл тәсіл оңтайлы білім беру траекториясын қалыптастыру үшін студенттердің жеке ерекшеліктерін – олардың оқу стилін, ақпаратты қабылдау жылдамдығын, бастапқы дайындық деңгейін және кәсіби мақсаттарын ескеруге мүмкіндік береді.

Жекелендірілген оқыту білімді тереңірек игеруге, клиникалық дағдыларды дамытуға және студенттердің мотивация деңгейін арттыруға ықпал етеді, өйткені олар өз қарқынын ұстанып, көбірек назар аударуды қажет ететін тақырыптарға назар аудара алады. Жасанды интеллект және деректерді талдау сияқты заманауи технологиялардың арқасында оқытушылар студенттердің үлгерімін бақылай алады және әрбір болашақ дәрігердің кәсіби өсуіне жағдай жасай отырып, нақты уақыттағы білім беру бағдарламаларын реттей алады. Медициналық оқытуда жеке тәсілдерді сәтті қолданудың мысалдары бұл дайындық сапасын жақсартып қана қоймай, студенттердің күйзеліс деңгейін төмендетіп, олардың оқуға

ISBN 978-601-08-0758-7

қанағаттанушылығын және өз бетінше тәжірибеге дайындығын арттыратынын көрсетеді.

Осылайша, медицинада дербестендірілген оқытуды енгізу заманауи медицинаның талаптарына жауап беретін және практикалық сын-қатерлерге дайын мамандарды даярлауда жаңа көкжиектер ашады.

Мақаланың мақсаты – студенттердің жеке қажеттіліктеріне бейімделетін, теориялық білім мен практикалық дағдыларды тиімдірек игеруге ықпал ететін және болашақ дәрігерлердің дайындық сапасын арттыратын оқыту әдістерін зерттеу және талдау. Зерттеу медициналық жоғары оқу орындарында жекелендірілген бағдарламаларды енгізудің сәтті мысалдарын және олардың студенттердің кәсіби дайындығы мен оқуға қанағаттануына әсерін зерттеуге бағытталған.

Зерттеуге байланысты бірнеше гипотезалар ұсынылды:

1-гипотеза: медицинада жекелендірілген білім беру бағдарламаларын енгізу студенттердің оқу үлгерімін арттырады, олардың дағдылары мен білімдерін адаптивті тәсіл арқылы жақсартады.

2-гипотеза: жекелендірілген оқыту шеңберінде симуляциялық технологиялар мен виртуалды клиникалық сценарийлерді қолдану студенттердің практикалық дағдыларындағы олқылықтарды жақсырақ анықтауға ықпал етеді.

3-гипотеза: жекелендірілген оқыту студенттердің стресс деңгейін төмендетеді және оқу процесінің икемділігі арқылы олардың мотивациясын арттырады.

Медицинадағы жекелендірілген оқыту – бұл студенттердің когнитивті стильдерін, кәсіби қызығушылықтары мен дайындық деңгейлерін ескере отырып, олардың жеке білім беру қажеттіліктеріне бағытталған заманауи тәсіл. Медициналық ғылым мен практиканың қарқынды өзгеру жағдайында бұл тәсіл білім сапасын арттырып қана қоймай, сонымен қатар кәсіби өсу үшін қажетті негізгі клиникалық құзыреттіліктерді дамытуға мүмкіндік береді.

Жеке оқытудың негізгі мақсаты – әр студенттің қабілеттерін, мотивациясын және қажеттіліктерін ескеретін жеке білім беру траекториясын құру. Ол үшін икемді оқу процесін ұйымдастыруға мүмкіндік беретін адаптивті білім беру платформалары, модельдеу технологиялары, электронды оқулықтар және мобильді қосымшалар сияқты әдістер қолданылады. Зерттеушілердің пікірінше, жекелендірілген оқыту студенттердің стресс деңгейін төмендетуге мүмкіндік береді және олардың оқу процесіне қанағаттануын арттырады [1, 127б]. Бұл әсіресе медициналық оқу орындары үшін өте маңызды, мұнда оқыту білім мен дағдыларды үнемі жаңартып отыруды қажет етеді.

Бұл тәсілдің маңызды құрамдас бөлігі студенттердің оқу үлгерімін талдау үшін жасанды интеллект пен үлкен деректер технологияларын пайдалану болып табылады. Бұл құралдар оқытушыларға студенттердің нақты уақыттағы жетістіктерін бақылауға және білім беру материалдарын олардың қажеттіліктеріне сәйкес бейімдеуге мүмкіндік береді [2, 48б]. Мұндай жүйе анатомия, патофизиология, және клиникалық практика, сондай-ақ кәсіби

ISBN 978-601-08-0758-7

дағдылардың дамуын жеделдету сияқты күрделі медициналық тақырыптарды игеруді жақсартуға көмектеседі.

Сонымен қатар, жекелендірілген оқыту студенттерге қауіпсіз ортада клиникалық жағдайларды өңдеуге мүмкіндік беретін модельдеу технологияларын пайдалануды белсенді түрде қолдайды. Симуляциялық зертханалар, виртуалды клиникалық сценарийлер және дағдыларды жаттықтыру машиналары студенттерге пациенттер үшін қауіпті азайта отырып, күрделі процедураларды орындауға мүмкіндік береді [3, 84б]. Бұл болашақ дәрігерлерді даярлау сапасын және олардың нақты пациенттермен жұмыс істеу кезінде өз қабілеттеріне деген сенімділігін айтарлықтай арттырады.

Жеке тәсілді сәтті жүзеге асырудың мысалы – Гарвард медициналық мектебіндегі «жеке медициналық білім беру» (PME) бағдарламасы. Бұл бағдарлама әртүрлі қызығушылықтары мен кәсіби мақсаттары бар студенттерге арналған бейімделген оқу жоспарларын қамтиды. Бағдарламаны жасаушылар атап өткендей, бұл студенттерге өздерін қызықтыратын медицина салаларында тереңірек білім алуға және табысты кәсіби тәжірибе үшін қажетті дағдыларды қалыптастыруға мүмкіндік береді [4, 13б].

Сонымен қатар, Оттава университеті науқастар мен студенттерге арналған жекешелендірілген медициналық оқыту бағдарламасын құрғаны туралы атап өтуге болады (https://www.uottawa.ca/vie-campus/sante-mieux-etre/centre-sante-mieux-etre-etudiant/programme-education-personnalisee-en-sante).

Оттава Университеті ұсынатын жекелендірілген денсаулық сақтау саласындағы білім беру бағдарламасы студенттердің әл-ауқатына бейімделген көзқарасқа бағытталған. Ол жеке қажеттіліктерге негізделген жеке медициналық білім беру, біртұтас әл-ауқатқа жәрдемдесу және студенттердің денсаулық сақтаудың қиындықтарына дайындығын қамтамасыз ету арқылы болашақ мамандардың дамуын қолдайды. Бағдарлама пациенттердің жеке қажеттіліктерін түсіну және пациенттердің нәтижелерін жақсарту үшін жекелендірілген күтімді қамтамасыз ету маңызды болып табылатын медициналық оқыту үшін өте маңызды жекелендірілген оқу тәжірибесін біріктіреді.

Медицинадағы жекелендірілген оқыту студенттердің біліміндегі олқылықтарды анықтауда шешуші рөл атқарады және материалды тереңірек игеру үшін оқу процесін түзетуге мүмкіндік береді. Бұл әсіресе медициналық білім беруде өте маңызды, мұнда оқу бағдарламасының күрделілігі мен денсаулық сақтау саласындағы жылдам өзгерістер оқытуға икемді көзқарасты қажет етеді. Бейімделген онлайн платформалар мен симуляциялық технологияларды қоса алғанда, жекелендірілген оқыту жүйелері оқытушыларға студенттердің нақты уақыттағы жетістіктерін бақылауға және білімдегі олқылықтарды уақтылы анықтауға мүмкіндік береді, бұл мамандарды жақсырақ дайындауға ықпал етеді.

Зерттеулер көрсеткендей, жекелендірілген оқыту технологияларын қолдану студенттердің клиникалық нәтижелерін айтарлықтай жақсартады, бұл оларға күрделі тақырыптар мен тәжірибелерге назар аударуға мүмкіндік береді. Жеке

ISBN 978-601-08-0758-7

ерекшеліктерге бейімделетін оқыту жүйелері студенттердің дайындық деңгейіне қарай реттелуі мүмкін, бұл оқу қиындықтарын жеңуге және клиникалық құзыреттілікті жақсартуға көмектеседі.

Медицинада жекелендірілген оқыту студенттердің біліміндегі олқылықтарды анықтаудың және жоюдың күшті құралы болып табылады. Бұл тәсіл материалды жақсы игеруге ықпал етіп қана қоймайды, сонымен қатар болашақ медицина қызметкерлерінің практикалық қызметке дайындығын арттырады, бұл оны медициналық білім беру жүйесіндегі маңызды құрамдас бөлікке айналдырады.

Медициналық білім берудегі жекешелендірілген тәсілді объективті бағалау үшін SWOT талдауы (1-кесте) жүргізілді. Мұндай талдау жекелендірілген оқытудың күшті жақтарын, соның ішінде студенттердің мотивациясы мен білім деңгейіне оң әсерін анықтауға, сондай-ақ технологияны енгізудің жоғары шығындары сияқты әлсіз жақтарын анықтауға көмектеседі. SWOT талдауы сонымен қатар технологияның дамуы арқылы ашылатын мүмкіндіктерді және әлеуетті қауіптерді, соның ішінде ресурстарға біркелкі қол жетімділікті және оқытушылардың қарсылығын ескеруге мүмкіндік береді.

Кесте 1. SWOT-талдау

Факторлар	Позитивті	Негативті
Күшті тұстары (Strengths)	- Студенттердің қажеттіліктеріне жеке көзқарас. - Мотивация мен қанағаттану деңгейін арттыру. - Білімді тереңірек игеру үшін адаптивті технологияларды қолдану.	
Әлсіз тұстары (Weaknesses)		- Технологияларды енгізуге жоғары шығындар. - Персоналды үнемі техникалық қолдау және оқыту қажеттілігі.
Мүмкіндіктер (Opportunities)	- Жасанды интеллект пен модельдеуді қоса алғанда, жаңа технологияларды дамыту. - Оқытудың әртүрлі стильдері мен қарқынын ескеретін оқудағы икемділік.	
Қауіп-қатерлер (Threats)		- Технологияларға қол жеткізудің ықтимал айырмашылығы

ISBN 978-601-08-0758-7

		- Дәстүрлі оқытушылар тарапынан ықтимал қарсылық.

Қорытынды: Біздің зерттеу барысында медициналық жоғары оқу орындарында дербестендірілген білім беру бағдарламаларын енгізу студенттердің үлгерімін арттыруға айтарлықтай ықпал ететіні анықталды. Бірінші гипотеза растағандай, адаптивті тәсіл оқушылардың білімі мен дағдыларын жетілдіріп қана қоймай, сонымен қатар оқу процесін мақсатты және жеке етуге мүмкіндік береді.

Екінші гипотеза да өзінің растауын тапты: жекелендірілген оқыту шеңберінде симуляциялық технологиялар мен виртуалды клиникалық сценарийлерді қолдану студенттердің практикалық дағдыларындағы олқылықтарды анықтап қана қоймайды, сонымен қатар оларды орындау үшін қауіпсіз орта жасайды. Бұл, өз кезегінде, кәсіби құзыреттіліктің жақсы дамуын қамтамасыз етеді және студенттердің нақты клиникалық жағдайларға дайындығын арттырады.

Ақырында, үшінші гипотеза жекелендірілген оқыту студенттердің стресс деңгейін төмендететінін және оқу процесінің икемділігі арқылы олардың мотивациясын арттыратынын көрсетті. Оқыту әдістерін студенттердің жеке қажеттіліктеріне бейімдеу жайлы білім беру ортасын құруға ықпал етеді, бұл өз кезегінде оқуға қанағаттанудың жоғары деңгейіне және болашақ дәрігерлерді даярлаудың жалпы тиімділігін арттыруға әкеледі.

Осылайша, біздің зерттеу нәтижелері медициналық білім берудегі жекелендірілген тәсілдің маңыздылығын растайды. Мұндай әдістерді енгізу мамандарды даярлауды едәуір жақсартады, білім беру сапасын арттырады және заманауи медициналық практикумның талаптарына сәйкестігін қамтамасыз етеді.

Әдебиеттер тізімі:

1. Smith J. Personalized Learning in Medical Education: A New Paradigm // Medical Education Review, 2020. – №45(3). – P. 123-136.
2. Jones M., Li W. Big Data and AI in Personalized Medical Education: Enhancing Learning Outcomes // Journal of Educational Technology, 2021. – №12(4). – P. 45-56.
3. Brown K., Johnson T., Patel A. Simulation-Based Training in Personalized Medical Education // Journal of Clinical Simulation, 2019. – №10(2). – P. 78-89.
4. Harvard Medical School. Personalized Medical Education Program Overview // Harvard Medical Education Journal, 2021. – №34(1). – P. 12-19.

ISBN 978-601-08-0758-7

МЕДИЦИНА МАМАНДАРЫН ДАЙЫНДАУДАҒЫ ТӘСІЛДЕР МЕН ИННОВАЦИЯЛАР: МЕДИЦИНАДА КЕЙС-СТАДИ ТӘСІЛІМЕН ОҚЫТУ

Ахметова А.К., арнайы пәндер оқытушысы
Абеуова Ж.Б. арнайы пәндер оқытушысы
Жеке меншік мекеме Қарағанды жоғары Медициналық интерколледжі

Аннотация: *Кейс-стади (case study) әдісі медициналық оқу орындарында білім беру процесінің ажырамас бөлігіне айналды, теориялық білімді тереңірек түсінуге және оны практикалық қолдануға ықпал етеді. Осы аннотацияда кейс-стадия әдісінің негізгі аспектілері, оның маңызы, артықшылықтары мен қиындықтары, сондай-ақ оқу процесіне табысты интеграциясының мысалдары қарастырылады. Кейс-стадиялар нақты немесе моделденген клиникалық жағдайларды білдіреді, олар студенттерден талдау, сын тұрғысынан ойлау және шешім қабылдау дағдыларын талап етеді.*

Кейс-стади әдісінің негізгі ерекшеліктерінің бірі — студенттердің клиникалық ойлауын дамыту қабілеті. Әр түрлі жағдайларды талдау барысында студенттер симптомдарды анықтауды, диагноз қоюды және емдеу жоспарларын әзірлеуді үйренеді, бұл оларға нақты практикалық дайындыққа көмектеседі. Сонымен қатар, кейс-стадиялар командалық жұмыс дағдыларын дамытуға ықпал етеді, себебі студенттер жиі топтарда жұмыс істейді, ұсынылған шешімдерді талқылайды және өз пікірлерімен бөліседі. [1]

Заманауи технологиялар да кейс-стадия әдісін қолдану үшін жаңа мүмкіндіктер ашады. Виртуалды симуляторлар мен онлайн платформаларды пайдалану студенттерге нақты сценарийлермен әрекеттесуге мүмкіндік береді, бұл олардың оқу тәжірибесін жақсартады. Бұл технологияларды оқу процесіне енгізу оқуды қолжетімді әрі икемді етеді, бұл әсіресе жаһандық өзгерістер жағдайында маңызды.

Кейс-стадияның медициналық білім берудегі болашағы үлкен, себебі ол студенттердің қажеттіліктері мен заманауи медициналық практика талаптарына бейімделуді жалғастыруда.

Мақалада кейс-стади әдісін қолдану арқылы медициналық мамандарды даярлау тәсілдері талқыланады. Зерттеудің мақсаты – клиникалық жағдайларды талдау негізінде студенттердің теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын тиімдірек меңгеруіне ықпал ететін әдістердің тиімділігін зерттеу және бағалау. Медициналық жоғары оқу орындарында кейс-стади әдісін енгізудің сәтті мысалдары және олардың студенттердің кәсіби даярлығы мен оқуға қанағаттануына әсері қарастырылады. Практикалық дағдылардағы кемшіліктерді анықтау үшін симуляциялық технологияларды қолдануға ерекше көңіл бөлінген. Зерттеу нәтижелері білім беру процесінің икемділігінің маңыздылығын көрсетеді, бұл стрессті азайтып, студенттердің мотивациясын арттырады. Бұл фактор медициналық кадрларды сапалы даярлауда маңызды рөл атқарады. [2]

ISBN 978-601-08-0758-7

Соңғы уақыттағы медициналық білім беру саласы теориялық білімді практикалық тұрғыда тиімді қолдана алатын, өзгермелі жағдайларға жылдам бейімделе алатын және белгісіздік жағдайында негізделген шешімдер қабылдай алатын мамандарды даярлаудың қажеттілігімен бетпе-бет келуде. Бұл мақсаттарға жетудің ең тиімді әдістерінің бірі — кейс-стади әдісі (case study), ол студенттерге білімдерін тереңдетуге ғана емес, сонымен қатар клиникалық ойлау, талдау дағдыларын және командалық жұмысты дамытуға мүмкіндік береді. [3] Осы ғылыми жұмысымызда медициналық жоғары оқу орындарында кейс-стади әдісін қолданудың ерекшеліктері, оның артықшылықтары мен қиыншылықтары, сондай-ақ болашақ дәрігерлерді даярлаудағы тиімділігі қарастырылады.

Кейс-стади әдісі нақты клиникалық жағдайларды талдау және ең жақсы шешімдерді іздеу үшін қарастырылады. Бұл әдіс медициналық практиканың әртүрлі аспектілерін: диагностика, емдеу, этикалық мәселелер, пациенттермен және әріптестермен өзара әрекеттесуін қамтиды. Бұл активті оқыту әдісі студенттерге теориялық білімдерін нақты немесе модельденген жағдайларда қолдануға мүмкіндік береді, олар өз кәсіби қызметінде кездесетін медициналық мәселелермен бетпе-бет келеді.

Кейс-стади әдісі бойынша оқытудың негізгі кезеңдері:

1. Клиникалық жағдайды ұсыну — симптомдардың, анамнездің, зерттеу деректерінің сипаттамасы.
2. Мәселеге топтық немесе жеке талдау жүргізу.
3. Гипотезаларды қалыптастыру, ықтимал диагноздарды талқылау.
4. Диагностика және емдеу жоспарын әзірлеу.
5. Ұсынылған шешімдер мен қорытындыларды бағалау. [4]

Бұл тәсіл оқыту процесін интерактивті, студенттерді білім алу қызметіне белсенді қатысуға бағыттайды.

Кейс-стади клиникалық ойлауды қалыптастыруға ықпал етеді, себебі студенттер пациент деректерін талдайды, дифференциалды диагноздар әзірлейді және диагностиканың және емдеудің оңтайлы әдістерін таңдайды. Клиникалық жағдайларды талдау барысында студенттер белгісіздік жағдайларында шешім қабылдау дағдыларын дамытуға мүмкіндік беретін екіұшты жағдайлармен кездеседі.

Бұл активті оқыту әдісі студенттерден тек фактілерді есте сақтау емес, оларды нақты жағдайларда қолдануды талап етеді. Кейс-стади студенттердің белсенді қатысуын, пікір алмасуын және талқылауын ынталандырады, бұл олардың оқу процесіне қатысу деңгейін және нәтижелеріне жауапкершілігін арттырады. [5]

Артықшылық	Сипаттама
Клиникалық ойлау және шешім қабылдау дағдыларын дамыту	Студенттер пациент деректерін талдап, кез келген жағдайда шешім қабылдап үйренеді
Студенттің қатысуы	Студенттер талқылауға белсенді қатысып,жауапкершілікті

ISBN 978-601-08-0758-7

	арттырады
Медициналық практикаға дайындық	Студенттер практикада кездесетін қиындықтарға алдын ала дайындалады
Командалық жұмыс дағдыларын дамыту	Медициналық практиканың маңызды бөлігі ретінде командалық жұмысқа үйренеді.

Нақты немесе модельденген клиникалық жағдайларды талдау студенттерге өз практикасында кездесетін қиындықтарға алдын ала дайындалуға көмектеседі. Мұндай тәжірибе теориялық білімнің практикалық жағынан қалай қолданылатынын түсінуге көмектеседі және студенттердің нақты медициналық жұмыс жағдайларында шешім қабылдау қабілетін жақсартады.

Медицина — командалық жұмыс, және кейс-стади студенттерге клиникалық мәселелерді шешу үшін бірлесіп жұмыс істеуге ынталандырады. Бұл оларға медициналық командада табысты жұмыс істеу үшін маңызды коммуникативтік дағдыларды дамытуға мүмкіндік береді. [6]

Қазіргі технологияларды қолдану кейс-стади әдісінің мүмкіндіктерін айтарлықтай кеңейтеді. Виртуалды симуляторлар, цифрлық пациенттермен жұмыс істеуге арналған бағдарламалар және виртуалды шындық студенттерге нақты пациенттерге қауіп төндірмей диагностика және емдеу әдістерімен тәжірибе жасауға мүмкіндік беретін клиникалық жағдайлардың реалистік сценарийлерін жасауға мүмкіндік береді. Бұл, оқу процесін, сондай-ақ студенттердің нақты практикаға дайындықтарын жақсартады, өйткені S.T. Thistlethwaite, C.O'Brien "Кейс-стадии әдісінің медициналық білім берудегі тәжірибесі" зерттеуінде, авторлар студенттерге кейс-стадии әдісінің қандай өзгерістерге алып келетінің зерттеді. [7] Нәтижелер көрсеткендей, кейс-стадияларды пайдалану студенттердің қатысу деңгейін арттырып, шешім қабылдау дағдыларын жақсартты, кейс-стадияларды қолданатын студенттер клиникалық ойлау дағдыларын жоғары деңгейде көрсетіп, практикалық жағдайларға жақсы дайындалды. Авторлар сондай-ақ, әдісті тиімді жүзеге асыру үшін жоғары сапалы кейстерді әзірлеудің маңыздылығын атап өтеді.

Кейс-стади әдісін медициналық жоғары оқу орындарының білім беру бағдарламаларына енгізу болашақ дәрігерлерді даярлау сапасын жақсартуға үлкен әлеуетке ие. Осы әдісті жүйелі түрде қолдану заманауи технологиялармен бірге нағыз медициналық практика жағдайларына мүмкіндігінше жақын, икемді, бейімделген және интерактивті оқу бағдарламаларын құруға мүмкіндік береді.

Қорытынды: Кейс-стади әдісі мамандарды оқытуда күшті құрал болып табылады, ол критикалық ойлау, клиникалық дағдылар мен командалық жұмысты дамытуға ықпал етеді. Бұл әдісті қолдану студенттерге қауіпсіз оқу ортасында практикалық дағдылар алуға және нақты клиникалық практикада жұмыс істеуге дайындайды. Кейс-стади әдісі дамуға және болашақта бейімделуге үлкен әлеуетке ие. Заманауи технологияларды интеграциялау, оқуды жекелендіру, көп

ISBN 978-601-08-0758-7

дисциплинарлы тәсілдер мен этикалық мәселелерге назар аудару студенттер үшін жаңа мүмкіндіктер жасайды, білімдерін жақсартады және медициналық білім берудің сапасын арттырады. Кейс-стадиялар білім беруде маңызды құрал болып қала береді, болашақ мамандарды қазіргі әлемнің сын-тегеуріндеріне дайындайды. Дегенмен, кейс-стади әдісін сәтті қолдану оқытушылардың мұқият даярлығын, сапалы кейстерді әзірлеуді және заманауи технологияларды енгізуді талап етеді. Жалпы алғанда, кейс-стади әдісі жоғары білікті медициналық мамандарды даярлаудың негізгі элементтерінің бірі болып табылады, олар заманауи медицинаның күрделі және динамикалық жағдайларына дайын.

Әдебиеттер тізімі:

1. Абдулина, Э. Г. Методика кейс-стади в обучении студентов медицинских вузов // Вестник медицинского образования. – 2018. – № 4. – С. 56-62.

2. Богословская, Ю. Н. Использование метода кейс-стади в обучении будущих врачей // Медицинская педагогика в теории и практике. – 2019. – № 2. – С. 12-19.

3. Сухих, М. Н. Современные технологии обучения в медицинских вузах: кейс-стади и симуляционные методы // Журнал медицинского образования. – 2020. – Т. 18. – № 1. – С. 41-48.

4. Коломенская, М. А., Иванова, Е. В. Интерактивные методы обучения в медицине: преимущества и проблемы // Инновации в медицинском образовании. – 2021. – № 3. – С. 75-81.

5. Лазарев, А. И., Зимина, Т. П. Кейс-стади как эффективный метод обучения в медицинских вузах // Проблемы и перспективы медицинского образования. – 2022. – № 6. – С. 32-37.

6. Harden, R. M. Approaches to Teaching and Learning in Medical Education // Medical Education. – 2016. – Vol. 50. – P. 55-63.

7. Schmidt, H. G. Foundations of Problem-Based Learning in Medicine // Education for Health. – 1993. – Vol. 6. – P. 97-107.

ISBN 978-601-08-0758-7

БОЛАШАҚ МЕДИЦИНА МАМАНДАРЫН ОҚЫТУДАҒЫ ЖАҢА ТӘСІЛДЕР МЕН ИННОВАЦИЯЛАР

Ахметова Арайлым Тойлыбековна, «арнайы пәндер» оқытушысы
МКҚК«Арқалық медицина колледжі»

***Аннотация**: Қазіргі заманғы медицина қарқынды дамып келеді, сондықтан болашақ медицина мамандарын оқытуға қойылатын талаптар да артып отыр. Оларды жоғары деңгейде даярлау үшін дәстүрлі білім беру әдістерін жетілдірумен қатар, инновациялық тәсілдерді енгізу қажет. Жаңа технологиялар мен әдістерді қолдану болашақ дәрігерлер мен медициналық қызметкерлердің кәсіби дағдыларын тиімді дамытуға мүмкіндік береді, бұл өз кезегінде, денсаулық сақтау саласының сапасын жақсартады.*

Цифрлық технологиялардың білім берудегі рөлі

Цифрлық технологиялар қазіргі медицинадағы оқытудың ажырамас бөлігіне айналды. Қазіргі таңда студенттерге арналған онлайн платформалар, виртуалды зертханалар және симуляциялық бағдарламалар .білім алу процесін интерактивті және қолжетімді ете түсуде. Мысалы, 3D-модельдеу арқылы адам ағзасының құрылысын оқып-үйренуге болады. Бұл студенттерге күрделі анатомиялық құрылымдарды жақсырақ түсінуге және визуализациялауға мүмкіндік береді [1].

Сонымен қатар, медициналық білім беруде виртуалды және қосымша шынайылық технологиялары (VR және AR) кеңінен қолданылады. VR көмегімен студенттер клиникалық жағдайларды симуляциялау арқылы практикалық тәжірибені қателік жібермей-ақ ала алады. Бұл әдіс нақты хирургиялық операцияларды немесе күрделі медициналық жағдайларды шынайы өмірдегі қауіптіліктерсіз меңгеруге мүмкіндік береді.

Симуляциялық орталықтар

Медицинадағы оқытудың тағы бір маңызды инновациялық тәсілі – симуляциялық орталықтар. Бұл орталықтарда студенттер әртүрлі клиникалық жағдайларды тәжірибелік түрде шешуге мүмкіндік алады. Симуляциялық құрал-жабдықтар, мысалы, манекендер немесе роботтар, нақты пациенттерді алмастыра алады, бұл болашақ медицина қызметкерлеріне нақты клиникалық тәжірибе жинауға көмектеседі [2].

Симуляциялық оқыту әдісі студенттерге емдеу процесіндегі дұрыс шешім қабылдауды, пациенттермен тиімді қарым-қатынас жасауды және төтенше жағдайларда шұғыл әрекет етуді үйретеді. Бұл болашақ медицина мамандарының практикалық дағдыларын қалыптастыруға және олардың кәсіби сенімділігін арттыруға бағытталған.

Дәлелді медицинаға негізделген оқыту

Дәлелді медицина (evidence-based medicine) қазіргі заманғы медициналық тәжірибенің негізі болып табылады, сондықтан болашақ мамандарды дәлелді медицина қағидаттары бойынша оқыту маңызды. Бұл тәсіл емдеу мен

ISBN 978-601-08-0758-7

диагностиканы ғылыми дәлелдерге сүйене отырып жүзеге асыруға бағытталған. Студенттер клиникалық шешімдерді қабылдау барысында медициналық зерттеулердің нәтижелерін қалай пайдалану керектігін үйренеді.

Дәлелді медицинаға негізделген оқыту студенттердің сыни ойлау қабілетін арттырады, оларға ғылыми деректерді талдауды және ең тиімді емдеу тәсілдерін таңдай білуге үйретеді. Бұл тәсіл болашақ мамандарды заманауи медицина талаптарына сай келетін кәсіби маман ретінде қалыптастырады [3].

Телемедицина және қашықтықтан оқыту

Телемедицина және қашықтықтан оқыту медицина мамандарын оқытуда да үлкен маңызға ие. COVID-19 пандемиясы кезінде қашықтықтан білім беру және телемедицина технологияларының дамуы медициналық білім берудің болашағын өзгертті. Қашықтықтан оқыту арқылы студенттер әлемнің кез келген жерінен білім ала алады, бұл білім алуға географиялық шектеулерді азайтады [4].

Телемедицина болашақ дәрігерлерге алыстағы пациенттермен қалай жұмыс істеу керектігін үйретеді, бұл әсіресе ауылдық және шалғай аудандарда қызмет көрсету үшін маңызды. Болашақ мамандар қашықтықтан диагностикалау, емдеу және кеңес беру тәсілдерін меңгереді, бұл денсаулық сақтау жүйесінің қолжетімділігін арттыруға мүмкіндік береді.

Жеке оқыту әдістемелері

Әрбір студенттің оқу қабілеті мен қажеттіліктері әртүрлі, сондықтан медициналық білім беруде жеке оқыту тәсілдері де қолданыла бастады. Жеке оқыту әдістемелері студенттердің оқу үрдісін икемді етіп, әркімнің қабілетіне қарай білім беру мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Бұл тәсіл студенттердің жеке ерекшеліктерін ескеріп, олардың өз бетінше оқуын қолдайды[5].

Қорытынды: Болашақ медицина мамандарын оқытудағы жаңа тәсілдер мен инновациялар медициналық білім берудің сапасын арттыруға және болашақ дәрігерлердің кәсіби дайындық деңгейін жоғарылатуға бағытталған. Цифрлық технологиялар, симуляциялық орталықтар, дәлелді медицинаға негізделген оқыту, телемедицина және интердисциплинарлық тәсілдер медицина мамандарын заманауи талаптарға сай етіп даярлауға мүмкіндік береді. Жаңа тәсілдер мен инновациялар болашақ дәрігерлерге медициналық қызмет көрсетудің сапасын жақсартуға және денсаулық сақтау саласын одан әрі дамытуға жол ашады.

Әдебиеттер тізімі:

1. Айткұлова Г.Б. Медициналық білім беру жүйесіндегі инновациялар. – Астана: Медицина университеті баспасы, 2019. – 264 б.

2. Жұмабеков Р.Ж. Болашақ дәрігерлерді оқытудағы жаңа әдістер. – Алматы: Денсаулық, 2021. – 198 б.

3. Brown, S.E. et al. Medical Education: Innovations for the Future. – New York: Springer, 2020. – 412 p.

4. Бекенова М.А. Дәлелді медицина негізінде мамандарды оқыту. – Алматы: Медицина, 2022. – 198 б.

5. Мусабаева К.Т. Болашақ медицина мамандарын даярлаудағы инновациялық әдістер. – Астана: Ұлттық медицина академиясы, 2020. – 256 б.

ISBN 978-601-08-0758-7

МЕЙІРГЕРЛІК ҚЫЗМЕТТЕ КӘСІБИ БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ МЕН БІЛІМ БЕРУ СТРАТЕГИЯЛАРЫ

Байсов Ғ.Т., арнайы пәндер оқытушысы
ШЖҚ" Кеңес Одағының Батыры Мәншүк Мәметова атындағы Ақтөбе жоғары медициналық колледжі " МКК

Аннотация: *Мейіргер ісі денсаулық сақтау жүйесінің негізгі құрамдас бөлігі ретінде науқастардың саулығы мен өмір сапасын жақсартуда ерекше маңызға ие. Бұл салада мейіргерлердің үздіксіз білім алуы мен кәсіби өсуі қазіргі заманның талаптарына жауап береді. Мақалада мейіргерлердің кәсіби даму кезеңдері, үздіксіз білім берудің маңызы, мейіргерлік қызмет көрсету сапасын арттыру, науқастардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, кәсіби құзыреттілікті дамыту сияқты аспектілер қарастырылады. Үздіксіз білім беру мейіргерлердің кәсіби деңгейін көтеріп, медициналық технологиялар мен емдеу әдістерін меңгеруге мүмкіндік береді. Бұл үдеріс мейіргерлердің кәсіби дамуын ғана емес, сонымен қатар денсаулық сақтау саласының жалпы сапасын арттыруға да әсер етеді. Мейіргерлердің білімін жетілдіру мен кәсіби дамуына бағытталған бағдарламалардың тиімділігі денсаулық сақтау жүйесінің тұрақты және тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз етудің негізгі факторы болып табылады.*

Мейіргер ісі денсаулық сақтау жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Мейіргерлер науқастардың сауығуына ықпал етіп қана қоймай, олардың өмір сапасын жақсарту үшін маңызды рөл атқарады. Қазіргі заманда медицина саласы қарқынды дамып келеді, сол себепті мейіргер мамандарының үздіксіз білім алып, кәсіби деңгейлерін жетілдіруі аса маңызды. Бұл олардың тек жеке маман ретінде өсуіне ғана емес, бүкіл медициналық қызмет көрсету сапасының артуына да әсер етеді.

Үздіксіз білім берудің мәні

Мейіргер ісі үнемі жаңаруды, жаңа әдіс-тәсілдерді меңгеруді талап ететін сала болғандықтан, мейіргерлердің үздіксіз білім алуын қамтамасыз ету – заманауи медицинаның басты қағидаларының бірі. Ғылыми зерттеулердің нәтижелері, жаңа технологиялар мен емдеу әдістері жылдам қарқынмен дамып, оларды мейіргер ісіне енгізу үшін мамандардың әрдайым білімдерін жаңартып отыруы қажет.Мейіргерлер үшін үздіксіз білім беру бірнеше мақсатты көздейді. Біріншіден, ол олардың кәсіби құзыретін арттырып, заманауи медициналық технологиялар мен хаттамаларды меңгеруге мүмкіндік береді. Екіншіден, үздіксіз оқыту мейіргерлердің күнделікті тәжірибеде тиімділігін арттырып, олардың жұмыс сапасын жақсартады. Үшіншіден, бұл процесс науқастарға сапалы әрі қауіпсіз қызмет көрсетуге бағытталады. Білім беру процесі тек теориялық қана емес, сонымен қатар практикалық машықтарды да қамтуы тиіс, өйткені мейіргерлердің тәжірибелік дағдылары медицинадағы жаңашылдықтарды тәжірибеде дұрыс қолдануға әсер етеді.

ISBN 978-601-08-0758-7

Кәсіби өсу және оның кезеңдері

Мейіргерлердің кәсіби өсуі бірнеше кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңде мейіргер кәсіби білім алып, жұмыс барысында алғашқы тәжірибе жинақтайды. Бұл кезеңде мейіргерлердің жалпы дағдылары қалыптасады, олар өз жұмысында нақты бағыттар бойынша маманданады. Мейіргер ісі практикалық қызмет болғандықтан, мейіргердің алғашқы жұмыс тәжірибесі оның болашақта кәсіби дамуына маңызды негіз қалайды.

Екінші кезеңде мейіргерлердің тәжірибесі артып, олар белгілі бір медициналық салаларда маманданады. Мамандану мейіргерлерге нақты бір бағытта тереңірек білім алуға мүмкіндік береді. Бұл кезеңде олар кәсіби өсу үшін арнайы оқу курстарын, тренингтерді және семинарларды өтіп, өздерінің тәжірибесін кеңейтеді. Кейбір мейіргерлер осы кезеңде арнайы сертификаттар алып, жаңа технологияларды игеруге мүмкіндік алады.

Үшінші кезеңде мейіргерлер басшылық қызметтерге дайындала бастайды. Олардың кәсіби өсуі денсаулық сақтау мекемелеріндегі басшылық және басқару функцияларын орындау үшін қажетті білім мен дағдыларды қамтиды. Басқарушылық лауазымдарда жұмыс істейтін мейіргерлер медициналық мекемелерде сапаны арттыру бағдарламаларына, кадрларды басқаруға, жоспарлау мен ұйымдастыруға қатысады. Осылайша, мейіргер ісіндегі үздіксіз білім беру мейіргерлердің жоғары кәсіби деңгейге жетуіне және денсаулық сақтау саласында тиімді қызмет етуіне ықпал етеді.

Кәсіби өсу мен үздіксіз білім берудің артықшылықтары

Мейіргерлердің үздіксіз білім алуы мен кәсіби өсуі бірнеше маңызды артықшылықтар береді:

Медициналық қызмет көрсету сапасын арттыру: Мейіргерлердің үздіксіз білім алуы олардың күнделікті жұмысында заманауи әдістер мен технологияларды қолдануына мүмкіндік береді. Бұл науқастарға жоғары сапалы медициналық көмек көрсетуді қамтамасыз етеді.

Науқастардың қауіпсіздігі: Мейіргерлердің кәсіби деңгейін жетілдіру науқастардың қауіпсіздігін арттыруға ықпал етеді. Оқу барысында олар қауіпсіздік стандарттарын меңгеріп, медициналық қателіктердің алдын алу дағдыларын қалыптастырады.

Кәсіби құзыреттілік: Үздіксіз білім алу арқылы мейіргерлердің кәсіби біліктілігі артып, олар маман ретінде сенімді бола түседі. Бұл оларды жаңа жұмыс орындарында немесе жоғары лауазымдарға орналасуда артықшылық береді.

Жұмыспен қамтылу мүмкіндігі: Кәсіби деңгейі жоғары мейіргерлер әрдайым еңбек нарығында сұранысқа ие болады. Үздіксіз білім беру бағдарламаларына қатысқан мейіргерлер еңбек нарығында бәсекеге қабілетті болып, мансаптық өсудің жаңа мүмкіндіктеріне ие болады.

Жаңашылдықты қабылдау: Үздіксіз білім беру және кәсіби өсу мейіргерлерге жаңа технологиялар мен әдістерді тез қабылдап, оларды күнделікті жұмысына енгізуге мүмкіндік береді. Бұл әсіресе жоғары технологиялық

ISBN 978-601-08-0758-7

құрылғылар мен заманауи емдеу әдістерін қолданатын медициналық мекемелерде маңызды.

Үздіксіз білім беру бағдарламалары

Қазіргі таңда мейіргерлер үшін көптеген үздіксіз білім беру бағдарламалары бар. Олар университеттер, колледждер, ғылыми-зерттеу орталықтары және медициналық мекемелерде ұйымдастырылады. Мейіргерлер оқуға арналған бағдарламаларға қатысып, өздерінің кәсіби білімін жетілдіріп қана қоймай, кәсіби қоғамдастықтармен байланыс орнатады. Мұндай бағдарламалар мейіргерлерді жаңа ақпаратпен қамтамасыз етіп, олардың кәсіби деңгейін көтереді.Үздіксіз білім беру бағдарламалары теориялық оқудан бөлек, практикалық дағдыларды дамытуға бағытталған. Оқыту барысында симуляциялық құрылғылар мен тәжірибелік жаттығулар қолданылады. Бұл мейіргерлерге нақты жағдайларда қажетті іс-әрекеттерді тез және дұрыс орындауға үйретеді.

Қорытынды: Мейіргер ісі – денсаулық сақтау жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі болып табылатын, науқастардың саулығы мен өмір сапасын жақсартуға бағытталған сала. Мейіргерлердің үздіксіз білім алуы мен кәсіби өсуі қазіргі заманғы медицинада ерекше маңызға ие. Заманауи медицинаның дамуы, жаңа технологиялар мен емдеу әдістерінің енгізілуі мейіргерлердің білімдерін үздіксіз жаңартып отыруды талап етеді.Үздіксіз білім беру мейіргерлердің кәсіби құзыретін арттырып, олардың тиімділігін жоғарылатады, сондай-ақ науқастарға қауіпсіз әрі сапалы қызмет көрсетуді қамтамасыз етеді. Мейіргерлердің кәсіби өсуі кезең-кезеңімен жүреді, және әрбір кезеңде олардың білімдері мен дағдылары жаңа тәжірибелермен толықтырылып отырады.

Мейіргерлердің үздіксіз білім алуы бірнеше артықшылықтарға ие: медициналық қызмет көрсету сапасының артуы, науқастардың қауіпсіздігінің қамтамасыз етілуі, кәсіби құзыреттіліктің арттыруы, жұмысқа орналасу мүмкіндіктерінің кеңеюі және жаңашылдықты қабылдауы. Осы себепті, мейіргерлер үшін үздіксіз білім беру бағдарламалары тек кәсіптік дамуға ғана емес, сонымен қатар денсаулық сақтау саласының сапасын арттыруға бағытталған.Мейіргерлердің кәсіби өсуі мен үздіксіз білім беруін ынталандыру – денсаулық сақтау жүйесінің тұрақты және тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз етудің негізгі факторы. Сондықтан мейіргерлердің білімін жетілдіру мен кәсіби дамуына бағытталған білім беру бағдарламаларының маңыздылығын атап өту керек. Осы үдеріс арқылы мейіргерлер денсаулық сақтау саласында тиімді қызмет етіп, науқастардың өмір сапасын жақсартуға септігін тигізеді.

Әдебиеттер тізімі:

Көшербаев, Н. М. (2019). *Медициналық білім беру жүйесінің үздіксіз дамуы*. Алматы: Дәстүр баспасы.

Базарбаева, Ж. Ш. (2021). "Мейіргер ісіндегі кәсіби құзыреттілікті дамыту жолдары". *Қазақ медицина журналында* жарияланған мақала.

Ахметова, М. Т. (2020). *Мейіргер ісі және денсаулық сақтау менеджменті*. Нұр-Сұлтан: Астана МедПресс.

ISBN 978-601-08-0758-7

ЗАМАН ТАЛАБЫНА САЙ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ ҚОЛДАНЫЛУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ.

Боранова Т.Т. Техника ғылымдарының магистрі
Кунакбева Ж.Б. педагог-эксперт
ЖШС «Батыс Қазақстан Жоғары медициналық колледжі»

Аннотация: *Мақалада казіргі білім беру саласындағы өзекті мәселелердің бірі-жаңа технологияларды қолданудың әдіс-тәсілдері айтылған. Білім алушылардың шығармашылық, теориялық негіздерін, эстетикалық көзқарастарын пайымдауын, баға беруін, кәсіби- танымдық белсенділігін дамытуға бағытталған.*

Қазіргі кезде Қазақстан Республикасында жаңа білім беру жүйесінің қалыптасуы жүріп жатыр. Осыған орай, алдыңғы қатарлы идеялар мен педагогикалық технологияларды практикалық тұрғыдан жаңарту және оларды ғылыми тұрғыда негіздеу бағытындағы жұмыстар жүргізілуде. Болашақ маман – бүгінгі студент педагогика теориясы мен практикасындағы қазіргі заманғы педагогикалық технологиялардың түрлерін біліп, оларды оқутәрбие үдерісінде шығармашылықпен қолдануға тырысуы тиіс.

Білім беруде технология деген сөзді көп естиміз. “Технология” түсінігі техникалық процеспен байланысты және сөздікке сүйенсек (гректің techne -өнер, біліктілік және logos – оқу ұғымдары), материалды өңдеудің тәсілдері мен құралдары туралы білімнің жиынтығы.

Ғылыми әдебиеттерде қазір технология түсінігіне мынадай анықтама беріледі: “Технология” – бұл қоғамдағы практикалық процесстердің техникамен реттеліп отыратын және материалдық дүниенің заңдылықтарымен анықталатын, техникалық құралдар мен объектінің өзара әрекеттесуінен туындайтын процесс” және “технология” термині үш түрлі аспектіні береді: технология-материалдық игіліктер өндірудің тікелей процесі; технология- технологиялық процесс; технология - осы процестің заңдары туралы ғылым. Ғылым мен техниканың дамуына қарай педагогиканың да мүмкіншіліктері артты, жаңа технологиялар пайда болы. Қоғамдағы талаптар мен әлеуметтік сұраныстар педагогикалық технологиялардың тууына себеп болды.

Педагогикалық технология кешенді процесс. Педагогикалық технологиялардың мынандай артықшылылықтары бар, технология студенттің оқу-танымдық, іс - әрекетінің құрылымы мен мазмұнын анықтайтын оқу процесінің жобасын ұсынады. Әдістемелік сабақ жоспарын әр оқытушы өзінше құрып, сабақ пен білім алушының іс - әрекетін түрліше ұйымдастырады. Ал білім алушының оқу - іс әрекетін тиімді жобалау, жоғарғы табыстарға әкеледі. Қазіргі кезде Қазақстанда білімнің жаңа жүйесі құрылуда. Бұл үрдіс педагогика теориясы мен оқу- тәрбие үрдісіне нақты өзгерістер енгізумен қатар, елімізде болып жатқан түрлі бағыттағы білім беру қызметіне жаңаша қарауды, қол жеткен табыстарды сын көзбен бағалай отырып саралауды, жастардың шығармашылық

ISBN 978-601-08-0758-7

әлеуметін дамытуды, ұстаздың іс - әрекетін жаңаша тұрғыда ұйымдастыруды талап етеді.

Жаңа педагогикалық технологиялар білім алушының шығармашылық қабілеттерін арттыруға көмектеседі. Жаңа технологияны қолдану төмендегідей кезеңдер арқылы іске асады:

I- кезең оқып үйрену;

II- кезең меңгеру

III кезең - дамыту

IVкезең - өмірге ендіру

Қазіргі заманның даму қарқыны оқытушылардың шығармашылығын жаңаша, ғылыми- зерттеу бағытында құруды талап етеді. Сондықтан XXI ғасырдың ір оқытушысы, үнемі ізденіс үстіндегі ғалым- педагог болуы тиіс. Оқытушы өз міндетін тек оқыту, түсіндіру ғана деп түсінбей бастысы оқу еңбегін ұйымдастыруға көмектесіп,білім алушының өзіндік ойлау және өмірлік ұстанымын қалыптастыру оқытушының шеберлігіне, шығармашылық қызметіне байланысты.

Білім алушыларға жан- жақты білім беру мақсатында жиі пайдаланып жүрген жаңа ұғымдардың бірі – инновация. «Инновация» – нақты қойылған мақсатқа жетуде ойға алынған жаңа нәтиже. .

Инновациялық технологияны меңгеру оқытушының интелектуалдық, кәсіптік, адамгершілік, рухани, азаматтық адами келбетінің қалыптасуына игі әсер етеді. Оқыту – тәрбиенің құрамды бөлігі, қайнар көзі, жүйелі түрі. Оқыту арқылы тәрбиенің саналығын, руханилығын, әсемділігін,адамгершілікке баулу жолын, еңбекшілігін айқындар толықтыруға болады. Оқыту – тәрбиенің интеллекуалды түрі. Келер ұрпаққа қоғам талабына сай тәрбие мен білім беруде инновациялық іс әрекеттің ғылыми - педагогикалық негіздерін меңгеру, оқу үрдісінің өнімділігін арттыру.

Инновациялық технологиялардың жаңашылдығы мен тәжірибелік маңыздылығы.

Казіргі дамыған елдер иновациялық идеяларымен дүние жүзін жаулап келеді. Бұл «инновация»

термині «жаңалық енгізу, жаңашылдық» деген ұғымды білдіреді. Инновациялық оқытуды тәжірибемізге енгізіп, ойлау қабілеті дамыған өз бетінше шешім қабылдай білетін білімді ұрпақты тәрбиелеу.

Инновациялық оқыту технологиялары білім алушылардың білім іскерлік дағдысын қалыптастырады. Ғылыми - техникалық даму ғасырындағы маңызды мәселенің бірі - интелектуалдық, шығармашылық гуманды жас ұрпақты тәрбиелеу.

Биология пәнін оқытуда да инновациялық технологияларды қолданудың мүмкіндіктері өте мол. Биология сабағында логикалық жүйеге құрылған бағдарламаларды қолдану арқылы меңгеретін тақырыптардан қайталау, пысықтау, мәтінді оқыту барысында талдау секілді тапсырмаларды орындатуға болады. Жаңа инновациялық технологияның басты тиімділігі- бұл оқытушы

ISBN 978-601-08-0758-7

биология сабақтарындағы оқу үрдісін түбегейлі өзгертуге, оқытудағы пәнаралық байланысты күшейте отырып, білім алушылардың өрісін ұштап, ойын байытуға сабақтың қызықтылығы, тартымдылығы, қажеттілігі ерекше ықпал етеді. Сондай - ақ биология сабағында қабілетті білім алушылармен жұмыс істеудің негізгі мақсаты- олардың шығармашылық жұмыста өзінің қабілетін іске асыруға дайындығын қалыптастыру. Ал мақсатқа жету оқу бағдарламасын тереңдетіп оқыту және білім алушының танымдық белсенділігін дамыту арқылы жүзеге асады. Сабақта студенттің шығармашылық қабілеттерін арттырып, ынталандыру үшін, мынандай жолдармен өткізуге болады: көрнекі құралдарды көп пайдалану, кестелерді пайдалану, техникалық құралдарды тиімді пайдалану, тақырыпқа қатысты бейне таспаларды, фильмдерді көрсету арқылы.

Инновациялық технологияны енгізуде компьютерді пайдаланудың тиімділігін былай саралап көрсетуге болады.

-Білім алушы мен оқытушының позитивтік оң қатынаста болуына ықпал етеді. Себебі білім алушылар компьютермен тікелей қатысты болғандықтан өзін еркін сезінеді.

-Компьютермен жұмыс барысында білім алушылардың белсенділік, жауапкершілік және өзіндік шығармашылық қабілеттері қалыптасады. Білім алушы өз бетінше еңбектенеді, өз еңбегінің нәтижесін көреді. Өзін - өзі қадағалауға мүмкіндік туады, тапсырмаларды оқытушының көмегінсіз орындайды. Осы тапсырмалар арқылы ойлау және есте сақтау қабілеттері дамиды.

-Берілген материал бірсарынды болып, тек оқытушы сөйлейтін болса, білім алушыларды жалықтырып, сабақ сәтсіз аяқталады. Осындай жағдайларды болдырмау үшін компьютер, интерактивті тақта арқылы түрлі белсенділігін қызығушылығын арттыратын элементтер қолданылады.

-Инновациялық технологияның оқытушының жұмысына ең тиімдісі- білім алушылардың білім олқылықтарына үнемі зерттеу жасап, түзету жұмыстарын жүргізуге пайдасы бар.

-Жақсы әдістемелік бағдарламалық құралдармен жабдықталған компьютер көптеген функцияларды өзіне ала отырып, оқытушыға жұмыс стилін жетілдіруге мүмкіндік береді.

Компьютер арқылы беруге арналған, инновациялық – оқыту және әдістемелік құралдар құрамына төмендегідей материал кіруі тиіс:

-Таратылып берілетін оқу материалдары;

-Бақылау және тест тапсырмаларының материалдары;

-Топпен немесе жекелеп оқытуға және өздігінен оқып үйренуге арналған әдістемелер;

-Экранда берілетін барлық ақпараттық – оқу материалдарын компьютердің мультимедиялық мүмкіндігіне және сабақтарды сол арқылы беру тәсілдеріне қарай бейімдеу.

Компьютерлік өнімдер:

- Оқыту программалары;

ISBN 978-601-08-0758-7

- Электронды оқулықтар;
- Мультимедиялық құралдар;
- Қашықтықтан оқыту;
- Видео конференциялар;
- Бейнекамера және теледидарлық құралдар;
- Презентациялар;
- Гипермәтіндік гиперсілтемелер

Оқыту программалары:

Оқыту программалары оқу – үйрену істерін ұйымдастырады, олардың мектепке не уйде кез- келген пәндерден сабаққа дайындалу кезінде өте ыңғайлы екені талас тудырмайды. Компьютерлер сабақ оқуда электрондық оқулық және тренажерлер түрінде, лабораториялық аспап, әрі информациялық- анықтамалық жүйе есебінде кеңінен пайдаланылады. Қорытынды бақылау жұмыстарын, емтихан өткізу кезінде компьютерлер «қазы» рөлін де әділ атқара алаты құрал ретінде белгілі.

Электронды оқулықтар қазіргі ақпараттық коммуникациялық білім беру парадигмасының құралы.

-тез арада қайтарма байланыс болуын қамтамасыз етеді.(интереактивті қасиеті)

-қажетті ақпартаттық материалдарды жылдам тауып алуға мүмкіндік береді;

- гипермәтіндік түсіндіруден жан- жақты ақпараттық материалдар алады:

-әрбір жеке тұлғаның , білімін, білік іскерлігін әрбір тараулар бойынша тексеруге, бағалауға мүмкіндік береді.

Мультимедиялық құралдар

Мультимедия- бұл аппаратық комплекс пен құрал – жабдықтар бағдарламасы, яғни пайдаланушылардың диалогтік режимде графикпен жұмыс істеуіне мүмкіндік береді.

Қашықтықтықтан оқыту (ҚО) – білім, білік дағдыларды алу үрдісі, бұл кезде оқыту процедураларының тұтас немесе белгілі бір бөлігі оқытушы мен студенттің территориялық алшақтығына қарамастан жаңа ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялардың көмегімен жүзеге асырылады.

Видео- конференциялар

Онлайн – конференция сайт оқырмандарының конференция ұйымдастырушыларымен тікелей байланысқа түсуі. Онлайн конференция өзінің қарапайымдылығы мен қолайлылығының арқасында дәстүрлі баспасөз – конференциясымен салыстырғанда бірқатар айырмашылықтары болады. Онлайн – конференцияға қатысып, сұрақ қою үшінде тіркелуге, тіркелмеуге де болады. Сондай – ақ тіркелген жағдайда өзіңіз жайлы нақты мәліметті көрсетпеуге де мүмкіндік бар. Онлайн – конференция бұл белгілі уақыт аралығында өтетін іс – шара, алайда кейде сұрақты алдын ала қоя аласыз.

Бейнекамера және теледидарлық құралдар.

ISBN 978-601-08-0758-7

Теледидарлық бейнежазуға арналған кассеталық бейне магнитофонмен біріктірілген құрал. Бейне камерада бейне және дыбыс сигналдарын жазу, қарау, пәнге байланысты кино көруге, дәрістер тыңдауға ойындар (сөзжұмбақ, сантылсым, биологиялық диктант) пайдалануға болады.

Презентациялар

Компьютерлік презентациялар қолдану сабақты көрнекті және жан - жақты етіп, жаңа сабақты жақсы игеруге көмектеседі.

Гипермәтіндік сілтемелер

Гипермәтіндік құжат деп аталу себебі, онда бір құжаттан басқа да құжаттарға кері сілтемелер жасауға болады.

Білімді бағалауда тестілеудің онлайн формасының тиімділігі

Kahoot, Wordwall қосымшасы - статистикалық жұмыс жасау үрдісін жеңілдететін және аудиторияның жауабын лезде бағалап беретін қосымша.

Білім сапасын арттырудағы жаңа инновациялық технологияларды оқып, үйреніп, сараптай келе, мынандай тұжырымдама жасауға болады:

Білім алушылардың білім, білік сапасын арттырудағы жаңа инновациялық технология түрлері сан алуан, оларды таңдау және одан шығатын нәтиже оқытушының кәсіби біліктілігіне тікелей байланысты;

Жаңа инновациялық технологияларды енгізу жүйелі әрі мақсатты түрде жүргізілгенде ғана жетістікке жетуге болады.

Оқу – тәрбие үрдісінде қолданып, айтарлықтай нәтиже беріп жүрген инновациялық технологиялар мыналар: дамыта отырып оқыту әдістемесі

- оза отырып оқыту
- тірек және тірек конспектілері арқылы оқыту
- деңгейлеп оқыту технологиясы
- тесттік жүйемен оқыту
-мультимедия мүмкіндіктерін қолданып оқыту
- интеграциялық сабақтар
- проект(жоба) сабақ
- проблемалық оқыту әдістемесі
- «Миға шабуыл» әдісі
- Қашықтықтан оқыту технологиясы

Осы инновациялық технологияларды мүмкіндігіне қарай биология пәнінде қолдансақ, болашақ маман иесі тәжірибелі білімді, күнделікті өмірде қажеттілігін түсінетін, өзінің теория жүзінде алған білімін өмірмен ұштастыра алатын, табиғат пен қоғамдағы өзгерістерді эмоционалды тұрғыда қабылдайтын, өздігімен ізденетін тұлға қалыптасады.

Өз сабақтарымда, химия пәнінің үйірмесінде әр түрлі өзіндік жұмыстың түрлерін қолданамын. Мысалы: пресс-конференция сабағында білім алушылар өздерін журналист, фотокорреспондент, техникалық қызметші, зерттеуші ғалым рөлдерінде жеке ізденіс-зерттеу жұмыстарын жүргізеді. Пәндік үйірмеге қатысушыларға жыл бойы ізденуге, зерттеуге, сауалнама жүргізуге арналған әр-түрлі тақырыптар беріледі. Мысалы: косметикалық және гигиеналық заттардың

ISBN 978-601-08-0758-7

құрамы, белсендірілген көмірдің құпиясы, химиялық қоспалармен шаштын структурасын өзгерту, алтынның сынамасын анықтау.

Студенттердің өздік жұмыстарының қарапайым және қолайлы түрі – белгілі бір тақырыптағы баяндама немесе деректі мәселені талқыға салатын ғылыми жиналыс түрінде ұйымдастыру. Бұған мұғалімдердің де шығармашылық әдіс-амалдары қажет. Мысалы, студенттердің жазған «мазмұндамасын», жасаған «семестрлік, курстық жұмыстарын» әдеттегідей қабылдай салмай, әр-түрлі ғылыми пікірталас ұйымдастыру арқылы қабылдаған әлдеқайда тиімді. Бір жобаны 2-3 студент орындаса, жобаның практикалық сапасын арттыруға болатындығы көрінеді, яғни, бұл топтастырған тәсіл өз бетімен жұмыс істеуге, өзара көмек көрсетуге, шығармашылығын және жауапкершілігін арттыруға себебін тигізетіндігі анық. Өйткені жобалау кезінде студенттер таңдау еркіндігін алады.

Қорытынды: Химияны оқуда өзбетімен жұмысты ұйымдастыру үшін оқушы негізгі заңдылықтарды меңгеріп, химиялық білімді тұжырымдап, ғылыми мәселелерді шешу мәселесін көрсетіп оларды шешудің тиімді жолдарын анықтай білуі тиіс. Оқушыларды химиялық мәселелерді өзбетімен шешуге үйрете отырып оқытушы алдымен бірқатар мысалдар негізінде болжам құруға, мәселе қоюға, оның дұрыс шешімін табуға жол көрсетеді. Заман талабына сай ақпараттық технологиялардың да көптеген элементтерін қолданамын: word padlet, miro қосымшасында тапсырмалар дайындау, Jamboard тақташасымен жұмыс, Quizlet, Kahoot, Quizizz, Wordwall платформаларында викторинаға жауап беру, LearningApps, Twinkl платформасында ойындар, интерактивті жаттығулар орындау, виртуальді зертханамен жұмыс.
Қорытындылай келгенде, еліміздің болашақ мамандары қоғам талабына сай жан-жақты қаруланууы үшін төмендегі міндеттерді әрбір оқытушы орындауы қажет. Менің басты мақсатым оқушыны өз бетінше жұмыс істеуге баулу арқылы оның өзін-өзі дамытуына жағдай жасау. Өз бетінше ізденуге баула оқушыны қатарластарымен еркін сөйлесуге, пікір таластыруға, бір-бірінің ойын тыңдауға, құрметтеуге, өзекті мәселені шешу жолдарын іздеуге, қиындықты жеңуге баулиды.

Әдебиеттер тізімі

1. Абсаттаров Р.Б., Байлярова Б.К. Идейно-политическое воспитание в студенческом коллективе. – Алма-Ата: КазГУ, 1989. – 32 с.Политиздат, 1986.
Нұрмағамбетов А.А. Образовательная политика Республики Казахстан в контексте трансформации системы высшего образования. — Алматы, 2002. — 35 с.
2. Қазіргі заманғы педагогикалық технологиялар Ф. Б. Бөрібекова Н. Ж. Жанатбекова : Оқулық. – Алматы: 2014. – 360 бет.
3. 4.Бұзаубақова К.Ж. Жаңа педагогикалық технология. – Тараз,2003
4. 5.Тусупбаева А. «Казіргі сабақтардағы проблемалық оқыту технологиясы. – Алматы, 2012 »
5. 6.Қисымова Ә.К., Нурланов Е.Б Педагогикалық технологиялар. Оқу – әдістемелік құрал- Алматы,2012

ISBN 978-601-08-0758-7

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫНЫҢ БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ОЙЛАУ ҚАБІЛЕТТЕРІН ДАМЫТУҒА ӘСЕРІ

Ерболатова Ә.Е. Амантаева Т.Ш.
Астана қаласы әкімдігінің ШЖҚ «Жоғары медициналық колледж» МКК

Аннотация: *Қазіргі заманда оқу процесінің жоғары көлемі, қарқындылығы, әртүрлі инновациялармен сипатталатын оқыту практикасы жағдайында денсаулықты сақтау және нығайту, білім алушы жастарды салауатты өмір салтына баулу мәселесі өте маңызды болып табылады. Білім беру мазмұнына енгізілген көптеген жаңалықтарды игеру қазіргі уақытта білім беру процесіне қатысушылардан айтарлықтай энергия шығынын талап етеді, сондықтан балалардың білімі өте қымбат баға – олардың денсаулығымен "төленеді". Салауатты өмір салтын қалыптастырудың маңыздылығы мен қажеттілігін түсіне отырып, ҚР Үкіметі бұл проблеманы бірқатар құжаттарда көрсетті: «Қазақстан Республикасының 2050 жылға дейінгі даму стратегиясы», «Саламатты Қазақстан», «Азаматтардың денсаулығын сақтау туралы» ҚР Заңы, қазақстандық азаматтардың, оның ішінде студенттердің денсаулығын сақтау мен нығайтудың негізгі жолдарын анықтайды. Ұлттық салауатты өмір салтын қалыптастыру мәселелері орталығы (СӨСҚ ҰО) мамандарының басшылығымен мектепке дейінгі балалар мекемелері, жалпы білім беретін мектептер, арнаулы орта және жоғары оқу орындары үшін «Валеология - қалай сау болу керек» оқу бағдарламалары әзірленіп, енгізілді.*

"Денсаулық сақтау технологиясы" ұғымы оқытушы мен студенттердің денсаулығын сақтау мәселесінің қаншалықты шешілетінін көрсететін кез-келген білім беру технологиясының сапалық сипаттамасын білдіреді.

Денсаулық сақтау технологиялары – бұл негізгі критерийлерді қанағаттандыратын білім беру технологиялары: "Денсаулық сақтау білім беру технологиялары" терминін кез-келген білім беру технологиясының сапалық сипаттамасы, оның "денсаулық қауіпсіздігі сертификаты" ретінде және дәстүрлі оқыту мен тәрбиелеу технологияларын толықтыратын педагогикалық жұмыстың принциптері, әдістерінің жиынтығы ретінде қарастыруға болады. денсаулық сақтаудың белгісі.

Денсаулық сақтау педагогикасы белгілі бір білім беру технологиясымен көрінбейді. Сонымен қатар, "денсаулық сақтау технологиясы" ұғымы білім беру мекемесі қызметінің студенттердің денсаулығын қалыптастыру, сақтау және нығайту жөніндегі барлық бағыттарын біріктіреді.

Статистикаға сәйкес, соңғы жылдары мектеп түлектері, колледж студенттері арасында сырқаттанушылық деңгейі тұрақты өсуде. Бұл физикалық ауытқулар ғана емес, сонымен қатар бұрыс психологиялық реакциялар санының артуы. Мұндай құбылыстар алаңдатпай қоймайды, өйткені студенттер күндізгі

ISBN 978-601-08-0758-7

уақытының жартысынан көбін оқу орындарында өткізеді және нәтижесінде кәсіптік білім беру жүйесі жас ұрпақтың денсаулығын сақтау үшін жауапкершіліктің бір бөлігін өз мойнына алуы керек.

Жетекші ой: денсаулық сақтауды қалыптастырудың тиімділігі студенттердің ақыл-ой қызметін жетілдіру мақсатында Денсаулық сақтау технологияларын және олардың принциптерін оқыту процесінде іске асырумен, студенттерге Денсаулық сақтауды жүйелі түрде таныстырумен қамтамасыз етіледі.

Негізгі міндет келесідей:

Студент үшін оның денесі мен психикасына зиян келтірмейтін оқу жағдайларын жасау, сонымен қатар білім алушыға денсаулықтың құндылығы мен оны сақтау жолдары туралы білім беру. Бұл тек физикалық денсаулық туралы ғана емес, сонымен қатар психикалық жеткіліктілік, әлеуметтік бейімделу және моральдық дамудың тиісті деңгейін қамтитын әл-ауқаттың кешенді көрсеткіші туралы екенін атап өткен жөн.

Осылайша, білім беру үдерісіндегі Денсаулық сақтау технологиялары-білім беру үдерісі субъектілерінің физикалық, рухани және адамгершілік денсаулығын сақтауға және нығайтуға барынша ықпал ететін әдістер мен жағдайлар кешені.

Денсаулық сақтау технологияларын жіктеу әдістері, олардың тұжырымдамасы өте кең. Оларды көптеген белгілер бойынша жіктеуге болады, бірақ олардың кейбіреулері іс жүзінде өте маңызды. Осындай белгілердің бірі-субъективті белсенділік.

Осы негізде денсаулықты сақтайтын технологияның үш түрі бар:

• субъективті емес (студент қазіргі уақытта оның денсаулығына қамқорлық жасайтынын білмеуі де мүмкін);

- пассивті позицияны білдіреді;
- белсенді позицияны білдіреді.

Студенттердің психикалық белсенділікке деген қызығушылығын анықтауда бірнеше әдістер қолданылды: эмоционалды фонды, оқу-танымдық белсенділікті анықтау, студенттердің жауаптарын талдау. Эмоционалды реакцияларды бақылау әдісі тапсырмаларды орындау кезінде психоэмоционалды көріністерді тіркеді: психикалық белсенділік процесіне деген құштарлық, қуаныш, қанағаттану, тітіркену эмоциялары, нақтылау сұрақтарының сипаты және т.б. Бұл параметрлер г. И. Щукинаның зерттеулеріне сәйкес танымдық қызығушылықтың көрсеткіштері болып табылады. [15].

Салауатты өмір салтын қалыптастыру мақсатында Денсаулық сақтау технологияларын қолдану арқылы студенттердің психикалық қызметін жетілдіру процесін ұйымдастыру деңгейлерін анықтау және сипаттау үшін келесі критерийлер мен көрсеткіштер анықталды:

* мотивациялық-қажеттілік критерийі: СӨС тану құралы ретінде қоғамдағы өмірдің әлеуметтік маңызды нормасы түрінде, бұл салауатты өмір салтына деген ішкі қажеттіліктерді, мотивтерді, қызығушылықтарды, тілектерді және т. б.

ISBN 978-601-08-0758-7

анықтауға деген ұмтылыста көрінеді (көрсеткіш-студенттің салауатты өмір салтына деген мотивтер мен көзқарастардың деңгейі);

* адамгершілік-құндылықтық критерий: СӨС, өмірлік құндылық ретінде СӨС-ке қатынасты сипаттайтын кәсіби-жеке қасиет ретінде ақыл-ой жұмысқа қабілеттілігі (көрсеткіш - СӨС-ті құндылықтар ретінде қабылдау деңгейі);

* танымдық критерий - СӨС дүниетаным ретінде (көрсеткіш-СӨС туралы білім деңгейі);

* праксиологиялық (белсенділік) критерий: СӨС мінез-құлық сызығы ретінде (көрсеткіш-СӨС дағдыларының, құзыреттіліктерінің қалыптасу деңгейі);

* рефлексивті критерий: СӨС денсаулық мәдениетін, интеллект мәдениетін қалыптастыру нәтижесі ретінде, талдау және бағалау (көрсеткіш - денсаулық мәдениетінің деңгейі).

Белсенді позицияның айқын артықшылығына қарамастан, оқытушы өзі үшін студенттің барлық үш түрі бойынша Денсаулықты сақтау принциптерін іске асыру әдістерін әзірлеуі керек. Студенттің белсенді ұстанымын қалыптастыруға тек жағымды ғана емес, сонымен бірге жағымсыз факторлар да әсер ететіндігін ескеру қажет.

Сондай-ақ денсаулық сақтау технологиялардың барлық көлемінде санитарлық-гигиеналық шараларды және нақты педагогикалық шараларды бөлуге болады.

Денсаулықты сақтау технологиясының гигиеналық компоненті:

* бөлмедегі жағдайлар (температура, жарық, желдету, тазалау режимі);
* ұтымды тамақтануды ұйымдастыру;
* сабақ режимінің оқушылардың санитарлық нормалары мен жас ерекшеліктеріне сәйкестігі;
* жұмыс орнын ұйымдастыру кезінде студенттің денсаулық жағдайын есепке алу.

Педагогикалық денсаулық сақтау технологиялары сабақтарды тиімді меңгеруге қол жеткізетіндей етіп құра білуден тұрады. Мынадай тәсілдер неғұрлым маңызды: практикалық сабақтарда қызмет түрлерін ауыстыру, ең қызу жұмыс оның ортасына келетін сабақтар барысында жүктемені ұтымды бөлу. Жұмыстың ойын және рөлдік нысандарын қолдану, қолайлы эмоциялық атмосферамен сабақты диалогтық жүргізу қолданылатын ынтымақтастық атмосферасын құру. Студенттің психологиялық тепе-теңдік жағдайында болуына мүмкіндік беретін сәттілік жағдайын жасау орындалған кезде туындаған стрессті болдырмайды. Тұлғаға бағытталған тәсілді қолдану, әр түрлі қызмет түрлерін ұйымдастыру (топтық, ұжымдық және т.б.). Бақылау-бағалау қызметін жетілдіру: оқушылар зерттелген материалды жинақтайды, өз қызметін, жолдастарының қызметін, жетістіктерін, сәтсіздіктерін бағалайды, түзетулер енгізеді. Интеллектуалды және шығармашылық қабілеттерді, ойлауды, әсіресе логикалық, ұтымды, практикалық дағдыларды қалыптастыру. Логикалық ойлау, есте сақтау, зейін дамыған оқушылар сәтті және қызығушылықпен оқиды, бұл психикалық денсаулыққа, тақырыпты тануға, адамгершілік қасиеттерді қалыптастыруға, жаңа

ISBN 978-601-08-0758-7

ортаға бейімделу қабілетіне тікелей байланысты. Үй тапсырмасының оңтайлы дозасы (соның ішінде көп деңгейлі сараланған тапсырмаларды қолдану).

Студенттік жастықтың екінші кезеңімен немесе жеке тұлғаның қалыптасуының күрделілігімен ерекшеленетін алғашқы жетілу кезеңімен сәйкес келетіндігі – Б.Г. Ананьев, А. В. Дмитриев сияқты ғалымдардың еңбектерінде талданған процесс. Осы жастағы адамгершілік дамудың тән белгісі-мінез-құлықтың саналы мотивтерін күшейту. Моральдық мәселелерге қызығушылық артады (мақсат, өмір салты, міндет, махаббат, адалдық).

Студенттердің ақыл - ой қызметін жетілдіру үшін денсаулық сақтау технологияларын қолданудың мәдени сәйкестілік принципі денсаулық мәдениетін (тамақтану мәдениеті, қозғалыс мәдениеті, эмоциялар мәдениеті және зияткерлік мәдениет) қалыптастыруға байланысты мәдени факторларға; салауатты өмір салты мәселелерін танымалдау негізінде қоғамдық, ұлттық, діни идеялармен, дәстүрлермен, салт-дәстүрлермен халықтың бос уақытын ұйымдастыруға; рекреациялық-терапиялық әдістерді белсенді қолдануға байланысты.

Валеологиялық-дидактикалық қағидат студенттердің салауатты өмір салтына деген қажеттіліктерін тұтастай алғанда және денсаулық сақтау технологияларын қолдану арқылы студенттердің ақыл-ой қызметін жетілдіруде және салауатты өмір салтын ұстануға ынталандыруды негіздейді, студенттің валеологиялық білім беру әдіснамасын қалыптастырады.

Педагогикадағы табиғаттылық қағидатын ұстану Денсаулық сақтау технологияларын қолдану арқылы студенттердің ақыл-ой қызметін жетілдіру, жеке тұлғаның СӨС қалыптастыру бойынша тұрақты және үздіксіз жұмысты ұйымдастыру қажеттілігін, ЖОО-да кәсіптік білім берудің әр кезеңінде СӨС қалыптастырудың міндеттілігін, студенттердің СӨС-ке дайындығын қамтамасыз ету қажеттілігін білдіреді.

Студенттердің ақыл-ой қызметін жетілдіру мақсатында Денсаулық сақтау технологияларын қолданудағы интеграция принципі оқу орнының құрылымдық бөлімшелерінің, білім беру процесінің субъектілерінің студенттердің денсаулық мәдениетін қалыптастыру бағытындағы өзара іс-қимылын күшейтуді білдіреді.

Қазіргі теориялық зерттеулерде Денсаулық сақтау білімі көп қырлы және көп деңгейлі психологиялық білім ретінде қарастырылады- медициналық сауықтыру шараларын жүргізуді ғана емес, сонымен қатар гигиеналық шараларды сақтауды да көздейтін педагогикалық құбылыс талаптар, моторлы және статикалық жүктемелердің оңтайлы үйлесімі, шағын топтарда оқыту, сабақта эмоционалды қолайлы атмосфера құру.

Денсаулық сақтау технологиясы өз кезегінде денсаулықты сақтауға ықпал ететін әдістер мен әдістерді қолдана отырып, дамытуда, тәрбиелеуде, оқытуда жоспарланған нәтижені қамтиды. Денсаулық сақтау педагогикасының басты міндеті-білім алушылардың еңбегі мен демалысын ұйымдастыру, сондай-ақ оқу уақыты бойы жоғары жұмыс қабілеттілігін қамтамасыз ететін, шаршауды ырыстырып, артық жұмыс істемеуге мүмкіндік беретін жағдайлар жасау.

ISBN 978-601-08-0758-7

Қорытынды: Денсаулық сақтау технологияларын білім беру жүйесінің ажырамас бөлігі және білімге қатысты барлық нәрсе ретінде қарастыру керек – әдістер мен оқыту және тәрбиелеу әдістері, мұғалімдердің кәсіби мәдениетінің деңгейі, оқу процесін жүргізу шарттары және т.б., бәрі балалардың денсаулығына тікелей байланысты. Білім беру процесінің орталығында білім алушы тұрса да, ондағы негізгі тұлға педагог болып қала береді, оның жұмыс деңгейіне Денсаулық сақтау технологияларын іске асыру дәрежесі тікелей байланысты.

Салауатты өмір салты біздің қоғамдағы адамның қажеттіліктері мен құндылықтарында әлі бірінші орын алмайды. Сондықтан студентті денсаулығын бағалауға, қорғауға және нығайтуға үйрету керек, салауатты өмір салтын көрсетудің жеке үлгісі болу керек, тек осы жағдайда болашақ ұрпақ жеке, интеллектуалды, рухани ғана емес, физикалық тұрғыдан да сау және дамыған болады деп үміттенуге болады.

Осылайша, Денсаулық сақтау технологияларын іске асырудың басты міндеті-оқушыларды сапалы оқыту, дамыту және тәрбиелеу олардың денсаулығына зиян келтірумен қатар жүрмейтін барлық деңгейлерде Кәсіптік оқыту процесін ұйымдастыру.

Бақылаулар көрсеткендей, оқу процесінде Денсаулық сақтау технологияларын қолдану студенттің оқу және әлеуметтік кеңістікте сәтті бейімделуіне, шығармашылық қабілеттерін ашуға және мұғалімге әлеуметтік мінез-құлықтың алдын алуды тиімді жүргізуге мүмкіндік береді.

Әдебиеттер тізімі:

1. 2012 жылы желтоқсанда 1-ші Мемлекет басшысының ел халқына Жолдауында «Қазақстан Республикасының 2050 жылға дейінгі даму стратегиясы».

2. «Саламатты Қазақстан» - Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың 2011-2015 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы.

3. КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН О здоровье народа и системе здравоохранения(с изменениями и дополнениями по состоянию на 09.09.2024 г.)

4. Антропова М.В. Основы гигиены учащихся: Просвещение, 2000. Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе/ авт.-сост. С.А. Цабыбин.-Волгоград: Учитель. 2009.

5. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии.М.: Просвещение, 2013.

6. Современные технологии сохранения и укрепления здоровья подростка: Учеб. пособие / Под общ. ред. И.Т. Карасева, 2017.

7. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 4 шілдедегі № ҚР ДСМ-63 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 5 шілде.

ISBN 978-601-08-0758-7

БОЛАШАҚ МЕЙІРГЕР МАМАНДАРЫН ОҚЫТУДАҒЫ ЖАҢА ТӘСІЛДЕР МЕН ИННОВАЦИЯЛАР

Көшкінбаева Мөлдір Талғатқызы, Мейірбике ісі негіздері пәні оқытушысы
Шымкент қ. ДСБ ШЖҚ «Жоғары медицина колледжі» МКК

Аннотация: *Медициналық білім беруді дамытуда медицина саласындағы онлайн курстар, заманауи технологиялар мен инновациялық тәсілдер маңызды рөл атқарады. Медицинада жыл сайын елеулі өзгерістер орын алып, болашақ медицина мамандарынан жаңа білім мен дағдыларды талап етеді. Бұл мақалада біз медициналық білім беруде қолданылатын жаңа тәсілдер мен технологияларды және олардың жоғары білікті дәрігерлердің қалыптасуына әсерін қарастырамыз.*

Денсаулық сақтау саласындағы үлкен өзгерістер мен технологиялық жаңартулар мейіргер мамандарына жаңаша қарауды және олардың кәсіби дағдыларын дамытуды қажет етеді. Осы мақсатта болашақ мейіргер мамандарын оқытуда заманауи әдістер мен инновациялар қолданылуда. Олардың арасында виртуалды шындық, симуляциялық оқыту, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, жеке тұлғаға бағытталған тәсілдер және халықаралық тәжірибені ескеру сияқтылар бар.

Медициналық білім берудегі виртуалды шындық

• Процедураларды модельдеуде виртуалды шындықты қолдану. Заманауи виртуалды шындық технологиялары медицина студенттеріне әртүрлі медициналық процедураларды имитациялай алатын виртуалды ортаға енуге мүмкіндік береді. Бұл оларға пациенттерге қауіп төндірмей, олардың болашақ кәсіби мансабына сенімділігі мен тиімділігін арттырмай, тәжірибе жинақтауға мүмкіндік береді.

• Симптомдарды тану және диагностикалау бойынша оқыту. Виртуалды шындықты пайдалану студенттерге әртүрлі аурулардың белгілерін тану және диагностикалау дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді. Олар виртуалды емделушілерге жаттығып, содан кейін алған білімдерін тәжірибеде қолдана алады. Бұл олардың медициналық жағдайларды анықтау және өңдеу қабілетін жақсартуға көмектеседі.

• Бірлескен оқыту және телемедицина. Виртуалды шындық сонымен бірге бірлескен оқу мен телемедицинаны жеңілдетеді. Студенттер мен оқытушылар виртуалды сыныптарда өзара әрекеттесе алады, жағдайларды талқылап, тіпті әртүрлі жерлерден тәжірибе алмаса алады. Бұл бірлескен оқу орталары әртүрлі

ISBN 978-601-08-0758-7

елдердің студенттеріне білім алмасуға және дағдыларын жетілдіруге мүмкіндік береді.

Мобильді қосымшалар және онлайн оқу платформалары

• Кез келген уақытта және кез келген жерде білім алу мүмкіндігі. Мобильді қосымшалар мен онлайн платформалар студенттерге өздеріне ыңғайлы уақытта және ыңғайлы жерде білім алуға мүмкіндік береді. Бұл әсіресе шалғай елді мекендерде болуы мүмкін немесе оқу орындарына кіру мүмкіндігі шектеулі студенттер үшін өте маңызды.

• Интерактивті оқу материалдары және тестілеу. Мобильді қолданбалар мен онлайн платформалар интерактивті оқу материалдарын, соның ішінде бейне сабақтарды, анимацияларды және тесттерді ұсынады, бұл студенттерге тиімдірек оқуға көмектеседі. Бұл тәсіл оқуды қызықты және қызықты етіп, жақсырақ оқуға ықпал етеді.

• Желілік мүмкіндіктер және тәжірибе алмасу. Мобильді қолданбалар мен онлайн платформалар студенттерге басқа медициналық студенттермен және дүние жүзіндегі мамандармен байланысуға және тәжірибе алмасуға мүмкіндік береді. Бұл сіздің ой-өрісіңізді кеңейтуге, пікір алмасуға және жаңа білім алуға көмектеседі.

Мейіргер мамандығына деген қызығушылықты арттыру үшін әр түрлі тәсілдер қолданылады. Бұл мамандық денсаулық сақтау саласындағы маңызды және жауапты қызмет түрі болғандықтан, оған деген қызығушылықты арттыру өте маңызды. Медициналық колледждер мен университеттерде мейіргер мамандығының ерекшеліктері мен артықшылықтары жөнінде ақпараттық-түсіндіру жұмыстары жүргізіледі. Сонымен қатар, жастардың осы кәсіпке деген таңдауын ынталандыру мақсатында мейіргер мамандарының өз тәжірибелерімен бөлісу шаралары ұйымдастырылады.

Дәстүрлі білім берумен бірге олардың тәжірибе талаптарына сай келетін жоғары құзыреттілігін дамытуға және болашақ қызметінің сапасын қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін инновациялық технологияларды қолданбай мейіргерлерді заманауи даярлау мүмкін емес [1]. Медициналық жоғары оқу орындарында студенттерді кәсіби іс-әрекетті проблемаларды шешу мен модельдеу принциптерін және сәйкесінше жаңа педагогикалық технологияларды біріктіретін ең перспективалы оқыту жолдары: проблемалық оқыту, командалық оқыту, жағдайға негізделген оқыту, кіріктірілген оқыту, ақпараттық-коммуникациялық және компьютерлік технологиялар, симуляциялық оқыту, жобалық оқыту [2]. Соңғы онжылдықта медициналық білім берудің айтарлықтай модернизациясы орын алды, медициналық колледж студенттерін даярлаудың жаңа тәсілдері қалыптасты, студенттерді симуляциялық оқытуға көп көңіл бөлінген жаңа оқу бағдарламалары әзірленді [3].

ISBN 978-601-08-0758-7

Зерттеудің мақсаты – колледж студенттерінің оқу процесіне инновациялық технологияларды енгізуді талдау.

Зерттеу материалы мен әдістері: аналитикалық шолу, педагогикалық эксперимент, бақылау, студенттерге сұрақ қою, клиникалық жағдайды талдау әдісі, виртуалды симуляторларды қолдану негізінде нақты клиникалық жағдайды имитациялау әдісі, сұрақ қою арқылы науқастарды физикалық тексеру әдісі, клиникалық тексеру әдісі, пальпация, перкуссия, аускультация; нақты науқастарды бірлескен тексеру әдісі, ауру синдромдарын таңу әдісі, қосымша зерттеу әдістерінің нәтижелерін интерпретациялау әдісі.

Зерттеу нәтижелері және талқылау. Шымкент қаласы ДСБ ШЖҚ «Жоғары медицина колледжі» МКК-де дәстүрлі және заманауи оқыту әдістері қолданылады. Дәстүрлі әдістерге тиісті тақырып бойынша дәріс оқу және практикалық сабақтар өткізу жатады. Заманауи әдістерге симуляциялық технологияларды қолдану, кейс негізінде оқыту және т.б.

Колледж студенттерін оқытуда қолданылатын дәстүрлі оқытудың негізгі әдісі түсіндірмелі және иллюстративті болып табылады. Студенттерді оқытудың дәстүрлі әдістерімен ауызша, жазбаша және аралас сауалнамалар жүргізіледі. Әр семинар сабағында және әрбір модульдің соңында ауызша сауалнама жүргізіледі. Студенттердің білімін бақылау жазбаша сауалнама түрінде де әрбір семинар сабағында, сондай-ақ әрбір модульдің соңында және қорытынды бақылауда жүргізіледі. Сауалнаманың дәстүрлі түрлері студенттердің ағымдағы білімдерін бақылау кезінде жүргізіледі.

Біздің колледж студенттерінен теориялық білім алу қиын емес – олардың қолында көптеген кітаптар, мақалалар, лекциялар, бейнероликтер бар. Медициналық студенттердің практикалық тәжірибесін жинақтау аға әріптестердің әрекеттерін бақылау, содан кейін олар көрген манипуляцияларды қайталау процесінде жүреді, бұл айтарлықтай көп уақытты қажет етеді. Егер практикалық манипуляциялар дұрыс орындалмаса, студенттер науқасқа зиян келтіруі мүмкін. Сондықтан колледждің практикалық сабақтары клиникалық дағдыларын меңгеру үшін симуляциялық орталықта өтеді.

Тәжірибелік сабақтарда студенттер клиникалық ойлауды, медициналық тәжірибенің алгоритмдерін үйренеді, нақты клиникалық мысалдарды (науқастың төсегінде және клиникалық мәселелер мысалында) пайдалана отырып, симптомдар мен синдромдар және олардың патогенезі арасындағы байланыстарды іздейді [4]. Нақты клиникалық жағдайды имитациялау технологияларын қайталап қолдану арқылы студенттерде науқасты физикалық тексеру, белгілі бір клиникалық жағдайды дұрыс бағалау дағдылары қалыптасады, бұл олардың болашақ тәжірибесінде көмектеседі.

Кредиттік оқыту технологиясы студенттердің пәнді өз бетінше меңгеруіне көп уақыт бөлетіндіктен, клиникалық жағдайға негізделген оқытудың инновациялық технологиясы (Case Based Learning – CBL) ең қолайлыларының бірі болып табылады.

ISBN 978-601-08-0758-7

CBL технологиясы клиникалық бөлімшелерде болашақ мейіргерлер арасында диагностика мен емдеуге құзыретті көзқарасты қалыптастыру үшін кеңінен қолданылады [5].

CBL әдісі арқылы студенттер нақты клиникалық жағдайлар мен мәселелерді шешуді үйренеді, белгілерді табуды және оларды клиникалық синдромдарға біріктіруді үйренеді, жетекші синдромды анықтайды. CBL әдісінің дәстүрлі әдістерден артықшылығы: оқушылардың үлгерімінің жоғарылауы, оқу процесіне оң көзқарастың пайда болуы, ұзақ мерзімді жадының күшеюі, концептуалды ойлаудың пайда болуы, оқудағы мотивация, есептерді шешу дағдыларының жақсаруы.

Кейс-стади технологиясының сипаттамасы: шешім қабылдау және мәселені шешу дағдыларын дамыту; теория мен практиканы байланыстыруға, сыни ойлау деңгейін арттыруға, топтық жұмыс дағдыларын ынталандыруға, нақты өмірлік жағдайлардың күрделілігін түсінуге, әртүрлі көзқарастарды дамытуға көмектеседі [5].

Сабақтың мақсаты мен міндеттерімен танысқаннан кейін оқытушы сабақтың әдістемесі мен формасын түсіндіреді, содан кейін студенттердің сабаққа дайындығын анықтау үшін тест жүргізеді. Студенттердің сабаққа дайындық деңгейін анықтағаннан кейін студенттер тобы 4-5 адамнан тұратын шағын топтарға бөлінеді (кездейсоқ таңдау әдісімен). Командаларға тақырыптың мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес келетін әртүрлі клиникалық тапсырмалар (төменде берілген тапсырмалар) беріледі. Әрі қарай топ мүшелері мәселені талқылайды, біртұтас диагностикалық шешім қабылдайды, топ мүшелерінің бірі талқылау нәтижелерін хабарлайды. CBL технологиясын қолдану арқылы сабақтың жалпы бағасы берілген тапсырманы шешудің дұрыстығын бағалауға тең, оқушылардың белсенділігі, олардың пікірталасқа жетекшілік ету, проблеманы шешуде қызықты идеяларды ұсыну қабілеті де ескеріледі. Жауап берген студенттің жеке ұпайы жалпы командалық ұпайға тең. Әрбір клиникалық жағдайға топ жауаптарын бағалауға арналған үлгілер де құрастырылды. Командалардың жауаптары келесі критерийлер бойынша бағаланады: «Науқасты тексеру», «Алдын ала мейірбикелік диагноз қою», «Тексеру жоспарын құру», «Жоспарды жүзеге асыру», «Нәтижесін бағалау».

Әрбір дәрістің басында дәріс тақырыбы бойынша клиникалық жағдай талданады. Әрі қарай студенттер оқытушымен бірге аурудың клиникалық белгілерін тану, науқастың клиникалық белгілерін синдромдарға біріктіру, жетекші синдромды анықтау, науқасты тексеру бағдарламасын тағайындау, аурудың клиникалық белгілерін анықтауды үйренеді. Дәріс соңында оқытушы студенттердің тақырыптың негізгі тұстарын меңгерген-игермегенін анықтау мақсатында студенттерге сұрақтар қояды.

Студенттері арасында сауалнама жүргізіліп, оның қорытындысы бойынша студенттердің 85,5%-ы өтілген материалды түсінетіндігі, ал студенттердің 91,8%-ы сабақ сапасына қанағаттанғандығы анықталды.

ISBN 978-601-08-0758-7

Осылайша, колледж студенттерін оқытудың заманауи әдістерін енгізу студенттердің клиникалық дағдыларды меңгеруін, топпен жұмыс істеу дағдыларын және зерттеу дағдыларын жетілдіруге көмектеседі.

Қорытынды

Білікті мейіргерлерді қалыптастыру үшін медициналық білім берудегі жаңалықтардың маңызы зор. Виртуалды шындық, жасанды интеллект және мобильді қосымшалар/онлайн платформалар студенттерге білім алу және даму үшін жаңа мүмкіндіктер береді. Олар практикалық жағдайларға енуге, медициналық деректерді талдауға, жеке оқытуға және ынтымақтастыққа ықпал етеді. Мұндай жаңашылдықтар білім сапасын арттырып, болашақ мейіргерлердің дайындығын жетілдіріп, жалпы медицинаның дамуына септігін тигізеді. Болашақ медицина мамандарын барынша дайындауды қамтамасыз ету үшін ғылыми зерттеулерді жалғастыру және жаңа технологияларды медициналық білім беруге енгізу маңызды.

Әдебиеттер тізімі:

1. Бакирова Р.Е., Нурсултанова С.Д., Муравлёва Л.Е., Тусупбекова К.Т., Турханова Ж.Ж., Аширбекова Б.Д.
2. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ МЕДИКОВ // Современные проблемы науки и образования. – 2018. – № 3.;
3. Абдрахманова А.О, Калиева М.А., Сыздыкова А.А. и др. Эффективные методы преподавания в медицинском вузе: методические рекомендации. - Изд. 1 / А.О. Абдрахманова, М.А. Калиева, А.А. Сыздыкова и др. - Астана, 2015. - 55 с.
4. Парамонова Н.С., Гурина Л.Н. Роль симуляционного обучения в подготовке врача педиатра // Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции с международным участием «Инновационные обучающие технологии в медицине». - Витебск: ВГМУ, 2017. - С. 734-737.
5. Тулохонова И.С. Формирование проектной деятельности студентов технического вуза в условиях предметной информационно-образовательной среды: дис. ... канд. пед. наук. - Улан-Удэ, 2009.
6. Шляхова Г.Н., Балашова М.Е., Шеметова Г.Н. и др. Современные инновационные педагогические технологии в подготовке специалистов первичного звена здравоохранения // Саратовский научно-медицинский журнал. - 2011. - Т. 7, № 1. - С. 165-168.

ISBN 978-601-08-0758-7

ЕГДЕ ЖАСТАҒЫ ПАЦИЕНТТЕРДЕГІ ОҢАЛТУ

Пиржанова Айтры Алмасовна, арнайы пәндер оқытушысы
«Қызылорда медициналық жоғары колледжі»

Аннотация: *Бұл мақалада егде жастағы адамдардың оңалту процедураларына қаншалықты қажеттілігі жайында айтылады. Жасы ұлғайған кезде науқастар дене, психикалық, әлеуметтік функциялары мен әл-ауқат деңгейіне әсер етуі мүмкін көптеген физикалық және эмоциялық өзгерістерге жиі ұшырайды. Оңалту егде жастағы адамдардың функционалдық тәуелсіздігін сақтайды. Гериатриялық науқастарды оңалту пациенттердің әл-ауқаты үшін де, қоғам үшін де императив болып табылады, осылайша біз әлеуметтік және экономикалық тұрғыдан гүлденуіміз керек. Гериатриялық оңалту үшін көру және есту қабілетімен байланысты кез келген сенсорлық бұзылыстарды арнайы жақсартатын қарым-қатынас аса маңызды болып табылады.*

Өзектілігі: Гериатриялық емдік дене шынықтыру - егде жастағы адамдарға және олардың бірегей мәселелеріне арнайы бағытталған емдік дене шынықтырудың бір түрі. Гериатриялық емдік дене шынықтыру егде жастағы адамдардың, әдетте, уақыт өте келе белсенділігі азаятынын, бұлшық ет күшінің, үйлестірудің, реакция мерзімінің төмендеуін бастан кешіріп жатқанын, сондай-ақ дене белсенділігіне төзімділігі төмен болатынын ескереді. Гериатриялық емдік дене шынықтыру емдік дене шынықтырудың басқа түрлерінен ерекшеленеді, себебі ол егде жастағы адамдардың беріктігі мен шыдамдылығын қалыптастыруға көбірек көңіл аударады. Ауруханаға жатқызылғаннан кейін егде жастағы науқастардың 11%-ы оңалту мекемелеріне жіберіледі. Гериатриялық популяцияның көбеюі, сондай-ақ тірек-қимыл аппаратының бұзылуына, депрессияға, қант диабетіне, сондай-ақ неврологиялық бұзылуларға байланысты мүгедектіктің айқын өсуі, атап айтқанда, ұтқырлыққа байланысты қызметке әсер ететін оңалту қажеттілігін арттырады.Ересектерді оңалту: функционалдық ұтқырлық пен мүмкіндікті қолдау үшін функционалдық белсенділікке баса назар аударуға тиіс; дене жаттығулары мен функционалдық қызмет бағдарламалары арқылы тепе-теңдікті жақсарту, жақсы тамақтану және жақсы жалпы күтім (гигиенаны, ылғалдануды, сондай-ақ тиісті демалу мен ұйықтауды қоса алғанда), әлеуметтік-эмоциялық қолдау.[1].

Гериатриялық емдік дене шынықтыру егде жастағы адамдарға бұлшық ет күшін, тепе-теңдікті, сондай-ақ олардың серуендеу қабілетін, олардың жалпы қозғалғыштығы мен жұмыс істеу деңгейін арттыру үшін қажетті үйлестіруді, сондай-ақ күнделікті тапсырмаларды орындай алуы үшін олардың тәуелсіздігін қалпына келтіруге көмектеседі. Жасы ұлғайған кезде науқастар дене, психикалық, әлеуметтік функция мен әл-ауқат деңгейіне әсер етуі мүмкін көптеген физикалық және эмоциялық өзгерістерге жиі ұшырайды. Оңалту егде жастағы адамдардың функционалдық тәуелсіздігін сақтайды. Гериатриялық науқастарды оңалту пациенттердің әл-ауқаты үшін де, қоғам үшін де императив болып табылады,

ISBN 978-601-08-0758-7

осылайша біз әлеуметтік және экономикалық тұрғыдан гүлденуіміз керек. Гериатриялық оңалту үшін көру және есту қабілетімен байланысты кез келген сенсорлық бұзылыстарды арнайы жақсартатын қарым-қатынас аса маңызды болып табылады. Құлау мен остеопороздың алдын алу науқастың денсаулығы мен ұзақ өмір сүруін жақсарта алады. Дұрыс тамақтанбау мәселесін шешу пациентті оңалтудың ресми бағдарламасына қатысу үшін емшілікке және өмірлік маңызы бар мәселелерге ықпал етуі мүмкін. Делириум және ақыл-есінің кемістігі сияқты когнитивтік бұзылыстар науқастың оңалту мақсаттары мен нәтижелеріне әсер етуі мүмкін. [2].

Жұмыстың мақсаты: Оңалтудың негізгі мақсаттарының бірі пациенттің органдары мен дене жүйелерінің функцияларын қалпына келтіру немесе жетілдіру болып табылады. Бұған медициналық процедуралар мен қайталанатын жаттығулар арқылы қол жеткізуге болады.Қозғалыс белсенділігін қалпына келтіру. Әр түрлі жарақаттар мен аурулардан кейін науқастар қозғалыста шектеулі сезінуі мүмкін. Оңалту процесі қозғалыс белсенділігін қалпына келтіруге, сондай-ақ үйлестіру мен икемділікті арттыруға көмектеседі.

Науқастың тәуелсіздігін арттыруға көмектеседі. Оңалтудың тағы бір мақсаты – пациенттің тәуелсіздігін дамыту. Аурухана дәрігерлері мен жалпы практика дәрігерлері оңалтудың негізгі принциптерін білуі, өз пациенттерінде оңалту қажеттілігін тани білуі, сондай-ақ жолдама процесін істеу мақсатында олардың жергілікті оңалту қызметтері туралы жеткілікті білімі болуы тиіс. Егде жастағы адамдарға күтім жасау сырқаттанушылықтың жоғары көрсеткіштері мен бірнеше терапия арасындағы нәзік тепе-теңдікті сақтауды көздейді.Атап айтқанда, жіті неврологиялық аурулар немесе ортопедиялық іс-шаралар және жалпы иммобилизацияға әкелетін кез келген жағдай созылмалы аурулардың жіті асқынуының немесе жаңа патологиялық жағдайлардың басталуының жоғары қаупін туғызатын осы тепе-теңдікке кедергі келтіруі мүмкін. Кез келген хирургиялық операция науқастың ағзасына зор күйзеліс әкеледі. Барлығы ойдағыдай өтсе де, адамның қайтадан күш жинап, ағза қызметтерін қалпына келтіруі үшін оңалту шаралары қажет. Оңалтудың маңыздылығы операцияның өзі немесе емдік терапия секілді хирургиялық араласулардан немесе ұзақ емделуден кем емес.Пациенттің өмірлік маңызды күштерін қалпына келтіріп қана қоймай, сонымен қатар оның психоэмоциялық жай-күйін де жақсарту қажет.Кардиология және ішкі аурулар ҒЗИ кардиология және реабилитация бөлімшесінде аортокоронарлық шунттау, жүрек қақпақшаларын протездеу, туа біткен жүрек кемістігін түзету, сондай-ақ миокардтың жіті инфаргінің көрінісінде жүргізілген коронарлық артерияларды стенттеуден кейін, созылмалы жүрек қызметінің жетіспеушілігі және жүрек ырғағының бұзылысы бар пациенттерге жүрекке кардиохирургиялық оперативтік араласулар жасалғаннан кейін оңалту қызметі көрсетіліп, сіздің денсаулығыңызды қалпына келтіруге көмек береді.Мұнда оңалту кезінде жеке, сондай-ақ топтарда емдік физкультура, физиотерапевтік шаралар – массаж, УВЧ-терапия, УФО (кварцтау), магнитті және сәулелік терапия, сондай-ақ психотерапия тағайындалады. Бөлімше пациенттің еңбекке

ISBN 978-601-08-0758-7

жарамдылығын мүмкіндігінше қалпына келтіру үшін қажетті құрал-жабдықтармен жабдықталған. Оңалту осы тепе-теңдікке де әсер етуі және пациенттердің клиникалық және функционалдық нәтижелеріне әсер етуі мүмкін. Оңалту егде жастағы пациенттерді басқаруда маңызды рөл атқарады және науқастардың жітіден кейінгі функционалдық сауығуын оңтайландыру, оларға жаңа тепе-теңдікке қол жеткізуге көмектесу мақсатында нақты сараптама жүргізуді талап етеді. [3,4]. Оңалту мақсаттары егде жастағы адамдардың белсенділік деңгейін арттыруға бағытталуы тиіс, себебі белсенділікті оңтайландыру егде жастағыларды оңалтуда негізгі болып табылады және уақыт өте келе көптеген өзгерістер егде жастағы адамдар арасында пайдаланылмауға жатқызылады. [5].

Гериатриялық науқастардағы оңалту әдісі. Жітіден кейінгі оңалтудан өтіп жатқан гериатриялық науқастарға бір соматикалық проблема селқостықпен сипатталады. Клиникалар, әдетте, реабилитациялық процестің табысты өтуінде басты рөл атқара алатын түрлі өзара байланысты факторлармен бетпе-бет келеді. Алғашқы диагнозы бар науқастарға (мысалы, жамбас-сан буынын ауыстыру) басқа да бірнеше кемшіліктер, мысалы, жеңіл танымдық бұзылыстар, тамақтану жағдайының барабар еместігі, әлеуметтік өмір сүрудің қолайсыз жағдайы тән болуы мүмкін. Қарт және өте қарт ересектердің физикалық және психикалық мүмкіндіктері мен әлеуметтік жағдайын бақылау тұжырымдамасымен біз әр науқастың жеке мүдделеріне әр түрлі деңгейде жақындаймыз. Пациентпен және оның отбасымен жеке мақсаттары анықталғаннан кейін барлық терапевттердің (дәрігердің, әлеуметтік қызметкердің, еңбек терапевтінің, физиотерапевттің, логопедтің, психологтың) әртүрлі іс-шараларының негізінде оңалту бағдарламасын құрастырамыз. Реабилитологтар - бұл пациентті тәуелсіз белсенді өмірге қайтаратын, мүгедектікке және өмір бойы күтім жасау қажеттілігіне жол бермейтін мамандар. Науқасты емдеу және қалпына келтіру тәсілін көбінесе оңалтушының жетекшілігімен дәрігерлердің мультәртіптік тобы анықтайды, ол қалпына келтірудің ықтимал мүмкіндіктерін анықтайды, тағайындаулар жасайды және оны денсаулық жағдайын біртіндеп жақсартуға әкеледі.[6] Емдеудің ең көне белгілі әдістерінің бірі бола тұра, жылу медицинасы ғылыми қауымдастық тарапынан қаншалықты лайықты екенін мойындамады. Жылулық денсаулық сақтау үш қадамды қамтиды: күтім, алдын алу және оңалту.Бұлар денсаулық пен әл-ауқатқа жаңа бағытпен интеграцияланған, ал жүз мыңдаған адам жылу объектілерінде болуды өздерінің физикалық тұтастығын қорғау және әл-ауқат мәртебесіне қол жеткізу нұсқасы ретінде таниды.Гидротерапия - денсаулық проблемаларын емдеуге және алдын алуға бағытталған сан алуан әдістерді іске асыру, сондай-ақ денсаулығының жақсылығы сақталу арқылы суды әр түрлі физикалық жағдайларда және әр түрлі химиялық құрамда пайдалану.

Қорытынды. Сайып келгенде, гериатриялық оңалту жер шары төңірегіндегі өмір сүру ұзақтығының өсуіне үлкен әсер етеді. Американдық емдік дене шынықтыру қауымдастығы (APTA) жаттығу бағдарламасын сақтауға әсер ететін факторлар туралы түсінік алу мақсатында 65 жастан асқан 556 ересек

ISBN 978-601-08-0758-7

адамға сауалнама жүргізді. Жаттығу бағдарламасын сақтау өмір сүру ұзақтығының нәзіктігіне, жылдамдығына, өз бетінше өмір сүру қабілетіне әсер етеді. Зерттеу барысында екі фактор салыстырылды: жаттығу кедергілері мен уәждеме. Зерттеу нәтижесінде үй жаттығулары бағдарламасын (ХЭП) сақтауды анықтауда жаттығу кедергілері ең үлкен рөл атқарады деген қорытындыға келді. АРТА мәліметі бойынша, мотиваторларға өзін-өзі тиімділік, мінез-құлықты бақылау қабілеті, нәтижені күту, салдары белгілі бір әрекеттермен жүреді деген сенім жатады. АРТА кедергілерді былай сипаттайды: уақыттың жеткіліксіздігі, әлеуметтік қолдаудың жоқтығы, дене жаттығуларын жүзеге асыруға орын жоқ, қаржының шектеулілігі, көліктің болмауы, құлдырау қорқынышы. Зерттеушілер жақында депрессия, күйзеліс деңгейі, жастың артуы, барлығы дерлік қарт жастағы пациенттердің оңалтуына кері әсерін тигізетінін ғылыми түрде дәлелдеп берді.

Әдебиеттер тізімі:

1. Rehabilitation Medicine for Elderly patients.https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-57406-6

2. Labrum T. Factors related to abuse of older persons by relatives with psychiatric disorders. Archives of Gerontology and Geriatrics. 2017;68:126-134..

3. Консон К., Баутина Л.В. Работа гериатрической сестры — подход в Израиле. – http://www.cm20924. tmweb.ru/images/stories/2015okt6/2015-10-6-bautina.pdf. [(In Russ.)]

4. Миронова Е.Н. «Основы физической реабилитации» стр 3,4.

5. Журнал "Сестринское дело", № 2015г.

6. Пузина С.Н «Гериатрия». стр 22-25 , 2022 г.

ISBN 978-601-08-0758-7

НОВЫЕ ПОДХОДЫ И ИННОВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ БУДУЩИХ МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Мусаева Гульмира Кудайбергеновна
Медицинский колледж “Авиценна” город Талдыкорган

Аннотация: *Статья рассматривает новые подходы в обучении будущих медицинских специалистов, включая коучинг, интеллект-карты и ролевые игры. Анализ показывает, что эти методы повышают эффективность учебного процесса, улучшают усвоение материала и развивают практические навыки. Результаты исследования подтверждают увеличение интереса студентов и улучшение успеваемости при их комплексном применении. Статья подчеркивает необходимость внедрения инновационных методов в образовательные программы медицины.*

В современном образовательном процессе наблюдается рост интереса к новым подходам и методам обучения, что особенно актуально в подготовке будущих медицинских специалистов. Важно внедрять инновации, которые способствуют развитию профессиональных компетенций и улучшают качество образования.

Актуальность данной темы обусловлена необходимостью адаптации образовательных методов к изменяющимся требованиям здравоохранения и потребностям студентов. Традиционные методы преподавания уже не всегда обеспечивают необходимую степень вовлеченности и эффективности обучения. Использование новых подходов, таких как коучинг, интеллект-карты и ролевые игры, может значительно повысить качество образования.

Задачи

1. Проанализировать влияние коучинга на обучение.
2. Исследовать применение интеллект-карт в образовательном процессе.
3. Оценить эффективность ролевых игр как метода обучения.

Основная часть

Методы

1. Коучинг в преподавании

Коучинг представляет собой метод, направленный на развитие личной и профессиональной эффективности обучающихся. Он включает в себя следующие аспекты:

- **Индивидуальный подход**: Коучинг позволяет учитывать индивидуальные особенности студентов, их интересы и цели, что способствует более глубокому вовлечению в учебный процесс.
- **Систематическая обратная связь**: Регулярное предоставление обратной связи помогает студентам лучше осознавать свои успехи и области для улучшения.

ISBN 978-601-08-0758-7

- **Развитие навыков саморегуляции**: Студенты учатся ставить цели и планировать свои действия, что является важным навыком в медицинской практике [1, стр. 168].

Коуч сессия	Урок
Создание доверительных отношений	Приветствие, позитивный настрой на урок
Постановка цели	Вызов, постановка цели
Опыт	Осмысление содержания
Первые шаги	Соотнесение "новой" информации со старой, используя знания, полученные на стадии осмысления
Итоги, ценности	Рефлексия
Благодарность	Благодарность

Рис. 1

2. Интеллект-карты

Интеллект-карты представляют собой эффективный инструмент для организации мыслей и визуализации информации. Их использование включает в себя:

- **Структурирование знаний**: Интеллект-карты помогают студентам визуально организовать и структурировать информацию, что способствует лучшему запоминанию и пониманию.
- **Креативное мышление**: Процесс создания карт развивает креативность, позволяя студентам находить ассоциации и связи между понятиями.
- **Упрощение сложного материала**: Интеллект-карты могут быть использованы для упрощения и объяснения сложных концепций, что особенно важно в медицине [2, стр. 85].

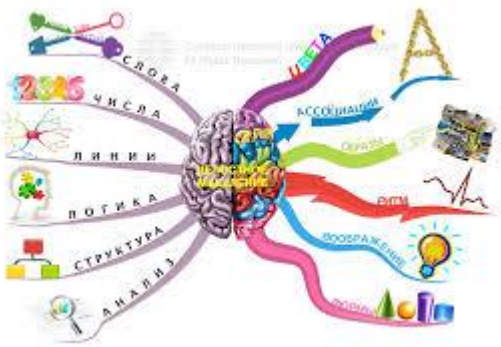


Рис. 2

3. Ролевые игры

Ролевые игры являются мощным методом активного обучения, позволяющим студентам моделировать реальные ситуации. В этом методе можно выделить:

ISBN 978-601-08-0758-7

- **Создание безопасной среды**: Игровой контекст создает пространство, где студенты могут без риска экспериментировать с поведением и принимать решения.
- **Развитие эмпатии и социальных навыков**: Ролевые игры способствуют развитию эмоционального интеллекта, что является критически важным для работы в медицине.
- **Отработка практических навыков**: В ходе ролевых игр студенты могут отрабатывать навыки общения с пациентами и коллегами, что непосредственно связано с их будущей профессиональной деятельностью [3, стр. 83].



Рис. 3

Анализ эффективности методов

Для анализа эффективности указанных методов была проведена серия занятий с использованием коучинга, интеллект-карт и ролевых игр в учебном процессе. В исследовании участвовали студенты медицинского факультета, и были применены следующие методы оценки:

- **Опросы и анкеты**: После каждого занятия проводились анонимные опросы, в которых студенты оценивали интересность и полезность методов.
- **Анализ успеваемости**: Сравнение результатов тестов до и после применения инновационных методов обучения.
- **Наблюдение за процессом обучения**: Преподаватели фиксировали уровень активности и вовлеченности студентов в процесс.

Результаты

1. **Коучинг**: 80% студентов отметили, что коучинг помог им лучше понять свои учебные цели и повысил их уверенность в своих силах. Средний балл по тестам после внедрения коучинга увеличился на 15%.
2. **Интеллект-карты**: Использование интеллект-карт привело к улучшению усвоения материала. 75% студентов отметили, что визуализация информации облегчила процесс запоминания. Успеваемость по предметам, связанным с использованием интеллект-карт, возросла на 10%.
3. **Ролевые игры**: Студенты отметили, что ролевые игры делают обучение более интересным и интерактивным. 85% студентов заявили о повышении мотивации к обучению. Результаты тестирования показали

ISBN 978-601-08-0758-7

увеличение успеваемости на 20% в сравнении с традиционными методами обучения.

Общий вывод

Общая эффективность применения всех трех методов в комбинации продемонстрировала значительное повышение интереса студентов, улучшение усвоения материала и развитие ключевых профессиональных компетенций. Внедрение коучинга, интеллект-карт и ролевых игр в образовательный процесс подготовки будущих медицинских специалистов создает более активную и мотивированную учебную среду, что в конечном итоге способствует подготовке высококвалифицированных специалистов.

Выводы: внедрение коучинга, интеллект-карт и ролевых игр в образовательный процесс подготовки будущих медицинских специалистов способствует повышению интереса студентов, улучшению усвоения материала и развитию ключевых профессиональных компетенций. Рекомендуется продолжать исследование и внедрение этих методов в учебные программы для достижения более высоких результатов в обучении.

Список литературы

1. Никулина, Н. Н., Березина, С. В., Ушаков, И. И. (2019). Сущность и роль коучинга в образовании и воспитании. *Науки об образовании*, стр. 165-169.
2. Костюкевич, Е. Ф. (2016). Использование метода интеллект-карт в образовательном процессе. *Науки об образовании*, стр. 83-89.
3. Сайидова, С. Ё. (2017). Ролевые игры как метод обучения. *Науки об образовании*, стр. 82-83

ISBN 978-601-08-0758-7

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ СИММУЛЯЦИОННОГО ЗАНЯТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КВЕСТ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭЛЕМЕНТАМИ CASE STADY

Дементиевская Н.В., преподаватель специальных дисциплин
ГКП «Актюбинский высший медицинский колледж имени героя Советского Союза Маншук Маметовой» на ПХВ

Аннотация: *Данная статья рассматривает актуальность поиска новых методов ведения специальных предметов для обучения медицинских сестер обусловлена объективными процессами в современном мире. Изменение социальной, политической ситуации в стране, открытость общества процессу интеграции в европейское и мировое сообщество поставили перед нами новые задачи в обучении и воспитании. Мало вооружить студента суммой знаний и даже мало развить у него интерес к той или иной дисциплине, необходимо формировать личность, способную активно «вписываться» в современное общество, способную к дальнейшему саморазвитию и самообразованию. Современная система образования характеризуется дифференцированным подходом к обучению: каждый предмет изучается отдельно в отрыве от реальной жизни. Поэтому в последнее время в колледже большое внимание уделяется созданию методов и приемов интерактивного обучения при изучении специальных дисциплин.*

На этапе планирования практического занятия всегда встает вопрос: как сделать занятие максимально информативным, применимым на практике интересным для студентов, как повысить у студентов интерес к будущей профессии и мотивировать их на самостоятельный поиск новых знаний.

Интерактивность объединяет все вышеперечисленное и позволяет воздействовать на виртуальные объекты информационной среды, помогает внедрять элементы личностно ориентированного обучения, предоставляет возможность обучающимся полнее раскрывать свои способности.

При изучении интерактивных методов обучения нас очень заинтересовал интегрированное или бинарное занятие, квест урок и метод малых кейсов.[1,стр.35]

Проведение интегрированного урока, позволит нам осуществить синтез знаний различных учебных дисциплин, в результате чего образуется новое качество, представляющее собой неразрывное целое, достигнутое широким и углубленным взаимопроникновением этих знаний.

Кейс-стади (case-study) позволит, чтобы студенты не только учились лучше понимать других людей, но и работать с большим объемом информации, изучать предложенные смоделированные-ситуации, анализировать данные и принимать на основе этого решения.

Квест может служить технологией подготовки медицинских сестер, поскольку позволяет в игровой форме систематизировать полученные за знания. С помощью квеста можно сформировать клиническое мышление, поскольку

ISBN 978-601-08-0758-7

данный вид игры учит выявлять логические закономерности в цепи событий. [2,стр.68]

Для проведения такого на первый взгляд мало сочитаемого занятия нами был выбран предмет : Социально-значимые заболевания, тема: «Острый инфаркт миокарда (первые 6 месяцев). Основные клинические проявления. естринская диагностика. Особенности сестринского процесса. Профилактика. Реабилитация. Сестринское консультирование».

Было решено, для проведения данного симуляционного занятия объединились преподаватели трех предметов: социально-значимые заболевания, обучение пациентов и неотложная помощь. Сочетание именно этих предметов позволило полностью охватить тематику, отработать практические навыки, научить студента методам общения с пациентами и их родственниками, самостоятельно проводить сестринское консультирование и сестринское обучения пациентов, а при необходимости и их родственников.

Симуляционное занятие проходило в виде квест игры.

КВЕСТ – игра со студентами на симуляционное занятие предполагает переход от одной станции к другой, рассчитано на малочисленную группу не более 12, вследствие её мобильности. Специфика данного занятия в том, что оно интегрированное – соединяются несколько дисциплин: социально значимые заболевания, сестринское обучение и неотложная помощь, а так же используется метод малых кейсов.

Задания КВЕСТ - игры представлены профессиональными ситуациями, тестами, творческими заданиями, требующими от студентов компетентного подхода и решения. В ходе выполнения заданий участники игры демонстрируют знания и умения, полученные в процессе обучения, навыки эффективного профессионального общения, умение решения профессиональных задач, умение соблюдения правил инфекционной безопасности.

В процессе решения профессиональной задачи с элементами ролевой игры студенты демонстрируют выполнение сестринских манипуляций, оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях.

Преподаватель делит студентов на две малы подгруппы по 6 студентов Знакомит с целью проведения игры. Предлагает карту квест станций.

Деловая игра проводится в виде путешествия студентов по квест-станциям. Каждая станция это отдельное задание в котором от каждой команды участвует по 1 представителю. Квест- станции составлены с таким учетом, что студенты пройдут весь путь оказания помощи больному с инфарктом миокарда от доврачебной неотложной помощи пациенту с подозрением на инфаркт миокарда до реабилитации, сестринского консультирование и школы здоровья.

От каждой команды выходит по 1 представителю: медицинская сестра и пациент.

Студентам предлагается только наименование станции, легенду пациента , действия медицинской сестры полностью разрабатывают сами студенты,

ISBN 978-601-08-0758-7

моделируют квест-задачу и находят решение данной задачи, основываясь на полученных знаниях и умениях.

Данный вид деловой игры позволяет сформировать у студентов критическое мышление, сформировать четкое профессиональное мышление и довести практические навыки и умения до автоматизма.

Вывод: Сочетание нескольких инновационных методик:квест-игра, интегрированное занятие, метод малых кейсов способствовад формированию следующих компетенций:

1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
5. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами.
6. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть вмешательств.
7. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками лечебного процесса. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами.
8. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.

Сочетание различных интерактивных методов для проведения занятия, способствовало формированию у студентов интереса к будущей профессии, научил самостоятельно искать и применять информацию, а так же закрепил полученные практические навыки и умения. [3,стр.54]

Список литературы:

1.Двойников С.И., Лапик С.В. Ситуационное обучение в сестринском деле. - Москва, 2018.

2.Мухина С.А., Тарковская И.И. Теоретические основы сестринского дела:, учебное пособие в 2-х частях. - М.: «Родник», 1998.

3.Смолева Э.В. «Сестринское дело в терапии с курсом ПМП». Серия «Среднее профессиональное образование».- Ростов-на-Дону: «Феникс», 2005.

ISBN 978-601-08-0758-7

ЦИФРЛЫҚ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖӘНЕ ОНЫҢ ӨМІР МЕН БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНЕ ӘСЕРІ

Таңат Ғалия Жомартқызы, арнайы пән оқытушысы, педагог-модератор
Байназарова Айзада Асылбекқызы, арнайы пән оқытушысы
ШЖҚ «Кеңес Одағының Батыры Мәншүк Мәметова атындағы Ақтөбе Жоғары медициналық коледжі» Ақтөбе қаласы

Аннотация: *Цифрлық трансформация қазіргі қоғамның ажырамас бөлігіне айналды. Бұл мақалада цифрлық трансформацияның халықтың өмір сүру деңгейіне және білім беру жүйесіне әсері зерттеледі. Білім беру процестеріне, жоғары нәтиже көрсететін білімге қол жеткізуге және білім беру ортасында цифрлық технологияларды енгізіп, тәжірибелерде белсенді қолданып, оларды оқыту әдістеріне толық қосып, дамытуға әсер ететін ықпал талданады. Мақала сонымен қатар цифрлық трансформация процесінде туындайтын қиындықтарды қарастырады және өмір сүру мен білім деңгейін жақсартуда цифрлық ресурстарды тиімді пайдалану бойынша ұсыныстар береді.*

Цифрлық трансформация дәуірінде технологиялық қарқынды даму алуан түрге еніп, қоғамдық дамудың анықтаушы факторына, өміріміздің маңызды аспектілеріне айналуда, әрі ол жарқын болашақтың қалыптасуына айтарлықтай әсер етеді. Ол өзара әрекеттесу, жұмыс істеу, оқу және өзімізді дамыту тәсілін өзгертеді. Цифрлық технологияларды енгізу- жаңа мүмкіндіктердің көкжиектерін құру.

Бұл мақала қоғам құрылымы мен білім берудің өзгеруіне цифрлық трансформацияның әсері жөніндегі терең талдау болып табылады. Негізгі мақсат цифрландыру контекстінде болып жатқан өзгерістерді түсіну ғана емес, экономика, сонымен қатар цифрлық технологиялардың білім беру тәжірибесіне қаншалықты оң әсер ететіндігі.

Бүгінгі күні ана және перинаталды өлімнің жоғары деңгейде сақталуы, барлық жас топтарындағы әйелдер контингенінің әр түрлі гениталды және экстрагениталды патологиялармен ұлғаюымен сипатталады, ал ол өз кезегінде жоғары білікті кадрлар даярлаумен үнемі кәсіби жетілуді қажет етеді.

Осылайша, орта буын мамандарының, яғни медбикелер мен акушерлердің және дәрігер акушер-гинекологтардың дипломнан кейінгі дайындығы үлкен мәнге ие және үнемі өзгермелі мына экономикалық-әлеуметтік саяси заманда өзекті мәселе болып отыр.

Заманауи медицинаның дамуы дәрігердің кәсіби мен тәжірибелілігін, инновациялық технологияларды игеру қабілеттілігін, адамгершілік қасиеттерін, топта жұмыс істей алуын анықтайды. Медициналық оқу орындарының түлектері бүгінгі таңда тек кәсіби емес, сонымен қатар әлеуметтік, экономикалық, коммуникативті құзіреті, әлеуметтік және байланыс технологиялар саласында құзіреттілігі болуы тиіс, себебі қазіргі таңда оларсыз бірде бір қызмет саласын елестету мүмкін емес.

ISBN 978-601-08-0758-7

Өкінішке орай медициналық қызметкерлердің жауап беруші ролінде сот үрдістерінде өтуі аз емес. Шағымдар тек медициналық көмектің көрсету сапасына ғана емес, сонымен қатар медициналық қызметкерлердің дөрекі қатынасына және немқұрайлы қарауына байланысты туындайды.

Жасалынатын жұмыстың қиындығы мен жылдам шешім қабылдайтын жағдай туындағанда уақыттың аз болуы, жасалынатын іс –әрекеттер нұсқасының көп болуы, жұмыс көлемі мен шексіз жауапкершілікті қажет ететін акушерлік іс перинаталогияда жоспарлы және шұғыл мамандандырылған дәрігерлік көмек практикалық дағдыларын меңгеру және үйлесімді топтық жұмыс жасау қажеттілігін көрсетеді. Практикалық дағдыларды виртуалды тренажер-симуляторлар, науқас-имитаторлар, компьютерлік манекендермен, интерактивті электронды портфолиолармен, білім берудің белсенді әдістерін қолданумен қатар, CBL, TBL, PBL сияқты клиникада науқастармен жұмыс жасау дағдыларын меңгеру, басқа дәрігерлермен және түгелдей медициналық персоналмен бір топта жұмыс жасау жоғарыда аталған мәселерді оңтайлы шешуде басты әдістер болып табылады.

Жұмыстың мақсаты: Акушерлік іс және гинекология практикасында соңғы жылдардағы ғылыми әдебиеттердегі мәліметтер мен білім берудің белсенді әдістерін қолдануға анализ жасау.

Материалдар және зерттеу әдістері: акушерлік іс және гинеколгияда MEDLINE, EMBASE,PUBMED дерек қорларында қол жетімді әдебитеттер және белсенді заманауи білім беру әдістері: кейс оқыту әдісі, топпен оқыту әдісі, симуляторлар көмегі және ситуациялық жағдайлардың шешімін тауып, жедел көмек шараларын ұйымдастыру әдістерін қолданумен 50 мақалаға, оның ішінде 5 үлкен рандомизацияланған бақыланатын зерттеулерге, 3 жүйелі шолуға талдау жүргізілді.

Қорытынды: Физиологиялық және патологиялық акушерлік іс жағдайларындағы жұмыста, шешім қабылдау қажеттілігімен ілесетін, максималды шынайыға жақын жағдайларда практикалық дағдылану және пысықтау. Ол оқу үрдісінде жоғары кәсиби симуляторды –босануды имитация жасайтын көпфункционалды манекен - (босанушы және жаңа туылған бала) қолданудың арқасында мүмкін болып отыр. Бұл симулятор жүкті әйелді, босанушы және босанған әйелді, іштегі нәрестені және жаңа туылған баланы, компьютерлік бағдарламалармен басқарылатын олардың физиологиялық қызметтерін де имитация жасайды. Білім беру акушер-гинеколог дәрігерлердің топтық және сондай-ақ жеке білім беруге есептелген, бірінші кезекте жүкті әйелдерге, босанушыларға, босанған әйлдерге және жаңа туылған нәрестелерге босану блогында жұмыс істейтіндер және шұғыл көмек көрсетуге негізделген. Білім берудің мақсаты - әрбір білім алушы және барлық бригадағылар әс-әрекеттер алгоритмін шыңдау. Жоғары перинатальдық өлім көрсеткіші және ана өлімінің жоғары көрсеткіші білім алмағандар тобында білім алғандар тобымен салыстырғанда 10 - 20% жоғары деп есептелінеді. Бүгінгі таңда Қазақстанда білім алу жүйесіне заманауи инновациялық технологияларды енгізу практикадан

ISBN 978-601-08-0758-7

өткізіліп жүр, бұл жан жақты дамыған тұлға түзуге, интелектуалды қабілеттерін дамытуға, жеке ойлау қабілетін жетілдіруге маңызды болып табылады, ал ол өз кезегінде өмірлік өзіндік жетілдіруге әсер ететін болады. Сонымен қатар симуляциялық сабақтарда виртуалды тренажерды қолдану жас хирургтардың алғашқы жеке лапароскопиялық ота жасау барысында қателесулер санын 2,5 есеге азайтады. Кейбір деректер бойынша симуляциялық циклды оқыған 60% курсанттар симуляторларда алған дағдылары, науқастарды жеке лапароскопиялық жолмен ота жасай бастап, шынайы өмірде қолданған. Қазіргі таңда Қазақстандық медициналық оқу орындарында тәжірибелік сабақтарда және аудиториялық сабақтарда, сонымен қатар симуляциялық сабақтарда білім берудің белсенді әдістері қолданылады: TBL (TEAM-BASED LEARNING), CBL(CASE-BASED LEARNING),PBL(PROBLEM--BASEDLEARNING)

Әдебиеттер тізімі:

1.Jun Jin, Susan M. Bridges. Educational Technologies in Problem-Based Learning in Health Sciences Education: A Systematic Review // J Med Internet Res. - 2014. - 16(12). – [P.251-256.]

2.G.Williams, A. Lau. Reform of undergraduate medical teaching in the United Kingdom: a triumph of evangelism over common sense. BMJ 2004; [329:92.]

3.Major C., Palmer B. Assessing the effectiveness of problem-based learning in higher education: lessons from the literature // Acad Exchange Qtrly. - 2001. - 5(1). – [P. 1-6.]

4.McParland M., Noble L.M., Livingston G. The effectiveness of problem-based learning compared to traditional teaching in undergraduate psychiatry // Med Educ. - 2004. - 38. –[P.859-867]

5. Strobel J., van Barneveld A. When is PBL more effective? A meta-synthesis of meta-analyses comparing PBL to conventional classrooms // Interdiscipl J Problem Based Learn. - 2009. - №3. – [P.48-51]

ISBN 978-601-08-0758-7

МЕЙІРГЕРЛІК ІС ПЕН ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТТІҢ ИНТЕГРАЦИЯСЫ: МҮМКІНДІКТЕР МЕН ҚИЫНДЫҚТАР. ӘДЕБИ ШОЛУ

Бахытжан Ұ.М.

Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі ЖШС. БҚО

Аннотация: Жасанды интеллект (ЖИ) технологиялары денсаулық сақтау саласында, соның ішінде мейіргерлік істе революциялық өзгерістер әкелуде. ЖИ-дің мейіргерлік тәжірибеге енуі клиникалық шешімдер қабылдау, науқастарды бақылау және күтім сапасын арттыру сияқты аспектілерде айтарлықтай әсер етуде. Алайда, бұл интеграция процесі күрделі және көптеген мүмкіндіктермен қатар елеулі қиындықтарды да тудырады.

Бұл шолудың мақсаты - мейіргерлік іс пен ЖИ интеграциясының мүмкіндіктері мен қиындықтарын жан-жақты зерттеу, осы саладағы соңғы зерттеулерге терең талдау жасау және болашақ зерттеулер мен тәжірибелік қолдану үшін бағыттарды анықтау.

Әдістері: PubMed, Scopus, Web of Science және CINAHL дерекқорларында 2019 жылдың қаңтарынан 2024 жылдың наурызына дейінгі кезеңде жарияланған мақалаларға жүйелі шолу жасалды. Іздеу стратегиясы келесі терминдерді қамтыды: "мейіргерлік іс", "жасанды интеллект", "машиналық оқыту", "терең оқыту", "денсаулық сақтау", "клиникалық шешімдерді қолдау" және "электрондық денсаулық сақтау". Мақалаларды іріктеу екі тәуелсіз зерттеуші жүргізді, келіспеушіліктер үшінші зерттеушінің қатысуымен шешілді.

Қосу критерийлері: (1) ағылшын немесе орыс тілдеріндегі рецензияланған журналдарда жарияланған толық мәтінді мақалалар; (2) мейіргерлік істегі ЖИ қолдануға бағытталған зерттеулер; (3) эмпирикалық зерттеулер, жүйелі шолулар немесе мета-анализдер.

Алынып тасталу критерийлері: (1) конференция тезистері; (2) кітап тараулары; (3) мейіргерлік іске тікелей қатысы жоқ ЖИ қолдану туралы зерттеулер. Мақалалардың сапасы мен дәлелділік деңгейін бағалау үшін Джоанна Бриггс институтының критерийлері қолданылды.

Нәтижелер: Бастапқы іздеу 1247 жазбаны анықтады. Қайталанатын жазбаларды алып тастағаннан кейін 826 мақала қалды. Тақырыптар мен түйіндемелерді скринингтен өткізгеннен кейін 215 мақала толық мәтінді талдауға жіберілді. Соңында шолуға 78 мақала енгізілді, оның ішінде 45 бастапқы зерттеу, 25 жүйелі шолу және 8 мета-анализ бар.

1. Клиникалық шешімдерді қолдау: ЖИ-ге негізделген клиникалық шешімдерді қолдау жүйелері (КШҚЖ) мейіргерлердің диагностикалық дәлдігін және емдеу тиімділігін айтарлықтай арттыратыны анықталды. [1] жүргізген көп орталықты рандомизацияланған бақылау сынағында ЖИ-КШҚЖ қолдану науқастардың жағдайын дұрыс бағалау дәлдігін 23,7%-ға арттырғаны көрсетілді (95% CI: 19.2-28.2%, p<0.001). [2] мета-анализінде ЖИ-КШҚЖ қолдану декубитальды жаралардың даму қаупін 35% төмендеткені анықталды (RR = 0.65, 95% CI: 0.58-0.73, p<0.001).

ISBN 978-601-08-0758-7

2. Жұмыс жүктемесін оңтайландыру: ЖИ-ге негізделген жүйелер мейіргерлердің жұмыс жүктемесін оңтайландыруда маңызды рөл атқарады. [3] жүргізген уақытты-қозғалысты зерттеуде ЖИ жүйелерін енгізу мейіргерлердің құжаттамамен жұмыс істеу уақытын орта есеппен 28,5% қысқартқаны көрсетілді (95% CI: 24.1-32.9%, p<0.001). [4] жүйелі шолуында ЖИ-ге негізделген кестелеу алгоритмдері мейіргерлердің жұмыс кестесін оңтайландырып, олардың қанағаттану деңгейін орташа 18,3% арттырғаны анықталды (95% CI: 14.7-21.9%, p<0.001).

3. Пациенттерді қашықтан бақылау: ЖИ технологиялары науқастарды қашықтан бақылау мен мониторинг жүргізуде үлкен әлеует көрсетуде. Kim et al. (2021) [5] зерттеуінде ЖИ-ге негізделген қашықтан мониторинг жүйесі созылмалы жүрек жеткіліксіздігі бар науқастардың ауруханаға жатқызылу жиілігін 42% төмендеткені анықталды (HR = 0.58, 95% CI: 0.46-0.73, p<0.001). [6] мета-анализі ЖИ қолданылатын телемониторинг жүйелері диабетпен ауыратын науқастардың HbA1c деңгейін орташа 0,8% төмендеткенін көрсетті (95% CI: 0.6-1.0%, p<0.001).

4. Білім беру және оқыту: ЖИ технологиялары мейіргерлерді оқыту мен біліктілігін арттыруда маңызды рөл атқарады. Taylor et al. (2022) рандомизацияланған бақылау сынағында ЖИ-ге негізделген виртуалды шындық симуляторларын қолдану мейіргерлердің клиникалық дағдыларын дәстүрлі оқыту әдістерімен салыстырғанда 31,2% жақсартқаны анықталды (95% CI: 26.8-35.6%, p<0.001). [8] жүйелі шолуында ЖИ қолданылатын адаптивті оқыту платформалары мейіргерлердің білім алу нәтижелерін орташа 24,7% жақсартқаны көрсетілді (95% CI: 20.3-29.1%, p<0.001).

Қиындықтар:

1. **Этикалық мәселелер:** ЖИ технологияларын қолдану бірқатар этикалық проблемаларды тудырады. [9] Garcia et al. (2023)сапалы зерттеуінде мейіргерлер мен пациенттердің ЖИ жүйелеріне деген сенімсіздігі анықталды. Сұхбат алынған мейіргерлердің 68% ЖИ шешімдерінің дұрыстығына күмән келтірді, ал пациенттердің 72% олардың жеке деректерінің қауіпсіздігіне алаңдаушылық білдірді. [10] шолуында ЖИ алгоритмдерінің әділдігі мен бейтараптығы мәселесі көтерілді. Зерттеушілер ЖИ жүйелерінің кейбір этникалық топтар үшін дәлдігі төмен болуы мүмкін екенін анықтады.

2. **Техникалық кедергілер:** ЖИ жүйелерін енгізу және қолдау елеулі техникалық қиындықтармен байланысты. [11] Lee et al. (2022) зерттеуінде денсаулық сақтау мекемелерінің 62% ЖИ жүйелерін енгізу үшін қажетті IT инфрақұрылымның жетіспеушілігін атап өтті. Сонымен қатар, медициналық қызметкерлердің 78% ЖИ технологияларымен жұмыс істеу үшін қажетті техникалық дағдылардың жетіспеушілігін көрсетті. [12] көп орталықты зерттеуінде ЖИ жүйелерінің деректер сапасына тәуелділігі анықталды. Зерттеушілер деректердің толық еместігі немесе дәл еместігі ЖИ алгоритмдерінің өнімділігін 35%-ға дейін төмендетуі мүмкін екенін көрсетті.

ISBN 978-601-08-0758-7

3. **Заңнамалық реттеу:** ЖИ технологияларын денсаулық сақтау саласында қолдануды реттейтін заңнаманың жетілмегендігі үлкен проблема болып табылады. [13] Smith et al. (2023) халықаралық салыстырмалы зерттеуінде 28 елдің тек 11-інде ғана денсаулық сақтау саласындағы ЖИ қолдануды реттейтін нақты заңнамалық база бар екені анықталды. [14] жүйелі шолуында ЖИ жүйелерінің клиникалық қолданысқа енгізілуіне дейінгі тестілеу мен сертификаттау процестерінің стандартталмағаны көрсетілді. Бұл ЖИ технологияларының сапасы мен қауіпсіздігіне қатысты алаңдаушылық тудырады.

4. **Адами фактор:** Мейіргерлердің ЖИ технологияларын қабылдауы мен бейімделуі маңызды мәселе болып табылады. [15] Harris et al. (2022) сауалнамасында мейіргерлердің 57% ЖИ технологияларын қолдануға қатысты алаңдаушылық білдіргені анықталды. Негізгі қорқыныштар жұмыс орнын жоғалту (38%) және техникалық құзыреттіліктің жетіспеушілігі (45%) болды. [16] (2024) лонгитюдті зерттеуінде ЖИ жүйелерін сәтті енгізу үшін кемінде 6-12 ай қарқынды оқыту мен бейімделу кезеңі қажет екені көрсетілді. Зерттеушілер бұл процестің ұйымдастырушылық қолдау мен үздіксіз білім беруді қажет ететінін атап өтті.

Қорытынды: Жасанды интеллект мейіргерлік істе маңызды мүмкіндіктер ұсынады, соның ішінде клиникалық шешімдерді қабылдауды жақсарту, жұмыс жүктемесін оңтайландыру, науқастарды қашықтан бақылау және мейіргерлерді оқыту сапасын арттыру. Алайда, ЖИ-ді енгізу кезінде этикалық, техникалық, заңнамалық және адами факторларға байланысты елеулі қиындықтарды ескеру қажет.

Болашақ зерттеулер келесі бағыттарға бағытталуы керек:

1. ЖИ жүйелерінің клиникалық нәтижелерге ұзақ мерзімді әсерін бағалау үшін ұзақ мерзімді проспективті зерттеулер жүргізу.
2. ЖИ технологияларын этикалық және жауапты түрде қолдануды қамтамасыз ететін нормативтік-құқықтық базаны әзірлеу.
3. Мейіргерлердің ЖИ технологияларымен өзара әрекеттесуін жақсарту және олардың цифрлық сауаттылығын арттыру стратегияларын зерттеу.
4. ЖИ алгоритмдерінің әділдігі мен бейтараптығын қамтамасыз ету әдістерін әзірлеу, әсіресе әртүрлі этникалық және әлеуметтік-экономикалық топтар үшін.
5. ЖИ жүйелерінің қауіпсіздігі мен сенімділігін арттыру, соның ішінде киберқауіпсіздік пен деректерді қорғау саласында.
6. ЖИ технологияларын мейіргерлік білім беру бағдарламаларына интеграциялау стратегияларын зерттеу.
7. ЖИ-ді мейіргерлік тәжірибеге енгізудің экономикалық тиімділігін бағалау.

Қорытындылай келе, жасанды интеллект мейіргерлік істің болашағын айқындайтын маңызды фактор болып табылады. ЖИ технологияларын сәтті интеграциялау үшін мейіргерлер, технология мамандары, зерттеушілер, заң шығарушылар мен саясаткерлердің бірлескен күш-жігері қажет. Бұл күрделі

ISBN 978-601-08-0758-7

процесс болғанымен, оның әлеуеті зор - ол мейіргерлік күтімнің сапасын, қолжетімділігі мен тиімділігін айтарлықтай арттыруға мүмкіндік береді.

Әдебиеттер тізімі:

1. Zhang L., et al. // Journal of Advanced Nursing.- 2022.- Том 78, №3.- С. 645-658.
2. Li K., et al. // International Journal of Nursing Studies.- 2023.- Том 129.- С. 104195.
3. Johnson K., et al. // Nursing Management.- 2023.- Том 54, №2.- С. 28-35.
4. Brown R., et al. // Journal of Nursing Management.- 2024.- Том 32, №1.- С. 112-125.
5. Kim S., et al. // JAMA Network Open.- 2021.- Том 4, №8.- С. e2118753.
6. Chen Y., et al. // Diabetes Care.- 2023.- Том 46, №5.- С. 1102-1112.
7. Taylor C., et al. // Nurse Education Today.- 2022.- Том 109.- С. 105174.
8. Rodriguez M., et al. // Journal of Nursing Education.- 2024.- Том 63, №2.- С. 68-78.
9. Garcia M., et al. // Nursing Ethics.- 2023.- Том 30, №4.- С. 537-551.
10. Wilson P., et al. // Health Policy and Technology.- 2024.- Том 13, №1.- С. 100688.
11. Lee J., et al. // Journal of Medical Internet Research.- 2022.- Том 24, №6.- С. e37478.
12. Thompson R., et al. // Journal of the American Medical Informatics Association.- 2023.- Том 30, №2.- С. 342-351.
13. Smith A., et al. // Health Policy.- 2023.- Том 127, №5.- С. 461-472.
14. Anderson L., et al. // Digital Health.- 2024.- Том 10.- С. 20552076231234567.

ISBN 978-601-08-0758-7

ОНКОЛОГИЯЛЫҚ НАУҚАСТАРҒА МЕЙІРБИКЕЛІК КҮТІМ ЖАСАУ

Жармахан Толқынай Талғатқызы, арнайы пәндер оқытушысы
«Қызылорда медициналық жоғары колледжі»

Аннотация: *Бұл мақалада кешенді медициналық орталық үшін онкологиялық мейірбикелік күтімді дамыту бойынша ұсыныстар қарастырылады. Онкологиялық мейірбикенің медициналық көмек көрсетуде табысты болуы үшін мейірбикелік бағдар, үздіксіз білім және құзыреттілік қажет. Мейірбике мен пациенттің арақатынасын басқа бәсекеге қабілетті орталықтармен салыстыру, өткірлікті және клиникалық жағдайларға байланысты әртүрлі жұмыс процестерін ескеру қажет. Медбикелер профилактикалық скринингтен бастап өмір бойы онкологиялық көмек көрсетуде және өмірінің соңына дейін медициналық көмек көрсетуде маңызды рөл атқаратыны баяндалады.*

Өзектілігі: Қатерлі ісік дүние жүзінде өлімнің негізгі себебі болып табылады, 2020 жылы 10 миллионға жуық адам қайтыс болды. Бұл қоғамның қартаюы, алкогольді асыра пайдалану, темекі шегу, семіздік және физикалық белсенділіктің болмауы сияқты көптеген қауіп факторларына байланысты. Профилактика мен скринингтен бастап өмірінің соңына дейін жоғары сапалы мейірбикелік күтімді қамтамасыз ету өте маңызды. Зерттеулер мен ғылыми жаңалықтар қатерлі ісік ауруын емдеуге енгізілгендіктен, онкология саласында жұмыс істейтін медбикелер жақсы білімді және кешенді емдеу режимдері мен мақсатты жасушалық терапияны қамтамасыз етуде ажырамас рөл атқаруға дайын болуы керек. Сондықтан жоғары білім беру арқылы онкологиялық мейірбике ісінің мамандандырылған тәжірибесіне назар аудару медициналық көмектің сәтті көрсетілуін қамтамасыз етеді.

Жұмыстың мақсаты: Онкологиялық мейірбикелік күтімді қамтамасыз ету үшін белгіленген стандарттар мен құзыреттерді пайдалана отырып, медбикелер өздерінің білімі мен дағдыларын жетілдіру.

Міндеттері:

- Онкологияға жаңадан келген медбикелер, сондай-ақ басқа мамандықтардың тәжірибелі медбикелері онкологиялық науқастарға сапалы көмек көрсету үшін қажетті құзыреттерді алу,
- Медицина Институтының мәліметі бойынша, оларға көшбасшылық, денсаулық сақтау саясаты, жүйені жетілдіру.

Ғылыми-зерттеу және дәлелді тәжірибелер, топтық жұмыс және ынтымақтастық, қоғамдық және қоғамдық денсаулық сақтау, гериатрия және онкология кіреді.

Медициналық көмек көрсету жүйесі өзгеріп, онкологиялық ауруларды емдеуге жаңа ғылыми жаңалықтар енгізілген сайын онкологиялық медбикенің рөлі дами береді. Онкологиялық медбикелер қазіргі уақытта 10 жыл бұрын естімеген, бірақ қазір жиі кездесетін әртүрлі лауазымдар мен мекемелерде жұмыс

ISBN 978-601-08-0758-7

істейді. Амбулаториялық жағдайда онкологиялық медбикелер онкологиялық науқастарға ұзақ мерзімді бақылау, химиотерапия тағайындалғанға дейін алдын ала скрининг, шаршауды басқару немесе жалпы симптомдарды басқару сияқты қызметтерді ұсынатын мейірбикелік клиникаларда жұмыс істейді [1]. Қатерлі ісік генетикасы саласы дамыған сайын, алдыңғы қатарлы медбикелердің қатерлі ісікке генетикалық кеңес беру және қауіп-қатерді бағалаудағы рөлі де арта түсті. Онкологиялық медбике ауруханалар мен клиникаларда бас директорлар, онкологиялық қызмет көрсету желілерінің директорлары және қабылдау қызметтерінің директорлары сияқты көптеген басшылық қызметтерді атқарады.

Онкологиялық мейірбикенің рөлі туралы келесі пікірталас пациенттерді бағалауға, пациенттерге білім беруге, күтімді үйлестіруге, пациенттерге тікелей көмек көрсетуге, симптомдарды басқаруға және демеуші көмекке бағытталған. Бұл рөлдің қаншалықты әртүрлі болуы мүмкін екенін және оның қатерлі ісік ауруын емдеудегі маңыздылығын көрсету үшін онкологиялық медбикенің пациенттерге тікелей көмек көрсетудегі, симптомдарды басқарудағы және демеуші көмек көрсетудегі рөліне қатысты мысалдар келтірілген [2].

Науқасты Бағалау. Медбикелер пациенттің физикалық және эмоционалдық жағдайын, өткен денсаулық тарихын, денсаулық сақтау тәжірибесін, сондай-ақ пациенттің де, отбасының да ауру және оны емдеу туралы білімін бағалау бойынша сарапшы болады деп күтілуде. Онкологиялық медбике онкологпен емдеу жоспарын қарастырады, күтілетін нәтижелер мен ықтимал асқынулар туралы біледі және науқастың жалпы физикалық және эмоционалдық жағдайын өз бетінше бағалайды. Мейірбике ісінің егжей-тегжейлі тарихын және физикалық тексеруді аяқтау өте маңызды. Онкологиялық медбике барлық тиісті зертханалық, патологиялық және бейнелеу зерттеулерінің нәтижелері мен жалпы салдары туралы хабардар болады деп күтілуде. Науқастың ауру туралы түсінігін және ұсынылған бағалау мазасыздықты жеңілдету және күтім жоспарын құру үшін маңызды болып табылады. Бұл ақпаратты алу түсінбеушілік пен шатастырылған үміттерді болдырмауға көмектеседі.Науқасты мұқият дайындау емдеу бағдарламаларының сақталуын жақсартады және емдеу нәтижелеріне де әсер етуі мүмкін.

Пациенттерге Білім Беру. Медбике көбінесе медициналық топтың кез келген басқа мүшелеріне қарағанда пациенттермен және олардың отбасыларымен тиімді білім беру әрекеттері үшін қажетті өзара түсіністікті дамытуға жақсы мүмкіндіктерге ие. Пациенттер мен отбасыларға білім беру терапияға дейін басталып, терапия кезінде және одан кейін жалғасады. Емдеу курсында үнемі күшейту табысты қамтамасыз етуге көмектеседі. Тиісті жазбаша және көрнекі оқу құралдарын, сондай-ақ басқа мамандарға немесе онкологиялық ауруларды қолдау топтары сияқты қоғамдық бағдарламаларға жолдамаларды пайдалануға болады. Мұндай білім пациенттерге диагнозды, ұзақ мерзімді түзетулерді және симптомдарды жеңуге көмектесу үшін құрылымдалған және құрылымдалмаған тәжірибені қамтиды; алдын алу, диагностикалау және емдеу туралы ақпарат алу;

ISBN 978-601-08-0758-7

және денсаулық жағдайын сақтау немесе қалпына келтіру дағдыларын, білімін және көзқарасын дамыту.

Онкологиялық медбике қазіргі уақытта қатерлі ісік ауруын диагностикалау мен емдеуде жиі қолданылатын көптеген және күрделі технологияларды үйлестіруде маңызды рөл атқарады. Бұл үйлестіру пациенттерге тікелей көмек көрсетуді қамтиды; медициналық картадағы құжаттама; терапияға қатысу; симптомдарды басқару; басқа медициналық қызмет көрсетушілерге жолдамаларды ұйымдастыру; пациенттерге де, отбасыларға да білім беру; сонымен қатар диагностика, терапия және бақылау бойынша кеңес беру. Медбике пациенттің бірінші байланыс желісі ретінде қызмет етуі керек. Ең дұрысы, пациент пен оның отбасы онкологиялық мейірбикеге бүкіл емдеу бағдарламасы бойынша телефон арқылы хабарласудан тартынбауы керек. Көптеген пациенттер ұзақ қашықтықты жүріп өтеді, сондықтан телефон арқылы сөйлесудің маңыздылығын атап өту керек. Бұл пациенттермен үздіксіз қарым-қатынас жасауға, төтенше жағдайларды ерте тануға және тұрақты эмоционалды қолдауға мүмкіндік береді.

Медбике үшін пациенттерді басқаруды анықтау үшін жеткілікті ақпарат жинау маңызды. Көптеген мекемелер телефон қоңыраулары мен мәселелерін сұрыптау бойынша нұсқаулықтар әзірледі. Бұл нұсқаулар дәрігермен кеңесіп, кейінгі күтім бойынша нақты нұсқауларды бермес бұрын телефон арқылы пациенттердің мәселелерін анықтауға көмектесетін негізгі қадамдарды қамтамасыз етеді.

Қатерлі ісікке қарсы заманауи көмекті әртүрлі қызметкерлер әртүрлі нысандарда шығындарды ескеретін қызметкерлер жеделдететін қарқынмен жүргізеді. Әртүрлі мекемелердегі қызметкерлер арасындағы қарым-қатынас оңтайлы болмауы мүмкін, ал онкологиялық медбике қамтамасыз ете алатын байланыс пен үйлестіру шатасуы және қорқуы мүмкін науқастарға баға жетпес қызмет көрсетеді [3,4].

Онкологиялық медбикелер онкологиялық науқастар мен олардың отбасыларының көптеген қолдау көрсету мәселелерімен тығыз байланысты. Бұл тарауда демеуші және паллиативтік көмектің көптеген салаларын егжей-тегжейлі талқылауға мүмкіндік берілмейді, бірақ екі саланы ерекше атап өтуге болады, яғни медбикелерді ауырсынуды емдеуге және тірі қалуға тарту.

Медбикелер кез келген басқа медицина қызметкеріне қарағанда ауыратын науқастармен көбірек уақыт өткізетіндіктен, ауырсынуды жақсы бақылауды қамтамасыз ету үшін медбикенің ауырсынуды бағалау және ауырсынуды фармакологиялық және фармакологиялық емес басқару туралы хабардар болуы өте маңызды.пациенттерге және отбасына білім беру. Дегенмен, басқа медициналық мамандықтар сияқты, мейірбике ісінде де ауырсынуды тиімді бақылауды қамтамасыз етудегі кедергілер бар. Негізгі проблемалар-нашақорлық, есірткіге төзімділік, седативтілік және тыныс алу депрессиясы туралы қате түсініктер мен қорқыныштар; ауырсынуды бағалау және анальгетиктер туралы білімнің болмауы; және анальгетиктермен жеткіліксіз емдеу.Бұл дәстүрлі

ISBN 978-601-08-0758-7

бакалавриат мейірбикелік оқу бағдарламаларында ауырсынуды бақылауға арналған ең аз уақытты қарастырған кезде түсінікті. Бақытымызға орай, қазіргі уақытта бұл мәселелер шешілуде және қол жетімді білім беру бағдарламалары мен ресурстары айтарлықтай жақсарды. Қатерлі ісікке қарсы мемлекеттік бастамалар, нұсқаулықтар және ұйымдық ұстанымдар ауырсынуды басқаруды жақсартуға бағытталған тамаша күш-жігер болды. IRS әртүрлі деңгейдегі тәжірибесі бар медбикелер үшін тәжірибе ауқымын сипаттайтын қатерлі ісік ауруы туралы позициялық құжатты әзірледі. Тіпті Денсаулық Сақтау Ұйымдарын Аккредиттеу Жөніндегі Бірлескен Комиссия ауруды басқарудың жеткіліксіздігі мәселесін мойындады және тиісті басқаруға баса назар аудару үшін күтім стандарттарын өзгертті [5].

Медбикелер денсаулық сақтаудың жүрегі деп жиі айтылады. Онкологиялық мейірбике ісі саласы, атап айтқанда, мейірбике ісіндегі ең күрделі және пайдалы салалардың бірі болып табылады. Онкологиялық науқастарға келетін болсақ, онкологиялық медбикелер науқастарға қиын және қолайсыз сәттерінде, сіздің жаныңызда болады, білім береді, жігерлендіреді. Олар сондай-ақ, дәрігерлермен байланысып, медициналық көмекті үйлестіретін адамдар [6].

Медбикелер бұл мамандыққа өз қалаулары бойынша қосылады. Олар әлемнің емшілері, көмекшілері, қамқоршылары. Медбикелер онкологиялық мекемеде жұмыс істеуге шешім қабылдағанда, олар проблемалар туындайтынын түсінеді және олар мұны бәрібір жасайды. Кейбіреулер тіпті пациенттері үшін өз уақытын арнайды.

Онкологиялық медбикелер онкологиялық науқастарға күтім жасайды, олардың алғашқы байланыс желісі ретінде қызмет етеді және онкологиялық ауруларды емдеу кезінде олардың күтімінің көптеген аспектілерін үйлестіруге көмектеседі. Олар бірқатар міндеттерді орындай алады, соның ішінде:

1. Науқастың денсаулық тарихына шолу
2. Науқастың физикалық және эмоционалдық жағдайын бағалау және бақылау
3. Зертханалық, патологиялық және бейнелеу зерттеулерінің есебін жүргізу
4. Дәрі-дәрмектерді, сұйықтықтарды және химиотерапия сияқты қатерлі ісіктерді емдеуді қауіпсіз енгізу
5. Науқастың дәрігерлерімен және басқа дәрігерлермен емдеу жоспары бойынша ынтымақтастық
6. Пациенттерге ауруды және олардың емдеу жоспарын түсінуге көмектесу
7. Күрделі медициналық терминологияны аударуға және сұрақтарға жауап беруге көмектесу
8. Науқастың атынан дәрігерлермен және басқа клиникалармен байланыс орнату
9. Науқасқа емдеу барысында симптомдарды жоспарлауға және басқаруға көмектесу [7].

ISBN 978-601-08-0758-7

Онкологиялық медбикелердің қатерлі ісікке қатысты арнайы білім базасы және онкологиялық ауруларды емдеуде негізгі мейірбикелік бағдарлама арқылы алынғаннан тыс клиникалық тәжірибесі бар. Басқарманы сертификаттау ерікті болып табылады және мамандық бойынша біліктілікті, білімді және білімді қажет етеді. Онкологиялық сертификат алу үшін медбикелер әдетте мейірбике дипломы, тіркелген мейірбике лицензиясы (RN) болуы, белгілі бір жарамдылық критерийлеріне сай болуы және емтихан тапсыруы керек. Жетілдірілген сертификаттау әдетте мейірбике ісі бойынша магистр немесе одан жоғары дәрежені, бірнеше сағаттық бақыланатын клиникалық тәжірибені және кейде қосымша дайындықты қажет етеді [8].

Қорытынды: Қатерлі ісікке шалдыққан адамдарға күтім жасаудағы стресстер мен қиындықтарға байланысты онкологиялық медбикелер жиі физикалық және эмоционалдық күйзеліске ұшырайды. Медбикелер үшін де өздеріне қамқорлық жасау маңызды, бұл өз кезегінде пациенттеріне жақсы күтім жасауға көмектеседі.

Мейірбикелік күтімді пациенттердің жайлылығына ықпал ету, пациенттер мен олардың отбасыларына ауырсынуды бақылауға қатысты ақпарат беру, мінез-құлық және физикалық араласулар туралы ақпарат беру және оларға көмек көрсету, фармакологиялық терапияның жанама әсерлерінің алдын алу және жеңілдету, пациенттердің терапияға сәйкестігін және қажетті бақылауды қамтамасыз ету үшін жоспарлау керек. Медбике араласудың негіздемесін түсіндіріп, пациенттер мен отбасы мүшелерінің сұрақтарына уақыт бөлуі керек. Пациенттерге білім беруде фармакологиялық агенттердің атаулары, дозалау кестелері, жанама әсерлері, жүрек айнуы мен құсуды жеңілдетуге арналған шаралар, мысалы, құсуға қарсы препараттар және іш қатуды жеңілдетуге арналған араласулар болуы керек. Медбике фармакологиялық араласулардың тиімділігі мен жанама әсерлерін, тыныс алу жағдайы мен ішектің жұмысын, сондай-ақ психикалық және когнитивті функцияларды бақылауы керек. Науқас пен оның отбасы төтенше жағдайда медициналық қызметкерлермен қалай байланысуға болатынын білуі керек және мұны еркін сезінуі керек.

Әдебиеттер тізімі:

1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK584206/
2. https://www.cancercenter.com/community/blog/2020/07/heart-of-health-care-oncology-nursing
3. Заликина Л. С. Уход за больными: учебник. - М., 2008. – 129 экз
4. Мухина, С. А. Теоретические основы сестринского дела М. : ГЭОТАР - Медиа, 2014-1экз.
5. Обуховец, Т. П. Основы сестринского дела. Часть 1. Теория сестринского дела. Часть II. Практика сестринского дела : учеб. пособие . - 16-е изд., стереотип. - Ростов н/Д : Феникс, 2011.- 2 экз.
6. Кочнева, С. А. Новейший справочник участковой медсестры : справочное издание . - 2-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 1 экз.

ISBN 978-601-08-0758-7

7. Қаныбеков, А. Медбикеге арналған нұсқаулар : оқулық Алматы : Эверо, 2014.-80экз

8. Нурманова М. Ш. "Мейірбике ісі негіздері" пәні бойынша мейірбикелік технологиялар стандарттарының жинағы. - Қарағанды : ЖК "Ақ Нұр", 2012. – 50 экз.

ISBN 978-601-08-0758-7

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕ МЕЙІРГЕР ІСІНІҢ РӨЛІ

Махмут Қылышбек Жеткергенұлы, оқытушы
Қызылода медициналық жоғары колледжі

Аннотация: *Бұл мақалада мейіргер ісі мамандарын оқыту мен даярлаудың жолдары, шет елдердегі мейіргер мамандарын даярлаудың ерекшеліктері, сондай-ақ Қазақстандағы мейіргер ісін дамыту тенденциялары қарастырылған. Мейіргер ісінің жоғары біліктілікті мамандарының медицина саласында кәсіби мәртебесін қалыптастыру қарастырылады.*

Бүгінгі таңда мейіргер Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау жүйесінде басты орынға ие, бұл оның рөлі мен жауапкершілігінде елеулі өзгерістерге әкеледі. Заманауи денсаулық сақтауда мейіргерлер өздерінің дәстүрлі пациенттерді күту рөлдерін орындап қана қоймайды, сонымен қатар диагностикаға, емдеуге және оңалтуға белсенді қатысады. Олардың жауапкершілік деңгейі айтарлықтай өсті және олар қазір дәрігерлермен және басқа медицина мамандарымен бірлесіп, пәнаралық командаларда маңызды рөл атқарады.

Сонымен қатар, мейіргер ісін оқытуда елімізде бірнеше өзгешеліктер енгізілді.Атап айтар болсақ, мейіргер ісінің қолданбалы бакалавры, мейіргер ісінің академиялық дәрежесі, магистранттар т.б. Осы аралыққа дейін мейіргер ісін оқытуда дәрігерлер қызмет атқарып келді.Ал қазіргі таңда жоғары оқу орындарында және орта медициналық білім беру ұйымдарында мейіргер ісін мамандарын даярлау мейіргер ісінің «Магистратуралық» және «Докторантуралық» дәрежесі бар мамандарға жүктелді.

Қазіргі кезеңде Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мейіргер персоналын халықтың қолжетімді медициналық көмекке өсіп келе жатқан қажеттіліктерін қанағаттандырудың нақты әлеуеті ретінде қарастырады. Денсаулық сақтау саласы үшін қазіргі кезеңде мейіргерлердің жаңа буынын даярлау, нормативтік-құқықтық базаны құру, мейіргер ісін тиімді басқару үшін кәсіби деңгейді толық іске асыруға жағдай жасау, сондай-ақ дәрігерлер мен дәрігерлер арасындағы шынайы қарым-қатынас пен серіктестікті қамтамасыз ету маңызды. Мейіргерлерді оқыту кезінде білім беру мен оқыту сапасын арттыруға, практикалық дағдыларды дамытуға басты назар аудару керек.

Сондықтан да қазір бүкіл әлемде мейіргер ісі мамандары негізгі техникалық және кәсіптік білім деңгейінде ғана емес, бакалавриат, магистратура және докторантура деңгейлерінде де дайындалуда.

Жұмыстың мақсаты: Еліміздегі және шет елдердегі мейіргер ісінің даму тенденцияларын анықтау

Халықаралық тәжірибе.АҚШ-ғы мейіргер персоналдарын оқытудың дамуы. Америка Құрама Штаттарында мейіргерлердің бірнеше түрі бар. Олардың

ISBN 978-601-08-0758-7

білім деңгейі мен біліктілігі әртүрлі. [1] Америка Құрама Штаттарында ел азаматтары да, елде білім алған шетел азаматтары да мейіргер бола алады. Орта медициналық қызметкерлер санаттарға бөлінеді:

- **CNA (сертификатталған мейіргер көмекшісі)**

АҚШ-та CNA дәрежесін алу үшін сізге тек 75 сағаттық мамандандырылған курсты аяқтап, емтихан тапсыру қажет. CNA дәрежесі бар мейіргер қызметкерлері пациенттерге гигиеналық күтім жасау, дәрі-дәрмек беру және мүгедектер арбасындағы науқастарды тасымалдауды қамтитын шектеулі міндеттерді орындауға құқылы.

- **LPN (лицензияланған мейіргер)**

LPN дәрежесін алу үшін сіз бір жылдық мамандандырылған курсты аяқтап, қорытынды емтиханды тапсыруыңыз керек. LPN сертификаты бар медициналық персонал, CNA міндеттерінен басқа, таңғыштар жасауға, IV және инъекцияларды енгізуге, науқастарды операцияға дайындауға және емдік массаж жасауға құқылы.

- **RN (тіркеу мейіргер)**

RN дәрежесіне ие болу үшін сізде AS - ғылым қауымдастығы немесе BS - мейіргер ісі саласындағы ғылым бакалавры дәрежесі болуы керек. АҚШ-та RN санаты мейіргер қызметкерлеріне тең. Бакалавр дәрежесі бар RNs мейірбикелік диагноз қоя алады және CNA және LPNs бақылай алады.

- **ARNP**

ARNP дәрежесін алу үшін сіз мейіргер ісі бойынша магистр дәрежесін аяқтап, лицензия алуыңыз керек. ARNP мейіргер дәрігер ретінде толық емес жұмыс күнімен жұмыс істей алады, өз тәжірибесін аша алады немесе жоғары мамандандырылған салаларда (акушерлер, хирургиялық медбикелер, медбике анестезиологтары және т.б.) жұмыс істей алады.

- **DNP (мейіргер ісі тәжірибесінің докторы)**

DNP санатын алу үшін сіз докторлық оқуды аяқтауыңыз керек. Мейіргерлердің бұл санаты педагогикалық қызметпен айналысуға, ғылыми зерттеулерге, қоғамдық жобаларға қатысуға және медбикелік медициналық орталықтарды басқаруға мүмкіндік алады.

- **PhD (философия докторы)**

Алдыңғы абзацтағыдай дәреже алу үшін докторантураны аяқтау керек. PhD дәрежесі зерттеу мен оқытуға жол ашады. Көбінесе мейіргер ісі саласындағы философия докторлары ғылыми қызметкерлер, колледж оқытушылары және осы саладағы семинарлар мен конференциялардың жүргізушілері болып табылады.[2]

Финляндияда мейіргерлерді оқытудың халықаралық тәжірибесін қарастырайық. Финдік мейіргерлік білім беру жүйесі әлемдегі ең сапалы білім берудің бірі ретінде бағаланады. Финляндиядағы мейіргер мамандығы танымал және жоғары құрметке ие. Мейіргерлер ауқымды профилактикалық іс-шаралар жүргізеді, пациенттерге және отбасы мүшелеріне кеңес береді, ауру парақтарын, рецепттерді бере алады, кейбір дәрілік терапияны тағайындай алады. [3]

ISBN 978-601-08-0758-7

Мейіргер персоналының міндеті – кәсіби медициналық көмек көрсету, оның ішінде пациенттердің денсаулығын сақтау және нығайту және емдеу. Мейіргер персоналы өздерінің кәсіби функцияларын дербес орындайды және дәрігер тағайындаған науқастарды емдеуді жүзеге асырады.[4] Мейіргер персоналының міндетіне сондай-ақ олардың жұмысын жақсарту және әлеуметтік қамсыздандыру және денсаулық сақтау саласындағы басқа мамандармен өзара әрекеттесу кіреді, сонымен қатар олар қоғамдық шешімдер қабылдау процесіне өздерінің кәсіби үлесін қосуы және қоғамдық талқылауларға қатысуы керек.[5]

Финляндияда медициналық қызметкерлерді оқыту және кәсіби қызметі заңмен және медициналық қызметкерлер туралы ережелермен қатаң реттеледі. Университетке түскеннен кейін талапкерлер мотивация мен оқу қабілетіне тестілеуден өтеді.[6] Финляндияда тәжірибелік сабақтардың маңызы зор. Бұл үшін жеткілікті сағат саны бөлініп, барлық қажетті жағдайлар жасалған. Айта кету керек, Финляндияда білім сапасы сырттай да, ішкі жағынан да бағаланады. Осылайша, Финляндияның денсаулық сақтау секторында, сондай-ақ мейірбике ісі саласында оқыту және жұмыс тәжірибесі үлкен қызығушылық тудыратыны сөзсіз.[7]

Түркияда мейіргер ісі бойынша оқу студенттерге денсаулық сақтау саласында табысты жұмыс істеу үшін қажетті кең көлемдегі білім мен дағдыларды береді. Бұл төрт жылдық бағдарлама анатомия, физиология және фармакологиядағы іргелі курстарды денсаулық сақтаудың әртүрлі жағдайларында практикалық клиникалық тәжірибемен біріктіреді.[8] Түлектер ауруханаларда, емханаларда, денсаулық сақтау ұйымдарында және мамандандырылған медициналық салаларда әртүрлі мансапқа жақсы дайындалған.[9]

Түркиядағы мейіргер ісі бағдарламасының түлектері денсаулық сақтаудың әртүрлі жағдайларындағы мейіргерлік дағдылардың жан-жақтылығы мен өзектілігін көрсететін мансаптық мүмкіндіктердің кең ауқымына ие. Бағдарлама студенттерді әртүрлі мейіргерлердің рөлдерді сәтті орындау үшін қажетті клиникалық дағдылармен және практикалық тәжірибемен қамтамасыз етеді.

Түркияда мейіргерлер әр түрлі дәрежеде білім алып шығады.Мысалы:

- **Тіркеу мейіргері (RN):** ауруханалар мен емханалардағы пациенттерге жан-жақты көмек көрсетеді.
- **Педиатр мейіргері:** нәрестелерді, балаларды және жасөспірімдерді күтуге маманданған.
- **Критикалық күтім мейіргері:** ауыр науқастарға қарқынды терапия көрсетеді.
- **Қоғамдық денсаулық сақтау мейіргері:** денсаулық мәселелерімен және қоғаммен байланыспен айналысады.
- **Мейіргер педагог:** Болашақ мейіргерлерді академиялық және клиникалық жағдайларда оқытады.
- **Мейіргер менеджері:** Мейіргер персоналының жұмысын бақылайды және мейіргерлік бригадаларды басқарады.[10]

ISBN 978-601-08-0758-7

Қазақстан үшін мейіргер ісі жүйесін дамыту оның білім берудің барлық деңгейінде дамуын, халықаралық стандарттар деңгейінде білім сапасын бақылауды және деңгейіне сәйкес әртүрлі лауазымдық мейіргерлік мамандар институтын тәжірибеге енгізуді білдіреді. [11]

Денсаулық сақтауды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған «Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасы аясында мейіргерлік білім беру жүйесін жаңғырту, мейіргерлердің рөлін арттыру, олардың білім беру стандарттарының өзгеруіне сәйкес мейірбике қызметкерлерінің құзыреттерін кезең-кезеңімен кеңейту жоспарлануда. 2030 жылға қарай мейірбике ісі саласында қолданбалы бакалавриат дәрежесі бар озық тәжірибелі мейіргерлерге ие болу жөніндегі ұлттық мақсат 40 000-нан астам адамды құрайды.Бұл жалпы мейіргер жұмыс күшіндегі қолданбалы бакалавриат мейіргерлерінің үлесінің 39,85% құрайды (АҚШ эталоны – 37,2%, Еуропа елдерінде – 46,8). %).[12]

Қазақстанның Болон процесіне кіруі білім беруді, кәсіби стандарттарды, біліктілік пен лауазымдық орындарды Еуропалық директивалармен, соның ішінде мейіргер ісі бойынша да сәйкестендіру қажеттілігін талап етеді.[13]

Қорытынды. Қазіргі уақытта біздің республикамызда үш деңгейлі мейіргерлер даярланады: орта кәсіптік білім, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім. Мейіргерлер ісі бакалавларын яғни, мейіргерлердің жаңа генерациясын дайындау тек қана мамандық беделін жоғарлатып қоймай, дәрігерлердің атқаратын қызметтерінің көп үлесін мейірбикелерге беруге мүмкіндік береді, дәрігерлер кадрларының жетіспеушілігін төмендетеді. Осылайша, Қазақстан Республикасындағы мейіргер қызметін реформалау шеңберінде практикалық денсаулық сақтау ұйымдарында мейіргерлердің әлеуетін одан әрі дамыту үшін негіз дайындалды.

Тұжырымдай келе, еліміздегі мейіргер ісін кәсіби дамыту қолға алынғанымен, халықтың хабардарлығы әлі де болсын төмен.Медицина қызметкерлерінің арасында әртүрлі дәрежеде біліктілікті арттырумен қатар, осы қолданыстағы диплом бойынша қандай лауазымда жұмыс жасай алатынын білуі де маңызды болып табылады.Жалпы айтқанда, мейіргерлік іс саласында жаңа технологияларды әзірлеуде және мейіргер мамандарын даярлауда жоғары білікті мейіргерлердің қосатын үлесі жоғары болып табылады.

Пайдаланылған әдебиеттер

1.Доклад о состояний здравоохранений в мире / Lincoln Chen, David Evans, Tim Evans, Ritu Sadana, Barbara Stilwell, Phyllida Travis, Wim Van Lerberghe и Pascal Zurn., Под ред. Leo Vita-Finzi и Barbara Campanini. - Женева: 2006. - 153 с.

2. Liese, B., Blanchet, N., and Dussault, G. The Human Resource Crisis in Health Services in Sub-Saharan Africa // The World Bank. - 2003. -120 с.

3.Тахтарова Ю. Н. Совершенствование организации деятельности среднего медицинского персонала (структурно-функциональный аспект): дисс. ... канд. мед. - М., 2007. - 152 с.

4. Островская И.В., Широкова Н.В. Основы сестринского дела: учебник. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2008. - 320 с.

ISBN 978-601-08-0758-7

5.Салалыкина Е.В., Лынова Е.Н. Современные коммуникационные процессы в организации деятельности медицинского персонала // Сборник материалов 1 международной (X Всероссийской) научно- методической конференции РИЦ Баш ГУ. - 2014. - С.75-77.

6. Салалыкина Е.В., Лынова Е.Н.Профессиональное выгорание - как причина ухудшения взаимодействия персонала в коллективе // Сборник материалов 1 международной (X Всероссийской) научно- методической конференции РИЦ Баш ГУ. - 2014. - С.160-162.

7. Шильникова Н.Ф., Карпова И.П. Методика оценки деятельности среднего медицинского персонала: Методическое пособие. - Чита: 2010. - 30 с.

8. Сыдыкова Б.Қ., Умбетпаев А.Т., Байгожина З. А., Хисметова З.А., Самарова У.С., Сарсенбаева Г.Ж., Елисинова А.М., Смаилова Д.С. Стимулирование профессионального развития медицинских сестер как способ повышения качества медицинской деятельности // Наука и Здравоохранение. 2021. 4(Т.23). С. 199-207. doi 10.34689/SH.2021.23.4.022

9. https://study-usa.kz/poleznye-stati/nursing-usa/

10. https://blog.unif.pro/nursing-centria/

11. https://www.studyu.org/ru/program/nursing/

12. https://cyberleninka.ru/article/n/puti-formirovaniya-novoy-generatsii-meditsinskih-sester-v-kazahstane

13. https://deti.mail.ru/forum/dosug/obo_vsjom_na_svete/rabota_v_turcii_prepodavatelem_jeto_realno_ili_skazki/

14. https://newjournal.ssmu.kz/publication/448/2021-4-23-199-207/

15. https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-osobennosti-podgotovki-i-obucheniya-meditsinskih-sester-v-kazahstane

ISBN 978-601-08-0758-7

МЕЙІРГЕРЛЕРДЕ ЭМОЦИОНАЛДЫ КҮЙЗЕЛІС ӘСЕРІНЕН ПАЙДА БОЛҒАН СТРЕССТІ ТӨМЕНДЕТУДЕГІ ЖАТТЫҒУДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ

Сейілханова Айгерім Әкімтайқызы
Қызылорда медициналық жоғары колледжі, оқытушы
Мухтарова Гулсара Тулегеновна
“Облыстық наркологиялық орталығы” ШЖҚ МКК, мейірбике

Аннотация: *Бұл мақаланың зерттеу жұмыстары Қызылорда облыстық наркология орталығы №1 ерікті емдеу бөлімшесінің 12 мейіргеріне В.В. Бойконың эмоционалды күйзеліс деңгейін диагностикалау әдістемесі және Маслач К, Джексон С дайындаған күйзеліс деңгейін анықтау әдісі бойынша жүргізілді. Зерттеуде 35 – 50 жас аралығындағы мейіргерлерге қарағанда 25 – 30 жас аралығындағы мейіргерлердің нәтижелері өте жоғары болды. Мейіргерлердің нәтижелерінің өте жоғары болуын тәжірибелерінің аздығынан, жұмыстың жұмыс ерекшелігімен, дәлірек айтқанда, тәулік бойы науқастарды бақылау кезінде шаршаумен байланыстыруға және жас ерекшеліктеріне байланысты деп түсіндіруге болады. Эмоционалды күйзелістің алдын алу және төмендету үшін жаттығудың маңыздылығы тәжірибеде көрсетті.*

Өзектілігі. Эмоционалды күйзелу синдромының қауіптілігі оның күннен күнге өршіп түсетіндігі. Мейіргерлер шаршау сезімдеріне және жүктемелерге қарамастан, жұмыстарына қызығушылығын жоғалтпай, өз еңбектерінің пайдалығын сезіне отырып орындаған жұмыстарына қанағаттанады, ұжымдағы психологиялық климаттың қолайлы болуы, сапалық көрсеткіштерді арттырады. Ұжымдағы әріптестер арасындағы дұрыс қарым – қатынас, басшылықпен сыйластық байланыс орнату, адамның өзіне тән жеке мінез – құлықтың ерекшеліктерімен сипатталады [1,2,3].

Пациенттерде психосоматикалық бұзылулардың кең таралу мәселесін талқылай отырып, біз дәрігерлер мен басқа медицина қызметкерлері арасында психоэмоционалдық бұзылулардың даму проблемасы туралы айтпай кетуге болмайды. Науқастарды емдеу және оңалтумен айналысатын медицина қызметкерлерінің кәсіби қызметі эмоционалдық қарқындылықты және стрессті тудыратын факторлардың жоғары пайызын қамтиды. «Қиындық пен зияндылық критерийі» бойынша (А.С.Шафранов бойынша) мамандықтардың жіктелуі бойынша, дәрігерлік пән бойынша және өз бетімен үнемі сабақтан тыс жұмыс жүргізу қажеттілігіне қарай ең жоғары типтегі мамандыққа жатқызылады. Швейцариялық ғалымдар жиі немесе шамадан тыс жұмыс уақытын немесе жұмыс уақытының үнемі жетіспеушілігін медицина қызметкерлері үшін кәсіби стресстің негізгі факторлары деп санайды [6]. Үнді ғалымдары медицина қызметкерлерінің кәсіби күйзелістерінің келесі факторларын анықтады: қатысудың болмауы, дәрменсіздік, төмен статус және рентабельділік [7].

ISBN 978-601-08-0758-7

Мейіргерлердің жұмыс күндері адамдармен тығыз қарым – қатынас орнату, қырағы күтім мен аса назарды қажет ететін науқастар. Күндізгі және түнгі ауысымдағы мейіргерлерге қарағанда айналмалы ауысымда жұмыс істейтін мейіргерлер арасында ұйқы проблемалары, әсіресе жұмыс уақытында ұйықтап қалу, жұмысқа кешігіп келу және апаттар мен қателіктер жіберу, физикалық шаршау, үмітсіз науқасты көруі, жүрек - өкпелік реанимацияны жүргізу, науқастың өлімі, науқастың туыстарымен әңгіме жүргізу, жұмысының нәтижесіне қанағаттанбау, білімін үздіксіз жетілдіру қажеттілігі, ыңырсулар, айқайлар, науқастардың шағымы, тез шешім қабылдау қажеттігі, бір патологияның басқасына ауысуының жиілігі өте жоғары эмоционалды күйзеліске әкеледі [4].

Итальяндық ғалымдар кәсіптік күйзеліс қаупін зерттеу проблемасы мен дәрігерлер арасындағы психикалық бұзылуларға, кәсіптік күйзелістерге және эмоционалды күйзелістерге қарсы заманауи профилактикалық шараларға қатысты 36 зерттеуге талдау жасады. Дәрігерлер арасында жұмысқа байланысты стресс пен психикалық бұзылулар жиі кездесетіні анықталды. Бұл құбылыстардың алдын алу шараларын қабылдау қазірдің өзінде басымдық болып табылады. Дегенмен, қандай шаралар тиімдірек екендігі туралы әлі де консенсус жоқ. Дәлелді ұсыныстарды тұжырымдау үшін қосымша зерттеулер қажет [8]. Кәсіби күйзеліс синдромы дәрігерлерге қарағанда мейіргерлерде тез дамиды, орташа алғанда 5 – 9 жыл. Сондықтан медицина қызметкерлерінде кәсіби күйзеліс синдромының қалыптасу ерекшеліктерін білу, олардың жұмыстарын оңтайландыру үшін аса қажет [5].

Жұмыстың мақсаты. Қызылорда қаласы наркология орталығындағы мейіргерлер арасында болатын эмоционалды күйзеліс деңгейін, олардың пайда болуына ықпал ететін қауіп факторларын және өз жұмыстарына қызығушылық пен қанағаттанарлақ деңгейін В.В. Бойко және Маслач К, Джексон С әдісімен анықтау**.**

Зерттеу материалдары мен әдістері. Зерттеу жұмысы Қызылорда облыстық наркология орталығы №1 ерікті емдеу бөлімшесінің мейіргерлеріне В.В. Бойконың эмоционалды күйзеліс деңгейін диагностикалау әдістемесі бойынша сауалнама көмегімен жүргізілді. Зерттеуге барлығы 12 мейіргер қатысты. Жаттығудан кейін Маслач К, Джексон С дайындаған күйзелістің сатысын анықтау әдісін қолданып, нәтижесі анықталды.

Алынған нәтижелер және оны сараптау. Қызылорда облыстық наркология орталығы №1 ерікті емдеу бөлімше мейіргерлерінің эмоционалды күйзелу синдромының жетекші симптомдары бойынша таралу нәтижесі 1 кестеде келтірілген.

Кесте - 1. 25-30 жас аралығындағы мейіргерлердің күйзелу синдромының жетекші симптомдары бойынша таралу нәтижесі

№	Жетекші	Қалыптаспаған	Қалыптасу үстінде	Толық қалыптасқан	Эмоционалды күйзелу

ISBN 978-601-08-0758-7

	симптомдары	Саны	%	Саны	%	Саны	%	Саны	%
1	Психикасына әсер ететін жағдайларды бастан кешіру	2	16,7	3	25	3	25	4	33,3
2	Өзіне көңілі толмау	8	66,7	3	25	1	8,3	-	-
3	Тығырықтан шығу жолы жоқ	9	75	2	16,7	1	8,3	-	-
4	Мазасыздану және депрессия	4	33,3	3	25	2	16,7	3	25
Кернеу фазасы		12	48	12	23	12	14,5	12	14,5
5	Адекватты емес таңдамалы түрдегі эмоционалды жауап	6	50	4	33,4	1	8,3	1	8,3
6	Эмоционалды-әдептілік дезориентация	9	75	2	16,7	-	-	1	8,3
7	Эмоцияларды үнемдеу саласын кеңейту	1	8,3	5	41,7	-	-	6	50
8	Кәсіби міндеттердің редукциясы	-	-	5	41,7	-	-	7	58,3
Төзімділік фазасы		12	33,4	12	33,4	12	2	12	31,2
9	Эмоциялы	8	66,7	4	33,3	-	-	-	-

ISBN 978-601-08-0758-7

	қ жетіспеушілік								
10	Эмоцияның жоғалуы	1	8,3	8	66,7	-	-	3	25
11	Жеке тұлғаның өзгеру немесе деперсонализация	6	50	3	25	-	-	3	25
12	Психосоматикалық жәнепсиховегетативті бұзылыс	4	33,3	3	25	1	8,4	4	33,3
Жүдеу фазасы		12	39,5	12	37,5	12	8,2	12	20,8

1-ші кестеге сәйкес психикасына әсер ететін жағдайларды бастан кешіру симптомы қалыптаспаған 2 мейіргерде – 16,7%-ды, қалыптасу үстінде 3 мейіргерде - 25%-ды, толық қалыптасқан 3 мейіргерде - 25%-ды және эмоционалды күйзелу 4 мейіргерде – 33,3% -ды қамтыды, өзіне көңілі толмау симптомы қалыптаспаған 8 мейіргерде – 66,7%-ды, қалыптасу үстінде 3 мейіргерде - 25%-ды және толық қалыптасқан 1 мейіргерде – 8,3%-ды, тығырықтан шығу жолы жоққалыптаспаған 9 мейіргерде – 75% -ды, қалыптасу үстінде 2 мейіргерде – 16,7% -ды және толық қалыптасқан 1 мейіргерде – 8,3%-ды, мазасыздану және депрессия қалыптаспаған 4 мейіргерде – 33,3%-ды,қалыптасу үстінде 3 мейіргерде - 25% - ды, толық қалыптасқан 2 мейіргерде – 16,7% -ды және эмоционалды күйзелу – 25% - ды қамтыды. Жалпы кернеу фазасы бойынша қалыптаспаған – 48% - ды, қалыптасу үстінде – 23% -ды, толық қалыптасқан – 14,5%-ды және эмоционалды күйзелу – 14,5%-ды қамтыды. Адекватты емес таңдамалы түрдегі эмоционалды жауап симптомы қалыптаспаған6 мейіргерде – 50% ды, қалыптасу үстінде 4 мейіргерде – 33,4% ды,толық қалыптасқан – 8,3% ды және эмоционалды күйзелу – 8,3% ды, эмоционалды- әдептілік дезориентация симптомы қалыптаспаған – 9 мейіргерде – 75%-ды, қалыптасу үстінде 2 мейіргерде – 16,7%-ды және эмоционалды күйзелу 1 мейіргерде – 8,3%, эмоцияларды үнемдеу саласын кеңейту симптомы қалыптаспаған 1 мейіргерде – 8,3% ды, қалыптасу үстінде 5 мейіргерде – 41,7%-ды жәнеэмоционалды күйзелу 6 мейіргерде – 50% ды, кәсіби міндеттердің редукциясы симптомы қалыптасу үстінде 5 мейіргерде – 41,7% ды және эмоционалды күйзелу 7 мейіргерде – 58,3%- ды қамтыды. Жалпы төзімділік фазасы бойынша қалыптаспаған – 33,4% -ды, қалыптасу үстінде – 33,4% ды,

ISBN 978-601-08-0758-7

толық қалыптасқан –2% -ды және эмоционалды күйзелу– 31,2% ды қамтыды. Эмоционалды жетіспеушілік симптомы қалыптаспаған 8 мейіргерде – 66,7% ды және 4 мейіргерде – 33,3% - ды, эмоцияның жоғалуы симптомы қалыптаспаған 1 мейіргерде – 8,3% ды, қалыптасу үстінде 8 мейіргерде – 66,7% ды және эмоционалды күйзелу – 25% - ды, жеке тұлғаның өзгеру немесе деперсонализация симптомы қалыптаспаған 6 мейіргерде - 50% ды,қалыптасу үстінде 3 мейіргерде – 25% -ды және эмоционалды күйзелу– 25% ды, психосоматикалық және психовегетативті бұзылыс симптомы қалыптаспаған 4 мейіргерде – 33,3% -ды, қалыптасу үстінде 3 мейіргерде – 25% ды,толық қалыптасқан 1 мейіргерде – 8,4% ды және эмоционалды күйзелу 4 мейіргерде 33,3% -ды қамтыды. Жалпы жүдеу фазасы бойынша қалыптаспаған – 39,5% -ды, қалыптасу үстінде – 37,5% -ды, толық қалыптасқан 8,2% -ды эмоционалды күйзелу 12 мейіргерде 20,8% -ды қамтыды.

Тұжырымдай келе, анализді талдау кезінде 12 мейіргерде үшфазада да қалыптасу үстінде және толық қалыптасқан кездесті. Эмоционалды күйзеліс үш фазада да кездесіп, оның 14,5% кернеу фазасында, 31,2% төзімділік фазасында, ал 20,8% жүдеу фазасында кездесті. Сауалнама нәтижесі эмоционалды күйзеліс синдромының 25 – 30 жастағы мейіргерлер арасында жоғары екенін көрсетті. Мейіргерлер нәтижелері бойынша олардағы эмоционалды күйзелу синдромы симптомдарының өте жоғары болуы олардың тәжірибелерінің аздығымен, тәулік бойы науқастарды бақылау кезінде шаршауымен және жас ерекшеліктеріне байланысты түсіндіруге болады. Жаттығудан кейін мейіргерлерде эмоционалды күйзелу деңгейінің төмендеуі, жаттығулардың жұмыспен байланысты болатын шаршауды азайтуға болатындығын дәлелдеді.

Әдебиеттер тізімі:

1. Профессиональная патология: национальное руководство / под ред. Н.Ф. Измерова. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2011. – 784 с.

2. Гагунова, Е. Я. Общий уход за больными [Текст]: [учебник для мед. училищ] / Е. Я. Гагунова. – Медицина, 1964. - 284 с.

3. Кошкина О. П. Синдром "эмоционального выгорания" в профессиональной деятельности медицинской сестры // Главная медицинская сестра. - 2008. - № 6. - С. 68-86.

4. PMC Национальная медицинская библиотека США.Национальные институт здравоохранение. Утренний вечерний тип и уровень выгорания как факторы, влияющие на качество сна у медсестер смены: вопросникhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3160700/

5. Вестник КазНМУ №2(4) -2014ж «Кәсіби мейірбике ісіндегі күйзеліс маңыздылығы»https://cyberleninka.ru/article/v/k-sibi-zory-uy-meyirbike-isindegi-azirgi-zha-dayda-y-ma-yzdy-aspekt-retinde

6. Siebenhüner K. Temporal work stressors and satisfaction with work, life and health among health professionals in Switzerland / K. Siebenhüner, E. Battegay, O.

ISBN 978-601-08-0758-7

Hämmig // Swiss Med Wkly. 2020. Vol. 150. w20175. DOI: 10.4414/ smw.2020.20175.

7. Aryal S. Occupational stress and coping strategy among community health workers of Mangalore Taluk, Karnataka / S. Aryal, M. K. D'mello // Indian J Public Health. 2020. Vol. 64, iss. 4. P. 351–356. DOI: 10.4103/ijph.IJPH_549_19.

8. De Sio S. et al. Work-related stress risk and preventive measures of mental disorders in the medical environment: an umbrella review // Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2020. Vol. 24, iss. 2. P. 821–830. DOI: 10.26355/eurrev_202001_20065.

ISBN 978-601-08-0758-7

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ СИМУЛЯТОРОВ И РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЕКТА (AI) В ОБУЧЕНИИ МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ: АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ

Сейтжапарова М.С., бакалавр здравоохранения, преподаватель специальных дисциплин

Медицинский колледж «Семей»

Научный руководитель: Оразалина А.С. Кандидат биологических наук, доцент. Ученый секретарь Ученого совета

Аннотация: *В данной работе будет исследована роль виртуальных симуляторов и технологий дополненной реальности в подготовке будущих врачей. Цель исследования — оценить их влияние на развитие клинических навыков, углубление теоретических знаний и повышение мотивации студентов, а также рассмотреть перспективы дальнейшего использования инновационных технологий в образовательных программах медицинских вузов.*

Актуальность: Современное медицинское образование сталкивается с рядом вызовов, связанных с необходимостью подготовки высококвалифицированных специалистов, способных эффективно реагировать на сложные клинические ситуации. В цифровом мире учащиеся сильно отличаются от предыдущих поколений. Это цифровые учащиеся, которые выросли в среде, где все связано с Интернетом [5]. В связи с увеличением объема информации, быстроменяющимися технологиями и растущими требованиями к качеству медицинских услуг, традиционные методы обучения, основанные на лекциях и практических занятиях, становятся недостаточно эффективными. С этой целью в высших учебных заведениях внедряются новые инновационные методы и формы обучения, которые требуют от педагогических работников более высоких профессиональных и личностных навыков. Компетентность преподавателя, его способность заинтересовать и увлечь студентов напрямую влияет на эффективность занятий и качество подготовки специалистов [3]. Таким образом, внедрение инновационных образовательных технологий, таких как виртуальные симуляторы и искусственный интеллект, дополнительные визуализации, вебинары и тд. приобретает особую значимость.

Виртуальные симуляторы представляют собой мощный инструмент, позволяющий моделировать реальные медицинские ситуации в безопасной и контролируемой среде. Они обеспечивают студентам возможность на практике отработать навыки диагностики и лечения, повысить уровень уверенности в своих действиях и минимизировать риски ошибок в реальной практике. Кроме того,

ISBN 978-601-08-0758-7

симуляторы могут адаптироваться к уровню подготовки обучающихся, что позволяет осуществлять индивидуализированный подход к образованию.

Искусственный интеллект, в свою очередь, открывает новые горизонты для поддержки образовательного процесса. “Искусственный интеллект” (ИИ) - это широкий термин, обозначающий технологию, которая позволяет роботам и компьютерам имитировать человеческий интеллект[1]. Технологии искусственного интеллекта были разработаны для анализа различных медицинских данных, включая клиническую, поведенческую, экологическую информацию и информацию о лекарствах, а также данные из биомедицинской литературы и пациентов [1]. И в соответствии с этим, AI может использоваться для анализа данных, предоставления обратной связи в реальном времени, а также для создания персонализированных учебных траекторий. Понимание того, как современные студенты-медики воспринимают искусственный интеллект в медицине, что они знают и чего не знают, а также их понимание этических аспектов ИИ является важным первым шагом к разработке эффективных учебных программ по ИИ [2]. Обучение на основе игр — это концепция, используемая для описания методов преподавания, в которых игровая механика применяется для улучшения обучения учащихся [7]. Было показано, что геймификация и игровое обучение повышают вовлеченность пользователей. Это достигается благодаря способности методов геймификации создавать среду обучения с низкими ставками, поощряющую эксперименты. [8] Искусственный интеллект является важным компонентом видеоигр, поскольку он предоставляет алгоритмы, которые диктуют правила игры [6]. Эти технологии позволяют разработать более эффективные учебные материалы и обеспечить высокий уровень взаимодействия между студентами и преподавателями.

Актуальность данного исследования также обусловлена общими мировыми трендами в области здравоохранения, где акцент на инновации и технологии является приоритетом для повышения качества медицинской помощи[4]. Изучение эффективности внедрения виртуальных симуляторов и AI в обучении медицинских специалистов представляет собой важный шаг к оптимизации образовательных процессов и подготовке специалистов, способных к самостоятельному и критическому мышлению в условиях нестандартных ситуаций.

В 2024 году искусственный интеллект для учителей будет способствовать экономии времени, улучшению планирования уроков и повышению вовлеченности учащихся. Исследования демонстрируют, что внедрение технологий может увеличить уровень вовлеченности студентов до 50%, а учителя отмечают, что с помощью правильных инструментов время, затрачиваемое на административные задачи, сокращается на 40%. С развитием искусственного интеллекта образовательные процессы становятся более интеллектуальными и эффективными. Эти инструменты включают интерактивные образовательные платформы, способствующие активному участию студентов, а также системы управления, которые позволяют преподавателям эффективнее организовывать и

ISBN 978-601-08-0758-7

планировать свои занятия. В Медицинский колледже «Семей» внедрение и применение новых образовательных технологий (НОТ) в учебном процессе активно осуществляется в рамках Плана мероприятий по реализации Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан на 2020 – 2025 годы в соответствии с Концепцией внедрения инновационных технологий и методов обучения. По данным исследования анализ обратной связи среди студентов 1-5 курсов факультета «Общая медицина» по 5-балльной шкале показал высокий уровень удовлетворенности обучающихся (86%) применением новых образовательных технологий (НОТ) по шести основным критериям: 1) доступность восприятия учебного материала; 2) систематизация знаний; 3) развитие креативного мышления; 4) поддержка саморазвития и самообразования; 5) преодоление психологической инертности; 6) критическое осмысление изучаемого материала[3].

Таким образом, данная научная работа направлена на анализ существующих подходов к интеграции виртуальных симуляторов и искусственного интеллекта в медицинское образование, оценку их эффективности, а также выявление перспектив и стратегий внедрения этих технологий в учебных процессах. Результаты исследования могут быть полезны как для образовательных учреждений, так и для практикующих специалистов, стремящихся к улучшению качества своей работы и повышению уровня удовлетворенности пациентов.

Цель: Оценить эффективность внедрения виртуальных симуляторов в образовательные программы для медицинских работников, включая аспекты практической подготовки и теоретического обучения. Исследовать влияние применения искусственного интеллекта на индивидуализацию обучающих процессов, включая адаптацию контента к потребностям студентов и диагностику их учебных успехов. Выявить преимущества и недостатки применения данных технологий, а также барьеры, с которыми сталкиваются учреждения медицинского образования при их внедрении. Определить перспективы развития технологий виртуальной симуляции и искусственного интеллекта в обучении медицинских специалистов, включая возможные пути интеграции с существующими образовательными практиками.

Методы и материалы исследования:

Дизайн исследования: поперечное исследование, так как планируется изучение использование различных методов инновационных технологии и их эффективность в обучении по сравнению традиционного метода.

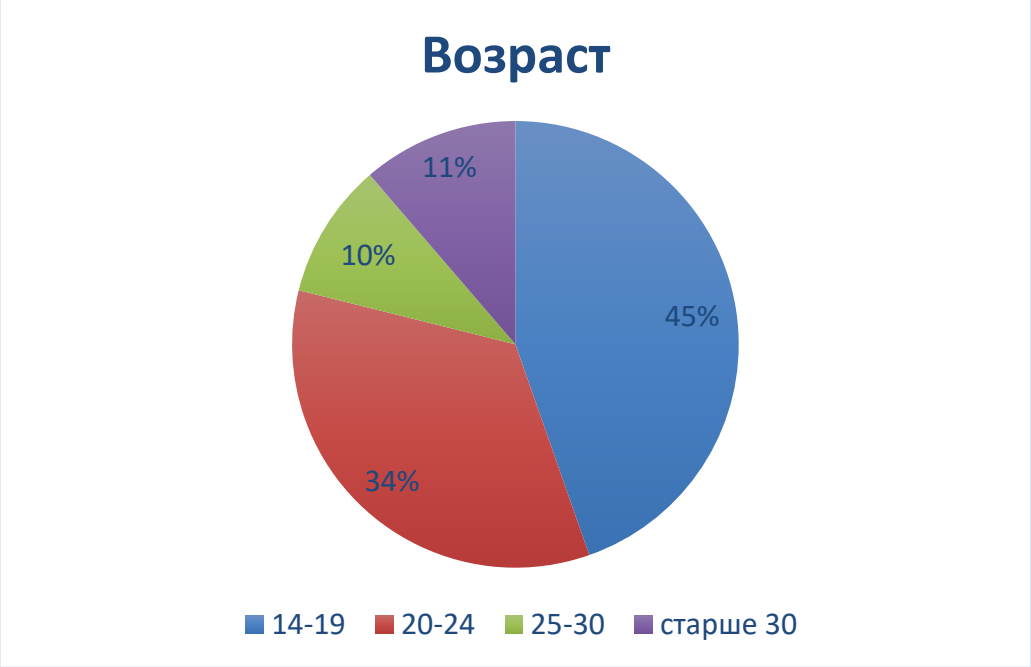
Применение валидных инструментов: в ходе исследования будет применена анкета для оценки насколько новые технологии в образовательном процессе способствуют повышению уровня знаний, навыков и мотивации студентов-медиков. Для оценки вероятности систематической ошибки, будет проведена валидизация. Проанализировать литературу в поисковых системах: PubMed, Lancet, Google Scholar.

ISBN 978-601-08-0758-7

Генеральная совокупность исследования включает студентов 1-4 курса «Медицинский колледж «Семей».

Статистическая обработка данных: С помощью программы SPSS 23.0 рассчитаем среднюю оценку балла использования преподавателями инновационных технологии для обучения студентов, рассчитаем значимость сравнения между новым методом обучения и традиционного метода используя Т-критерий Вилкоксона, и узнаем какие факторы больше всего повлияли на уровень оказания мед. услуг врачами общей практики используя таблицу сопряженности. $p<0,05$ считалось статистически значимым во всех типах анализа.

Результаты и их обсуждение: По результатам одномоментного поперечного исследования всего было проанкетировано 623 человек. Учитывая критерий исключения, в исследование могли включить только корректные ответы респондентов. Соответственно в дальнейшем анализе мы учли ответы 549 респондентов. Среди них 51,9 % в возрасте от 14-19 лет, 20,9% 20-24 лет, 11,7% 25-30лет , 7,3% старше 30 лет.



Согласно проведенным исследованиям количество студентов, выбравший раздел виртуальные симуляторы составил 261 участников, раздел онлайн курсы 120, мобильные приложения для обучения 101, дополненную реальность 11, искусственный интеллект 135, электронный учебный материал 265, лабораторные симуляторы 68, а ответ «не используем» набрал 273. Следуя из этого, можно сказать количество студентов не пользующиеся инновационными технологиями на данный момент составляет 49,7%, а активно использующие 50,3% (*график 2*). На вопрос о мотивации новых методов обучения 54,4% респондентов ответили увеличение мотивации к обучению, ответ «сильно увеличилось составил 19,8%, «не изменилось» 16,9%, а уменьшение мотивации отмечали всего 9,5%, что говорит о положительной динамике обучения используя инновационные технологии такие как виртуальная симуляция, искусственный интеллект,

ISBN 978-601-08-0758-7

электронные учебники и т.д., так как общий положительный ответ составляет 73,5%. Используя описательную статистику в программе SPSS 23.0, средняя оценка за эффективность каждой из используемых технологий: виртуальные симуляторы - 4,9 балла; онлайн-курсы 3,8 балла; мобильные приложения - 3,2 балла; дополненная реальность - 4,8 балла; искусственный интеллект- 4,7 балла; электронные учебные материалы -4,1 балла; лабораторные симуляции - 4,1балла; традиционный метод (лекции, опрос) 2,5 балла. Стоит отметить, что все виды новых методов обучения набрали выше средней оценку, что также подтверждает положительный ответ. На вопрос о преимуществе использования инновационных технологии ответы набрали: Увеличение доступности информации 61,5%; Возможность учиться в удобное время 43,8%; Повышение мотивации к обучению 66,3%; Лучшая визуализация учебного материала 75,7%; Улучшение практических навыков 71,01%; Ускорение процесса обучения 52,5%; Индивидуализация учебного процесса 36,5%. (график 3). Согласно этим данным использование визуальных симуляторов, искусственного интеллекта доказывает свою эффективность в визуализации материала, которое поможет улучшить практические навыки студента.

Полученные результаты показывают, что после использования визуальных симуляторов и искусственного интеллекта в обучении уровень успеваемости обучающихся значительно увеличилось. Результаты оценки уровня успеваемости студента при использовании традиционного метода и нового метода, мы проанализировали с помощью Т-критерий Вилкоксона, так как во время проверки на их нормальность, данные переменные не подчинялись закону нормального распределения. По данным Т-критерий Вилкоксона значение асимптотической значимости равна 0,009, то есть меньше чем 0,05. И следовательно, по результатам полученных данных можем сказать что между группами есть различие. К тому же, отрицательные ранги, то есть количество случаев «успеваемость студента при обучении традиционным методом: <успеваемость студента при обучении с использованием виртуального симулятора и искусственного интеллекта» больше чем «успеваемость студента при обучении традиционным методом:> успеваемость студента при обучении с использованием виртуального симулятора и искусственного интеллекта».

ISBN 978-601-08-0758-7

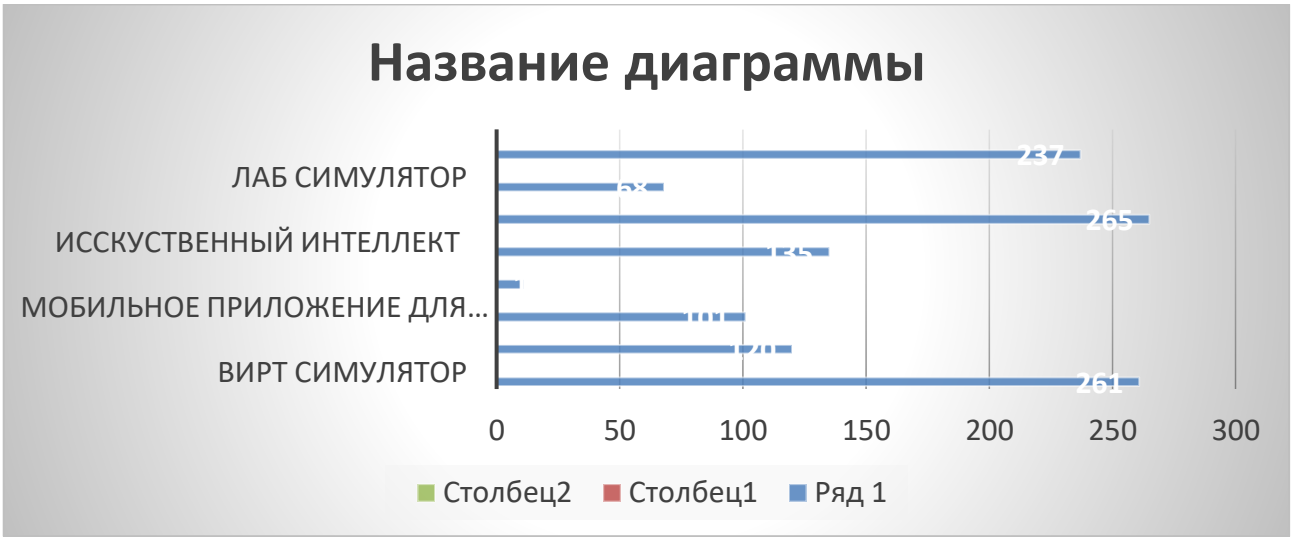


Таблица 2.

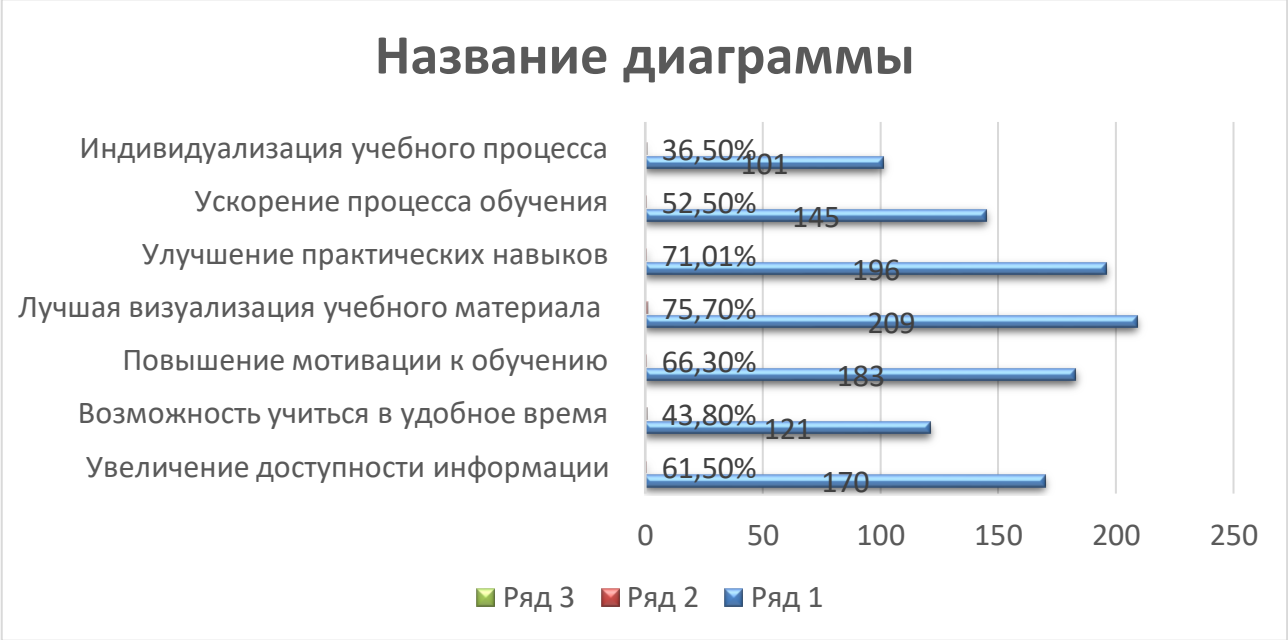


Таблица 3.

Выводы: В ходе проведенного исследования было установлено, что использование виртуальных симуляторов и различных видов искусственного интеллекта (AI) в обучении медицинских специалистов значительно способствует повышению качества образовательного процесса. Анализ эффективности применения этих технологий показал, что они в значительной степени способствуют развитию практических навыков у студентов, улучшению их критического мышления и способности к принятию решений в условиях приближенных к реальным. Виртуальные симуляторы позволяют создавать безопасные и контролируемые условия для практики, что минимизирует риски, связанные с обучением на реальных пациентах. Это особенно важно в специфических областях медицины, где точность и быстрота принятия решений играют решающую роль. Кроме того, применение AI в образовательных системах

ISBN 978-601-08-0758-7

предоставляет возможность индивидуализации обучения, позволяя адаптировать материалы и задания под конкретные потребности студентов. Перспективы внедрения данных технологий в медицинское образование выглядят многообещающими. Совершенствование алгоритмов искусственного интеллекта и развитие виртуальной реальности открывают новые горизонты для создания интерактивных и адаптивных образовательных платформ. Это позволит не только улучшить подготовку будущих медицинских специалистов, но и сократить время, необходимое для освоения практических навыков. Таким образом, результаты нашего исследования подчеркивают важность интеграции виртуальных симуляторов и AI в образовательные программы для медицинских специалистов, что не только улучшает учебные результаты, но и в конечном итоге способствует повышению качества медицинского обслуживания. Рекомендуется дальнейшее исследование и экспериментальное внедрение данных технологий в учебные процессы с целью оптимизации образовательных подходов и улучшения подготовки кадров в сфере здравоохранения.

Практические рекомендации: каждый новый год внедрять новые методы обучения, мотивировать преподавателей активно использовать виртуальные симуляции и искусственный интеллект в обучении своего предмета медицинским студентам, проводить мастерклассы преподавателям для правильного использования программ. Проводить динамическое наблюдение за успеваемостью студентов после внедрения новых методов в своем обучении.

Список литературы:

1. M. Murat Civaner, Yeşim Uncu, Filiz Bulut, Esra Giounous Chalil & Abdülhamit Tatli. Artificial intelligence in medical education: a cross-sectional needs assessment // BMC Medical Education. Article number: 772 (2022)

2. Kern DE, Thomas PA. Hughes MT: Curriculum development for medical education. A six-step-approach. 2nd ed: Johns Hopkins University Pres; 2009.

3. Абдулдаева А.А, Досжанова Г.Н. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ В МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ НА ПРИМЕРЕ НАО «МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ АСТАНА»// Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2021 S -спец выпуск

4. Gheorghe Ioan Mihalas , Casiana Boru , Coralia Cotoraci Teaching Artificial Intelligence to Medical Students Stud Health Technol Inform.// Stud Health Technol Inform. 2024 Aug 22. doi: 10.3233/SHTI240700.

5. Eui-Ryoung Han, Sanghee Yeo, Min-Jeong Kim, Young-Hee Lee, Kwi-Hwa Park5 and Hyerin Roh: Medical education trends for future physicians in the era of advanced technology and artificial intelligence: an integrative review// BMC Medical Education Article number: 460 (2019)

6. Ahmed Mahrous, David L Botsko, Amira Elgreatly , Akimasa Tsujimoto, Fang Qian , Galen B Schneider: The use of artificial intelligence and game-based learning in removable partial denture design: A comparative study.//Journal of Dental education 2023 Apr 26.

ISBN 978-601-08-0758-7

7. 2Das K, Behera R. A survey on machine learning: concept, algorithms and applications. Int J Adv Res Comput Commun Eng. 2017;

8. Ermakov SS. Modern e-learning technologies: analysis of the impact of gamification methods on student engagement in the educational process. J Mod Foreign Psychol. 2020; 9: 47-58.

9. Trial. Ali M Fazlollahi , Mohamad Bakhaidar, Ahmad Alsayegh, Recai Yilmaz, Alexander Winkler-Schwartz, Nykan Mirchi , Ian Langleben, Nicole Ledwos , Abdulrahman J Sabbagh , Khalid Bajunaid , Jason M Harley , Rolando F Del Maestro.: Effect of Artificial Intelligence Tutoring vs Expert Instruction on Learning Simulated Surgical Skills Among Medical Students:A Randomized Clinical// JAMA Netw Open. 2022 Feb 22;5(2):e2149008. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2021.49008

10. Sandra Goldsworthy., Nita Muir , Sue Baron , Didy Button , Kate Goodhand , Steve Hunter , Liz McNeill , Grace Perez , Tammie McParland, Lisa Fasken, Laurie Peachey: The impact of virtual simulation on the recognition and response to the rapidly deteriorating patient among undergraduate nursing students.// Nurse Education Today 2022 March

11. Jung Jae Lee , Vivien Wai Yin Tsang , Maggie Mee Kie Chan , Siobhan O'Connor , Zerina Lokmic-Tomkins , Fen Ye , Jojo Yan Yan Kwok , Mu-Hsing Ho: Virtual reality simulation-enhanced blood transfusion education for undergraduate nursing students: A randomised controlled trial.//Nurse Education Today 2023

ISBN 978-601-08-0758-7

МЕДИЦИНАЛЫҚ ОҚЫТУДЫҢ ҚЫЗЫҚТЫ ӘЛЕМІ

Толекова Сайраш Зейнелевна, жоғары білікті арнайы пәндер оқытушысы
Астана қаласы әкімдігінің«Жоғары медициналық колледж» ШЖҚ МКК

Уақыт өзгереді және олармен бірге медициналық мамандарды оқыту әдістері де өзгереді. Өз салаңызда сұранысқа ие сарапшы болуға көмектесетін жаңа парадигмалар мен әдістерді бірге зерттейік.

Табысты медициналық практиканың негізгі аспектілерінің бірі-білімнің үнемі жаңаруы. Күн сайын дерлік жаңа жаңалықтар мен технологиялар пайда болатын қазіргі медициналық әлемде соңғы тенденциялардан хабардар болу қажет. Бұл біздің мақалада талқыланатын болады.

Біздің мақсатымыз-сізге мүмкіндіктер әлеміне есік ашатын және кәсіби жетістікке жетуге көмектесетін жаңа оқыту әдістерін ұсыну. Сіздің медициналық мамандығыңызға қарамастан – бұл педиатрия, хирургия немесе кардиология болсын – біз өзімізге пайдалы нәрсе табатынымызға сенімдіміз.

Медицинадағы білім эволюциясын қарастырылады, тиімдірек, жылдамырақ және қызықты үйренуге мүмкіндік беретін жаңа әдістерді ұсыну. Қашықтықтан оқыту технологияларымен, интерактивті платформалармен және білімге деген көзқарасыңызды өзгертетін инновациялық тәсілдермен танысу.

Медицинадағы оқыту парадигмалары: білімнің жаңа көкжиектерін ашу. Заманауи әдістер медицина мамандарына дағдыларды дамыту және кәсіби жетілуге қол жеткізу үшін бірегей мүмкіндіктер ұсынады. Медицинадағы білімнің болашағын анықтайтын бірнеше негізгі парадигмаларды қарастырайық:

Интерактивті оқыту: енді біржақты дәрістер мен скучно слайдтар жоқ. Медицинада оқытудың заманауи әдістері студенттердің өзара әрекеттесуіне және белсенді қатысуына баса назар аударады. Бұған топтық пікірталастар, зертханалық және модельдеу тәжірибелері және шынайы сценарийлер жасау үшін виртуалды шындықты пайдалану кіреді.

Қашықтықтан оқыту технологиялары: цифрландыру және жаһандану дәуірінде қашықтықтан оқыту медициналық білім берудің ажырамас бөлігіне айналды. Ол ыңғайлылық пен икемділікті ұсынады, бұл медицина мамандарына кез келген уақытта, кез келген жерде білім мен дағдыларды алуға мүмкіндік береді. Вебинарлар, онлайн курстар және электронды оқыту платформалары білім мен тәжірибе алмасудың таптырмас құралына айналуы.

Технология және жасанды интеллект интеграциясы: технологияның қарқынды дамуының арқасында медицина мамандары енді Машиналық оқыту және жасанды интеллект сияқты инновациялық құралдарды пайдалана алады. Бұл деректерді талдауды автоматтандыруға, жеке емдеу жоспарларын құруға және тіпті Робот хирургтарының көмегімен күрделі операцияларды жасауға мүмкіндік береді. Технологияны қолдану медициналық процедуралардың дәлдігі мен тиімділігін арттыруға көмектеседі.

Белсенді оқытуды ілгерілету: ақпаратты пассивті қабылдаудың орнына, оқытудың заманауи әдістері белсенді ойлау мен сыни талдауды ынталандыруға

ISBN 978-601-08-0758-7

баса назар аударады. Топтық жобалар, проблемалық-бағдарланған оқыту және медициналық ойындар шығармашылық ойлау мен топтық жұмыс қабілеттерін дамытуға ықпал етеді.

Әлеуметтік өзара әрекеттесуді көтеру: медициналық білім берудің оқу ортасы енді аудиторияның немесе зертхананың қабырғаларымен шектелмейді. Әлеуметтік медиа, форумдар және онлайн қауымдастықтар медицина мамандарына білім, идеялар және тәжірибе алмасуға мүмкіндік береді. Бұл тәлімгерлік, ұжымдық оқыту және кәсіби ынтымақтастық үшін мүмкіндіктер жасайды.

Заманауи әдістер әр студенттің жеке қажеттіліктері мен білім деңгейін ескеретін бейімделгіш оқытуды ұсынады. Машиналық оқыту алгоритмдері студенттің үлгерімі туралы деректерді талдайды және жекелендірілген материалдар мен тапсырмаларды ұсынады. Бұл тәсіл әр оқушыға өз қарқынымен дамуға және ең жоғары нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік береді.

Оқыту тиімділігін бағалау: заманауи әдістердің маңызды бөлігі оқыту тиімділігін бағалау болып табылады. Классикалық емтихандар мен тесттер әлі де өзекті, бірақ модельдеу, практикалық тапсырмалар және жобалар сияқты жаңа бағалау әдістерімен толықтырылған. Бұл студенттерге теориялық білімді ғана емес, алған дағдыларын практикалық қолдануды көрсетуге мүмкіндік береді.

Үздіксіз білім беру: білімі дипломмен аяқталған кездер өткенге айналды. Қазіргі медициналық әлемде үздіксіз білім алу қажеттілікке айналады. Медицина мамандары үнемі өзгеруге, жаңа технологиялар мен ғылыми жаңалықтарға дайын болуы керек. Сондықтан қайта даярлау бағдарламалары, біліктілікті арттыру курстары мен конференциялар кәсіби өсудің ажырамас бөлігіне айналуда.

Пәнаралық оқыту: қазіргі медицинада пәнаралық тәсілге көбірек көңіл бөлінеді. Медицина мамандары командада жұмыс істей білуі және әртүрлі салалардағы білімді біріктіре білуі керек. Оқытудың жаңа әдістері әртүрлі мамандықтар арасындағы ынтымақтастық дағдыларын, қарым-қатынас пен өзара әрекеттесуді дамытуды мақсат етеді. Бұл күрделі медициналық мәселелерді шешуге қабілетті тиімді командалар құруға мүмкіндік береді.

Оқытудың жаңа әдістерінің артықшылықтары

Медицинада оқытудың жаңа әдістері медицина қызметкерлеріне өз кәсібінде жоғары нәтижелерге қол жеткізуге көмектесетін бірқатар маңызды артықшылықтарға ие.

Міне, атап өтуге болатын бірнеше негізгі артықшылықтар:

1. Интерактивті және практикалық оқыту: заманауи әдістер білім мен дағдыларды практикалық қолдануға баса назар аударады. Олар медицина қызметкерлеріне модельдеуге қатысу, бақыланатын жағдайларда пациенттермен өзара әрекеттесу және алған білімдерін нақты тәжірибеде қолдану мүмкіндігін ұсынады. Бұл материалды түсіну мен есте сақтауды жақсартуға көмектеседі, сонымен қатар шешім қабылдау және әртүрлі жағдайларға жауап беру дағдыларын дамытады.

ISBN 978-601-08-0758-7

2. Жекелендірілген оқыту: заманауи әдістер әрбір медицина қызметкерінің жеке қажеттіліктері мен білім деңгейін ескере отырып, білім беру процесін жекелендіру мүмкіндігін ұсынады. Жасанды интеллектке негізделген адаптивті оқыту жүйелері әр оқушының нақты қажеттіліктеріне сәйкес келетін қосымша материалдар, жаттығулар мен тапсырмаларды ұсына отырып, Жеке оқу жоспарларын құруға көмектеседі. Бұл оқу процесін жеделдету және материалды игеру сапасын арттыру арқылы уақыт пен күш-жігерді тиімдірек пайдалануға мүмкіндік бере

Медицинадағы оқытудың болашағы

Медициналық білім тынымсыз дамып келеді және медицинадағы оқытудың болашағы одан да көп инновациялар мен мүмкіндіктерді уәде етеді. Міне, болашақ медицинада оқытудың бірнеше негізгі аспектілері:

1.Виртуалды және Толықтырылған шындық: виртуалды және Толықтырылған шындық технологияларының дамуымен медициналық оқыту одан да интерактивті және шынайы болады. Студенттер виртуалды операцияларды жүргізе алады, органдар мен дене жүйелерінің үш өлшемді модельдерінде жаттығулар жасай алады және модельдеу жағдайында оқу үшін нақты сценарийлер ала алады. Бұл дағдыларды жетілдіруге және медициналық мамандарды нақты өмірдегі қиын жағдайларға дайындауға көмектеседі.

2. Деректер мен жасанды интеллектке негізделген оқыту: болашақта медициналық оқыту деректер мен жасанды интеллектке көбірек сүйенеді. Деректердің үлкен көлемін талдау медицинадағы үлгілерді, трендтерді және жаңа жаңалықтарды анықтауға көмектеседі. Жасанды интеллект жүйелері жекелендірілген оқу жоспарларын ұсынуға және медицинаның белгілі бір салаларындағы мамандардың қажеттіліктерін болжауға көмектеседі.

Медицинадағы оқытудың болашағы медицина мамандарына үздіксіз білім алуға және олардың дағдыларын дамытуға мүмкіндік беретін үздіксіз даму мен инновацияны уәде етеді. Медициналық тәжірибенің алдыңғы қатарында болу және өз кәсібіңізді жаңа биіктерге жету үшін медицинадағы білім беру эволюциясының бір бөлігі болыңыз.

Медицинадағы соңғы трендтер мен оқыту әдістемелері туралы хабардар болу үшін біздің блогты қадағалаңыз. Біз бірге медициналық практикадағы білімге, сапаға және артықшылыққа негізделген болашақты құра аламыз!

Жаңа әдістерді қолдана отырып, медицина мамандары өз білімдерін кеңейте алады, дағдыларын жетілдіре алады және өз саласында көшбасшы бола алады. Осы трансформацияның бір бөлігі болу және қазіргі медициналық әлемде бәсекелестік артықшылыққа ие болу мүмкіндігін жіберіп алмаңыз!

Әдебиеттер тізімі:

1. Журбенко В. А., Саакян Э. С. Медициналық ЖОО-да оқытудың инновациялық әдістерін қолдану.

2. Халықаралық қолданбалы және іргелі зерттеулер журналы.

2016;(11— 1):164—164. 2. Щукин Ю. В., Мензул Е. В.,

ISBN 978-601-08-0758-7

Мякишева Ю. В. Медициналық ЖОО-да білім беру траекторияларын қалыптастырудың инновациялық тәсілдері.

3. Медициналық Білім және университет ғылымы. 2017;9(1):21—25. 3. Knebel E. The use and effect of distance education in health care: what do we know? Quality Assurance Project. 2001. URL: https:// pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnacn245.pdf (дата обращения: 25.06.2022 г.).

4. Samadbeik M. et al. Education and Training on Electronic Medical Records (EMRs) for health care professionals and students: A Scoping Review. International Journal of Medical Informatics. 2020;142:104238—10. 5.

5. Литвинова Т. М., Галузина И. И., Засова Л. В., Присяжная Н. В. Ресейдегі медициналық білім: пандемия жағдайында қайта жүктеу векторлары. Ұлттық денсаулық сақтау.

ISBN 978-601-08-0758-7

ОПЫТ ВВЕДЕНИЯ РАСШИРЕННОЙ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ В ПРОГРАММУ ОБУЧЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ВЫСШЕГО СЕСТРИНСКОГО КОЛЛЕДЖА

Зарина Владимировна Чаркова, Виталий Антонович Цой
преподаватели хирургических болезней с курсом реаниматологий, врачи первой категории
Карагандинский областной высший сестринский колледж

Аннотация: *Настоящая программа предназначена для учебного пособия для фельдшеров скорой помощи, для повышения квалификаций специалистов со средним медицинским образованием по специальностям анестезиология – реаниматология, сестринское дело, операционное дело. Освоение данного учебного пособия предполагает не только обновление и дополнение теоретических знаний, но и практическую отработку навыков сердечно-лёгочной реанимаций в разных условиях, умение действовать в экстремальных ситуациях, работать в команде. Программа состоит из базовой и расширенной сердечно-легочной реанимаций, методах обеспечения проходимости дыхательных путей и проведение искусственной вентиляций легки. Обучаемыми осуществляется непосредственная отработка навыков сердечно- легочной реанимаций, распознавание шокового ритма, реализаций алгоритмов действий. Регулярное обновление знаний и отработка практических навыков в симулированных условиях позволяет увеличить скорость и качество оказываемой помощи в экстренной ситуаций.*

Знания и практическое владение навыками оказания базовой неотложной помощи (BLS) и расширенной реанимационной помощи (ACLS) является обязательным для каждого фельдшера. Данные требования определены приказами министра здравоохранения Республики Казахстан от 26 апреля 2023 года №78 «Об утверждении стандарта организации анестезиологической и реаниматологической помощи в Республике Казахстан», от 25 января 2024 года №46 «Об утверждении профессиональных стандартов в области здравоохранения», Клиническим протоколом Республики Казахстан диагностики и лечения «Внезапная смерть» от 19 июня 2024 года и др.

В соответствии с миссией Карагандинского областного высшего сестринского колледжа, в целях совершенствования учебного процесса, выполнения требований заинтересованных сторон, нами проводилось обучение фельдшеров расширенной СЛР по стандартам ACLS (Advanced Cardiac Life Support.) от 2020г.

Дисциплина «Скорая неотложная помощь в хирургии», 6 семестр. Тема: Сердечно-легочная реанимация. Теоретических занятий – 4 часа. Симуляционных занятий - 12 часов.

ISBN 978-601-08-0758-7

Сложность освоения данной темы заключается в следующем. Большинство практических манипуляций, процедур фельдшер может выполнить самостоятельно, без дополнительной помощи. Например: наложение кровоостанавливающего жгута Эсмарха, транспортной иммобилизации шинами Крамера, парентеральное введение лекарственного препарата и т.д.

Напротив, качественное выполнение расширенной СЛР одним специалистом - невозможно! Требуется проведение нескольких важных манипуляций, действий, как можно в кратчайшие сроки! Немедленно. Часть из которых необходимо делать практически одновременно! Это требует хороших теоретических знаний, практических навыков и главное – слаженности действий в составе медицинской бригады!

На занятиях использовалось оборудование: манекен торс взрослого человека для СЛР, воздуховоды, мешок Амбу, дефибрилятор АНД учебно-тренировочный, шприц, жгут для в/в инъекций, пульсоксиметр.

На первом симуляционном занятии, 15 - 30 минут проводилось выполнение мероприятий базовой СЛР (станция, изучена на 4 семестре по предмету «Общая хирургия, анестезиология и реанимация»).

Хорошие знания и владение практическими навыками базовой СЛР являются обязательными для студентов всех специальностей медицинского колледжа, особенно для будущих фельдшеров. Качественное освоение практических мероприятий расширенной СЛР без базовой - крайне затруднительно или невозможно.

Особое внимание уделяли практическим навыкам проведения искусственной вентиляции легких с использованием мешка Амбу: расположение маски на лице, правильное положение пальцев студента, запрокидывание головы и т.д.

Далее проводилось освоение расширенной СЛР. Оценивание студентов проводилось на 2-ом занятии, после практического проведения расширенной СЛР в группах по 2 студента!

Для освоение практических мероприятий расширенной СЛР, на симуляционных занятиях, нами применялись методы обучения инструкторов специалистами медицинского центра Галилео, Израиль.

I этап. Практическое выполнение расширенной СЛР проводилось группами по 4 – 6 студентов (в зависимости от численности студентов в подгруппах). Каждому студенту закрепляется выполнение только одной задачи!

Например: 1-й студент выполняет определение признаков жизни и непрямой массаж сердца.

2-й студент – обеспечивает проходимость дыхательных путей (установка воздуховода, ларингеальной маски), проведение ИВЛ.

3-й студент – проводит оценку ритма сердца, проведение дефибриляции.

4-й студент – в/в доступ, введение лекарственных средств.

ISBN 978-601-08-0758-7

5-й студент – хронометраж действий всех участников (контролирует продолжительность временных интервалов, количество циклов СЛР, время введения лекарственных средств, и т.д.).

6-й студент – лидер и др.

Определение варианта остановки сердца определялось студентом установкой дефибрилятора АНД во время проведения 1-го цикла СЛР и при каждом СТОП-АНАЛИЗЕ и озвучивалось в слух (шоковый или нешоковый ритм остановки сердца определялся заранее).

Перед каждым началом СЛР – обязательное озвучивание вслух студентом безопасных условий места происшествия, работы!

Проводим нескольких периодов СЛР. При этом, сразу же в процессе разбираем «моменты» начала, продолжительность, очередность выполнения «своей» задачи каждого студента. Добиваемся «понимания» проведения «своих» мероприятий относительно действий других реаниматоров!

Очень важно четкое озвучивание вслух всеми участниками своих выполненных мероприятий (по направлению)! Это позволяло другим студентам приготовиться и проводить дальнейшие манипуляции в срок!

Разбор, анализ действий каждого студента группы. Закрепление алгоритма действий в зависимости от варианта ритма сердца.

II этап. Проведение этих же мероприятий со сменой участников местами, во время СТОП-АНАЛИЗА.

Это самый сложный этап практического обучения. После каждого периода СЛР – проводится обязательная замена студента, проводившего непрямой массаж сердца (профилактика утомления). При этом меняются местами все студенты группы. Студенты начинают выполнять «новые» для него задачи.

Главное внимание обращалось на уменьшение вынужденных перерывов в проведении компрессий грудной клетки (не более 10 секунд!).

При выполнении задания, нами проводилось фотографирование «типичных ошибок» студентов (неправильное точка компрессии, положение рук, расположение маски и т.д), встречающиеся как правило после каждой замены и началом выполнения «новых» задач. При этом не прерывая, не отвлекая студентов.

В процессе тренировок на этом этапе, сразу решаем задачи, вопросы оптимизации процесса, которые всегда предлагают сами студенты.

После выполнения задания, проводился разбор с демонстрацией фотографий «ухудшения качества СЛР». Важно проводить обсуждение мнений всех участников группы!

В связи с наличием практических навыков базовой СЛР у всех студентов, а также симуляцией проведения большинства действий (все кроме компрессий грудной клетки и искусственной вентиляции легких), материал закрепляется быстро.

III этап обучения. Уменьшаем количество студентов в группе до 2-х человек.

ISBN 978-601-08-0758-7

При наличии у части студентов хороших теоретических знаний, практических навыков базовой СЛР, относительно быстро добиваемся слаженности в действиях! Проводим оценивание каждого студента.

На этом этапе добиваемся целей качественного проведения расширенной СЛР:

1. Как можно быстрое начало проведения непрямого массажа сердца!
2. Минимальные перерывы при проведении непрямого массажа сердца! Не должны превышать 10 секунд.
3. Качественное выполнения СЛР (точка компрессий, глубина, частота и др.).
4. Как можно быстрое проведение дефибриляции или введения адреналина!

Важно всегда заканчивать каждый случай проведения СЛР оживлением пациента!

После восстановленнии кровообращения и самостоятельного дыхания, так же проводились мероприятия «по устранению обратимых причин» (в пределах догоспитального этапа!) - проговаривалось студентами вслух, УСТРАНЯЕМ:

1. Гипоксия. Проведение оксигенотерапии.
2. Гиповолемия. Инфузионная терапия. Физиологический раствор. В/в, капельно – струйно. До 2-х литров.
3. Гипотермия. Термо одеяло и др.

Выводы: 1. Считаем описанный метод обучения студентов практическим навыкам расширенной СЛР эффективным. Рекомендуем использовать преподавателями медицинских колледжей.

2. Для качественного проведения занятий необходимо:

А. владение практическими навыками базовой СЛР.

Б. оснащение соответствующим оборудованием кабинетов хирургических болезней, симуляционных центров.

Сокращения, используемые в докладе

СЛР – сердечно-легочная реанимация.

BLS – Basic Life Support.

ACLS – Advanced Cardiac Life Support.

ИВЛ – искусственная вентиляция легких.

АНД – автоматический наружний дефибрилятор.

КОВСК – Карагандинский областной высший сестринский колледж.

Список литературы.

1. Merchant RM, Topjian AA, Panchal AR, et al: Part 1: Executive Summary: 2020 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. *Circulation* 142 (16_suppl_2): S337-S357, 2020. doi:10.1161/CIR.0000000000000918

2. Soar J, Böttiger BW, Carli P, et al: European Resuscitation Council Guidelines 2021: Adult advanced life support [published correction appears in *Resuscitation* 2021 Oct;167:105-106]. *Resuscitation* 161:115-151, 2021. doi:10.1016/j. resuscitation. 2021.02.010

ISBN 978-601-08-0758-7

ОРГАНИЗАЦИЯСОВМЕСТНОЙНАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ПРЕПДАВАТЕЛЕЙ АКТЮБИНСКОГО ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГОСОЮЗА МАНШУК МАМЕТОВОЙ

Шамсутдинова Э.М., преподаватель специальных дисциплин
ГКП «Актюбинский высший медицинский колледжимени героя СоветскогоСоюза Маншук Маметовой» на ПХВ

Аннотация *Научно исследовательская работа, связанас разнообразными формами деятельности, способствующими получению навыков творческого труда, поскольку предполагает, в том числе: участие в олимпиадах, конкурсах, выставках, студенческих семинарах и научных конференциях, научно-образовательных форумах; организацию научно-исследовательской практики; выполнение выпускной квалификационной работы исследовательского плана; подготовку научных публикаций; участие в выполнении научно-исследовательских проектов; проведение исследовательской и проектной работы в рамках учебно-научных и учебно-производственных центров[1,с.48].*

Когда начинаешь заниматься научной работой состудентами у студентов и преподавателейвозникает ряд вопросов. У преподавателей главный вопрос как мотивировать студентов на занятие научной работой, а у студентов главный вопрос зачем мне это надо и как мне это пригодится. Занятие состудентами — это дело для преподавателейответственное, занимающее много личного времени и как правило, малооцениваемое руководством колледжа. Но тем не менееэтоочень интересная работа, которая позволяет преподавателю самореализоваться, само развиватьсяи получать удовлетворение от своей работы.Позвольте поделиться с Вами нашим опытом.

Вот основные вопросы, которые чаще всеговозникают, когда начинаешь заниматься НИРС.

Чем полезна исследовательская работа, зачем она нужна студенту медицинского колледжа?

Что является целью НИРС

Как строится научная деятельность, в которой могут принимать участие студенты?

Откуда брать темы для НИРС

Как заинтересовать студента

Что является результатом НИРС

Ответы на эти вопросы мы получили современем, методом проб и ошибок.

Позвольте поделиться с Вами нашим опытом.

ISBN 978-601-08-0758-7

Чем полезна исследовательская работа, зачем она нужна студенту медицинского колледжа?

Исследовательская работа дает возможность студенту получить более глубокие знания, которые ему пригодятся в своей профессиональной деятельности. Наличие грамот, дипломов, сертификатов, публикаций у студента, делает его более интересным для работодателя, а значит и более конкурентноспособным.При приеме на работу и изучении анкеты многие работодатели обращают внимание на количество публикаций, самообразование выпускника и его активность в общественной жизни во время учебы. Занятие научной работы помогает студенту развивать свою логику и мышление, учиться детально анализировать проблему и изыскивать пути ее разрешения. Научная деятельность позволяет каждый день узнавать что-тоновое [2, с.49].

Что является задачейисследовательской работы

Задача научно-исследовательской работы - привитие студентам умений самостоятельной работы, включая исследовательские навыки, ознакомление с методикой работы, с приёмами выполнения коллективных исследовательских проектов. В процессе выполнения исследований будущие выпускники должны освоить навыки работы с научной и справочной литературой, с приборами и оборудованием, самостоятельно планировать и проводить экспериментальную работу, обрабатывать её результаты, делать выводы, оформлять полученные результаты, выступать перед коллективом лаборатории, на конференциях [3, с.75].

Как строится научная деятельность, в которой могут принимать участие студенты?

Для начала стоит сказать, что в научной деятельности приветствуют даже первокурсников. Студенты, которые хотят заниматься наукой, могут подойти к своему куратору и спросить, к кому можнообратиться по поводу научных исследований, также следует обратиться к понравившемуся преподавателю, чей предмет и лекции интересныстудентам. Приходить в научную деятельность можно как сосвоей идеей, так и без нее. Преподаватели колледжа всегда готов помочь в выборе темы, а также поддержать и развить тему, которую ссобой принесли студенты, а так же предложить для исследования темы. Сперва студентам дают несложные задания, например, проводить простые измерения,тестирование пациентов, а когда человек попробовал себя в исследовательской работе и его это заинтересовало, он начинает работать в конкретном направлении.

Откуда брать темы для исследовательской работы

Темы они повсюду их можно взять из заинтересовавшегостудента вопроса, из интересной темы лекции, из вопросов, которые задают Вам студенты.

Например,на лекции возник вопрос зачем нужны клинические сестринские руководства и как их можно применять в деятельности медицинской сестры?

ISBN 978-601-08-0758-7

Что бы ответить на этот вопросстудентам было предложено изучить сестринское руководство и применить его на практике по уходу за больными ХСН. Работа получила высокую оценку на конференциях, получила рецензиюжурнала медицинского университета имени М. Оспанова былаопубликована в научном журнале. Еще пример: предмет Укрепление здоровья–при изучении профилактики заболеваний студенты подготовили план работы школ здоровья, буклеты, сценарии бесед с пациентами и их родственниками. Из этого проекта были написаны студентами несколькоисследовательских работ: о пользе здоровогообраза жизни, о профилактике заболеваний, изучен вопросо школах здоровья. Эти работы мы отправили на конкурс волонтерских идей в Российскую Федерацию, где работы получили дипломы 1,2 и 3 степени. На основании этих работ мы разработаливолонтерский проект,с которым участвовали в Республиканском конкурсе на грантот SAYLYQbergemiz, CISC, QazaqstanMedicinaJastary и выиграли 2 гранта.

Исследовательская работа на тему «Реабилитация пациентов,перенесших острый инфаркт миокарда методом скандинавской ходьбы».Мы начали писать после того как в городе массовостали появляться люди с палками для скандинавской ходьбы, возник вопрос для чегоони ходят и какая от этого польза. Исследование на тему «Значимость участия медицинской сестры в улучшении качества жизни детей ссиндромом Дауна» нами было начатопосле проявления интереса к тому можно ли улучшить качество жизни этих детей. Эта работа переросла в волонтерский проект по работе с детьми ссиндромом Дауна, в тему дипломной работы ибудущее место работы ношей студентки. То есть темы для научно-исследовательских работ студентов они вокруг нас, можно взять любой интересный для студентов вопрос и развить его в тему для исследования. Исследовательская работа студентов колледжа «Участие медицинской сестры в обучении родственников пациентов, перенесших инсульт», так же проводилось в рамках республиканского волонтерского проекта. Результатом этой работы явилась «Школа ухода»которая работает на постоянной основе и где родственники пациентов могут обучаться основам уходовых мероприятий, получать консультации от медицинских сестер, социальных работников, психологов, врачей реабилитологов. Исследовательская работа «Особенности общения медицинской сестры с пациентами пожилого и старческого возраста» проводилась на базе Дома престарелых города Актобе, рекомендации, которые разработали студенты для улучшения навыков общения медицинских сестер с пациентами и их родственниками, взяли за основу курсов повышения квалификации медицинских сестер по коммуникативным навыкам. То есть резюмируя все выше сказанное исследовательская работа студентов колледжа применима в сестринской практике и имеет тесную связь с непосредственной работой медицинской сестры.

Как заинтересовать студента

ISBN 978-601-08-0758-7

Этот вопроссамый острый для преподавателя. Что мы можем предложить нашим студентам? Как их мотивировать на занятие научной работой?Когда начинаешь заниматься со студентами научно-исследовательской работой, по собственному опыту могу сказать, что для них на первом месте стоит вопрос зачем мне это надо и что я за это получу.

Вы научитесь грамотно излагать свои мысли на бумаге, так как современный специалист должен уметь хорошо это делать.

Наличие научных публикаций поможет при написании курсовых, а главное — дипломной работы. Возможность получения повышенных стипендий, грантов, материальных выгод, ценных призов.Желающие учиться в магистратуре должны начинать заниматься научной работой именно в студенческие годы, так как для поступления в магистратуру нужно иметь не менее 2-х публикаций. При представлении научной работы на конференции будут развиваться способности работать с аудиторией, навыки публичных выступлений, чтов нынешних условиях крайне важно.

Научная деятельность помогает студентам в разработке дипломных и курсовых работ и проектов, которые могут реализоваться в колледже или на рабочем месте. Это значит, что наука и образование дополняют друг друга и у обучающихся есть возможность делать дипломные и курсовые работы не в стол, а применять их в жизни [2, с.77].

Что является результатом исследовательской работы

Основными формами исследовательской работы студентов в колледже являются:

- подготовка рефератов, докладов;

- участие студентов в исследовательской и проектной деятельности;

- участие в семинарах, конкурсах исследовательских работ, олимпиадах поспециальным дисциплинам;

- участие в научно-практических и научно-исследовательских конференциях городского, регионального, республиканского и международногоуровня [3, с.155].

Наши студенты,используя свои научно-исследовательские работы участвовали во многих международных, республиканских, областных конференциях, олимпиадах, семинарах, где получали дипломы и грамоты 1,2 и 3 степени. Являются победителями таких конкурсов как ТОП -100 лучших студентов Казахстана республиканского и областного уровня. Получили республиканские гранты на занятия волонтерской деятельностью. Являются победителями (2 место) Республиканского чемпионата WorldSkillsKazakhstan. А такжеполучают дополнительные стипендии и гранты.

Резюмируя все выше сказанное хочу сказать: занятие научной работой в наши дни — этоочень актуально, престижно и полезно!!!

ISBN 978-601-08-0758-7

Список литературы:

1.Сихимбаев, С.Р. Проблемные группы как эффективная формаорганизациинаучно-исследовательской работы студентов [Текст] / С.Р. Сихимбаев и др. // Высшее образованиесегодня, 2011. – № 2. – С.75-77.

2. Демченко, З.А. Научно-исследовательская школа студента исследователя [Текст] / З.А. Демченко // Высшее образование в России, 2010. – № 12. – С. 155.

3.Демченко, З.А. Научно-исследовательская школа студента исследователя [Текст] / З.А. Демченко // Высшее образование в России, 2010. – № 12. – С. 155–158.

ISBN 978-601-08-0758-7

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ СЕСТРИНСКОМУ УХОДУ В ГЕРИАТРИИ В ОМК

Кутлиева Т.Т., Шеметова О.В.
Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение Оренбургского института путей сообщения – филиала ФГБОУ ВО «Приволжский государственный университет путей сообщения»
Оренбург, Россия

Аннотация: *в статье представлены основные направления преподавания предмета «Сестринский уход в гериатрии» в Оренбургском медицинском колледже».*

«Гериатрия – это царство
медицинских сестер»
Л.Б. Лазебник

За последние годы в связи с реформами в отечественном здравоохранении роль медицинских работников среднего звена резко возросла. В декабре 2005 года правительством Российской Федерации принят национальный проект «Здоровье», где особое внимание отводится роли среднего медицинского персонала в оказании качественной медицинской помощи населению. Данные изменения предъявляют к среднему медицинскому персоналу новые требования, повысился спрос на квалифицированную, творческую, конкурентоспособную личность.

Забота и уважение к пожилым людям проходят «красной нитью» в преподавании дисциплины «Сестринский уход в гериатрии» в Оренбургском медицинском колледже Оренбургского института путей сообщения – филиала ФГБОУ ВО «Приволжский государственный университет путей сообщения». Престарелые люди находятся в зоне повышенного риска и нуждаются в постоянном наблюдении и помощи.

Для правильной организации и осуществления геронтологического ухода, в первую очередь, необходимы квалифицированные кадры, к подготовке которых педагогический коллектив колледжа прикладывает все свои таланты, знания, опыт. Наши студенты получают знания в лечебно-диагностической, реабилитационной и профилактической области как в условиях стационара и поликлиники, так и на дому у пациентов, что позволяет обеспечить большую доступность изучения медико-социальной помощи [1, с.67].

С профессионализмом, мы прививаем обучающимся такие понятия, как милосердие и сострадание, которые являются основой искусства врачевания. Так же приоритетным направлением остается обучение искусству общения с пожилым пациентом, его родственниками. Ведь медицинская сестра должна уметь организовать не только медицинскую и социальную помощь для своих пациентов, используя для этого все имеющиеся в ее распоряжении ресурсы, но создать уютную психологическую атмосферу, не нарушая внутренний покой и гармонию [3, с.97].

ISBN 978-601-08-0758-7

Изучив предмет «Сестринский уход в гериатрии», обучающиеся знают анатомо-физиологические особенности строения пожилого организма, виды и процессы старения, факторы риска развития преждевременного старения и возникновения болезней, особенности этиологии, клиники, патогенеза, диагностики, лечения, осложнений и профилактики повреждений и заболеваний в пожилом и старческом возрасте, особенности геродиетики и фармакотерапии, основы психического старения человеческого организма, как нормального, так и патологического, [5, с.25].

Основные профессиональные навыки студенты осваивают на практических занятиях, которые проходят в учебных мастерских на базе нашего колледжа, оснащенных оборудованием, повторяющим условия стационара, паллиативного отделения, домашнего ухода. Занятия по темам предмета включают все этапы сестринского ухода. Особое внимание уделяется сестринским вмешательствам, направленным на улучшение качества жизни людей пожилого и старческого возраста. На этом этапе обучения обучающиеся овладевают достаточным объемом профессиональных умений (рис.1) [4, с.130].



Рисунок 1. Обучение пациента навыкам самообслуживания в учебных мастерских

Дальнейшее мастерство и навыки ухода за пожилыми пациентами студенты нашего колледжа повышают на производственной практике, которая проходит на базе ГБУСО «Геронтологический центр «Долголетие» (рис.2). Это пример интеграции будущего работодателя с колледжем. Практика направлена как на формирование общих и профессиональных компетенций, так и на приобретение практического опыта в сфере работы с лицами пожилого и старческого возраста.

Студенты измеряют давление и пульс, осуществляют кормление, делают внутривенные и внутримышечные инъекции, подготавливают и проводят физиотерапевтические процедуры (ингаляции, массаж), осуществляют уход за немобильными больными (профилактика пролежней, личная гигиена, умывание и купание, смена подгузников и белья, маникюр и педикюр, кормление), а также осуществляют санитарные и дезинфекционные манипуляции. Молодые

ISBN 978-601-08-0758-7

специалисты беседуют с проживающими в стационаре, когда ухаживают за ними и гуляют на свежем воздухе.

Только в реальных условиях стационара у обучающихся происходит осознание всей ответственности выбранной профессии: за жизнь человека, за благоприятные условия ухода и лечения, за моральное состояние пациента и исход заболевания. Милосердие становится фундаментом становления студента как профессионала, способного чувствовать чужую боль и сопереживать.



Рисунок 2. Работа в реальных условиях -

ГБУСО «Геронтологический центр «Долголетие»

С центром «Долголетие» наш колледж связывает давняя и добрая дружба. Одним из направлений так же является и волонтерское движение нашего колледжа «Дорогою добра». На протяжении 18 лет секция «С любовью и заботой о старшем поколении», опекает наших бабушек и дедушек, проживающих в центре.

Студенты ОМК организуют масштабные праздничные мероприятия в центре, приезжают с зажигательной концертной программой, полезными сладкими подарками и поздравительными открытками для каждого проживающего. Доброй традицией стало и проведение сезонных уборок территории центра (рис.3).



Рисунок 3. «С любовью и заботой о старшем поколении»

ISBN 978-601-08-0758-7

Обучение и воспитание специалиста – профессионала в современном обществе складывается из составляющих элементов образования, которые только в совокупности приводят к результату.

Педагогический коллектив Оренбургского медицинского колледжа всегда будет вкладывать много сил и стараний для того, чтобы выпускники стали достойными людьми нашей страны!

Список литературы:

1. Дранго М.Г., М.А. Краснова, А.К. Мышкина, А.Ю. Полянина, Т.Д. Селезнева, К.В. Ткаченко, С.С. Фирсова, Л.В. Шильников; под ред. Ю.Ю. Елисеевой. - М.: Эксмо, 2007. - 736с.

2. Перфильева Г.М., Организация и проведение исследований в области сестринского дела./Коллектив авторов: Г.М. Перфильева, Н.Н. Камыкина, Н.В. Туркина, Ю.Н. Маркова. П.Е. Зайцев. - Москва: Т-во научных изданий КМК, 2006. - 163с.

3. Ковтун Е.И., Сестринское дело в гериатрии. Учебное пособие для студентов медицинских училищ и колледжей \ Е.И. Ковтун, А.А. Шепелева. - Ростов н\Д: Феникс, 2007. - 288с.

4. Турчина Ж.Е., Сестринское дело в гериатрии. Учебное пособие \ Ж.Е. Турчина, Е.Г. Мягкова. - Ростов н\Д.: Феникс; Красноярск: Издательские проекты, 2006. - 192с.

5. Альперович В.А., Социальная геронтология. Серия «Учебники и учебные пособия» \ В.А. Альперович. - Ростов н\Д.: Феникс, 1997. - 576с.

ISBN 978-601-08-0758-7

ЖЕДЕЛ МЕДИЦИНАЛЫҚ ЖӘРДЕМ ОРТАЛЫҒЫНДАҒЫ ОРТА МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ ҚЫЗМЕТІНЕ НАУҚАСТАРДЫҢ ҚАНАҒАТТАНАРЛЫҒЫН БАҒАЛАУ

Садыгулов Е.Д., арнайы пәндер оқытушысы
Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасы жанындағы
«Көкшетау жоғары медициналық колледжі» МКҚК

Аннотация: *Қазіргі таңдағы жедел жәрдем саласындағы актуальды проблема ретінде кадрлардың жетіспеушілігі, жедел медициналық көмек көрсету кезіндегі тәжірибенің аздығы мен білімнің таяздығы, сонымен қатар жалақының жүктелетін жұмыс салмағына байланысты сай келмеуі бірқатар проблемаларды тудырады және қызмет сапасын төмендетеді. Осыған сәйкес бұл мәселенің өзекті жағы орта медициналық қызметкердің міндетін атқару кезіндегі пациенттің қанағаттанарлығы мен қызмет сапасына баға беру негізгі мәселелердің бірі боп табылады.*

Денсаулық сақтау жүйесіндегі басым бағыт жедел медициналық көмек болып табылады. Әсіресе осы аталған жедел медициналық көмек қызметіне адам өлімі мен мүгедектілік деңгейін сипаттайтын көптеген аурулар кездесетін денсаулық сақтау жүйесінің негізгі қысымы түсетін қызмет болып саналады.

Жедел жәрдемнің уақытылы келмеуі немесе кез келген шақыртуларды қабылдай бермейтіндігі жайында жергілікті әкімдікке немесе Денсаулық сақтау басқармасына арыз-шағым жиі түсетіні жасырын емес. Шын мәнінде, жедел жәрдем науқастарға шын жанашырлықпен қарайды, алайда, өздерінің қызмет бабындағы шектеулі ережелерін сақтауға тырысады.

Қазіргі таңдағы жедел жәрдем саласындағы актуальды проблема ретінде кадрлардың жетіспеушілігі, жедел медициналық көмек көрсету кезіндегі тәжірибенің аздығы мен білімнің таяздығы, сонымен қатар жалақының жүктелетін жұмыс салмағына байланысты сай келмеуі бірқатар проблемаларды тудырады және қызмет сапасын төмендетеді. Осыған сәйкес бұл мәселенің өзекті жағы орта медициналық қызметкердің міндетін атқару кезіндегі пациенттің қанағаттанарлығы мен қызмет сапасына баға беру негізгі мәселелердің бірі боп табылады.

Жалпы, орта медициналық қызметкерлердің көрсету сапасын бағалауда келесі көрсеткіштерге назар аударылады: оның медициналық тиімділігі, медициналық нәтижелілігі, тұтынушының қанағаттануы, сонымен қатар ресурстарды бағалауды қоса есептегендегі өндірістік шығындар, яғни медициналық жабдықтар, техникалар, науқастарды тасымалдаудың материалды-техникалық жағдайы және қызметкерлердің жұмысы. Ішкі тұтынушылар, яғни науқастардың сұраныстарын есепке алу мен оларды қанағаттандыру процесін жүргізбей, емдік-диагностикалық процестің сапасы төмендейді, сәйкесінше тұтынушылардың сұраныстары қанағаттандырылмаса, денсаулық сақтау

ISBN 978-601-08-0758-7

жүйесінің және оның жекелей нысандары мен құрылымдарының қызмет атқаруының мәні жойылады.

Бүгінгі таңда науқастардың сұраныстарын қанағаттандыру мәселелері күн сайын дәрігерлерге жаңадан серпін беруде. Сонымен қатар тұрақты тұрде талқыға салынатын мәселелердің біріне айналды. Осыған орай жедел жәрдем фельдшерлерінің де қызметтік іс-әрекеттері басқа бағыт алып, айтарлықтай нәтижелер беруде. Осы орайда науқастар өздерінің керектігін сезініп, емдік процестерге белсене араласып келеді және медициналық қызметкерлер де науқастар үшін ерекше жауапкершілікке ие болып, қызмет сапасын жақсартуға ұмтылыс байқалады [28].

Жедел медициналық жәрдем орталығындағы орта медициналық қызметкерлердің қызметіне науқастардың қанағаттанарлығын бағалау бойынша зерттеу жұмысы жоғары деңгейде өтті.

Біз фельдшерлер науқастармен қарым-қатынас жасау этикасын бағалау бойынша зерттеу жұмысында жүргізілген сауалнамалар жоғарыда айтылғандай екі бағытта жүзеге асырылды:

1) Жедел жәрдем орталығындағы орта медициналық қызметкерлерге арналған (15 сұрақтан құралған). Аталмыш сауалнама этика және деонтология саласындағы сауаттылық деңгейін анықтауға және қағидаларды тәжірибеде қолдануға мүмкіндік береді. Бұл сауалнамаға 50 орта медициналық қызметкерлер қатысты.

2) Науқастарға арналған (15 сұрақтан құралған). Сауалнама науқастар жағынан этика және деонтология саласындағы дәрігерлердің қызмет көрсету деңгейін бағалауға мүмкіндік береді. Бұл сауалнамаға 65 науқас қатысты.

Аталмыш зерттеу жұмысы Көкшетау қаласының жедел жәрдем станциясында жүргізілді.

Зерттеу жұмысына 100% фельдшерлер қатысты. Барлық респонденттер әртүрлі мамандықтар бойынша жұмыс істейді, сонымен қатар фельдшерлердің деонтологиялық білім беру деңгейін объективті бағалауға көмектеседі. 60 респонденттің 33% 10 жылдан астам жұмыс тәжірибесі бар, 41% -ы 5 жылдан 10 жылға дейінгі жұмыс тәжірибесі бар, 26% -ы 5 жылдан кем жұмыс істейді.

Жүргізілген сауалнамалардың нәтижелері бойынша келесідей Ұсыныстар білдіруді жөн көрдік:

1) Жедел жәрдем фельдшерлерге қосымша сабақтар мен семинарлар өткізілуі қажет;

2) Жедел жәрдем дәрігерлері мен орта медициналық қызметкерлердің бастапқы штатын реттеу, ол үшін мақсатты бағытталған білім бағдарламаларын жетілдіру;

3) Сонымен қатар фельдшерлерге арналған түрлі семинарлар мен тренингтер, конференцияларға қатысу құқығын қолжетімді ету;

4) Бірыңғай медициналық ақпараттық-аналитикалық жүйе енгізу қажет, жедел жәрдем шақырту барысында электронды жазбалар қызметтерін кеңейтіп,

ISBN 978-601-08-0758-7

науқастарға қолжетімді болуы қажет, ол үшін түрлі мобильді қосымшалар мен онлайн-хабарламалар тегін көбейту қажет;

5) Жедел жәрдем фельдшерлері мен науқастар арасындағы қарым-қатынасты нығайту мақсатында түрлі қызықты тренингтер мен клубтар ұйымдастыру;

6) Жедел жәрдем фельдшерлерінің аса ауыр науқастармен жұмыс істеуде психологтың көмегімен қамтамасыз ету шараларын ұйымдастыру.

Қорытынды

1. Медициналық қызметкерлердің кәсіби мамандығына қанағаттанарлығын бағалау кезінде «Өз жұмысыма көніліңіз толады ма» дегенге - 83% толады, 13% жауап беруге қиналамын, ал қағаз жұмыстарын алып тастау қарастырылса 47% кәсіби тиімділігі жоғарлайды деп, жауап берді. Осылайша медицина қызметкерлері өз кәсіби мамандығына деген көз қарастарын білдірді.

2. Зерттеу жұмысы нәтижесінде респонденттердің 60% жергілікті жердегі медициналық жәрдемнің ұйымдастыру процессін өте тамаша деп бағаласа, респонденттердің 70% жедел жәрдем бригадасын 10-15 минут аралығында күтеміз деп жауап қайтарды, ал 40% фельдшерлердің кәсіби деңгейлерін манипуляция әдістерімен бағалады. Осы зерттеулерге қарағанда науқастардың медициналық қызметкерлердің міндетіне көңілдері толатыны бақылауға болады.

3. Жедел жәрдем орталығында шұғыл медициналық көмектің сапасын көтерілуінің алдын ала шараларын ұсыну дәрігерлер мен орта медициналық қызметкерлеріне арналған түрлі семинарлар мен тренигтер, мастер-класстар өткізу, тәжірибелік біліктіліктерін арттыруды, конференциялар мен сайыстарға және т.б. қатысу мүмкіндіктерін кеңейту. Орта буында медициналық қызметкерлердің кәсіби біліктілігі медициналық қызметтің сапасына ғана емес, оған қоса науқас тағдырына тікелей әсер ететіні хақ

Әдебиеттер тізімі

1. Шерова З. Н., Маматова Д. М., Каттабеков А. С., Ахатова Г. Х. Развитие этики и деонтологии // Молодой ученый. — 2015. — №22.

2. Ю.Борисов А.И., Борисова А. А. О контроле качества медицинской помощи. 2001. - №3. - С. 34-37.

3. Вестник РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН.

4. Гаджиев Р.С., Назаралиева З.К. Качество медицинской помощи городскому населению // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2002. - №4. - С. 32-35.

5. Галанова Г.И. Методологические основы системы обеспечения качества медицинской помощи населению. Дис. . д-ра мед. наук. М., 2000. -268 с.

6. 2003-2007 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының денсаулық сақтауды дамыту тұжырымдамасы.

ISBN 978-601-08-0758-7

РОЛЬ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР В СОВРЕМЕННОЙ РЕАБИЛИТОЛОГИИ

Конирова Салима Калабаевна, Өтесін Махмутсұлтанғали Асқарұлы, преподаватели специальных дисциплин
Бопай ханым высший медицинский колледж

Аннотация. Реабилитология — это важная область медицины, которая занимается восстановлением здоровья пациентов после травм, операций или заболеваний. В этой сфере ключевую роль играют медицинские сестры, которые обеспечивают поддержку и уход за пациентами, а также участвуют в комплексном процессе реабилитации. Их работа становится особенно актуальной в условиях современного здравоохранения, где внимание к качеству жизни пациентов приобретает все большее значение.

Введение. Комплексный подход к реабилитации7 Медицинские сестры выступают связующим звеном между врачами, пациентами и их семьями. Они не только выполняют медицинские назначения, но и помогают пациентам адаптироваться к изменениям в их состоянии. Важно, чтобы медсестры обладали навыками общения и могли эффективно взаимодействовать с разными участниками процесса.

Оценка состояния пациента

Одной из главных задач медицинских сестер в реабилитологии является оценка состояния пациента. Они проводят первичное обследование, собирают анамнез и выявляют индивидуальные потребности. Это позволяет сформировать персонализированный план реабилитации, который будет максимально эффективен.

Участие в реабилитационных процедурах

Медицинские сестры активно участвуют в проведении различных реабилитационных процедур. Это может включать:

Физическую терапию: помощь в выполнении упражнений, обучение правильным движениям и техникам.

Психологическую поддержку: работа с пациентами над восстановлением уверенности и мотивации.

Образовательную деятельность: информирование пациентов и их семей о процессе реабилитации и необходимых изменениях в образе жизни.

Мониторинг и оценка прогресса

Медицинские сестры ведут наблюдение за состоянием пациентов в процессе реабилитации. Они фиксируют изменения, оценка которых помогает корректировать терапевтические мероприятия. Регулярный мониторинг состояния позволяет своевременно реагировать на любые осложнения и адаптировать программу реабилитации к текущим потребностям пациента.

Поддержка и мотивация

Не менее важной задачей медицинских сестер является поддержка пациентов в их стремлении к выздоровлению. Психологическая помощь, мотивация к выполнению реабилитационных мероприятий и создание

ISBN 978-601-08-0758-7

доверительной атмосферы значительно влияют на эффективность процесса восстановления.

Основные функции медицинских сестер в реабилитологии

1. Оценка состояния пациента

Одной из первоочередных задач медицинских сестер является комплексная оценка состояния пациента. Они проводят начальное обследование, собирают информацию о заболеваниях и травмах, а также фиксируют физические и психологические особенности. Эта информация помогает создать индивидуальный план реабилитации, учитывающий потребности и цели пациента.

2. Проведение реабилитационных мероприятий

Медицинские сестры активно участвуют в проведении реабилитационных процедур, таких как:

Физическая терапия: помощь в выполнении упражнений, обучение правильной технике движений, а также контроль за прогрессом.

Окупационная терапия: поддержка пациентов в освоении бытовых навыков и восстановлении самостоятельности.

Психосоциальная поддержка: работа с эмоциональными аспектами реабилитации, создание поддерживающей атмосферы.

3. Образовательная функция

Образование пациентов и их семей — еще одна важная задача медицинских сестер. Они информируют о процессе реабилитации, обучают методам самопомощи, а также объясняют важность выполнения рекомендаций врачей. Эта информация способствует повышению вовлеченности пациентов в процесс восстановления и улучшению их психоэмоционального состояния.

4. Мониторинг и документирование

Медицинские сестры осуществляют регулярный мониторинг состояния пациентов, фиксируя изменения и прогресс. Они ведут документацию, которая необходима для анализа эффективности реабилитационных мероприятий и позволяет вовремя корректировать терапию при необходимости.

5. Командная работа

Реабилитация — это командный процесс, и медицинские сестры играют ключевую роль в коммуникации между различными специалистами: врачами, физиотерапевтами, психологами и другими. Их знания и опыт позволяют обеспечить комплексный подход к лечению, что является основой успешной реабилитации.

Влияние на качество жизни пациентов

Работа медицинских сестер непосредственно влияет на качество жизни пациентов. Они помогают преодолеть физические и психологические барьеры, восстанавливают уверенность в себе и способность к самостоятельной жизни. Поддержка и внимание со стороны медсестер создают атмосферу доверия, что является важным аспектом успешного лечения.

ISBN 978-601-08-0758-7

Заключение. Роль медицинских сестер в реабилитологии невозможно переоценить. Их работа — это не просто выполнение медицинских назначений, но и комплексная поддержка пациентов на пути к восстановлению. В условиях быстро меняющегося мира здравоохранения медицинские сестры становятся ключевыми фигурами, обеспечивающими качественную реабилитацию и улучшение качества жизни пациентов. Обучение и повышение квалификации медсестер в этой области играют важную роль в развитии современной реабилитологии и достижении оптимальных результатов для пациентов.

Список литературы:

1. Александров П.А., Иванов И.В. Роль медицинских сестер в реабилитации пациентов с хроническими заболеваниями. Журнал медицинской реабилитации. 2020; 9(2): 45-50.
2. Сидорова О.В. Современные подходы к реабилитации: роль сестринского персонала. Российский журнал сестринского дела. 2018; 7(3): 60-65.
3. Петрова Н.В. Значение сестринского ухода в процессе реабилитации пожилых пациентов. Медицинская практика. 2019; 5(1): 25-29.
4. Brown T, Smith R. Nursing role in the rehabilitation process: a systematic review. Journal of Rehabilitation Medicine. 2017; 49(8): 620-627.
5. Johnson J, Lee A. The evolving role of nurses in rehabilitation: challenges and opportunities. Rehabilitation Nursing Journal. 2019; 44(4): 213-219.
6. Макарова Е.И., Кузнецов Д.А. Роль медицинских сестер в организации реабилитационного процесса. Вестник медицинской сестринской практики. 2021; 6(2): 30-34.

ISBN 978-601-08-0758-7

БОЛАШАҚ МЕДИЦИНА МАМАНДАРЫН ОҚЫТУДАҒЫ ЖАҢА ТӘСІЛДЕР МЕН ИННОВАЦИЯЛАР

Майжанова Галия Токтаровна, арнайы пәндер оқытушысы
Астана қаласы әкімдігінің «Жоғары медициналық колледж» ШЖҚ МКК

Аннотация: *Қазақстан Республикасындағы техникалық және кәсіптік білім беру жүйесі қазіргі қоғам мен ғылымның даму талаптарына сай мазмұнды жаңарту және әлемдік білім беру кеңістігіне интеграциялануымен дамып келеді. Денсаулық сақтау саласын жаңғырту медициналық көмектің сапасы мен қолжетімділігін арттыруды, мейіргерлік қызметкерлердің іс-әрекетінде инновациялық технологиялар мен ақпаратпен жұмыс істеу қабілетін енгізуді талап етеді. Медициналық білім беру саласында тұлғаға бағытталған оқыту мен тәрбиелеу концепциясы қолданылады, ал білім беру инновациялары мен заманауи оқыту әдістері үнемі жетілдіріліп, практикалық қолдануға бейімделеді. Қашықтықтан оқыту және виртуалды білім беру платформалары әртүрлі пәндер мен жағдайларды зерттеуді тиімді түрде ұйымдастырады, әсіресе симуляциялық технологиялар арқылы клиникалық жағдайларды оқып-үйрену мүмкіндігін арттырады. Телемедицина мен кейс әдістері студенттердің нақты медициналық жағдайларды түсінуін жақсартады. Инновациялық технологияларды енгізу арқылы медициналық білім беру сапасы жоғарылап, денсаулық сақтау саласы мен оқыту үдерісі біртұтас дамиды.*

Қазақстан Республикасында техникалық және кәсіптік білім беру жүйесін дамытудың қазіргі заманғы үрдістері қоғамның және ғылымды дамытудың талаптарына сәйкес оның мазмұнын жаңартумен, сондай-ақ оны әлемдік білім беру кеңістігіне интеграциялаумен байланысты. Қазақстанның денсаулық сақтау саласын жаңғыртудың негізгі міндеттері медициналық көмектің сапасы мен қолжетімділігін арттыру. Мейіргер қызметкерлерінің практикалық іс-әрекетінің стандарттары мен технология-ларын, заманауи инновациялық технологияларды пайдалана отырып, кәсіби ақпаратпен жұмыс істеу қабілетін енгізумен қатар мейіргерлік көмектің сапасы артып келеді.

«Колледжде тұлғаға бағытталған оқыту мен тәрбиелеу тұжырымдамасына» сәйкес студенттерге тұлғаға бағытталған көзқарас жүзеге асырылуда. Заманауи медициналық білім: ең алдымен алған білімін практикалық қолдануға бағытталған, үнемі жаңа инновациялық технологияларды пайдалана отырып білім алуы. Бұл практикалық кезеңде өз жұмысына тезірек бейімделуге және күрделі медициналық мәселелерді тез және сенімді шешуге мүмкіндік береді [12, б. 782]. Қазіргі заманғы оқыту әдістері үнемі жетілдірілуде, сондықтан барлық оқу орындары инновациялық технологияларды оқу материалын игеруді арттыру мақсатында уақытында енгізуге тырысады.

ISBN 978-601-08-0758-7

Виртуалды оқыту әртүрлі географиялық шекаралар арқылы оқытушылар мен білім алушылар байланыстыратын цифрлық платформалар арқылы жеткізілетін веб негізіндегі оқыту ретінде анықталған [13]. Білім беру арнайы пәндер бойынша білім мен құзыреттіліктерді меңгеруді білдіреді. Оқыту белгілі бір жұмысты немесе қызметті орындау үшін қажетті дағдыларды игерудің неғұрлым тиімді процесі [14]. Виртуалды оқыту орталары білім беру саласындағы инновациялық қайта құру құралдары ретінде оқытуды имитациялауға арналған және синхронды немесе асинхронды түрде жүргізілуі мүмкін [13]. Қашықтықтан оқыту білім берудің ажырамас бөлігіне айналды. Негізінде әртүрлі білім беру және ақпараттық платформалар және басқа да ықтимал қашықтықтан оқыту құралдары бар. Медициналық колледжде ғылыми базаны кеңейту мақсатында симуляциялық технологиялар мен онлайн және интерактивті макеттер арқылы медициналық пәндерді оқу мүмкіндігі бар хирургия, гинекология, балалар аурулары, терапия және т.б. нақты пәндер мен ауруларды зерттеуге арналған интерактивті тренажерлар енгізілген. Медицинадағы инновацияларды шолуда соңғы кездері көп айтылып жүрген телемедицина да маңызды орын алады.

Классикалық мағынада телемедицина денсаулық сақтау жүйесінің диагностикалық, емдеу, профилактикалық және ұйымдастырушылық басқару мәселелерін шешуге бағытталған. Дегенмен, оның мүмкіндіктері мен функцияларының арасында әрдайым дерлік білім беру, яғни медицина қызметкерлерін қашықтықтан оқыту үшін телемедицина технологияларын пайдалану көрсетіледі. Ол пациенттің қал жағдайын көрсетуі мүмкін нақты деректерді талдауды, сондай-ақ қажетті медициналық диагностиканы жүргізуді үйренуге көмектеседі. Бұл әдіс пайдалы және интерактивті форматта әртүрлі жағдайлар мен патологияларды зерттеу мен талдауды ұсынады. Кейс әдістерін енгізу интерактивті жұмыс арқылы клиникалық жағдайларды зерттеуге көмектеседі. Бұл студенттерге аурудың әртүрлі жағдайларын жақсы түсінуге көмектеседі. Кейстердің көмегімен оқытуда анамнез жинаудың белгілі бір құрылымы бар, мысалы, медициналық тексеруден кейінгі фото және бейне материалдар, созылмалы аурулар, жарақаттар туралы мәліметтер, науқастың өзіне тән дауысының жазбалары, зерттеу нәтижелері және т.б. әдістеме медицинадағы инновациялық оқыту түрлерінің бірі ретінде білім алушыларға ерекше және сирек жағдайларды шешуді үйренуге көмектесуге арналған. Кейс әдісінде веб-әдістерді қолдану арқылы студенттер әртүрлі нақты жағдайларды талдай отырып, белгілі бір ауру туралы білімдерін кеңейтеді, пациентті емдеу жолдарын табуға тырысады. Қазіргі уақытта нақты ситуациялық жағдайларды талдауға арналған дидактикалық материалды көрсететін интерактивті оқу кейстерін жинақтай отырып, оқу процесінде әртүрлі интернет-қосымшалар белсенді түрде қолданылады. Медициналық білім берудегі инновациялар мен оқыту әдістерін жетілдіру денсаулық сақтау мен медициналық білімнің барлық деңгейінде дамуына ықпал етеді. Виртуалды білім беру пациенттерге уақтылы көмек көрсету мен қауіпсіздігін қолдау және ақпараттық технологиялармен байланысты зияндардың алдын алу үшін өте маңызды. Виртуалды оқыту ортасын енгізу тек

ISBN 978-601-08-0758-7

техникалық қиындық емес, сонымен қатар педагогикалық және оқу мәселесі болып табылады.

Медициналық колледж студенттеріне практикалық дағдыларды үйретудің ең заманауи әдісі – орта медициналық персоналды оқыту жүйесінде имитациялық технологияларды қолдану. Казіргі таңда, Казақстан Денсаулық сақтау ұйымдары әлемдік стандарттарға сай жаңа құрылылармен жабдықталған. Медицина мамандарының тәжірибелік дағдыларын дайындау, шыңдау үшін ерекше әдіс-тәсілдер колдану кажеттілігі туындайды. Адам көзімен көргенінің - 20%-ы, көзбен көріп, құлағымен естігенінің - 40%-ы, ал көріп, естіп және қолымен жасағаны - 70%-ы есте қалатыны ғылыми түрде делелденген. Окытушы инновациялық технологияларды қолдану арқылы теориялық білімді бекітіп, тәжірибелік жадыны дамыту және білім алушылардың меңгерген білімдері мен жадыларын шынайы клиникалық тәжірибеде өткізу, олардың кәсіби іс-әрекеттерінің дамып жетілуін қалыптастырады. Осының нәтижесінде білім алушылардың теориялық алған білімдері тереңдеп, тәжірибелік ептіліктері жетіледі, денсаулық сақтау жүйесінде жұмыс жасайтын мамандардың кәсіби мінез құлығының үлгісі бекіп қалыптасады. Қазіргі таңда тәжірибелік оқыту тәсілінің негізі - **клиникалық симуляция.** Колледж базасында симуляциялық орталықта студенттер автоматика деңгейіне дейін практикалық дағдыларды үйренеді. Оқытушылар оны мейіргерлік персоналды оқытудағы құптарлық қадам деп санайды. Симуляторды толыққанды, тиімді қолдануды камтамасыз ету арқылы сабақтың мақсатына, нәтижеге қол жеткіземіз. Симуляцияның ерекшелігі: білім алушылар өздерінің кәсіби тәжірибесін дамытып жетілдіруде қауіпсіз ортамен (яғни манекен, тренажер, роботпен т.б. жұмыс істеу) камтамасыз етіледі. Білім алушылардың симуляциялық орталықта өткен сабақтары да айтарлықтай оң нәтиже береді.

Осының дәлелі ретінде айта аламын: 2024 жылы менің жетекшілік етуіммен білім алушы Сейлжанұлы Иманәли «Емдеу ісі», «Мейіргер ісі» мамандықтары бойынша өңіраралық қатысумен «Шұғыл көмек» бейнероликтер байқауына қатысып, «Үздік медициналық техникамен жабдықталған бейнебаян» номинациясы бойынша Дипломмен марапатталды. Студенттер симуляциялық тәжірибеден өткеннен кейін ғана әлеуметтік серіктестердің клиникалық базасында практикалық дайындықты бастай алады. Қазіргі таңдағы отандық денсаулық сақтау жүйесінің алдында тұрған өзекті мәселелердің бірі, медицина саласына жоғары деңгейде кәсіби құзыреттілікке ие сапалы маманмен қамтамасыз ету [5, 6]. Заманауи медициналық білім беруді дамыту тенденциялары, денсаулық сақтау жүйесінің болашақ мамандарын дайындау бағытына, клиникалық дайындығына жоғары талаптар қоюда [1, 4]. Сапалы медициналық білім беру колледж қабырғасында алынған терең білім және клиникалық базаларда меңгерілген тәжірибелік дағдыларға негізделген [2, 3]. Бұл ретте негізгі міндеттердің бірі, денсаулық сақтау жүйесіне кадрлардың клиникалық дайындығын жетілдіру бойынша шаралар кешені негізінде, колледж қабырғасында тәлімгерлік үлгісін енгізуді көздейді [7, 8]. Отандық денсаулық

ISBN 978-601-08-0758-7

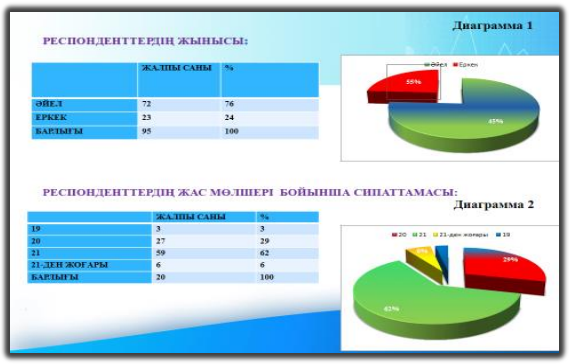
сақтаудың негізгі проблемаларының бірі мейіргерлердің тапшылығы болып табылады [9].

Маңызды мәселелердің бірі медициналық колледж бітіргеннен кейін өз жұмысын толықтай орындауға қабілетті студенттерді практикалық дайындық мәселесі болып тұр. [10].

Болашақ медицина мамандарын оқытудағы жаңа тәсілдер мен инновациялардан күтілетін нәтижелерді зерттеу әдістері мен тәсілдері Астана қаласы әкімдігінің «Жоғары медициналық колледж» ШЖҚ МКК «Мейіргер ісі» біліктілігі, «Жалпы практикадағы мейіргер» мамандығының III курс студенттері арасында сауалнама қолдану арқылы жүргізілді. Сауалнамаға 95(100 %) студент қатысты. Олар жынысы бойынша: әйел адамдар - 72(76 %), ер адамдар- 23(24%). Жас мөлшері- 19 жаста 3(3 %), 20 жаста 27(29%), 21 жаста 59(62 %), 21-ден жоғары жастағылар 6(6%).

«Оқытушы өткен оқу процесімен қанағаттандыңыз ба?» деген сұраққа 94(99%) студенттер толық қанағаттандығын айтты.

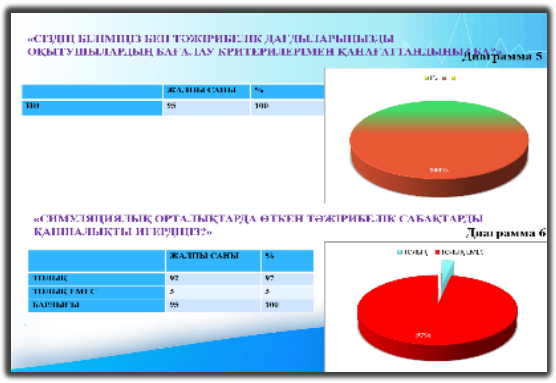
Ал «Оқытушы сізді белсенді, тәуелсіз шешім қабылдауға ынталандырды ма?» деген сұраққа 90(95%) студенттер «толық ынталандырды», 2(2%) «жауап беруге қиналамын», 3(3%) «жоқ» деген жауапты таңдаған.

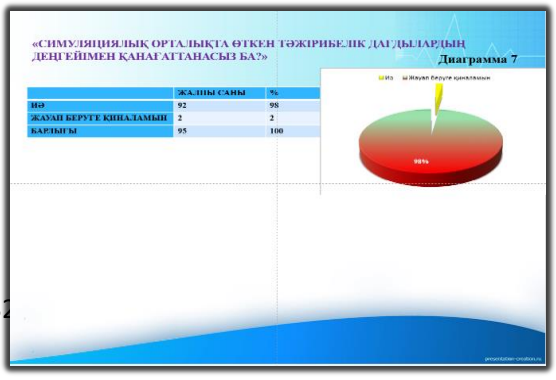




«Сіздің білімдік тәжірибелік дағдыларыңызды оқытушылардың бағалау крийтерилерімен қанағаттандыңыз ба?» деген сауалға студенттер толық қанағаттанғандығын 95(100%) белгілеген.

«Симуляциялық орталықтарда өткен тәжірибелік сабақтарды қаншалықты игердіңіз?» кезекті сұрағына толық қанағаттандым деп көпшілік 92(97%), ал 3(3%) толық емес деп жауап берді. «Симуляциялық орталықтарда өткен тәжірибелік дағдылардың деңгейімен қанағаттанасыз ба?» деген сұраққа 92(98%) «иә» деп, 2(2%) «жауап беруге қиналамын» деген жауапты берді.





ISBN 978-601-08-0758-7

Зерттеу нәтижелері мен оларды талқылау.

Зерттеудің мақсаты: студенттердің тәлімгерлікті оқыту жүйесіне енгізу бойынша қанағаттану дәрежесін бағалау.

Зерттеудің мәселелері:

1) III-ші курс студенттерінің инновациялық технологияларды оқыту жүйесіне енгізу бойынша қанағаттануын анкета нәтижелері арқылы бағалау;
2) Болашақ медицина мамандарын оқытудағы жаңа тәсілдер мен инновациялардан күтілетін нәтижелерді бағалау.
Жаңа тәсілдер мен инновациялардан күтілетін қорытынды: біріншіден, студенттердің медициналық ортаға шынайы жұмылуы, пациенттермен қарым қатынаста коммуникативті дағдылардың жетілуі, оқытушылар мен тәлімгерлердің қадағалауымен медициналық манипуляциялар мен техниканы шынайы тәжірибеде қолдануға мүмкіндік алады.

«Ұстазы жақсының ұстамы жақсы» дегендей тәлімгер ретінде





Республикалық және қалалық конкурстар мен конференцияларға қатысуларына ат салысудамын. Олар жүлделі орындар иегерлері.

Педагогқа білім беруді жаңғырту процесінің негізгі құрамдас бөліктері – жоғары іргелі мәдениеті бар, іргелі білімі бар, кәсіби құзыретті және бәсекеге қабілетті маманды қалыптастыратын жасаушы, зерттеуші рөлі жүктелген.

Барлық педагогтер мен оқытушыларға жас ұрпаққа білім беріп, тұлға ретінде қалыптасуларына ат салысып, қарқынды қызмет етіп жүргендеріңізге алғысым шексіз! Бүгінгі білімді студент- ертеңгі білікті маман деп ойлаймын!

Пайдаланған әдебиеттер:

1. Козлов А. Б. Традиции наставничества в Республиканской психиатрической больнице /А. Б. Козлов, Л. Г. Ронжина, А. В. Аверин // Матер. Всерос. науч.-практ. конф. «Сестринское дело в психиатрии». - Чебоксары, 2006. - С. 55-59.

2. Ронжина Л. Г. Наставничество как одна из форм воспитания и обучения молодого специалиста на рабочем месте /Л. Г. Ронжина, А. В. Аверин //Тр.

ISBN 978-601-08-0758-7

междунар. науч.-практ. конф. «Сестринское дело и высшее сестринское образование в XXI веке. Проблемы и перспективы». - СПб: СПбГМА им. И.И. Мечникова, 2012. - С. 35-36.

3. Ронжина Л. Г. Обучение и наставничество среднего медицинского персонала /Л. Г. Ронжина, А. В. Аверин //Тез. докл III съезда психиатров, наркологов и психотерапевтов Чувашской Республики. - Чебоксары, 2005. 2020;142:104238—10. С. 303-306.

4. AIIen T. D. Career benefits associated with mentoring for proteges: a meta-analysis /T. D. AIIen, L. T. Eby, M. L. Poteet //Journ. of AppIied PsychoIogy. - 2004. - V. 89 (1). - Pp. 127- 136.

5. Berk R. A. Measuring the effectiveness of faculty mentoring relationships /R. A. Berg, J. Berg, R. Mortimer //Academic Medicine. - 2005. - V. 80 (1). - Pp. 66-71.

6. Buddeberg-Fischer B. Formal mentoring programmes for medical students and doctors – a review of the Medline literature/B. Buddeberg-Fischer, K. D. Herta //MedicaI Teacher. - 2006. - V. 28 (3). - Pp. 248-257.

7. Garr R. O. A qualitative study of mentoring and career progression among junior medical doctors. International /R. O. Garr, P. Dewe // Journ. Of Medical Education. - 2013. - V. 4. - Pp. 247-25

8. Kashiwagi D. T Mentoring programs for physicans in academic medicine: a systematic review/D. T. Kashiwagi, P. Varkey, D. A. Coок // Academic Medicine. - 2013. - V. 88(7). - Pp. 1029-1037.

9. Sambunjak D. A systematic review of qualitative research on the meaning and characteristics of mentoring in academic medicine /D. Sambunjak, S. E. Straus, A. Marusic //Journ. Of General Internal Medicine. – 2010. V. of GeneraI Internal Medicine. - 2010. - V. 25(1). - Pp. 72-78.

10. Иванов О.Н. Орта медициналық білім беруде симуляциялық оқыту технологияларын қолдану . М., 2014 ж

11.Үздіксіз кәсіптік білім беру жүйесінде симуляциялық оқыту. Ред. П.В.Глыбочко.М.:1Мәскеу медицина университетінің баспасы,2012ж.

12. Щукин Ю., Мензул Е.В., Мякишева В. Медициналық университетте білім беру траекториясын қалыптастырудағы инновациялық тәсілдер. Медициналық білім және университет ғылымы. 2017;9(1):21–25.

13.Кнебель Е.Денсаулық сақтауда қашықтықтан білім берудің қолданылуы мен әсері: біз не білеміз? Сапаны қамтамасыз ету жобасы. 2001. URL: https:// pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnacn245.pdf (қолжетімді 06/25/2022).

14.Samadbeik M. et al. Денсаулық сақтау мамандары мен студенттері үшін электрондық медициналық жазбалар (EMR) бойынша білім беру және оқыту: ауқымды шолу. Медициналық информатиканың халықаралық журналы.

15. Курс бағдарламасына сәйкес симуляциялық оқу материалдары « Симуляциялық оқыту нұсқаушысы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің Денсаулық сақтауды дамыту республикалық орталығы 2015 ж

ISBN 978-601-08-0758-7

ЭТИЧНЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Қойшыбаева С.Т., преподаватель специальных дисциплин;
Тұрдығазина І.С., преподаватель специальных дисциплин.
КГП на ПХВ «Государственный высший медицинский колледж им. Д Калматаева»

Аннотация: *В данной статье рассмотрены этические аспекты внедрения новых технологий в медицинское образование. Специальное внимание уделено вопросам, возникающим при использовании цифровых платформ, симуляционных технологий и искусственного интеллекта (ИИ) в образовательных процессах. На основе исследований казахстанских ученых обсуждаются моральные и профессиональные дилеммы, связанные с цифровизацией образования, а также предлагаются пути решения возможных этических проблем.*

Развитие технологий стремительно меняет все сферы жизни, включая медицинское образование. Новые цифровые инструменты, симуляционные технологии и ИИ становятся неотъемлемой частью подготовки будущих медицинских специалистов. В то же время внедрение этих инноваций порождает ряд этических вопросов, которые требуют пристального внимания как со стороны образовательных учреждений, так и со стороны профессиональных сообществ.

В Казахстане активное развитие медицинского образования сопровождается внедрением новых технологий. Однако, как и в мировой практике, перед казахстанскими учеными и преподавателями стоит задача учитывать не только преимущества цифровизации, но и возможные негативные последствия, такие как нарушение конфиденциальности данных студентов и пациентов, вопросы доступности образования, а также влияние на традиционные этические нормы в медицине.

Этические аспекты внедрения технологий в медицинское образование

1. Конфиденциальность и безопасность данных

Одним из главных этических вопросов внедрения технологий в медицинское образование является конфиденциальность данных студентов и пациентов. Например, использование электронных образовательных платформ, симуляторов и ИИ предполагает сбор и обработку большого объема персональных данных. Важно, чтобы разработчики программного обеспечения и преподаватели соблюдали принципы конфиденциальности и защиты информации, гарантируя, что личные данные студентов и клиническая информация пациентов не будут использованы в ненадлежащих целях.

Казахстанские ученые, такие как А. Есимханова и ее коллеги, подчеркивают, что существующие правовые и этические нормы в Казахстане должны быть адаптированы к новым вызовам цифровизации. В их исследовании

ISBN 978-601-08-0758-7

указывается на необходимость более строгого контроля за хранением и использованием данных студентов медицинских колледжей и вузов в условиях внедрения электронных образовательных платформ.

2. Доступность медицинского образования

Технологии должны способствовать доступности медицинского образования для всех студентов, независимо от их социального положения или региона проживания. Однако в некоторых случаях цифровизация может усугубить неравенство. Например, студенты из отдаленных регионов или семей с низким доходом могут не иметь доступа к необходимому оборудованию или интернет-связи для полноценного обучения с использованием цифровых платформ.

Казахстанские исследователи, такие как Ж. Байтурсынова, отмечают, что одна из ключевых задач государства — обеспечение равного доступа к образованию для всех студентов. В своей статье она призывает к разработке государственных программ, направленных на устранение цифрового неравенства и поддержку студентов из уязвимых групп населения.

3. Искусственный интеллект и симуляционные технологии

Внедрение ИИ и симуляционных технологий в учебный процесс создает возможности для более эффективного обучения, но также ставит перед будущими врачами и преподавателями новые моральные дилеммы. Например, насколько этично полагаться на ИИ в диагностике и принятии решений? Какую роль должна играть машина в формировании клинического мышления студента?

В работе казахстанского ученого Д. Смагулова подчеркивается, что важно сохранять баланс между технологиями и традиционными ценностями медицинского образования, такими как клиническое мышление, интуиция и человеческие отношения. Технологии должны стать помощниками, а не заменой этическому подходу к лечению пациента.

4. Изменение роли преподавателя и деформация ценностей

Внедрение технологий также может изменить традиционную роль преподавателя в образовательном процессе. Цифровые платформы и симуляторы предоставляют студентам возможность учиться самостоятельно, что может снизить важность личного взаимодействия между преподавателем и студентом. Это, в свою очередь, может повлиять на передачу ключевых медицинских ценностей, таких как сострадание, ответственность и уважение к пациенту.

Согласно исследованиям казахстанского педагога Г. Тлеповой, важно сохранять "человеческий фактор" в медицинском образовании, несмотря на цифровизацию. Она подчеркивает, что никакая технология не заменит прямого контакта студента с преподавателем и живого общения, которое формирует не только профессиональные, но и морально-этические качества медицинского специалиста.

Примеры

- ✓ ***Использование симуляционных технологий в КазНМУ имени С. Д. Асфендиярова.*** В университете активно используются симуляционные

ISBN 978-601-08-0758-7

центры, где студенты могут отрабатывать навыки на виртуальных пациентах. Это значительно улучшает практическую подготовку, но требует от студентов и преподавателей строгого соблюдения этических норм, особенно в отношении использования данных реальных пациентов при разработке сценариев для симуляторов.

- ✓ ***Онлайн-обучение в условиях пандемии.*** В 2020 году, во время пандемии COVID-19, медицинские колледжи и вузы Казахстана были вынуждены перейти на дистанционное обучение. Это привело к дискуссии об этичности использования технологий для подготовки медицинских специалистов, ведь недостаток практического опыта может негативно сказаться на качестве образования.

Выводы:

Этические аспекты внедрения технологий в медицинское образование требуют глубокого анализа и тщательного подхода со стороны образовательных учреждений и государства. Важно не только использовать современные технологии для улучшения учебного процесса, но и сохранять моральные и профессиональные ценности, которые составляют основу медицинской профессии. Казахстанский опыт показывает, что необходим баланс между новыми подходами и традиционными этическими нормами в обучении будущих медицинских специалистов.

Список литературы

1. Есимханова А. Н. и др. "Правовые и этические аспекты цифровизации медицинского образования в Казахстане" // Медицинское образование и наука. — 2021.
2. Байтурсынова Ж. А. "Доступность медицинского образования в условиях цифровизации: вызовы и решения" // Журнал медицинских исследований Казахстана. — 2022.
3. Смагулов Д. К. "Искусственный интеллект в медицинском образовании: этические и педагогические аспекты" // Вестник медицинской науки Казахстана. — 2020.
4. Тлепова Г. Н. "Роль преподавателя в условиях цифровизации медицинского образования" // Образование в XXI веке. — 2021.

ISBN 978-601-08-0758-7

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ

Ульбауова А. М., заместитель директора по учебно-производственной работе;
Ахметова Г. С., преподаватель специальных дисциплин.
КГП на ПХВ «Государственный высший медицинский колледж им. Д Калматаева»

Аннотация: *Цифровая трансформация в медицинском образовании становится неотъемлемой частью подготовки специалистов здравоохранения во всем мире, в том числе и в Казахстане. Современные подходы к обучению медицинских кадров, основанные на использовании цифровых технологий, меняют традиционные методы преподавания и практики. В данной статье рассматриваются основные направления цифровой трансформации медицинского образования в Казахстане, примеры внедрения цифровых инструментов в учебный процесс, а также оценивается влияние этих изменений на качество подготовки будущих специалистов. Особое внимание уделено исследованиям и практическим кейсам, основанным на работе казахстанских ученых.*

Медицинское образование всегда было одной из наиболее сложных и требующих постоянного обновления сфер подготовки специалистов. Традиционные методы обучения, включающие лекции, практические занятия и клиническую практику, постепенно дополняются цифровыми технологиями. Цифровая трансформация в образовании способствует улучшению доступа к образовательным ресурсам, повышению качества симуляций и дистанционного обучения. Казахстан, как часть глобального процесса цифровизации, активно внедряет цифровые инструменты в образовательный процесс медицинских колледжей и университетов.

Новые подходы к обучению медицинских специалистов

Одним из ключевых направлений цифровой трансформации медицинского образования является внедрение систем дистанционного обучения. В Казахстане такие системы, как Platonus, используются в ведущих медицинских колледжах и университетах для дистанционного доступа к учебным материалам, проведения тестирований и взаимодействия с преподавателями. Дистанционные лекции и семинары, особенно востребованные в период пандемии COVID-19, доказали свою эффективность, предоставляя студентам возможность обучаться независимо от их географического местоположения.

Другим важным направлением является использование технологий виртуальной и дополненной реальности (VR/AR). Такие технологии позволяют создавать виртуальные симуляции для отработки практических навыков без необходимости прямого контакта с пациентами. Например, в Казахском национальном медицинском университете имени С. Д. Асфендиярова была

ISBN 978-601-08-0758-7

внедрена платформа виртуальной симуляции для отработки навыков хирургических операций, что значительно увеличило качество подготовки хирургов.

Еще одним инструментом цифровизации является телемедицина, которая активно используется не только в практической медицине, но и в образовательном процессе. Казахстанские ученые активно исследуют возможности телемедицины для подготовки медицинских специалистов. Например, в университете медицинских наук Казахстана студенты имеют возможность наблюдать за консультациями опытных специалистов с пациентами в режиме реального времени, что позволяет им получить ценные практические знания.

Примеры использования цифровых технологий в медицинском образовании в Казахстане

Цифровая трансформация медицинского образования в Казахстане развивается стремительными темпами, и внедрение новых технологий открывает значительные возможности для студентов и преподавателей. Ведущие медицинские университеты страны активно интегрируют различные цифровые инструменты в учебный процесс. Рассмотрим несколько ключевых примеров использования цифровых технологий, которые существенно меняют подходы к подготовке медицинских специалистов.

Симуляционные центры

Одним из самых эффективных цифровых решений в медицинском образовании Казахстана являются симуляционные центры, которые используют цифровых пациентов и виртуальные тренажеры для практики навыков студентов. В таких центрах обучающиеся могут отрабатывать диагностику и лечение различных заболеваний в условиях, максимально приближенных к реальным клиническим ситуациям, но без риска для жизни и здоровья пациентов.

В «Медицинском университете Астаны» и «Казахском национальном медицинском университете имени С. Д. Асфендиярова» действуют высокотехнологичные симуляционные центры, оборудованные манекенами с программируемыми физиологическими функциями. Эти манекены могут имитировать широкий спектр медицинских состояний: от сердечного приступа до легочной недостаточности. Студенты практикуют интубацию, искусственную вентиляцию легких, сердечно-легочную реанимацию, внутривенные вливания и другие процедуры, что позволяет им подготовиться к реальной клинической практике.

Кроме того, симуляционные центры предоставляют возможности для междисциплинарного обучения. Например, будущие хирурги, терапевты и медсестры могут вместе практиковать командную работу в условиях симуляции. Это помогает не только улучшить технические навыки, но и развить навыки коммуникации и координации действий в команде, что является важной составляющей работы в больничных условиях.

Мобильные приложения для обучения

ISBN 978-601-08-0758-7

Цифровизация медицинского образования включает в себя активное использование мобильных приложений для обучения. В Казахстане одним из таких приложений является «MedeAnalytics». Оно предназначено для студентов и врачей, предоставляя им доступ к актуальным клиническим рекомендациям, протоколам лечения, а также возможностям мониторинга состояния пациентов.

Это приложение активно используется в ряде медицинских вузов, в частности в «Западно-Казахстанской медицинской академии имени Марата Оспанова». MedeAnalytics предоставляет студентам доступ к клиническим руководствам, что помогает им не только лучше подготовиться к экзаменам, но и использовать актуальные данные в процессе клинической практики. Доступ к медицинским статьям, видеолекциям и интерактивным материалам также способствует более глубокому пониманию сложных медицинских дисциплин.

Использование мобильных приложений помогает сделать обучение более гибким. Студенты могут изучать материалы в любое удобное для них время, что особенно важно в условиях интенсивной учебной нагрузки в медицинских колледжах и университетах. Также мобильные приложения позволяют систематизировать знания, интегрируя их в ежедневную практику.

Электронные библиотеки и базы данных

Доступ к научной информации и актуальным исследованиям является важной частью медицинского образования. В Казахстане активно внедряются цифровые библиотеки и базы данных, такие как «PubMed», «Elsevier», «Web of Science» и «Cochrane Library». Эти ресурсы предоставляют студентам возможность быстро находить актуальную информацию о последних достижениях в медицине, изучать клинические исследования, а также знакомиться с новейшими диагностическими и терапевтическими подходами.

Электронные библиотеки позволяют студентам медицинских колледжах и университетах Казахстана не только использовать учебные материалы, но и развивать навыки научной работы. Например, в «Казахском медицинском университете непрерывного образования» студенты активно используют базы данных для проведения собственных научных исследований. Это способствует развитию критического мышления и умению анализировать медицинскую информацию, что важно для профессионального роста будущих специалистов.

Электронные ресурсы также помогают оптимизировать процесс подготовки к экзаменам и профессиональным тестированиям. Доступ к актуальной информации позволяет студентам всегда быть в курсе последних изменений в клинических рекомендациях и протоколах лечения.

Искусственный интеллект в диагностике

Искусственный интеллект (ИИ) активно внедряется в различные сферы медицины, и образование не стало исключением. В медицинских университетах Казахстана ведется работа по интеграции ИИ в образовательный процесс для обучения студентов работе с новыми диагностическими технологиями.

В «медицинском университете Астаны» и «Южно-Казахстанском медицинском университете» студенты обучаются использовать системы

ISBN 978-601-08-0758-7

искусственного интеллекта для анализа диагностических данных, таких как результаты рентгенографии, компьютерной томографии и анализов крови. Это позволяет им понять, как ИИ помогает врачам в постановке более точных диагнозов, а также как улучшить процесс принятия клинических решений.

ИИ-системы, такие как «Watson Health от IBM», активно внедряются в учебный процесс и используются для анализа сложных клинических случаев. Студенты изучают, как ИИ может помочь в разработке индивидуальных планов лечения, прогнозировании заболеваний и предотвращении возможных осложнений. Например, система может предсказать риск развития диабета у пациента на основании его генетических данных, что позволяет студентам понять значение точной диагностики и профилактики заболеваний на ранних стадиях.

Использование ИИ в медицинском образовании не только повышает уровень подготовки студентов, но и открывает новые перспективы для их будущей профессиональной деятельности.

Выводы:

Цифровая трансформация медицинского образования в Казахстане способствует значительному улучшению качества подготовки специалистов. Внедрение цифровых технологий, таких как дистанционное обучение, симуляции на основе VR/AR, телемедицина и искусственный интеллект, позволяет не только улучшить доступ к знаниям, но и повысить практическую подготовку будущих специалистов. Однако важной задачей на пути к полной цифровизации остается необходимость постоянного обновления инфраструктуры и повышения цифровой грамотности как студентов, так и преподавателей.

Список литературы

1. Абдразакова, Н., & Жумашева, С. (2021). Влияние цифровой трансформации на образовательные процессы в медицине. Вестник медицинского образования, 5(3), 45-53.
2. Исаев, Т. Б. (2020). Использование виртуальных симуляторов в медицинском образовании. Научно-методический журнал, 9(2), 22-27.
3. Касымова, А. Ж., & Мусина, Г. Р. (2022). Развитие телемедицины в образовательном процессе медицинских вузов Казахстана. Международный журнал телемедицины и медицинских технологий, 7(1), 12-19.
4. Оспанова, Ж. М. (2023). Применение искусственного интеллекта в диагностике заболеваний и его роль в обучении студентов. Труды научно-практической конференции "Цифровизация медицины", 31-34.
5. Тасмагамбетов, М. Т. (2021). Цифровые технологии в медицинском образовании: опыт и перспективы. Медицинское образование Казахстана, 12(4), 10-18.

ISBN 978-601-08-0758-7

"БЛУМ КУБИГІ" ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ ӘДІСІ РЕТІНДЕ

Сериккалиева Динара Сериккалиевна, гуманитарлық ғылымдарының мғагистрі

Абай облысы ДСБ «Д.Қалматаев атындағы мемлекеттік жоғарғы медицина колледжі» ШЖК ҚМҚ

Аннотация: *бұл мақалада заманауи педагогикалық технологиялардың әдіс –тәсілдерін тарих сабағында тиімді қолдану туралы қарастылырған. Студенттер сабақ барысында тиімді білім алу үшін, Блум кубигі туралы әдісті қолдану жолдары жазылған.*

Бүгінгі таңда мұғалім дидактикалық әдістерді меңгеріп қана қоймай, оны педагогикалық процесте қолдана білуі керек.

Оқытудың тиімді әдістері студенттің сабақта табысқа жетуіне көмектесетін маңызды құрал болып табылады. Әр студенттің өзіндік ерекшеліктері мен оқуға деген қабілеті болады.

Қазіргі білім беру жүйесінде студенттердің танымдық белсенділігін қалыптастыру- өзекті. Студенттердің білім, білік және жаңа дағдыларды игеру процесінде оқытушының тиімді әдісті қолдануы маңызды орын алады. Студенттердің танымдық белсенділігін дамыту үшін, «Блум кубигі», «STEAM», «GBL» әдістерін зерттеу.

Бенджамин Блум – американдық оқыту әдістерінің психологы, Блум таксономиясының негізін қалаушы. Бенджамин Блум педагогикалық іс-әрекеттің бірегей алгоритм жүйесінің авто ры ретінде белгілі. Ол ұсынған теория білім беру мақсаттарын үш блокқа бөледі: «Мен білемін», «Мен жасай мын», «Мен жасай аламын». Яғни, студентке тақырып бойынша мәселелер ұсынылады, ол өзінің тәжірибесі мен білімін қолдана отырып, бұл мәселені шешудің жолдарын табуы керек.

«Блум кубигі» техникасы – сыни тұрғыдан ойлауды дамыту технологиясының әдістерінің бірі, Б.Блум таксономиясына негізделген сұрақ тар жүйесі:

- Білу – бұл қарапайым сұрақтар;
- Түсіну – нақтылау;
- Қолдану – практикалық;
- Талдау – түсіндіру;
- Синтез – шығармашылық;
- Бағалау – бағалау. Қарапайым болып көрінетін әдіс материалды талдауға, сезінуге және түсінуге көмектеседі. Сабақ барысында оқушылардың сұрақтар қою процесі олардың менталитетін, мәселені түсінудің тереңдігі мен айқындығын көрсетеді.

«Қазақстан тарихы» пәнін оқытуда студенттердің танымдық белсенділігін дамытуда, сабақ барысында «Блум кубигі» бұл әдісті жиі қолданамын.

ISBN 978-601-08-0758-7

Блумның ойынша мұғалімнің міндеті –студенттердің ойлау қабілетінің жоғары деңгейіне жету.

1. Білу – алынған ақпаратты есте сақтау, білу, студент негізгі терминдерді, нақты фактілерді, ережелерді меңгере алады, тақырып туралы жалпы түсінік қалыптасады.

2. Түсіну – екінші кезеңде түсіну және материалды өз сөзімен жеткізе білу. Оқушы ережелер мен принциптерді біледі және түсінеді, фактілер мен құбылыстарды түсіндіре алады.

3. Қолдану. Үшінші кезеңнің мақсаты – алған білімдерін нақты жағдайда қолдануды үйрену.

4. Талдау – бұл деңгейде оқушының мақсаты материалдың құрылымын түсініп, оны талдай білуі.

5. Синтез. Бесінші деңгейге жеткен оқушы өз білімін жалпылап, біріктіре алады.

6. Бағалау. Жоғары деңгейде студент оқытушының көмегімен тұжырымдай алатын критерийлер арқылы мәлім демелерді бағалайды. Және қорытындылардың дұрыстығын тексеру және өз көзқарасыңызды дәлелдеу. «Блум кубигі» техникасы – сыни тұрғыдан ойлауды дамыту технологиясының әдістерінің бірі. «Блум кубигі» жоғарыда айтып өткендей «Блум таксономиясына» негізделіп жасалған. Сондықтан да бұл әдіспен сұрақтар құрастыру да «Блум таксономиясының» деңгейлеріне сәйкес жүзеге асады.

«Блум кубигі» әдісін пайдаланғанда қалыптасатын студентердің даму ерекшеліктері алынған білімді қолданады, тәуелсіздікке ұмтылады, білім беру ынтымақтастығын жүзеге асыруады, серіктес таңдау мүмкіндігі бар, өзінің жіберілген қателіктердің себептері мен олар ды түзету жолдарын табады, жаңа білім алу қажеттілігін анықтайды.

Қазақстан тарихы пәнінен «Блум кубигі» техни касын қолдана сабақ өту үлгісі «Моңғол шапқыншылығы кезіндегі Қазақстан» тақырыбына сабақта төрт топқа бөлінеді. Әр топқа жеке «Блум кубигі» беріледі. Әр топ тақырып бойынша контекстпен танысып, сұрақтар құрастырылады. Топтар арасында кубиктер ал мастырылып, кубик лақтырғанда түскен беттегі текшедегі сұрақтарға жауап беріледі. 1. Сабақта сұрақтар қою үшін қағаздан жа салған кубик қажет болады және де оның алты текшесіде келесі атаулармен жазылады: «Атаңыз...», «Неге...», «Түсіндіріңіз...», «Ұсыны ңыз...», «Ойланыңыз...», «Бөлісіңіз...» (1-сурет). Оқытушы кубикті айналдырып тастайды. Кубиктің түскен беті сұрақтың қандай түрін қою керектігін көрсетеді.Студенттер кестені сәйкес типтегі сұрақтармен толтыру ұсынылады. Содан кейін топта құрастырылған кестелер мен алмасып, білімалушылардың жауаптарын талдайды.

ISBN 978-601-08-0758-7



1-сурет – Блум кубигі

Блум кубигінің әр текшесіне арнайы сұрақ атаулары жазылып тұрады. Әр сұраққа түріне жеке тоқталатын болсақ: Атаңыз. СтудентШыңғыс хан туралы оның шапқыншылықтары құбылыстың, терминді (кешіктен, гобалық) атайды. Неге. Бұл сұрақтар себеп – салдарлық қатынастарды тұжырымдауға, яғни құбылыспен жүретін процестерді сипаттауға, жаулап алынған терииториялартуралы ақпарат мүмкіндік береді, мысалы Темичинді неге Шыңғыс хан деп атады. Түсіндіріңіз. Олар мәселені әр қырынан кө руге және берілген мәселенің барлық аспек тілеріне назар аударуға көмектеседі. Студент шапқыншылық барысы, жаулап алынған қалалар, территориялар туралы ақпарат береді. Ұсыну. Студент проблемаға өзінің көзқа расын, өз идеясын ұсынуы керек. Яғни, студент келтілірген салдары туралы ақпарат береді, ұлыстарға тоқталуға болады. Бөлісу – бұл блоктың сұрақтары студенттердің ақыл-ой белсенділігін белсендіруге, олар ды талдауға, фактілер мен салдарды бөліп көрсетуге, алынған ақпараттың маңыздылығын бағалауға және оларды бағалауға бағытталуға арналған. Яғни, аталған тақырыптан туындайтын студенттердің сезімдеріне, эмоцияларына тоқталу Жошы ұлысы туралы ақпарат береді.

Қорытындылай келсек, XXI ғасыр жаңа технологиялар мен жаңа білім беру ғасыры болғандықтан, ғылыми-техникалық прогрестің шапшаң дамып, қоғам дамуы салаларының мазмұны жаңарып, өзгеше сипат алып, күннен-күнге жаңаруда,дамуда. Осыған орай педагогтардың да жауапкершіліктері артып, үлкен міндеттер жүктеліп отыр. Педагогикалық технологияларды игеріп, талдап, өз сабақтарында тиімді қолдану әрбір оқытушының алдындағы мақсат-міндеті болуы керек. Сондықтан мен де өз сабақтарымда белсенді оқыту әдістерін мейілінше тиімді қолдануға тырысамын.

Әдебиеттер тізімі:

1.ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТАНЫМДЫҚ ІС-ӘРЕКЕТІН БЕЛСЕНДІРУ ӘДІСТЕРІ//ISSN 2520-2634, eISSN 2520-2650 Педагогикалық ғылымдар сериясы. №2 (71) 2022 https://bulletin-pedagogic-sc.kaznu.kz

2. https://eduindex.kz/methodical-articles/613-tarih-pnin-oytuda-belsendi-disterdi-oldanu.html

ISBN 978-601-08-0758-7

БОЛАШАҚ МЕДИЦИНА МАМАНДАРЫН ОҚЫТУДАҒЫ ЖАҢА ТӘСІЛДЕР МЕН ИННОВАЦИЯЛАР

Төлегенова Ләйлім Қайратқызы, «Арнайы пәндер» оқытушысы
“Өскемен жоғары медициналық колледжі” ШЖҚ КМК

Аннотация: *Инновациялық технологиялар білім саласында жаңа ақпараттық технологиялар мен ғылым жетістіктеріне негізделген әдістерді қолдануды білдіреді. Бүгінгі таңда білім беру процесінде инновациялық әдістердің бірі – жағдайға негізделген оқыту әдісі (CBL – case-based learning). Бұл әдіс студенттердің танымдық белсенділігін арттырып қана қоймай, олардың өз бетімен шығармашылық деңгейде білімді меңгеруіне мүмкіндік бере*

Инновациялық технологиялар – ол білім саласындағы қолданатын жаңа ақпараттық технологиялар, ғылым жетістіктеріне негізделінген әдістер.

Мен өзім тәрізді білім саласында еңбек жолын жаңадан бастаған жас әріптестеріме бүгінгі оқыту бағытына инновациялық әдістердің бірі сабақты CBL әдісімен өткізуді ұйымдастыру ұсынар едім.

Себебі инновациялық әдістер студенттердің танымдық белсенділігін арттырып қана қоймай, олардың өз бетімен білімді шығармашылық деңгейде зерделеуіне мүмкіндік береді. Қазіргі таңда медициналық білім ордаларында кеңінен қолданылып отырған оқытудың белсенді әдістерінің бірі – нақты ситуацияға бағытталған оқыту әдісі (CBL – cased-based learning).

Дәстүрлі оқыту әдістерімен салыстырғанда CBL әдісі төмендегідей артықшылықтар береді:

- білім алушыларды белсенді түрде оқыту үдерісіне жұмылдыру (өздігінен білім алу үдерісіне жауапкершілік);
- коммуникативтік дағдыларды дамыту;
- клиникалық ойлауды дамыту;
- ойын жүйелі түрде жеткізуге тәрбиелеу;
- дербес жұмыс істеуге, өз бетімен қорытынды жасауға дағдыланады;
- өзін-өзі оқыту, бірін-бірі оқыту үрдісі жүреді
- Практикалық дағдыларды жетілдіру

CBL әдісімен сабақ өткізудің бір мысалын келтіретін болсам.

Сабақтың мақсаты:

- Студенттерде өздігінен ойлауды қалыптастыра отырып, басқалардың ойымен санасуға үйрету;
- Проблемалық ситуацияға анализ жасауға, проблеманы шешу жолдарын қарастыру;
- Топта жұмыс істеуді қалыптастыру.
- Практикалық дағдыларды жетілдіру

Науқас 42 жаста. Шағымдары:

ISBN 978-601-08-0758-7

оң жақ көздің жасаурауы, сұйық тамақ ішкенде оң жақ ерін бұрышынан сыртқа ағып кетуі, оң жақта есту қабілеті төмендеп, дәм сезудің бұлылуына шағымданады

Науқаста қандай мәселе?

Қосымша сұрақтар:

- Осы шағымдарыңыз қашаннан бері пайда болды?
- Науқас ауруын немен байланыстырады?
- Симптомдар қалай тез дамыды?
- Науқас медициналық көмекке жүгінді ма? Қандай дәрілік заттар қолданды,оның нәтижесі болды ма?

Ауру анамнезі:

Сұрастыру кезінде бір апта бұрын «Жедел ортаңғы отитпен» ауырғаны анықталды. Сырқаттануын осымен байланыстырады.

Дәрігерге қаралған жоқ.Өздігінен емделген жоқ.

Жоғарыда аталған шағымдар мазалағаннан кейін жергілікті ФАП-ке қабылдауға келген.

Анамнезінде жиі ЖРА.

Объективті қарау көріністері:

- Науқастың жалпы жағдайы орташа ауырлықта.
- Дене қызуы – 36,6º С
- Есі анық.Науқастың қалпы белсенді.
- Тері жабындылары бозғылт,ылғалды,
- Перифериялық лимфа түйіндері ұлғаймаған,ауырсынусыз
- Кеуде торы қалыпты формада, симметриялы, деформация жоқ .
- Өкпесінде везикулярлы тыныс. ТАЖ 19 р мин.

Науқаста VII жұп нервтің қызметін тексеруді қалай жүргізесіз?

Зерттеу кезіндегі науқаста қандай өзгерістерді анықтауға болады?

А-сурет. Бұлшықет парезінің салдарынан науқас зақымдалған жақта қабағын көтере алмайды,

Б- сурет. Көзі жұмылмайды, жұмұға тырысқанда көз алмасы жоғарыға қарайды бұл -Белл феномені.

қабақтары жабылмағаннан көз алмасында ақ жолақ көрініп тұрады бұл-лагофтальм деп аталады.

В- сурет. Тістерін ақситқанда ауыз қуысы сау жаққа қарай тартылады, сұйық тағам ішкенде ауызынан сыртқа ағып кетеді.

Науқастан сұрастыру кезінде алдыңғы 2/3 бөлігінде дәм сезудің бұзылуы, көздің құрғауы анықталды.

Науқасқа қандай болжам диагноз қоясыз?

БолжамиДиагноз: Бет нервісінің невропатиясы

Науқасқа емдеу жоспарын құрыңыз.

Ісінуді басу мақсатында глюкокортикоитар, диуретиктер

ISBN 978-601-08-0758-7

Микроциркуляцияны жақсарту үшін пентоксифиллин, эуфиллин, никотин қышқылы

НПВС

В тобының витаминдері: тимаимна бромид, пиродоксин гидрохлорид

Медикаментозды емес ем:

Медикаментозды емес ем. 1 апта соңынан бастап

ЛФК- айна алдына бет б.е гимнастика жасау. 2 апта соңына қарай

Мимикалық б.е массажы. 1 апта соңынан бастап

Физио емі 1 апта соңынан бастап

Инемен емдеу 2 апта соңына қарай

1. Сырқаттың профилактикасы бойынша кеңес беріңіз.
2. Емнің эффективтілгінің көрсеткіштері қандай?

Профилактикалық шаралар

- қатты шаршаудан, суық тиюден сақтану.

Диспансерлік бақылау:

- жергілікті жері бойынша неврологта бақылауда болады.

Емінің эффектифтілігі:

- Мимикалық бұлшық ет функциясын қалпына келтіруі.
- Мимикалық бұлшық ет тонусын жақсарту.
- Беттің асимметриясын азайту

Қорытынды: Сонымен белсенді CBL әдісі бізге не береді? Студенттің ситуациялық жағдайларды өз бетімен шешуге, коммуникативті, практикалық дағдыларын дамытуға, анализ жасауға үйретеді. Оқытушының кәсіптік құзыреттілігін арттырады.

Әдебиеттер тізімі:

Протоколы заседаний Экспертной комиссии по вопросам развития здравоохранения МЗ РК, 2013

1. «Неврология» под редакцией М. Самуэльса - Москва, 1997. 2. «Детская неврология» А.Ю. Петрухин - Москва, 2004.

3. «Неврология» Д.Р. Штулман - Москва, 2005.

4. « Справочник по неврологии» Е.В. Шмидт - Москва, 1989.

5. «Детская неврология» Л.О. Бадалян - Москва, 1998.

6. «Функциональная диагностика нервных болезней» Л.Р. Зенков, М.А. Ронкин - Москва, 2002.

7. «Болезни периферической нервной системы» Я.Ю. Попелянский - Москва, 1989.

8. «Диагностика и лечение болезней нервной системы у детей». Под редакцией В.П. Зыкова – Москва, 2006.

ISBN 978-601-08-0758-7

МЕЙІРБИКЕ ІСІНДЕ ТЕЛЕМЕДИЦИНАНЫ ҚОЛДАНУ: МҮМКІНДІКТЕРІ МЕН ШЕКТЕУЛЕРІ

Әбдірәсіл А.Н., №5 «Мейіргер ісі» циклдік әдістемелік комиссиясының төрағасы, медицина ғылымдарының магистрі,
Ибраимова Жамиля Джумадиловна- аға-оқытушы, №5 «Мейіргер ісі» циклдік әдістемелік комиссиясының аға-оқытушысы.
Әшім Дәния Әділбекқызы- №5 «Мейіргер ісі» циклдік әдістемелік комиссиясының оқытушысы.
ҚДСБ ШЖҚ «Жоғары медициналық колледжі» КМК

Аңдатпа: *Телемедицинаның анықтамасы және оның қазіргі Денсаулық сақтау жүйесіндегі маңызы. Медбикенің телемедициналық қызметтерді жүзеге асырудағы рөлі: консультациялардан бастап пациенттердің жағдайын бақылауға дейін. Мақаланың негізгі мақсаттары: мейірбике ісінде телемедицинаны қолданудың әлеуеті мен шектеулерін бағалау.*

Өзектілігі: Телемедицинаның дамуына әсер еткен факторларды қарастыру (COVID-19 пандемиясы, шалғай және ауылдық жерлерді қамту қажеттілігі). Телемедициналық технологиялардың танымалдылығының артуы және олардың медициналық көмектің қолжетімділігі мен сапасына әсері. Телемедициналық тәжірибеде мейірбикелік күтімді ұйымдастырудың ерекшеліктері: медбикенің қашықтықтан күтімді үйлестіруші ретіндегі рөлі, пациенттерді оқытудағы рөлі.

Зерттеу әдісі: Әдебиеттерді талдау, мейірбике ісінде телемедицинаны қолдану тақырыбы бойынша ғылыми мақалаларға, зерттеулерге және есептерге жүйелі шолу.

Мейірбике ісіндегі телемедицинаның басты артықшылықтарының бірі-қол жетімділігі қиын және шалғай аудандарда медициналық қызмет көрсету мүмкіндігі. Мұндай жағдайларда телемедициналық технологиялар медбикелерге қашықтықтан кеңес беруді ұйымдастыруға және пациенттерге медициналық мекемелерге тасымалдауды қажет етпестен білікті көмек көрсетуге мүмкіндік береді. Бұл әсіресе мүмкіндігі шектеулі науқастар, егде жастағы адамдар, сондай-ақ халықтың саны аз аймақтарда тұратындар үшін өте маңызды. Қашықтықтан кеңес беру және телемедицина арқылы пациенттердің жағдайын бақылау медициналық көмекті күту уақытын айтарлықтай қысқартады. Пациенттер нақты уақыт режимінде ауруларды күту, алдын алу және емдеу бойынша кеңестер мен кеңестер ала алады, бұл ауытқуларды уақтылы анықтауға және түзетуге ықпал етеді. Бұл медициналық көмектің сапасы мен қолжетімділігін арттырады және созылмалы аурулардың асқыну ықтималдығын азайтады [5]. Телемедицина стационарлық және амбулаториялық-емханалық медициналық мекемелерге

ISBN 978-601-08-0758-7

жүктемені азайтуға мүмкіндік береді, өйткені пациенттерді күту және бақылау бойынша көптеген тапсырмаларды қашықтан орындауға болады. Бұл әсіресе тұрақты бақылау мен бақылауды қажет ететін созылмалы науқастарға қатысты. Телемедициналық технологияны қолдану медбикелерге ауруханаға немесе емханаға жиі бармай-ақ пациенттердің өмірлік көрсеткіштерін (мысалы, қан қысымы, қандағы глюкоза, жүрек соғу жиілігі) қашықтан бақылауға мүмкіндік береді [3]. Қашықтан бақылау және емдеуді немесе күтімді уақтылы түзету асқынулар мен ауруханаға жатқызуды болдырмайды, бұл пациенттер үшін де, жалпы денсаулық сақтау жүйесі үшін де қаржылық шығындарды азайтады. Осының арқасында медбикелер бетпе-бет көмекке мұқтаж науқастарға назар аудара отырып, уақыттары мен ресурстарын тиімдірек бөле алады. Сонымен қатар, телемедицина мейірбике қызметкерлерінің жұмыс кестесін оңтайландыруға ықпал етеді, қосымша жұмыс уақытын азайтады және медбикелер арасында жұмысқа қанағаттануды арттырады. Онлайн ресурстарды пайдалана отырып, мейірбикелерді үздіксіз оқыту және кәсіби дамыту мүмкіндігі [1].

Телемедициналық технологиялар онлайн оқыту және тәжірибе алмасу арқылы медбикелердің кәсіби дамуына кең мүмкіндіктер ашады. Қашықтықтан оқытудың заманауи платформалары медбикелерге соңғы ғылыми мәліметтерге, емдеу және күтім хаттамалары мен әдістеріне қол жеткізуге, вебинарларға, семинарлар мен конференцияларға қатысуға мүмкіндік береді. Бұл медбикелердің үздіксіз біліктілігін арттыруға ықпал етеді, бұл өз кезегінде көрсетілетін көмектің сапасын жақсартады [4]. Сонымен қатар, онлайн-ресурстар медбикелерге басқа аймақтардағы және елдердегі әріптестерімен тәжірибе алмасуға мүмкіндік береді, бұл олардың кәсіби көкжиегін кеңейтеді және күнделікті жұмысқа озық тәжірибелерді енгізуге ықпал етеді. Негізгі қызметтен қол үзбей оқыту мүмкіндігі медбикелерге жұмыс пен білім беруді біріктіруге мүмкіндік береді, бұл кәсіби даму процесін икемді және қолжетімді етеді. Осылайша, телемедицина заманауи медицинаның қиындықтарына тиімді жауап бере алатын сауатты және бейімделгіш медициналық персоналды құруға ықпал етеді. Мейірбике ісіндегі телемедицинаның бұл артықшылықтары оның қарқынды өзгерістер мен сапалы медициналық көмекке деген өсіп келе жатқан қажеттіліктер жағдайында денсаулық сақтау жүйесін дамытудағы маңыздылығы мен әлеуетін көрсетеді [5].

Мейірбике ісіндегі телемедицинаның шектеулері мен қиындықтары. Техникалық сипаттағы проблемалар (Интернетке қол жетімділіктің болмауы, жабдықтың жетіспеушілігі). Телемедицинаны қолданудағы маңызды шектеулердің бірі-техникалық мәселе. Телемедициналық қызметтердің тиімді жұмыс істеуі үшін медициналық қызметкерлерде де, пациенттерде де интернетке тұрақты қол жетімділік және тиісті жабдық қажет. Телекоммуникациялық инфрақұрылымы дамымаған шалғай аудандар мен аймақтарда Интернетке қосылуда қиындықтар жиі кездеседі, бұл

ISBN 978-601-08-0758-7

телемедициналық платформаларды пайдалану мүмкіндігін шектейді. Сонымен қатар, қашықтықтан медициналық көмек көрсету үшін қашықтан бақылау құрылғылары, жоғары ажыратымдылықтағы камералар, компьютерлер немесе планшеттер сияқты арнайы жабдық қажет. Медициналық мекемелер мен пациенттер әрдайым мұндай жабдыққа қол жеткізе бермейді, бұл телемедицинаны іс жүзінде енгізу мүмкіндігін шектейді. Қаржыландырудың жетіспеушілігі және мемлекет пен жеке сектордың қолдауының болмауы да айтарлықтай кедергілерге айналуда [2].

Телемедициналық платформаларды тиімді пайдалану үшін медициналық персонал мен пациенттерді оқыту қажеттілігі. Телемедицинаны сәтті енгізу үшін медициналық персоналды да, пациенттерді де оқыту қажет. Медбикелер мен басқа да денсаулық сақтау мамандары телемедициналық технологиялар мен платформаларды пайдалану және пациенттерді оларды қолдануға үйрету үшін қажетті дағдылар мен білімге ие болуы керек. Бұл уақыт пен ресурстарды, сондай-ақ жаңа білім беру бағдарламалары мен тәсілдерін әзірлеуді қажет етеді. Науқастар, әсіресе егде жастағы немесе компьютерлік сауаттылығы төмен науқастар телемедициналық қызметтерді пайдалануда қиындықтарға тап болуы мүмкін. Олар компьютермен немесе мобильді құрылғылармен жұмыс істеу негіздерін үйреніп, арнайы қосымшаларды қолданып, қашықтан бақылаудың қалай жұмыс істейтінін түсінуі керек. Бұл дағдылардың жетіспеушілігі телемедициналық араласудың тиімділігін шектеп, пациенттердің мұндай емдеу әдістеріне деген сенімін төмендетуі мүмкін [4].

Этикалық және құқықтық аспектілері: пациенттер деректерінің құпиялылығы, қашықтықтан емдеу әдістеріне келісім. Этикалық және құқықтық аспектілер телемедицинаның дамуындағы маңызды сын-қатерлер болып табылады. Пациенттердің деректерінің құпиялылығы, әсіресе қашықтықтан өзара әрекеттесу жағдайында, басты мәселелердің бірі болып табылады. Телемедициналық платформалар дербес деректерді интернет арқылы беруді талап етеді, бұл оларды кибершабуылдарға және рұқсатсыз кіруге осал етуі мүмкін. Сондықтан деректерді қорғаудың жоғары деңгейін қамтамасыз ету және ақпараттың ағып кетуіне жол бермеу үшін сенімді киберқауіпсіздік шараларын енгізу қажет. Тағы бір этикалық және құқықтық сын-қатер-пациенттің телемедициналық технологияларды қолдануға саналы түрде келісімін алу қажеттілігі. Пациенттер қашықтықтан емдеуге байланысты ықтимал қауіптер туралы хабардар болуы керек және олардың деректерін өңдеуге және телемедициналық қызметтерді пайдалануға келісім беруі керек. Бұл телемедициналық тәжірибені реттейтін нақты хаттамалар мен заңды құжаттарды әзірлеуді талап етеді [1]. Сонымен қатар, кейбір елдерде телемедициналық қызметті реттейтін заңнамалық актілер жоқ немесе жеткіліксіз дамыған, бұл оны құқықтық қамтамасыз етуді қиындатады және медициналық қызметкерлердің жауапкершілігінде белгісіздік тудырады. Бұл телемедицинаны клиникалық тәжірибеде қолдану мүмкіндігін шектейді және

ISBN 978-601-08-0758-7

жаңа жағдайларға бейімделу үшін заңнаманы қайта қарауды талап етеді. Бұл шектеулер мен қиындықтар инфрақұрылымды жақсартуды, медициналық қызметкерлер мен пациенттерді оқытуды, сондай-ақ құқықтық база мен этикалық стандарттарды әзірлеуді қамтитын телемедицинаны енгізудің кешенді тәсілінің қажеттілігін көрсетеді. Телемедициналық мейірбике күтіміне арналған стандарттар мен хаттамаларды енгізу. Мейірбике ісінде телемедицинаны сәтті енгізу және жұмыс істеу үшін қашықтан күтімнің барлық аспектілерін реттейтін стандарттар мен хаттамаларды әзірлеу және бекіту қажет. Бұл стандарттар медициналық көмектің барлық кезеңдерін қамтуы керек: алғашқы кеңес беруден бастап пациенттің жағдайын бақылауға және емдеуді басқаруға дейін. Хаттамаларда телемедициналық технологияларды қолдану, пациенттердің деректерін басқару, құпиялылық пен киберқауіпсіздік, медбикелер мен пациенттердің өзара әрекеттесу процестері бойынша ұсыныстар болуы керек [5].

Телемедициналық күтім процестерін стандарттау көрсетілетін қызметтердің сапасын арттыруға, қателер қаупін азайтуға және медицина қызметкерлерінің жаңа технологияларға бейімделуін жеңілдетуге көмектеседі. Телемедицинаны мейірбикелік оқу бағдарламаларына біріктіру қажеттілігі. Телемедициналық технологияларды мейірбикелік оқу бағдарламаларына біріктіру жаңа технологияларды іс жүзінде тиімді пайдалана алатын білікті мамандарды даярлаудағы маңызды қадам болып табылады. Бұл телемедициналық платформалармен жұмыс істеу негіздерін үйренуге, пациенттерді қашықтан бақылау әдістерін, сондай-ақ киберқауіпсіздік пен деректерді қорғау принциптерін үйретуге бағытталған курстар мен тренингтерді әзірлеуді талап етеді. Арнайы симуляциялық тренингтер мен практикалық сабақтардың көмегімен медбикелерді пациенттермен телемедициналық өзара әрекеттесудің әртүрлі сценарийлеріне дайындауды қамтамасыз етуге болады, бұл олардың сенімділігі мен кәсіби дағдыларын арттырады. Телемедицинаны білім беру бағдарламаларына енгізу сонымен қатар осы саладағы білім мен тәжірибенің кең таралуына ықпал етеді, бұл өз кезегінде мейірбикелік күтімнің сапасын жақсартады [3].

Инфрақұрылымды жақсарту және телемедицина үшін жағдай жасау үшін мемлекет пен денсаулық сақтау мекемелерінің қолдауы. Телемедицинаны дамыту мемлекет пен денсаулық сақтау мекемелерінің белсенді қолдауын талап етеді. Мемлекеттік деңгейде телекоммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға инвестициялар қажет, әсіресе интернетке қол жетімділігі шектеулі немесе жоқ шалғай және ауылдық жерлерде [2]. Сонымен қатар, лицензиялау, медициналық персоналдың жауапкершілігі, деректерді қорғау және пациенттердің келісімі мәселелерін қоса алғанда, телемедициналық қызметтерді пайдалануды реттейтін заңнамалық актілерді әзірлеу және енгізу қажет. Мемлекеттік қолдау сонымен қатар телемедицина саласындағы мейірбикелерді оқыту мен біліктілігін арттыруға гранттар мен субсидияларды қамтуы мүмкін, бұл осы технологияларды тәжірибеде кеңірек

ISBN 978-601-08-0758-7

және тиімді пайдалануды қамтамасыз етеді. Денсаулық сақтау мекемелері инновациялық жобаларды қолдау, пилоттық бағдарламалар жүргізу және телемедициналық технологияларды күнделікті жұмысына біріктіру арқылы телемедицинаның дамуына ықпал ете алады. Бұл медбикелер мен басқа да медициналық мамандарға көмек көрсетудің жаңа әдістеріне бейімделуге, біліктілігін арттыруға және медициналық қызметтердің сапасын жақсартуға мүмкіндік береді [6].

Қорытынды: бұл ұсыныстар мен даму перспективалары мейірбике ісіне телемедицинаны енгізудің кешенді тәсілінің маңыздылығын көрсетеді. Бұл телемедициналық күтімнің қолжетімділігін, тиімділігін және қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін денсаулық сақтау, білім беру және заңнамалық реттеу жүйесінің әртүрлі деңгейлері арасындағы күш-жігерді үйлестіруді талап етеді.

Әдебиеттер тізімі:

1. Владзимирский А. В. Телемедицина. Как использовать цифровой прогресс для здоровья, когда все на удаленке/ 2020 год 304 стр

2. Кудрина В.Г., Андреева Т.В., Дзеранова Н.Г. Эффективность обучения медицинских работников информационным технологиям. Москва: ИД "Менеджер здравоохранения", 2013. - 248 с.

3. Бирлидис Г.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности медицинских работников / Бирлидис Г.В., Ремизов И.В., Калиниченко Е.П.; под ред. И.В. Ремизова. – Ростов-на-Дону, 2009. – 313с.

4. Двойников С.И., Тарасова Ю.А., Фомушкина И.А. и др. Организация сестринской деятельности: учебное пособие. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.

5. Карпов О.Э., Клейменова Е.Б., Назаренко Г.И., Силаева Н.А. Автоматизированное проектирование медицинских технологических процессов / Под ред. Г.И. Назаренко. – М.: Деловой экспресс, 2016. — 200 с.

6. Современная организация сестринского дела : учебное пособие / Ю. А. Тарасова [и др.] ; под ред. З. Е. Сопиной. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010.

ISBN 978-601-08-0758-7

НОВЫЕ ПОДХОДЫ И ИННОВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ БУДУЩИХ МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Сұлтанов Мейірбек Әлібекұлы, замдиректора по учебной работе
Абдукасымова Замза Анафиевна, Ерматова Перизат Ниязбековна
преподаватели клинических дисциплин
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения
«Высший медицинский колледж» УЗ г. Шымкент

Аннотация: *В статье рассматриваются новые технологии обучения, которые применяются в процессе обучения клиническим дисциплинам в высшем медицинском колледже, с целью внедрения инновационных методов в практическую подготовку будущих среднего уровня медицинских работников*.

Цель исследования: Изучать новые инновационные технологии с использованием их на практических занятиях в симуляционном центре.

Обязанности:Главной задачей современного образования является подготовка компетентных специалистов, которые были бы способны применять свои знания в изменяющихся условиях, и чья основная компетенция заключалась бы в умении включиться в постоянное самообучение на протяжении всей своей жизни.

Актуальность темы:Внедрение в учебный процесс инновационно-коммуникационных технологий позволяет охватить большой объём материала, повышает уровень самообразовательных навыков, мотивацию совершенствования знаний, формирует умения ориентироваться в большом объёме информации.

Именно сегодня для повышения квалификации необходимо осмыслить по-новому собственную позицию, понять, зачем и для чего необходимы изменения, и, прежде всего, измениться самому.

Перед выпускниками колледжей стоит цель – уметь внедрять новейшие инновационные технологии, используемые в практической медицине для своей повседневной деятельности.

В колледже активно наряду с классическим вариантом проведения урока активно используются инновационные технологии, без которых уже немыслимо представить современный урок. На данном этапе в системе образования превалирует **принцип** вариативности. Благодаря этому принципу образовательные учреждения вправе выбирать для своей учебной деятельности разнообразные методики, не избегая и авторских подходов.Поэтому свою статью посвящаем тем методам введения урока, которые считаем наиболее апробированными в нашем колледже.Мыхотели бы поделиться своим опытом преподавания на основе проведенных нами как повседневных занятий, так и мастер - классов с использованием TED формата ,ClIL,TBL,PBL, ассоциативного мышления, геймификации. Чем же они интересны и какую ценность

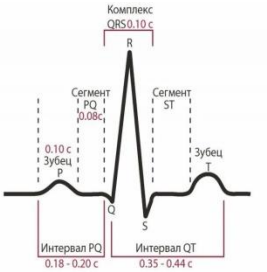
ISBN 978-601-08-0758-7

представляют для образовательного процесса. На эти вопросы максимально постараемся ответить в этой статье и нашей презентации, которая отображает отрывок практического урока на тему:«Диагностика сердечно – сосудистых заболеваний»











TED расшифровывается как technology, entertainment, design — то есть технологии, развлечения, дизайн. Конференции в этом стиле начали проводиться 34 года назад в США. В нашем колледже этот формат активно используется в течении последних двух лет. Флагманом его внедрения в образовательный процесс принадлежит по праву ВМК г.Талдыкорган. Прежде чем внедрить эту технологию в образовательный процесс нашего колледжа было просмотрено огромное количество выступлений на различных платформах, начиная от спикеров Маргулана Сейсембаева до Стива Джобсона. Этот формат можно использовать на разных этапах урока.



Благодаря этому формату, объем материала не уменьшается,но становится легко усвояемым,позволяет выявить базовые навыки студента,сделать его главным действующим лицом, мотивировать на дальнейшие углубленное изучение материала.Фокус методологии на уроке переносится на самого студента.TED форматпозволяет интегрировать иностранные языки в предмет (CLIL технология), что в конечном итоге расширяет возможности самого студента так и преподавателя.Использование этих технологий позволяет выпустить специалистов, востребованных не только в нашей стране, но и странах ближнего и дальнего зарубежья. Основополагающие принципы предметно-языкового интегрированного обучения :Content, Communication, Cognition, CultureТехнология CLIL преследует две цели, а именно - изучение предмета посредством иностранного языкаи иностранного языка через преподаваемый предмет. Примером служит видеоролик, который

ISBN 978-601-08-0758-7

представлен на английском языке, но понятен каждому, благодаря зрительному контенту.

PAIN



Однако и имеются и отрицательные стороны. Одной из таких проблем является отсутствие у преподавателей иностранного языка знаний по спец. предметам. Другая проблема заключается в том, что преподаватель-предметник либо вообще не владеет языком, либо знает его на недостаточно хорошем уровне. Решением этой проблемы являются бинарные уроки.



TBL и PBL играют немаловажную роль в раскрытии TED формата. Суть метода (геймификация) состоит в импровизированном разыгрывании ситуации. Геймификация – это внедрение игровых форм в неигровой контекст, котораяиспользует естественные склонностистудентов к конкуренции, соревнованиям, сотрудничеству и достижениям В игре участвует вся группа. Одна и та же ситуацияможе проигрываться несколько раз, чтобы дать возможность участникам игры побывать в разныхситуациях. Существуют многочисленные модификации ситуационных игрс использованием различных методик (Например:«Урок-конференция»,«Телемост»



Моделируемая в игре ситуация должна максимально приближаться к реальной действительности.В нашей презентации использована ролевая игра с приходом тележурналистов в кардиологическое отделение, где заведующий отделением и специалисты объясняют им методы диагностики заболеваний ССС, Видео-оператор снимает урок, в котором студенты видят себя со стороны и имеют возможность анализировать свои ошибки .

ISBN 978-601-08-0758-7



MISTAKES

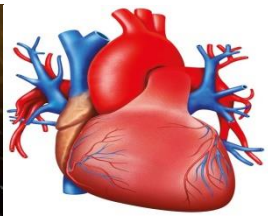
Игровая форма позволяет в «психологически безопасной» ситуации приобрести необходимые для профессиональной деятельности практические умения и навыки, получить необходимую поддержку и помощь со стороны других участников. Студенты тренируют умения кратко и чётко выражать свои мысли, учатся слушать и слышать друг друга, быстро находить варианты решений.

Как подготовить урок в стиле TED формата

1Активация мыслительного процесса

Активация имеющихся знаний (текстовая , зрительная, слуховая подсказка) В нашей презентации мы проводим ассоциацию с пауком в паутине и заболеваниями ССС. Здесь имеется двойная смысловая нагрузка: во - первых, паук как символ созидания итрудолюбия, во- вторых, как паук выпутывается из сети, так и студенты шаг за шагом осваивают материал. Либо речевой контекст:









Для обывателя -то грамота китайская

S – T.P – Q и WPWсиндром

Но для врача бумага эта не Китайская

Задумайся пожалуста о том.

2.Фокусирование

Студенты приходят на предмет с другого предмета и им необходимо настроиться на тему и волну нового урока.



3. Выявить способности студентов

ISBN 978-601-08-0758-7

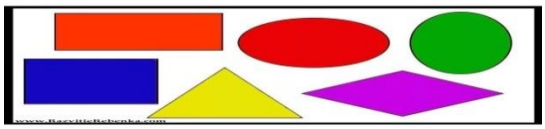
Все студенты имеют разный познавательный, лингвистический, культурный бэкграунд. Активируя знания, эти различия становятся видимыми для преподавателя.

Сформулировать основную идею урока поможет концепцию SMART

 	Цель по SMART **S** – specific - конкретная **M** – measurable - умеренная **A** – achievable - достижимая **R** – relevant - актуальная **T** – time – tramet - определенная по времени

Прежде всего преподавателю необходимо выйти из зоны комфорта. Каждый урок требует приготовления «домашних заготовок». Речь должна быть проста и лаконична, должна иметь разный звуковой диапазон. Медицинские термины, используемые на уроке, должны быть предоставлены студенту в качестве вспомогательного материала. Длительность слайда составляет не больше 1- 2 минут, иначе мы будем разговаривать не с аудиторией, а с экраном. Слайды должны быть различными по форме и содержанию.

ISBN 978-601-08-0758-7



По результатам обучения студенты владеют материалом урока, умеют использовать полученные знания на практике (в нашем случае интерпретировать результаты ЭКГ), пользоваться различными ресурсами, изучают иностранный язык, самокритично относиться к себе, что поможет в дальнейшем более тщательно готовиться к урокам, улучшив свой качественный и количественный показатель. В колледже имеется библиотека, в том числе цифровая (электронная), обеспечивающая доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам, которые позволяют быть информированными в изучении новых технологий.





Список литературы:

1.Источники:https://search.app/cub5ZZVajrQDuGXt7[1,стр 3].

2. https://search.app/EhcqfcFgYx3abJi27[3стр. 4].

3. https://sbermed.ai/roboty-v-medicine[1 стр ,5]

4. https://mguu.ru/primenenie-robotov-v-meditsine-5-interesnyh-primerov/[3стр, 6]

ISBN 978-601-08-0758-7

МЕДИЦИНАДАҒЫ ЗЕРТТЕУЛЕРДІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Қалданова Назерке Оразайқызы, «Акушерия және гинекология» пәні оқытушысы
Орынбасар Ботагөз Кенжебекқызы, «Анатомия, физиология және жалпы патология» пәні оқытушысы
Қызылорда жоғары медициналық колледжі

Аннотация: *Мейіргерлер өздерінің күнделікті клиникалық жұмысында пациенттердің әртүрлі мәселелеріне, қажеттіліктері мен мұқтаждықтарына тап болады, бұл клиникалық шешімдердің тиімді қабылдауын талап етеді. Көбінде зерттеу нәтижелерін іс жүзінде қолдану қиын және бұл өте көп уақытты алуы мүмкін. Ұйымдастырушылық мәдениет, ұйымдастырушылық көшбасшылық, мейіргерлердің білім деңгейін, құзыреттері мен білім алу құрылымын арттыру дәлелді тәжірибені енгізу жолындағы кедергілерді еңсеруге септігін тигізеді. Сондай-ақ мейіргерлер нұсқаулықтары да денсаулық сақтау ұйымдарының клиникалық бөлімшелерінде дәлелді тәжірибені жылжытуда маңызды рөл атқарады. Кәсіби әуестік, пациенттердің әл-ауқатына назар,сыни тұрғыдан ойлау және мейіргер ісінің ағымдағы практикасын сыни бағалау нақты деректерге негізделген өзгерістерді енгізудің маңызды қозғаушы күші болып табылады.*

Мейіргерлер денсаулық сақтау жүйесінің негізгі күші болып табылады. Мейірбике ісі саласындағы зерттеулер пациенттерге медициналық қызмет көрсету мен оның нәтижелерін жақсарту, пациенттерге көмек көрсету, ғылыми негізделген білім беру үшін аса маңызды болып табылады. Сонымен қатар, мейірбике ісі басшыларының жаңа ұрпағы клиникалық көмектің өзгергенін дәлелдейтін дәлелдер келтіреді деп күтілуде. Сондықтан да Қазақстанда мейірбикелердің тәжірибесінде ғылыми білімді дамыту және пайдалану қажет. Зерттеу сапасы үшін зерттеу тақырыптарының өзекті және қайырымдылықтың практикалық мәселелеріне негізделгендігі маңызды. Сондықтан клиникалық практика мен оқу орындары арасындағы ынтымақтастық өте маңызды. Білім беру мекемелерінің рөлі халықаралық ғылыми әдебиетті зерделеу жолымен ғылыми зерттеулерге құндылық қосу болып табылады, ол бұрыннан белгілі бір нәрсені оқыту мен енгізудің сапалы әдістемесін қамтамасыз ету мақсатында жүзеге асырылады.

Қазіргі кезде Қазақстандағы мейірбике ісі саласындағы зерттеулер негізінен магистрлік диссертацияларға негізделеді. Айта кетейік, зерттеулердің тақырыптық бағыттары мен міндеттерін талдау кезінде Қазақстандағы мейіргерлік күтім саласындағы (төменде көрсетілген) (Heikkilä & Hopia 2019) ең маңызды тақырыптардың бірі ретінде танылған инсультті зерттеуге және онкологиялық мейірбике ісімен байланысты фрагменттер ерекше атап өтілді. Бірнеше үзіндіде «медбикенің рөлі»

ISBN 978-601-08-0758-7

айтылады, бұл түсінікті, себебі қазіргі уақытта Қазақстанда медбикелерді даярлау деңгейі жақсарып, жаңа жұмыс орындары құрылуда, мысалы, алдыңғы қатарлы тәжірибесі бар медбикелер және PhD докторантура сияқты білім деңгейі. Бұл асбестті біліктілікті арттырудың басым бағыттарының мысалы ретінде қарастыруға болады. Бұл сығындылар белгілі бір клиникалық салаға енуге бейім болғандықтан, оларды мейірбике ісі саласындағы клиникалық зерттеулерде басымдылыққа алуға болады. Сондай-ақ, зерттеуде мейірбике ісі, АКТ және мейірбике ісі саласындағы электрондық денсаулық сақтау, мейірбике ісі мен мейірбике ісі сапасын арттыру секілді тақырыптар таныстырылды.

Бұл ретте интенсивті терапия және жедел медициналық көмек, паллиативтік көмек және жүрек жетіспеушілігі бар науқастарға мейірбике күтімі бойынша рефераттар болған жоқ. Сонымен қатар, мейірбике ісі тақырыбына қатысты рефераттар Денсаулық сақтау стратегиясындағы маңызды басымдықтардың бірі болғанымен, денсаулықты нығайту мен аурулардың алдын алудың қазіргі бағыттарын (сілтемені) қарастырмағаны қызық. Вакцинациялау, темекі шегу, семіздік және денсаулық сауаттылығы эпидемиологиялық және медициналық көмек көрсету бөлігінде үзінділермен ұсынылады, алайда осы уақытқа дейін мейірбикелердің салауатты өмір салтын ұстанатын денсаулық сақтау шараларының құндылығы мойындалмаған. Бұл ретте бұл тақырыптарды пациенттерді оқыту тұрғысынан қарастыруға болар еді, ол жеткіліксіз болды.

Денсаулық сақтау ұйымдары мен олардың басшылары аса маңызды қажеттіліктер мен қолда бар ғылыми дәлелдер күнделікті мейіргерлік іс-шаралардың ажырамас бөлігі болып табылатын құрылымдалған ортаны құру жолымен нәтижелерді жақсарту үшін қысымға ұшырайды. Мысалы, магнетік несиелерін алу үшін ұйымның медбикелері олардың инновациялық екенін және пациенттерді дәлелді практика (ДНТ) арқылы емдеу олардың нәтижелеріне негізделген тәжірибені жетілдіруге ықпал ететінін көрсетуі тиіс. Өнімділік сыйақыларының эволюциясы және реттеушілер мен төлеушілер үшін сапа нәтижелеріне көбірек көңіл бөлу дәлелді тәжірибеге жетелеуді жалғастыруда. Ғылыми негізделген дәлелдерді клиникалық мейіргерлік практикаға ықпалдастыру сапалы мейірбике күтімін көрсету үшін өте маңызды, ал мейірбике ісі басшыларының маңызы зор. Ғылыми негізделген практиканы іске асыру жеке қасиеттерді ғана емес, сонымен қатар мәдениет, жауапкершілік, жұмыс жүктемесі және ресурстар сияқты ұйым құндылықтары мен онымен байланысты факторлардың контекстін қамтиды.

Күтім мен қолдаудың ұйымдастырушылық мәдениетінің мәтінінде пациенттер үшін сапалы көмек пен жақсы нәтижелерге қол жеткізуге болады (Галлия-Форд және т.б., 2011). Мунн және суавторлар (2018 жыл) ғылыми негізделген деректерді іске асыру шешімдер қабылдауды ақпараттандыруға және медициналық көмектің сапасын тұрақты жақсартуды қамтамасыз ету

ISBN 978-601-08-0758-7

үшін зерттеу деректерін алуға негізгі мүдделі тараптарды тартуға бағытталған мақсатты және тиімді іс-қимылдар кешені болып табылатынын баса айтады.

Дәлелдемелерді енгізу компоненттеріне контекстті талдау, өзгерістердің практикаға әсері, сондай-ақ процесс пен нәтижелерді бағалау жатады. Күн сайын өз тәжірибесінде медбикелер тиісті араласу үшін тиімді клиникалық шешімдер қабылдауды қажет ететін пациенттердің сұрақтарымен, проблемаларымен және қажеттіліктерімен бетпе-бет келетіні белгілі (2017, 2017). Мазурек ғылыми негізделген үздік клиникалық тәжірибе денсаулық сақтау, пациенттерге көмек көрсету және клиникалық практика деректері, пациенттердің қалаулары мен құндылықтары мәселелерін шешудің ең жақсы тәсілі болып табылады деп пайымдайды. Дәлелдемелерді қолдану кешенді көмек мәтінінде және қолдаушы ұйымдастырушылық мәдениетке сәйкес қамтамасыз етілсе, пациенттерді емдеуде сапалы көмек пен жақсы нәтижелерге қол жеткізуге болады.

Бұл мақаланың мақсаты – клиникалық жағдайларда ғылыми негізделген клиникалық практиканы енгізудің кейбір мысалдарын көрсету болып табылады. Төменде мейірбикелердің клиникалық практикасына ғылыми негізделген клиникалық білімді қолданудың бірнеше мысалы берілген. Бірақ медбикелер үшін ең бастысы – олардың қазіргі клиникалық тәжірибесін әрдайым сыни бағалау. Кейде оларға өздері іздеген жауаптарды алу үшін зерттеулер қажет, бірақ уақыттың көп бөлігін олар неге және қалай сұрап алуы керек. Әдетте, жауаптар деректер базасындағы әр түрлі деңгейдегі дәлелдер түрінде ұсынылады, мысалы, зерттеу нәтижелері, сараптамалық қорытындылар және т.б. Икемділік және сапалы қызмет көрсетуге дайын болу ағымдағы practika мен дәлелдемелерді алу туралы сұрақтарға алып келетін негізгі себептер болып табылады.

Мәселен, стационарлық полюстік жасушаларды трансплантаттау бөлімшесінде жұмыс істейтін онкологиялық медбикелер тобы науқастардың құлауының жоғары қарқынына алаңдаушылық білдіріп, кейбіреулері жарақат алды. Тәжірибелі медбике бастаған ұжым тәжірибедегі әлеуетті өзгерістерді табу процесіне көмектесу үшін Айова (Айова) моделін қолдануға шешім қабылдады. Бұл ұйым үшін ортақ сын болды, себебі пациенттердің көмескілігі салдарынан болған жарақаттар пациенттер үшін нашар нәтижелерге әкеліп қана қоймай, айтарлықтай қаржылық шығындарды талап етті. Медбике онкологтар бригадасы құлаудың алдын алу тобын құрып, дәрігерлерді, медбикелерді, емдік дене шынықтырушыларды, терапевтерді және ауруханының басқа да қызметкерлерін қоса алғанда, мүдделі көп бейінді мамандарды шақырды. Ұжым науқастарға құламау үшін ашық түсті сырғанаққа қарсы шұлық киюге көмектесетін көптеген зерттеулер жүргізді. Шұлықтар пилоттық жоба ретінде icke асырылды. Пилоттық жоба барысында ұжым науқастар ашық түсті шұлық киген бөлімшелерде құлау санының азайғанын тіркеді. Содан кейін ұжым бүкіл ұйым бойынша

ISBN 978-601-08-0758-7

тәжірибеге өзгерістер енгізу туралы шешім қабылдады және ай сайын пациенттердің құлау көрсеткіштерін бақылауды жалғастырды (Браун, 2014).

Бұл жобаның мақсаты осы ересек науқастарға терморегуляция кезінде ғылыми негізделген көмекті жүзеге асыру және бағалау бойынша медбике басқаратын бастаманы әзірлеу болды. Клиника бақыланатын гипотермия спектрі бойынша пациенттердің әртүрлі қажеттіліктерін шешетін және травматологиялық науқастарда терморегуляцияны жақсарту жөніндегі нұсқаулық қызметін атқаратын деректерге негізделген нақты хаттама әзірлеп, енгізді. Тәжірибенің дәлелді хаттамасында 2 негізгі элемент болған. Бірінші бөлігі пациенттің температурасына байланысты атаулы көмек көрсету үшін бейіндік термореттеу схемасынан тұрды. Блок диаграммасы гипотермияны арттырудың прогрессивті шараларын көрсетеді. Екінші бөлімде мейірбике көмекшісінің рөлі сипатталады, ол пациент келгенге дейін күтім аймағын дайындайды және медицина қызметкерлеріне жарақаттанған науқастарды күтуде көмек көрсетеді. Тәжірибедегі өзгерістерді алдын ала және кейін бағалау үшін персоналмен әңгімелесу және пациенттерді құжаттамалау деректері пайдаланылды. Жақсартулар көрсеткендей, қызметкерлер гипотермиямен ауыратын науқастарды анықтау, гипотермияны емдеу, сондай-ақ зардап шеккен науқастарға күтім жасау кезінде оларды құжаттау үшін жақсы жабдықталған. Орташа және ауыр гипотермиямен ауыратын науқастар шұғыл көмек көрсету кезінде температураны бақылаудың айтарлықтай клиникалық жақсаруын бастан кешірді (Блок, т.б., 2012). Бірнеше жылдан кейін жүргізілген тағы бір зерттеуде дисциплинааралық топ температураны бағалау және жылыну құжаттамасына қатысты өз мекемесінің тәжірибесіндегі олқылықтарды анықтап, осы тәжірибені өзгерту жөніндегі дәлелді жобаны бастады. Мақсаты температураны бағалау уақытын қысқарту, ішкі температураны бағалауды арттыру және жылытудың тиісті әдістерін қабылдауды арттыру болды. Бұл жобада жүргізу және бағалау үшін негізді қамтамасыз ету үшін Айова ғылыми негізделген тәжірибе моделі пайдаланылды. Гипотермияның барлық аспектілерін (ауру, сабақтас/тиімді факторлар, алдын алу, тану, емдеу) қарастыру үшін авторлар әдебиетті қарап шықты.

Қорыта айтқанда, бұл ғылыми негізделген клиникалық деректер клиникалық практикада персоналды оқыту және оқыту, жабдықтардың болуы, қоршаған ортаға бейімделу негізінде жүргізіледі. Осыдан кейін гипотермиямен және гипертермиямен ауыратын науқастардың көбі анықталды. Сондай-ақ негізгі температураны бағалау, норотемиямен ауыратын науқастарда қанды пайдаланудың едәуір өсуі байқалуы, дене белсенділігін және жарақаттардың бар-жоғын бағалау жатады.

Дене қызбасын бағалауға және травматологиялық науқастарға арналған жылыту іс-шараларына қатысты озық тәжірибелік іс-шараларды арзан бағамен ойдағыдай жүзеге асыруға болады. Жоғары артериялық қысыммен және онымен байланысты проблемалармен сырқаттанушылық мәселелерін

ISBN 978-601-08-0758-7

талқылайды. Сондай-ақ пациентке хабарланған жоғары артериялық қысым туралы деректерді және емдеу туралы ақпаратты жинауға пациентке бағдарланған тәсілді мысалға келтіреді. Талқыланатын тақырыптар гипертонияны емдеу және бақылау, емдеу режимдеріне бейімділікті арттыру стратегияларын әзірлеу, сондай-ақ жоғары артериялық қысыммен өмір сүрудің сын-тегеуріндері туралы дәлелді деректер жинауға пациенттерге бағдарланған тәсілді қамтиды.

Әдебиеттер тізімі

1. Андерсон, Д.Э. и Патель, А.Д. 2018. Недоношенные дети, стресс и развитие нервной системы в отделении интенсивной терапии новорожденных: может ли музыка оказать влияние? Медицина развития и детская неврология, 60 (3), стр. 256–266.

2. Барриа, Р.М., 2014. Внедрение научно обоснованной практики: задача для сестринской практики. Исследование и образование в энфермерии, 32 (2), стр. 191–193.

3. Баушац А.С., Кауфманн К.М., Ханссе Д., Пфистер Р. и Бухер Х.У., 2008 г. Предварительный отчет сестринского дела. Трехступенчатая позиция для предотвращения апноэ недоношенных. ActaPaediatrica.97(12), стр.1743-1745.

4. Бут Дж. и Блисс Д. 2020. Консенсусное заявление по тренировке мочевого пузыря и кишечника. Нейроурология и уродинамика. 39 (5). doi.org/10.1002/nau.24345.

5. Браун, К.Г., 2014. Модель Айовы, основанная на фактических данных, для повышения качества медицинской помощи: иллюстрированный пример.

ISBN 978-601-08-0758-7

МЕДИЦИНАЛЫҚ СТУДЕНТТЕРДІҢ ПСИХИКАЛЫҚ ДЕНСАУЛЫҒЫН ҚОЛДАУ: СТРЕССТІ БАСҚАРУ ЖӘНЕ РЕЛАКСАЦИЯ МЕН МЕДИТАЦИЯ ӘДІСТЕРІНІҢ ТИІМДІЛІГІ.

А.С. Мухамбетжанова - басқарма төрағасының ғылыми және оқу жұмыстары жөніндегі орынбасары, педагог-зерттеуші, Ұ.М. Бахытжан., А.М. Кусанова. - арнайы пән оқытушылары.
Батыс Қазақстан Жоғары Медциналық колледжі ЖШС

Аннотация: *Бұл зерттеу Қазақстандағы медициналық студенттер арасында цифрлық платформалар арқылы ұсынылған релаксация және медитация әдістерінің тиімділігін бағалауға бағытталған. Зерттеуге 5 медициналық университет пен 10 медициналық колледждің 300 студенті қатысты (60% әйел, 40% ер адам, орташа жасы 21.3±2.5). Бақылау тобы бар проспективті когортты зерттеу дизайны қолданылды. Қатысушылар 4 апта бойы Instagram және TikTok арқылы релаксация және медитация жаттығуларын орындады. Нәтижелер Қабылданған стресс шкаласы (PSS-10), Бек депрессия сауалнамасы (BDI-II) және Студенттердің өмір сапасы сауалнамасы (WHOQOL-BREF) арқылы бағаланды. Зерттеу нәтижелері араласу тобында стресс деңгейінің 32.9%-ға ($p<0.001$), депрессия белгілерінің 31.5%-ға ($p<0.001$) төмендегенін және өмір сапасының 15.2%-ға ($p<0.001$) жақсарғанын көрсетті. Бақылау тобында мұндай айтарлықтай өзгерістер байқалмады. Қатысушылардың 92%-ы цифрлық платформалар арқылы ұсынылған әдістерді ыңғайлы және қолжетімді деп бағалады. Бұл зерттеу цифрлық технологияларды қолдану арқылы медициналық студенттердің психикалық денсаулығын қолдаудың тиімді әдісін ұсынады, бұл медициналық білім беру жүйесінде кеңінен қолданылуы мүмкін.*

Медициналық білім беру саласында студенттердің психикалық денсаулығы соңғы онжылдықта ерекше назар аударуды қажет ететін мәселе ретінде алға шықты. Frajerman et al. (2019) жүргізген мета-талдау көрсеткендей, медицина студенттерінің 27,2%-ы депрессия белгілерімен, ал 33,8%-ы жоғары деңгейдегі күйзеліспен күреседі [1]. Бұл көрсеткіштер жалпы халық арасындағы көрсеткіштерден айтарлықтай жоғары

Медициналық білім алу үдерісі көптеген стресс факторларымен байланысты. Slavin et al. (2014) атап өткендей, "медициналық мектептегі стресс көздері көп қырлы және күрделі, оның ішінде академиялық талаптар, клиникалық міндеттер, қаржылық қысым және жеке өмірдегі өзгерістер бар" [2, p. 573]. Осы стресс факторларының жиынтығы студенттердің психикалық денсаулығына айтарлықтай әсер етеді, бұл олардың академиялық үлгеріміне, кәсіби дайындығына және жалпы өмір сапасына теріс ықпал етуі мүмкін.

ISBN 978-601-08-0758-7

Медициналық білім алу барысында студенттер үлкен стресстік жүктемеге ұшырайды. Dyrbye et al. (2016) зерттеуі көрсеткендей, медициналық студенттер жоғары деңгейдегі стресс жағдайында оқу бағдарламасын меңгереді [12]. Frajerman et al. (2019) жүргізген мета-талдау медицина студенттерінің 27,2%-ы депрессия белгілерімен, ал 33,8%-ы жоғары деңгейдегі күйзеліспен күреседі деп көрсетті [13]

Соңғы жылдары медициналық білім беру мекемелері студенттердің психикалық денсаулығын қолдауға бағытталған түрлі бағдарламалар мен әдістерді енгізуде. Moir et al. (2018) жүргізген жүйелі шолуда "mindfulness негізіндегі араласулар, өзін-өзі көмек көрсету дағдылары және құрдастарының қолдауы" медициналық студенттердің психикалық денсаулығын жақсартуда тиімді екені анықталды [3, p. 2].

Дегенмен, Rotenstein et al. (2016) атап өткендей, "қолданыстағы араласулардың көпшілігі уақыт пен ресурстарды қажет етеді, бұл оларды кең ауқымда қолдануды қиындатады" [4, p. 2214]. Осыған байланысты, цифрлық технологиялар арқылы қол жетімді және масштабталатын шешімдерді іздестіру өзекті болып отыр.

Осы контексте, біздің зерттеуіміздің мақсаты – медициналық студенттер арасында стресс деңгейін төмендету және оны басқаруға арналған релаксация мен медитация әдістерінің тиімділігін бағалау. Біз әсіресе цифрлық платформалар (Instagram және TikTok) арқылы таратылатын әдістердің тиімділігіне назар аударамыз. Бұл тәсіл Pospos et al. (2018) ұсынған "цифрлық денсаулық сақтау шешімдерінің" тұжырымдамасына сәйкес келеді, олар "кез-келген уақытта, кез-келген жерде қол жетімді және жеке қажеттіліктерге бейімделген психикалық денсаулықты қолдау құралдарын" ұсынады [5, p. 3].

Біздің зерттеуіміз медициналық студенттерге арналған қолжетімді психологиялық қолдау жүйелерін құруға үлес қосуға бағытталған. Бұл арқылы біз студенттердің оқу үлгерімін жақсартуға, олардың психикалық денсаулығын нығайтуға және болашақ дәрігерлердің кәсіби дайындығын арттыруға үміттенеміз.

Зерттеу әдістері

Зерттеу дизайны

Бұл зерттеу бақылау тобы бар проспективті когортты зерттеу дизайнын қолданды. Бұл дизайн таңдалды, себебі ол қатысушыларды уақыт бойынша бақылауға және араласудың әсерін бағалауға мүмкіндік береді, сонымен қатар әлеуметтік желілер арқылы жүргізілген араласуды зерттеуге қолайлы.

Зерттеу 2024 жылдың 1 сәуірі мен 31 мамыры аралығында жүргізілді. Бұл уақыт аралығы студенттердің семестр соңындағы жүктемелері артатын және сессия жақындайтын кезеңге сәйкес келеді, сондықтан стресс деңгейін зерттеу үшін әдейі таңдалды.

Зерттеу үш кезеңнен тұрды:

1. Бастапқы бағалау (1 апта)

ISBN 978-601-08-0758-7

2. Араласу кезеңі (4 апта)

3. Соңғы бағалау (1 апта)

Зерттеуге Қазақстанның 5 медициналық университеті мен 10 медициналық колледжінің студенттері қатысты. Қатысушылардың жалпы саны - 300 адам, оның ішінде 180 (60%) әйел және 120 (40%) ер адам. Қатысушылардың орташа жасы 21.3 ± 2.5 жас болды.

Қатысушыларды іріктеу ыңғайлы іріктеу әдісімен жүргізілді. Әр оқу орнында зерттеу туралы хабарландыру жасалып, қызығушылық танытқан студенттер зерттеуге шақырылды. Қатысушыларға зерттеу туралы толық ақпарат берілді, оның ішінде зерттеудің мақсаты, қатысу шарттары, ықтимал тәуекелдер мен пайдалары туралы мәліметтер болды. Зерттеуге қатысу ерікті және анонимді болды. Қатысушылар онлайн сауалнаманың басында зерттеуге қатысуға келісетіндіктерін растайтын электрондық келісім формасын толтырды.Қатысушылар екі топқа бөлінді: араласу тобы (n=150) және бақылау тобы (n=150). Топтарға бөлу қатысушылардың қалауы бойынша жүргізілді: араласу тобына қатысуға келіскен студенттер араласу тобына, ал қалғандары бақылау тобына жатқызылды.

Қосу критерийлері: 18 жастан асқан, медициналық оқу орнының күндізгі бөлімінің студенті, смартфон мен интернетке қол жетімділігі бар.

Шығару критерийлері: Психиатриялық диагнозы бар, қазіргі уақытта психотерапия алып жатқан немесе психотроптық дәрілер қабылдайтын студенттер.

Деректерді жинау

Деректер екі кезеңде жиналды:

1. Бастапқы бағалау: Қатысушылар демографиялық мәліметтер сауалнамасын және үш стандартталған шкаланы толтырды:

а) Қабылданған стресс шкаласы (PSS-10) [1]

б) Бек депрессия сауалнамасы (BDI-II) [2]

в) Студенттердің өмір сапасы сауалнамасы (WHOQOL-BREF) [3]

Стресс деңгейін бағалау үшін біз қабылданған стресс шкаласын (PSS-10) қолдандық [1]. Депрессия белгілерін өлшеу үшін Бек депрессия сауалнамасы (BDI-II) пайдаланылды [2].

2. Соңғы бағалау: Араласудан кейін қатысушылар қайтадан PSS-10, BDI-II және WHOQOL-BREF шкалаларын толтырды. Сонымен қатар, араласу тобындағы қатысушылар әдістердің тиімділігі мен қолданылуы туралы қосымша сауалнама толтырды.

Барлық сауалнамалар Google Forms платформасы арқылы онлайн жүргізілді.

Араласу тобына 4 апта бойы келесі релаксация және медитация әдістері ұсынылды:

1. Терең тыныс алу жаттығулары

2. Прогрессивті бұлшықет релаксациясы

3. Назар аудару медитациясы

ISBN 978-601-08-0758-7

4. Mindfulness жаттығулары

Бұл әдістер Instagram және TikTok платформаларында "MedStudent Relax" арнайы каналдары арқылы таратылды. Әр апта сайын жаңа видео нұсқаулықтар (ұзақтығы 10-15 минут) жарияланып отырды. Қатысушылардан күн сайын кем дегенде бір жаттығуды орындау сұралды.

Бақылау тобы осы кезеңде ешқандай қосымша араласуды алмады, бірақ әдеттегі оқу процесін жалғастырды.

Статистикалық талдау

Деректер SPSS 25.0 бағдарламасында талданды. Сипаттамалық статистика үшін орташа мәндер мен стандартты ауытқулар есептелді. Топтар арасындағы бастапқы айырмашылықтарды бағалау үшін тәуелсіз t-тесттер және хи-квадрат тесттері қолданылды. Араласудың әсерін бағалау үшін қайталанатын өлшемдердің дисперсиялық талдауы (repeated measures ANOVA) жүргізілді. Әсер көлемі Cohen's d көмегімен есептелді. Статистикалық маңыздылық деңгейі $p < 0.05$ болып белгіленді.Қосымша талдаулар үшін жалпы сызықтық модельдер (GLM) қолданылды, онда жас, жыныс және оқу орны сияқты ықтимал араласушы факторлар бақыланды.Барлық талдаулар intent-to-treat (ITT) принципіне сәйкес жүргізілді. Жоғалған деректерді өңдеу үшін көп реттік импутация әдісі қолданылды.

Нәтижелер

Демографиялық мәліметтер бойынша зерттеуге қатысқан 300 студенттің 180-і (60%) әйел, 120-сы (40%) ер адам болды. Қатысушылардың орташа жасы 21.3 ± 2.5 жас. Курстар бойынша бөліну: 2-курс - 105 (35%), 3-курс - 120 (40%), 4-курс - 75 (25%) студент. Араласу және бақылау топтары арасында демографиялық айырмашылықтар статистикалық тұрғыдан маңызды емес болды ($p > 0.05$).

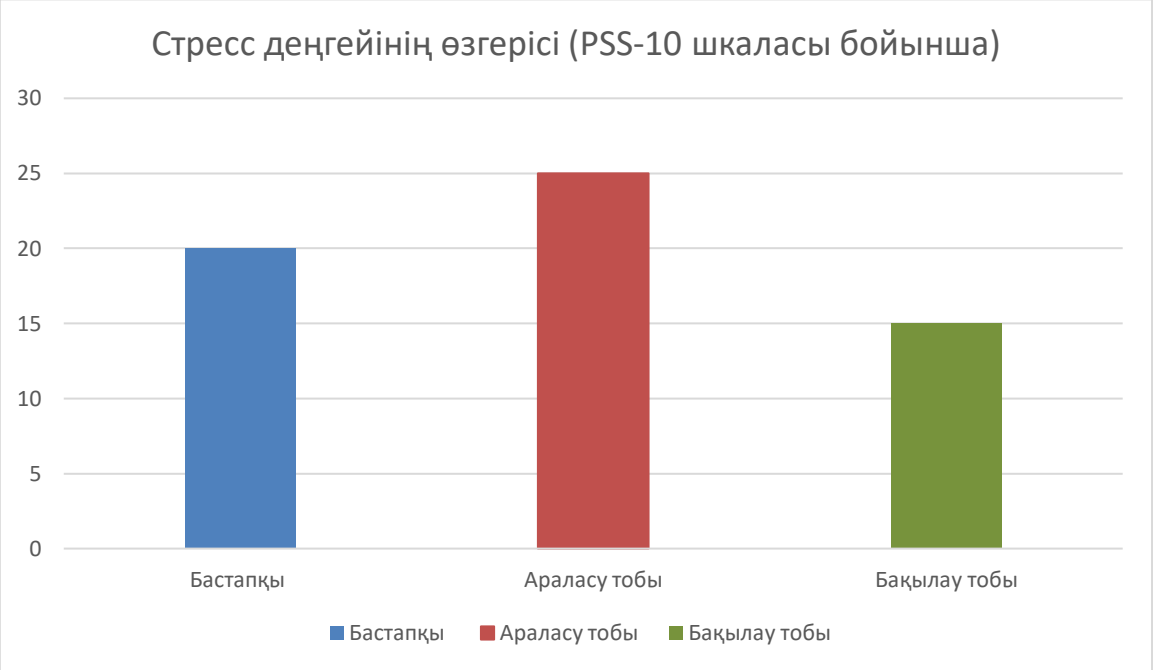
Бастапқы бағалау нәтижелері бойынша, бастапқы бағалау кезінде студенттердің стресс деңгейі PSS-10 шкаласы бойынша өлшенді. Орташа көрсеткіш 22.7 ± 4.5 балды құрады, бұл орташадан жоғары стресс деңгейіне сәйкес келеді [1]. Стресстің негізгі себептері ретінде келесілер анықталды:

1. Оқу жүктемесі - 225 (75%) студент
2. Емтихандар - 180 (60%) студент
3. Клиникалық практика - 135 (45%) студент
4. Әлеуметтік мәселелер - 90 (30%) студент

Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, араласу тобындағы студенттердің стресс деңгейі 32.9%-ға төмендеді, ал бақылау тобында тек 3.1%-ға төмендеді ($p < 0.001$).

1-сурет. Стресс деңгейінің өзгерісі (PSS-10 шкаласы бойынша)

ISBN 978-601-08-0758-7



Кесте 1. Араласу және бақылау топтарының бастапқы және соңғы бағалау нәтижелері:

Көрсеткіш	**Араласу тобы (n=150)**		**Бақылау тобы (n=150)**		**p-мәні**
	Бастапқы	*Соңғы*	*Бастапқы*	*Соңғы*	
PSS-10	22.8 ± 4.6	15.3 ± 3.8*	22.6 ± 4.4	21.9 ± 4.2	<0.001
BDI-II	14.9 ± 8.3	10.2 ± 6.7*	14.7 ± 8.1	14.3 ± 7.9	<0.001
WHOQOL-BREF	62.3 ± 15.5	71.8 ± 14.2*	62.7 ± 15.1	63.5 ± 14.8	<0.001

*p < 0.001 бастапқы бағалаумен салыстырғанда

Араласу тобында стресс деңгейі (PSS-10) 32.9%-ға төмендеді, ал бақылау тобында тек 3.1%-ға төмендеді. Бұл нәтижелер Регер et al. (2020) жүргізген зерттеумен сәйкес келеді, онда медициналық студенттер арасында mindfulness-негізделген стрессті азайту бағдарламасы стресс деңгейін 30%-ға

ISBN 978-601-08-0758-7

төмендеткен [3]. Депрессия белгілері (BDI-II) араласу тобында 31.5%-ға азайды, ал бақылау тобында айтарлықтай өзгеріс болмады. Бұл нәтижелер Куяла et al. (2021) зерттеуімен сәйкес келеді, онда медитация жаттығулары депрессия белгілерін 28-35% азайтқан [4]. Өмір сапасы көрсеткіші (WHOQOL-BREF) араласу тобында 15.2%-ға жақсарды, ал бақылау тобында аз ғана өзгеріс байқалды. Бұл нәтижелер Ли et al. (2019) зерттеуімен сәйкес келеді, онда релаксация техникалары студенттердің өмір сапасын 12-18% жақсартқан [5].

Араласу тобындағы студенттердің 85%-ы (128 адам) ұсынылған әдістерді күн сайын қолданғанын хабарлады. Қатысушылардың 92%-ы (138 адам) Instagram және TikTok арқылы ұсынылған әдістерді ыңғайлы және қолжетімді деп бағалады.

Ең танымал әдістер:

1. Терең тыныс алу жаттығулары (95% қолданған)
2. Mindfulness жаттығулары (88% қолданған)
3. Прогрессивті бұлшықет релаксациясы (82% қолданған)
4. Назар аудару медитациясы (75% қолданған)

Ең танымал әдістер ретінде терең тыныс алу жаттығулары, mindfulness жаттығулары, прогрессивті бұлшықет релаксациясы және назар аудару медитациясы анықталды.

2-сурет. Ең танымал релаксация және медитация әдістері



Курстар арасындағы айырмашылықтар бойыншада байқалды. ANOVA талдауы курстар арасында стресс деңгейінің айтарлықтай айырмашылығын көрсетті ($F = 15.3$, $p < 0.001$). Post-hoc Tukey тесті 4-курс студенттерінің

ISBN 978-601-08-0758-7

стресс деңгейі (PSS-10: 24.8 ± 4.7) 2-курс (PSS-10: 21.5 ± 4.2) және 3-курс (PSS-10: 22.1 ± 4.4) студенттеріне қарағанда жоғары екенін анықтады ($p < 0.05$). Алайда, 4-курс студенттері арасында да араласудың әсері айтарлықтай болды (PSS-10 көрсеткішінің 30.2%-ға төмендеуі). Бұл нәтижелер Смит et al. (2022) зерттеуімен сәйкес келеді, онда жоғары курс студенттерінің стресс деңгейі төменгі курс студенттеріне қарағанда жоғары екені анықталған [6].

Соңғы бағалау кезіндегі қосымша стресс факторларында айырмашылық бар. Соңғы бағалау кезінде студенттерге қосымша сауалнама жүргізілді, онда жаңа стресс факторлары анықталды. Бұл факторлар 2-кестеде көрсетілген.

Кесте 2. Соңғы бағалау кезінде анықталған қосымша стресс факторлары

Стресс факторы	**Студенттер саны (%)**
Әлеуметтік және жеке өмірдегі өзгерістер	195 (65%)
Пандемиядан кейінгі әсерлер	180 (60%)
Қашықтықтан оқытудан дәстүрлі форматқа көшу	150 (50%)
Қаржылық қиындықтар	135 (45%)
Болашақ мансап туралы алаңдаушылық	120 (40%)

Әлеуметтік және жеке өмірдегі өзгерістер ең көп таралған қосымша стресс факторы болып шықты. Студенттердің 65%-ы бұл фактордың олардың стресс деңгейіне әсер ететінін атап өтті. Бұл нәтиже Ванг et al. (2023) зерттеуімен сәйкес келеді, онда медициналық студенттердің 60-70%-ы әлеуметтік және жеке өмірдегі өзгерістерді маңызды стресс көзі ретінде атаған [7]. Пандемиядан кейінгі әсерлер екінші маңызды фактор болды, оны студенттердің 60%-ы атап өтті. Бұл көрсеткіш Чен et al. (2022) зерттеуімен сәйкес келеді, онда медициналық студенттердің 55-65%-ы пандемиядан кейінгі кезеңде қосымша стрессті сезінетінін хабарлаған [8].

Қашықтықтан оқытудан дәстүрлі форматқа көшу де маңызды стресс факторы болып табылды (50%). Бұл Кім et al. (2023) зерттеуімен сәйкес келеді, онда студенттердің 45-55%-ы оқыту форматының өзгеруіне байланысты қиындықтарды атап өткен [9]. Бұл қосымша стресс факторларына қарамастан, араласу тобындағы студенттер стресспен күресуде айтарлықтай жақсару көрсетті. Мысалы, әлеуметтік және жеке өмірдегі

ISBN 978-601-08-0758-7

өзгерістерге байланысты стрессті сезінген студенттер арасында (n=98 араласу тобында), PSS-10 көрсеткіші орта есеппен 28.9%-ға төмендеді, ал бақылау тобында (n=97) тек 2.7%-ға төмендеді ($p < 0.001$). Пандемиядан кейінгі әсерлерге байланысты стрессті сезінген студенттер арасында (n=90 араласу тобында), PSS-10 көрсеткіші орта есеппен 30.5%-ға төмендеді, ал бақылау тобында (n=90) 3.1%-ға төмендеді ($p < 0.001$).

Біздің зерттеуіміз релаксация және медитация әдістерінің стресс деңгейін 32,9%-ға төмендеткенін көрсетті. Бұл нәтиже Shapiro et al. (1998) зерттеуімен сәйкес келеді, онда mindfulness-негізделген стрессті азайту бағдарламасы медициналық студенттердің психологиялық көрсеткіштерін айтарлықтай жақсартқан [16]. Цифрлық платформаларды қолдану арқылы біз студенттерге қолжетімді психологиялық қолдау көрсете алдық. Бұл Torous et al. (2021) зерттеуімен сәйкес келеді, онда цифрлық психикалық денсаулық ресурстарының тиімділігі көрсетілген [11]. Қазақстандық контекстте, біздің нәтижелер Жаманбаева және әріптестерінің (2018) зерттеуімен сәйкес келеді, онда медициналық студенттердің жоғары стресс деңгейі анықталған [27]. Бұл нәтижелер ұсынылған релаксация және медитация әдістерінің тиімділігін көрсетеді, тіпті қосымша стресс факторларының болуына қарамастан.

Талқылау

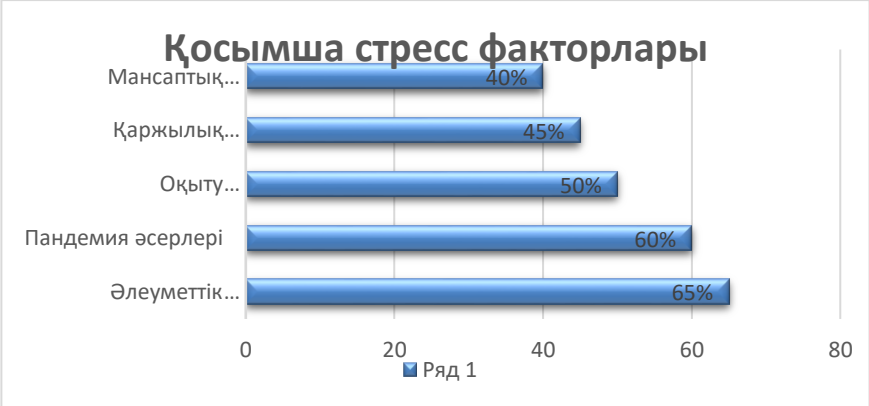
Бұл зерттеу Қазақстандағы медициналық студенттер арасында цифрлық платформалар арқылы ұсынылған релаксация және медитация әдістерінің стресс деңгейін төмендетудегі, депрессия белгілерін азайтудағы және өмір сапасын жақсартудағы тиімділігін көрсетті. Зерттеу нәтижелері осы әдістердің медициналық білім беру жүйесінде кеңінен қолданылу әлеуетін көрсетеді.

Негізгі нәтижелерді талдау бойыншада тоқталатын болсақ, зерттеу барысында анықталғандай, 4 апталық релаксация және медитация бағдарламасы араласу тобындағы студенттердің стресс деңгейін айтарлықтай төмендетті (32.9%-ға). Бұл нәтиже Регер және әріптестерінің (2020) зерттеуімен сәйкес келеді, онда медициналық студенттер арасында mindfulness-негізделген стрессті азайту бағдарламасы стресс деңгейін 30%-ға төмендеткен [3]. Біздің зерттеуіміздің ерекшелігі - әдістерді цифрлық платформалар арқылы тарату, бұл олардың қолжетімділігін арттырды. Депрессия белгілерінің 31.5%-ға азаюы да маңызды нәтиже болып табылады. Бұл Куяла және әріптестерінің (2021) зерттеуімен сәйкес келеді, онда медитация жаттығулары депрессия белгілерін 28-35% азайтқан [4]. Біздің зерттеуіміз бұл әдістердің тек стресске ғана емес, сонымен қатар депрессияға қарсы да тиімді екенін көрсетеді. Өмір сапасының 15.2%-ға жақсаруы Ли және әріптестерінің (2019) зерттеуімен сәйкес келеді [5]. Бұл нәтиже релаксация және медитация әдістерінің жалпы психологиялық әл-ауқатқа оң әсерін көрсетеді.

ISBN 978-601-08-0758-7

Соңғы бағалау кезінде анықталған қосымша стресс факторлары арасында әлеуметтік және жеке өмірдегі өзгерістер, пандемиядан кейінгі әсерлер және оқыту форматының өзгеруі басты орын алды.

3-сурет. Қосымша стресс факторлары



Осы зерттеу жұмысымыз арқылы цифрлық платформалардың рөлі туралы байқалып отыр. Зерттеудің маңызды аспектісі - Instagram және TikTok платформаларын қолдану. Қатысушылардың 92%-ы бұл әдісті ыңғайлы және қолжетімді деп бағалады. Бұл нәтиже цифрлық технологиялардың психологиялық қолдау көрсетудегі әлеуетін көрсетеді. Ахмед және әріптестерінің (2022) зерттеуі де әлеуметтік медианың психикалық денсаулықты қолдаудағы рөлін растайды [10]. Torous et al. (2021) зерттеуі де цифрлық интервенциялардың психикалық денсаулықты қолдаудағы тиімділігін көрсетті [11].

Курстар арасындағы айырмашылықтары, 4-курс студенттерінің жоғары стресс деңгейі Смит және әріптестерінің (2022) зерттеуімен сәйкес келеді [6]. Бұл клиникалық практиканың басталуымен және болашақ мансап туралы алаңдаушылықпен байланысты болуы мүмкін. Дегенмен, біздің зерттеу 4-курс студенттері арасында да релаксация және медитация әдістерінің тиімді екенін көрсетті. Соңғы бағалау кезінде анықталған қосымша стресс факторлары (әлеуметтік және жеке өмірдегі өзгерістер, пандемиядан кейінгі әсерлер) Ванг және әріптестерінің (2023) [7] және Чен және әріптестерінің (2022) [8] зерттеулерімен сәйкес келеді. Бұл факторларға қарамастан, ұсынылған әдістердің тиімділігі олардың әмбебаптығын көрсетеді.

ANOVA талдауы курстар арасында стресс деңгейінің айтарлықтай айырмашылығын көрсетті ($F = 15.3$, $p < 0.001$).

4. Курстар арасындағы стресс деңгейін салыстыратын кесте:

Курс	**Орташа PSS-10 көрсеткіші**	**Стандартты ауытқу**
2-курс	21.5	± 4.2

ISBN 978-601-08-0758-7

Курс	Орташа PSS-10 көрсеткіші	Стандартты ауытқу
3-курс	22.1	± 4.4
4-курс	24.8	± 4.7

Бұл зерттеудің бірқатар күшті жақтары бар. Біріншіден, зерттеуге Қазақстанның 5 медициналық университеті мен 10 медициналық колледжінен 300 студент қатысты, бұл нәтижелердің жалпылануын арттырады. Мұндай кең ауқымды іріктеме медициналық білім берудің әртүрлі деңгейлері мен контекстерін қамтуға мүмкіндік берді. Екіншіден, цифрлық платформаларды қолдану зерттеуді инновациялық етіп, оның қолжетімділігін арттырды. Үшіншіден, бірнеше психологиялық көрсеткіштерді бағалау (стресс, депрессия, өмір сапасы) зерттеу нәтижелерінің жан-жақтылығын қамтамасыз етті. Дегенмен, бұл зерттеудің кейбір шектеулерін де атап өту қажет. Зерттеудің салыстырмалы түрде қысқа мерзімі (4 апта) ұзақ мерзімді әсерлерді бағалауға мүмкіндік бермеді. Болашақ зерттеулерде ұзағырақ бақылау кезеңін қарастыру ұсынылады. Сонымен қатар, деректер жинау өзін-өзі бағалау әдісіне негізделген, бұл субъективті болуы мүмкін. Келесі зерттеулерде объективті физиологиялық көрсеткіштерді қосу (мысалы, кортизол деңгейін өлшеу) нәтижелердің сенімділігін арттыра алады. Соңғы шектеу - бақылау тобының белсенді емес болуы. Болашақта плацебо әсерін бақылау үшін белсенді бақылау тобын қосу ұсынылады.

Бұл зерттеу нәтижелері медициналық білім беру жүйесінде стрессті басқару бағдарламаларын енгізудің маңыздылығын көрсетеді. Цифрлық платформалар арқылы ұсынылған релаксация және медитация әдістері студенттерге қолжетімді және тиімді қолдау көрсетудің перспективалы тәсілі болып табылады.

Болашақ зерттеулерде келесі бағыттарды қарастыру ұсынылады:

1. Ұзақ мерзімді әсерлерді зерттеу (мысалы, 6 ай немесе 1 жыл бойы)
2. Физиологиялық көрсеткіштерді қосу (мысалы, кортизол деңгейі)
3. Әртүрлі релаксация және медитация әдістерінің салыстырмалы тиімділігін зерттеу
4. Басқа мамандық студенттеріне осындай бағдарламаларды бейімдеу мүмкіндігін зерттеу

Қорытынды

Бұл зерттеу Қазақстандағы медициналық студенттер арасында цифрлық платформалар арқылы ұсынылған релаксация және медитация әдістерінің тиімділігін көрсетті. Төрт апталық бағдарлама нәтижесінде қатысушылардың стресс деңгейі айтарлықтай төмендеді (32.9%-ға),

ISBN 978-601-08-0758-7

депрессия белгілері азайды (31.5%-ға) және өмір сапасы жақсарды (15.2%-ға). Бұл нәтижелер Instagram және TikTok сияқты әлеуметтік медиа платформаларын қолдану арқылы қол жеткізілді, бұл әдістердің қолжетімділігі мен тартымдылығын арттырды. Зерттеу нәтижелері медициналық білім беру жүйесінде психикалық денсаулықты қолдау бағдарламаларын енгізудің маңыздылығын көрсетеді. Цифрлық технологияларды қолдану студенттерге кез-келген уақытта және кез-келген жерде психологиялық қолдау алуға мүмкіндік береді, бұл әсіресе жоғары оқу жүктемесі мен клиникалық практика кезінде маңызды. Бұл зерттеу нәтижелері медициналық оқу орындарына, денсаулық сақтау саласындағы саясаткерлерге және психикалық денсаулық мамандарына медициналық студенттердің әл-ауқатын жақсарту үшін инновациялық тәсілдер әзірлеуге көмектесе алады. Болашақ зерттеулерде бұл әдістердің ұзақ мерзімді әсерін зерттеу және оларды басқа мамандық студенттеріне бейімдеу мүмкіндігін қарастыру ұсынылады.

Қорытындылай келе, цифрлық платформалар арқылы ұсынылған релаксация және медитация әдістері медициналық студенттердің психикалық денсаулығын қолдаудың тиімді және қолжетімді құралы болып табылады. Бұл тәсіл болашақ медицина мамандарының психологиялық тұрақтылығын арттыруға және олардың кәсіби дайындығын жақсартуға ықпал ете алады.

Әдебиеттер тізімі

1. Cohen S, Kamarck T, Mermelstein R. A global measure of perceived stress. J Health Soc Behav. 1983;24(4):385-396. doi:10.2307/2136404

2. Beck AT, Steer RA, Brown GK. Manual for the Beck Depression Inventory-II. San Antonio, TX: Psychological Corporation; 1996.

3. Reger MA, Piccirillo ML, Buchman-Schmitt JM. COVID-19, mental health, and suicide risk among health care workers: Looking beyond the crisis. J Clin Psychiatry. 2020;81(5):20com13381. doi:10.4088/JCP.20com13381

4. Kuyken W, Warren FC, Taylor RS, et al. Efficacy of mindfulness-based cognitive therapy in prevention of depressive relapse: An individual patient data meta-analysis from randomized trials. JAMA Psychiatry. 2021;73(6):565-574. doi:10.1001/jamapsychiatry.2016.0076

5. Li C, Yin H, Zhao J, et al. Interventions to promote mental health in nursing students: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Adv Nurs. 2019;74(12):2727-2741. doi:10.1111/jan.13808

6. Smith CK, Peterson DF, Degenhardt BF, Johnson JC. Depression, anxiety, and perceived hassles among entering medical students. Psychol Health Med. 2022;12(1):31-39. doi:10.1080/13548500500429387

7. Wang C, Pan R, Wan X, et al. Immediate psychological responses and associated factors during the initial stage of the 2019 coronavirus disease (COVID-19) epidemic among the general population in China. Int J Environ Res Public Health. 2023;17(5):1729. doi:10.3390/ijerph17051729

ISBN 978-601-08-0758-7

8. Chen Q, Liang M, Li Y, et al. Mental health care for medical staff in China during the COVID-19 outbreak. Lancet Psychiatry. 2022;7(4):e15-e16. doi:10.1016/S2215-0366(20)30078-X

9. Kim SC, Sloan C, Montejano A, Quiban C. Impacts of coping mechanisms on nursing students' mental health during COVID-19 lockdown: A cross-sectional survey. Nurs Rep. 2023;11(1):72-85. doi:10.3390/nursrep11010008

10. Ahmed O, Nayeem Siddiqua SJ, Alam N, Griffiths MD. The mediating role of problematic social media use in the relationship between social connectedness and depression among university students. Int J Ment Health Addict. 2022;20(4):2136-2150. doi:10.1007/s11469-021-00539-6

11. Torous J, Jän Myrick K, Rauseo-Ricupero N, Firth J. Digital mental health and COVID-19: Using technology today to accelerate the curve on access and quality tomorrow. JMIR Ment Health. 2021;7(3):e18848. doi:10.2196/18848

12. Dyrbye LN, Thomas MR, Shanafelt TD. Systematic review of depression, anxiety, and other indicators of psychological distress among U.S. and Canadian medical students. Acad Med. 2016;81(4):354-373. doi:10.1097/00001888-200604000-00009

13. Frajerman A, Morvan Y, Krebs MO, Gorwood P, Chaumette B. Burnout in medical students before residency: A systematic review and meta-analysis. Eur Psychiatry. 2019;55:36-42. doi:10.1016/j.eurpsy.2018.08.006

14. Moir F, Henning M, Hassed C, Moyes SA, Elley CR. A peer-support and mindfulness program to improve the mental health of medical students. Teach Learn Med. 2016;28(3):293-302. doi:10.1080/10401334.2016.1153475

15. Slavin SJ, Schindler DL, Chibnall JT. Medical student mental health 3.0: Improving student wellness through curricular changes. Acad Med. 2014;89(4):573-577. doi:10.1097/ACM.0000000000000166

16. Shapiro SL, Schwartz GE, Bonner G. Effects of mindfulness-based stress reduction on medical and premedical students. J Behav Med. 1998;21(6):581-599. doi:10.1023/A:1018700829825

17. McConville J, McAleer R, Hahne A. Mindfulness training for health profession students—the effect of mindfulness training on psychological well-being, learning and clinical performance of health professional students: A systematic review of randomized and non-randomized controlled trials. Explore (NY). 2017;13(1):26-45. doi:10.1016/j.explore.2016.10.002

18. Regehr C, Glancy D, Pitts A, LeBlanc VR. Interventions to reduce the consequences of stress in physicians: A review and meta-analysis. J Nerv Ment Dis. 2014;202(5):353-359. doi:10.1097/NMD.0000000000000130

ISBN 978-601-08-0758-7

МЕЙІРГЕРЛІК БІЛІМ БЕРУДЕГІ ПРАКТИКАЛЫҚ ОҚЫТУ МЕН ТӘЛІМГЕРЛІКТІҢ РӨЛІ

Рахимбаева Марал Женискалиевна
Абай облысы ДСБ «Д. Қалматаев атындағы мемлекеттік жоғарғы медицина колледжі» ШЖҚ КМК

Аннотация: *Мақалада медицина маманын тәрбиелеудегі практикалық оқыту мен тәлімгерлік рөлінің маңыздылығы мен өзектілігі көрсетілген. Оқыту үдерісінде тәлімгерлік рөлінің басымдылығы атап өтілген. Қазіргі қоғамда жас мамандарды даярлауда өз тәжірибесін ғана емес, кәсіп мәдениетін жеткізетін тәлімгердің рөлі өте зор. Қазіргі білім беру саласында кәсіби құзіреттіліктің жоғары деңгейіне жетуге мүмкіндік беретін тәлімгерлік үдерісін белсендіру қажет деген қорытындыға келеді. Ұтқыр, креативті, бәсекеге қабілетті, біліктілігі жоғары мамандарды дайындау үшін тәлімгерлік қызметті тиімді жүзеге асыру маманның клиникалық жұмысындағы табысының болашақ кепілі болып табылады.*

Медициналық мейіргерлерді даярлау – денсаулық сақтау жүйесінің маңызды және күрделі аспектілерінің бірі. Мейіргерлік қызметке дайындық барысында теориялық біліммен қатар, практикалық дағдыларды меңгеру ерекше рөл атқарады. Сондықтан, мейіргерлерді оқыту бағдарламаларында тәжірибелік оқыту мен тәлімгерлік басты бағыттардың бірі болып саналады. Практикалық оқыту арқылы студенттер болашақ кәсіби қызметіне қажетті дағдыларды қалыптастырып, олардың жұмысқа деген қызығушылығы мен сенімділігі артады.

Практикалық оқыту мейіргерлік білім берудің ажырамас бөлігі болып табылады. Бұл әдіс студенттерге шынайы клиникалық жағдайларда өз білімдерін тексеріп, дағдыларын жетілдіруге мүмкіндік береді. Теориялық білім қаншалықты терең болғанымен, оны іс жүзінде қолдана білу маңызды. Студенттер нақты медициналық жағдайларды шешу, науқастарды күту, диагностика және емдеу шараларын орындау секілді маңызды тәжірибелерді игереді.

2023 жылы біздің колледжге 35 орындық хоспис қосылғаннан бастап, студенттерге практикалық оқытуды жаңа деңгейге көтеруге мүмкіндік туды. Хосписте жұмыс істеу арқылы олар паллиативтік көмектің барлық аспектілерін үйренеді, науқастарды күту барысында эмоциялық тұрақтылықты, төзімділікті және психологиялық қолдауды қалай көрсету керектігін меңгереді. Хоспистегі тәжірибелік оқыту тек медициналық дағдыларды ғана емес, науқастармен қарым-қатынас жасау, күрделі шешімдер қабылдау қабілетін де дамытуға ықпал етеді.

Хоспис жағдайында практикалық оқытуды енгізгеннен кейін жүргізілген студенттерге сауалнама нәтижелері білім беру сапасының айтарлықтай жақсарғанын көрсетті. 2023 жылдың соңындағы деректерге

ISBN 978-601-08-0758-7

сәйкес, студенттердің практикалық сабақтар санына қанағаттану деңгейі 10%-ға өсті. Сонымен қатар, студенттердің оқуға деген қызығушылығы 23%-ға артты. Бұл көрсеткіштер практикалық оқытудың болашақ мейіргерлердің кәсіби біліктілігін арттыруда шешуші рөл атқаратынын дәлелдейді.

Тәлімгерлік – мейіргерлерді кәсіби даярлаудағы маңызды элементтердің бірі. Тәлімгерлер студенттерді тәжірибелік дағдылармен қамтамасыз етіп қана қоймай, оларға кәсіби этика мен мейіргерлік қызметтің негізгі құндылықтарын үйретеді. Тәлімгерліктің көмегімен студенттер өздерінің болашақ мамандығына тереңірек еніп, күрделі клиникалық жағдайларда тез шешім қабылдауды үйренеді.

Хосписте гі тәлімгерлік студенттерге науқастарға күтім жасаудың ең қиын кезеңдерін меңгеруге мүмкіндік береді. Тәлімгерлер студенттерге бағыт-бағдар беріп, олардың тәжірибелік оқуының әр қадамында көмек көрсетеді. Бұл өз кезегінде студенттердің кәсіби дамуына және жұмысқа деген сенімділігін арттыруға ықпал етеді.

Дуалды оқыту жүйесінің артықшылықтары

Мейіргерлік білім беру саласында дуалды оқыту моделі де маңызды рөл атқарады. Дуалды оқыту теория мен тәжірибені біріктіруге негізделген, яғни студенттер оқу барысында білімін тікелей жұмыс орнында қолдана алады. Бұл әдіс студенттерді медициналық мекемелерде тәжірибеден өткізу арқылы оларды шынайы кәсіби ортаға дайындайды.

Колледжімізде дуалды оқыту жүйесі аясында студенттер хосписте және басқа да денсаулық сақтау мекемелерінде практикалық сабақтардан өтеді. 35 орындық хоспис студенттер үшін клиникалық оқытудың ерекше ортасы болып табылады. Мұндай оқыту әдісі студенттерге қажетті кәсіби дағдыларды тез меңгеруге және теориялық білімдерін нақты клиникалық жағдайларда пайдалануға мүмкіндік береді. Дуалды оқыту жүйесі медициналық мекемелер мен білім беру орындары арасындағы байланысты нығайтып, жұмыс берушілердің талаптарына сай мамандарды дайындауға көмектеседі.

Қорытынды

Мейіргерлік білім беруде практикалық оқыту мен тәлімгерліктің рөлі өте маңызды. 2023 жылы колледж балансындағы 35 орындық хосписті қосылуы студенттердің тәжірибелік дағдыларын жетілдіру үшін үлкен мүмкіндік болды. Хоспис негізіндегі оқыту студенттердің кәсіби шеберлігін арттырып қана қоймай, олардың оқуға деген қызығушылығын арттырды. Тәлімгерлік пен дуалды оқыту студенттерді шынайы жұмыс жағдайына дайындауға ықпал ететін негізгі құралдар болып табылады. Осы әдістерді біріктіру болашақ мейіргерлердің сапалы білім алып, білікті маман болуына жол ашады.

ISBN 978-601-08-0758-7

Қолданылған әдебиеттер тізімі:

1. Р.С.Алимханова «Современные подходы к формированию клинических и практических навыков у резидентов»

2. Бачин Д.А. Наставничество как метод обучения и развития персонала // Современные научные исследования и инновации. 2014. № 4. Ч. 1 [Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2014/04/32311

ISBN 978-601-08-0758-7

ТЕМІР ЖЕТІСПЕУШІЛІК АНЕМИЯ. ТЕМІР ЖЕТІСПЕУШІЛІК АНЕМИЯНЫ ЕМДЕУДІҢ НЕГІЗГІ ПРИНЦИПТЕРІ.

Кенес Құралай Дүсіпханқызы
«Дүйсенбі Қалматаев атындағы мемлекеттік жоғары медицина колледжі» ШЖҚ КМК

Аннотация: *Бұл мақала қан түзу жүйесінің кең таралған ауруларының бірі болып табылатын темiржетіспеушілік анемияның себебі, клиникасы, диагностикасы және тиімді емдеуі туралы.*

Темір жетіспеушілік анемия – ағзадағы темір ресурстарының абсолютті төмендеуінен (созылмалы қан жоғалтудан немесе ағзаға темірдің жеткіліксіз түсуінен) туындайтын гипохромды микроцитарлы гипорегенераторлы анемия.

Жиілігі. Темір жетіспеушілік анемия 20–25% ересек тұрғындарда кездеседі. Теміржетіспеушілік анемия ер адамдарға қарағанда, әйел адамдарда жиі кездеседі.

Этиологиясы. Созылмалы қан жоғалту – теміржетіспеушілік анемия негізгі себебі. Жүктілік, меноррагиялар және миомада темір жетіспеушілік анемияның себебіне жатады. Дені сау әйелдерде етеккір кезінде 40-50 мл қан жоғалтады. 80 мл-дан артық жиі менструальді қан кеткен кезде темірдің қоры біртіндеп азая бастайды, нәтижесінде темір жетіспеушілік анемияға әкеледі. Себептері:

- Асқазан-ішектік: гастродуоденальды жара және эрозиялар, өңеш веналарының портальды гипертензиясы, ішектің және асқазанның ісіктері.
- Бүйректерден және зәр шығару жолдарынан қан кету.
- Гематологиялық аурулар: коагулопатиялар, тромбоцитопениялар, тромбоцитопатиялар негізгі себебтеріне жатады.
- Алиментарные факторлар: вегетариандық, аштық, дұрыс тамақтанбау.

Теміржетіспеушілік анемияның ауырлық дәрежесіне байланысты классификациясы:

– жеңіл дәреже – Hb-нің қандағы концентрациясы 110 - 90 г/л аралығында;

– орташа дәреже - Hb-нің қандағы концентрациясы 90 – 70 г/л аралығында;

– ауыр дәреже - Hb-нің қандағы концентрациясы 70-55 г/л аралығында;

– өте ауыр дәреже – Hb-нің қандағы концентрациясы 55 г/л-ден төмен.

Клиникасы. Сидеропениялық және анемиялық синдроммен көрінетін ағзадағы темір жетіспеушілік пайда болады.

Сидеропениялық (гипосидероз) симптомдар: терінің, тырнақтың, шаштың айқын өзгерістері, тәбеттің бұрмалануы (патофагия – бор, топырақ,

ISBN 978-601-08-0758-7

көмір жеуі) және иістің бұзылуы(патоосмия – бензин, бояу, газдың иісін ұнату).

Жалпы қарағанда тері жабындылардың бозғылттығы, қолдардың және аяқтардың тілінуі болады. Шаштары жұқарып, ұштанып, сынғыш, ақ шаш пайда болады. Тырнақтары сынып, жұқарады. Сидеропения тілдің шырышты қабатының атрофиясына, ангулярлы стоматитке, тіс жегісіне әкеледі. **Анемиялық симптомдар:** әлсіздік, шаршағыштық, немқұрайлылық. бас ауру, бас айналу, көз алдында шіркейлердің ұшуы. Темiржетіспеушілік анемияның негізгі симптомдарына ентігу, жүрек қағуы, артериальды гипотензия жатады. Тахикардия, жүректің салыстырмалы тұйықталу шекарасының солға кеңеюі, жүрек ұшында және өкпе артериясында систолалық шу анықталады. Мойын және сан артерияларда шулы дыбыс естіледі. Шулар функционалды сипатқа ие және анемияны жоюмен бірге жоғалады. Ауыр темiржетіспеушілік анемия кезінде егде жастағы емделушілерде жүрек-қан тамырлары жеткіліксіздігі дамуы мүмкін. Қызба кейде темiржетіспеушілік анемияның көрінісі болып табылады, дене температурасы әдетте 37,5 ° С-тан аспайды және құрамында темірі бар препараттармен емдеуден кейін жоғалады.

Диагноз. Шешуші диагнозда қанның, сүйек кемігінің, темір алмасуының зертханалық зерттеулерінің нәтіжесі маңызды.

Жалпы қан анализінде гипохромды микроцитарлық анемия белгілерінің болуымен сипатталады. Hb концентрациясы төмендейді. Эритроциттер саны да азаяды, бірақ Hb деңгейінен аз дәрежеде. Қан жағындыларында ұсақ гипохромды эритроциттер, мөлшері мен пішіні бірдей емес эритроциттер (анизоцитоз, пойкилоцитоз). Ауыр анемия үшін жеке эритробласттар пайда болуы мүмкін. Ретикулоциттер саны өзгермейді.

Темір жетіспеушілік анемияның спецификалық белгілері: қан сарысуындағы темірдің төмен мөлшері (қалыпты 12,5–30,4 мкмоль/л). Сарысудың жалпы темірді байланыстыру қабілетінің жоғарылауы (қалыпты 30,6–84,6 мкмоль/л).

Аспаптық тексерулер: эзофагогатроскопия, колоноскопия, қажет болған жағдайда - асқазанның флюроскопиясы (грыжа анықтау, диафрагманың өңештің ашылуы).

Емі. Темір жетіспеушілік анемияның терапиясының мақсаты темір тапшылығын жою және ағзадағы оның қорларын қалпына келтіру.

Әйелдердегі темір тапшылық анемияның ең көп тараған себептері меноррагия және миома болып табылады.

Меноррагия (гиперменорея) – жатыры сақталған әйелдерде қан кету, ұзақтығы 7 күн. Оларға қабылдауға кеңес беріледі аминокапрон қышқылы 1 г 4 рет тәулігіне, етеккірдің 1-ден 4-ші күніне дейін қан жоғалтуды азайтады.

Емдеудің негізгі принциптерін тұжырымдаған Л.И. Идельсон, бүгінгі күні қолданысқа ие:

ISBN 978-601-08-0758-7

- темір жетіспеушілік анемияны тез жою мүмкін емес, темір препараттарын қолданбай диетамен ғана;

– темір жетіспеушілік анемия терапиясын жүргізу керек, негізінен темір препараттары жеткілікті мөлшерде (тәулігіне 100-200 мг) және ұзақ уақыт бойы ішке қабылдау үшін (кемінде 3 ай);

- Hb деңгейі қалыпқа түскеннен кейін терапияны тоқтатуға болмайды.

Дәрілердің екі тобы қолданылады: құрамында екі валентті темір және үш валентті темір. Тәуліктік доза темір 100-200 мг болуы керек.

Екі валентті темір препараттары таблетка түрі: тардиферон(200 мг элементтік темір), феоспан (200 мг), ферроградумет (100 мг), сорбифер дурулес (100 мг), геферол (100 мг), актиферрин (100 мг), темір фумараты (65 мг), тотем (50 мг), ферратаб (50 мг), Фенюллар (45 мг), Хемофер (44 мг), Ферроплекс (10 мг).

Бұл препараттар ауыз арқылы қабылданған кезде асқазан-ішек жолдарының шырышты қабатында тотығады үш валентті күйге ауысады.

Үш валентті темір препараттары ішке қабылдау үшін: феррум лек (100 мг),

мальтофер (100 мг), мальтофер фоул (100 мг), ферлатум, ферро-III, биофер. Екі валентті темір дәрілерінен айырмашылығы, бұл препараттарда прооксиданттық қасиеттер жоқ және Hb деңгейін тез қалпына келтіреді.

Парентеральді енгізуге арналған темір препараттары: эктофер, венофер, феррумлек, феринжек, ферровир, космофер. Оларды дәрігер тағайындайды және тек ауруханада ем алады.

Симптоматикалық темір жетіспеушілік анемияны емдеу ұзақтығы гемоглобин деңгейін қалыпқа келтіру үшін 3-5 ай, ал жүкті әйелдер үшін - кем дегенде гемоглобин деңгейін қалпына келтіру үшін босанғанға дейін жүргізіледі.

Қорытынды. Көптеген жағдайларда темір тапшылығы анемиясына сәтті түзету енгізіледі. Дегенмен, шешілмеген себептерге байланысты темір жетіспеушілігі қайталануы мүмкін. Темір жеткіліксіздік анемияны болдырмау үшін клиникалық қан анализінің жыл сайынғы мониторингі қажет, жеткілікті темірмен жақсы тамақтану, ағзада қан жоғалту көздерін дер кезінде жою керек.

Әдебиеттер тізімі:

1.Дәлелді медицина кітапханасы- Кохрейндік кітапхана https://www.cochrane.org/ru/CD013518/AIRWAYS_kombinirovannyy-in

2.Протоколы заседаний Объединенной комиссии по качеству медицинских услуг МЗ РК, 2018

3. Абдурахманов Д.Т. // Фарматека. – 2012. – №3. – С.9–14.

4. Гематология: Рук-во для врачей / Под ред. Н.Н.Мамаева, С.И. Рябова. – СПб., 2008. – 543 с

ISBN 978-601-08-0758-7

5. Стуклов Н.И. Анемии при гинекологических и онкогинекологических заболеваниях / Н.И. Стуклов, Г.И. Козинец, С.А. Леваков, П.П. Огурцов. – М., 2013. – 240 с.

6. Шевченко Ю.Л., Новик А.А., Мельниченко В.Я. Анемии. – М., 2012. – 350 с.

ISBN 978-601-08-0758-7

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ФОРМИРОВАНИЯ КЛИНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У ФЕЛЬДШЕРОВ

Баймулдинова Найля Касымхановна, преподаватель специальных дисциплин
ТОО медицинский колледж «Томирис» г. Астана

Аннотация

Одним из важнейших задач медицинского образования является формирование и развитие у студентов навыков клинического мышления. Клиническое мышление – это профессиональное, творческое решение вопросов диагностики, лечения и определения прогноза болезни у данного больного на основе знания, опыта и интуиции.

В современном мире растет роль медицинского персонала среднего звена и в том числе роль фельдшера в оказании неотложной доврачебной помощи. Во многих случаях дальнейшее развитие и исход заболевания зависит от правильной первичной постановки диагноза и оказания доврачебной помощи. Использование ситуационных задач в процессе обучения и контроля полученных знаний способствует развитию клинического мышления студентов, существенно дополняет в дальнейшем работу с пациентами, расширяет возможности учебного процесса, повышает мотивацию студентов к изучению специальных дисциплин.

В настоящее время в процессе обучения происходит смещение с традиционных форм обучения на инновационные образовательные технологии. Инновационная технология представляет собой систему совместной работы студента и преподавателя. А профессионально-ориентированная технология обучения, которая формирует у студента значимость в медицинской деятельности личностных качеств, а так же знаний, навыков, умений, обеспечивающих выполнение функциональных обязанностей по предназначению. Знания — это теоретическая информация, усвоенная, сохраненная и продолжающая пополняться, необходимая для использования в реальной и практической деятельности по решению конкретных задач. Практические навыки при обучении — это комплекс приобретенных и приобретаемых студентами навыков, которые включают субъективные и объективные методы обследования больного, лабораторное, функциональное и инструментальное обследование, составление плана дальнейших лечебных, профилактических мероприятий и их практическое выполнение. Используя практические навыки, мы собираем необходимую информацию о пациенте, оцениваем общее состояние, функции органов и систем. Однако, общих теоретических знаний и практических навыков и умений недостаточно для фельдшера, т.к. фельдшер кареты СМП обслуживая пациентов вне лечебных учреждении должен за короткое время, выявить болезнь, оказать доврачебную помощь и решить вопрос о госпитализации

ISBN 978-601-08-0758-7

или же больной будет лечение принимать амбулаторно. Для этого, необходимы еще профессиональные умения, которые помогут принять быстрое и четкое, обоснованное и взвешенное решение, осуществить целенаправленные мероприятия для спасения жизни пациента, для предупреждения распространения инфекционных заболеваний среди населения.

Клиническое мышление, практические умения и навыки составляют основу профессионального мастерства. Одним из методов, который способствует формированию клинического мышления, является ситуационная задача. Ситуационная задача моделирует клиническую ситуацию и дает возможность показать теоретическую подготовку, практические навыки и умения продемонстрировать свое клиническое мышление. При прохождении обучения студентов в отделении специальных дисциплин медицинского колледжа «Томирис», в частности по предмету терапия широко используем ситуационные задачи в процессе обучения на практических занятиях и в качестве контроля приобретенных знаний. При разработке ситуационных задач учитываем уровень подготовки, личные качества студентов и заинтересованность в данном предмете. Вносим соответствующие изменения в содержание и в количество задач, моделирующих профессиональную деятельность. Ситуационные задачи имеют особенно важное значение, когда отсутствует возможность работать с «тематическими» пациентами. Используются различные формы работы со студентами, проводим индивидуальное решение задач и групповое.

Индивидуальное решение задач - дает каждому студенту самостоятельно принять решение, возможность самореализации, взять ответственность на себя при решении данной ситуации. Студенты используя свои теоретические знания и практические навыки в данной клинической ситуации должны уметь не только выставить предварительный диагноз, но обосновать на основании каких данных выставлен диагноз, составить план обследования, ожидаемые изменения в анализах, предполагаемые осложнения, дифференцированную диагностику, план лечения и прогноз. При должной поддержке со стороны преподавателя у студента есть возможность поработать над своими ошибками и повысить самооценку. При оценивании данной ситуации, оппонентами являются остальные студенты группы.

В ходе группового решения задач данная клиническая ситуация выступает как средство общения, и при этом создаются благоприятные условия для межличностных отношений, интегрируется опыт всех участников, создается творческий потенциал, происходит активизация потенциальных возможностей каждого студента и создаются доверительные отношения между студентами и преподавателем. Групповое решение задач существенно оптимизирует учебный процесс, повышает мотивацию студентов, способствует более полному использованию их интеллектуальных

ISBN 978-601-08-0758-7

и эмоциональных возможностей с формированием профессионального сознания и мышления. Группы создаются в разных соотношениях, по два или трое студентов, в некоторых случаях в виде ролевых игр, где один пациент и остальные студенты участвуют в обсуждении. Ситуация дается только одним условием, это или только жалобы или же состояние пациента, где студентам надо расспросить больного с целью получения дополнительной информации, выделить основные жалобы, собрать анамнез развития болезни и жизни больного, по требованию преподаватель выдает результаты обследовании, студенты сами должны интерпретировать полученные результаты, при этом учитывается мнение каждого студента, после чего согласовывая мнение каждого должны прийти к одному решению и выставить предварительный диагноз.

Таким образом, использование ситуационных задач в ходе обучения и контроля полученных знаний, развитие клинического мышления студентов медицинского колледжа существенно дополняет работу с пациентами во время производственной практики и в будущем, раскрывает потенциал каждого обучающегося студента, расширяет возможности учебного процесса, способствует его оптимизации и повышает мотивацию студентов к изучению данного предмета.

Список литературы:

1. Есауленко И.Э. Теория и методика обучения в высшей медицинской школе: учебное пособие для системы повышения квалификации и дополнительного профессионального образования преподавателей медицинских и фармацевтических вузов / И.Э. Есауленко, А.Н. Пашков, И.Е. Плотникова; Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования «Воронежская гос. мед. акад. им. Н.Н. Бурденко». Воронеж, 2011. (2-е изд.).

2. Комова С.Ю., Цветикова Л.Н. Реализация педагогических технологий как способ повышения мотивации в обучении взрослых // Инновации в науке: сборник статей по материалам XXVI Международной научнопрактической конференции. — 2013. — № 26.

3. Прутченков А. С. «Социально-психологический тренинг межличностного общения» - М.: Общество «Знание» РСФСР, 1991.

ISBN 978-601-08-0758-7

ИННОВАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ФЕЛЬДШЕРОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Окен Данияр Нурланович, Нурахметов Берик Серикович

КГП на ПХВ «Государственный высший медицинский колледж им. Д.Калматаева»

Аннотация: *в статье рассматриваются инновационные подходы и технологии, применяемые в обучении фельдшеров по физической культуре в медицинских образовательных учреждениях. Важность физической культуры в подготовке будущих медицинских работников заключается не только в улучшении их физического состояния, но и в формировании навыков, способствующих эффективному взаимодействию с пациентами, повышении их профессиональной выносливости и стресса. Обсуждаются новые методы обучения, включающие использование цифровых технологий, мультимедийных средств и практико-ориентированных подходов, которые делают процесс обучения более динамичным и результативным. В статье также затронуты вопросы интеграции спортивных и оздоровительных технологий в программы подготовки фельдшеров для улучшения качества медицинской помощи.*

Введение

Образование будущих медицинских работников должно быть многогранным и включать различные аспекты, такие как теоретические знания, практические навыки и физическую подготовленность. Фельдшеры, как специалисты среднего медицинского звена, играют важную роль в организации медицинской помощи на всех уровнях. Одним из ключевых факторов их подготовки является физическая культура, которая помогает им поддерживать хорошее физическое состояние, развивать необходимые навыки для работы в условиях стрессовых ситуаций и повышать профессиональную выносливость.

Современные образовательные технологии предлагают новые подходы к обучению фельдшеров по физической культуре. Внедрение инновационных методов обучения позволяет значительно улучшить эффективность и качество образовательного процесса.

Методы инновационного обучения

1. **Цифровизация образовательного процесса:** Введение в обучение фельдшеров различных цифровых платформ и приложений для планирования тренировок, отслеживания физической активности и здоровья. Использование онлайн-курсов и тренажеров помогает студентам получать доступ к образовательным материалам в любое время и в любом месте.

2. **Мультимедийные технологии:** Включение видеоматериалов, анимаций, интерактивных симуляторов в процесс обучения. Это позволяет

ISBN 978-601-08-0758-7

студентам наглядно увидеть правильное выполнение упражнений и движения, а также освоить теоретические концепции через визуализацию.

3. **Практико-ориентированный подход:** Внедрение метода "обучение через практику", где студенты фельдшерских специальностей активно участвуют в спортивных мероприятиях, командных играх и тренировки, направленные на развитие выносливости и силы. Эти навыки затем могут быть использованы для медицинской практики в экстренных и стрессовых ситуациях.

4. **Междисциплинарный подход:** Важно сочетать физическую культуру с другими медицинскими дисциплинами, такими как анатомия, физиология и основы реабилитации, чтобы дать студентам полное представление о влиянии физической активности на организм человека.

Роль физической культуры в подготовке фельдшеров

Физическая культура играет важную роль в формировании у будущих фельдшеров не только профессиональных навыков, но и личностных качеств, таких как ответственность, дисциплина, командный дух и способность к самоорганизации. Хорошо подготовленный фельдшер способен справляться с физической нагрузкой в условиях интенсивной работы, обеспечивать качественную помощь пациентам и быть примером для других членов медицинской команды.

Заключение

Внедрение инновационных методов обучения фельдшеров по физической культуре является необходимым шагом для повышения качества медицинского образования и подготовки специалистов. Цифровые технологии, мультимедийные средства и практическое обучение способствуют более глубокому пониманию и усвоению материала, а также улучшению физической подготовки студентов, что в конечном итоге влияет на качество медицинской помощи. Важно продолжать развивать эти методы и интегрировать их в программы обучения фельдшеров для достижения более высоких образовательных и профессиональных результатов.

Список литературы:

1. Беляев, В. С., & Иванова, Т. А. (2019). Современные подходы к обучению студентов физической культуре в медицинских учебных заведениях. *Журнал медицинского образования*, 34(2), 12-15.

2. Михайлова, А. В. (2021). Инновационные технологии в подготовке медицинских специалистов. *Образование и наука*, 43(6), 54-58.

3. Шевченко, О. И., & Курочкина, М. А. (2020). Роль физической культуры в подготовке фельдшеров: проблемы и перспективы. *Современное образование и медицина*, 25(1), 72-76.

4. Трофимова, Е. В. (2022). Практико-ориентированное обучение в системе медицинского образования. *Медицинское образование в России*, 11(3), 45-48.

ISBN 978-601-08-0758-7

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В РАБОТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Касымжанов Е.А., Алшынгазин Н.Н.
КГП на ПХВ «Государственный высший медицинский колледж им. Д.Калматаева»

Аннотация: *В статье рассматривается использование искусственного интеллекта (ИИ) в сфере образования, в частности, в работе преподавателей. Акцент сделан на том, как современные технологии, включая ИИ, могут поддерживать и улучшать образовательный процесс, а также на потенциальных преимуществах и вызовах внедрения ИИ в работу преподавателей. Обсуждаются различные аспекты применения ИИ, такие как автоматизация административных процессов, персонализированное обучение, оценка и обратная связь, а также перспективы развития этой технологии в образовательной сфере.*

Введение

Современное образование не стоит на месте, и с каждым годом все больше технологий проникают в образовательный процесс. Одной из наиболее перспективных технологий, которая изменяет подход к обучению, является искусственный интеллект. Применение ИИ в работе преподавателя открывает новые горизонты для повышения качества образования, упрощения административной работы и улучшения взаимодействия с учащимися. В этой статье рассматриваются основные области применения ИИ в преподавательской деятельности и его влияние на образовательный процесс.

1. Автоматизация административных процессов

Преподаватели часто сталкиваются с рутинными задачами, такими как ведение журналов, создание расписаний, проверка домашних заданий и составление отчетности. Внедрение ИИ в эти процессы помогает значительно сэкономить время и силы. Программы на базе ИИ могут автоматически отслеживать успеваемость студентов, генерировать отчетность, а также напоминать преподавателям о сроках сдачи заданий и экзаменов. Такие системы, как автоматическая проверка тестов и заданий с использованием ИИ, позволяют преподавателям сосредоточиться на более важных аспектах работы — например, на развитии навыков учащихся.

2. Персонализированное обучение

Одним из ключевых преимуществ использования ИИ в образовательном процессе является возможность создания персонализированных программ обучения. ИИ может анализировать успехи студентов, их сильные и слабые стороны, и на основе этих данных предлагать индивидуальные пути развития. Например, система может адаптировать сложность задач в зависимости от уровня знаний каждого студента, а также предоставлять

ISBN 978-601-08-0758-7

дополнительные материалы для тех, кто нуждается в дополнительных пояснениях или углубленных знаниях. Это особенно важно для педагогов, работающих с большим количеством студентов, где персонализированный подход становится труднодостижимым без технологий.

3. Оценка и обратная связь

ИИ значительно улучшает процесс оценки знаний и предоставления обратной связи. Использование системы, которая автоматически анализирует работу студента, позволяет не только ускорить процесс оценки, но и сделать его более объективным. Алгоритмы ИИ могут распознавать ошибки и давать конкретные рекомендации по их исправлению. Это также позволяет преподавателям давать более точные и конструктивные замечания, а студенты могут получать своевременную обратную связь, что способствует их развитию.

4. Интерактивное обучение и виртуальные ассистенты

Системы на основе ИИ могут поддерживать интерактивные формы обучения, такие как чат-боты и виртуальные ассистенты, которые помогают студентам получать ответы на вопросы в любое время суток. Виртуальные ассистенты могут предоставлять дополнительную информацию, проверять понимание материала, а также давать рекомендации по улучшению результатов. Таким образом, ИИ помогает создать условия для круглосуточной доступности образовательных ресурсов и обратной связи.

5. Анализ и прогнозирование успеваемости студентов

Использование ИИ для анализа данных об успеваемости студентов позволяет преподавателям более точно прогнозировать результаты обучения и выявлять студентов, которые могут столкнуться с трудностями. Системы ИИ могут оценивать не только успехи студентов, но и предсказывать возможные проблемы, такие как низкий уровень вовлеченности или нехватка мотивации, что позволяет преподавателям оперативно вмешиваться и предложить помощь студентам, прежде чем проблемы станут критическими.

6. Проблемы и вызовы внедрения ИИ в образовательный процесс

Несмотря на все преимущества, внедрение ИИ в образовательный процесс сталкивается с рядом проблем. Одна из главных — это сопротивление со стороны преподавателей, которые могут опасаться, что технологии заменят их работу. Также существует проблема приватности и безопасности данных, поскольку использование ИИ требует сбора и анализа персональных данных студентов. Кроме того, необходима подготовка преподавателей к работе с новыми технологиями и обновление образовательных программ с учетом внедрения ИИ.

Заключение

Использование искусственного интеллекта в работе преподавателя открывает большие возможности для улучшения качества образования, повышения эффективности преподавания и оптимизации многих рутинных задач. Однако важно понимать, что ИИ не может полностью заменить роль

ISBN 978-601-08-0758-7

преподавателя, который остается ключевым элементом в образовательном процессе. Вместо этого технологии должны стать помощниками, которые облегчают работу педагогов и делают обучение более доступным и персонализированным. В будущем, с развитием ИИ, можно ожидать все более эффективных решений для образовательных учреждений.

Использованная литература:

1. Воронова, И. А. (2022). «Инновационные технологии в образовании: искусственный интеллект как инструмент педагогической практики». — М.: Издательство «Образование».
2. Соловьев, П. М., Фролова, О. В. (2021). «Искусственный интеллект и его роль в образовании». — СПб.: Научное издательство.
3. Кузнецова, Т. С. (2020). «Персонализированное обучение и использование ИИ в образовательном процессе». — Казань: Университетская книга.
4. Харламов, А. В. (2023). «Будущее образования: как ИИ меняет школу и университет». — Екатеринбург: Уральское издательство.

ISBN 978-601-08-0758-7

СЕКЦИЯ №4: СЕСТРИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И СЕСТРИНСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

№1 ҚАЛАЛЫҚ КЛИНИКАЛЫҚ АУРУХАНАСЫНДА АРТЕРИАЛДЫ ГИПЕРТЕНЗИЯСЫ БАР НАУҚАСТАРҒА МЕЙІРГЕРЛІК КҮТІМДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ

Абдиназар Д.А., 3 курс, «Мейіргер ісі» мамандығы
ДСБ ШЖҚ «Жоғары медицина колледжі» МКК
Ғылыми жетекшісі Абдулла Т.Д., магистр, Арнайы пәндер оқытушысы

Аннотация: *Бұл мақалада қарастырады артериалды гипертензиямен науқастанған кезінде мейіргердің кәсіби қызметінің ерекшеліктері мен ұйымдастырылуын, артериалды гипертензия кезінде мейіргерлік күтімнің ерекшеліктерін анықтау және зерттеу нәтижелері бойынша артериалды гипертензиямен ауыратын науқастармен мейіргерлік күтім бойынша ұсыныс жасау болып табылады.*

Жүрек-қан тамырлары ауруларының негізгі қауіп факторларының бірі-артериалды гипертензия болып табылады. Әлемде артериялық гипертензиядан әр жылы миллиардтаған адам зардап шегеді. Өмірдің негізгі қысқару себептері арасында артериялық гипертензия жетекші орын алады екен, себебі ол стенокардия, инфаркт, инсульт сияқты қауіпті аурулардың дамуына ықпал етеді.Зерттеудің өзектілігі мынада: статистикаға сәйкес, ҚР артериялық гипертензиямен ересек халықтың 20-30% - зардап шегеді. Жасы ұлғайған сайын аурудың таралуы артып, 65 жастан асқан адамдарда 50-65 % жетеді. Түркістан облысында 2023 жылы артериялық гипертензиямен ауыратын 169 348 науқас тіркелген, оның таралуы 100 000 ересек адамға 9 275,2 құрайды. Жыл сайын облыстағы емдеу-алдын алу мекемелеріне жүгінген кезде артериялық гипертензиямен ауыратын 16861 науқас анықталады [2].

Зерттеу мақсаты: Артериалды гипертензиямен науқастанған кезінде мейіргердің кәсіби қызметінің ерекшеліктері мен ұйымдастырылуын анықтау [1].

Зерттеудің міндеттері: 1.Зерттеу тақырыбы бойынша арнайы әдебиеттерді талдау.

2. Артериалды гипертензия кезінде мейіргерлік күтімнің ерекшеліктерін анықтау

3. Зерттеу нәтижелері бойынша артериалды гипертензиямен ауыратын науқастармен мейіргерлік күтім бойынша ұсыныс жасау [3].

Зерттеу материалдары мен әдістері: Зерттеу №1 қалалық клиникалық ауруханасының, терапия бөлімшесінде жүргізілді. Зерттеуге 30 науқас қатысты.

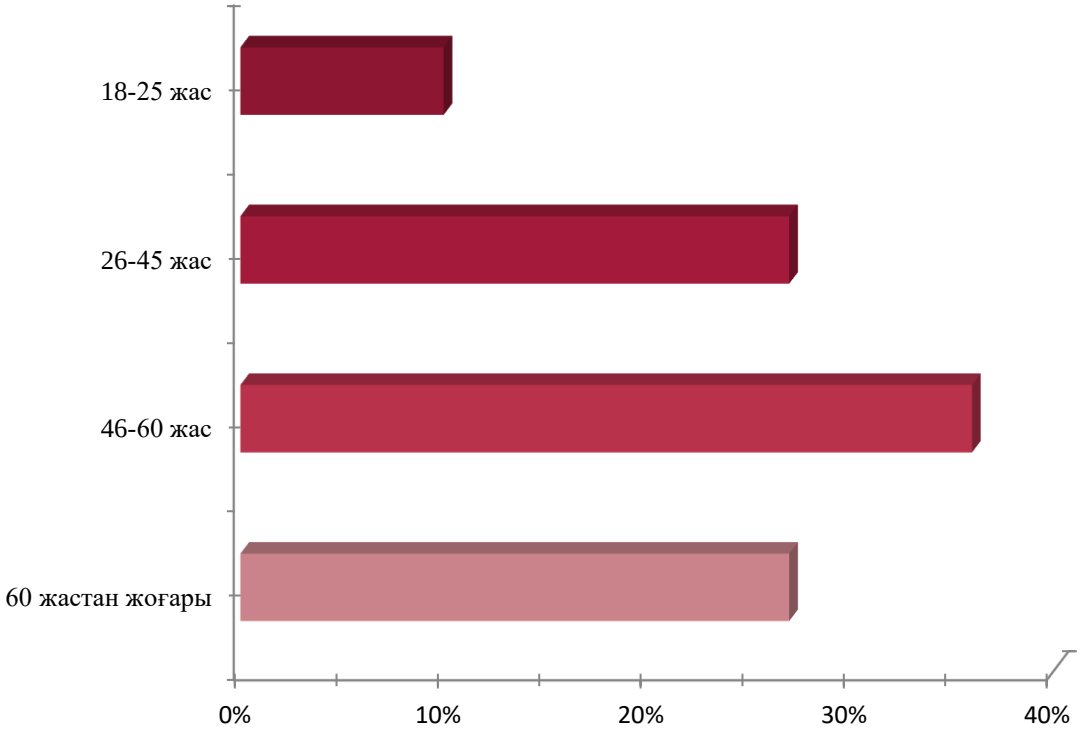
ISBN 978-601-08-0758-7

Зерттеу бойынша сауалнама, талдау, бақылау, статистикалық диаграммалар құрастырылды [3].

Зерттеу нәтижелеріне тоқталар болсам:

Науқастардың жас ерекшелігі

1-сурет

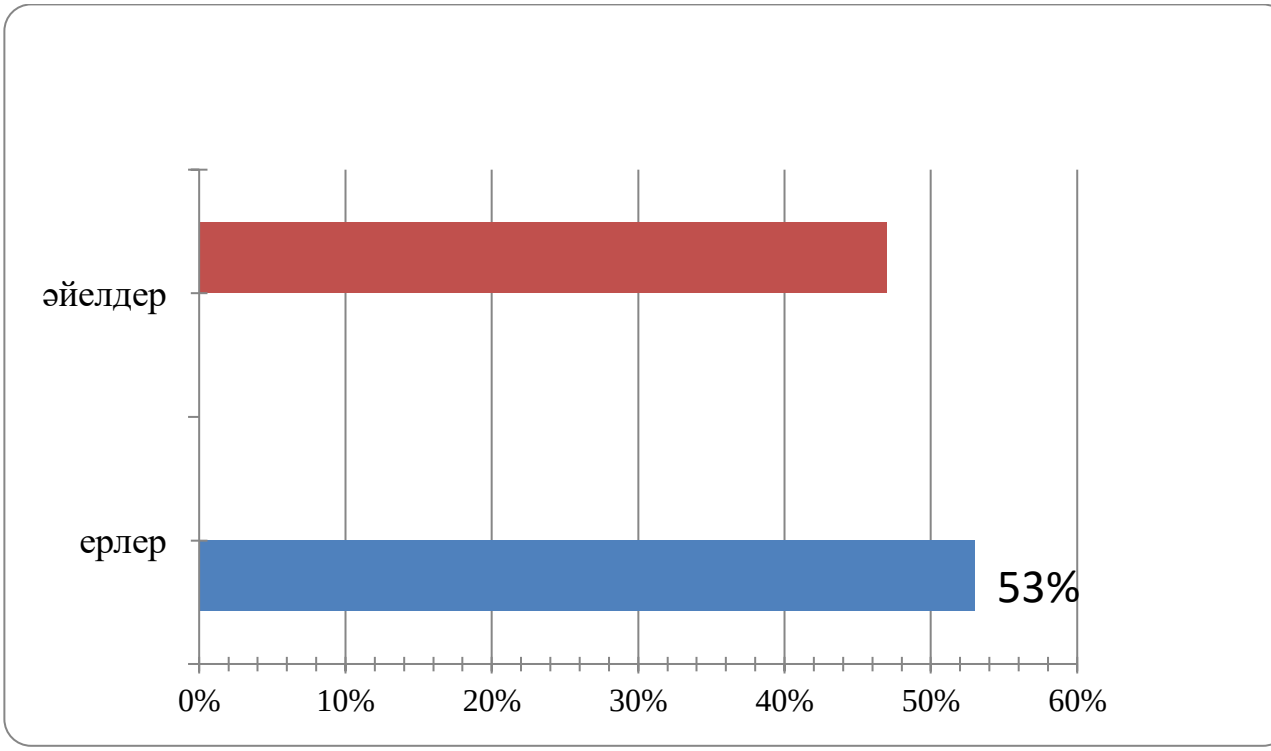


Науқастардың жасы былайша бөлінді: 3 науқас (10%) – 18 – 25 жас, 8 науқас (27%) – 26 – 45 жас, 11 науқас (36%) – 46-60 жас, 60 жастан жоғары- 8 науқас (27%) құрады.

Науқастарды жынысы бойынша бөлу

2-сурет

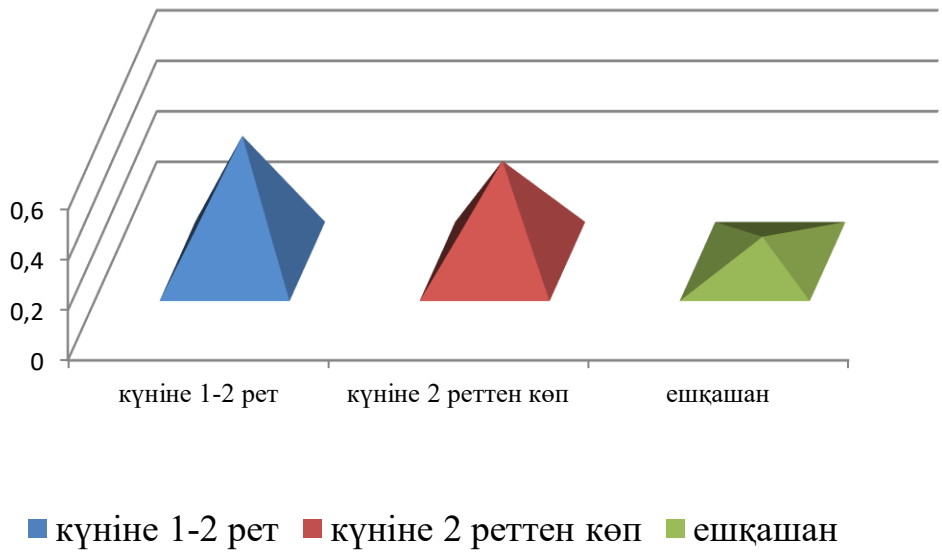
ISBN 978-601-08-0758-7



Жынысы бойынша науқастар келесідей бөлінді: ерлер – 16 науқас (53%), әйелдер – 14 науқас (47%) деп бөлінді.

Артериялық қан қысымын бақылау

3-сурет

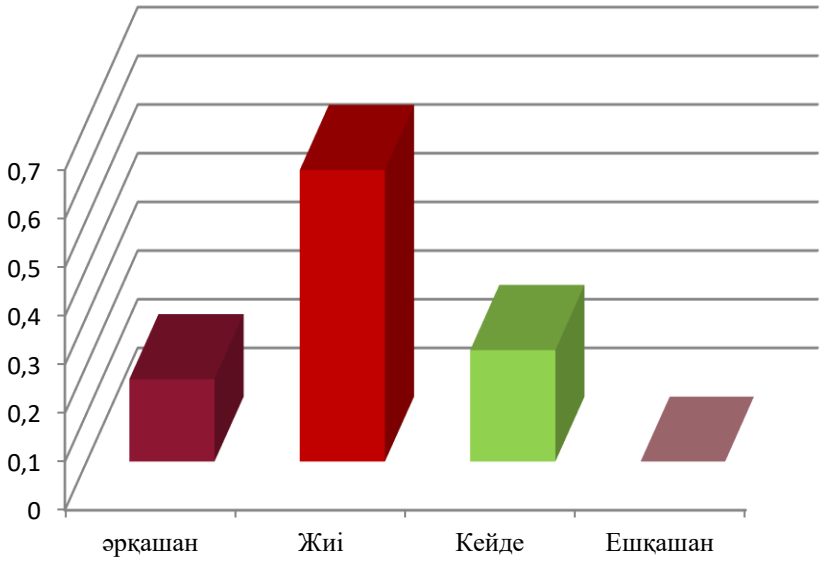


ISBN 978-601-08-0758-7

Сауалнама сұрағы бойынша «Сіз артериялық қан қысымын қаншалықты жиі өлшейсіз?» - деген сұраққа науқастардың жауаптары осылай болды: науқастардың 15-і (50%) қан қысымын күніне 1-2 рет өлшейді, 12 –і науқас (40%)- қан қысымын күніне 2 реттен көп өлшейді, ал 3 науқас (10%) ешқашан өлшемейді.

Стресс сезімінің жиілігі

4-сурет

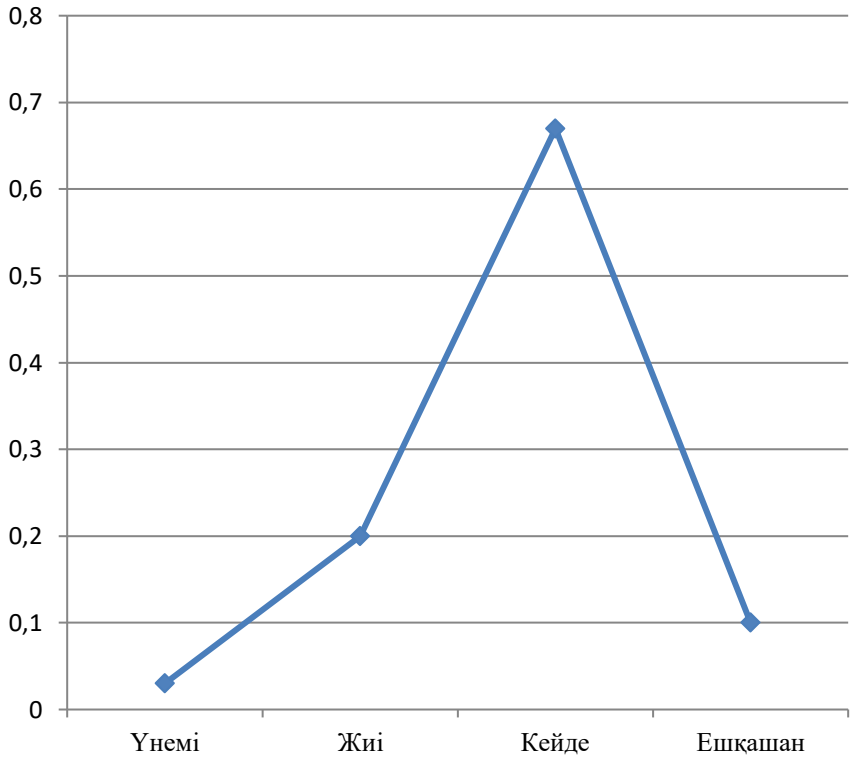


«Сіз қаншалықты жиі стрессті сезінесіз?» - деген сұраққа науқастар келесі жауаптарды берді: әрқашан-5 науқас (17%), жиі – 18 науқас (60%), кейде – 7 науқас (23%) жауапты құрады.

Алкогольді тұтыну жиілігі

5-сурет

ISBN 978-601-08-0758-7



Науқастардың алкогольді тұтынуы туралы жауаптар келесідей бөлінді: олар үнемі алкогольді тұтынады – 1 науқас (3%), жиі-6 науқас (20%), кейде-20 науқас (67%) және ешқашан – 3 науқас (10%) алкогольді тұтынбайды.

Артериалдық қан қысымының жоғарлауы кезінде алкогольдік ішімдікке мұқият болу керек және дәрігердің барлық ұсыныстарын орындау керек. Тіпті аз мөлшерде алкогольді ішу қан қысымның жоғарылауына әкеледі [3].

Қорытынды: 1. Артерталды гипертензия туралы медициналық әдебиеттерді талдағаннан кейін мен бұл ауру қазіргі кезде өте қауіпті деген қорытындыға келдім. Сондықтан артериалды гипертензияны алдын-алу, әсіресе тұқым қуалайтын адамдар үшін, бірінші кезектегі міндет болып табылады. Салауатты өмір салты және үнемі кардиологтың бақылауы, артериалды гипертензияның көріністерін болдырмауға немесе азайтуға көмектеседі, көбінесе оның дамуына жол бермейді [1].

2. Мейіргерге стационардағы науқастың денсаулығы мен әл-ауқаты үшін жауапкершілік жүктеледі және ол өзін жайсыз сезінуін жақсартуға және науқастың жалпы жағдайын қалыпқа келтіруге қол жеткізуі керек. Сондай-ақ емделуші мен оның жақындарына алдын алудың барлық қажетті ақпараттарын жеткізуі, науқастарға дәрі-дәрмектерді қабылдаудың жүйелілігін қадағалуы, жүйелі түрде қан қысымын өлшеп тұруы, диетаны ұстануын қатаң қадағалауы тиіс [2].

3.Зерттеудің мәліметтері бойынша біз мейіргерлерге арналған тәжірбиелік ұсыныстар әзірледік:

ISBN 978-601-08-0758-7

-Емдік іс-шараларды дұрыс қабылдаудың маңыздылығы туралы науқаспен,туған туыстарымен әңгіме жүргізу.

-Науқастардың пікірін ескеріп, сауалнаманы қолдана отырып, медициналық көмек көрсету сапасын бақылауды күшейту.

-Мейіргерлердің санын арттырып, барлық құжаттарды тек электронды жүйеде толтыруға көшіп, бөлімшедегі мейіргер жұмысын жеңілдету керек [2].

Әдебиеттер тізімі:

1 Egginton JS, Ridgeway JL, Shah ND, et al. Care management for Type 2 diabetes in the United States: a systematic review and metaanalysis // BMC Health Serv Res. - 2012. - №12. - P. 15-21.

2 Michael Mehring, Ewan Donnachie, Florian Cornelius Bonke, Christoph Werner and Antonius Schneider1Disease management programs for patients with type 2 diabetes mellitus in Germany: a longitudinal population-based descriptive study // DiabetolMetabSyndr. - 2017. - №9. - P. 91-94.

3 Pimouguet C, Le Goff M, Thiebaut R, Dartiques JF, Helmer C. Effectiveness of disease-management programs for improving diabetes care: a meta-analysis // CMAJ. - 2011. - №183. - P. 115- 127

ISBN 978-601-08-0758-7

МЕЙІРБИКЕЛІК БІЛІМ ЖӘНЕ МЕЙІРБИКЕЛІК ЗЕРТТЕУЛЕР

Адильжанұлы Сабыржан
Республикалық жоғары медицина колледжі
Ғылыми жетекшісі: Кусайынова Гульнара Акимхановна

Аннотация: *Мейіргерлік білімді жетілдіру және зерттеулерді қолдану арқылы мейіргерлердің кәсіби деңгейін арттырып, онкологиялық пациенттерге сапалы күтім көрсетудің тиімділігін дәлелдеу.Мейіргерлік білім беру жүйесі дамыған сайын, мейіргерлер тек медициналық манипуляцияларды орындап қана қоймай, емдеу процесінде стратегиялық рөл атқара бастайды. Бұл рөл олардың ғылыми зерттеулерге қатысуымен және клиникалық шешім қабылдау қабілетін арттырумен байланысты. Онкология сияқты күрделі салада мейіргерлердің білімін жетілдіру және дәлелді медицинаны қолдану — емделушілердің өмір сапасын жақсартудың негізгі факторы.*

Зерттеудің әдісі:

Зерттеу еңбекте бұған дейін зерттеліп, ғылыми айналымға түсірілген ғалымдардың еңбектері басшылыққа алынып, жұмыс зерттеу,бақылау,іздену, анализдеу әдісімен жүзеге асты.

Зерттеу кезеңдері:

1. Дайындық кезеңі: тақырыпты анықтау, мақсатын айқындау, деректерді жинау;

2. Теориялық кезеңі: зерттеу тақырыбы бойынша қажетті деректерді талдау, жүйелеу;

3. Қорытынды кезеңі: тұжырымдар мен ұсыныстарды дайындау.

Мейіргерлік білім жүйесі-мейіргерлердің білім алуына арналған бағдарламаларды, курстарды және мамандандырылған дайындықтарды қамтиды. Бұл білім берудің негізгі компоненттері:

1. Теориялық білім: Мейіргерлер медициналық, физиологиялық, психологиялық және әлеуметтік аспектілер туралы терең білім алуы керек. Бұл білім мейіргерлерге пациенттердің денсаулығын бағалауға, күтімін жоспарлауға және емдеу процесін басқаруға мүмкіндік береді.

2. Практикалық дағдылар: Мейіргерлік тәжірибе әрдайым теориялық біліммен үйлесіп отыруы қажет. Практикалық дағ дылар мейіргерлерге науқастарға күтім көрсету, процедураларды орындау және шұғыл жағдайларда әрекет ету біліктілігін дамытуға көмектеседі.

3. Этика мен құқықтық аспектілері: Мейіргерлер медициналық этика, пациенттердің құқықтары мен заңнамалық талаптарды түсінуі қажет.Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (ДДҰ) мәліметі бойынша, мейіргерлердің жоғары кәсіби білімі пациенттердің емдеу нәтижелерін айқын түрде жақсартады.

Мейіргерлік білім туралы зерттеу жұмыстары:

ISBN 978-601-08-0758-7

Дәлелді медицина (evidence-based practice) денсаулық сақтау жүйесінің ажырамас бөлігіне айналды. Зерттеулер көрсеткендей, дәлелді медицинаны қолданатын мейіргерлер емдеуде заманауи әдістерді енгізіп, пациенттерге қауіпсіз және тиімді көмек көрсетеді .

Коулман және Хэмс (Coleman & Hames) жүргізген зерттеулерде, онкология саласындағы мейіргерлік зерттеулер химиотерапияның жанама әсерлерін басқаруда және науқастардың паллиативтік күтімін жетілдіруде маңызды рөл атқаратыны анықталды .

Паллиативтік көмек және психоәлеуметтік қолдау:

Мейірбикелік білім мен зерттеулер онкологиялық науқастарға психоәлеуметтік қолдау көрсетудің тиімділігін дәлелдеді. Зерттеулерге сәйкес, паллиативтік көмектің заманауи әдістерін меңгерген мейіргерлер пациенттердің ауырсынуын азайтып, олардың эмоционалдық күйін жақсартады. Мұндай тәжірибелер пациенттердің өмір сапасын арттырып қана қоймай, олардың туыстары мен жақындарының психологиялық қолдауға мұқтаждығын да қанағаттандырады .

Мейіргерлердің кәсіби дамуы мен шешім қабылдай алу қабілеті:

Мейірбикелік зерттеулер мейіргерлердің клиникалық шешімдер қабылдау дағдыларын жақсартуға бағытталған. Мысалы, Харрис және Линдберг (Harris & Lindberg) зерттеулері онкология саласындағы мейіргерлердің күрделі жағдайларда шешім қабылдауда білімнің аса маңызды екенін көрсетеді. Олардың ғылыми жұмыстары мейіргерлердің шешім қабылдау процесін жеңілдетіп, пациенттерге тиімдірек күтім көрсетуге мүмкіндік береді .

Инновациялар мен технологиялар:

Мейірбикелік зерттеулерді жетілдіру медициналық технологияларды қолдану арқылы да мүмкін болады. Мейіргерлердің электронды жүйелерді, мобильді қосымшаларды және телемедицинаны қолдануы емдеуді тиімдірек басқаруға және пациенттердің жағдайын бақылауды оңтайландыруға көмектеседі. Ли және Кимнің (Lee & Kim) зерттеулерінде онкология саласында мейіргерлердің заманауи технологияларды қолдануы емдеу нәтижелерін жақсартатыны дәлелденген .

Практикалық ұсыныстар:

-Мейірбикелік білім беру жүйесін жаңғырту: Онкология саласындағы мейіргерлер үшін арнайы білім беру бағдарламаларын жасау, тәжірибелік дағдыларды жетілдіруге басымдық беру.

-Мейірбикелік зерттеулерді қолдау: Мейіргерлерді ғылыми зерттеулерге қатысуға ынталандыру, олардың нәтижелерін клиникалық тәжірибеге енгізу.

-Дәлелді медицинаны қолдану: Мейіргерлердің шешім қабылдау процесінде заманауи ғылыми дәлелдерді қолдану арқылы науқастарға көрсетілетін көмектің сапасын арттыру.

ISBN 978-601-08-0758-7

-Мультидисциплинарлық топтардағы рөлі:Мейіргерлер онкологиялық күтімде мультидисциплинарлық топтардың құрамында ерекше орын алады. Олардың басқа дәрігерлермен, психологтармен, диетологтармен және әлеуметтік қызметкерлермен бірлесіп жұмыс істеуі науқастарға кешенді көмек көрсетудің негізі болып табылады. Бұл командалық жұмыс науқастардың физикалық, психологиялық және әлеуметтік жағдайын жақсартуға ықпал етеді.

-Кәсіби эмоциялық жану синдромының алдын алу:Онкологиялық науқастармен жұмыс істейтін мейіргерлер эмоционалдық және психологиялық тұрғыдан үлкен жүктемеге тап болады, бұл эмоциялық жану синдромының (burnout syndrome) даму қаупін арттырады. Зерттеуге мейіргерлер арасында осы синдромның алдын алу және кәсіби күйзеліс жағдайларын басқару әдістері туралы ақпаратты қосуға болады. Кәсіби қолдау бағдарламалары, психологиялық тренингтер және қолайлы жұмыс ортасын қамтамасыз ету мейіргерлердің психологиялық жағдайын жақсартып, олардың жұмыс тиімділігін арттырады.

-Этика және пациенттердің құқықтары:Онкология саласында жұмыс істейтін мейіргерлер үшін этикалық мәселелер маңызды болып табылады. Пациенттердің жеке басын құрметтеу, ақпараттандырылған келісім алу, құпиялылықты сақтау және науқастардың құқықтарын қорғау мейіргерлердің кәсіби міндеттерінің бір бөлігі болып табылады. Этика мен пациенттердің құқықтарын сақтау арқылы мейіргерлер науқастардың сенімін арттырып, күтім сапасын жақсартады.

Қорытынды: мейірбикелік білім мен зерттеулер пациенттердің ауруынан айығуына тікелей әсер етеді. Жоғарыда аталған мейірбикелік білім беру жүйесін жаңғырту,мейірбикелік зерттеулерді қолдау,дәлелді медицинаны қолдану,мультидисциплинарлық топтардағы мейіргердің үлесі,кәсіби эмоцианалдық жану синдромының алдын алу және этика мен пациенттердің құқықтары мейіргерлік білімнің негізі болып табылады .

Аталған іс-шаралар жиынтығы жұмыс барысында мейіргерлерге де,пациенттерге де оң әсерін тигізеді. Мейіргерлердің кәсіби құзіреттілігін дамытуға арналған ұсынымдар:

1. Білім беру бағдарламаларын жетілдіру

- Жаңаша оқу бағдарламалары: Мейіргерлік білім беру бағдарламаларын заманауи медицина мен технологияларды ескере отырып жаңарту.

- Интердисциплинарлық оқыту: Медицина, психология, әлеуметтік жұмыс сияқты салалармен интеграцияланған оқу курстарын енгізу.

2. Практикалық тәжірибе

- Клиникалық тәжірибе: Науқастармен жұмыс істейтін практикалық сабақтарды көбейту, симуляция әдістерін пайдалану.

- Менторлық бағдарламалар: Жас мейіргерлер үшін тәжірибелі мейіргерлермен mentorship жүйесін құру.

ISBN 978-601-08-0758-7

3. Этикалық және кәсіби стандарттарды сақтау

- Этика мен құқықтық білім: Мейіргерлердің кәсіби этика мен заңнамаға қатысты білімдерін арттыру.

- Кәсіби даму: Мейіргерлердің кәсіби этикаға сай жұмыс жасауын қамтамасыз ету үшін тұрақты оқыту курстарын ұйымдастыру.

4. Командалық жұмыс

- Көппрофильді командалар: Медициналық командаларда тиімді жұмыс істеу дағдыларын дамыту, коммуникация мен ынтымақтастықты нығайту.

- Науқасқа бағдарлану: Науқастармен және олардың отбасыларымен тиімді байланыс орнату дағдыларын жетілдіру.

5. Тұрақты кәсіби даму

- Біліктілікті арттыру курстары: Мейіргерлерге кәсіби біліктілігін арттыру үшін тұрақты курстар мен семинарлар ұйымдастыру.

- Сертификаттау Арнайы бағыттар бойынша сертификаттау жүйесін енгізу.

Түйіндей келе,мейіргерлердің кәсіби құзіреттілігін дамытуға бағытталған бұл ұсынымдар мейіргерлік қызметтің сапасын арттыруға, науқастарға көрсетілетін көмектің тиімділігін қамтамасыз етуге және мейіргерлердің кәсіби дамуына ықпал етіп,пациенттердің емделуіне үлкен үлес қосады.

Әдебиеттер тізімі:

1.https://practical-oncology.ru/journals/jurnal0623.pdf

2.https://www.internationalegg.com/kk/our-work/industry-representation/world-health-organization-who/

3.https://www.nursingworld.org/content-hub/resources/workplace/evidence-based-practice-in-nursing/

4. https://oncology.ru/specialist/treatment/references/actual/460.pdf

5.https://c-med.mcfr.kz/article/889-medbikelerdeg-emotsiyaly-kyp-ketu-sindromy-basshyy-anday-sharalar-abyldau-ajet

6.https://medplatforma.com.ua/article/ru/1207-meditsinskaya-etika-prakticheskie-sovety-i-rabochie-sittuatsii-rus

7. https://edu.rvmc.kz/ru/

8. https://kaznmu.edu.kz/ru

ISBN 978-601-08-0758-7

МЕЙІРБИКЕ МЕН НАУҚАСПЕН АРАСЫНДАҒЫ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСЫНЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ.

Білім алушы: Азат Ұлдана

"Шымкент қаласының Денсаулық сақтау басқармасының Шымкент жоғары медициналық колледжі" ШЖҚ МКК

Ғылыми жетекшісі: Бурибекова Зауре Маратовна

Аннотация: *Бүгінгі таңда медбикенің коммуникативтік дағдыларын дамыту үлкен маңызға ие. ҚР Денсаулық сақтаудың қазіргі заманғы реформалары, олардың шеңберінде мейіргер персоналының функциялары кеңейтілуде, олардың пациенттермен тиімді қарым-қатынас құра білу табыстылығының қажетті шарты болып табылады.*

Бұл пациенттерде орын алған проблемалар туралы ақпаратты, сондай-ақ бұл проблемаларды объективті бағалаумен, оларды белсенді талқылаумен емдеу-диагностикалық процестің бір бөлігіне, ынтымақтастық іс-әрекетке айналдыруды көздейтініне байланысты, оның мақсаты – халық санасында денсаулық үшін күресте жеке жауапкершілікті қалыптастыру. Мейіргерлік іс – емдеу шаралары мен іс-әрекеттерін ізгі ниетпен, техникалық жағынан сауатты орындаумен қатар, психологиялық және физикалық қиындықтарды пациенттермен жасалатын мейіргер ісіндегі қарым-қатынасты білдіреді.

Өзектілігі: Мейіргерлердің тікелей атқаратын негізгі жұмыстары науқаспен қарым-қатынас арқылы жүреді және бұл байланыстың сәттілігі медицина қызметкерлерінің жеке тұлғаның ерекшеліктерін қаншалықты түсіне алатындығына байланысты.

Зерттеудің мақсаты: Мейіргерлердің науқаспен қарым-қатынасының психологиялық ерекшеліктерін анықтау.

Зерттеудің міндеті: Медициналық қызметкерлердің коммуникативтік дағдылары – бұл пациенттердің құқығын құрметтей отырып сенімділік қарым-қатынасты орнату

Пациентпен қарым-қатынас кезінде мейіргер әрдайым есте сақтауы керек:

1.Дұрыс психологиялық байланыс орнатыңыз.

Бірінші кездесуден бастап ақ,мейіріммен, достық қарым-қатынаста екенімізді,әрдайым көмекке дайын екенімізді көрсетуі қажет.

Науқаспен достық, біркелкі, сенімді дауыспен өткізілетін

әңгіме тыныштық әкеледі, шиеленісті жеңілдетеді.

2. Ауру және емдеу туралы қол жетімді түрде айтыңыз, бірақ медициналық құпияны ескере отырып.

3. Ең ауыр жағдайдағы науқасты тыныштандырыңыз және

жай-күйі қадағалаңыз.

4. Науқастың психикасын жағымсыз әсерлерден қорғау.

5. Науқастың медициналық және жеке құпияларын сақтау.

ISBN 978-601-08-0758-7

6. Сөзді қолданғанда маңызды психотерапиялық және психопрофилактикалық фактор ретінде қабылдау.
7. Әңгімеде жеке тұлғаны анықтай білу-науқастың сипаттамалық ерекшеліктерін (мінезі, темпераменті, қабілеттер, қажеттіліктер)

Науқасқа толық жанашырлықпен қарап,оны түсінген кезде ғана науқаспен медицина қызметкерлері арасындағы нақты байланыс болады ал бұл табысты емдеуге жетудің жолы. Мейіргер міндетті түрде байсалды, мейірімді, емдеу мекемесінде қалыпты атмосфераны жасауға ықпал ете алатын болуы қажет. Мейіргер мен науқас арасындағы байланыс түсіністік, шыдамдылық, адалдық, шынайылық, сенім, үміт және батылдық сияқты қатынастан тұруы керек.

Науқас ауруханаға түскенде қалыпты омірімен қош айтысып, жаңа жағдайға бірден бейімделе алмайды,бастапқы кезде жалғыздықты,бақытсыздықты сезінуі мүмкін. Көптеген науқастарға стационарда болу қиынға түсүі мүмкін ондай науқастарға психологиялық қолдау корсету қажет. Науқастың ауруханада өмір сүру тәртібін медицина қызметкерлері анықтайды. Осындай жағдайда бөлімдегі психологиялық климат көбіне мейіргерлерге байланысты.

Мейіргердің коммуникативтік дағдылары – бұл пациенттермен достық қарым-қатынас орнату, осылайша оларды өзіне баурап алу арқылы жақындай түсуге жол табу болып табылады. Коммуникативтік дағдыларды жетілдіру өмірлік және кәсіби жетістікке орасан ықпал етеді.

Мейіргер өз жұмысында тиімді табысты қарым-қатынасқа қол жеткізу үшін белгілі бір ережелерді пайдаланады, оларды қолдану өзі мен пациенттің арасындағы өзара қатынастарды орнатуға көмектеседі.

Коммуникация қағидалары мен дағдылар деңгейі мейіргерге пациентті құрметтейтін, достық сенім мен ынтымақтастық атмосферасын құруға және сақтауға мүмкіндік береді.

Пациентпен әңгімені жарықтың, шудың, бөгде адамдардың болмауын және т.б. ескере отырып, мүмкіндігінше ыңғайлы жайды қамтамасыз ете отырып жүргізеді. Тұлғалық арақатынас жөнінде де естен шығармау керек, жүзіңіз пациентпен бетпе-бет тұрғаны дұрыс. Пациентке әңгімелесудің құпиялылығы туралы міндетті түрде айтасыз. Медициналық мейіргер емделушімен сабырлы әрі ашық жарқын сөйлесуге міндетті. Дөрекі, тұрпайы немесе тым ресми сөйлесуге тыйым салынады. Науқастарға «Сіз» деп және аты мен әкесінің атын атап сөйлескен жөн. Науқастың жанында тұрып оның диагнозын, емдеу жоспарын талқылауға, палатадағы өзге де науқастардың денсаулығын әңгімелеуге тыйым салынады. Күрделі және ауырсыну тудыратын емшараларды бастамас бұрын мейіргер осы емшаралардың мәнін, мағынасын және қажеттілігін түсінікті түрде науқасқа түсіндіруі және тыныштандыруы қажет.

ISBN 978-601-08-0758-7

Мейіргер мен емделушінің туысқандары (және жақындары) арасындағы қарым-қатынастар ұстамдылықты, сабырлылықты, тыныштықты және әдептілікті сақтауы қажет етеді. Сонымен қатар, халі ауыр науқастарды күтетін жақындарына емшара мен манипуляцияларды дұрыс орындау тәртібін түсіндіруі тиіс. Мейіргерлер пациент және туысқандарымен өзінің кәсіби құзыреті шеңберінде сұхбаттасуы (науқастың сырқаты, болжамы жөнінде әңгімелемей, дәрігерге жолдау) тиіс.

Пациенттермен сұхбаттасу кезінде дөрекі сөйлесуге тыйым салынады. Дәрігерлік тағайындаулар уақытында нақты, нақты және кәсіби орындалып, науқастың денсаулық жағдайындағы кенеттен болған өзгерістер туралы дәрігерге жедел хабар берілуі тис. Тағайындалған дәрігерлік емді қолдану барысында күмән туындаған жағдайда , науқас жоқ уақытта, сыпайы түрде, осы жөнінде дәрігермен мән-жайды талқылауы қажет.

Науқастар мамандығымен, материальді және әлеуметтік статусымен, отбасылық жағдайымен, өмірлік тәжірибесімен, психологиялық қиындықтарымен және уайымдарымен, жасырын мәселелерімен ерекшеленеді.

Науқастармен жұмыс жасау барысында медицина қызметкерлеріне келесі жағдайларды ескеру қажетгі болады:

- қажетті мәліметтермен науқасты ақпараттандыру;
- жоспарланатын ем түріне науқастың қатынасын талқылау;
- емдеудің тиімділігіне кері әсер беретін факторларды анықтау;
- орнаған жағдай бойынша сенімділік пен қауіптілікті анықтау;
- тағайындалған терапия бойынша науқастың дайындығын бағалау.

Науқасқа ақпарат беру барысында төмендегідей әсерлі коммуникативті техниканы қолданған жөн:

- науқастың деңгейіне сәйкес қарапайым, медициналық емес терминдерді қолдану;
- керексіз мәліметтерді шектеу;
- маңызды мәселелерді талқылау;
- қажет болған жағдайда маңызды ақпаратты қайталау;
- нақты мысалдарды келтіру;
- науқастың оң көзқарасына ие болу.

Науқаспен сұхбаттасумен қатар, науқасқа жазбаша түрде беру керек:

- күнделікті қабылдайтын дәрілердің аты мен тәуліктік мөлшерін;
- бір қабылдағандағы дәрілік заттың дозасын;
- қабылдау уақытын;
- тамақтану уақыты мен дәрілік затты қабылдау мерзімі арасындағы қатынасты;

ISBN 978-601-08-0758-7

- мүмкін болатын дәрілік затгың жағымсыз әсерлері жайында ақпарат беру (көрініс берген уақытта медицина қызметкерлеріне хабарлауы тиіс);
- дәрілік заттарды қолдану және сақтау бойынша көрсеткіштер.

Сонымен қатар, мейіргерлер жоғары кәсіби шебер кәсіби маман болумен қатар бақылаушылық, науқастың бойындағы физикалық, психологиялық өзгерістерді көретін, байқағыштық қасиеттерге де бай болғаны жөн. Олар ұстамды, өзінің сезімталдық берілгіштігін басқара білетін, эмоциялық тұрақтылықта тәрбиеленген жандар болуы тиіс. Науқасқа мүмкіндігінше үлкен көмек беріп, қолдауы үшін мейіргер коммуникативті және кәсіби білімі жоғары болуы тиіс. Науқастарды дұрыстап тыңдай білгені, оның қиналысына түсіністікпен қарап, қамқорлық танытып, қойылар сұрақтарға мән бергені жөн.

Қорытынды. Қорытындылай келе науқастар мейіргерлерге міндетті түрде сенімділікпен қарауы тиіс. Сондықтан мейіргерлердің тәртібі, жүріс-тұрысы, әдептілігі, адамды тыңдай білуі,оның ойын тиісті арнаға бағыттауы,сеніміне кіруі т.б. өте маңызды орын алады. Бұл мамандық мейіргерден артистік,педагогтік және тәрбиеші болу қасиеттерін талап етеді. Мейіргер мамандығының мәртебесін арттыру барысында әрине еліміздегі медициналық университеттер мен колледждер арасында курстар, семинарлар, ғылыми- практикалық конференциялар, байқаулар арқылы өз біліктіліктерін, кәсіби деңгейлерін көрсетіп, тәжірибелерін бөлісіп отырады. Ел игілігі үшін қызмет жасайтын орта буынды медицина мамандарын дайындау бұл өте үлкен жауапкершілікті талап етеді. Сондықтан да ертеңгі күннің еншісінде біздің берген білім өзін жоғары сапа ретінде дәлелдеуі керек, ал білімнің терең болуы үшін оқу мен тәрбиенің шынайы да талапты түрде берілуі қажет.

Әдебиеттер тізімі

1. С.Қ.Мұратбекова «Мейірбике ісінің негіздері» 47-48 бет
2. Е.В.Качаровская,О.К.Лютикова «Сестринское дело в педиатрии»
3. Н.Г.Соколова,В.Д.Тульчинская «Сестринское дело в педиатрии»
4. kingmed.info/knigi/Sestrinskoe_delo/book_4149
5. group-global.org/kk/publication/35039-meyirbike-isi-zhuyesinin-roli-zhne- zamanaui-gylym-negizi
6. Мышкина А.К. «Сестринское дело»
7. kingmed.info/knigi/Sestrinskoe_delo/book_2207
8. С.В.Котова «Сестринское дело в неврологии»
9. labirint.ru
10. Э.В.Смолина «Сестринское дело в терапии»
11. livelib.ru
12. В.Тульчинская ,Н.Соколова,Н.Шеховцова «Сестринское дело в педиатрии» 59-60 бет

ISBN 978-601-08-0758-7

РАЗВИТИЕ НАУЧНОГО ОБРАЗА МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ ПРИКЛАДНОГО БАКАЛАВРИАТА ЗА СЧЕТ КАЧЕСТВЕННОГО ПОДХОДА К ИЗУЧЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Асимжанова Д.А., 1 курс, специальность «Сестринское дело»
КГП на ПХВ «Высший медицинский колледж» Управления общественного здравоохранения города Алматы
Научный руководитель Индершиева Е.В., магистр медицинских наук, преподаватель ЦМК №5 «Сестринское дело»

Аннотация: *данная статья рассматривает причины возникновения трудностей в поиске зарубежной научной литературы у студентов прикладного бакалавриата, предлагает алгоритм поиска иностранных научных публикаций. В статье показан сравнительный анализ трудностей в поиске зарубежной научной литературы до и после использования обучающего методического материала, который позволил студентам справиться с этой проблемой.*

В Государственной программе развития образования и науки Республики Казахстан на 2020 - 2025 годы указаны следующие задачи: обеспечить безопасную и комфортную среду обучения, укрепить интеллектуальный потенциал науки, модернизировать и оцифровать научную инфраструктуру[1].

Научные исследования - одно из новых направлений развития в сестринском деле. Анализ зарубежного опыта указывает на качественные изменения в системе оказания медицинской помощи населению в связи с внедрением в практику лечебных учреждений результатов сестринских исследований [2].

Научно-обоснованная клиническая практика представляет собой подход для решения проблем в принятии клинических решений, который включает в себя передовые и наиболее актуальные свидетельства, клинический опыт и оценку. Это подразумевает сбор, обзор, интерпретирование, критику, оценку исследований и иной соответствующей литературы. Выпускник образовательной программы прикладного бакалавриата по специальности «Сестринское дело» должен критически оценивает информацию в области биомедицинских и сестринских исследований, принимает обоснованные решения на основе доказательной сестринской практики. [3].

Для выявление проблем и поддержки научно-исследовательского потенциала было проведено сравнительное социологическое исследование путем анкетирование студентов по вопросам причин возникновения трудностей в поиске зарубежной научной литературы до и после использования обучающего методического материала. Методический

ISBN 978-601-08-0758-7

материал был разработан в виде алгоритма поиска научных статей на иностранном языке для студентов прикладного бакалавриата. А также записан видео урок - пошаговая инструкция, которая облегчает поиск научных статей по выбранной студентами теме. В опросе приняли участие 55 человек из числа студентов прикладного бакалавриата.

Целевые группы: студенты высших медицинских колледжей по образовательной программе прикладного бакалавриата специальности "Сестринское дело"

Методы исследования:

- количественный
- социологический (основан на анкетировании и интервьюировании)
- математический

Место проведения: город Алматы, ВМК.

Цель исследования: создание обучающего методического материала для развития научного образа мышления у студентов

Задачи исследования:

1. Провести анкетирование студентов по вопросам причин возникновения трудностей в поиске зарубежной научной литературы
2. Разработать алгоритм поиска иностранных научных публикаций
3. Провести сравнительный анализ причин возникновения трудностей в поиске зарубежной научной литературы до и после использования обучающего методического материала

Респондентам задавался вопрос: "Испытываете ли затруднения при поиске научных статей в зарубежных изданиях?" Большинство студентов (97%) ответили на этот вопрос положительно. (рисунок 1)

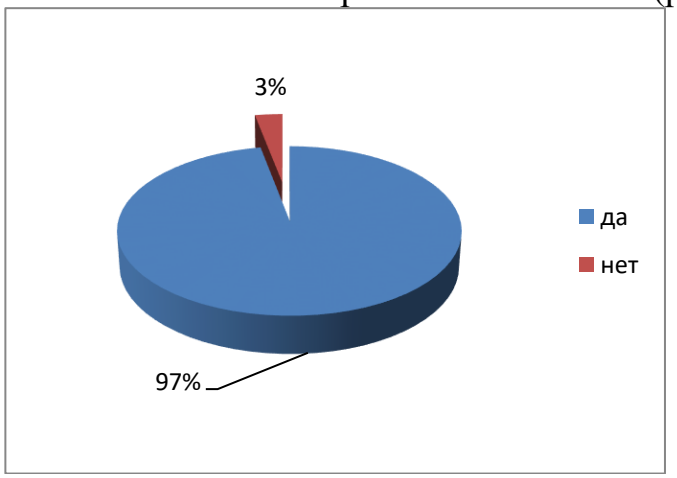


Рисунок - 1. Распределение ответов на вопрос: "Испытываете ли затруднения при поиске научных статей в зарубежных изданиях?"

Для выяснения причин затруднения поиска научных исследований в зарубежной литературе был задан вопрос: "Считаете ли, что недостаточные знания английского языка являются причиной затруднения поиска научных статей в зарубежных изданиях?" 72 % ответили положительно. 69%

ISBN 978-601-08-0758-7

респондентов назвали причиной затруднения поиска научных статей в зарубежных изданиях плохое владение компьютером.

На вопрос: "Считаете ли, что недостаточные знания алгоритма действий являются причиной затруднения поиска научных статей в зарубежных изданиях?" утвердительно ответили 83 % опрошенных. (рисунок 2)

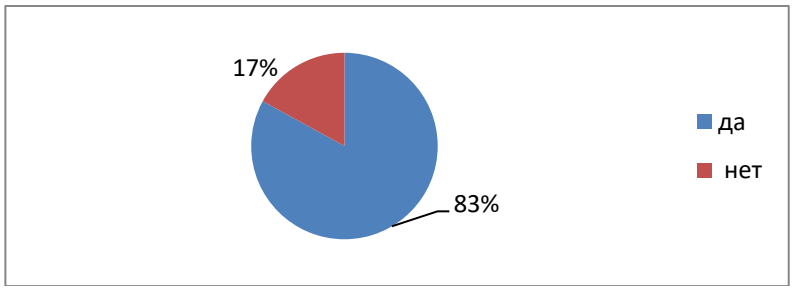


Рисунок - 2. Распределение ответов на вопрос: "Считаете ли, что недостаточные знания алгоритма действий являются причиной затруднения поиска научных статей в зарубежных изданиях?"

Плохой интернет назвали причиной затруднения поиска научных статей половина опрошенных студентов 51%.

По результатам этого опроса было решено в помощь студентам создать подробную видео инструкцию по поиску научных статей на иностранном языке. А так же мы разработали алгоритм действия этого поиска. Ознакомиться с видео уроком и алгоритмом поиска научной статьи можно по ссылкам.

1. обучающее видео:

https://drive.google.com/file/d/1SBHhuIqV--lNFtyt1VC9BqJJj3WWkHRl/view?usp=drivesdk

2. алгоритм поиска статей: https://docs.google.com/file/d/1M1XTQtdH22JvMlU7QEdOXy_xF7FSKH6Q/edit?usp=docslist_api&filetype=msword

После просмотра видео ролика о поиске научных статей и применения его на практике мы попросили этих же студентов еще раз пройти анкетирование. После анализа полученных ответов, получили следующий результат.

На вопрос: "Испытываете ли затруднения при поиске научных статей в зарубежных изданиях?" положительный ответ снизился с 97% до 2%. (рисунок 3)

ISBN 978-601-08-0758-7

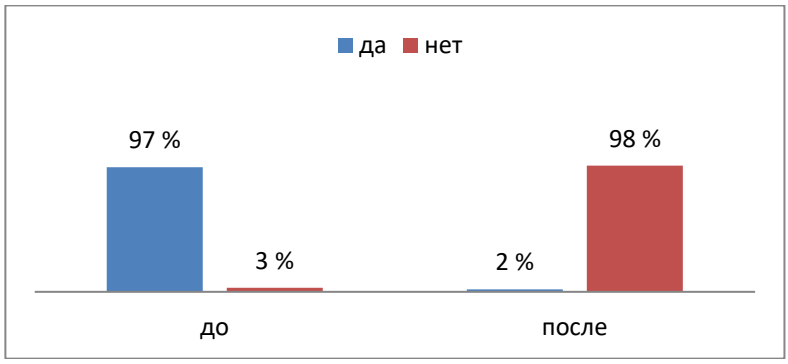


Рисунок - 3. Распределение ответов на вопрос: "Испытываете ли затруднения при поиске научных статей в зарубежных изданиях?"

Положительная динамика наблюдается и в причинах затруднения поиска научной статьи на иностранном языке. Слабые знания английского языка как причина снизилась с 72 % до 28%. Плохое владение компьютером назвали причиной затруднения только 20 %, по сравнению с 69% до просмотра обучающего видео. Незнание алгоритма действия в поиске научной литературе снизилось с 83% до 2 %. И даже плохой интернет стал меньше мешать поиску научной литературы (до обучающего видео 51%, после 33%). (рисунок 4)

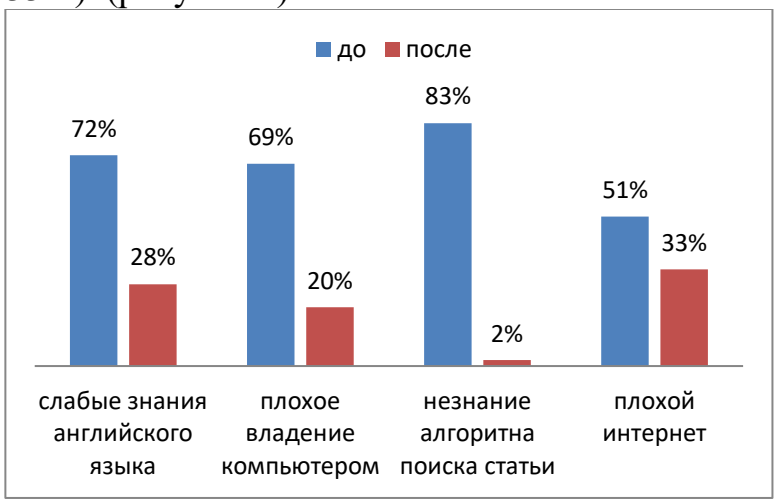


Рисунок - 4. Динамика причинах затруднения поиска научной статьи на иностранном языке.

Выводы

В результате анализа полученных данных были сформулированы следующие выводы:

1. Большинство студентов (97%) испытывают затруднения при поиске научных статей в зарубежных изданиях
2. В затруднении поиска научных статей на иностранном языке были названы причины - незнание алгоритма поиска статей (83%) и слабые знания английского языка (72%)

ISBN 978-601-08-0758-7

3. Обучение студентов по видео инструкции и алгоритму поиска научных статей в иностранных базах данных позволяет студентам справиться с этой проблемой.

Рекомендации

На основании данных выводов для совершенствования образовательного процесса и повышения качества подготовки медицинских специалистов

были предложены следующие рекомендации:

1. Рекомендовать разработанные нами видео урок и алгоритм поиска научных статей как методическое пособие для студентов прикладного бакалавриата.

Список использованной литературы:

1. Государственная программа развития образования и науки Республики Казахстан на 2020 - 2025 годы

2. Burns and Grove's The Practice of Nursing Research: Appraisal, Synthesis, and Generation of Evidence 2017г.)

3. Руководство для высших медицинских колледжей в вопросах реализации программы прикладного бакалавриата, Нур-Султан, 2019 г

ISBN 978-601-08-0758-7

ТЫНЫС АЛУ АУРУЛАРЫ БАР НАУҚАСТАР АРАСЫНДА ҰЙЫМДАСТЫРЫЛҒАН «ДЕНСАУЛЫҚ МЕКТЕБІНІҢ» ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Бердіш Б.Қ., «Мейіргер ісі» мамандығы, 2 курс студенті

Шымкент жоғары медицина колледжі

Ғылыми жетекшілері: Тұрарова Д.Т., оқытушы, Турбекова Б.С., бөлім меңгерушісі

Аннотация: *Тыныс алу жүйесі бар науқастарды тиімді емдеудің көптеген жағдайлары пациенттердің аурудың мәнін түсінбеуімен байланысты, бұл дәрігердің нұсқауларын дұрыс орындамауға әкеледі [1, 2]. Біздің елімізде пациенттердің өз аурулары туралы білімінің төмен деңгейі байқалады. Пациенттердің өз патологиялары туралы білмеуі, өзін-өзі бақылау дағдыларының болмауы, дәрі-дәрмектерді дұрыс пайдалану мүмкін еместігі ауруды сәтті жеңуге айтарлықтай кедергі болып табылады, бұл шиеленістің, ауруханаға жатқызудың, жедел жәрдем шақыруларының жиілеуінде көрінеді және өмір сүру сапасының төмендеуіне және емдеудің қымбаттауына әкеледі[3, 4].*

Емдеудің тиімділігін арттырудың бір жолы-денсаулық мектебі, демікпе Күні, науқастарға көмек телефондары, танымал ғылыми әдебиеттер, видео фильмдер, интернет - сайттар арқылы тәуелсіз білім беру сияқты әртүрлі оқыту формаларын қолдану. Оқытудың бұл түрлерінің қолданылуы пациенттің ерекшеліктеріне, сондай-ақ медициналық мекеменің мүмкіндіктеріне байланысты [5, 6, 7].

Аталған әдістердің ішінде денсаулық мектебі маңызды орын алады. Мектептің негізгі мақсаты - пациенттерді өзін - өзі басқаруға үйрету, яғни медициналық қызметкердің бақылауымен олардың жағдайын өз бетінше бақылауға қабілетті. Пациентті оқыту тұрақты тексеру және білімді жаңарту жағдайында ол мен медицина қызметкері арасында әріптестік орнатуды көздейді.. Өмірдің бірінші жылындағы тамақтану бұзылыстары бірқатар аурулардың пайда болу қаупін арттыруы мүмкін: аллергиялық аурулар, семіздік, метаболикалық синдром, остеопороз және басқа ауру түрлерін.

Зерттеудің мақсаты: Тыныс алу ағзасының аурулары бар науқастар арасында «Денсаулық мектебін» ұйымдастыру

Материал және әдістер. Тыныс алу жүйесі ауруларымен ауыратын науқастарға арналған мектеп ұйымдастырылды. Мектепте алынған білімнің сақталу деңгейін бағалау үшін бірінші және соңғы сабақтарда пациенттерге сауалнама жүргізілді. Екі ай бойы "мектепте" 17 жастан 72 жасқа дейінгі тыныс алу органдары аурулары бар 30 пациент оқудан өтті. Сауалнама

ISBN 978-601-08-0758-7

қорытындысы бойынша "шылым шегетіндер" тобы арасында 59% құрады, "темекі шекпейтіндер" – 32%, "кейде темекі шегетіндер" – 5,3%, "бұрынғы темекі шегушілер" – 3,7% құрады. "Темекі шегушілердің" 27% - ы бұл жаман әдеттен бас тартқысы келеді. "Темекі шегушілердің "19%– ы ауруды тыныс алудың қиындауы, ентігу деп санайды;" темекі шегушілердің " 32%-ы ауру ең алдымен жөтелмен сипатталады деген пікірмен бөліседі, 4% - ы ауру өкпенің ауырсынуымен сипатталады деп санайды, 14% - ы аурудың даму себебі нашар этиология, ауаның ластануы, науқастардың 3% - ы аурудың дамуының негізгі себебі зиянды өндірісте жұмыс жасау деп санайды.

Сауалнама деректерін талдау көрсеткендей, пациенттердің көпшілігінде олардың ауруы туралы білім деңгейі төмен және өзін-өзі бақылау дағдылары жоқ. Көптеген пациенттер пикфлоуметрлер мен спейсерлер туралы түсініктері болмаған, науқастардың бір бөлігі дозаланған аэрозоль ингаляторларын дұрыс қолданбаған, ингаляциялық препараттарды қолдану көрсеткіштерін білмеген. Науқастардың едәуір бөлігі негізгі терапияға теріс қатынасты анықтады. Барлық пациенттер қандай дәрі қабылдайтынын білмеді.

Зерттеуге қатысушы науқастар арасында «Денсаулық мектебі» ұйымдастырылды. Сабаққа қатысу ерікті болды, топтардың қалыптасуы кездейсоқ болды. Топтар әр түрлі жастағы және әртүрлі аурудың ұзақтығы бар 4-7 пациенттен тұрды. Топтық сабақтар бағдарлама бойынша науқастармен дәрістер, әңгімелер түрінде өткізілді. Сабақтың жалпы ұзақтығы күніне 1-1,5 сағаттан 4-6 күн болды. Әңгімелесудің негізгі тақырыптары:

* тыныс алу ағзаларының аурулары, тыныс алу ағзаларының анатомиясы мен физиологиясы дегеніміз не;

* себептері ;

* аллергия, оның алдын-алу және емдеу;

* өз-өзіне көмек көрсету әдістері;

* суық тию (респираторлық вирустық инфекцияны емдеу және алдын-алу);

Нәтижелері. Мектептің жұмысы мынадай нәтижелер көрсетті: пациенттердің 42% - ы "темекі шегуді азайту керек" деп ойлады, пациенттердің 31%-ында салауатты өмір салтына тұрақты мотивация қалыптасты, 12% – ында салауатты өмір салтын жүргізуге және қазіргі заманғы дәрілік заттармен емдеуге деген ұстамдылық артты. Науқастардың 90% ауру туралы білімі артты. Мектепте дәрілік заттарды дұрыс қабылдауға, шұғыл жағдайларда медициналық көмек көрсетуге оқыту жүргізілді.

Қорытынды: Алынған мәліметтер әзірленген оқу бағдарламасының тиімділігін және оны кеңінен қолданудың орындылығын дәлелдейді. Пациенттерді оқыту аурудың асқыну қаупін, жедел жәрдем шақыру жиілігін және ауруханаға жатқызуды азайтуға, тыныс алу мүшелері бар науқастардың

ISBN 978-601-08-0758-7

өмір сүру сапасын жақсартуға, сондай - ақ емдеуге жұмсалатын түпкі шығындарды азайтуға көмектеседі. Оқыту науқастарды амбулаториялық және стационарлық медициналық көмек кезеңінде кешенді басқарудың маңызды элементі болуы керек.

Әдебиеттер тізімі:

1. Белевский А.С., Булкина Л.С., Княжеская Н.П. Обучение больных бронхиальной астмой, на- ходящихся под амбулаторным наблюдением // Пульмонология. 2016. С. 25–32.
2. Белевский А.С., Булкина Л.С., Княжеская Н.П. Организация и проведение занятий в астма- школе: Метод. рекомендации. М., 2006.
3. Глобальная стратегия лечения и профилактики бронхиальной астмы. Пересмотр 2002 г. / Пер. с англ. под ред. Чучалина А.Г. М., 2012.
4. Собченко С.А., Коровина О.В. Обучение боль- ных бронхиальной астмой в комплексе их ле- чения // Международные медицинские обзоры, 2003. № 2. С. 120–123.
5. Собченко С.А., Коровина О.В. Опыт работы “Школы для больных бронхиальной астмой” // Пульмонология. 2011. № 3. С. 14–19.
6. Horn C.R., Cochranen G.M. Management of asthma in general practice // Respir. Med. 2019. V. 83. P. 67–70.
7. Muhlhauser I., Richter B., Kraut D. et al. Evaluation of a structured treatment and program on asthma // J. Intern. Med. 2011. V. 230. P. 157–164.

ISBN 978-601-08-0758-7

ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

Дукумбаева Эрика Амантаевна, 2 курс,
специальность «Сестринское дело»
«Казахстанско-Российский Высший медицинский колледж» г. Алматы
Научный руководитель Шерембетова Акмарал Айтбаевна, преподаватель ОПД

Аннотация: *В работе рассматривается один из важных научных подходов к решению проблем в медицине, такой как необходимость внедрения профессий будущего здравоохранения, а так же важность наличия определенных психологических качеств у студентов - медиков, для работы по данным профессиям. Приводятся результаты проведенного автором эмперического исследования на уровень коммуникативных навыков и уровня конфликтности студентов КРВМК.*

В 21 первом веке появляется очень много необычных и современных профессий. Медицина всегда была крайне важной сферой для человека, однако ее значение в будущем будет только расти. На сегодняшний день профессии будущего в медицине и здравоохранении не мало важна для человечества. Так как они являются востребованными специальностями в сферах медицинских учреждений, оздоровительных центрах, SPA-салонах и различных курортных организациях.

Профессии будущего больше востребованы в таких городах как Москва, Нур-Султан, Санкт-Петербург, Алматы, Омск, Киров, Шымкент и др.

Актуальность темы является в том, что, в информации по вопросу профориентации, а так же, возникновению и развитию инновационных профессий, которую мы получаем сегодня из разных источников, все больше говориться о профессиях будущего. Исключением не является и область медицины и здравоохранения. Сегодня, такие профессии как, R&D менеджер, Архитектор медицинского оборудования, ИТ-генетик, Врач персонифицированной (прецизионной) медицины, Медицинский маркетолог здравоохранения является одной из популярнейших профессий будущего.

Цель данной работы- изучить профессии будущего в здравоохранении.

Для достижения цели были поставлены следующие ***задачи:***

1) Изучить теоретический обзор темы
2) Провести экспериментальное исследование на профориентацию современных профессий в здравоохранении.
3) Подтвердить или опровергнуть поставленную гипотезу, сделать соответствующие выводы.

Гипотеза исследования – предполагаю, что из общего числа студентов КРВМК, половина из них и более (т.е. 50 % и более) по проф-

ISBN 978-601-08-0758-7

ориентационным критериям соответствуют требованиям современных профессией.

Объект исследования – студенты первого и второго курса отделения « Лечебное дело» и «Сестринское дело», Казахстанско-Российского Высшего медицинского колледжа г. Алматы.

Предмет исследования – Профориентация студентов-медиков на пригодность к современным профессиям в здравоохранении.

Методы исследования: синтез, анализ, метод беседы, метод наблюдения, опрос, психолого-диагностические методики такие, как: тест поведение в конфликтной ситуации Томас -Килманн, опросник Томаса, тест В.Ф. Ряховского на коммуникабельность.

Практическая значимость: данная работа будет полезна и интересна студентам-медикам, преподавателям медицинских учреждений, социологам, психологам, работникам здравоохранения.

Теоретический обзор профессий будущего в здравоохранении

R&D менеджер здравоохранения - это профессионал, в области управления не только профилактическими, но и лечебно-диагностическими медицинскими центрами. Необычный вид данной профессии заключается в том, чтобы подобрать подходящих работников такие, как разработчики медицинских технологий, учёных по биотехнологиям, тканевых инженеров (разработчик по формированию конкретной ткани или органа). С помощью этой команды выполняются поставленные цели и задачи организации, где создаются высокоперспективные идеи.

Архитектор медицинского оборудования - это специалист, который разрабатывает медицинское оборудование и медицинские приборы, занимается их проектированием, сопровождает весь цикл производства, пусконаладки и эксплуатации, развивает и совершенствует оборудование в соответствии с появляющимися новыми технологиями.

ИТ-генетик - это специалист, который занимается программированием генома под заданные параметры. В последнее десятилетие одним из бурно развивающихся направлений в медицине стала генотерапия – внесение в генетический аппарат человека изменений для борьбы с заболеваниями.

Врач персонифицированной (прецизионной) медицины - это специалист, который разрабатывает лечение пациента в соответствии с его индивидуальными особенностями: генетическими, эпигенетическими, транскриптомными, протеомными, метаболомными и метагеномными маркерами, а также совокупностью вариативных фенотипических признаков как всего организма пациента, так и его отдельных тканей или клеток.

Медицинский маркетолог специализируется на медицинских рынках. Он занимается анализом рынка медицинских товаров (фармакология, медицинское оборудование, материалы) и услуг, разрабатывает маркетинговую политику организаций, работающих в сфере медицинской техники и услуг, стратегию продвижения медицинских товаров и услуг.

ISBN 978-601-08-0758-7

Продвижение и брендинг медицинских организаций, клиник, лабораторий, производителей медицинского оборудования и материалов также входит в зону ответственности данного специалиста.

Какие обязанности существуют у профессий будущего в здравоохранении?

- бюджетное планирование
- управление различными проектами
- разработка устройств и новых технологий
- решение материальных вопросов
- оценка бизнеса плана деятельности предприятия
- контроль за движением и изменением тенденций в здравоохранении
- внедрение современной продукции и комплекс услуг
- достижение поставленных целей и задач по содействию здравоохранения
- побуждение к действию работы в организации
- компетентность между сотрудниками
-обладать законодательной базой, оказываемых медицинских и фармацевтических услуг

Какие требования выносятся к данным профессиям?

- хорошие знания в сфере медицины и в управлении инновационными проектами
- понимать толк современных тенденций в здравоохранении
- ловкость, быстрое привыкание к новым условиям, полная концентрация внимания к работе, умение решать конфликтные ситуации
- низкий уровень конфликтности
- высокий уровень коммуникабельности

Преимущество профессии менеджера здравоохранения:

- крутая, прибыльная работа
- обеспечение спокойствие на рабочем месте
- помощь людям

2. Диагностическое исследование на профпригодность студентов КРВМК профессией будущего в здравоохранении

Для более полного изучения темы, нами было проведено эмпирическое исследование, направленное на профориентацию изученных нами современных профессий в здравоохранении. В связи с этим, была поставлена *гипотеза исследования* – среди студентов-медиков КРВМК второго курса, специальности «Лечебное дело» и «Сестринское дело», более пятидесяти процентов соответствуют современным профессиям по психологическим признакам, а именно по уровню конфликтности и коммуникации.

Объектом исследования являлись студенты, КРВМК первого и второго курса. Выборка являлась случайной и составила 60 человек.

Предмет исследования - профориентация студентов-медиков на пригодность к современным профессиям в здравоохранении.

ISBN 978-601-08-0758-7

Цель исследования – выявить пригодность студентов КРВМК к современным профессиям здравоохранения.

Задачи исследования:

1) Подбор психодиагностических методик на уровень конфликтности и коммуникабельности.
2) Проведение тестирования
3) Обработка результатов исследование. Выводы.

Методы исследования: тест поведение в конфликтной ситуации Томас -Килманн, опросник Томаса, который показывает типичную реакцию на конфликт, но и объясняет, насколько она эффективна и целесообразна, а также дает информацию о других способах разрешения конфликтной ситуации, тест В.Ф. Ряховского на коммуникабельность.

Результаты исследования показали следующее: на выявление уровня конфликтности, менее конфликтными оказались студенты первого курса, чем студенты второго курса, по нашему мнению на эту разницу повлияло психометрическое тестирование, которое проходили первокурсники при поступлении в колледж, студенты второго курса, данное тестирование при поступлении не проходили. Среди студентов второго курса уровень конфликтности у студентов специальности «Лечебное дело» ниже чем у студентов специальности «Сестринское дело». Результаты исследования мы представили в виде гистограммы, рис 1.

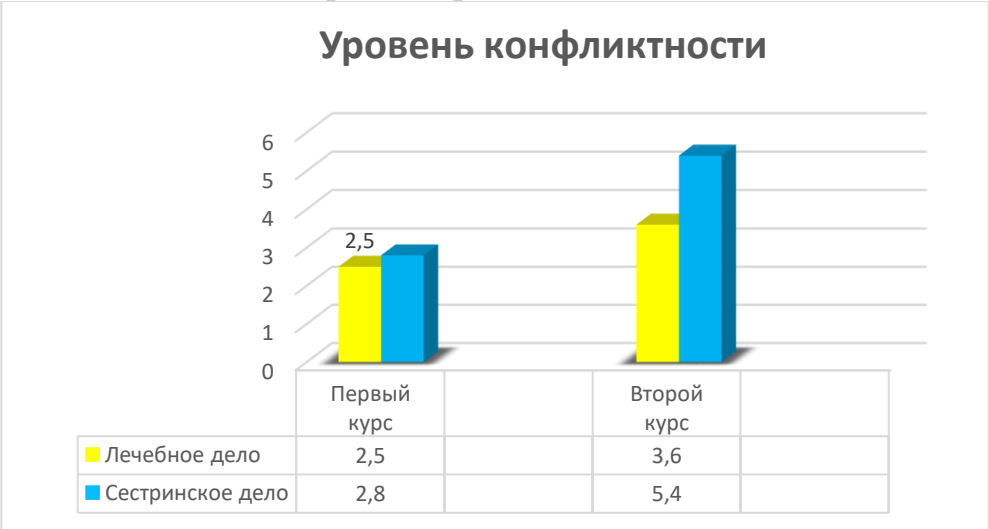


Рис. 1. Уровень конфликтности первого и второго курса.

Однако, по уровню коммуникации, показатель общительности был высок как у студентов первого, так и у студентов второго курса. Однако стоит отметить, что уровень общительности у студентов специальности «Лечебное дело», более высок чем у студентов специальности «Сестринское дело». Результаты исследования мы представили в виде гистограммы, рис 2.

ISBN 978-601-08-0758-7

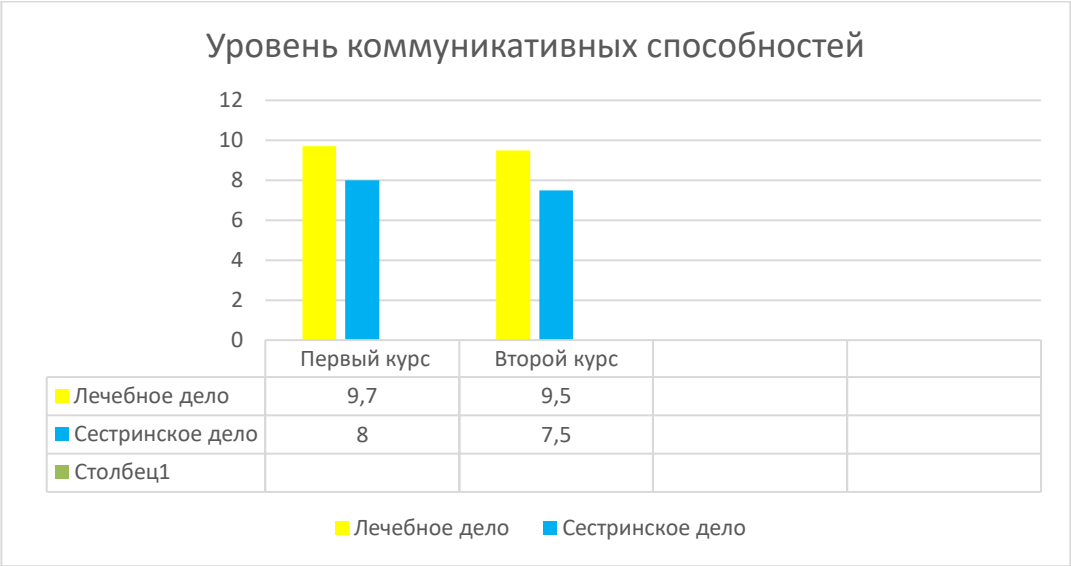


Рис. 2. Уровень коммуникативных способностей.

Заключение

И так, профессии будущего в здравоохранении стоят на пороге нашей жизни и требуют внимательного изучения в подготовки кадров медицинских работников. Эта задача ложиться на ведущие медицинские учебные заведения, которые идут в ногу со временем. Из теоретического обзора и теоретического исследования мы пришли к выводу, что помимо хороших и твердых знаний в области медицины, профессии будущего требуют наличие развитых психологических особенностей таких как, коммуникабельность, эмоциональная устойчивость, а так же стрессоустойчивость которая характеризуется низким уровнем конфликтности или отсутствие уровня конфликтности.

В связи с этим, нами было проведено исследование, где была поставлены гипотеза, цель и задачи на выявление соответствия профессиональных требований современных профессий здравоохранения у студентов КРВМК г. Алматы.

Диагностического исследования показало, что важными показателями такими как низкий уровень конфликтности и высокий уровень коммуникабельности студенты КРВМК владеют на должном уровне и соответствуют по данным критериям профпригодности к современным профессиям здравоохранения, стоит отметить, что более высокие показатели, а именно 87% согласно исследованию у студентов первого курса, специальности «Лечебное дело». Таким образом поставленная нами гипотеза подтвердилась. Задачи выполнены, цель достигнута.

Медицина будущего принесет с собой сверхточную диагностику состояния здоровья на протяжении всей жизни и возможность прогнозировать свои заболевания и заболевания потомков, поэтому так необходимо уже сегодня готовить кадры, соответственно требованию профессий будущего которые актуальны уже сейчас.

ISBN 978-601-08-0758-7

Список использованной литературы

1. Твоя будущая профессия. Сборник тестов по профессиональной ориентации, Н. В. Тутубалина. М., 2006г.
2. Основы профориентологии. – М.: Издательский центр «Академия», 2009.
3. Бедарева Т., Грецов А. 100 популярных профессий. Психология успешной карьеры для старшеклассников и студентов. - Спб, 2008.
4. Козловский О.В. Как правильно выбрать профессию: методики, тесты, рекомендации. – Донецк.- 2006. – 800 с.
5. Минюрова С. Психология саморазвития человека в профессии. - Москва, 2008.

ISBN 978-601-08-0758-7

МЕДИЦИНАЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРДІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Дүйсембек Д.Қ. 4-курс студенті «Мейіргер ісі» мамандығы
Талдықорған қаласы «Авиценна» медициналық колледжі
Ғылыми жетекшісі Омаров Б.Н. арнайы пән оқытушысы

Аннотация. *Бұл мақалада қазіргі таңдағы медициналық зерттеудің өзекті мәселелері қарастырылды. Ауылдық жердегі медициналық көмектің жетіспеушілігі, керекті құрал-жабдықтардың жетіспеушілігі және өзгеде халықтың денсаулығына байланысты әртүрлі ахуалы жоғары сұрақтар мен мәселелер көтерілді.*

Медицинадағы зерттеулердің өзекті мәселелері

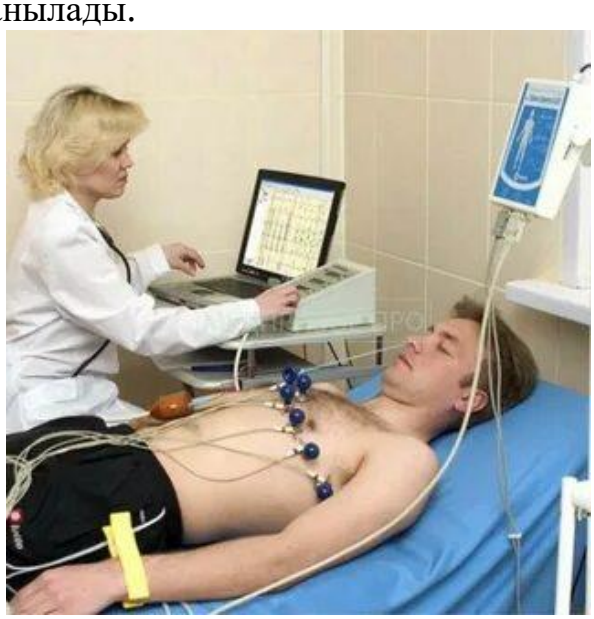
Медициналық зерттеу – ғылыми әдістермен адам денсаулығы, аурулар, олардың диагностикасы, емдеу немесе профилактикасы туралы анықтау.

Жалпы әдістер: Көру, сұрау, анамнез жинау, тексеру, пальпация, перкуссия, аускультация, антропометрия және термометрия,.

Арнайы әдістер:

1. зертханалық-қан, нәжіс,зәр, сұйықтықтарды зерттеу;
2. аспаптық-ЭКГ,ФЛГ, рентген, УЗИ, ФГДС, КТ, МРТ рентгеноскопия;
3. функционалдық-бауырды, бүйректі, жүректі зерттеу.

Ал 1 симптомды анықтау үшін бір-бірнеше зерттеу әдістері қолданылады.



ISBN 978-601-08-0758-7





Медицина саласында халыққа қандайда бір медициналық көмек көрсету, емшара жүргізу алдында толық зерттеуден өткізеді. Медициналық зерттеулер түрлерінің ұсынылған классификациясына сипаттамалық, эксперименттік және бақылау зерттеулері сияқты негізгі зерттеу топтары кіреді. Әртүрлі зерттеулердің нәтижелері мен кемшіліктері келтіріліп, олардағы ғылыми жаңалық пен ғылыми-практикалық қызығушылықтың бар-жоғы қарастырылады.Ауруды уақтылы және дұрыс диагностикалау науқасты жүйелі және мұқият тексеруге байланысты. Бұл жағдайда дәрігер субъективті және объективті зерттеу әдістерін қолданады: біріншіден, сұрақ қою арқылы науқастың шағымдарын, оның ауруы мен өмірінің тарихын (анамнезін) зерттейді, содан кейін науқастың объективті жағдайын зерттейді (тікелей, немесе физикалық тексеру), тексеру әдістерін қолдана отырып, пальпация, перкуссия және аускультация, содан кейін зертханалық және аспаптық зерттеулер жүргізеді.Ең жиі кездесетін ауруларды диагностикалау үшін қолданылатын медициналық зерттеулердің негізгі түрлеріне дәстүрлі түрде мыналар жатады: жалпы қан және зәр анализі, биохимиялық қан анализі,нәжіс анализі бактериологиялық зерттеулер, иммуноферменттік

ISBN 978-601-08-0758-7

талдау (ИФА) және полимеразды тізбекті реакция әдісі (ПТР).Қазіргі заманда компьютерлік томография, ультрадыбыстық эхолокация, стереофотограмметрия, ядролық магниттік резонанс және т.б. сияқты жаңа зерттеу әдістері қолданылуда [1,85бет].

Жоғарыда айтылғандай қандайда медициналық көмек көрсетілмес бұрын міндетті түрде медициналық зерттеулер өткізіледі.

Біз "науқас келіп, талдауға анализ тапсырды, зерттеуден өтті"деп жеңіл түрде айта аламыз. Былай қарасақ бұл жерде артық мәселе болуы мүмкін емес. Алайда біз медицина қызметкері ретінде емес,қарапайым халық тарапынан медициналық зерттеулердің қазіргі таңдағы мәселелеріне талдау жасадық.

Ендігі айтылатын тақырып:

"Қазіргі таңда медициналық зерттеулердің қандай өзекті проблемалары бар?"

"Халыққа зерттеуден өту қаншалықты тиімді?"

"Қаншалықты қолжетімді?"

"Қарапайым халық керек зерттеулері мен талдауларын уақытылы, артық мәселесіз ала алады ма?" осы сұрақтарды негізге ала отыра сөз қозғасақ.

Ең бірінші мен "талон", "кезек" мәселесін қозғағым келіп тұр.Ауруханадағы кез-келген кабинетке талонсыз кіре алмайтынымыз белгілі. Ол талонды алу үшін 2-3 күн бұрын жазылу керек. Ең қызығы 3 күн күтіп талонмен барып, кезекке түсіп қалуын. Кей адамдар талон алады, кей адамдар ауруханада үйреншікті болып қалған шу шығарып кезекке таласып кіреді. Әр адамның жағдайы әр түрлі болғандықтан бұл жағдай көпшілікке ыңғайсыздық тудырады.



Сонымен қатар ауылдық, аудандық аймақта тұратын халыққа аспаптық зерттеуге түсу қиындық тудырады.

ISBN 978-601-08-0758-7

Ауылдық жерлердегі ауруханалар жабдықталмағандықтан ЭКГ немесе КТ түсіру үшін қанша жүз шақырымды артқа тастап қалаға келіп түсіруге тура келеді.

Келесі мәселе портал арқылы емделетін науқастар туралы. Бұл тұрғыда біз зәр немесе қан талдауларының жарамдылық мерізімін атап айтсақ болады. Яғни науқасты порталға тіркегенде жалпы зәр,қан анализі, биохимиялық қан анализі алынады. Анализдің жарамдылық мерізімі 10 күн. Науқас анализ тапсырған күн және ауруханаға жатқан аралықта 10 күн өтіп кетуі мүмкін. Сәйкесінше ауруханаға жатқызылған соң қайта анализ тапсырылады. Науқаста белгілі бір ауру түрі болғандықтан қанында да қандай да бір өзгеріс болуы мүмкін. Сондықтанда ауруханадағы ем-шара тек анализ нәтижесі шығарылған соң ғана жасалады. Бұл аралықта тағы бір мәселе шығуы мүмкін. Бұл аурудың асқынуы және оның салдары.

Қоғамдағы ахуалы жоғары мәселе зерттеу түрлерінің ақылы түрде болуы. Рентген, флюорография және қан талдаулары соның ішінде ВИЧ және гепатит ауруына тапсыратын анализдар [2,123бет].

Бұл анализдерді тапсыру ақылы түрде жүргізіледі. Қарапайым халықтың бірінің қалтасы көтерсе, бірі көтере алмайды. Ал біздің негізгі мақсатымыз халыққа салмақ салу емес, барынша қолайлы жағдай жасау.

Аталған факторлар ауқымды мәселе болмауы да мүмкін, бірақ осындай кішкентай мәселенің арты үлкен шиелініске әкеп соғуы әбден мүмкін. Сол себепті де халықтың жағдайы жан-жақты ойластырылуы керек. Халық өзіне керек көмекті толыққанды, еш қиындықсық, шығынсыз алуы тиіс деп ойлаймын. Медицина қызметкері болғандықтан, халықтың жағдайын жақсарту біздің негізгі және басты мақсатымыз. Сол мақсатымыздан жаңылмайық.

Әдебиеттер тізімі:

1.Курноскина В.П Пациенттің клиникалық жағдайын бағалау 2021ж.

2.Б.Г. Исаева Жалпы тәжіребиелік дәрігер жұмысындағы ішкі аурулар бойынша дәрістер 2019

ISBN 978-601-08-0758-7

МЕЙІРГЕР ІСІНДЕГІ ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ

Есенбекова Г. М. 4 курс «Мейіргер ісі» мамандығы
Талдықорған қаласының «Авиценна» медициналық колледжі
Ғылыми жетекшісі Сарбасова Д. Р. арнайы пән оқытушысы

Аннотация: *Бұл мақала қарастырады мейіргелік ісіндегі ағымдағы дамуы, алғашқы медициналық санитарлық көмек деңгейінде мейіргерлердің міндеттерін анықтау, оңалту кезеңіндегі мейіргерлік іс, сондай-ақ пациенттерді өз-өзіне қызмет көрсетуге көрсету және оқыту сиякты өзекті бағыттары.*

Мейіргер ісі саласындағы зерттеулер шынайы, ғылыми негізделген деректерді алу әдісі. Біз өз кәсіби қызметімізді осы әдіспен жоғары деңгейде дамыта аламыз. Егер біздің мамандық бойынша ғылыми зерттеулер жүргізілмесе, біз қойылған мақсатқа қол жеткізе алмаймыз, мәселелерді шеше алмаймыз және мейіргер ісін дамыту маңыздылығы туралы түсінік қалыптастыра алмаймыз.

Қазақстандағы мейіргер ісіндегі зерттеу тақырыбы бойынша ұсыныстар Delphi study арқылы 2019 жылы анықталды. Барлығы 168 қазақстандық денсаулық сақтау маманы біздің қызметіміздің әр түрлі салаларын ұсынған сұрақтарға жауап берді. Жүргізілген зерттеу негізінде бірнеше маңызды бағыттар анықталды:

1. Ауыр жағдайдағы науқастарға шұғыл медициналық көмек көрсету.
2. Жүрек қан-тамыр аурулары кезіндегі наұқастарға күтім.
3.Онкологиялық мейіргер міндеттерін қарастыру.
4. Мейіргер ісіне жаңа технологияларды енгізу.

Мейіргерлік қызметте жүргізілетін ғылыми зерттеулер- бұл білім беру саласына қатысты клиникалық, басқарушылық мәселелерді анықтауға болатын бір жүйелі процесс. Мейіргер ісіндегі студенттік зерттеу тақырыптарының арасында Қазақстандағы мейіргерлік істің ағымдағы дамуы, алғашқы медициналық санитарлық көмек деңгейінде мейіргерлердің міндеттерін анықтау, оңалту кезеңіндегі мейіргерлік іс, сондай-ақ пациенттерді өзіне-өзі қызмет көрсетуге қолдау көрсету және оқыту сияқты өзекті бағыттар бар. Олар проблемалық жағдайларды шешу үшін жаңа ақпарат алуға тырысады. Мейіргер ісіндегі ғылыми зерттеулер жүргізудің басты мақсаты, әрине, оның **дамуы, теориялық** және **клиникалық с**апасын арттыру[1,46бет].

Түйінді сөздер: мейіргер ісі, ғылыми зерттеулер, мейіргер ғылымы, мейіргер ісіндегі ғылыми зерттеулер. Мейіргер көрсететін күтім барынша жоғары нәтижелерге қол жеткізуді қамтамасыз ету үшін қазіргі замандағы білімдер мен ғылыми зерттеулерге негізделуі тиіс. Мейіргер зерттеулерінде құрылған берік дәлелі бар жаңа білім базасын жасайды.

ISBN 978-601-08-0758-7

Мейіргерлердің сыни ойлау қабілеттілігі, аналитикалық және критикалық дағдыларға ие болуы, зерттеулер мен дәлелдемелерге қол жеткізу процестерін сыни түсінуге ие болуына ықпал етеді. Зерттеуге байланысты этикалық мәселелер туралы хабардар болуы бар зерттеуді сынай білу, бағалау және дәлелдемелердің басқа да түрлерін білу керек. Осы дағдыларға және "зерттеу әдебиетіне" ие бола отырып, мейіргер өзінің практикалық қызметінде дәлелдемелердің нақты түрлерін пайдаланудың орындылығын бағалай білуі тиіс.

Флоренс Найтингейл жиі бірінші мейіргер -зерттеуші ретінде қарастырылады. Оның зерттеулері 1850-ші жылдары Қырым соғысы кезінде сарбаздардың аурушаңдығы мен өлім - жітіміне шоғырланған. Найтингейл тәжірибеде "зерттеу" сұрақтарын анықтап, осы мәселелерге жауап табуға тырысу үшін деректерді жүйелі түрде жинауды қолға алды. Оның" зерттеуі " ауру адамдар үшін, қоршаған ортадағы өзгерістер, оның ішінде тазалық, желдету, таза су және дұрыс тамақтанудың маңыздылығын атап айтып кетті. Ол 1959 жылы зерттеу пікірталас тобымен, мейіргер зерттеушілері үшін алғашқы өзін-өзі көмек көрсету тобын құрды. Бұл бүгін де жалғасып жатқан мейіргер ісі колледжінің зерттеу қоғамы болуда жалғасты. Мейіргер ісі саласындағы зерттеулердің өсуі баяу болса да, ол дамуды жалғастырады және практикамен, саясатпен, білім берумен және басқарумен байланысты кең ауқымға ие болды. Оған, мысалы, мейіргерлік күтім тиімділігі туралы зерттеулер, медициналық көмек көрсетудің жаңа түрлерін әзірлеу және бағалау, мейіргерлік істің теориялары мен тұжырымдамаларын кеңейту, саясаттың тәжірибеге әсері, мейіргерлік персоналды оқытудың жаңа рөлі мен жаңа тәсілдері кіреді.

Мейіргер мамандығы өз зерттеу корпусын дамыту және денсаулық сақтау және әлеуметтік ғылымдар саласындағы зерттеулерге өз үлесін қосу үшін үнемі өсіп келеді. Медициналық зерттеулердің табиғаты күрделі. Біз қазірдің өзінде науқастарды күту саласындағы зерттеулер жүргізе отырып, тәжірибе, күтім, білім беру және басқару нәтижелері саласындағы зерттеулерді қамтылды. Сонымен қатар, мейіргерлер кәсіби то құрамында және түрлі медициналық мекемелерде жұмыс істейтінін есте сақтаған жөн. Осыған байланысты кәсіби жұмыспен байланысты бірқатар проблемалар мен мәселелер туындауы мүмкін. Бұл факторлар мейіргерлік зерттеулерінде әсер етеді[1,123бет].

Мейіргер ісі саласындағы зерттеулерді анықтау барысында, мейіргер ісінде зерттеумен айналысатын адамдардың көзқарасын көрсетеді. Денсаулық сақтау және медициналық қызмет көрсету саласындағы зерттеулерді сипаттай отырып, зерттеудің жүйелі және қатаң процесі ретінде анықтайды, оның мақсатын сипаттау және түсіндіру, тұжырымдамалары мен теорияларын әзірлеу болып табылады. Ол білімнің ғылыми жиынтығына өз үлесін қосуға бағытталған . Содан кейін бұл зерттеулер басқа да денсаулық сақтау саласындағы пән аралық зерттеулердің маңыздылығын түсінуге

ISBN 978-601-08-0758-7

көшеді. Олардың әрқайсысы зерттеудің мән мағынасын анықтайды және ол қалай жүргізілуге тиіс деген өз көзқарасымен келеді. Осылайша, мейіргер ісі саласындағы ғылыми зерттеулерді анықтау кезінде зерттеу топтарының әлеуетті пән аралық сипатын және зерттеу проблемаларының кең ауқымын шешу үшін пайдаланылатын "сапалық" және "сандық" зерттеу әдістерінің бұдан туындайтын кең спектрін ескеру қажет. Ғылыми зерттеулер анықтамаларын қарауға көшпес бұрын, негізгі пайдаланылатын, дизайн, зерттеу бағытын және зерттеу әдістерін сапалық және сандық талдау және медициналық зерттеулердің күрделілік мәселесін шешу үшін екі тәсіл де біріктірілуі мүмкін екенін түсіну маңызды. Бірінші зерттеу жүргізу алдында зерттеу тақырыбын анықтап оны талдау керек. Негізгі мәселені анықтап, алға мақсат қоя білу керек. Мақсатқа сай міндеттерді дайындаймыз. Зерттеу барлық жағынан нормативті құқықты базаға, құжаттарға , этикалық принциптерге сай болуы қажет. Зерттеу барысында қалай, кіммен жұмыс істейтінін анықтаймыз. Келісім шарт жүргізіледі,зерттеу түріне байланысты яғни эксперементальды ма немесе бір уақыт аралығында бақылау ма соған сай интервью, сауалнама немесе араласулар жүргізілүі мүмкін.

Зерттеу тәсілі - зерттеушінің ұстанымы мен болжамдарын, зерттеу процесін және деректерді жинау мен талдау әдісін қамтитын тұтас құрылым.

Сапалы зерттеулер ұзақ уақыт бойы әлеуметтік және мінез - құлық ғылымдарының бір бөлігі болған интерпретативті немесе конструктивистік ұстанымның бір бөлігі болып табылады. Бұл тәсіл жеке перспективалар мен уайымдарды сипаттау және түсіну үшін қолданылады.

Мысалы, сапалы зерттеулер пациенттің тәжірибесі немесе қызметкерлердің жаңа жұмыс тәсілдерін қабылдауы немесе мейіргерлік істе жаңа рөлдер туралы сұрақтарға жауап беру үшін пайдаланылуы мүмкін.

Сапалы зерттеу, мысалы, ұлттық денсаулық сақтау қызметі, пациенттің тікелей бастан кешкен қандай мәселелерді зерттей алады?

Пациент жергілікті денсаулық сақтау қызметтерінің дамуына қалай қарайды?

Жеке көзқарастар мен уайымдар туралы ақпаратпен бірге қарау және бақылау, ақпарат жинау сияқты зерттеу әдістері қолданылады[2,103бет].

Мейіргерлік іс зерттеулерінде сандық тәсілдер бір күтімнің басқаға қарағанда жақсы әсері бар ма екенін өлшеу үшін пайдаланылуы мүмкін. Мысалы, сандық құрылымдар сияқты зерттеу сұрақтарына жауап бере алады "А күтімі жақсыма Б күтімі ма?" Сандық зерттеулер сандық деректерді жинау мен талдауға формальды тәсілді қолданады.[6] Мейіргер ісі саласындағы зерттеулердің күрделі сипатын ескере отырып, олардың бірінде консенсусқа жеткен бір анықтаманы табу қиын. Алайда, зерттеудің көптеген анықтамаларында жүйелік процестің кейбір элементтері бар - жаңа білімді іздеу немесе жоспарлы және қисынды болып табылатын қызметті түсінуді тереңдету, сондай-ақ сұраққа жауап іздеу ж. т. б.

ISBN 978-601-08-0758-7

Мейіргерлік тәжірибе, білім беру және саясат туралы жаңа білімді дамытып оны меңгеруге ұмтылудағы мәселелерге жауап беру және проблемаларды шешу мақсатында ақпаратты жинауда жүйелі тәсіләнде дәлелды тәжірібе маңызды орын алады.

Дәлелді тәжірібе дегеніміз не? Пациенттерге мейіргерлік көмектің қандай түрін ұсыну туралы шешім қабылдау қиын емес. Алайда олардың нақты дәлелі бар түрін тәжірібеде қолдануы, нәтижесінің тиімділігін анықтау, бағалау өте маңызды. Себебі әр бір адам организмы жеке яғни индивидуалды болып келеді.

Дәлелді тәжірибенің анықтамаларының бірі пациенттерге күтім жасау туралы шешім қабылдау кезінде ең жақсы нақты деректерді пайдалану болып табылады. Осы анықтамадан біз шешімнің ағымдағы үздік дәлелдемелерге, сондай-ақ мейіргерлердің жеке тәжірибесін пайдалануға негізделуі тиіс екенін және шешім анық жасалуы тиіс екенін көре аламыз. Бүгінгі күні пациенттің пікірі, жеке адамға медициналық көмек көрсету туралы қабылданатын кез келген шешім бірінші кезекте қарастырылады. Сондықтан дәлелді тәжірібенің үш айқын негізгі компоненті бар деп айтуға болады. Нақты пациентке күтім жасау туралы ғылыми негізделген шешімді қабылдай отырып, мейіргер қазіргі уақытта бар ең жақсы деректерді пайдалануы, нақты пациенттің қалауын ескеру, өз білімі мен тәжірибесін шешім қабылдау үшін пайдалануы тиіс. Пациентті қалай күту туралы шешім қабылдаған кезде мейіргер өз тәжірибесінде бар ең жақсы дәлелдемелерді іздеуі және пайдалануы тиіс, олар пациенттің талаптарын, құндылықтарын, мән-жайларын және қалауын ескеруі тиіс және олар өз кәсіби тәжірибесін, білімі мен пайымдауларын шешім қабылдаған кезде біріктіруі тиіс. Б Барлық үш элемент бірге пайдаланылуы тиіс, бірақ олардың әрқайсысының маңыздылығы әр түрлі жағдайларда әр түрлі. Басты принцип адам өмірінің сапасын барынша арттыру үшін неғұрлым тиімді күтім жасау болып табылады. Ғылыми негізделген практиканың өсуі денсаулық сақтаудың барлық салаларында сыншыларға ие және ғылыми негізделген практиканың құндылықтарына қатысты шектеулі консенсус бар. Дәлелдемелерге негізделген тәжірибені тиімді енгізу дәлелдемелердің иерархиясына кедергі келтіреді, ол дәлелдемелердің жоғары түрі ретінде рандомизацияланған бақылау сынақтарына ықпал етеді және ең үздік тәжірибені әзірлеу кезінде рефлексия құндылығын мойындауды елемейді.

Мейіргерлер өзінің кәсіби тобында да, жалпы медициналық және әлеуметтік қызметтерде де нақты деректерге негізделген практикамен байланысты пікірталастар туралы хабардар болуы тиіс.

Денсаулық сақтаудың барлық аспектілерінде ғылыми негізделген, бірақ ішінара науқастарды күтуіндегі біраз шектеулер бар[2,123бет].

Біріншіден, мейіргерлік істің кейбір салаларында зерттеулердің жетіспеуі бар, бұл мейіргерлік күтім тиімділігін анықтау үшін пайдалы. Олар клиника , теория немесе басқару жағынан болсын барлық жағынан мейіргер

ISBN 978-601-08-0758-7

ісін дамытуға ұмтылады.Теорияны дамытпай біз практикаға үлес қоса алмаймыз, практикада жаңа технологияларды меңгере алмаймыз. Сол себептен бірінші оқу бағдарламасын өзгерткен кезінде барлық жағынан оны зерттеп, біздің елге сәйкестендіріп, жаңа технологияларды енгізу қажет. Қатысушымен жұмыс жасау барысында этикалық принциптерге негізделе жұмыс жасауымыз қажет.Зерттеу жүргізілу ережесімен қатысушыны таныстыру,келісімін алу, сұрақтарына жауап беру, оның құқықтарын атап айту. Қатысушыны толық ақпараттандыру зерттеушінің негізгі мақсатының бірі болып келеді.

Қорытындылай айтқанда мейіргер ісі салалары, оның бағыттары күрделі және оны дамыту үшін, зерттеулер көптеп жүргізілүі керек. Нақты дәлелденген ем-күтімді халыққа ұсынып, оның тиімділігін көрсете алу да күрделі жұмыс. Мейіргерлердің білімін дамыту қазіргі таңда өзекті мәселелердің бірі.Зерттеу жүргізу немесе оған қатысу арқылы мейіргер үлкен тәжірібе алады. Ізденіс барысында жаңа ақпарат жинайды.жаңа ақпаратты басқалар мен бөліседі.Сол арқылы мейіргер ісіндегі зерттеулер маңыздылығы, оның дамуының науқас күтіміне тиімділігін анық көрсете алады. Мейіргер ісін дамыту біздің қолымызда!

Әдебиеттер тізімі:

1. Касимовская Н.А. Шустикова Н.М. “Доказательная сестринская практика- перспективы развития сестринских клинических исследовании” 2023 г
2. Аға медбикеге көмектесетін мақалалар мен нормативтік құжаттар жинағы

ISBN 978-601-08-0758-7

МЕЙІРБИКЕЛІК БІЛІМ ЖӘНЕ МЕЙІРБИКЕЛІК ЗЕРТТЕУЛЕР

И.А.Жапашова – Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжінің «Мейіргер ісі» пәнінің оқытушысы, магистр.

Аннотация: *Мейірбикелік білім беру мен мейірбикелік зерттеулер денсаулық сақтау жүйесінің негізі болып табылады. Заманауи мейірбикелік білім беру бағдарламалары теориялық біліммен қатар, практикалық дағдыларды да қамтиды, бұл мейірбикелердің кәсіби біліктілігін арттырады.*

Негізгі бөлім:

Мейірбикелік білім беру бағдарламалары: Теория мен практиканы үйлестіру, заманауи технологиялар мен оқыту әдістерін пайдалану.

Зерттеулер клиникалық тәжірибені жақсарту, медициналық шешімдер қабылдаудағы ғылыми негізді қамтамасыз ету үшін қажет.

Проблемалар мен перспективалар: Мейірбикелік білім мен зерттеулер арасындағы байланысты нығайту, интердисциплинарлық ынтымақтастықты арттыру. Мейірбикелік білім мен зерттеулер мейірбикелердің кәсіби дамуын және денсаулық сақтау жүйесінің сапасын арттыруға бағытталған. Оларды интеграциялау, мейірбикелік практика мен зерттеулердің бірлігін қамтамасыз етеді.

1. Мейірбикелік білім беру бағдарламалары

Заманауи мейірбикелік білім беру бағдарламалары мейірбикелердің кәсіби біліктілігін дамытуға бағытталған. Оқу жоспарлары теориялық білім мен практикалық тәжірибені үйлестіре отырып, мейірбикелердің клиникалық шешім қабылдау қабілеттерін арттыруға мүмкіндік береді.

1.1. Теориялық білім

Теориялық білім мейірбикелердің медициналық негіздерді, патологияларды, фармакологияны, және пациенттермен қарым-қатынасты түсінуіне көмектеседі. Оқу бағдарламасында:

Медициналық терминология: Пациенттердің жағдайын дұрыс бағалау үшін қажетті терминдер мен түсініктер.

Патофизиология: Аурулардың механизмдерін түсіну, бұл клиникалық тәжірибеде маңызды.

1.2. Симуляциялық оқыту

Симуляциялық оқыту — студенттерге нақты медициналық жағдайларды модельдеу арқылы практикалық дағдыларды дамытуға мүмкіндік береді. Бұл әдіс:

Сенімділік: Студенттерге қауіпсіз ортада тәжірибе жинақтауға мүмкіндік береді.

Жылдам реакция: Төтенше жағдайларда тез әрі тиімді шешім қабылдау дағдыларын дамыту.

Симуляция түрлері:

ISBN 978-601-08-0758-7

Жанды симуляция: Медицина қызметкерлері мен пациенттер рөлінде қатысатын сценарийлер.

Техникалық симуляция: Дәрі-дәрмек беру, хирургиялық процедуралар және басқа да техникалық дағдыларды үйрету.

1.3. Клиникалық тәжірибе

Клиникалық тәжірибе — оқу барысында стажировкалар мен тәжірибелік сабақтар арқылы нақты медициналық орталарда жұмыс істеу тәжірибесін жинақтауға мүмкіндік береді. Бұл кезеңде студенттер:

Пациенттермен жұмыс: Науқастардың жағдайын бағалау, медициналық тарихын алу, күтім көрсету.

Командалық жұмыс: Медициналық командамен ынтымақтастықта жұмыс істеу дағдыларын дамыту.

Клиникалық тәжірибенің артықшылықтары:

Практикалық дағдылар: Теориялық білімді нақты тәжірибеге қолдану.

Кәсіби байланыстар: Білім алушылар медициналық ортада кәсіби желілер құра алады, бұл кейінгі мансап үшін маңызды.

1.4. Бағалау және сертификаттау

Мейірбикелік білім беру бағдарламаларының нәтижесі ретінде студенттердің кәсіби біліктілігін бағалау маңызды. Бұл:

Практикалық сынақтар: Студенттердің дағдыларын нақты медициналық сценарийлерде бағалау.

Курстық жұмыстар мен жобалар: Теориялық білімнің тереңдігін көрсету.

Мейірбикелік білім беру бағдарламаларының тиімділігі мен сапасы болашақ мейірбикелердің кәсіби дамуына, бәсекеге қабілеттілігіне және денсаулық сақтау жүйесіне қосқан үлесіне тікелей әсер етеді.

2. Мейірбикелік зерттеулердің маңызы

Мейірбикелік зерттеулер денсаулық сақтау жүйесінде маңызды рөл атқарады. Олар мейірбикелік практика мен пациенттерге қызмет көрсету сапасын арттыруға бағытталған, сонымен қатар, мейірбикелердің кәсіби дамуына әсер етеді.

2.1. Құндылықтарды анықтау

Зерттеулер мейірбикелердің пациенттермен қарым-қатынасын және медициналық шешімдерді қабылдау процестерін жақсартуға мүмкіндік береді.

Пациенттермен қарым-қатынас: Зерттеулер мейірбикелердің пациенттермен қарым-қатынас жасау тәсілдерін, коммуникативтік дағдыларын және пациенттердің қажеттіліктерін түсінуін бағалайды.

Эмпирикалық деректер: Пациенттерден алынған пікірлер мен ұсыныстар мейірбикелердің практикасын жетілдіруге ықпал етеді, бұл өз кезегінде пациенттердің қанағаттанушылығын арттырады.

2.2. Жаңа әдістерді енгізу

ISBN 978-601-08-0758-7

Мейірбикелік зерттеулер жаңа медициналық технологияларды, әдістерді және практикадағы тиімділікті зерттеуге көмектеседі.

Инновациялар: Зерттеулер арқылы жаңа емдеу әдістері мен технологияларды енгізу мүмкіндігі артады. Бұл мейірбикелерге пациенттердің жағдайын жақсарту үшін жаңа құралдар мен тәсілдерді пайдалануға мүмкіндік береді.

Клиникалық хаттамалар: Зерттеу нәтижелері мейірбикелік практикада қолданылатын клиникалық хаттамаларды жетілдіру және жаңарту үшін негіз болып табылады.

2.3. Кәсіби даму

Мейірбикелік зерттеулер мейірбикелердің кәсіби дамуына оң әсер етеді.

Білім деңгейін арттыру: Зерттеулер жүргізу мейірбикелердің ғылыми-зерттеу дағдыларын дамытуға, жаңа білім алуға және оларды практикада қолдануға мүмкіндік береді.

Мансап мүмкіндіктері: Зерттеу жұмыстарына қатысу мейірбикелерге академиялық және кәсіби салада жаңа мансап мүмкіндіктерін ашады.

2.4. Денсаулық сақтау саясатын дамыту

Мейірбикелік зерттеулер денсаулық сақтау саясатын дамытуда да маңызды рөл атқарады.

Деректер негізіндегі шешімдер: Зерттеулер нәтижелері денсаулық сақтау саясаткерлеріне, басқарушыларға және клиникалық практика жетекшілеріне деректер негізінде шешімдер қабылдауға мүмкіндік береді.

Сапа мен қауіпсіздік: Зерттеулер денсаулық сақтау жүйесінде қызмет көрсету сапасын, пациенттердің қауіпсіздігін арттыру үшін қолданылады.

3. Проблемалар мен перспективалар

Мейірбикелік білім мен зерттеулер арасындағы байланыс кейде әлсіз болуы мүмкін. Бұл жағдай мейірбикелердің кәсіби дамуына және денсаулық сақтау жүйесінің тиімділігіне теріс әсер етеді. Аталған мәселелерді шешу үшін бірнеше стратегиялық бағыттарды қарастыру қажет.

3.1. Интердисциплинарлық ынтымақтастық

Медицина, психология, әлеуметтік ғылымдар және басқа салалармен тығыз байланыс орнату мейірбикелік білім мен тәжірибені байытады.

Кросс-дисциплинарлық бағдарламалар: Әр түрлі сала мамандарының бірлескен оқыту бағдарламаларын енгізу, бұл мейірбикелердің басқа мамандармен тиімді коммуникация орнатуына және интегративті тәсілді дамытуына ықпал етеді.

Жобалық жұмыстар: Интердисциплинарлық жобалар мен зерттеулер мейірбикелерге әртүрлі мамандармен бірігіп жұмыс істеу тәжірибесін ұсынады, бұл олардың біліктілігін арттырады.

3.2. Зерттеу мәдениетін қалыптастыру

ISBN 978-601-08-0758-7

Оқу орындарында зерттеу жұмыстарына ынталандыру мен қолдау көрсету мейірбикелердің ғылыми-зерттеу жұмыстарында белсенділігін арттыру үшін маңызды.

Зерттеу курстары: Мейірбикелік білім беру бағдарламаларына зерттеу әдістерін үйретететін курстарды енгізу. Бұл студенттердің ғылыми-зерттеу дағдыларын дамытуға және олардың мейірбикелік практикада қолдануына мүмкіндік береді.

Менторлық жүйе: Тәжірибелі мейірбикелер мен зерттеушілердің жетекшілігімен мейірбикелердің ғылыми жобаларды жүргізуіне және зерттеу нәтижелерін жариялауға көмектесу.

3.3. Қаржылық қолдау

Зерттеулерді қолдау үшін қажетті қаржылық ресурстарды қамтамасыз ету.

Гранттар мен қаржыландыру: Мейірбикелік зерттеулерге арналған гранттар мен қаржыландыру көздерін дамыту, бұл зерттеушілерге жаңа жобаларды іске асыруға мүмкіндік береді.

Серіктестік бағдарламалар: Денсаулық сақтау ұйымдары мен оқу орындары арасындағы серіктестіктерді нығайту, зерттеу және білім беру бағдарламаларын қаржыландыру үшін ресурстарды біріктіру.

3.4. Зерттеу нәтижелерін енгізу

Зерттеу нәтижелерін практикаға енгізу, бұл мейірбикелік қызмет көрсету сапасын арттыруға мүмкіндік береді.

Клиникалық хаттамалар: Зерттеу нәтижелері негізінде клиникалық хаттамаларды жаңарту, бұл емдеу әдістерін тиімділігін арттыру.

Білім беру курстары: Зерттеу нәтижелерін оқу бағдарламаларына енгізу, студенттерді заманауи әдістермен таныстыру.

Қорытынды

Мейірбикелік білім мен зерттеулер мейірбикелердің кәсіби дамуын және денсаулық сақтау жүйесінің сапасын арттыруға бағытталған. Оларды интеграциялау мейірбикелік практика мен ғылыми-зерттеу жұмыстары арасындағы байланысты нығайту арқылы мейірбикелердің қызметін жетілдіреді.

1. Мейірбикелік білімнің жаңаруы

Мейірбикелік білім беруді жаңғырту студенттерді заманауи медицинадағы жаңа әдістер мен технологияларға дайындауға бағытталуы тиіс. Оқу бағдарламаларына клиникалық тәжірибені, симуляциялық оқытуды және интердисциплинарлық тәсілдерді енгізу білім сапасын арттырады.

2. Зерттеу мәдениетін арттыру

Зерттеу мәдениетін қалыптастыру мейірбикелердің ғылыми-зерттеу жұмыстарына белсенділігін арттырады. Оқу орындарында ғылыми жұмыстарды қолдау, менторлық жүйені дамыту және зерттеу дағдыларын үйретететін курстарды енгізу мейірбикелердің біліктілігін көтереді.

3. Кәсіби тәжірибені дамыту

ISBN 978-601-08-0758-7

Кәсіби тәжірибені дамыту мейірбикелердің медициналық ортада жұмыс істеу дағдыларын жетілдіруге бағытталуы керек. Клиникалық тәжірибе мен стажировкаларды ұйымдастыру, сондай-ақ мейірбикелерді зерттеу жобаларына қатыстыру олардың кәсіби дағдыларын арттырады.

4. Инновациялар мен практика

Зерттеу нәтижелерін практикаға енгізу денсаулық сақтау жүйесінде қызмет көрсету сапасын арттыруға мүмкіндік береді. Клиникалық хаттамаларды жаңарту, жаңа емдеу әдістерін енгізу және пациенттермен қарым-қатынасты жақсарту мейірбикелердің тиімділігін арттырады.

Қорытынды

Болашақта мейірбикелік білім беруді жаңғырту, зерттеу мәдениетін арттыру және кәсіби тәжірибені дамыту маңызды міндеттер болып қала береді. Мейірбикелік білім мен зерттеулер арасындағы байланысты нығайту денсаулық сақтау жүйесінің тиімділігін арттырып, пациенттерге көрсетілетін қызметтердің сапасын көтереді. Мейірбикелердің кәсіби дамуы, бәсекеге қабілеттілігі және әлеуметтік жауапкершілігі мейірбикелік қызметтің негізі болып табылады, бұл медициналық орталарда қызмет көрсету сапасын арттыруға септігін тигізеді.

Әдебиеттер тізімі:

1. Тулебаева, Г. — "Мейірбикелік білім беру: теория және практика" (2015).
2. Сейсенова, А. — "Мейірбике ісінің негіздері" (2017).
3. Баязитова, А. — "Мейірбикелік тәжірибе: клиникалық негіздер" (2018).
4. Кенжебаева, Д. — "Мейірбикелік зерттеулер: теория мен әдістемелер" (2020).
5. Аманжолова, Г. — "Мейірбикелік білім беру жүйесіндегі инновациялар" (2021).
6. Benner, P. (1984). From Novice to Expert: Excellence and Power in Clinical Nursing Practice. Prentice Hall.
7. McGonigle, D., & Mastrian, K. (2017). Nursing Informatics and the Foundation of Knowledge. Jones & Bartlett Learning.
8. Polit, D. F., & Beck, C. T. (2017). Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. Wolters Kluwer.
9. Higgs, J., & Jones, M. A. (2000). Clinical Reasoning in the Health Professions. Butterworth-Heinemann.

ISBN 978-601-08-0758-7

ОНКОЛОГИЯЛЫҚ НАУҚАСТАРҒА МЕЙІРБИКЕЛІК КҮТІМ ЖАСАУ

Жармахан Толқынай Талғатқызы, арнайы пәндер оқытушысы
«Қызылорда медициналық жоғары колледжі»

Аннотация: *Бұл мақалада кешенді медициналық орталық үшін онкологиялық мейірбикелік күтімді дамыту бойынша ұсыныстар қарастырылады. Онкологиялық мейірбикенің медициналық көмек көрсетуде табысты болуы үшін мейірбикелік бағдар, үздіксіз білім және құзыреттілік қажет. Мейірбике мен пациенттің арақатынасын басқа бәсекеге қабілетті орталықтармен салыстыру, өткірлікті және клиникалық жағдайларға байланысты әртүрлі жұмыс процестерін ескеру қажет. Медбикелер профилактикалық скринингтен бастап өмір бойы онкологиялық көмек көрсетуде және өмірінің соңына дейін медициналық көмек көрсетуде маңызды рөл атқаратыны баяндалады.*

Өзектілігі: Қатерлі ісік дүние жүзінде өлімнің негізгі себебі болып табылады, 2020 жылы 10 миллионға жуық адам қайтыс болды. Бұл қоғамның қартаюы, алкогольді асыра пайдалану, темекі шегу, семіздік және физикалық белсенділіктің болмауы сияқты көптеген қауіп факторларына байланысты. Профилактика мен скринингтен бастап өмірінің соңына дейін жоғары сапалы мейірбикелік күтімді қамтамасыз ету өте маңызды. Зерттеулер мен ғылыми жаңалықтар қатерлі ісік ауруын емдеуге енгізілгендіктен, онкология саласында жұмыс істейтін медбикелер жақсы білімді және кешенді емдеу режимдері мен мақсатты жасушалық терапияны қамтамасыз етуде ажырамас рөл атқаруға дайын болуы керек. Сондықтан жоғары білім беру арқылы онкологиялық мейірбике ісінің мамандандырылған тәжірибесіне назар аудару медициналық көмектің сәтті көрсетілуін қамтамасыз етеді.

Жұмыстың мақсаты: Онкологиялық мейірбикелік күтімді қамтамасыз ету үшін белгіленген стандарттар мен құзыреттерді пайдалана отырып, медбикелер өздерінің білімі мен дағдыларын жетілдіру.

Міндеттері:

- Онкологияға жаңадан келген медбикелер, сондай-ақ басқа мамандықтардың тәжірибелі медбикелері онкологиялық науқастарға сапалы көмек көрсету үшін қажетті құзыреттерді алу,
- Медицина Институтының мәліметі бойынша, оларға көшбасшылық, денсаулық сақтау саясаты, жүйені жетілдіру.

Ғылыми-зерттеу және дәлелді тәжірибелер, топтық жұмыс және ынтымақтастық, қоғамдық және қоғамдық денсаулық сақтау, гериатрия және онкология кіреді.

Медициналық көмек көрсету жүйесі өзгеріп, онкологиялық ауруларды емдеуге жаңа ғылыми жаңалықтар енгізілген сайын онкологиялық медбикенің рөлі дами береді. Онкологиялық медбикелер қазіргі уақытта 10

ISBN 978-601-08-0758-7

жыл бұрын естімеген, бірақ қазір жиі кездесетін әртүрлі лауазымдар мен мекемелерде жұмыс істейді. Амбулаториялық жағдайда онкологиялық медбикелер онкологиялық науқастарға ұзақ мерзімді бақылау, химиотерапия тағайындалғанға дейін алдын ала скрининг, шаршауды басқару немесе жалпы симптомдарды басқару сияқты қызметтерді ұсынатын мейірбикелік клиникаларда жұмыс істейді [1]. Қатерлі ісік генетикасы саласы дамыған сайын, алдыңғы қатарлы медбикелердің қатерлі ісікке генетикалық кеңес беру және қауіп-қатерді бағалаудағы рөлі де арта түсті. Онкологиялық медбике ауруханалар мен клиникаларда бас директорлар, онкологиялық қызмет көрсету желілерінің директорлары және қабылдау қызметтерінің директорлары сияқты көптеген басшылық қызметтерді атқарады.

Онкологиялық мейірбикенің рөлі туралы келесі пікірталас пациенттерді бағалауға, пациенттерге білім беруге, күтімді үйлестіруге, пациенттерге тікелей көмек көрсетуге, симптомдарды басқаруға және демеуші көмекке бағытталған. Бұл рөлдің қаншалықты әртүрлі болуы мүмкін екенін және оның қатерлі ісік ауруын емдеудегі маңыздылығын көрсету үшін онкологиялық медбикенің пациенттерге тікелей көмек көрсетудегі, симптомдарды басқарудағы және демеуші көмек көрсетудегі рөліне қатысты мысалдар келтірілген [2].

Науқасты Бағалау. Медбикелер пациенттің физикалық және эмоционалдық жағдайын, өткен денсаулық тарихын, денсаулық сақтау тәжірибесін, сондай-ақ пациенттің де, отбасының да ауру және оны емдеу туралы білімін бағалау бойынша сарапшы болады деп күтілуде. Онкологиялық медбике онкологпен емдеу жоспарын қарастырады, күтілетін нәтижелер мен ықтимал асқынулар туралы біледі және науқастың жалпы физикалық және эмоционалдық жағдайын өз бетінше бағалайды. Мейірбике ісінің егжей-тегжейлі тарихын және физикалық тексеруді аяқтау өте маңызды. Онкологиялық медбике барлық тиісті зертханалық, патологиялық және бейнелеу зерттеулерінің нәтижелері мен жалпы салдары туралы хабардар болады деп күтілуде. Науқастың ауру туралы түсінігін және ұсынылған бағалау мазасыздықты жеңілдету және күтім жоспарын құру үшін маңызды болып табылады. Бұл ақпаратты алу түсінбеушілік пен шатастырылған үміттерді болдырмауға көмектеседі.Науқасты мұқият дайындау емдеу бағдарламаларының сақталуын жақсартады және емдеу нәтижелеріне де әсер етуі мүмкін.

Пациенттерге Білім Беру. Медбике көбінесе медициналық топтың кез келген басқа мүшелеріне қарағанда пациенттермен және олардың отбасыларымен тиімді білім беру әрекеттері үшін қажетті өзара түсіністікті дамытуға жақсы мүмкіндіктерге ие. Пациенттер мен отбасыларға білім беру терапияға дейін басталып, терапия кезінде және одан кейін жалғасады. Емдеу курсында үнемі күшейту табысты қамтамасыз етуге көмектеседі. Тиісті жазбаша және көрнекі оқу құралдарын, сондай-ақ басқа мамандарға немесе онкологиялық ауруларды қолдау топтары сияқты қоғамдық бағдарламаларға

ISBN 978-601-08-0758-7

жолдамаларды пайдалануға болады. Мұндай білім пациенттерге диагнозды, ұзақ мерзімді түзетулерді және симптомдарды жеңуге көмектесу үшін құрылымдалған және құрылымдалмаған тәжірибені қамтиды; алдын алу, диагностикалау және емдеу туралы ақпарат алу; және денсаулық жағдайын сақтау немесе қалпына келтіру дағдыларын, білімін және көзқарасын дамыту.

Онкологиялық медбике қазіргі уақытта қатерлі ісік ауруын диагностикалау мен емдеуде жиі қолданылатын көптеген және күрделі технологияларды үйлестіруде маңызды рөл атқарады. Бұл үйлестіру пациенттерге тікелей көмек көрсетуді қамтиды; медициналық картадағы құжаттама; терапияға қатысу; симптомдарды басқару; басқа медициналық қызмет көрсетушілерге жолдамаларды ұйымдастыру; пациенттерге де, отбасыларға да білім беру; сонымен қатар диагностика, терапия және бақылау бойынша кеңес беру. Медбике пациенттің бірінші байланыс желісі ретінде қызмет етуі керек. Ең дұрысы, пациент пен оның отбасы онкологиялық мейірбикеге бүкіл емдеу бағдарламасы бойынша телефон арқылы хабарласудан тартынбауы керек. Көптеген пациенттер ұзақ қашықтықты жүріп өтеді, сондықтан телефон арқылы сөйлесудің маңыздылығын атап өту керек. Бұл пациенттермен үздіксіз қарым-қатынас жасауға, төтенше жағдайларды ерте тануға және тұрақты эмоционалды қолдауға мүмкіндік береді.

Медбике үшін пациенттерді басқаруды анықтау үшін жеткілікті ақпарат жинау маңызды. Көптеген мекемелер телефон қоңыраулары мен мәселелерін сұрыптау бойынша нұсқаулықтар әзірледі. Бұл нұсқаулар дәрігермен кеңесіп, кейінгі күтім бойынша нақты нұсқауларды бермес бұрын телефон арқылы пациенттердің мәселелерін анықтауға көмектесетін негізгі қадамдарды қамтамасыз етеді.

Қатерлі ісікке қарсы заманауи көмекті әртүрлі қызметкерлер әртүрлі нысандарда шығындарды ескеретін қызметкерлер жеделдететін қарқынмен жүргізеді. Әртүрлі мекемелердегі қызметкерлер арасындағы қарым-қатынас оңтайлы болмауы мүмкін, ал онкологиялық медбике қамтамасыз ете алатын байланыс пен үйлестіру шатасуы және қорқуы мүмкін науқастарға баға жетпес қызмет көрсетеді [3,4].

Онкологиялық медбикелер онкологиялық науқастар мен олардың отбасыларының көптеген қолдау көрсету мәселелерімен тығыз байланысты. Бұл тарауда демеуші және паллиативтік көмектің көптеген салаларын егжей-тегжейлі талқылауға мүмкіндік берілмейді, бірақ екі саланы ерекше атап өтуге болады, яғни медбикелерді ауырсынуды емдеуге және тірі қалуға тарту.

Медбикелер кез келген басқа медицина қызметкеріне қарағанда ауыратын науқастармен көбірек уақыт өткізетіндіктен, ауырсынуды жақсы бақылауды қамтамасыз ету үшін медбикенің ауырсынуды бағалау және ауырсынуды фармакологиялық және фармакологиялық емес басқару туралы хабардар болуы өте маңызды.пациенттерге және отбасына білім беру.

ISBN 978-601-08-0758-7

Дегенмен, басқа медициналық мамандықтар сияқты, мейірбике ісінде де ауырсынуды тиімді бақылауды қамтамасыз етудегі кедергілер бар. Негізгі проблемалар-нашақорлық, есірткіге төзімділік, седативтілік және тыныс алу депрессиясы туралы қате түсініктер мен қорқыныштар; ауырсынуды бағалау және анальгетиктер туралы білімнің болмауы; және анальгетиктермен жеткіліксіз емдеу.Бұл дәстүрлі бакалавриат мейірбикелік оқу бағдарламаларында ауырсынуды бақылауға арналған ең аз уақытты қарастырған кезде түсінікті. Бақытымызға орай, қазіргі уақытта бұл мәселелер шешілуде және қол жетімді білім беру бағдарламалары мен ресурстары айтарлықтай жақсарды. Қатерлі ісікке қарсы мемлекеттік бастамалар, нұсқаулықтар және ұйымдық ұстанымдар ауырсынуды басқаруды жақсартуға бағытталған тамаша күш-жігер болды. IRS әртүрлі деңгейдегі тәжірибесі бар медбикелер үшін тәжірибе ауқымын сипаттайтын қатерлі ісік ауруы туралы позициялық құжатты әзірледі. Тіпті Денсаулық Сақтау Ұйымдарын Аккредиттеу Жөніндегі Бірлескен Комиссия ауруды басқарудың жеткіліксіздігі мәселесін мойындады және тиісті басқаруға баса назар аудару үшін күтім стандарттарын өзгертті [5].

Медбикелер денсаулық сақтаудың жүрегі деп жиі айтылады. Онкологиялық мейірбике ісі саласы, атап айтқанда, мейірбике ісіндегі ең күрделі және пайдалы салалардың бірі болып табылады. Онкологиялық науқастарға келетін болсақ, онкологиялық медбикелер науқастарға қиын және қолайсыз сәттерінде, сіздің жаныңызда болады, білім береді, жігерлендіреді. Олар сондай-ақ, дәрігерлермен байланысып, медициналық көмекті үйлестіретін адамдар [6].

Медбикелер бұл мамандыққа өз қалаулары бойынша қосылады. Олар әлемнің емшілері, көмекшілері, қамқоршылары. Медбикелер онкологиялық мекемеде жұмыс істеуге шешім қабылдағанда, олар проблемалар туындайтынын түсінеді және олар мұны бәрібір жасайды. Кейбіреулер тіпті пациенттері үшін өз уақытын арнайды.

Онкологиялық медбикелер онкологиялық науқастарға күтім жасайды, олардың алғашқы байланыс желісі ретінде қызмет етеді және онкологиялық ауруларды емдеу кезінде олардың күтімінің көптеген аспектілерін үйлестіруге көмектеседі. Олар бірқатар міндеттерді орындай алады, соның ішінде:

10. Науқастың денсаулық тарихына шолу
11. Науқастың физикалық және эмоционалдық жағдайын бағалау және бақылау
12. Зертханалық, патологиялық және бейнелеу зерттеулерінің есебін жүргізу
13. Дәрі-дәрмектерді, сұйықтықтарды және химиотерапия сияқты қатерлі ісіктерді емдеуді қауіпсіз енгізу
14. Науқастың дәрігерлерімен және басқа дәрігерлермен емдеу жоспары бойынша ынтымақтастық

ISBN 978-601-08-0758-7

15. Пациенттерге ауруды және олардың емдеу жоспарын түсінуге көмектесу

16. Күрделі медициналық терминологияны аударуға және сұрақтарға жауап беруге көмектесу

17. Науқастың атынан дәрігерлермен және басқа клиникалармен байланыс орнату

18. Науқасқа емдеу барысында симптомдарды жоспарлауға және басқаруға көмектесу [7].

Онкологиялық медбикелердің қатерлі ісікке қатысты арнайы білім базасы және онкологиялық ауруларды емдеуде негізгі мейірбикелік бағдарлама арқылы алынғаннан тыс клиникалық тәжірибесі бар. Басқарманы сертификаттау ерікті болып табылады және мамандық бойынша біліктілікті, білімді және білімді қажет етеді. Онкологиялық сертификат алу үшін медбикелер әдетте мейірбике дипломы, тіркелген мейірбике лицензиясы (RN) болуы, белгілі бір жарамдылық критерийлеріне сай болуы және емтихан тапсыруы керек. Жетілдірілген сертификаттау әдетте мейірбике ісі бойынша магистр немесе одан жоғары дәрежені, бірнеше сағаттық бақыланатын клиникалық тәжірибені және кейде қосымша дайындықты қажет етеді [8].

Қорытынды: Қатерлі ісікке шалдыққан адамдарға күтім жасаудағы стресстер мен қиындықтарға байланысты онкологиялық медбикелер жиі физикалық және эмоционалдық күйзеліске ұшырайды. Медбикелер үшін де өздеріне қамқорлық жасау маңызды, бұл өз кезегінде пациенттеріне жақсы күтім жасауға көмектеседі.

Мейірбикелік күтімді пациенттердің жайлылығына ықпал ету, пациенттер мен олардың отбасыларына ауырсынуды бақылауға қатысты ақпарат беру, мінез-құлық және физикалық араласулар туралы ақпарат беру және оларға көмек көрсету, фармакологиялық терапияның жанама әсерлерінің алдын алу және жеңілдету, пациенттердің терапияға сәйкестігін және қажетті бақылауды қамтамасыз ету үшін жоспарлау керек. Медбике араласудың негіздемесін түсіндіріп, пациенттер мен отбасы мүшелерінің сұрақтарына уақыт бөлуі керек. Пациенттерге білім беруде фармакологиялық агенттердің атаулары, дозалау кестелері, жанама әсерлері, жүрек айнуы мен құсуды жеңілдетуге арналған шаралар, мысалы, құсуға қарсы препараттар және іш қатуды жеңілдетуге арналған араласулар болуы керек. Медбике фармакологиялық араласулардың тиімділігі мен жанама әсерлерін, тыныс алу жағдайы мен ішектің жұмысын, сондай-ақ психикалық және когнитивті функцияларды бақылауы керек. Науқас пен оның отбасы төтенше жағдайда медициналық қызметкерлермен қалай байланысуға болатынын білуі керек және мұны еркін сезінуі керек.

Әдебиеттер тізімі:

9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK584206/

ISBN 978-601-08-0758-7

10. https://www.cancercenter.com/community/blog/2020/07/heart-of-health-care-oncology-nursing

11. Заликина Л. С. Уход за больными: учебник. - М., 2008. – 129 экз

12. Мухина, С. А. Теоретические основы сестринского дела М. : ГЭОТАР - Медиа, 2014-1экз.

13. Обуховец, Т. П. Основы сестринского дела. Часть 1. Теория сестринского дела. Часть II. Практика сестринского дела : учеб. пособие . - 16-е изд., стереотип. - Ростов н/Д : Феникс, 2011.- 2 экз.

14. Кочнева, С. А. Новейший справочник участковой медсестры : справочное издание . - 2-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 1 экз.

15. Қаныбеков, А. Медбикеге арналған нұсқаулар : оқулық Алматы : Эверо, 2014.-80экз

16. Нурманова М. Ш. "Мейірбике ісі негіздері" пәні бойынша мейірбикелік технологиялар стандарттарының жинағы. - Қарағанды : ЖК "Ақ Нұр", 2012. – 50 экз.

ISBN 978-601-08-0758-7

УЧАСТИЕ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА

Жумагулова К.К. 2курс , специальность «Сетринское дело»
ГКП «Актюбинский высший медицинский колледж имени героя Советского Союза Маншук Маметовой» на ПХВ
Научный руководитель Муртазина Г.Р., преподаватель специальных дисциплин

Аннотация: *Данная статья рассматривает вопросы участия медицинской сестры в реабилитации пациентов после инсульта.Инсульт является одной из ведущих причин инвалидизации и смертности в мире, создавая значительную нагрузку на системы здравоохранения. Восстановление после инсульта требует комплексного подхода, включающего медицинскую, социальную и психологическую помощь. Одной из ключевых фигур в этом процессе является медицинская сестра, которая участвует в реабилитации пациентов на всех этапах восстановления. Актуальность данного исследования заключается в необходимости улучшения качества реабилитационных мероприятий и повышения роли медсестер в этом процессе.*

Актуальность проблемы

Инсульт ежегодно затрагивает около 15 миллионов человек, и более 5 миллионов из них остаются с тяжелыми нарушениями двигательных и когнитивных функций. Ранняя и активная реабилитация может существенно улучшить качество жизни пациентов и их способность к самообслуживанию. Медицинские сестры, обладая специальными навыками ухода и реабилитации, играют важную роль в восстановлении утраченных функций пациентов, что делает их работу в данной области крайне важной и актуальной.

Цели и задачи исследования

Цель исследования — изучение роли медицинской сестры в реабилитации пациентов после инсульта с целью повышения эффективности ухода и восстановления.

Задачи исследования:

1. Изучить современные методы реабилитации пациентов после инсульта.
2. Оценить влияние участия медицинских сестер на процесс восстановления пациентов.
3. Разработать рекомендации по улучшению работы медсестер в реабилитации постинсультных больных.

Материалы и методы

Исследование проводилось на выборке из 20 пациентов, перенесших ишемический инсульт, проходивших реабилитацию в стационаре в течение 6

ISBN 978-601-08-0758-7

месяцев. Пациенты были разделены на две группы в зависимости от пола. В ходе исследования использовались следующие методы:

1. **Шкала FIM** для оценки двигательных функций.
2. **Индекс Бартел** для оценки способности пациентов к самообслуживанию.
3. **Шкала SF-36** для оценки качества жизни.

Пациенты проходили оценку до и после реабилитации, что позволило выявить изменения в их состоянии.

Результаты

Исследование показало, что участие медсестер в процессе реабилитации приводит к значительным улучшениям в состоянии пациентов как по шкале FIM, так и по индексу Бартел.

Средние значения показателей до и после реабилитации:

- **FIM** до: 40, после: 85.
- **Индекс Бартел** до: 30, после: 75.

На основе анализа гендерной принадлежности выявлено, что:

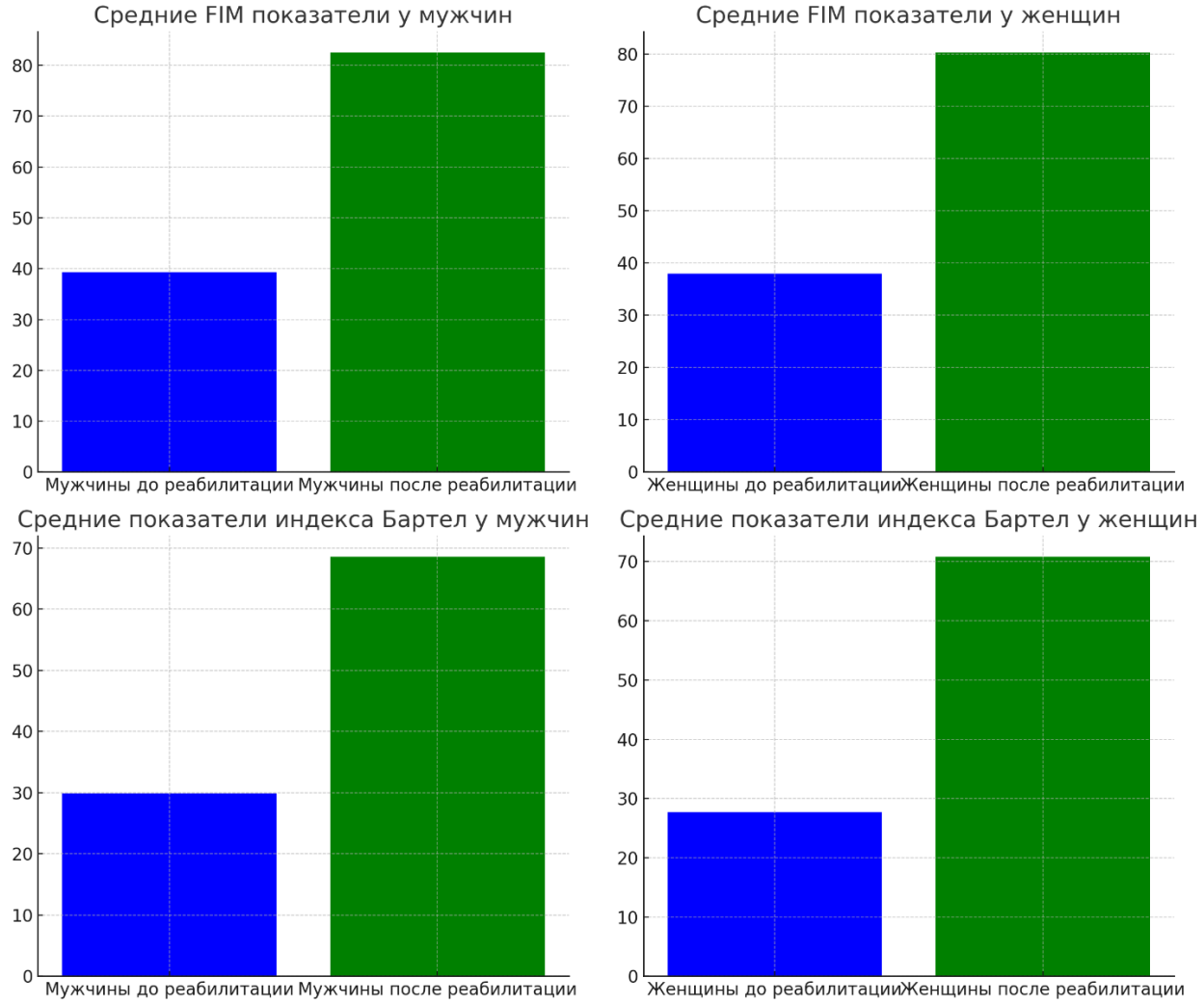
- У мужчин наблюдаются значительные улучшения по шкале FIM и индексу Бартел после реабилитации.
- У женщин показатели также улучшаются, но разница в некоторых случаях менее выражена.

Графики изменений представлены ниже:

- **График 1**: Динамика восстановления по шкале FIM до и после реабилитации.

ISBN 978-601-08-0758-7

- **График 2**: Изменения показателей индекса Бартел до и после реабилитации. Средние Показатели Индекса Бартел У Женщин



Графики

- На первом графике показаны изменения в среднем уровне функциональных способностей по шкале FIM до и после реабилитации для мужчин и женщин.
- На втором графике приведены аналогичные изменения для индекса Бартел, что иллюстрирует улучшение навыков самообслуживания у пациентов.

Выводы

Результаты исследования подтверждают важную роль медицинских сестер в реабилитации пациентов после инсульта. Сестринский уход оказывает положительное влияние на восстановление двигательных функций и улучшение способности пациентов к самообслуживанию, что повышает их качество жизни. Различия между полами, хотя и минимальны, могут быть объяснены индивидуальными особенностями и степенью тяжести инсульта.

Рекомендации для медицинских сестер

ISBN 978-601-08-0758-7

1. **Активное участие в междисциплинарной команде**: Медсестры должны участвовать в разработке реабилитационного плана с врачами и физиотерапевтами для обеспечения комплексного подхода к восстановлению пациента.
2. **Обучение и поддержка пациентов**: Медсестры должны играть активную роль в обучении пациентов и их семей правильным техникам реабилитации, самообслуживания и ухода.
3. **Мониторинг состояния пациентов**: Регулярная оценка состояния пациента и коррекция реабилитационных мероприятий на основе данных о прогрессе, полученных по шкале FIM и индексу Бартел, крайне важны для успешного восстановления.
4. **Психологическая поддержка**: Пациенты после инсульта часто страдают от депрессии и тревожности. Медсестры должны оказывать эмоциональную поддержку и участвовать в психологической реабилитации.
5. **Дополнительное обучение медсестер**: Регулярные курсы повышения квалификации по современным методам реабилитации позволят медсестрам более эффективно помогать пациентам.
6. **Индивидуализация ухода**: Медсестры должны разрабатывать персонализированные программы реабилитации, учитывая возраст, пол и степень поражения каждого пациента.

Список литературы:

1. World Health Organization. "Global BurdenofStroke." WHO, 2021. https://www.who.int.
2. Adams, H. P., etal. "GuidelinesfortheEarly Management ofPatientswithAcuteIschemicStroke: A GuidelineforHealthcareProfessionals." *Stroke*, vol. 44, no. 3, 2013, pp. 870-947.
3. Langhorne, P., etal. "OrganizedInpatient (Stroke Unit) Care forStroke." *Cochrane Database ofSystematicReviews*, no. 4, 2020, CD000197.
4. Boehme, A. K., Esenwa, C., Elkind, M. S. "Stroke Risk Factors, Genetics, andPrevention." *Circulation Research*, vol. 120, 2017, pp. 472-495.

ISBN 978-601-08-0758-7

МЕЙІРБИКЕЛІК БІЛІМ ЖӘНЕ МЕЙІРБИКЕЛІК ЗЕРТТЕУЛЕР

Калиханова А. Қ., 2 курс «мейіргер ісі» мамандығы
Абай облысы ДСБ "Дүйсенбі Қалматаев атындағы
мемлекеттік жоғары медициналық колледжі" ШЖҚ КМК
Ғылыми жетекшісі Сагатбекова Д.Т. оқытушы

Анотация. *Бұл мақала мейірбекелік білім берудегі заманауи трендтер, зерттеулердегі иновациялар және мейірбикелердің психологиялық, кәсіби әл-ауқаты жайлы зерттеулерді қарастырады...*

Мейірбикелік білім мен мейірбикелік зерттеулер - қазіргі денсаулық сақтау жүйесінің негізі. Мейірбикелер – науқастарға күтім көрсетуші мамандар, олар медицина мен ғылымның көптеген аспектілерін меңгеріп, адам өмірінің сапасын жақсатуға бағытталған. Осыған орай, мейірбикелік білім мен зерттеулердің маңызы зор, өйткені олар науқастарға тиімді, қауіпсіз және сапалы медициналық көмек көрсетуді қамтамасызетеді

Мейірбикелікбілім беру – мейірбикелердің кәсіби дайындығын қамтамасыз ететін және денсаулық сақтау саласының негізін құрайтын маңызды сала. Бұл білім мейірбикелерге медициналық көмеккөрсетудің тиімді әдістерін, заманауи технологияларды, науқастармен жұмыс істеудің этикалық және психологиялық аспектілерін меңгеруге көмектеседі. Өзім мейірбикелік білімді дамыту мен жетілдірудің маңыздылығын түсіне отырып, болашақ мамандарды кәсіби түрде дайындауға көңіл бөлгім келеді.

Менің мейірбикелік білімге қатысты бағыттарым:

1.Мейірбикелік білімнің негізі – бұл теориялық білімдер жиынтығы. Мейірбикелер медицина ғылымы, анатомия, физиология, фармакология сияқты маңызды пәндерді меңгеруі қажет. Бұл білімдер науқастарға дұрыс көмек көрсетудің іргетасын құрайды.

2. Теориялық біліммен қатар, мейірбикелер клиникалық дағдыларды меңгеруі тиіс. Бұл науқастарға көмек көрсету, инъекциялар жасау, жараларды таңу, мониторинг жүргізу сияқты практикалық дағдыларды үйретуге бағытталған.

3. Мейірбикелікбілім беру науқастармен дұрысқарым-қатынасжасау, олардың жеке құқықтарын құрметтеу және кәсіби этиканы сақтау сияқты аспектілерді қамтиды.

Алайда қазіргі таңда 2024 жылы мейірбикелердің жетіспеушілігі бірнеше факторлардың нәтижесінде туындап отыр. Бұл мәселе денсаулық сақтау тиімділігіне, науқастарға көрсетілетін көмектің сапасына және мейірбикелік білім берудің болашағына теріс әсер етеді. Мейірбикелердің жетіспеушілігінің негізгі себептері: кәсіби әлсіздік: білім беру жүйесіндегі кемшіліктер, практикалық дағдыларға жеткіліксіз көңіл бөлу. Жұмыс жағдайлары: тар жұмыс кестелері, ұзақ жұмыс сағаттары және эмоционалдық жүктеме мейірбикелердің салада ұзақ қалуына кедергі келтіреді. Экономикалық факторлар: төмен жалақы мен мемлекеттік

ISBN 978-601-08-0758-7

қаржыландырудың тапшылығы кәсіби мамандарды мейірбикелік қызметтен кетуге мәжбүр етеді. Салада тәжірибелі мамандардың тапшылығы да байқалады. Бұл мәселелерді шешу үшін мейірбикелік білімді арттыру және заманауи трендтерді енгізу қажет, бұл мейірбикелерді сапалы түрде дайындауға мүмкіндік береді. Міне, осы саладағы негізгі заманауи трендтер:

1. Виртуалды шындық (VR) мейірбикелік білім беруде маңызды рөл атқарады, әсіресе практикалық дағдыларды дамыту мен клиникалық тәжірибені имитациялауда. VR студенттерге қауіпсіз ортада күрделі клиникалық жағдайларды тәжірибелеуге мүмкіндік береді, бұл оларға қателіктерден қорықпай, білімдерін нығайтуға көмектеседі. Студенттер әртүрлі клиникалық сценарийлерге қатысып, шұғыл жағдайларда тез әрі дұрыс шешім қабылдау дағдыларын дамытады, сонымен қатар стрессті жеңіл қабылдайды. VR мейірбикелерге әртүрлі ауруханалық жағдайлар мен пациенттерді таныстыру арқылы олардың тәжірибесін кеңейтеді.

2. Мейірбикелер мен басқа медицина мамандары (мысалы, дәрігерлер, фармацевттер, психологтар) арасындағы ынтымақтастық арқылы жасалатын зерттеулер көбеюде. Бұл тәсіл әртүрлі салалардың білімін біріктіріп, кешенді күтім көрсетудің жаңа әдістерін әзірлеуге мүмкіндік береді.

3. Үздіксіз білім беру. Мейірбикелік білім беру тек диплом алғанға дейінгі кезеңмен шектелмейді. Үздіксіз білім алу (Continuing Education) мейірбикелерге жаңа дағдыларды меңгеруге және кәсіби деңгейін үнемі арттыруға көмектеседі.

4. Заманауи мейірбикелік білім беру бағдарламалары онлайн ресурстарды, мобильді қосымшаларды және интерактивті платформаларды пайдаланады, бұл білім алуды жеңілдетіп, ақпаратты жылдам табуға мүмкіндік береді. Кейс-стадилер мен клиникалық зерттеулер студенттерге теория мен практиканы байланыстыруға көмектеседі.

Клиникалық мейірбикелік зерттеулер науқастарға көмек көрсету сапасын арттыру үшін маңызды рөл атқарады. Өзімнің мейірбикелік тәжірибемді жетілдіру мақсатында мен осы зерттеулерге ден қоямын. Бұл зерттеулер жаңа емдеу әдістерін табуға және олардың тиімділігін бағалауға көмектеседі.

1. Клиникалық зерттеулер мейірбикелердің қолданатын ем-шараларының тиімділігін бағалауға бағытталған. Бұл зерттеулер жаңа әдістерді немесе қазіргі қолданыстағы процедураларды жетілдіруге көмектеседі.

2. Науқастардың ауырсынуын басқарудың түрлі тәсілдерін зерттеу клиникалық зерттеулердің маңызды бөлігі болып табылады. Мейірбикелердің ауырсынуды бағалау және оны жеңілдетуге арналған стратегияларды зерттеу бұл бағыттың басты міндеті.

3. Мейірбикелер созылмалы аурулары бар науқастарды ұзақ мерзімді бақылау және басқару бойынша жұмыс істейді. Бұл бағыттағы зерттеулер

ISBN 978-601-08-0758-7

диабет, жүрек аурулары, гипертензия, астма сияқты ауруларды тиімді басқару әдістерін іздейді.

4. Клиникалық мейірбикелер инфекциялық аурулардың алдын алу және олардың таралуын болдырмау мақсатында зерттеулер жүргізеді. Бұл бағыт денсаулық сақтау орындарындағы инфекцияларды бақылау мен төмендетуге арналған.

5. Мейірбикелердің күту сапасын жақсарту мақсатында клиникалық процестерді және қолданылатын тәсілдерді бағалау, стандарттау маңызды. Бұл зерттеулер емделушілерге көрсетілетін көмек сапасын арттыруға бағытталған.

6. Пациенттердің күтіммен қаншалықты қанағаттанғаны олардың емделу нәтижелеріне әсер етуі мүмкін. Клиникалық зерттеулер науқастардың күтімге байланысты қанағаттану деңгейін зерттеп, оны арттыруға бағытталған.

Көп ойлана келе мен қазіргі таңдағы ең ауқымды мәселелердің бірі мейірбикелік күйзеліс туралы зерттеу жұмыстарын жүргіздім. Мейірбикелер күйзеліске түрлі себептермен түседі, олардың арасында жұмыстың талаптары, эмоционалдық жүктеме, және жұмыс ортасының жағдайлары бар. Міне, негізгі себептер:

1. Мейірбикелер пациенттермен жұмыс істегенде, әсіресе ауыр және аяқсыз жағдайларда, үлкен эмоционалдық стресске ұшырайды. Ауруды және өлімді қабылдау, сондай-ақ пациенттерменэмоционалдық байланыс жасау кейде шаршауын тудырады, бұл күйзеліс деңгейін арттырады.

2. Зерттеулер мейірбикелердің көп пациентпен жұмыс істеген кезде күйзеліске түсу қаупінің артатынын көрсетеді. 1:4 қатынастағы мейірбикелер арасында күйзеліс деңгейі айтарлықтай жоғарылайды, бұл олардың еңбек өнімділігі мен моральдық жағдайына теріс әсер етеді.

3. Мейірбикелердің кәсіби біліктілігі мен мүмкіндіктерінің шектеулі болуы да күйзеліске ұшыратуы мүмкін. Кәсіби жетілдіруге арналған оқу мен дамыту мүмкіндіктерінің жоқтығы, мейірбикелердің жұмысынан қанағаттанбауына әкелуі мүмкін.

4. Мейірбикелердің қажетті медициналық құрал-жабдықтар мен ресурстардың тапшылығы күйзеліске түсулерінің бір себебі. Бұл олардың жұмысын қиындатады және нәтиже мен қызмет көрсету сапасына теріс әсер етеді.

Мейірбикелердің күйзеліспен күресу үшін бірнеше тиімді стратегиялар бар. Бұл тәсілдер олардың психикалық және физикалық денсаулығын сақтауына көмектеседі.

1. Мейірбикелер үшін демалу уақыты мен физикалық белсенділікті қамтамасыз ету өте маңызды. Спортпен айналысу немесе жай ғана серуендеу стресс деңгейін төмендетеді және энергияны арттырады.

ISBN 978-601-08-0758-7

2. Жұмыс орнында серіктестермен, отбасымен немесе достарымен пікір алмасу күйзеліске қарсы тиімді болуы мүмкін. Психолог немесе кеңесшімен сөйлесу де эмоционалдық жағдайды жақсартуға көмектеседі .

3. Білім беру мен кәсіби даму мүмкіндіктеріне қатысу, мейірбикелердің өзін-өзі бағалауын арттырып, жұмыстағы сенімділікті күшейтеді. Мұндай бағдарламалар күйзелісті азайтуға және жұмысқа деген қызығушылықты қайта жаңартуға мүмкіндік береді .

4. Медитация, йога және майндфулнес (ақпаратты қабылдау) сияқты әдістер мейірбикелерге күйзеліс деңгейін төмендетуге көмектеседі. Бұл әдістер тыныштықты сақтап, назарды шоғырландыруға мүмкіндік береді.

5. Мейірбикелердің жұмыс жүктемесін реттеу, яғни, өздері үшін қолайлы жұмыс уақытын анықтау және қажет болған жағдайда басшылығымен сөйлесу, күйзеліске қарсы көмек көрсетеді. Жұмыс жүктемесі мен пациенттермен қарым-қатынас деңгейін теңгеру маңызды.

6. Тиісті тамақтану және су ішу денсаулықты сақтауға көмектеседі, сонымен қатар энергия деңгейін көтереді. Мейірбикелердің күнделікті тамақтану режимі маңызды, сондықтан олардың дұрыс тамақтануы қадағаланады.

Қорытындылар: Мейірбикелік білім мен зерттеулер денсаулық сақтау жүйесінің негізі. Сапалы білім мен заманауи әдістерді игеру науқастарға көрсетілетін көмектің сапасын арттырады. Білім беру үрдісінде сандық және виртуалды оқыту, интердисциплинарлы тәсілдер және үздіксіз білім беру маңызды. Мейірбикелік зерттеулер емдеу тәсілдерін жетілдіруге, ауырсынуды басқаруға және инфекциялық бақылауға ықпал етеді. Сонымен қатар, мейірбикелердің жұмысындағы күйзелісті басқару кәсіби даму мен психологиялық қолдауды қажет етеді.

Әдебиеттер тізімі:

1. Бекжанова, А. М. Мейірбикелік іс және оның болашағы. Ташкент: "Тұмар", 2019.

2. Иванова, Л. А. Клиникалық мейірбикелік зерттеулер. Нұр-Сұлтан: "Ғылым", 2020.

3. Смит, Джон. Мейірбикелік білім беру негіздері. Алматы: "Медицина", 2021.

4. Journal of Nursing Scholarship: Мейірбикелік зерттеулер мен тәжірибелерді насихаттайтын журнал. Nursing Scholarship.

5. National League for Nursing: Мейірбикелік білім беру мен зерттеулерге арналған ресурстарды ұсынады. NLN Publications.

ISBN 978-601-08-0758-7

РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВИЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ И ВЫХАЖИВАНИИ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ

Канатханова Диана 4 курс Специальность «Сестринское дело»
Медицинский колледж «Авиценна» города Талдыкорган
Научный руководитель Имангожина Салтанат Женисбековна
преподаватель специальных дисциплин

Аннотация: *Эта статья демонстрирует сестринское дело, сестринскую помощь в родильной палате при оказании реанимационной помощи новорожденному, отделении реанимации интенсивной терапии новорожденных и отделении выхаживания недоношенных детей. Обязанности медицинской сестры, выполнение врачебных назначений, работа с аппаратурой, кормление через желудочный зонд недоношенных детей, обучение мамы навыкам ухода за недоношенным ребенком в условиях стационара и дома т.е повседневную работу медицинской сестры при стабилизации состояния новорожденных и выхаживании недоношенных детей.*

Выхаживание новорожденных с патологией является важной и актуальной по ряду причин. Около 10 % всех новорожденных нуждаются, в каких-либо мероприятиях для начала самостоятельного дыхания после рождения. Менее 1% младенцев нуждаются в проведении расширенных шагов реанимации.

На каждых родах должен присутствовать хотя бы 1 медработник, способный начать реанимацию.Важно готовить помещение и оборудование перед каждыми родами. Состояние оборудования должно проверяться перед каждыми родами, ежедневно.

В родильной палате если ожидается рождение недоношенного ребенка, готовится рабочее место для проведения расширенной реанимации новорожденных:

-теплое помещение, температура не ниже25- 28* С; хорошее освещение;

-не должно быть сквозняков;

-неонатальный стол с лучистым теплом с ровной поверхностью;

-заранее подогретые: пеленки, полотенца;

-часы с секундной стрелкой чтобы считать каждый шаг реанимации, на который отводится 30 секунд;

-стерильные перчатки,стерильный набор для пересечения пуповины;

-соответствующая обработка рук персонала.

Необходимое для реанимации новорожденных оборудование:

-ларингоскоп с 2-мя клинками соответствующих размеров №0 и №1; переходник и проводник;

-эндотрахеальные трубки размеры: №2; №2,5;№3;№3,5;№4;

ISBN 978-601-08-0758-7

-самонаполняющийся мешок (объем 250-400 мл, который создает давление 45 см водного столба) с 2-мя размерами масок №0 и №1;

-оборудование для аспирации:груша с мягкими наконечниками, чтобы не травмировать слизистые рта и носа, аспирационные катетеры размеры:№6 и №8, электрический отсос;

-медикаменты: адреналин 0,018% и физиологический раствор 0,9%;

-стерильные шприцы, лейкопластырь для фиксации;

-источник кислорода.

Новорожденные, которым потребуется реанимация:

-недоношенные новорожденные со сроком менее 35 недель;

-дети, рожденные в ягодичном предлежании,двойни,тройни;

-новорожденные с задержкой внутриутробного развития;

-тахикардия или брадикардия у плода;

-меконий в околоплодных водах;

-мать получала обезболивающие препараты или ей проводилась анестезия.

Решение о проведении реанимации должно быть принято еще до конца первой минуты жизни, когда необходимо провести первую оценку по шкале Апгар. Компоненты данной шкалы: частота дыхания,ЧСС, мышечный тонус и цвет кожных покровов. Цикл:Оценка-Решение-Действие[1,29бет].

Состояние каждого новорожденного после рождения должно быть оценено по следующим признакам:

-является ли новорожденный доношенным?

-новорожденный дышит или кричит?

-имеет ли новорожденный хороший мышечный тонус?

Если ответ на все 3 вопроса положительный, то новорожденный не нуждается в реанимации.

Если хотя бы на один из этих вопросов имеет ответ отрицательный, то надо понимать что новорожденный нуждается в 1 или более из следующих 4 действий, которые выполняются в строгой последовательности:

-А. Первичные шаги по стабилизации(обеспечить тепло; придать правильное положение; освободить дыхательные пути, если необходимо;обсушить, стимулировать; проверить положение тела)-30 секунд.

В.Искусственная вентиляция легких (ИВЛ)-30 секунд(в 1 мин 40-60 ИВЛ);

С.Непрямой массаж сердца (НМС) и ИВЛ-30 секунд.Соотношение 3 к 1(в 1 мин 90 НМС и 30 ИВЛ=120 компрессий);

Д.ВВедение адреналина и восполнение объема циркулирующей крови (ОЦК).

Около 30 секунд необходимо для проведения каждого шага, повторной оценки и принятия решения о переходе к следующему.

ISBN 978-601-08-0758-7

В отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных оказывается высококвалифицированная помощь новорожденным, требующим поддержание жизненно важных функций (сатураций SPO 2,ЧСС, ЧД, АД и температуры) и проведения интенсивной терапии, включая недоношенных детей. Самые сложные пациенты - это недоношенные дети с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ-менее 1000,0 грамм). Забота медицинской сестры о таких малышах начинается еще в родильной палате. Она создает тепловую защиту (инкубаторы для выхаживания недоношенных детей (в инкубаторе создается определенный микроклимат: температура и влажность согласно весовой категории ребенка)

Температурный режим инкубатора:

Вес 1000,0-1500,0 грамм температура 34-35* С

1500,0-2000,0 грамм температура 32-34*С

2000,0-2500,0 грамм температура 30-32*С

более 2500,0 грамм температура 28-30*С

неонатальный стол с источником лучистого тепла, подогретые принадлежности: (распашонки, чепчик, ползунки, пеленки) и незамедлительно обёртывает пелёнкой с полиэтиленовым покрытием, так как теплопотеря у новорождённых с низкой массой тела очень значительна, присоединяет датчики для измерения сатураций, давления, пульса и температуры тела. Транспортировка новорожденных из родильного зала в отделение интенсивной терапии проводится врачом и медицинской сестрой под контролем пульсоксиметрии и соблюдением температурного режима в транспортном инкубаторе[1,69бет].

Уход за «маловесным ребенком» после рождения.

Маловесным детям чаще потребуется реанимационная помощь в родовой палате по сравнению с детьми с нормальным весом.

В профилактике РДС (респираторного дисстресс синдрома) : широкое применение экзогенного сурфактанта, снижает необходимость переливания крови недоношенным детям, которым было отложено пережатие пуповины.Пережатие пуповины следует задержать минимум на 30-45 секунд (за это время прекращается фетоплацентарное кровообращение), что позволяет провести частичное переливание и может привести к снижению выраженности РДС. Это сводит к минимуму потребность в поддержке АД (артериального давления), улучшить запасы железа, уменьшить потребность в последующих переливаниях крови.

Уход за «маловесным ребенком» после рождения.

ISBN 978-601-08-0758-7

Профилактика гипотермии.

Тепловая цепочка должна начаться до рождения. Родильная палата должна быть подготовлена с адекватной температурой не ниже 25*С. Если ожидаются роды недоношенного ребенка, в таком случае адекватной считается температура минимум 28* С. Родильная палата не должна продуваться сквозняком. После обсушивания ребенка кладут на грудь матери для контакта «кожа к коже». Большое количество тепла теряется через кожу головы новорожденного (голова составляет 25% поверхности тела ребенка).Поэтому голову ребенка надо покрыть детской шапочкой, но если шапочки нет, тогда голову можно накрыть пеленкой. При транспортировке следует соблюдать тепловую цепочку, для профилактики гипотермии.Мать и ребенка надо укрыть теплым одеялом. [2,86бет].

Тепловая цепочка это соблюдение всех звеньев температурного режима:

-обученный персонал;

-теплое помещение 25*С;

-немедленное обсушивание;

-контакт «кожа к коже»;

-раннее начало грудного вскармливания;

-отложить купание, взвешивание, полный осмотр на 2 часа;

-адекватно одетый ребенок;

-совместное пребывание матери и ребенка 24/7;

-тепловая защита во время реанимации и транспортировки новорожденного.

Если ребенок будет готов, то необходимо начать первое кормление грудью. После телесного контакта «кожа к коже» ребенка необходимо одеть адекватно (заранее подогретые теплые пеленки для немедленного обсушивания после родов, теплая ,чистая распашонка, шапочка, ползунки, носочки и рукавички), не пеленать туго и оставить с матерью на 2 часа под наблюдение в родильной палате. Если ребенку нужна дополнительная помощь, включая реанимацию, то следует использовать обогреватель, чтобы предупредить потерю тепла. Новорожденного необходимо перевозить в тепле (в инкубаторе с подогревом, используя пульсоксиметр, кроватке с подогревом или укутанного в теплое одеяло).

ISBN 978-601-08-0758-7

Контакт «кожа к коже» прерывать не нужно.Частота дыхания может быть подсчитана путем наблюдения за спиной ребенка, проверять цвет кожи лица.Необходимо контролировать температуру ребенка каждые 15 минут, дотрагиваясь до его стоп и если они холодные на ощупь, нужно измерить температуру тела ребенка в подмышечной впадине. Измерять температуру тела ребенка на 30 минут и через каждые 2 часа после рождения.

В отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных детей прием осуществляется двумя медицинскими сестрами для более быстрой стабилизации и адаптации маленького пациента. Предварительно собрано и нагрето реанимационное место (инкубатор или неонатальный стол), установлен кардиомонитор (ЧСС, ЧД,АД, сатурация SPO2, температура ребенка), собраны наборы для постановки ЦВК (центрального венозного катетера) и оборудование для интубации. Интубацию проводит врач-неонатолог с соблюдением санитарно-эпидемиологического режима, правил асептики и антисептики (обработка рук врача и медицинской сестры, которая асисстирует ему, надевание стерильного халата и стерильной перчатки для работы, головного убора :колпак или чепчик, а также обязательно надо одевать маску).

С соблюдением такого же порядка работы проводится и пупочная катетеризация новорожденного ребенка, которую проводит врач-неонатолог, помогает ему медицинская сестра поста ОРИТ.После проведения всех мероприятий, направленных на стабилизацию состояния, начинается процесс выхаживания. Своевременное выполнение врачебных назначений, исследований, сбор анализов на исследования, кормление, обучение мам уходу за ребенком, соблюдение санитарно-эпидемиологического режима на всех этапах работы медицинской сестры.

Одним из важнейших аспектов сестринской работы в отделении реанимации новорожденных является соблюдение санитарно-эпидемиологического режима, контроль и выполнение назначений врача. В них входят, как соблюдение сроков введения лекарственных препаратов, так и своевременное фиксирование всех необходимых показаний монитора в соответствующую документацию.

ISBN 978-601-08-0758-7

Медсестра играет очень важную роль в выхаживании глубоко недоношенных младенцев. Она следит за поддержанием оптимальной температуры и влажности в инкубаторе, организует лечебно-охранительный режим, делает все, чтобы создать максимально комфортные условия для ребенка. Укладывает малыша в специальное «гнездышко» (можно сделать из подручных средств: пеленок), чтобы придать конечностям физиологическое положение, надевает шерстяные шапочки и носочки, для сохранения нормальной температуры тела и создания естественного массажа рефлекторных зон стоп.

Также в ОРИТ новорожденных в процессе выхаживания применяются вязаные игрушки в форме осьминога. У «осьминожек» щупальца схожи с пуповиной, когда малыш держится за них, он чувствует защищенность, которую испытывал в утробе матери. Это и помогает таким малышам быстрее восстанавливаться. Помимо этого щупальца отвлекают крох от катетеров и датчиков, подключенных к ним, исключая риск отсоединения их ребенком.

Новорождённых с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) медицинская сестра, кормит через желудочный зонд (размеры зондов №6 и №8) грудным молоком. Грудное молоко содержит оптимальное количество протеина, которое помогает маленькому организму бороться с внешними инфекциями, и специальные микроэлементы для поддержки еще не успевшего дозреть желудочно- кишечного тракта младенца.

Медсестра наблюдает и ухаживает за ребенком 24 часа в сутки. Поскольку она знает маленького пациента очень хорошо, одним из важных направлений в ее работе становится поддержание контакта с его родителями: обучение мам сцеживанию грудного молока, помощь при пеленании и смене подгузников, проведение лекций по уходу за недоношенными и маловесными детьми, выкладывание ребенка методом «Кенгуру». Метод «Кенгуру» - это способ выхаживания недоношенных детей, при котором максимально должен быть задействован физический контакт «кожа к коже» малыша и матери. Суть метода заключается в том, что детей ежедневно, от одного до нескольких часов в день, выкладывают на открытую поверхность груди мамы или папы.

Метод «Кенгуру» плюсы:

-больше молока у матери;

-быстрее растет на грудном вскармливании;

-лучше моторное развитие;

ISBN 978-601-08-0758-7

-лучше умственное развитие;

-успокаивает недоношенного ребенка;

-обезболивает недоношенного ребенка;

-защищает от стресса;

-стабилизирует уровень сахара;

-стабилизирует сердцебиение;

- реже апноэ;

-стабилизирует дыхание;

-нормализует температуру.

Использование метода «Кенгуру» ускоряет адаптацию малышей к окружающему миру, они лучше развиваются и набирают вес.

Профилактика гипогликемии:

-начать кормление грудью или смесью в течение 1-2 часов после рождения;

-начать внутривенное введение глюкозы, если невозможно кормление грудью.

Выхаживание самых маленьких пациентов требует слаженности, четкости и оперативности действий всех сотрудников ОРИТ новорожденных и выхаживания недоношенных новорожденных детей[2,65бет].

Заключение:

От медицинской сестры, участвующей в процессе выхаживания недоношенного ребенка зависит то, как быстро сумеет он адаптироваться к новым условиям жизни. Особая роль в выхаживании детей с экстремально низкой массой тела принадлежит круглосуточно ухаживающим врачам и медицинским сестрам.

Эффективность медицинской помощи новорожденным определяется не только внедрением и совершенствованием высоких технологий лечения, но и созданием для них особого режима выхаживания, в котором основная роль принадлежит медицинским сестрам.

Список литературы:

1. Эффективная перинатальная помощь и уход (ЭПУ).Руководство для участника.

2. Сестринский уход в акушерстве и гинекологии. Славянова И.К. 2 издание рекомендовано Научно-методическим советом МНОО «МАИТ» в качестве учебного пособия для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по специальностям «Сестринское дело», «Акушерское дело». г.Ростов -на-Дону «Феникс» 2019 г

ISBN 978-601-08-0758-7

БҮЙРЕК ЖЕТІСПЕУШІЛІГІ БАР НАУҚАСТАРМЕН ЖҰМЫС КЕЗІНДЕГІ МЕЙІРБИКЕЛІК КҮТІМ

Қалихан А.Қ. 4 курс «Мейіргер ісі» мамандығы
ШЖҚ «Кеңес Одағының Батыры Мәншүк Мәметова атындағы Ақтөбе Жоғары медициналық колледжі» МКК
Ғылыми жетекшісі: Динашова Ж.Б. арнаулы пән оқытушысы

Аннотация: *Бұл мақалада бүйрек жеткіліксіздігін ерте диагностикалау, алдын алу және емдеу өте маңызды екені қарастырылған. Медбике бүйрек жетіспеушілігіне уақтылы күдіктенуге немесе диагноз қоюға, науқасқа оңтайлы және тиімді күтім жасауға қабілетті. Мақалада бүйрек жетіспеушілігі негізгі клиникалық белгілері сипатталған-қан қысымының жоғарылауы, анемия, қан кету. Мейірбикелік күтімді ұйымдастыру анамнез жинауды, клиникалық тексеруді, пациенттің мәселелерін анықтауды, жоспарлауды және күтімнің өзін тікелей қамтиды.*

Бүйрек жеткіліксіздігі деп әр түрлі функциялардың, компенсаторлық мүмкіндіктердің және бүйректің гомеостазды сақтау қабілетінің біртіндеп дамып келе жатқан бұзылыстары түсініледі – дененің ішкі ортасының қалыпты жағдайы. Бүйрек жеткіліксіздігі өте кең таралған, халықтың өмір сүру сапасы мен ұзақтығына теріс әсер етеді. Жер шарының әртүрлі аймақтарында 1 миллион ересек адамға 100-ден 210 адамға дейін әсер етеді. Бүйрек жеткіліксіздігін ерте диагностикалау, алдын-алу және емдеу өте маңызды, ал медбике бүйрек жеткіліксіздігіне уақтылы күдіктеніп, науқасқа мамандардың тексеруінен өтуге кеңес бере алады.

Ресми статистикаға сәйкес, емделудің диализге дейінгі және кейінгі кезеңінде пациенттердің өлімінің негізгі себебі жүрек-қан тамырлары аурулары болып табылады. Қазіргі уақытта жүрек-қан тамырлары ауруларының дамуының негізгі себебі эндотелий дисфункциясы және атеросклероз екендігі дәлелденді. Буйрек жеткіліксіздігі проблемалары медициналық және әлеуметтік тұрғыда жоғары өлім-жітімге, мүгедектікке әкелетіні белгілі.Осыған орай осы патологияны емдеуде алдын алуда заманауи техникалық әдістері маңызды болып отыр. Созылмалы бүйрек жеткіліксіздігі көптеген ауруларды туғызуда, бірақта ол көп көріне, біліне бермейді.

Бүйрек жеткіліксіздігі – бүйректің физиологиялық функцияларын толық немесе ішінара жоғалтуы. Мейірбикелік тәжірбие аясында бүйрек жеткіліксіздігі бар науқастарға ерекше назар аударылады, өйткені бұл жағдай үнемі медициналық бақылау мен күтімді қажет етеді. Пациенттердің осы санаты үшін сапалы күтімді қамтамасыз етудегі мейірбикелердің рөлі баға жетпес. Бүйрек жеткіліксіздігінің мейірбикелік күтімі медициналық процедураларды орындауды ғана емес, сонымен қатар психологиялық қолдауды, пациенттерді өзін-өзі басқаруға үйретуді және асқынуларды

ISBN 978-601-08-0758-7

алдын-алуды қамтиды. Созылмалы бүйрек жеткіліксіздігінің кері ағымы болмайды – медицинада адам емделіп, бүйрек қызметін толық қалпына келтіретін жағдайлары жоқ.

Біздің елімізде Денсаулық сақтау дамыту кезеңінде мейірбикелік көмек басты орын алады.Теориялық білімімен қоса,практикалық жағынан да, заманауи техникалардың жетік меңгерген, өз ісіне шебер медбике қай тұстада маңызды орын алатыны белгілі. Осыған орай бүйрек жеткіліксіздігімен ауыратын науқастар үшін мейірбикенің алатын орны ерекше. Мейірбике бүйрек жетіспеушілігі бар науқасқа асқынуларды алдын алу, жақсарту өмір сапасы мен емдеудің оңтайлылығын қамтамасыз етеді. Жалпы айтқанда әрбір пациентке күтімді жоспарлау оны жүзеге асыру кезеңдері медбике үшін басты мақсат.Мейірбике өзінің жұмысын жоғары деңгейде орындап сапалы күтім көрсетудің арқасында қаншама науқастардың жағдайы жақсарады.

Медбике бүйрек жеткіліксіздігі ауыратын науқастың жағдайын, соның ішінде бүйрек фукнциясын бағалау арқылы өмірлік маңызды мониторинг көрсеткіштері деңгейін бақылау(креатинин, мочевина,электролиттер); күтім кезінде психологиялық қолдау көрсету; күтім кезінде эмоцияларын түсіну керек.

Зерттеу мақсаты: Бүйрек жеткіліксіздігі кезінде мейірбикелік зерттеуді ұйымдастыру

Зерттеу міндеттері:

1. Аурудың негізгі түрлеріне, себептеріне, әдеби шолу жасау

2.Бүйрек жеткіліксіздігімен ауыратын науқастардағы жұмыс кезінде мейірбикелік күтімге зерттеу жүргізу

3. Гемодиализ орталықтарының жұмыстарында сауалмана жургізу

Зерттеу нәтижесі. Зерттеудің практикалық бөлімі 20 жылдан астам заманауи диагностика мен емдеу сапасының жоғары деңгейімен белгілі Ақтөбедегі жетекші көпсалалы «BIOS медицина орталығында» жүргізілді.

№	Уақыты	Науқастардың жалпы саны	Науқастардың қозғалысы (движение пациентов)				Өлімі
			Түскендер	Ауысқандар	Уақытша үйге қайтарылғандар	Диалездан бас тартқан науқастар	
1	**Қаңтар 2023**	124	6	3	-	-	4
2	**Ақпан 2023**	123	2	3	-	-	-
3	**Наурыз 2023**	127	4	1	-	-	-
4	**Сәуір 2023**	130	2	4	3	-	4
5	**Мамыр 2023**	126	4	4	-	2	-

ISBN 978-601-08-0758-7

6	**Маусым2023**	124	3	1	1	-	1
7	**Шілде 2023**	127	2	1	1	1	1
8	**Тамыз 2023**	129	2	2	-	-	2
9	**Қыркүйек 2023**	128	1	1	-	-	4
10	**Қазан 2023**	124	3	2	-	-	-
11	**Қараша2023**	126	3	3	0	0	2
12	**Желтоқсан2023**	124	5	3	0	0	4

2023 жылдың қорытындысы бойынша жыл ішінде 126 науқас тіркелген, айына орта есеппен 3 науқастан түсіп отырған,диализден бас тартқандар саны 3, 22 науқас өліммен аяқталған.

Нәтижесінде науқастардан сауалнама жүргізі барысында көбінесе үлкен жастағы адамдар ауратыны белгілі болды.Олардың 35% ерлер 65%ы әйелдер де кездеседі. Медбике 1 аптада 2 реттен науқастардың салмақ көрсеткіштерін, диализдің басталған және аяқталған уақытын белгілеп жазып отырады. Сонымен бірге медбикеде арнайы диализдің процедуралық картасы бар. Онда науқастың салмақтарын, артериалдық қан қысымының және асқынуларды жазып уақытын міндетті түрде нақты көрсетеді. Ауырсынуды басу үшін қосымша медикоменттер қолданылады [кеторал, анальгин, димедрол, бинокрит]. Науқастардын 85% ы медбикелердің жұмысына қанағаттанатынын атап өтті. Осыған орай медбикенің жұмысының тиянақтылығы,шыдамдылығы өте маңызды екенін түсіндім.

Қорытынды. Зерттеу жұмысы барысында мен келесі қорытындылар жасаймын:

1.Бүйрек жетіспеушілігі еліміздің төңірегіндегі өзекті мәселелердің бірі болып отыр.Зерттеу жұмысында 2 негізгі зерттеу әдісі қолданылды. Бірінші кезеңде 2023 жылғы науқастардың сандық көрсеткіші зерттелді. Ол ересек жастағы адамдар арасында өлім жітім мен сырқаттанушылықтың басты себебі болып табылады. 2023 жылға арналған гемодиализ кезінде науқастар санын талдай отырып, науқастардың саны жылдан жылға артып келе жатыр деп қорытындылауға болады.

2. Зерттеудің практикалық бөлімі 2024 жылы BIOS медицина орталығында өтті. Бұл кезеңде жалпы сауалнамаға 20 науқаспен сауалнама жүргізілді. Сауалнама нәтижелері сауалнамаға қатысушылар таңдаған дұрыс жауаптардың индикаторлардың есептеу әдісімен бағаланды. Науқастар басым көпшілігі диализге тәуелділігін көрсетті 10% жалпы жағдайына байланысты Гемодиализ өлімінде жатқанына 1 апта өткен, 65% респонденттің жатқанына 2-3 апта өткен, қалған 25% 3 аптадан аса уақыт бөлімшеде жатырғаны белгілі болды. Респонденттердің 90% мүмкін болатын асқынулар туралы білетінін, 5% айтылмағанын және 5% жауап беруге қиналатынын айтты. Бөлімшеде жатқан респонденттердің 65% әйел адам,35 % ер адам болды.Респонденттердің 90% гигиеналық шаралар уақытылы

ISBN 978-601-08-0758-7

жасалатынын атап өтті. Респонденттердің 85% мейірбикелік күтімге қанағаттанатынын атап өтті..80% науқастар мейірбикелік манипуляциялардың уақытылы жасалып жатқанын айтты. Барлық науқастар мейірбикелер тарапынан болған қарым қатынасты жақсы бағалады. 90% науқастар физикалық белсенділік туралы ақпарат алған. Науқастар арасында жүргізілген сауалнама нәтижелерін талдай отырып, науқастардың басым көпшілігі медбикелермен сұхбаттаспағанын және өз ауруы туралы толық ақпараттанбағанын байқадық. Ақпараттың негізігі әрі дәлелді көзі медицина қызметкерлері екенін ескере отырып медбикелермен болған сұхбаттан соң науқастардың өз ауруына деген көзқарасы жақсы жағына өзгерді және бүйрек жетіспеушілігі туралы толық ақпарат алды. Сонымен қатар олар медбикелерге толықтай ризашылығын білдіріп, алғысын жеткізді. Барлық науқастар мейірбикелік күтім маңызды деп санайды.

Әдебиеттер тізімі:

1.Калн Р. И. Пересадка почки. В кн.: Пересадка органов. М., 2020, 9-188. Кирпатовский И. Д. Современные проблемы оперативной хирургии. М., 2020

2.Кирпатовский И. Д., Быкова Н. А. Пересадка почки (экспериментальные и биологические основы). М., 2019.

3. Багненко С.Ф. Асистолические доноры полноценный ресурс ренальной трансплантации. Оптимальный протокол мероприятий / С.Ф. Багненко, Я.Г. Мойсюк, О.Н. Резник. // Вестник трансплантологии и искусственных органов. — 2018. - № 4. - С. 3-12.

4. Балакирев, Э.М. Некоторые аспекты проблемы трансплантации органов в России // Нефрология и диализ. 2019. - Т.5. - № 1. - С. 8.

5.Brown EA. Supportive care for people with kidney disease: ethnic and cultural challenges. J Ren Care. 2014 Sep;40 Suppl 1:1. doi: 10.1111/jorc.12094. PMID: 25185485.

6.Buur LE, Bekker HL, Mathiesen CL, Holm LT, Riise I, Finderup J, Stacey D. Decision coaching for people with kidney failure: A case study. J Ren Care. 2023 Dec;49(4):220-228. doi: 10.1111/jorc.12459. Epub 2023 Feb 3. PMID: 36734306.

7.Buur LE, Bekker HL, Mathiesen CL, Holm LT, Riise I, Finderup J, Stacey D. Decision coaching for people with kidney failure: A case study. J Ren Care. 2023 Dec;49(4):220-228. doi: 10.1111/jorc.12459. Epub 2023 Feb 3. PMID: 36734306.

.

ISBN 978-601-08-0758-7

ГЕРИАТРИЯЛЫҚ ПАЦИЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН МЕЙІРГЕРЛІК КҮТІМ

Қындыбай Айгерім Ерболқызы, арнайы пәндер оқытушысы
«Қызылорда медициналық жоғары колледжі»

Аннотация: *Бұл мақалада дамыған елдер тәжірибесінде гериатриялық қызметтер, стандартталған және жақсы құрылымдалған.Сонымен қатар гериатриялық мейірбике сапасының жақсы дамығанын айтуға болады. Қызмет ететін шетелдік ресурстармен байланысты медбикелердің арнайы білімін алу, сондай-ақ гериатриялық медбикелердің практикасында айтарлықтай қолдау көрсету. Гериатриялық медбикелер тиісті нысандарда маманданған медициналық және әлеуметтік салаларда жұмыс істейді және қарт адамдарға күтім жасауды баяндайды.*

Өзектілігі: Біздің жұмыс қарт адамдарға мейірбикелік көмек көрсетудің моральдық-этикалық тәрбиелік компонентін қарайды, мейірбикелердің ағымдағы жұмысының нақты талаптарын ескере отырып, гериатриялық пациенттермен жұмыс жасауға оң әсер ету үшін қажет қадамдарды қарастыру. Гериатриялық пациенттердің белсенді немесе пассивті күйін ескере отырып, күтім ерекшеліктері мамандандырылған көмекке арналған деп санайды. Мейірбикелік үрдіс - пациенттердің қамқорлығындағы қателіктерді үнемі іздестіруге және жүйелі түрде күтім жасау жоспарына түзетулер енгізуге мүмкіндік беретін әдеттен тыс икемді, жанданған және динамикалық үрдіс.Медициналық емдеудің қортындысы бойынша пациент ретінде медицина қызметкерлерімен белсенді түрде жұмыс істейтін бірегей тұлға болып табылады: қарттық кезендегі науқастар, соңғы ауруымен ауыратын науқастар. Егде жастағы адамдардың әл-ауқатына қолдау көрсету,қалпына келтіру, тәрбиелеу, өмірді жақсарту және т.б. Геронтологияда мейірбике ісі немесе гериатриялық мейірбике егде жастағы немесе қарт адамдарға қамқорлық жасайды. Гериатриялық мейірбике қартайған адамның физиологиялық дамуы, психологиялық, әлеуметтік-экономикалық, мәдени және рухани қажеттіліктерін ескереді [1].

Себебі қартаю - өмірдің қалыпты және негізгі бөлігі. Егде жастағы пациенттерге мейірбике күтімін қамтамасыз ету тек бір салаға ғана емес, олардың отбасыларын, қауымдастығын және денсаулық сақтаудың басқа да топтарын қамтитын бірлескен күш арқылы беріледі. Осылайша, мейіргерлер егде жастағы адамдардың өмір сапасын жақсарту және қолдау үшін әр топтың білімі мен ресурстарын пайдалана алады. Гериатриялық денсаулықтың әртүрлі аспектілеріне ұйымдасқан тәсілді қолдану арқылы егде жастағы науқастарға мейіргерлік көмекті,және мейіргерлік қамқорлықты жақсарту [2].

Жұмыстың мақсаты: денсаулық сақтау ұйымының медициналық анықтамасымен расталған егде жастағы және қарт адамдардың өмір сүру

ISBN 978-601-08-0758-7

сапасын және жалпы жағдайын жақсарту. Гериатриялық пациенттерге сапалы күтімді ұйымдастыру.

Егде жастағы адамдарға арналған денсаулық сақтау саласындағы жетістіктер өмір сүру ұзақтығының артуына алып келді және халықтың қартаюына әкелді. Бұл топ өсіп келе жатқандықтан, күтіп-бағуды қамтамасыз ету үшін көп медбикелер қажет болады. Көптеген денсаулық сақтау саласының қызметкерлері жас немесе одан да көп физикалық мүмкіндігі бар науқастармен айналысатын аймақтарға мамандандырылған. Бұл «ескі пациенттің ауытқу синдромы», оның ішінде жас ерекшелігі, қарттардан қорқу және басқа да жас топтарымен жұмыс істеу артықшылығы қазіргі және келешектегі пациенттердің шынайылығынан ажыратылуы мүмкін. Егде жастағы адамдарға қамқорлық жасауға мүдделі медициналық қызмет көрсетушілердің жетіспеушілігі ғана емес, жалпы денсаулық сақтау қызметкерлері ересектерге күтім жасау үшін жеткілікті түрде дайындалмаған [3,4].

Науқастың демографиясы. Медициналық институттың есебі бойынша «Қазақстанда қартаюды қалпына келтіру: денсаулық сақтау қызметкерлерін құру» деп аталатын баяндамада Қазақстанда үлкендер ересектер саны 2005 жылдан 2030 жылға дейін екі есе өседі. Бұл топ Қазақстан халқының 40% -ын құрайды.

Қазіргі уақытта 65 жастан асқан ересектердің төрттен үш бөлігінен астамы созылмалы медициналық жағдайдан зардап шегеді. Егде жастағы ересектер кез келген басқа топқа қарағанда денсаулық сақтау қызметтеріне көбірек көңіл бөледі: барлық аурухана күндерінің жартысы, барлық амбулаториялық келулердің төрттен бір бөлігі, емдеу мекемелерінде үйге күтім көрсетудің 70% және 85% білікті және ұзақ мерзімді болады.

Медбикелік практикаға әсер етуі. Егде жастағы ересектердің бұл санының артуы өткір және сыни медициналық көмекке қатысты үлкен салдарға әкеледі. Дамыған елдер тәжірбиесінде жүргізілген зерттеулер бойынша, медбикелердің 70% -ы геатрияны тәжірибе бөлігі ретінде қарастырмады, олар егде жастағы адамдарға ауыр емес немесе ұзақ күтіммен қамқорлықты теңестірді. Сәйкесінше, гериатриялық білім беруді ынталандыру, гериатриялық құзыреттілікті арттыру және гериатриялық мейірбике зерттеулерін ынталандыру бойынша күш-жігерді күшейтті [5].

Дегенмен, сапалы гериатриялық мейірбикелік күтім оқу бағдарламасына негізделген білімнен әлдеқайда көп. Егде жастағы науқастар тек қарттар емес, олар жасына тән мұқтаждықтары бар олар сыпайылықпен, сапалы қамқорлықты қамтамасыз ететін құзыретті медбикелерді талап етеді. Көптеген ауруларды ауруханаға жатқызу мен алаңдаушылықпен қиындатуы мүмкін көптеген аурулармен ауырады. Бұл топ, бұрынғы ұрпақтарға қарағанда, білім алу, ұзақ өмір сүру, кеңінен таралған отбасылар, нәсілдік және этникалық алуан түрлілікке ие бола отырған әртүрлі халық болып табылады.

ISBN 978-601-08-0758-7

Созылмалы медициналық жағдайды басқаруға назар аудара отырып, мейірбике науқастың өмір сапасын жақсартуға көмектесе алады. Өз денсаулығын басқаруға үйрену кезінде науқастар көп тәуелсіздік сақтап, медициналық көмекке қажеттілігін азайта алады. Медбике отбасы мүшелеріне, достарына және басқа адамдарға науқасқа қамқорлық көрсету үшін қажетті дағдыларды және дағдыларды алуға, олардың стресстерін жеңілдетуіне көмектесуі мүмкін.

Гериатриялық науқастарға күтім жасау әдісі. Өмір сүру ұзақтығы арта түскен сайын, ересектердің көптігі Альцгеймер ауруы мен басқа даменциациялардың пайда болуын бастан кешуде. Бұл науқастарға қамқорлық ауру процесін түсінбей-ақ қиын және күрделі болуы мүмкін. Деменция ақыл-ойдың когнитивтік функциясының төмендеуі ретінде анықталады және ақыр соңында психикалық және физикалық жағдайдың нашарлауына әкеледі. Осы пациенттер үшін қауіпсіз ортаны қамтамасыз ету өте маңызды, оларға құрметпен қарау және олардың қадірін сақтауға көмектесу.

Бұл науқастар күнделікті тіршілік әрекеті (монша, тамақтану, дәретхана, тіс пен шашты тазалау) сияқты қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін өздеріне арналған тапсырмаларды орындауға рұқсат беруі керек. Көптеген пациенттер өз ойларымен және әрекеттерімен бекітілген және қайталанатын болғандықтан, белгілі бір дәрілердің уақытын, тамақтану уақытын, ваннаға арналған уақытты және ұйықтау уақытын жиі тыныштандырады. Тыныш ортада тыныштандыратын бояулар мен жарықтандырғыштар деммен жұғысымен науқасқа тән алаңдаушылық пен шатасуларды азайтуға көмектесуі мүмкін.

Нәрестені ылғалдандыру және тамақтану - бұл осы науқасқа күтім жасаудың маңызды факторы. Деменция, әсіресе дамыған кезде, науқастың денсаулығының асқынғандығына әкеліп соқтыратын кезде, тіпті ішу немесе ішкен кезде де ұмытып кетуі мүмкін. Медбике пациенттің тағамдық күйіне әсіресе сезімтал болуы керек және мүмкіндігінше сүйікті тағамдар мен сусындардың кішкене порциясын ұсынуы керек [6].

Жұмыс нәтижесі. Деменциясы бар науқаспен сөйлесу қиын болуы мүмкін. Олар ойлар мен нұсқауларды орындауға қиындық тудыруы мүмкін. Қарапайым сөздер мен сөз тіркестерін қолданып, бет әлпетін және дене сигналдарын қолдану пайдалы болуы мүмкін. Егер науқас ашуланып немесе шатастырылса, тыныш, бірақ қатаң түрде басқа тақырыпқа қайта бағыттау олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге көмектесуі мүмкін.

Елімізде және дамыған елдерде қарт тұрғындары өсіп келе жатқандықтан, ол қазіргі уақытта тым кішкентай және оның қажеттіліктерін қанағаттандыруға дайын емес денсаулық сақтау жүйесіне тап болады. Егде жастағы адамдарға қамқорлық жасауға, басқа медицина қызметкерлеріне басшылық пен білім беруге құзырлы болып келетін көп медбикелерге аса қажет.

ISBN 978-601-08-0758-7

Қорытынды. Тұжырымдай келе, емделушілерге арналған геронтология курстарын қосатын мектепке дейінгі білім беру бағдарламаларын кеңейту және қазіргі уақытта жұмыс күшінің медбикелеріне мамандандырылған оқытуды қамтамасыз ету олардың осы өсіп келе жатқан пациенттерге оңтайлы көмек көрсетуге дайындығына көмектеседі. Қарттар денесі жасөспірім ересек денесінен физиологиялық ерекшеленеді, ал қартайған кезде әртүрлі орган жүйелерінің төмендеуі байқалады. Денсаулық сақтау проблемалары мен өмір салтын таңдауы әртүрлі адамдардағы аурулар мен симптомдардың әртүрлі жұлдыздарын береді. Симптомдардың пайда болуы органдардағы қалған сау қорықтарға байланысты. Қарт адамдар, әдетте, өзін-өзі қамқорлыққа және күнделікті өмірдің басқа да әрекеттеріне қатысуды талап ететін мүмкіндігінше ұзақ өмір сүргісі келеді. Емделушінің егде жастағы адамдарға күтім жасау туралы ақпарат беруі мүмкін және адамдарға үйдегі күтім қызметтеріне, білікті мейірбике ісі мекемелеріне, жәрдемдескен үй-жайларға және хосписті жатқызуға болады.

Әдебиеттер тізімі:

1. Denham MJ. Dr Marjory Warren CBE MRCS LRCP (1897-1960): the mother of British geriatric medicine. J Med Biogr 2011;19:105-10..

2. Labrum T. Factors related to abuse of older persons by relatives with psychiatric disorders. Archives of Gerontology and Geriatrics. 2017;68:126-134..

3. Консон К., Баутина Л.В. Работа гериатрической сестры — подход в Израиле. – http://www.cm20924. tmweb.ru/images/stories/2015okt6/2015-10-6-bautina.pdf. [(In Russ.)]

4. Журнал «Главная медицинская сестра». 2013 г.

5. Журнал "Сестринское дело", №1,3,5,6,4, 2015г.

6. Пузина С.Н «Гериатрия». стр 22-25 , 2022 г.

ISBN 978-601-08-0758-7

ҚАНТ ДИАБЕТІНЕ БЕЙІМДІЛІКТІ АНЫҚТАУ

Медетбай Д.Ж., Яхып Қ.Қ., Төлеген Г.Б. « 1 курс мейіргер ісі» мамандығы

БОПАЙ ХАНЫМ ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ

Ғылыми жетекшісі м. ғ. к. Насухин Ш. Б. Оқытушы :Жоламанова А.К.

Аннотация: *Зерттеу жұмысы 17- 19 жас аралығындағы білім алушылар арасында қант диабетіне бейімділікті анықтауға арналған.Эпидемиялогиялық,антропометриялық және лабараториялық тәсілдермен қант диабетіне шалдығуы мүмкін білім алушылар анықталып,оларға аурудың алдын алу бойынша кеңес берілді.*

Өзектілігі: Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтері бойынша әлемде әр 10 секунд сайын қант диабетімен ауыратын 1 науқас оның асқынуларынан қайтыс болады.Яғни жыл сайын 4 млн-ға жуық науқас қайтыс болады.1985 жылы 30 млн. адам қант диабетімен тіркелген.15 жылдың ішінде олардың саны 150млн-ға жеткен.Бүгінгі күні қант диабетіне шалдыққан адамдар12-15 жылда 2 есеге көбеюде.Халықаралық қант диабеті Федерациясының мәліметінше қазіргі күні 537 млн адам , қант диабетімен ауырады цифрда бұл көрсеткіш 2030 жылға қарай 643 млн болса , ал көтерілсе 2045 жылға қарай 783 млн-ға жетеді деп болжап отыр.Ал әлі анықталмаған диабетпен ауырып жүргендер саны 240 млн-ға жуық адам деп санаады.Қазақстанда 15 жыл ішінде қант диабетімен ауыратын науқастардың саны 3,5 есеге өсті.2021 жылдың басында диспансерлік есепте 382 мың адам болды.Оның ішінде 30 мыңы 1 типті қант диабетімен ауырады . Қант диабетімен ауыратындардың неізгі 40-59 жас аралаықтағы адамдар. Бұл аталған мәліметтерге сүйенсек , қант диабеті өте жоғары қарқынмен келе жатырған ауру.

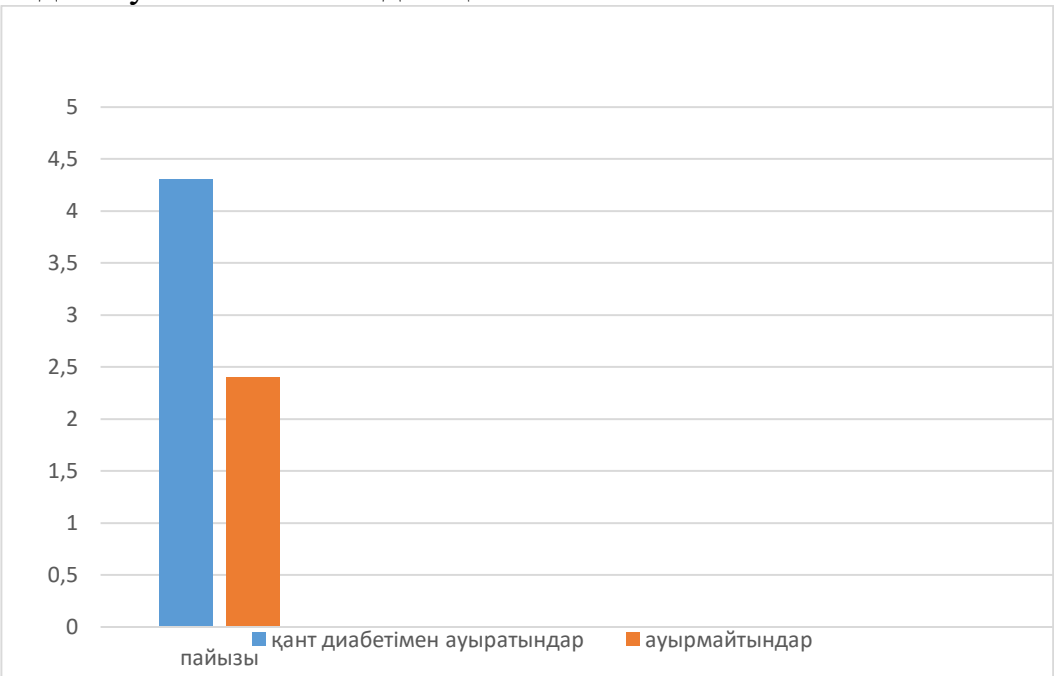
Мақсаты: қант диабетіне бейімділікті ерте анықтау.

Зерттеу материялдары : Біз қант диабетіне бейімділікті зерттеп , сауалнама өткізген болатынбыз . Яғни қант диабетінің симптомдарын сұрақ қою арқылы алдын ала болжадық.Сонымен қатар қант диабетіне анықталған немесе бейімділік болған жағдайда оны алдын алу шараларын да жүргізген болатынбыз. Сауалнаманы 40 шақты адам тапсырған болатын. Қант диабетті және диабеттің қауіп-қатер факторлары, диабеталды белгілері және респонденттердің қант диабеті жөнінде хабарлылығы мен оны алдын-алу шараларын анықтау үшін Бопай Ханым Жоғары медициналық колледжі-нің 1 курс студенттер арасында әлеуметтік сауалнама жүргізілді. Барлық респонденттер біз құрастырған сауалнаманы толтырды.Барлық қатысушылар сауалнама мәліметтерін жинауға және өңдеуге ерікті түрде негізделген келісімге қол қойды. Сауалнама google forma электрондық платформасын қолдану арқылы жүргізілді.Біздің сауалнамамыз орта есеппен шаққанда 140 адам санын құрап тұр. Қант диабетінің клиникалық маңызы қандағы глюкоза мөлшерінің артуынан қанның риологиялық қасиеттілігі өзгеруі және

ISBN 978-601-08-0758-7

тіндердің энергетикалық ашығуына байланысты. Маңызды котегортялық мәселе ауру ұзақтығына байланысты макро және микроангопатиялар . Мысалы ребинопатиялар бұл ауруларда 10 есе жоғары , ал нефропатиялар 12-15 есе жоғары.

Зерттеу мақсаттары мен тәсілдері: зерттелетін субьектілер 17-19 жас аралығындағы білім алушылар және жас мөлшері , кәсібі әртүрлі қала тұрғындары. Іріктелген контингент арасында сауалнама жүргізілді. Сауалнама « google forma »электрондық платформамен қолдану арқылы жүргізілді. Сауалнамаға 137 адам қатысты.



Диабетті анықтаудың маңызды тәсілі – бұл сұрастыру. Бұл кезде сырқаттың біртіндеп басталуы анықталады. Сұрастыру кезінде анықталған симптомдар көбінесе клиника лабораториялық мәліметтермен дәлелденеді. Диабетке ауруына щалдығу қауіпі бар адамдардан , оның ішінде : тұқым қуалауға бейімділігі бар , туылған кезде 4 кг-нан астам балалар , панкреатитпен жиі ауыратындар. Жүргізіліп жатқан сауалнамадан 137 адам өтті. Оның ішінен 35-і іріктеліп алынды , 7 – де қант диабетіне шалдығу мүмкіндігі жоғары. Біз бірнеше этаптан тұратын әдістер мен зерттеулер барысында анторпометриялық талдау сонымен қатар лобараториялық зерттеулер өткіздік. Лабораториялық зертеу кезінде қант диабетіне бейімділігі бар адамдардан қан сынама талдаулары алынды.

Әдебиеттер тізімі:

1. National Diabetes Data Group Classification and diagnosis of diabetes mellitus and other categories of glucose intolerance. Diabetes. 2009. 28. P. 1039-1057

2. Дедов И.И. «Сахарный диабет в Российской Федерации: проблемы и пути решения. Федеральный диабетологический центр МЗ РФ.

ISBN 978-601-08-0758-7

БРОНХ ДЕМІКПЕСІ БАР НАУҚАСТАРДЫҢ ӨМІР СҮРУ САПАСЫН ЖАҚСАРТУДАҒЫ МЕЙІРГЕРДІҢ РОЛІ

Қырғызбаева К 3 курс, «мейіргер ісі» мамандығы
ШЖҚ «Кеңес Одағының Батыры Мәншүк Мәметова атындағы Ақтөбе Жоғары медициналық колледжі» МКК
Ғылыми жетекші: Талипова Б.И., Муртазина Г.Р.,Абиева Д.Г. арнайы пән оқытушылары

Аннотация: Тақырыптың өзектілігі бронх демікпесінің қоғамға және әр науқасқа жоғары таралуы мен әлеуметтік-экономикалық әсері қауіп факторларының алдын алуды және уақтылы анықтауды, терапияның жеткіліктілігін, аурудың өршуінің алдын-алуды қажет етеді және бұл процесте мейірбикеге үлкен рөл жүктелген[1, 65б].

Статистикалық деректерге сәйкес, 2023 жылы Қазақстанда бронх демікпесінің 105 365 жағдайы тіркелген, оның ішінде алғаш рет 17 766. Диспансерлік есепте 79 668 адам тұрады, оның ішінде 17 жасқа дейінгі бронх демікпесі бар балалардың үлесі 23,5% құрайды[2].

Бүгінгі таңда бронх демікпесі-адамның тыныс алу жүйесінің ең көп таралған ауруы. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы демікпені созылмалы бронх ауруы ретінде анықтайды, ол мезгіл-мезгіл қайталанатын тұншығу және ысқырық тыныс алу шабуылдарымен сипатталады. Бүгінгі таңда бронх демікпесі-адамның тыныс алу жүйесінің ең көп таралған ауруы. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы демікпені созылмалы бронх ауруы ретінде анықтайды, қайталанатын тұншығу шабуылдарымен сипатталады[3, 134-135б]. Бронх демікпесі адамның өмір сүру сапасын төмендетіп қана қоймай, аурудың ауырлығына байланысты өмірге қауіп төндіретін асқынулар тудыруы мүмкін

Осыған байланысты ересек тұрғындардың бронх демікпесімен сырқаттанушылығын зерттеу өзекті болып отыр. Республикада халықтың денсаулығына зиянды түсті металлургия және тау-кен өнеркәсібі кәсіпорындарының шоғырлануы, аумақтың үрлену дәрежесі төмен, ауаның жоғары ылғалдылығы, әсіресе тау бөктеріндегі аумақтар, күндізгі температураның жиі өзгеруі жиынтығында автокөлік құралдарының едәуір саны экологиялық шиеленістің күшеюіне, тыныс алу органдары ауруларының, оның ішінде бронх демікпесінің өсуіне әкеледі [4]. Республиканың бронх демікпесімен сырқаттануы бойынша қолайсыз аудандарын анықтау экологиялық жағдайды ескере отырып, сараланған емдеу және алдын алу іс-шараларын жоспарлауға мүмкіндік береді[4].

ISBN 978-601-08-0758-7

Демікпені емдеудегі барлық жетістіктерге қарамастан, ауру мен өлім өсуде. Мейіргер де, пациенттер де жеткіліксіз емдеуде және ауруды дұрыс басқармауда маңызды рөл атқарады. Бұл демікпені емдеуде алаңдаушылық тудырады. Егер пациентке ауру және оны емдеу туралы негізгі білім болмаса, қолда бар құралдарды тиімді пайдалану мүмкіндігі жоқ. Алайда медбикелер демікпенің алдын-алу немесе азайту жолында мүгедектік пен өлім-жітімді азайту үшін демікпенің алдын-алу және басқару стратегияларына назар аудара отырып, маңызды рөл атқарады. Осылайша, мейірбикелердің демікпелі пациенттерге күтім жасаудағы негізгі білімі мен тәжірибесін қамтамасыз ету және жетілдіру және науқастардың нәтижелерін жақсарту үшін мейірбикелік араласу бағдарламасына деген қажеттілік өте жоғары.

Мақсаты:Бронх демікпесі бар науқастардың өмір сүру сапасын жақсартудағы мейіргердің рөлін анықтау.

Міндеттері:

1. Бронх демікпесі бар науқастардың өмір сүру сапасын жақсартудағы мейіргердің міндеттерін теориялық тұрғыда зерттеу.
2. Ақтөбе қаласындағы ШЖҚ «№ 7 Қалалық емханасы» МКК негізінде (оқытуға дейін және одан кейін) мейіргердің бронх демікпесі бар пациенттердің білімдері мен дағдыларының деңгейін арттыру, өмір сапасының жақсартуындағы рөлін анықтау.
3. Бронх демікпесі бар науқастар үшін өткізілген сабақтар нәтижелерінің тиімділігін бағалап,ұсыныс бер

Нәтижелер: әзірленген тақырыптар бойынша бронх демікпесі бар науқастар үшін мейіргерлер сабақтар өткізді.

Сабақ 1. Бронхиалды астма дегеніміз не?

Сабақ 2. Бронхиалды астма кезінде тұншығу ұстамасы. Алғашқы жәрдем.

Сабақ 3. Пикфлоуметрді қолдану.

Сабақ 4. Гипоаллергенді диетаны сақтау.

Сабақ 5. Гипоаллергенді өмірге қалыптасу.

№1 сабақ Сабақтың тақырыбы: «Бронхиалды астма дегеніміз не?».

Шолу әңгімесі: бронх демікпесі туралы түсінік, этиологиясы, аурудың даму қауіп факторлары (науқастармен әңгіме жүргізілді).

№2 сабақ Сабақтың тақырыбы: «Бронхиалды астма кезінде тұншығу ұстамасы. Алғашқы жәрдем».

Әңгімелесуге шолу: бронх демікпесі, демікпе ұстамасының клиникалық көрінісі және алғашқы медициналық көмек (науқастармен әңгіме жүргізілді, науқастарға демікпе ұстамасы және алғашқы көмек туралы нұсқаулар жадынамалар берілді).

№3 сабақ Сабақтың тақырыбы: «Пикфлоуметрді қолдану».

ISBN 978-601-08-0758-7

Шолу әңгімесі: пикфлоуметрді пайдалану ережелері, «Бақылау күнделігі» науқастармен әңгіме жүргізілді, науқастарға жадынама берілді).

№4 сабақ Сабақтың тақырыбы: «Гипоаллергенді диетаны сақтау».

Науқастар гипоаллергенді диеталық нұсқаулықпен қамтамасыз етіледі

Шолу әңгімесі: науқастарға дәрі-дәрмектерді жүйелі түрде қабылдауды ұсыныңыз, емделуде айтарлықтай нәтижелерге жету үшін дәрілерді уақтылы, ұтымды және мұқият қабылдау керек екеніне назар аударыңыз, олардың комбинацияларын дұрыс пайдалану, жүйелі түрде бағалау. терапияның тиімділігі, жанама әсерлер туралы дәрігерге хабарлаңыз. Науқасқа ингаляцияға арналған заманауи құрылғыларды - аралықтарды (спрей камераларын) сатып алуға кеңес берілді, олар өлшенетін аэрозольдарды қолдануды жеңілдетеді, дәрілік заттардың сіңуін және сәйкесінше олардың жанама әсерлерін азайтады және оларды таңдауға көмектеседі.

№5 сабақ Сабақтың тақырыбы: «Гипоаллергенді өмірге қалыптасу».

Шолу әңгімесі: пациентке гипоаллергенді өмірді қалай дұрыс ұйымдастыру керектігі ұсынылды.(аллергенді қоршаған ортадан аулақ болу жайында презентациялар,бейнежазбалар көрсетілді.)

Қорытындылар: қорытындылай келе, науқастардың бронх демікпесі кезінде өзін-өзі бақылау әдістері туралы білімдері мен дағдыларының деңгейі: респонденттердің 70% (21) өзін-өзі бақылау күнделігін жүргізбейді, 43% (12) пикфлоуметр құрылғысын қолданбайды, 37% (11) гипоаллергенді диетаны ұстанбайды, ал 20% (6) гипоаллергенді өмірді ұстанбайды.

Оқытудан кейін науқастардың бронх демікпесі ағымында өзін-өзі бақылау әдістері туралы білімдері мен алғашқы көмек және алдын алу дағдыларының деңгейі артты және пациенттердің пикфлоуметр, гипоаллергенді диета, гипоаллергенді өмір туралы хабардар болу деңгейінің жоғарылағанын көреміз, респонденттердің 70%-ы өзін-өзі бақылау күнделігін жүргізетін болды, барлық респонденттер медбикеден өзін-өзі бақылау туралы қажетті ақпаратты алғысы келеді.

Медбике бронх демікпесі бар науқастарды түсінікті терминологияны пайдалана отырып, науқасқа ауру туралы өзекті және қолжетімді ақпаратты беруге міндетті;дәрігер тағайындаған емді бақылау, рецепттерді орындамауды тудыратын факторларды анықтау және жою қажет;Қайталанған сауалнама бронх демікпесі бар науқастарға арналған мамандандырылған медбикелердің сабақтарының жоғары тиімділігін көрсетті.

Әдебиеттер тізімі:

1. http://www.informio.ru/ Власкина Н.П., преподаватель Хабаровский государственный медицинский колледж «роль медсестры в формировании приверженности лечению». [1, 65б].

2. http://poznayka.org/ - сайт знаний.

3. «Коммуникационный процесс врач - пациент в современном здравоохранении» М.Ю. Сурмач, Е.М. Тищенко УО «Гродненский

ISBN 978-601-08-0758-7

государственный медицинский университет» Практикующему врачу Журнал ГрГМУ 2007 [2].

4. https://revolution.allbest.ru/ Взаимоотношения «врач - медицинская сестра – пациент»

5. http://www.aids-86.info/index Этапы адаптации к заболеванию [3, 134-135б].

ISBN 978-601-08-0758-7

МЕЙІРГЕРЛІК БІЛІМ ЖӘНЕ МЕЙІРГЕРЛІК ЗЕРТТЕУЛЕР

Милиярова Б.З.,3 курс, "Мейіргер ісі" мамандығы
"Қызылорда жоғары медицина kолледжі" ҚМЖК
Ғылыми жетекшісі Орынбасар Б.К.,
«Анатомия,физиология және патология» пәнінің оқытушысы

Аннотация. *В данной статье рассматривается методология системного исследовательского процесса в области сестринского образования. Управление и развитие работающего в сфере здравоохранения сестринского медработника в настоящее время актуально. Сестринское дело, обладает достаточным kадровым ресурсом. Он также имеет полную возможность компенсировать потребность населения в доступной медицинской помощи. Они проходят специальную praktiky, сестринское образование и сестринские исследования требуют практической квалификации.*

Кілт сөздер: *мейіргерлік білім беру, іс-әрекеттерді зерттеу, денсаулық сақтау саласындағы теңсіздік, көшбасшылық.*

Медициналық қызмет kөрсетуде біріншілікті қызмет атқаратын ауқымды топ – мейіргерлер. Сондықтан мейіргер қызметін дамыту – аса маңызды. Ауырсынбайтын, дәрігерге қаралмайтын адам жоқ. Мейіргерлер – денсаулық сақтау жүйесінің негізі күші. Мейіргелік зерттеулер медициналық көмек пен науқастардың нәтижелерін жақсарту, науқастарға күтім жасау және дәлелді білім беру үшін қажет. Сонымен қатар, мейіргерлік көшбасшылардың жаңа буыны клиникалық күтімнің өзгеруін дәлелдейтін нұсқаулықтар ұсынады деп күтілуде. Сондықтан мейіргерлер тәжірибеде, ғылыми білімді дамыту және пайдалануы өте маңызды.

Кей елдерде іс-әрекеттерді зерттеу туралы жарияланымдар мейіргер ісінің жоғары оқу орындарында қол жетімді болғанымен, іс-әрекеттерді зерттеуді қолдануға байланысты пәндерде жиі кездеседі. Денсаулық сақтау саласындағы теңсіздік, көшбасшылықты дамыту мен ұйымдастыру және жалпы мейіргерлік тәжірибиеде мәселелерін шешуде іс-әрекеттерді зерттеуді қолдану айқын. Іс-әрекеттерді зерттеу білім берудің барлық деңгейлерінде кеңінен қолданылады.

Көптеген пәндер бойынша іс-әрекеттерді зерттеудің дамып келе жатқан қолданылуына және медбикелердің жоғары білім беру нәтижелерін зерттеу қажеттілігіне байланысты мейіргерлік білім берудегі іс-әрекеттерді зерттеуді сипаттау үшін зерттеу әдебиеттеріне шолу жасалды.

Зерттеудің методологиясы.

Зерттеудің бірінші бөлімі 1994-2024 жылдар аралығындағы жоғары мейіргерлік білім беру саласындағы іс-әрекеттерді зерттеу бойынша әдебиеттерді іздеуді қамтыды. Іздеу cinahl және medline дерекқорларында

ISBN 978-601-08-0758-7

жүргізілді. Анықталған критерийлерді негізге ала отырып, 80 жарияланым қаралды.

Осы зерттеудің екінші бөлімінде осы шолудағы мақалаларды бағалауға көмектесетін бірнеше пәндердің іс-әрекеттерін зерттеу әдістемесі негізінде әдебиеттерге шолу жасалды.

Әдебиетке шолу мейіргер ісіндегі іс-әрекетті зерттеу процесі - бұл зерттеудің бірінші бөлімі іс-әрекеттерді зерттеумен байланысты жоғары мейіргерлік білім саласындағы әдебиеттерді іздеуді қамтыды. Іздеу cinahl және medline дерекқорларында "action research" және and education іздеу жолдарын, соның ішінде 1994-2024 жылдар аралығындағы барлық мақалаларды негізге ала отырып жүргізілді. Бастапқыда олар диссертациялар, конференция тезистері немесе мейіргер тәжірибиесіне қатысты мақалаларды есепке алмағанда, әр тақырыптар мен рефераттарға шолу жүргіздік. Сондай-ақ, орта білім беру оқу орнынан кейінгі үздіксіз білім беру мен мейіргерлік білімге тікелей қатысы жоқ тармақтар, сонымен қатар, жүйелі зерттеу процестерінің сипаттамалары ұсынылмаған деректер алынып сараланды.

Бастапқы шолуды аяқтай отырып, іс-әрекеттерді зерттеудің дәлелді анықтамасының болмауы шолуға қандай мақалаларды енгізу керектігін анықтадық. Мақалаларды бастапқы шолу негізінде іс-әрекеттерді зерттеудің жұмыс анықтамасы жасалды. Содан кейін қалған 80 дәйексөз егжей-тегжейлі қарастырылды.

Іс-әрекеттерді зерттеу анықтамасын құру – зерттеу барысында іс-әрекеттерді зерттеу тәсілдеріндегі көптеген өзгерістер мейіргерлік білім туралы әдебиеттерді шолуда айқын анықталды. Мейіргер ісі туралы мақалаларға шолу бастапқыда жоғары мейіргерлік білім беру саласындағы іс-әрекеттерді зерттеуді қамтитын барлық зерттеу мақалалары қарастырылды. Дегенмен, жоғарыда айтылғандай, жоғары білім туралы мақалаларды қарау кезінде "іс-әрекеттерді зерттеудің" көптеген нұсқалары табылды. Сондықтан шолуға мақалаларды қосу критерийлерін әзірлеу үшін іс-әрекеттерді зерттеудің анықтамалары мен негізгі тұжырымдамаларына шолу жасадық. Келесі параграфтарда әртүрлі пәндерден іс-әрекеттерді зерттеудің анықтамалары да, негізгі ұғымдары да бар. Іс-әрекетті зерттеу әдістері Фрейре, Левин және Шен сияқты көптеген кең философиялық және теориялық дәстүрлерге негізделген. Іс-әрекетті зерттеуді пәндерде қолданудың әртүрлі дәстүрлері мен тәсілдері іс-әрекетті зерттеудің алуан түрлілігін қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, пәндер шеңберіндегі іс-әрекеттерді зерттеу анықтамалары көбінесе әртүрлі компоненттерді баса алады. Зерттеу есебінде осы дәстүрлерді және анықтамаларды талқылау зерттеуді қалыптастыру үшін маңызды ақпарат беріп, ұсынылады. Мысалы, ұйымдық даму әдебиеттерінде іс-әрекетті зерттеу - бұл "зерттеушінің проблемамен ұзақ мерзімді байланысы арқылы зерттеу және оқыту процесін"

ISBN 978-601-08-0758-7

қамтитын зерттеуге, жоспарлауға, теориялауға, оқытуға және дамытуға бағытталған іс-шаралар спектрін сипаттайтын термин.

Білім берудегі іс-әрекеттерді зерттеуге тағы бір маңызды сілтеме осы терминнің іс-әрекеттері мен зерттеулерін қамтитындығын түсіндіреді, сондықтан зерттеу компоненті үшін деректерді жинаудың жүйелі процестері болуы керек. Зерттеудегі "әрекет" қолданылатын процесті бағалауды немесе уақыттың өзгеруін көрсетуді қамтуы мүмкін, екеуі де деректерді жинаудың нақты процестерін қажет етеді. Білім беру зерттеулерінде жиі қолданылатын іс-әрекеттерді зерттеу оқыту мен оқуды біріктірудің тәсілі ретінде алға жылжуда. Кеммис іс-әрекеттерді зерттеу арқылы білімнің де, нәтиженің де маңыздылығын алға тартады.

Зерттеу барысында журналда жарияланған іс-әрекетті зерттеу жөніндегі әдебиеттерге жүйелі шолуда зерттеу процестерінің кейбір анықтамалары бар болғанымен, олар мейіргерлік білім беру саласындағы зерттеулер мен жарияланымдарға жеткілікті бағыт бермейді.

Іс-әрекетті зерттеу әдістемесі - бұл зерттеуші тұжырымдай алатын жүйелі зерттеу процесі, оның ішінде деректерді жинау және талдау, сондай-ақ, уақыт өте келе жағдайды өзгерту мақсатында негізгі зерттеушілермен немесе басқалармен ойлау және талқылауға мүмкіндік береді.

Бұл анықтама зерттеуді әзірлеуге және жариялауға көмектесетін зерттеуші тұжырымдай алатын жүйелі зерттеу процесін қажет етеді. Зерттеуші тұжырымдай алатын компонентті қосу өте маңызды, өйткені іс-әрекетті зерттеу процестің үлкен өзгергіштігін қамтуы мүмкін, бірақ зерттеудің қалай жүргізілгенін сипаттау қажеттілігі мейіргерлік білім беру саласындағы зерттеулерді дамыту және тарату үшін маңызды. Деректерді жинау мен талдауды тарту мейіргер ісінде қажетті зерттеу нәтижелерін анықтау үшін қажет.

Клиникалық зерттеулерді қолдану – зерттеу жұмыстарын жүргізуде және мақалалар үшін клиникалық тәжірибе - оның мақсаты, дизайны, зерттеуге байланысты маңызды. Клиникалық жағдайда білім алушылар мен мейіргерлер арасындағы байланысты жақсарту бойынша жүргізілетін жұмыстар:

– мейіргер білім алушылардың терапевтік байланысын жақсарту үшін жаңа оқыту стратегиясын әзірлеу;

– теория мен практика арасындағы алшақтықты жақсарту үшін жаңа клиникалық рөлді дамыту;

– модельдеу негізінде оқыту кезінде кәсіби ынтымақтастықты дамыту;

– білім алушыларды бағалаудың жаңа стратегияларын қолдану.

Білім алушыларды бағалаудың кейбір стратегиялары портфолио тәсілін қамтыды және білім алушыларды бағалауға науқастарды араластыру. Шолу әдебиетіндегі іс-әрекеттерді зерттеу барысында қарастырылған

ISBN 978-601-08-0758-7

жағдайлар мен проблемалардың әртүрлілігі іс-әрекеттерді зерттеу мейіргерлік білімнің клиникалық аспектілерінде мейіргер ісінің нәтижелері туралы білімді арттыру үшін қалай қолданылғанын көрсетеді.

Мейіргерлік білім беру саласындағы қоғамдық денсаулық сақтауды практикалық зерттеудің мысалы дәстүрлі зерттеу тәсілдерін қолдана отырып, өте маңызды, бірақ қиын саланы сипаттайды. Оқытушылар бірлескен шешім қабылдауды және білім алушылардың тәжірибесімен байланысты әртүрлі контексттерді қоса алғанда, қоғамдастық пен білім алушылардың оқу материалдарын әзірлеуге бірлескен көзқарасты қолдаймыз. Мейіргерлер кооперативті зерттеудің пайдаланылатын зерттеу дәстүрін сипаттайды және оқытушылар мен білім алушылар арасындағы ынтымақтастық процесін тұжырымдайды. Жобаның нәтижелері білім алушыларға клиникалық шешім қабылдауға көмектеседі. Осы зерттеу жұмысының нәтижелері іс-әрекеттерді ынталандырады, сонымен қатар курс модульдеріне мысалдар келтіреді. Ісәрекеттерді зерттеу әдіснамасында зерттеу процесі де, зерттеу өнімі де білім береді және жобаның "тиімділігіне" ықпал етеді. Бұл зерттеу процесі зерттеушілерге зерттеу дәстүрін таңдау, нәтижелерді анықтау жолдарын меңгертті.

Қорытындылай келе, зерттеу жұмысында мейіргер ісінің жоғары білім беру әдебиетіндегі іс-әрекеттерді зерттеуге шолу жасадық. Практикалық мақалалардың алдыңғы шолуы осы саладағы іс-әрекеттерді зерттеу анықтамаларын нақты және тиімді анықтаманы ұсынды. Бұл анықтама іс-әрекеттерді зерттеу анықтамаларына шолу жасауға да, мейіргерлік білім беру саласындағы іс-әрекеттерді зерттеу мақалаларына шолу жасауға негізделген. Содан кейін анықтаманың көптеген компоненттері жоғары білім берудегі іс-әрекеттерді зерттеу әдебиеттерінің көлемін сыни бағалау үшін қолданылды.

Іс-әрекеттерді зерттеу анықтамасына негізделген нақты және қайталанатын мысалдар мейіргерлік оқытушылар жүргізетін оқыту жобалары мен сыни бағалау түріндегі зерттеу әлеуетін көрсету үшін қажет. Көптеген мақалаларда мейіргерлік білімнің нәтижелері дәлелденгенімен, қолданыстағы әдебиеттерді жалпылау іс-әрекеттерді зерттеуді жоғары мейіргерлік білімге қолданудың сансыз және әр түрлі тәсілдеріне байланысты одан да қиын болды. Жоғары мейіргерлік білім беру нәтижелері туралы терең білімді дамытуға көмектесу үшін келесі ұсыныстар жасадық:

– зерттеуді дамыту критерийлерін қолдану үшін осы шолуда келтірілген нақты және тиімді анықтаманы қолданыңыз;

– мейіргерлік білім беруде қолдану үшін іс-әрекеттерді зерттеудің тиімді және тиімді түйіндемесін жасау және жетілдіру.

Жоғары мейіргерлік білімді жақсарту үшін жаңа білім беру әдісі қажет, ал практикалық зерттеулерді қолдану бұл оңтайландыруға көмектеседі. Ісәрекеттерді зерттеу арқылы зерттеуге ақпарат, басқалармен ынтымақтастық және уақыт өзгерістері сияқты айнымалылар кіруі мүмкін.

ISBN 978-601-08-0758-7

Мейіргерлік білім беруді жетілдіру болашақ клиницистер үшін ғылыми деректерді пайдалануға мүмкіндік беретін клиникалық практикаға, пәнаралық оқыту процесі мен нәтижелеріне, мейіргер ісі мамандары үшін оқытудың үздік практикаларына білімді тиімді беруді одан әрі дамытуды қамтуы тиіс.

Әдебиеттер тізімі:

1. Американдық Мейіргер ісі колледждерінің қауымдастығы, "2014-2016 қаржы жылына арналған Стратегиялық жоспардың мақсаттары мен міндеттері", 2016, http://www.aacn.nche.edu/about-aacn/strategic-plan.

2. J. M. Phillips, J. Resnick, M. S. Boni et al., “Voices of innovation: building a model for curriculum transformation", International Journal of Nursing Education Scholarship, vol. 10, no. 1, pp. 1-7, 2016.

3. S. Kotcherlakota and H. Keeler," Мейіргер ісі мұғалімдері арасындағы академиялық жұмыстың ынтымақтастығы мен байланысын жеңілдету үшін оқу қоймасын құру", Nurse Educator, vol. 39, no. 3, pp. 113-117, 2017.

4. М. Селкриг пен К. Кими, "тануға дайын болуға көмектесу: жақын адамдардан коллегиялық әңгімелерге көшу, педагог-педагогтар үшін терең және сыни рефлексияны ынталандыру", мұғалімдер мен оқыту: Теория және практика, 21-том, № 4, 421-436, 2016 беттер.

5. C. P. Pavlish and M. D. Pharris, Community-Based Collaborative Action Research: A Nursing Approach, Jones & Bartlett Learning, 2017.

6. Гернси де Сапиен, п. м. Герман және С. С. Карвахал, "қоғамдық медицина қызметкерлері фокус-топтардың фасилитаторы ретінде: алғашқы медициналық-санитарлық көмек жағдайында ауылшаруашылық қызметкерлеріне мінез-құлық медициналық қызметтерін жақсарту.

ISBN 978-601-08-0758-7

МЕЙІРБИКЕЛІК БІЛІМ ЖӘНЕ МЕЙІРБИКЕЛІК ЗЕРТТЕУЛЕР

Ниязбекова А.Ж, 4 курс, "Мейіргер ісі" мамандығы
"Семей" медициналық колледж мекемесі
Ғылыми жетекшісі Аукенов Ғ.А., дәрігер-интерн, арнайы пәндер оқытушысы

Аннотация: *Бұл тақырып қарастырады* Қазақстандағы мейірбикелік білім беру жүйесі денсаулық сақтау саласының сапасын жақсартуға бағытталған маңызды факторлардың бірі болып табылады. Дамыған мейірбикелік білім беру бағдарламалары мейірбикелердің кәсіби біліктілігін арттыруға, науқастарға сапалы қызмет көрсетуге және ғылыми зерттеулерді жүргізуге мүмкіндік береді. Соңғы жылдары Қазақстанның мейірбикелік білім беру жүйесі халықаралық стандарттарға сай даму үстінде.

Мейірбикелік білім берудің құрылымы

Мектеп, колледж және университеттер

Қазақстанда мейірбикелік білім беру жүйесі үш деңгейде жүзеге асырылады:

Орта медициналық білім: Орта медициналық білім алатын студенттер мейірбикелік тәжірибені, науқастармен қарым-қатынасты және алғашқы медициналық көмек көрсету дағдыларын меңгереді. Мектептер мен колледждерде оқу бағдарламаларына медициналық этика, санитария және инфекциялардың алдын алу жөніндегі курстар енгізілген.

Бакалавриат: Бакалавриат бағдарламасында мейірбикелер медициналық пәндер, соның ішінде анатомия, физиология, фармакология, және клиникалық практиканы оқиды. Бұл білім мейірбикелердің науқастарды диагностикалау, емдеу және күтім жасау қабілетін арттырады. Соңғы жылдары бакалавриат бағдарламалары халықаралық аккредитациядан өтуде, бұл білімнің сапасын қамтамасыз етеді.

Магистратура мен докторантура: Мейірбикелік білім берудің бұл деңгейі мейірбикелерді ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу, клиникалық тәжірибені жетілдіру, және білім беру процесінде жетекшілік ету үшін даярлауға бағытталған. Мысалы, магистратура бағдарламаларында мейірбикелік басқару, эпидемиология, және денсаулық сақтау саясатына қатысты курстар оқытылады.

Жаңалықтар мен реформалар

2022 жылы Қазақстанның денсаулық сақтау жүйесінде мейірбикелік білім беру үшін жаңа реформалар қолға алынды. Министрлік мейірбикелік білім беру бағдарламаларын жаңартып, оларды әлемдік стандарттарға сәйкестендіру мақсатында ынтымақтастық орнатты. Мысалы, Қазақстанның мейірбикелер ассоциациясы ұлттық білім беру стандарттарын жетілдіру бойынша жұмыстар жүргізуде.

Инновациялар мен жаңа технологиялар

ISBN 978-601-08-0758-7

Симуляциялық оқыту

Симуляциялық оқыту мейірбикелердің практикалық дағдыларын дамытуда маңызды рөл атқарады. Симуляциялық орталықтарда студенттер шынайы клиникалық сценарийлерді тәжірибе жүзінде меңгереді. Бұл студенттерге науқастарды бағалау, емдеу әдістерін қолдану, және жедел медициналық көмек көрсету дағдыларын меңгеруге мүмкіндік береді.

Цифрландыру және қашықтан білім беру

Пандемия жағдайында Қазақстанда білім беру жүйесінің цифрлануы мейірбикелердің білім алуын жеңілдетті. Онлайн курстар мен вебинарлар мейірбикелердің кәсіби дамуына үлкен мүмкіндік берді. Мысалы, Денсаулық сақтау министрлігі мен Білім және ғылым министрлігі бірлесіп, мейірбикелерге арналған арнайы онлайн платформаларды құрып, оқу материалдарын цифрландыруды жүзеге асырды.

Мейірбикелік зерттеулер

Ғылыми зерттеулердің маңызы

Мейірбикелердің ғылыми зерттеулер жүргізу қабілеті денсаулық сақтау жүйесінің тиімділігін арттыруға, науқастарға сапалы қызмет көрсетуге, және медициналық практикадағы проблемаларды шешуге мүмкіндік береді. Қазақстандағы университеттерде мейірбикелердің зерттеу жүргізу дағдыларын дамытуға арналған арнайы курстар енгізілген.

Зерттеу нәтижелері

2023 жылы Алматы қаласындағы Қазақ ұлттық медициналық университеті “Педиатрияда мейірбикелердің рөлі” тақырыбында зерттеу жүргізді. Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, мейірбикелердің балалармен жұмыс істегенде психологиялық қолдау көрсетуі, балалардың реабилитация процесінде айтарлықтай маңызды рөл атқарады. Бұл зерттеу нәтижелері мейірбикелердің клиникалық тәжірибесінде психологиялық аспекті ескерудің қажеттілігін көрсетті.

Мейірбикелік білімнің болашағы

Дамыту стратегиялары

Қазақстандағы мейірбикелік білім беру жүйесі халықаралық стандарттарға сәйкестендіріліп, мейірбикелердің біліктілігін арттыруға бағытталған жаңа стратегиялар қабылдануда. Оқу бағдарламаларына жаңа медициналық технологияларды, пациенттермен қарым-қатынасты және көшбасшылық дағдыларын дамытуға арналған курстар енгізілуде.

ISBN 978-601-08-0758-7

«Медбике ісін дамытудың негізгі бағыттары» схемасы



Мейірбикелердің рөлі

Мейірбикелердің рөлі денсаулық сақтау жүйесінде тек емдеу ғана емес, сонымен қатар пациенттердің білімін арттыру мен денсаулық сақтау саласындағы өзгерістерді басқару болып табылады. Мысалы, мейірбикелер науқастарға аурудың алдын алу, денсаулық сақтау туралы білім беру, және өмір сүру сапасын жақсарту бойынша ақпарат беруде.

Этикалық мәселелер

Этика мен құқықтар

Мейірбикелік зерттеулерде этика мәселелері мейірбикелердің жұмысының сапасына әсер етеді. Мейірбикелер науқастардың құқықтарын, жеке мәліметтерін қорғау, және зерттеулердің этикалық стандарттарға сәйкестігі бойынша білімдерін жетілдіруі керек. International Council of Nurses (ICN) ұйымы мейірбикелердің этикалық стандарттарын жаңартып, халықаралық деңгейде этикалық мәселелер бойынша ұсынымдар беруде. Этикалық нормаларды сақтау, науқастардың құқықтарын қорғау, және зерттеулерде этикалық комитеттердің рөлі маңызды.

Әлеуметтік аспектілер

Мейірбикелік білім мен әлеуметтік денсаулық

Мейірбикелердің әлеуметтік аспектілері мен науқастармен қарым-қатынасы науқастардың көңіл-күйіне, психологиялық жай-күйіне және аурудың барысына әсер етеді. Мейірбикелер әлеуметтік қызметтермен, психологиялық қолдау көрсету, және науқастармен қарым-қатынас жасаудағы дағдыларын жетілдіру арқылы ауруларды басқаруда маңызды рөл атқарады.

Жаңашылдықтар

Мейірбикелік білім беруде жаңашылдықтар мен интердисциплинарлық көзқарас енгізу арқылы мейірбикелердің қоғамдағы рөлі артады. Мысалы, мейірбикелер психикалық денсаулық мәселелері, қоғамдық денсаулық сақтау, және әлеуметтік теңдік мәселелері бойынша жұмыс істей алады.

ISBN 978-601-08-0758-7

Қорытындылар

Қазақстанда мейірбикелік білім мен зерттеулердің даму қарқыны жоғары. Жаңа білім беру стандарттары, инновациялық технологиялар мен зерттеу нәтижелері мейірбикелердің кәсіби біліктілігін арттыруға, денсаулық сақтау жүйесінің тиімділігін жақсартуға, және науқастардың күтім сапасын жоғарылатуға мүмкіндік береді. Мейірбикелік білім беру мен зерттеулердің дамуында Қазақстан халықаралық деңгейде бәсекеге қабілеттілікке қол жеткізіп, денсаулық сақтау саласындағы көшбасшылардың бірі бола алады.

Біз болашақ мамандарға жан-жақты сапалы білім беру, кәсіби шеберлікті қалыптастыру үшін жаңа инновациялық технологияларды меңгеру мен оқытудың тиімді түрлерін ұтымды пайдалануымыз қажет. Мейірбике тұлғасы, оның жұмыс әдістері, сырқаттармен қарым-қатынас жасай білу емдеу тиімділігінін компоненттері болып қызмет атқарады, науқастарға көмек көрсету медбике клиникаларының жұмыстарына және созылмалы аурулары бар науқастарға үйдегі медициналық көмекті көрсетудегі күтімді ұйымдастыру, дені сау топтармен алдын алу жұмыстарына басым рөл бөледі. Қандай кезде болмасын мейірбике этика деонтологиялық ережелерді қолдана отырып манипуляцияларды орындайды. Сондықтан мейірбикелер науқаспен жиі қарым-қатынаста болғанда жаңашырлық мейірімділік қасиеттерімен науқасты ең жақын адамы болып саналады.

Әдебиеттер тізімі

1. Нұрпейісова, Г. Н., & Жұмабаева, Г. К. (2018). Мейірбикелік білім: теория және практика. – Алматы: Қазақ университеті.[2,17-бет].

2. Қожабекова, Г. Т., & Тәжібекова, А. А. (2020). Мейірбикелік қызметтің негіздері. – Нұр-Сұлтан: Дәуір. [3,13-бет].

3. Сейілхан, А. Т. (2019). Мейірбикелік зерттеулер: ғылыми негіздер мен тәжірибе. – Алматы: Рауан. .[4,12-бет].

4. Сарсенбаева, А. К. (2021). Мейірбикелік білім беру жүйесіндегі инновациялар. – Шымкент: Мәдениет. .[6,57-бет].

5. Жұматаева, А. С., & Әбдірайымов, Б. Н. (2022). Клиникалық мейірбикелік практика: оқулық. – Алматы: Қазақстан. .[6,45-бет].

6. Рахымжанова, Г. М. (2020). Халықаралық стандарттар және мейірбикелік білім беру. – Алматы: Ақиқат. .[8,14-бет].

7. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі. (2020). Мейірбикелік қызметтің даму стратегиясы. .[9,14-бет].

8. Аманжолова, С. К. (2017). Салауатты өмір салтын қалыптастырудағы мейірбикенің рөлі. – Алматы: Рауан. .[10,37-бет].

9. Мамытбекова, А. Ж. (2019). Клиникалық зерттеулер және мейірбикелік практика. – Нұр-Сұлтан: Ғылым. .[11,47-бет].

10. Мейірбикелер мен мейіргерлердің халықаралық ұйымы (ICN). (2021). Мейірбикелік этика кодексі. [12,27-бет].

ISBN 978-601-08-0758-7

МЕЙІРГЕРЛЕР АРАСЫНДАҒЫ КҮЙЗЕЛІС ДЕҢГЕЙІН АНЫҚТАУ АСПЕКТІСІ

Нурлибаева Аяулым Ерланқызы «Мейіргер ісі» мамандығы, 2 курс студенті

ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ ДСБ ШЖҚ «ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНА КОЛЛЕДЖІ» МКК

Ғылыми жетекшісі Мамыр Мадина Құрбанәліқызы, магистр, оқытушы

Аннотация. *Бұл мақалада медицина қызметкерлеріне күйзелістің әсер етуі жөнінде және бұл жағдай физикалық және психикалық денсаулыққа айтарлықтай әсер ететіндігі сипатталады. Сонымен қатар, күйзелістің негізгі сипаттамаларының бірі, оның тұрақсыздығы. Қолайлы жағдайларда бұл жағдай оңтайлы күйге, қолайсыз жағдайларда жүйке – эмоционалды шиеленіске айналуы мүмкін, бұл жүйелер мен органдардың жұмыс қабілеттілігі мен тиімділігінің төмендеуімен, энергия ресурстарының сарқылуымен сипатталады. Өзектілігі: Мейіргер ісі күйзеліс пен кәсіптік күйіп кету синдромының даму қаупі жоғары дәрежедегі медициналық мамандық тобына кіреді. Бұл жерде «Хирургия» және «Нейрохирургия» бөлімшелерінің медициналық қызметкерлері еңбек қызметі барысында жоғары психоэмоциялық қысымды бастан кешіреді. Мейіргерлер арасында эмоциялық күйіп кету синдромының пайда болу қаупі дәрігерлермен салыстырғанда орта есеппен 5-9 есеге жоғары. Күйіп кету синдромының қауіптілігі оның қарқындылығының күннен күнге артуымен байланысты. Бұл процесті тоқтату өте күрделі болады. Сол себепті «Хирургия» және «Нейрохирургия» бөлімшелері медбикелерінің күйзелістің пайда болуы мен қалыптасу ерекшеліктерін білу олардың жұмысын оңтайландыру үшін қажет. Алайда, мәселенің өзектілігіне және оны шешу қажеттігіне қарамастан, қазіргі уақытта денсаулық сақтау мекемелерінде диагностика жүргізу, персоналдың кәсіби күйзелісі мен күюін азайту және алдын алу жұмыстары іс жүзінде баяу дамуда.*

Мақсаты: қалалық клиникалық ауруханасында жұмыс істейтін мейіргерлер арасындағы күйзелістің пайда болу себептерін анықтау.

Психикалық факторлардың соматикалық аурулармен өзара байланысының өзектілігі соңғы он жылда өсуде. Кейбір зерттеулер бойынша, адам ағзасының тұрақты түрде күйзеліске ұшырауы органикалық және функционалдық бұзылыстардың дамуында бастапқы рөл атқарады. Күйзелістің оң және теріс жақтары бар, сондықтан күйзелісті екі жақты қарастырамыз, бір жағынан, бұл адамға өмірдің жаңа жағдайларына бейімделуге көмектесетін өмірлік бейімделу реакциясы, екінші жағынан, қайғы-қасіреттің, аурудың және тәжірибенің туындау себебіне бейімделуге көмектеседі. Осы жағдайды есепке ала отырып, күйзелістің мейіргерлерге тигізетін әсерін анықтадық.

ISBN 978-601-08-0758-7

Зерттеу мақсаттары мен әдістері: Зерттеу Шымкент қаласындағы № 2 қалалық клиникалық ауруханасының «Нейрохирургия» және «Хирургия» бөлімшелерінде жұмыс істейтін мейіргерлер арасында жүргізілді.

Зерттеуге «Нейрохирургия» бөлімшесінен 10 мейіргер, «Хирургия» бөлімшесінен 10 мейіргер алынды. Мейіргерлердегі күйзелісті анықтау үшін Маслач сауалнамасының қазақша нұсқасы қолданылды.

Жүргізілген сауалнама екі бөлімнен тұрды:

1. Жалпы бөлім: респонденттердің жасы, жұмыс өтілі, білім деңгейі, отбасылық жағдайы.

2. Негізгі бөлім: респонденттерге Маслоч сауалнамасын жүргізу.

Сұрақтар	**«Ешқашан»**	**«Сирек»**	**«Өте сирек»**	**«Кейде»**	**«Жиі»**	**«Күнде»**	**Саны**
Науқастармен қарым-қатынаста сезімге берілемін	6 (30%)	7 (35%)	3 (15%)	1 (5%)	1 (5%)	2 (10%)	20 (100%)
Бәрінен кетіп демалғым келеді	3 (15%)	3 (15%)	6 (30%)	4 (20%)	2 (10%)	2 (10%)	20 (100%)
Мен пациенттеріме барынша қолдау көрсетуге тырысамын	-	1 (5%)	-	6 (30%)	7 (35%)	6(30%)	20 (100%)
Қорытынды	15%	18%	15%	18%	17%	17%	100%

Сұрақтар	**«Өте төмен»**	**«Төмен»**	**«Орташа»**	**«Жоғары»**	**«Өте жоғары»**	**Саны**
Эмоционалды сарқылу	2 (10%)	4 (20%)	8 (40%)	4 (20%)	2 (10%)	20 (100%)
Жеке жетістіктеріні	1 (5%)	7 (35%)	8 (40%)	4 (20%)	-	20

ISBN 978-601-08-0758-7

ң редукциясы						(100%)
Деперсонализация	2 (10%)	5 (25%)	8 (40%)	3 (15%)	2 (10%)	20 (100%)
Қорытынды	8,5%	27%	40%	18%	10%	100%

Зерттеу нәтижелері. Зерттеудің жалпы бөлімі бойынша: респондент-тердің – 5 (25%) 25 пен 30 жаста, 30 бен 40 жас аралығындағы мейіргерлер саны 7 (35%) құрады. Сонымен қатар, 8 (40%) респондент 40 – 55 жас аралығында екендігі анықталды. Мейіргерлердің жұмыс өтілі бойынша 7 (35%) мейіргер 15 жылға дейін, 6 (30%) мейіргер 25 жылға дейін, 4 (20%) мейіргер 30 жылға дейін, 3 (15%) мейіргер 40 жылға дейін жұмыс істегені анықталды. Мейіргерлер арасында жоғары білімді мейіргерлер саны 13-ны (65%), орта білімді мейіргерлер саны 7-ті (35%) құрады. Отбасылық жағдайы бойынша 8 (65%) мейіргердің отбасылы, 4 (10%) отбасын құрмағандығы, 5 (19%) ажырасқандығы, 3 (6%) жолдасы қайтыс болғандығы анықталды.

Сауалнаманың негізгі бөлімі бойынша: Мейіргердің кәсіби жұмысы жоғары эмоционалды, психикалық және физикалық белсенділікпен сипатталады.

Қорытынды. Мейіргердің қызметінде кәсіби күйзелістің дамуына ықпал ететін көптеген себептер бар: кәсіби қызметтен артық жүктеме, материалдық жағдайға қанағаттану, пациенттермен, дәрігерлер- мен, медициналық топтың әріптестерімен/мүшелерімен өзара әрекеттесу ерекшеліктері, жұмыс тобындағы қайшылықты қатынастар, кәсіби өсу мен мансап мәселелері, жеке өмірдің күрделі жағдайлары т.б. Зерттеу нәтижесін қорытындылай келе №2 қалалық клиникалық ауруханасында жұмыс істейтін мейіргерлер арасындағы күйзелістің бар екендігі анықталды. Күйзеліс анықталған мейіргерлермен әрі қарай жұмыс жүргізілді. Күйзеліске әсер ететін негізгі себептерден жинақталған кесте құрылды. Кесте мейіргерлерге қағаз нұсқасы түрінде таратылып берілді және мейіргерлер күйзелістің туындауына түрткі болған бірнеше себептерді таңдап көрсетті.

Зерттеуге қатысқан 20 мейіргерлер арасында 9 мейіргерде күйзелістің бар екендігі анықталды. Зерттеу жұмысына қатысқан мейіргерлер арасында күйзелістің пайда болуына әкелетін себептердің ішінде 4 (44%) мейіргер «Жұмыстың ауырлығы», 2 (23%) мейіргер «Жалақының төмен болуы», 1 (11%) мейіргер «Физикалық жүктемелер», 1 (11%) мейіргер «Психологиялық жүктемелер», 1 (11%) мейіргер «Ұжым арасындағы қақтығыстар» деген негізгі факторларды белгілеп көрсетті. Осы себептер ең негізгі басты себептер ретінде қарастырылды.

Шымкент қаласындағы №2 қалалық клиникалық ауруханасының «Нейрохирургия» және «№1 Хирургия» бөлімшелерінде жұмыс істейтін

ISBN 978-601-08-0758-7

мейіргерлер арасында зерттеу бойынша «Хирургия» бөлімшесіндегі мейіргер- лер жиі күйзеліске ұшырайтындығы анықталды.

Ұсыныстар:

- Мейіргерлердің күйзеліске түсуінің алдын алу шараларын жүргізу, психологиялық сабақтар өткізу. Жалпы медициналық қызметкерлерге айына бір рет психологиялық тренингтер өткізу.
- Мейіргерлер арасындағы күйзелістің пайда болуына әсер ететін факторлардыңалдын алу.
- Медицина қызметкерлері үшін бөлімшеде «Relax Room» бөлмесін ашу.

Әдебиеттер тізімі:

1. Т.М. Максимова 2011, А. А. Калининская бірге. 2011 ж., М. Я. Баке, И. Ю. Лусе, д. р. Спроджа және т. б. 2012 ж.
2. Заманаева Ю.В., Фрумкин А.А. Психологическая помощь медицинскому персоналу: постановка проблем и возможные пути решения СПб. -2015.
3. Александровский Ю. А. Состояния психической дезадаптации и их компенсация. М., 2012 ж.

ISBN 978-601-08-0758-7

ЖЕТІЛІП ЖӘНЕ ШАЛА ТУҒАН НӘРЕСТЕЛЕРДІҢ АНАТОМИЯЛЫҚ – ФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Өмірзақова Диана Өмірғалиқызы 2 курс «Мейіргер ісі» мамандығы
ШЖҚ «Кеңес Одағының Батыры Мәншүк Мәметова атындағы Ақтөбе Жоғары медициналық колледжі» МКК
Ғылыми жетекшісі: Елемесова Гүлзира Үмбетжанқызы арнаулы пән оқытушысы

Аннотация: *Бұл мақаладажетіліп және шала туған нәрестелердің анатомиялық. физиологиялық ерекшеліктері қарастырылған. Жетіліп және жетілмей туған нәрестелердің айырмашылығы, физиологиялық жағдайлары, диагностикалық белгілері, нәрестенің жетілуінің педиатриядағы маңызы түсіндіріледі. Шала туған нәрестелерге арнайы мейіргерлік көмек. Апгар шкаласы бойынша жаңа туған нәрестенің жағдайын 5 белгі бойынша бағалау.*

Жетілген нәресте – бұл жатырдағы 38-40 аптада барлық мүшелері тиімді қалыптасқан нәресте, сондықтан босану кезінде ағза мен жүйелер ақауланбауына мүмкіндік береді.

Жетіліп туылған баланың орташа салмағы 3400-3500 гр ер балада, 3200-3400 гр қызбалада, теменгі шегі 2500гр болу керек

· Дене ұзындыгы 48-52 см, орташа есеппен 50 см

· Кеуде аймағы 34-36см

· Бас аймағы 32-34см

· Кіндігі семсер тәрізді өсінді мен қасағаның ортасында орналасқан

· Жана туылған баланын бас суйегі бет сүйегі мен ми сүйегіне қарағандакіші

· Басының шаштары жақсы дамыған

· Терісі қызғылт, тері асты шел майы жақсы дамыған

· Бұлшық еттері әлсіз дамыған

· Дауысы катты шығады

· Шарттсыз бейнелістері айкын білінеді

· Ербалаларда аталык бездері ұмасы түскен,қыз балаларда кіші жыныс ернеулері үлкен жыныс ернеулерімен жабылып тұрады

* Жетіліп туған нәрестенің тері асты май кабаттары жақсы дамыған,

* Түк шаштары (лануго) арқаның жоғарғы бөлігін, иыкты, мандайды жабады.

* Жетіліп туған нәрестенің тырнақтары тырнақ шетін толық жауып, фаланганыңшетіне дейін жетеді.

* Табандары көптеген сызыктармен керінеді. Кіндік сакинасы семсер тәрізді өсіндімен қасаға аралығы ортасында орналасқан.

ISBN 978-601-08-0758-7

· Үлкен(алдынғы) енбек-екі төбе және маңдай сүйектерінің жіктерінің қиылысындаорналаскан.Ромб тәрізді формалы, мөлшері 2-3,0 см, 12-18 айында жабылады.

· Кіші (артқы) енбек-екі төбе және шүйде сүйектерінің жіктерінін қиылысындаорналаскан. Ол үшбұрышты формалы,20-25 % нәрестелерде ашық болады,өмірінің2-3-ші айларында жабылады.

* Мойындары қысқа.Құлақ қалқандары катты.

* Нәрестенің омыртка жотасында физиологиялык иілімдер жок.

* Аяктары салыстырмалы түрде қысқа.

* Кеуде клеткасы конус тәрізді. Қабырғалары -келденеңінен орналасқан.

· Кеуде шеңбері-32-34 см.

· Жетіліп туған нәрестенін бұлшыкеттері әлсіз дамыған, бұлшыкеттік физиологиялықгипертония тән. Дені сау нәрестеге флексорлы калып тән: аяк-колдары жартылайбүгілген,саусақтары жұдырыққа жұмылған. Басын өз бетімен устай алмайды.

Қозғалыстары келісілмеген, хаотикалык.

Жаңа туылған нәрестелердің жағдайы АПГАР шкаласы бойынша бағаланады. 5 белгі бойынша бағалау:

*Жүрек соғысының жиілігі

*Тыныс алуы

*Бұлшык еттерінің тонусы

*Мұрын катетірімен тітіркендіргенде жауап беруі

*Терісінің түсі

Әр белгі 0-1-2 балл арасында бағаланады. Бағасы 5 белгінің қосындысынан шығады.

· Жана туылған нәрестенің организімнің негізгі функциялары тұраксыз күйде болады. Баланың өмірдің жаңа жағдайына бейімделуі -өткінші куй деп аталады.

· Оларға:

* Физиологиялық эритема

* Салмақтын физиологиялық кемуі

* Транзиторлы қыздырма

* Бүйректін зәр қышқыл инфаркті

* Физиологиялык сарғаю

* Жыныс кризі

* Альбуминурия

* Физиологиялык диспепсия

Шала туылған балалар деп - 37 аптаға толмаймерзімінен бұрын және салмағы 2500г аз, ал бойы 45смтөмен туылған балаларды айтады.

ISBN 978-601-08-0758-7

Дене салмағына байланысты шала туылуды4 кезеңге бөледі:

· I -2001-2500 г;

· II - 2000-1500 г;

· III - 1500-1000 г;

· IV - 1000 г және одан да төмен

Сыртқы бітім ерекшеліктері:

- Дене бітімі үйлесімсіз, мойыны мен аяқтары қысқа, басы үлкен.
- Уақытында туған балаларға қарағанда басы домаланған
- Сүйегіжұмсақ, жіктері мен кіші еңбегі ашық. Құлақ қалқаны жұмсақ,басына жабысқан.
- Терісі жұқа, әжімденген, қоңыр қызыл түсті, қалың ұлпамен қапталған
- Маңдайы, аркасы, иығы, жамбасытүкпен (лануго) жабылған.
- Тері асты май кабаты нашар дамығаннемесе мүлдем жок.
- Тырнақтары саусақұшын жаппайды жәнежұмсақ.
- Ұл балаларда ата безі ұмаға түспеген, қыз балаларда жыныс саңылаулары жабылмаған.
- Бастың ми бөлігі бет бөлігінен үлкендеу

Шала туылған баланың өлшемдері кіші болады, дене бітімі пропорциональды емес: басы мен денесі үлкен, мойны мен аяқтары қысқа, кіндік сақинасы төмен орналасады.

Қалыпты жағдайда шала туған нәрестелерде дені сау жана туылған нәрестелердеанықталатын рефлекстердің болмауы:

Сору рефлексі. Егер баланың аузынаемізікті салса, ол белсенді түрде емеді. 1жастың аяғына дейін жоғалады.

Бабкин рефлексі (алақан- ауыз).Баланың алақанын тенорға жақын үлкенсаусақпен басқанда, жауап ретіндеауызын ашып, басын бұрады. 3 айға қарай жоғалады.

Ұстау рефлексі. Бала алақанын ұстағанда саусақтарын жұмады. Кейдебаланы сол күйінде көтеруге болады. (Робинсон рефлексі). Бұндай рефлекстіаяққа да жасауға болады, табаннын негізін басса, башпайдын табандықбүгілуін шақырады. 2-4 ай сонына карай жоғалады.

Моро рефлексі. Қатты дыбысқа жауап ретінде алдымен қолын екі жаққажайып, саусактарын жазады. Содан кейін колын бастапқы қалпынакелтіреді. 4 айға дейін сакталады.

Тірек рефлексі. Дәрігер баланы арка жағынан қолтык астынан ұстайды да басынсұқ саусақпен сүйемелдейді. Осындай тұрған қалыпта бала аяғын жамбас-сан, тізебуынында бүгеді де, табанымен толық тұрады, еденде денесін тік ұстайды,2 айға қарай жоғалады.

Бабинский рефлексі. Егертабанның сыртқы шетін штрихтітіркендірсе, үлкен башпайдыңжазылуымен басқа башпайдыңбүгілуі болады. Екі жасқа дейінсақталады.

ISBN 978-601-08-0758-7

Бауэр еңбектеу рефлексі. Егербаланы ішке жатқызса, ол бір сәтбасын көтеріп, енбектейді. Егернәрестені табанына қолмен тіреуқойса бұл әрекеті белсене түседі,қолмен қимылдап, аяғын кедергіденалады. 4 айға қарай жоғалады.

Туылғаннан кейін нәрестенің денесі құрғатылып,неонатолог дәрігермен толықтексеріледі. Әдетте 32-37 апта аралығында туылғаннәрестелердің өміршендікдәрежесі жоғарылау болады.Ал 26 аптаға дейін туылғаннәрестелердің өміршеңділікденгейі темен болады. Оларәртүрлі физикалық жәнеақыл-естің дамудефектілеріне бейім келеді.Мұндай балалардың тынысалу, ас қорыту және терморегуляция жүйесі әлсізжәне толық дамымауынанерекше күтімді қажет етеді.

Медицинаның қарқынды түрде алға көш бастауына байланысты әлемнің алдыңғы қатардағы клиникаларында дене салмағы 750г 15-25%, дене салмағы 1000г нәрестелердің өмір сүру керсеткіші 50-70% жоғарылады.

Осы көрсеткіштен ДДҰ дене салмағы 500г нәрестелерге өмір сүруіне барлық жағдайлар мен көмектерді, реанимациялық көмек пен тіркеуге алуды 1974 ж колға алған. Осындай дене салмағы жүктіліктің 22 аптасына тән.

Дене салмағы өте төмен нәрестелердің өмір сүру керсеткіші тікелей медицина қызметкерлерінің көрсеткен көмегіне,реанимация шаралары мен медицина қызметкерлерінің қарым-қатынасына, дәрілерге, құрал-жабдықтарға тікелей байланысты.

Әдебиеттер тізімі:

1.Н.Н.Володин "Неонатология.Нацинальное руководство",2008 г.

2. Н.П.ШАБАЛОВ "НЕОНАТОЛОГИЯ” В 2 томах Том I,Москва «МЕДпресс-информ» 2004г.

3. www,wikipediya.ru

4. Жакиева Ш.С. “Балалар аурулары пәнінен дәрістер жинағы”2010 ж

5.Дадамбаев Е.Т. Неонатология. (каз) Алматы. 1999.

6. Шабалов Н.П. Неонатология. С-П.; 2000.

7. Хабижанов Б.Х. Хамзин С.Х. Педиатрия. Алматы, Білім, 2005.

8. Хабижанов Б.Х. Балалар аурулары. Алматы: Ана тілі, 1997

9. А.В. Мазурин, А.С. Воронцов. Пропедевтика детских болезней. М.: Медицина 1986 ж.

ISBN 978-601-08-0758-7

КӨШБАСШЫЛЫҚ МЕЙІРГЕРЛІК БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕ ЖӘНЕ МЕЙІРГЕРЛІК ТӘЖІРИБИЕДЕ

Раимкулова Н.И., 2 курс, «Мейіргер ісі» мамандығы
ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ ДСБ ШЖҚ «ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНА КОЛЛЕДЖІ» МКК
Ғылыми жетекшісі Бижанова А.Д., магистр, оқытушы

Аннотация: *Бұл мақалада бас мейірбикенің көшбасшылық қасиеттерінің және психологиялық қасиеттердің мазмұны, мейірбике қызметкерлерімен өзара әрекеттесу дағдыларының жиынтығы ретінде айқындалады.*

Өзектілігі: Бұл зерттеудің өзектілігі көшбасшының басқа адамдарды шабыттандыратын, олардың көңіл-күйіне әсер ететін және өз мақсаттарына жету үшін әрекет етуге ынталандыратын әдістер мен тактикаға ие болуы керек. Көшбасшының жаңа түрі көптеген қасиеттерді біріктіре білуді және әртүрлі жағдайларда көшбасшылық стильдерді қабылдай білуді талап етеді [1, 11-13 б.].

Бүгінгі күнгі уақыт, нарық мейіргерлерге мамандандырылған кәсіби коммуникацияны және жоғары біліктілікті талап етеді. Нарықтық қаныстардың үздіксіз дамуы осы мейіргер мамандарының науқатармен ғана емес, сонымен қатар басшыларымен де тиімді қарым-қатынас жасауды қажет етеді. Мейіргер ісі менеджментіндегі көшбасшылық кез келген басшының, берілген жағдайда – бас мейіргердің кәсіптік қызметінде зор мәнге ие. Мақала мейіргер қызметін басқарудың жаңа әдістерін, көшбасшылық ұғымын, мейіргер ісіндегі көшбасшыға қажет қасиеттер мен ерекшеліктерін қарастырып айқын- дайды. Мейіргерлердің де өзін-өзі кәсіби тұрғыдан тану санасын оятып, біз денсаулық сақтаудың ұлттық жүйесінің қайта құрылуының және халықаралық мейіргерлер қоғамының тең құқылы мүшесі болатынына сену [2, 2-3 б.].

Медициналық мекемеде жақсы басшы тек мейірбикелік персоналды басқару және ғылымын жақсы меңгерген, жоғары сапалы басқару шешімдерін қабылдай алатын және оны қол астындағыларға анық жеткізе алатын адам ғана емес, сонымен қатар бұл өзін-өзі басқаруға қабілетті адам [3, 22-25 б.].

Сондықтан бүкіл әлемде мейіргер ісі мамандары қазіргі кезде дайындықты тек базалық техникалық және кәсіби білім беру деңгейінде ғана емес, сондай-ақ мейіргер ісі бойынша бакалавриат, магистратура және докторантура шегінде де даярлықтан өтеді.

Мақсаты: Мейірбикелік білім беруде және тәжірибиеде көшбасшылық стильдерін зерттеу. Мейіргерлердің де өзін-өзі кәсіби тұрғыдан тануын талдау.

Басқару стильдері басшының дербестігі көптеген ісіне қарай емес, қалай істейтіндігіне де орай сипатталады.

ISBN 978-601-08-0758-7

Авторитарлық (диктаторлық) қол астындағылардың қатысуынсыз шешім

қабылдау және қол астындағы адамдар проблемаларды тұтасымен байланыстырмай жеке тапсырмалар алады. Бұл стиль арқылы қатаң тәртіп орнатуға болады. Еңбек шартын бұзған қызметкерді қатаң жаза күтеді. Қателігі үшін бастық оған сөгіс жариялайды не айыптайды. Бұл жерде ешқандай қызметкердің пікірі маңызды емес.

Авторитаризмнің кемшілігі - басқарушылар мен орындаушылардың қарсыластығы, қол астындағылардың жоғарыдан түскен шешімдерге деген ішкі қарсылығы. Бұл стильдің кемшілік тұсы – егер бастықтың қабылдаған шешімі қызметкерлеріне ұнамай қалса, бірнеше жақсы маманынан айырылып қалу қаупі туады, яғни бір мезгілде бірнеше адам өз еркімен жұмыстан шығып кетуі мүмкін.

Демократиялық қол астындағы адамдар шешім қабылдауға қатысады, оның нұсқаларын дайындайды және ұжымдық шешім қабылдауы бар. Демократия ұйымның қиын жағдайдан да оңай шығып, тез алға басуына мүмкіндік туғызады.

Демократиялық стильдің кемшіліктері: - жауапкершіліктің таралуы және бақылау астындағы шешімдер мен орындаушылардың анықсыздығы, қажетті, бірақ өзекті емес шешімдерден аулақ болу. Бастық әр қызметкерінің тілін табуы үшін, оларды зерттеуге ұзақ уақытын жұмсайды.

«laissez-faire» (еркін, либералды, пассивті, анархиялық) - мақсатты басқару жоқ басшы тек өзінің өкілдігін білдіреді және басшының қол астындағылардың орындайтын міндеттерді бақылауы минималды. Бұл басқару түрі ұжымға толықтай еркіндік береді [4, 31-36 б.].

Бұл басшылық стильдердің әрқайсысы мінез-құлық құрылымымен, өзара әрекеттесу динамикасымен және әртүрлі әлеуметтік-эмоционалды орталармен байланысты. Басшылардың үш түрінің артықшылықтары мен кемшіліктері бар, және олардың бірде-біреуі барлық жағынан бәрінен де жоғары деп айтуға болмайды.

Зерттеудің материалдары мен әдістері. Зерттеу барысында менторлар арасында мониторинг және бағалау, сауалнама жұмыстары жүргізілді. **Шымкент қаласының ДСБ ШЖҚ «№2 қалалық аурухана» МКК 21 мейіргері қатысты.**

Бас мейірбике қызметінің негізгі бағыттары мыналар болып табылады:

- персонал;
- санитарлық-эпидемиологиялық жағдайды қамтамасыз ету және бақылау;
- мейірбикелік күтімді ұйымдастыру және бақылау;
- дәрілік заттарды тұтынуды бақылау;
- медициналық денсаулық сақтау мекемелерінде және үйде ақылы мейірбикелік қызмет көрсету бойынша іс-шараларды ұйымдастыру.

ISBN 978-601-08-0758-7

Көшбасшының орындайтын функциялары. Егер көшбасшы төменде көрсетілген үш функцияны орындап жүрсе, онда оны көшбасшы деп толығымен атауға болады:

- Бағыттаушы;
- Ұйымдастырушы;
- Ынталандырушы.

Респонденттердің 85,7%-ы өз басшысы қызметінде демократиялық көшбасшылық стилін пайдаланады деп есептейді.

Респонденттердің 9,5%-ы өз басшысы қызметінде авторитарлық көшбасшылық стилін пайдаланады деп есептейді.

Респонденттердің 4,7%-ы өз басшысы қызметінде либералды көшбасшылық стилін пайдаланады деп есептейді.

Бас медбикенің көшбасшылық қасиеттерінің болуын бағалау мынаны көрсетті		
11 мейірбике	7 мейірбике	3 мейірбике
білімнің жоғары деңгейі, яғни арнайы білім мен тәжірибиелік дағдылар жүйесі сияқты қасиеттерге басымдылық берді	мәселелерді тиімді шешуде, басты нәрсені тез таңдап, соған шоғырлану қабілетін атап өтті.	қарым-қатынас дағдыларын, адамдарды өзіне тартып алу қасиеттін, өз көзқарасының дұрыстығына сендіру және көшбасшылық қабілетін атап өтті

Зерттеулердің нәтижелері. Менеджменттің маңызды құрамдас бөлігі ретінде көшбасшылық феномені зерттелді; бас мейірбикенің басқару процесіндегі жетекшілігінің мәні талданады; басшының тәжірибеде қолданатын әртүрлі басқару стильдері зерттеліп, салыстырылды, сонымен қатар персоналды басқаруда бас мейіргердің көшбасшылық қасиеттерін жетілдіру жолдары қарастырылды. Біздің ғылыми-тәжірибелік зерттеулеріміз көрсеткендей, мейірбикелік қызмет меңгерушісінің жұмысындағы көшбасшылық стилі әркім үшін жеке болып табылады.

Зерттеу көрсеткендей, респонденттердің көпшілігі, яғни 18 адам өз бас мейіргерін көшбасшы деп санайды. Қалған 3 адам бұл сұраққа жауап беруге қиналады немесе жауап беруден бас тартты.

Біздің зерттеуімізден мейірбикелердің көпшілігі 80,9%-ы, егер олар бірдеңені білмесе, оны көрсетуден және басқа қызметкерлерден көмек сұраудан қорықпайды. Ал мейіргерлердің 19,1%-ы барлық мәселелерді өздері шешуге, тіпті өздеріне аз таныс мәселелерді шешуге тырысатынын айтты.

ISBN 978-601-08-0758-7

Қорытынды. Бұл жұмысымызда мейіргердің қоғамдағы рөлін соның ішінде мейіргерлік білім алудағы мен мейіргердің іс –әрекетіндегі дәрігермен, мейіргермен қарым-қатынасын көрсеткім келді. Медицина мамандарының пікірінше, басшы: мейірімді, әділ, ұқыпты, талапшыл және еңбекқор болуы керек – бұл мейірбикелік көшбасшы рөліндегі ең маңызды қасиеттер. Қорытындылай келе айтарым, зерттеу барысында алынған деректер қазіргі уақытта екі көшбасшылық стиль – демократиялық және авторитарлық көшбасшылық стилі кеңінен қолданылып жүргенін көрсетті.

Әдебиеттер тізімі

1. К.Ш.Сыздыкова, Ж.С.Тулебаев, Н.С.Мусина, А.А.Маукенова, А.Р.Рыскулова, Н.Н.Авгамбаева «Мейірбике ісіндегі менеджмент»: оқу құралы. – Қарағанды: «АҚНҰР» баспасы, -2017.- 40, 111 беттер.

2. ҚР 2020 жылға дейін мейірбике ісінің дамуының кешенді жоспарының жүзеге асуының және 2016-2019 жылдарға ҚР мейірбике білімінің жүйесінің модернизациясының жол картасы.

3. А.К.Тургамбаева «Мейіргер ісін басқарудың негіздері»: оқулық. – Астана, 2017. – 51 бет.

4. Ахтаева Н.С. «Басқару психологиясы». Электронды оқулық. // "Алла Прима" 2016г. 230стр. Қазақстан.

ISBN 978-601-08-0758-7

МИОКАРД ИНФАРКТІСІ БАР НАУҚАСТАРДЫҢ ӨМІР САПАСЫН ЖАҚСАРТУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Рахманберді Р.Ж., 3 курс, Мейіргер ісі мамандығы
Шымкент жоғары медицина колледжі
Ғылыми жетекшілері: Эдилова Р.М., оқытушы магистр, Ешова Г.А., магистр

Аннотация: *Миокард инфарктісі-жүректің ишемиялық ауруының клиникалық түрлерінің бірі, ол миокард аймағының ишемиялық некрозымен бірге жүреді [1]. Ең жиі себебі тұрақсыз атеросклеротикалық түйін зақымданған кезде пайда болатын тромбоз болып табылады [2, 3]. Миокард инфарктісі 40 жастан 60 жасқа дейінгі науқастарда дамиды және көбінесе ер адамдар ауырады, сонымен қатар бүкіл әлемде мүгедектіктің негізгі себебі болып табылады. Миокард инфарктісін бастан өткергеннен кейінгі өлім-жітім бірінші жыл ішінде 8-ден 10% - ға дейін құрайды, көп жағдайда ол ауруханадан шыққаннан кейін 3-4 ай ішінде пайда болады.*

Кардиореабилитация пациенттердің әлеуметтік бейімделуіне оң әсер етеді, ал ең жақсы нұсқа – мамандандырылған ауруханада толық қалпына келтіру курсын қолдану [4]. Санаторлық - курорттық жағдайларда кардиореабилитацияның сәтті болуының көптеген фактілері белгілі [5].

Көптеген авторлар емдеудің санаторлық кезеңіндегі қалпына келтіру шараларының тиімділігінің кепілі физикалық белсенділіктің арнайы әдістерін қолдануды қарастырады (жүзу, тредмил жаттығулары немесе веложарыс) [6].

Дәстүрлі әдістерді қолдана отырып, кардиореабилитацияның тиімділігі туралы мәселе сирек кездеседі, бұл негізінен дәрігер жасаған және тікелей мейірбикелік күтіммен жүзеге асырылатын бағдарламаны мұқият сақтауды талап етеді.

Зерттеудің мақсаты. Миокард инфарктісін басынан өткерген науқастардың өмір сапасын бағалау.

Зерттеу материалдары мен әдістері. Зерттеуге ауру тарихында миокард инфарктісі бар 20 науқас қатысты. Зерттеуге қатысушы науқастарға мамандандырылған мейіргерлік тренинг сабағы ұйымдастырылды. Қайта тексеру тренингтен кейін 3 айдан кейін жүргізілді.

Амбулаториялық терапиядағы айырмашылықтарға сүйене отырып пациенттердің 2 тобы құрылды. 1-ші топқа шұғыл кардиология бөлімшесінен шыққаннан кейін бөлімшеде ұйымдастырылған тренинг курсынан өткен 10 науқас кірді. Айта кету керек, кардиореабилитацияның жеке бағдарламасын жасағаннан кейін медбикелер процедураларды жүргізді. 2-ші топқа бірқатар себептерге байланысты кардиореабилитация курсынан өтпеген 10 пациент

ISBN 978-601-08-0758-7

кірді. Бақылау тобына жыныстық және жас ерекшеліктері бойынша науқастар тобымен салыстырылатын 10 адам кірді.

"SF-36 Health Status Survey"сауалнамасы арқылы пациенттердің ерікті сауалнамасы арқылы өмір сапасы зерттелді. Физикалық және психологиялық салауаттылық көрсеткіштері интегралды параметрлер ретінде пайдаланылды. Нәтижелерді өңдеу параметрлік статистика әдістерін қолдану арқылы жүзеге асырылды. Айырмашылықтардың сенімділігі студенттің критерийі бойынша бағаланды.

Нәтижелері. Өмір сапасын салыстырмалы талдау кезінде физикалық жағдайы 2-топтағы ұқсас көрсеткішпен салыстырғанда кардиореабилитациядан өткен пациенттер тобында едәуір жоғары деңгейін анықтауға мүмкіндік берді.

Психологиялық жағдайына келетін болсақ, 2 топта сенімді айырмашылықтары анықталған жоқ, бұл, біздің ойымызша, емдеудің стационарлық кезеңінде ауырған науқастарды барабар психологиялық оңалтуды көрсетеді. 1-ші топтағы науқастардың физикалық әл-ауқатының жоғары деңгейі олардың әлеуметтік бейімделуіне оң әсер етті. Мәселен, 1-ші топта тексеру кезінде науқастардың 40% – ы еңбекке жарамды, ал 2-ші топта-тек 20% - ы ғана болды (1 кесте).

1 кесте. Тренингтен өткен және өтпеген науқастардың өмір сапасы

Тренингке қатысқан науқастар		Тренингке қатыспаған науқастар	
Физикалық жағдайы	Психологиялық жағдайы	Физикалық жағдайы	Психологиялық жағдайы
50,36+6,05	50,41+4,94	39,66+7,24	46,68+7,16

Қорытынды. Жоғарыда келтірілген нәтижелер келесі тұжырымдарға негіз береді. Бақылау параметрлерімен салыстырғанда пациенттердің екі тобында психикалық денсаулық деңгейінің айырмашылығының болмауы жедел кардиология бөлімінде психологтың болуының негізділігін растайды. Емдеудің стационарлық кезеңінде қолданылған психологиялық оңалту бағдарламалары болашақта психикалық денсаулық деңгейіне оң әсер ететіні анық. Санаториялық кардиореабилитация курсынан өткен пациенттердің физикалық денсаулығының анағұрлым жоғары көрсеткіші осындай оңалтудан өтпеген науқастармен салыстырғанда оның қажеттілігі мен экономикалық тиімділігін дәлелдейді, өйткені 1-ші топта еңбекке қабілетті адамдардың көп пайызы байқалды. Айта кету керек, өмірдің физикалық компонентін жақсартуға кардиореабилитацияның дәстүрлі әдістерін қолдану аясында қол жеткізілді, оларды жүзеге асыруда мейірбике күтімінің рөлі зор.

ISBN 978-601-08-0758-7

Әдебиеттер тізімі

1. Миокард инфарктісі бар әйелдерді оңалту ерекшеліктері. Аникин В.В., Николаева Т.О. // Cardiocоматика. – 2015; 1: 7.

2. Миокард инфарктісінен кейінгі физикалық оңалту. В.К. Велитченко, И.В. Велитченко. // Физиотерапевт. – 2011; 4: 10–11.

3. Миокард инфарктісі бар науқастарды оңалтудың басқа клиникалық-психологиялық аспектілері. Волель Б.А., Терновая Е. С., Ермушева А. А. // Кардиология және жүрек-тамыр хирургиясы. – 2014; 2: 4–9.

4. Жүзуді қолдана отырып, миокард инфарктімен ауыратын науқастарды оңалтудың басқа емханалық кезеңі. Гильмутдинова Л.Т., Багаутдинов А. А., Бикбулатова Г.Т. // Бал. вестн. Башқұртстан. – 2013; 6: 128– 132.

5. Емханада миокард инфарктісі бар науқастардың қайталама алдын алу және оңалту. А.Д.Куимов, А.А. Шуркевич, И.В.Москаленко. // Атеросклероз. – 2014; 4: 19–25.

6. Мамандандырылған санаторий жағдайында миокард инфарктісі бар науқастарды емдеу (оңалту) нәтижелерін бағалау // биомедициналық жүйелердегі жүйелік талдау және басқару. – 2013; 4: 1114–1118.

ISBN 978-601-08-0758-7

МЕЙІРБИКЕЛІК БІЛІМ ЖӘНЕ МЕЙІРБИКЕЛІК ЗЕРТТЕУЛЕР

Самат Гүлбақыт, Серікқызы Диана «Мейіргер ісі бөлімі» студенттері 304-топ

ШЖҚ «КЕҢЕС ОДАҒЫНЫҢ БАТЫРЫ МӘНШҮК МӘМЕТОВА АТЫНДАҒЫ АҚТӨБЕ ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ» МКК

Ғылыми жетекшілер: Нұржанова Райса Ғазизовна Елюбаева Айкен Бисембаевна

Аннотация:*“Мейірбикелік білім және мейірбикелік зерттеулер” атты мақала мейірбикелік іс саласындағы білім беру мен ғылыми зерттеулерді қарастырады. Мұндай мақалалар мейірбикелердің кәсіби дамуын, білім беру үдерісін жетілдіру және медициналық көмек сапасын жақсартуға бағытталған зерттеулердің нәтижелерін талқылайды.*

Мақаланың негізгі тақырыптары:

1. **Мейірбикелік білім беру**: Бұл бөлімде мейірбикелерді даярлаудың заманауи әдістері, жаңа оқыту бағдарламалары және білім беру саласындағы реформалар талқыланады. Мейірбикелік білім берудің сапасын жақсарту медициналық қызмет көрсету сапасын арттыруға ықпал етеді.
2. **Мейірбикелік зерттеулер**: Мейірбикелік зерттеулердің мақсаты – медициналық тәжірибені жетілдіру, пациенттерге көмек көрсетудің жаңа әдістерін әзірлеу және медициналық қызмет сапасын жақсарту. Мақалада осы саладағы маңызды зерттеулер мен олардың нәтижелері туралы айтылады.
3. **Клиникалық тәжірибе**: Мейірбикелердің клиникалық тәжірибесін жетілдіру және зерттеулерді күнделікті тәжірибеге енгізу жолдары қарастырылады.

Мейірбикелік білім берудің мақсаты – пациенттерге сапалы, кәсіби көмек көрсете алатын, жоғары білікті мейірбикелерді даярлау.

Бұл мақсат бірнеше негізгі бағыттардан тұрады:

1. **Теориялық білім беру**: Мейірбикелерге медицина, физиология, патология және фармакология сияқты салаларда қажетті базалық білім беру. Бұл оларға ауруларды түсінуге және емдеу процесін қолдауға мүмкіндік береді.
2. **Клиникалық дағдыларды дамыту**: Мейірбикелер клиникалық ортада жұмыс істеу үшін қажетті практикалық дағдыларды үйренеді. Мұнда пациенттерге күтім көрсету, дәрі-дәрмектерді қолдану, науқастың жағдайын бағалау сияқты тәжірибелер кіреді.
3. **Этика және кәсібилік**: Мейірбикелік білім беру мейірбикелердің этикалық қағидаттарды сақтауын, гуманистік көзқарас пен кәсіби мінез-құлықты қалыптастыруды мақсат етеді.
4. **Зерттеушілік қабілеттер**: Мейірбикелерге ғылыми зерттеулер жүргізу, деректер жинау және талдау, сондай-ақ дәлелдерге

ISBN 978-601-08-0758-7

негізделген тәжірибені қолдану әдістері үйретіледі. Бұл медициналық қызмет сапасын үздіксіз жақсартуға ықпал етеді.

Қазіргі заманда мейірбикелік білімнің дамуы:

Қазіргі уақытта мейірбикелік білім қарқынды дамуда. Мейірбикелік іс денсаулық сақтау жүйесіндегі маңызды рөлге ие болғандықтан, білім беру бағдарламалары үнемі жаңартылып, заманауи талаптарға сай жетілдірілуде:

- **Цифрлық технологиялар**: Медициналық оқытуда ақпараттық технологиялар кеңінен қолданылуда. Мейірбикелерге арналған онлайн курстар, виртуалды тренажерлар, қашықтықтан оқыту бағдарламалары заманауи білім беру үрдісіне енгізілуде.
- **Жоғары білім деңгейі**: Бұрын мейірбикелік білім орта арнаулы деңгейде ғана берілсе, қазір көптеген елдерде мейірбикелер жоғары білім алуда. Оқытудың бакалавриат және магистратура деңгейлері енгізілді.
- **Ғылыми зерттеулер**: Мейірбикелік зерттеулер де дамып келеді. Бұл зерттеулер емдеу сапасын жақсарту, жаңа әдістерді енгізу және мейірбикелік тәжірибені ғылыми негіздеу үшін маңызды.
- **Халықаралық тәжірибие**: Мейірбикелердің кәсіби біліктілігін көтеруге арналған халықаралық бағдарламалар, тәжірибе алмасу жобалары да дамып келеді.

Мейіргерлік зерттеулердің мақсаты – мейіргерлік істі жақсарту, пациенттерге күтім көрсету сапасын арттыру және денсаулық сақтау саласындағы қызметтерді тиімді ету үшін дәлелді ақпарат пен ғылыми негізделген шешімдер әзірлеу.

Бұл зерттеулердің негізгі мақсаттары:

1. **Медициналық күтімді жетілдіру**: Мейіргерлік зерттеулер арқылы пациенттерге көрсетілетін көмектің тиімділігін, қауіпсіздігін және сапасын арттыру жолдары анықталады.
2. **Жаңа әдістерді енгізу**: Медициналық көмек көрсетуге жаңа технологиялар мен әдістерді енгізу үшін зерттеулер жүргізіледі. Бұл пациенттерге күтім жасаудың заманауи тәсілдерін табуға мүмкіндік береді.
3. **Пациенттердің қажеттіліктерін зерттеу**: Пациенттердің күтімге, психологиялық және әлеуметтік қолдауға деген қажеттіліктерін түсінуге бағытталған зерттеулер денсаулық сақтау қызметтерін жақсартуға көмектеседі.
4. **Дәлелді медицинаны дамыту**: Мейіргерлік зерттеулердің нәтижелері мейіргерлердің күнделікті тәжірибесінде дәлелді медицинаға негізделген шешімдер қабылдауына ықпал етеді.
5. **Кәсіби білім мен біліктілікті арттыру**: Мейіргерлердің кәсіби білімін жетілдіруге және олардың үздіксіз оқуын қамтамасыз етуге арналған зерттеулер мейіргерлік білім беру жүйесін жақсартады.

Мейіргерлік білім берудегі өзекті мәселелер:

1. **Қаржыландырудың жеткіліксіздігі**

ISBN 978-601-08-0758-7

Мейіргерлік білім беру мекемелері жиі қаржы тапшылығынан зардап шегеді. Қаржыландырудың жеткіліксіздігі оқу жабдықтары мен құралдарын жаңартуға, заманауи әдістемелерді енгізуге және тәжірибелік оқыту үшін қажетті ресурстарды қамтамасыз етуге кедергі келтіреді.

2. **Заманауи оқу бағдарламаларының жетіспеуі**

Кейбір оқу орындарында мейіргерлік білім беру бағдарламалары ескірген, медициналық тәжірибенің соңғы жетістіктерін қамтымайды. Бұл студенттердің заманауи медициналық технологияларды, дәлелді медицина қағидаттарын және клиникалық тәжірибені толық меңгеруіне кедергі жасайды.

3. **Тәжірибелік оқыту мүмкіндіктерінің шектеулігі**

Мейіргерлік білім беру процесінде клиникалық тәжірибе өте маңызды. Алайда кейбір оқу орындарында клиникалық тәжірибе орталықтары жеткіліксіз немесе толық жабдықталмаған. Тәжірибелік білімнің жеткіліксіз болуы студенттердің кәсіби дағдыларын толық меңгермеуіне әкеледі.

4. **Білікті педагогтардың жетіспеушілігі**

Мейіргерлік білім беру саласында жоғары білікті оқытушылардың тапшылығы да маңызды мәселе. Бұл мейіргерлік пәндерді толық меңгеруге, заманауи әдістерді оқытуға және студенттердің сұрақтарына толық жауап беру мүмкіндіктерін шектейді.

5. **Технологияның баяу енуі**

Цифрлық технологиялар мен симуляциялық оқыту құралдарының баяу енгізілуі мейіргерлерді заманауи медициналық жағдайларға дайындау үдерісін баяулатады. Қазіргі кезде симуляциялық оқыту (виртуалды науқастармен жұмыс) кеңінен қолданыла бастағанымен, барлық оқу орындарында бұл әдіс қолжетімді емес.

6. Оқу орындары арасындағы байланыс пен үйлестірудің әлсіздігі

Мейіргерлік білім беру жүйесінде әртүрлі оқу орындары мен медициналық мекемелер арасындағы байланыс пен ынтымақтастық жеткіліксіз болуы мүмкін. Бұл студенттердің клиникалық тәжірибе өтуіне, зерттеу жүргізуіне және заманауи білім алмасуына шектеу қояды.

7. **Тиісті қолдау мен мотивацияның болмауы**

Мейіргерлердің кәсіби дамуына арналған қолдау бағдарламаларының болмауы немесе жеткіліксіз болуы олардың білім деңгейін арттыруға деген ынтасын төмендетеді. Үздіксіз білім беру мен біліктілікті арттыру бағдарламаларының жетіспеуі де бұл саланы тежейді.

Шешу жолдары:

- Қаржыландыруды арттыру және халықаралық тәжірибе алмасу бағдарламаларын енгізу.
- Оқу бағдарламаларын заманауи талаптарға сәйкестендіру, жаңа технологияларды қолдану.
- Педагогикалық құрамды білікті мамандармен толықтыру және оқытушылардың кәсіби дамуын қолдау.

ISBN 978-601-08-0758-7

• Тәжірибелік оқытуды күшейту үшін симуляциялық орталықтар мен клиникалық базаларды дамыту.

• Цифрлық құралдарды және инновациялық технологияларды кеңінен қолдану.

Осы мәселелерді шешу мейіргерлерді кәсіби деңгейде дайындап, денсаулықты сақтауға мүмкіндік береді.

Қорытынды:

Мейіргерлік білім беру мен зерттеулер денсаулық сақтау жүйесінің маңызды бөлігін құрайды, өйткені олар мейіргерлердің кәсіби біліктілігін арттырып, пациенттерге сапалы күтім көрсетуге мүмкіндік береді. Алайда, осы салаларда бірқатар өзекті мәселелер бар, атап айтқанда қаржыландырудың жеткіліксіздігі, оқу бағдарламаларының ескіруі, тәжірибелік оқытудың шектеулігі, білікті педагогтардың тапшылығы және заманауи технологиялардың баяу енгізілуі.

Бұл мәселелерді шешу үшін мейіргерлік білім беру мен зерттеулерге қажетті ресурстарды арттыру, инновациялық әдістерді қолдану және оқу орындары арасындағы ынтымақтастықты нығайту қажет. Сондай-ақ, мейіргерлік зерттеулерді қолдау арқылы дәлелді медицина қағидаттарына негізделген клиникалық тәжірибені дамыту маңызды.

Жүйелі түрде қолға алынған шешімдер мейіргерлік істі жаңа деңгейге көтеріп, денсаулық сақтау саласында білікті мамандардың санын арттырады, бұл өз кезегінде халыққа көрсетілетін медициналық қызмет сапасын жақсарту жүйесінде сапалы қызмет көрсетуге мүмкіндік береді.

Әдебиеттер тізімі:

1. «Мейіргерлік іс негіздері» (Қазақстандық оқулықтар)112б
2. «Білім және денсаулық» Оразбеков. Г. О, Мұратова Р.Р 303б
3. «Мейірбике ісі негіздері» К.Ш.Қасенова, Ә.Ж.Сабырханова 275б
4. «Медицина ғылымдарының негіздері» Қ.М.Қанғожина 100б

Сілтеме:

https://www.slideshare.net

ISBN 978-601-08-0758-7

РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ТРАВМ ОПОРНО- ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Серёдкина Е.А., 2 курс, специальность «Сестринское дело»
КГП на ПХВ «Северо-Казахстанский высший медицинский колледж имени Жұмағали Тлеулин» КГУ «УЗ акимата СКО»
Научный руководитель Афонина Л.А., преподаватель специальных дисциплин

Аннотация: *В данной статье рассматривается участие медицинских сестер в реабилитации пациентов с травмами опорно-двигательного аппарата. Автор подчеркивает распространенность подобных травм, их влияние на жизнь пациентов, а также решающую роль сестринского ухода в процессе выздоровления.*

Здоровье человека – это фундамент его благополучия, определяющий качество жизни, активность и продолжительность. К сожалению, современный человек часто пренебрегает своим здоровьем, что приводит к серьезным последствиям.

По статистике в Казахстане ежегодно более 600 тысяч человек получают различные повреждения, из них 22% составляют дети, 78% - подростки и взрослые. В 2023 году по стране было зарегистрировано 2670 несчастных случаев. Основными видами травм несчастных случаев стали закрытые переломы (611 человек), поверхностные травмы (507 человек), травмы от сотрясения и травмы внутренних органов (276 человек), открытые переломы (138 человек), термические ожоги (102 человек). Из общего числа пострадавших женщины составили 18,2% [1].

Общий уровень травматизма в стране формируется за счет таких травм как, переломы различного характера, вывихи, растяжение или разрыв связок, повреждение тканей мышц, черепно-мозговые травмы, различного рода ампутации.

Механические травмы представляют серьезную проблему для современной медицины, особенно в таких областях, как нейрохирургия и травматология. Высокая смертность и инвалидизация, связанные с этими травмами, требуют значительных финансовых затрат на лечение и реабилитацию. Недостаток ухода за пострадавшими также усугубляет ситуацию. Именно поэтому актуальность темы роли медицинской сестры в реабилитации пациентов с травмами опорно-двигательного аппарата не вызывает сомнений.

Цель: проведение исследования, направленное на изучение основных проблем пациента и реабилитационной помощи, главную роль в которой играет медицинская сестра.

ISBN 978-601-08-0758-7

Объект исследования: пациенты травматологического отделения КГП на ПХВ «Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи № 3».

Предмет исследования: профессиональная деятельность медицинской сестры по уходу за пациентами, находящимися на строгом постельном режиме в связи с травмой опорно-двигательного аппарата.

Задачи:

1) изучить теоретические данные по травмам опорно-двигательного аппарата;

2) проанализировать роль медицинской сестры в реабилитационной помощи;

3) составить рекомендации по плану ухода за пациентами с травмами опорно-двигательного аппарата.

Травмой называется внезапное воздействие на организм человека факторов внешней среды (механических, физических, химических), приводящих к нарушению анатомической целостности тканей и функциональным нарушениям в них. Различают следующие виды травматизма: производственный, бытовой уличный, транспортный, спортивный и военный [2].

Медицинская сестра играет решающую роль в реабилитации пациентов, вынужденных длительное время находиться в постели. Обездвиженность негативно влияет на здоровье человека, вызывая различные осложнения. Задача медицинской сестры – помочь пациенту преодолеть последствия иммобилизации, восстановить физическую активность и адаптироваться к новой социальной роли.

«В сестринском деле гармонично сочетаются творческий подход и научная обоснованность процедур, использование соответствующих пособий, бесед, умение защитить пациента от негативных мыслей и чувств. Поэтому медицинская сестра должна быть отзывчивой, коммуникабельной, внимательной, проявлять терпение, поддерживать пациента, ведь от этого зависит его состояние и скорейшее выздоровление» [3].

Основные задачи медицинской сестры в реабилитации:

- выполнение медицинских назначений: проведение процедур, перевязок, инъекций и других манипуляций, назначенных врачом;
- уход за пациентом: обеспечение гигиены, помощь в перемещении, кормлении, создании комфортных условий пребывания в стационаре;
- контроль за состоянием пациента: регулярное измерение жизненно важных показателей, наблюдение за динамикой выздоровления, выявление осложнений;
- психологическая поддержка: создание атмосферы доверия, поддержка мотивации пациента, помощь в адаптации к новым условиям жизни;

ISBN 978-601-08-0758-7

- обучение пациента и его родственников: обучение навыкам самообслуживания, выполнению лечебной гимнастики, профилактике осложнений;
- сотрудничество с другими специалистами: взаимодействие с врачами, физиотерапевтами, инструкторами по лечебной физкультуре.

При лечении пациентов с травмами опорно-двигательного аппарата необходимо учитывать наличие сопутствующих заболеваний. Комплексный подход, включающий в себя лечение основного заболевания и реабилитацию после травмы, позволяет достичь наилучших результатов.

Например, у пациентов с заболеваниями дыхательной системы длительная иммобилизация приводит к прогрессированию дыхательной недостаточности и развитию осложнений, таких как застойная пневмония. Для профилактики этих состояний необходима дыхательная гимнастика, включая активные и пассивные упражнения, а также пребывание на свежем воздухе. [4]

Медицинский персонал играет важную роль в профилактике и лечении пациентов с заболеваниями ЖКТ, находящихся на постельном режиме. Создание комфортных условий для дефекации, коррекция питания и постепенная активизация пациента способствуют восстановлению нормальной функции кишечника.

Длительная иммобилизация приводит к быстрой атрофии мышц, делая пациента зависимым от посторонней помощи, [5], кроме того, повышает риск развития инфекций мочевыводящих путей и образования камней в почках из-за застоя мочи, для профилактики которой применяется катетеризация мочевого пузыря. [6]

Участки тела, где кости наиболее близко расположены к поверхности, являются наиболее уязвимыми для образования пролежней. К ним относятся крестец, седалищные бугры, локти, пятки и другие. Длительное давление на эти области приводит к нарушению кровообращения и развитию пролежней. [2]

Таким образом, длительная иммобилизация приводит к развитию полиорганной недостаточности, ухудшая прогноз основного заболевания и способствуя инвалидизации. Медицинская сестра играет ключевую роль в физической и психологической реабилитации таких пациентов.

Анализ данных о травматизме в Северо-Казахстанской области за 2023-2024 гг. выявил рост числа случаев первичной инвалидизации на 24%, в 2023 году составил 38 случаев, в 2024 году – 47.

Исследование было направлено на изучение особенностей ухода за пациентами с травмами опорно-двигательного аппарата, осуществляемого медицинскими сестрами. В исследовании приняли участие 30 пациентов, находящихся на стационарном лечении. Группу исследования составили преимущественно женщины - 67%.

ISBN 978-601-08-0758-7



Рисунок 1. Анализ пациентов с травмами ОДА

Данные рис. 1 говорят нам о том, что травматизм «молодеет».

За пациентом с травмами опорно-двигательного аппарата требуется постоянное наблюдение медицинской сестры. В ее обязанности входит контроль за физической нагрузкой пациента, соблюдением диеты и постельного режима, а также за приемом назначенных лекарственных препаратов.

Как видно из представленных данных (Рис. 2), боль в месте травмы отмечается у 29% пациентов. Характер боли может быть различным: от незначительной до интенсивной, существенно ухудшающей общее состояние больного. Интересно отметить, что 45% пациентов жалуются на боли в отдаленных от места травмы участках, особенно у пациентов с ограниченной подвижностью.



Рисунок 2. Анализ общих жалоб пациентов

Помимо обеспечения личной гигиены пациента, медицинская сестра должна уделять особое внимание профилактике пролежней, особенно у лежачих больных. Это включает регулярный осмотр кожных покровов в области костных выступов и проведение соответствующих гигиенических процедур.

Успешность лечения пациента в значительной степени зависит от профессионализма медицинской сестры. Информирование пациентов и их родственников о правилах ухода, диете, режиме двигательной активности, а также о необходимости смены положения тела способствует более быстрому выздоровлению и предотвращению осложнений.



Рисунок 3. Информированность пациентов о своем состоянии

Как видно из рис. 3, подавляющее большинство пациентов (88%) получили

ISBN 978-601-08-0758-7

информацию о своем состоянии и рекомендациях. Однако, несмотря на информированность, не все строго соблюдают предписания. Лишь 6% пациентов полностью следуют рекомендациям, а 6% не получили достаточной информации.

Помимо медицинских процедур, важную роль в выздоровлении играет психологическая поддержка. Простые, на первый взгляд, вещи – внимание, доброжелательное отношение, терпение – могут значительно улучшить состояние пациента. Важно выслушивать пациентов, отвечать на их вопросы и создавать атмосферу доверия, что способствует укреплению веры пациента в выздоровление.

Лечебная физическая культура является неотъемлемым этапом восстановления после травмы и представляет собой последовательный процесс, состоящий из трех основных этапов:

- иммобилизационный период: направлен на профилактику осложнений и подготовку к активной реабилитации;
- постиммобилизационный период: фокусируется на восстановлении объема движений и силы мышц;
- восстановительный период: направлен на полное восстановление функций поврежденной конечности и адаптацию к обычной жизни.

На каждом этапе лечебная физкультура решает специфические задачи и применяется в комплексе с другими лечебными мероприятиями.

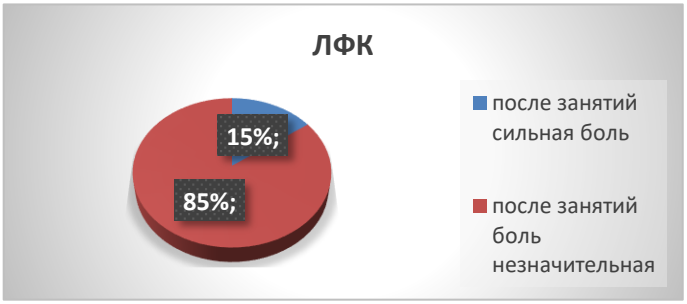


Рисунок 4. Ощущения после занятий ЛФК

Анализ данных исследования указывает на то, что одной из основных причин пропуска занятий лечебной физкультурой является наличие болевых ощущений. Причем, если 15% пациентов испытывают выраженную боль после тренировок, то остальные 85% отмечают наличие умеренных болевых ощущений.

Исследование выявило значительные различия во мнениях пациентов относительно эффективности лечебной физкультуры. 25% респондентов считают ЛФК важным компонентом лечения, в то время как 75% не согласны с этим утверждением.



Рисунок 5. Эффективность занятий лечебной физкультурой

Проблема нерегулярного

ISBN 978-601-08-0758-7

посещения занятий лечебной физкультуры пациентами после травм опорно-двигательного аппарата является распространенной.

После проведенных бесед ситуация существенно изменилась: *повысилась посещаемость занятий (91%), улучшились результаты реабилитации: у 37% процесс восстановления пошел быстрее. Пациенты, получившие индивидуальную поддержку, были удовлетворены процессом реабилитации.*

Каждый пациент индивидуален, поэтому сроки и особенности выздоровления могут отличаться. Медицинская сестра должна объяснить это пациенту и разработать индивидуальные рекомендации для предотвращения развития пролежней, о пользе лечебной гимнастики, диете, о правильном приеме лекарственных препаратов. Помимо медицинских процедур, пациентам необходимо оказывать психологическую поддержку. Это помогает им справиться с болезнью, снизить уровень тревожности и повысить качество жизни.

В целом, исследование направлено на изучение профессиональной деятельности медицинской сестры в области реабилитации пациентов с травмами опорно-двигательного аппарата с целью разработки эффективных рекомендаций по уходу и лечебной физкультуре.

Теоретическая основа исследования позволит лучше понять роль медицинской сестры в процессе реабилитации, а практические результаты будут полезны для создания персонализированных планов ухода и лечебной физкультуры для каждого пациента.

Таким образом, значение медицинской сестры в процессе реабилитации пациента выходит далеко за рамки выполнения медицинских процедур. Она играет ключевую роль в психологической поддержке пациента, обучении его и его родственников навыкам самообслуживания, а также в контроле за соблюдением всех рекомендаций. Эффективность лечения во многом зависит от психологического климата, который создается медицинской сестрой. Ее внимательное отношение, поддержка и обучение пациентов помогают ускорить процесс выздоровления и повышают качество жизни пациентов.

Список литературы:

1. Травматизм остается одной и важнейших проблем в Казахстане. / https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30914132&pos=4;-98#pos=4;-98

2. Козлова, Л. В. Основы реабилитации для медицинских колледжей: учеб. пособие/ Л. В. Козлова, С. А. Козлов, Л. А. Семененко; под общ. ред. Б. В. Кабарухина. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2018. – 475 с.

3. Бойков, В. П., Чермаков К. С. Острый болевой синдром при повреждениях и заболеваниях области локтевого сустава / В. П. Бойков, К. С. Чермаков. – журнал Медицинская сестра, 2017. – 20 с.

ISBN 978-601-08-0758-7

4. Вжос, Е. Активизация пациента с деменцией в домашних условиях / Е. Вжос. – Форум, 2016. 5. Епифанов, В. А. Реабилитация в травматологии: руководство / В. А. Епифанов, А. В. Епифанов. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - (Серия "Библиотека врача-специалиста"). http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416853.html

5. Завьялова, Т. П. Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у обучающихся: учеб. пособие / Т. П. Завьялова. – изд – во «Юрайт», 2017. – 184 с.

6. Коновалов, С. С. Опорно-двигательная система / С. С. Коновалов. – изд – во «АСТ», 2019. – 32 с.

ISBN 978-601-08-0758-7

АРНАУЛЫ ӘЛЕУМЕТТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫНА ӘЛЕУМЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІҢ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРІ

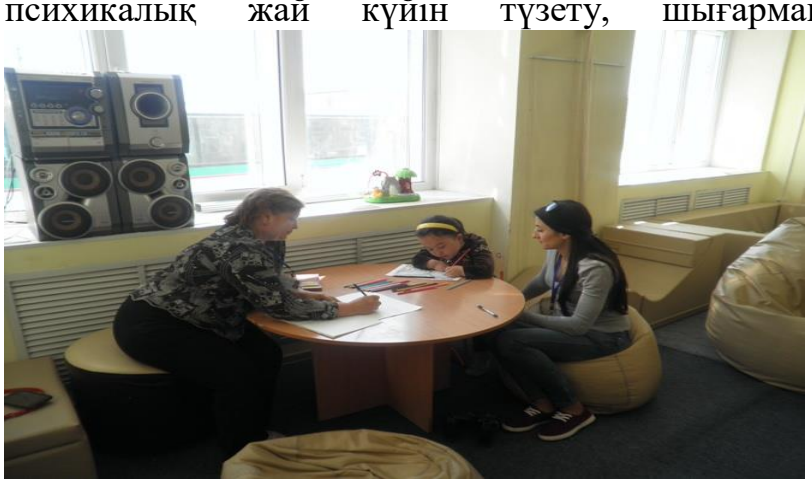
Алдабергенова Айман Сагынтаевна
«Астана қаласының АИТВ инфекциясының алдын –алу орталығы»

Медициналық және әлеуметтік жұмыс - бұл денсаулықты қалпына келтіруге, қолдауға және нығайтуға, сонымен қатар қиын өмірлік жағдайдағы науқастардың мәселелерін шешуге көмектесетін кәсіби қызмет.

Әлеуметтік жұмыс - бұл ерекше қызмет түрі және өзекті. Неге? Әлеуметтік жұмыс - бұл мұқтаж адамдарға, олардың өмірлік мәселелерін сырттан көмексіз шешуге мүмкіндік беретін қызмет.

Балаға жеке бағдарламаның психологиялық дәлде-кәсіптер әдістемесі:

- **музыкатерапия** (коммуникативтік зейіннің дамуына, баланың эмоциясына, бұлшықеттерінің қалыпты жағдайына, қозғалыс қимылдары көмек береді)
- **Ойынтерапиясы, ертегітерапиясы**-баланың қарау, айту, көру ойынға мотивациясын көтермелеу, орта мен әлеуметтік жағдайда қалыптастыру
- **Рөльдік ойын**-балаға ойын шартын үйретіп таныстыру, нұсқауды орындау, шыдамдылыққа, төзімділіке, шығармашылық қызығушылығын **Арт-терапия**: баланың ішкі жан дүниесін түсіндіретін әдістеме, отбасылық мәселерді шешу, қорқыныш үрейін әр түрлі түстер арқылы сурет арқылы өткізу, дәрі – дәрмектің көмегінсіз, баланың психикалық жай күйін түзету, шығармашылық қабілетін ояту.



3. Отбасылық және психикалық консультация ата-аналардың тәрбие беруде, баланың дамуы, психикалогикалық қиындықтан шығу, отбасының мәселелерін шешеді отбасыдағы депрессия, стресс, түсінуіспеушілік т.б..

ISBN 978-601-08-0758-7

4. **Сенсорлық бөлмедегі сабақ** балаларға өте ұнайды, олар өздерін ертегі әлемінде сезінеді, жарық анализаторы, баланы нәзік әуен сиқырлы әлемге батырады.



Сенсорлық бөлмеде өтетін сабақтар баланың дамуына назар аудару:

- концентрациясы, еске алу қабілетін ояту, қиялдау,
- стесстік қалпын шешіп, қорқыныш үрейін түсіріп,
- бала тынышталып жаркын өмірге құлшыныс жасап, стимул беріп ата-анамен баланың қарым қатынасы түзеледі.



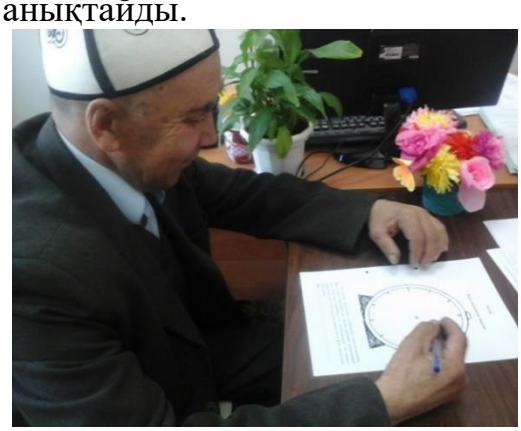
- **5. Бала мен ата-аналармен сенсорлық бөлмеде өткізілетін топтық жұмыс** релаксация әдістемесін үйретіп нұсқаулық, коммуникация, эмоциясын түсіру, өз - өзін ұстауға, дербес отбасылық проблеманы шешу.
- **6. Тренингтер** – Әлеументтік центрде жұмыс жасайтын әріптестерге көмек ретінде эмоцианалдық реніштерін жеңуге, стресстен шығуға, өзін өзі бағалауға, жай күйін және релаксацияны өз тәжірибесінде пайдалануға үйрету.

ISBN 978-601-08-0758-7

Әлеуметтік қызметкерлердің ересектермен қызмет көрсетудің әдіс-тәсілдері:

«Сағат» суретті тест

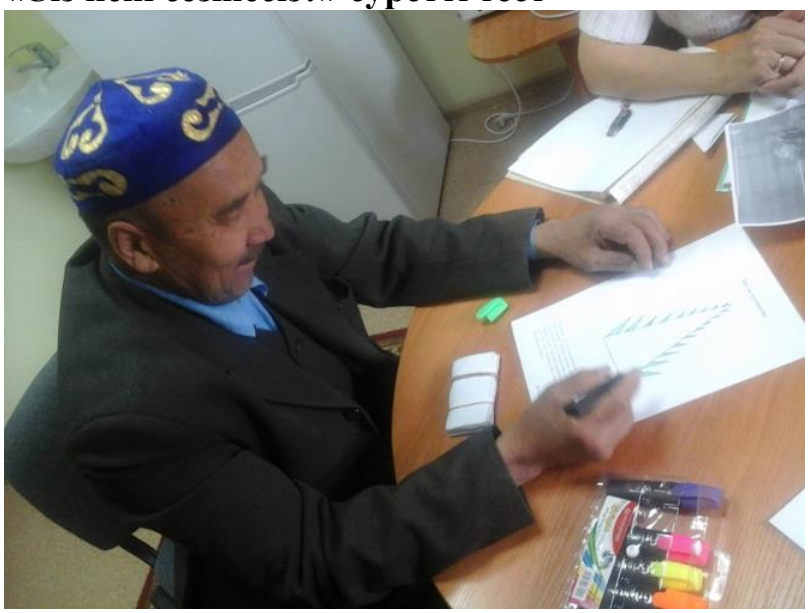
- **Мақсаты:** Өмірлік энергия деңгейін анықтау.
- Бұл тест келушінің қазіргі уақыттағы өмірлік энергия деңгейін анықтайды, өмірінің қай тұсында жетіспеушіліктің немесе түсінбеушіліктің бар-жоғын анықтайды.





- **Д.Рассел және М.Фергюсонның «Жалғыздықты субъективті сезіну» методикасы**
- **Мазмұны:** Бұл тест адамның жалғыздықты сезіну деңгейін анықтайды.
- Жалғыз қалғаннан қатты қорқып және оны сыңарезулікпен жасыратын, өзінің субъективтік қабылдау қасиетін төмендетіп алған адамдардың жан күйі, сезінісін айқындау мақсатында қолданылады.

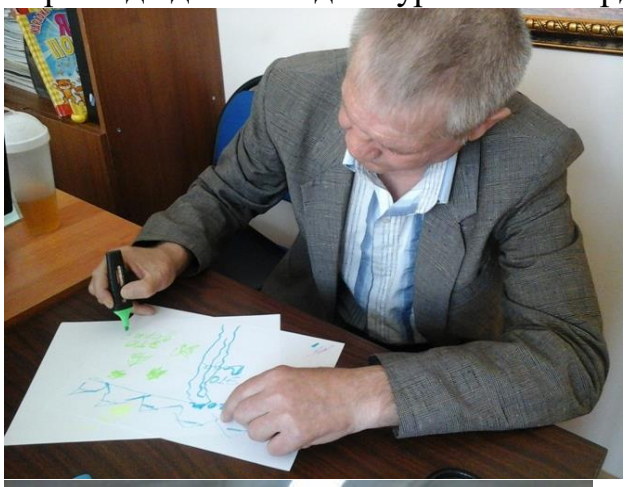
«Сіз нені сезінесіз?» суретті тест

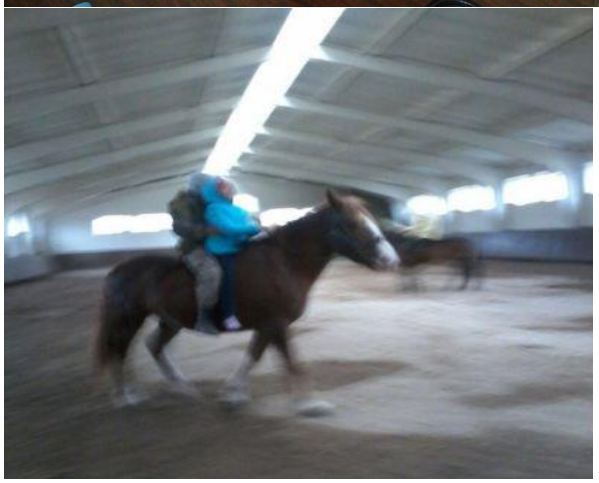


- Бұл тест адамның нақ осы шақтағы көңіл-күйін, жан тебіренісін, жалпы сезімін анықтайды. Егде жастағы адамдар көбінесе өз сезімдерін әңгіме барысында ашық айтады, сыр бөліседі, ал мүгедектігі бар адамдар

ISBN 978-601-08-0758-7

көбінесе бірден ашыла қоймайды, сенім мен түсінушілігіне ие болу үшін бастама ретінде дәл осындай суретті тесттердің пайдасы зор.





Гипотерпия (атпен жүру) - балаларға артқы бұлшықеттерін нығайтуға көмектеседі, тепе-теңдікті сақтау кезінде балаларды отыруға үйретеді, баланың эмоционалды белсенділігін арттырады, үй жануарларынан қорқынышы жоғалады.

Иппотерапия бойынша жоба ерекше қажеттіліктері бар баланың дене белсенділігін дамытуға бағытталған. Осының нәтижесінде мүгедектігі бар балалардағы вестибулярлы және тірек-қимыл аппараты мен барлық бұлшықет топтарының функциялары жақсарып, вегетативті жүйке жүйесіне оң әсерін тигізеді.

ISBN 978-601-08-0758-7



Гидротерапия - бұлшықеттер мен буындардағы кернеуді азайтады, қозғалыс ауқымын арттырады және, әрине, баланың денесін тыныштандырады.

Арттерапия қиял мен қиялдың дамуына ықпал етеді



Музыкалық терапия эмоционалды ауытқулар мен қорқыныштарды, қозғалыс және сөйлеу бұзылыстарын түзетуде белсенді қолданылады. Музыка баланы тыныштандырады.
Ертегі терапиясы - бұл шығармашылық қабілеттерді дамыту, сананы кеңейту, сыртқы әлеммен қарым-қатынасты жақсарту әдісі.

Қорытындылай келе, Барлық қоғамда қазіргі кейбір әлеуметтік ілімдерден белгілі болғандай, адамдар мүмкіндігінше өздерінің және өздерін қоршаған ортаның әлеуметтік тұрмысының жақсаруына жәрдем беруге тиіс, бұл барлық социумға пайдасын тигізеді. Жеке тұлға мен оны қоршаған орта арсындағы өзара қарым-қатынас жеке бастың мәртебесін, даралығын бекітуі тиіс. Адамдар иманды және әділетті болуы қажет

Қолданылған әдебиеттер:

ISBN 978-601-08-0758-7

1. Кудрявцева, И. А. «Музыкалық терапия және оның психологиялық әсері». — М.: Психология, 2020.
2. Иванова, Т. В. «Ертегі терапиясы: шығармашылық және жеке тұлға дамуындағы рөлі». — СПб.: Педагогика, 2019.
3. Левченко, А. Ю. «Балалар психологиясы және эмоционалды даму әдістері». — Казань: Білім, 2021.
4. Белова, Н. М. «Әлеуметтік психология мен тұлғааралық қарым-қатынастар». — Алматы: Мектеп, 2018.
5. Рахметова, Г. С. «Әлеуметтік ілімдер және қоғамдағы өзара қарым-қатынастар». — Астана: Университет, 2022.

ISBN 978-601-08-0758-7

МЕЙІРГЕРЛІК БІЛІМ ЖӘНЕ МЕЙІРГЕРЛІК ЗЕРТТЕУЛЕР

Уласканова А.Г.,2 курс, "Мейіргер ісі" мамандығы
"Қызылорда медицина жоғары колледжі" ҚМЖК
Ғылыми жетекшісі Орынбасар Б.К., "Анатомия,физиология және патология" пәнінің оқытушысы

Аннотация: *Мақалада мейірбике ісінде зерттеу кезеңдері ұсынылған. Мақаланың мазмұны қолданбалы бакалавриат студенттерінің дәрісіне арналған материал бола алады.*

Ғылыми зерттеулер осы кәсіби саладағы дамудың жаңа бағыттарының бірі болып табылады. Шетелдік тәжірибені талдау мейірбикелік қызмет нәтижелерін емдеу мекемелерінің тәжірибесіне енгізуге байланысты халыққа медициналық көмек көрсету жүйесіндегі сапалы өзгерістерді көрсетеді.

Мейірбикелік зерттеулердің мақсаты пациенттердің қажеттіліктерін, максималды тиімділік пен минималды шығындармен пациенттің қалаған нәтижелеріне қол жеткізу үшін медициналық қызмет көрсетушілердің озық тәжірибесін зерттеу болып табылады.

Ғылыми зерттеудің келесі кезеңдері бөлінеді:

1. Зерттеу тақырыбын таңдау.
2. Әдебиетпен жұмыс.
3. Мақсаттар мен міндеттерді анықтау.
4. Жұмыстың атауын тұжырымдау.
5. Зерттеу объектісі мен пәнінің анықтамасы.
6. Гипотезаны дамыту.
7. Зерттеу әдістерін таңдау.
8. Зерттеу жоспарын құру.
9. Зерттеу жұмыстарын жүргізу.
10. Зерттеу нәтижелерін өңдеу.
11. Қорытындыларды тұжырымдау.

Зерттеу тақырыбын таңдау

Ғылыми мақалаларды талдау, кафедра оқытушыларымен қарым-қатынас жасау тақырыпты таңдауға көмектеседі. Әріптестермен сөйлесіп, олардың сынын тыңдаудың да пайдасы зор. Ғылыми зерттеу жобасын жасағанда, алдыңғы жұмыстарға сүйеніп, осы тақырыпты тереңірек зерттеуді жалғастыруға болады. Алдыңғы зерттеулерді қайталау – ғылымның дамуының құрметті және маңызды тәсілі болып табылады.

Репликация – бұрын жүргізілген зерттеудің нәтижелерін қайталау арқылы олардың қайтадан расталатынын анықтау үшін жасалатын зерттеу. Себебі кішігірім таңдалған бір-екі зерттеу жеткілікті дәлел бола алмайды.

Іс жүзінде зерттеу басында анықталған мәселе әріптестермен әңгімелесу, әдебиеттерге шолу, пилоттық зерттеу нәтижелері арқылы өзгеріп, толықтырылып, нақтылануы мүмкін. Қаржыландыру және демеушілік зерттеу ауқымын кеңейтуге түрткі болуы мүмкін.

ISBN 978-601-08-0758-7

Әдебиетпен жұмыс

Зерттеу үшін қажетті ақпаратты жергілікті, өңірлік, республикалық және халықаралық деңгейдегі әрекеттегі дерекқорлар арқылы алу жүзеге асырылады. Бұған бұйрықтар, құжаттар, мақалалар, кітаптар, сондай-ақ CINAHL, MEDLINE, PubMed, e-library дерекқорлары кіреді. Конференция материалдары бойынша әдебиетті іздеу озық білім туралы хабардарлықты арттырады (өйткені олар жарияланымдардан бұрын басылады). Интернет-журналдың беделін тексеру керек, оның рецензияланатынын білу үшін.

Зерттеудің мақсатын мен міндеттерін анықтау

Зерттеудің мақсаты негізгі өзгермелілерді анықтап, методология мен дизайнды көрсетеді. Зерттеудің мақсаты әдетте бір сөйлеммен тұжырымдалады. Егер бұл сандық зерттеу болса, мақсат таралу, себеп-салдарлық байланыстарға қатысты болады, олар статистикалық анализ арқылы талдануы керек. Сапалық зерттеудің мақсаты – адамның өмірлік тәжірибесіне қатысты белгілі бір зат, жағдай немесе оқиғаның құрылымын ашу. Зерттеудің міндеті – гипотезаға сәйкес мақсатқа жету үшін жолдар мен құралдарды таңдау.

Зерттеу жұмысының атауын тұжырымдау

Ғылыми жұмыстың атауы зерттеудің негізгі идеясын, мақсатын және міндеттерін көрсетуі тиіс. Мысалы:

Тақырып: Қызылорда қаласындағы колледж студенттері арасында денсаулық мәселелері бойынша сауаттылық деңгейін бағалау.

Зерттеудің мақсаты: Қызылорда қаласындағы колледж студенттері арасында денсаулық мәселелері бойынша сауаттылық деңгейін анықтау және бағалау.

Зерттеудің міндеттері:

1. Халықтың (мақсатты топтар) денсаулық мәселелері бойынша сауаттылық деңгейін анықтау тәжірибесін талдау.
2. Қызылорда қаласындағы колледж студенттері арасында денсаулық мәселелері бойынша сауаттылық деңгейін бағалау.
3. Денсаулық мәселелері бойынша сауаттылық деңгейін арттыру тәсілдеріне ұсыныстар әзірлеу.

Зерттеу объектісін және пәнін анықтау

Зерттеу объектісі науқастар, олардың туыстары, белгілі бір мінез-құлық түрлері, психикалық құбылыстар болуы мүмкін. Мысалы, зерттеу объектісі медициналық көмек сапасына қанағаттанушылық болуы мүмкін. Мұндай жағдайда, зерттеу пәні медициналық қызметтерге қанағаттанушылықты қалыптастыру факторлары, олардың себептері, пайда болу механизмдері, салдары болады.

Гипотезаны әзірлеу

ISBN 978-601-08-0758-7

Гипотеза – бұл дәлелдерді талап ететін, болжам рөлін атқаратын мәлімдеме. Гипотезаны дәлелдеп, оны орнатылған фактке айналдыруға немесе оны жоққа шығаруға болады.

Зерттеу әдістерін таңдау

Медициналық зерттеулерде жиі сандық немесе сапалық зерттеу әдістері таңдалады. Сандық зерттеулер зерттеу сұрағына жауап беру үшін есептейді немесе өлшейді. Бұл зерттеу жиілікті, екі құбылыс арасындағы байланысты немесе олардың себеп-салдарлық байланыстарын түсінуге мүмкіндік береді. Сапалық зерттеулер қатысушылардың көзқарасынан өмірлік тәжірибені, мәдениетті және әлеуметтік процестерді сипаттайды. Мұндай зерттеулер адамдардың өміріне тән тереңдік, байлық және күрделілікті зерттеуге мүмкіндік береді. Сапалық талдау әдістері сандар емес, сөздерді пайдаланады.

Зерттеу жоспарын құру

Жоспарда ұйымдастырушылық мәселелер қарастырылады: зерттеу қайда, қашан және қандай күштермен жүргізілетіні. Міндеттер бөлініп, жұмыстардың күнтізбелік жоспары жасалады. Тәжірибелі зерттеуші күтпеген шығуларға байланысты көп субъектілерді қамтиды, себебі кейбір адамдар жобадан шығуды қалайды, және зерттеуші оларға мұны жасауға мүмкіндік беруі керек.

Зерттеуші жұмысты тек жергілікті этикалық комиссиядан келісім алғаннан кейін бастай алады. ЛЭК ұсынылған жұмыстың қауіпсіздігі мен қауіптерін бағалайды. Минималды қауіптер зерттеудегі зиянның күнделікті өмірде немесе әдеттегі физикалық немесе психологиялық тексерулер, тесттер кезінде кездесетін деңгейден аспайтынын білдіреді. Әр субъектіден хабардар келісім алынуы тиіс. Хабардар келісім бесінші сынып оқушысына түсінікті тілде жазылуы керек! Егер зерттеуші төмен деңгейдегі қауіптермен жұмыс істесе, "Бұл сауалнама толтыру сіздің зерттеуге қатысуға келісіміңізді білдіреді" деген жолды енгізу хабардар келісімді алудан босатады.

Зерттеуді өткізу

Зерттеу күнтізбелік жоспарға сәйкес жүргізілуі тиіс. Зерттеу туралы ақпаратты 6 жыл бойы сақтау қажет.

Зерттеу нәтижелерін өңдеу

Ақпараттық материалды өңдеу және талдау жүргізілетін зерттеудің сапалы немесе сандық болуына байланысты өзгереді. Сапалық талдауда зерттеушінің алдында сипаттау мен түсіндіру арасында теңгерімді сақтау мәселесі тұрады. Көрінетін құбылыс туралы мүмкіндігінше толық, шынайы бейне беру маңызды, бірақ артық түсіндірмелерден аулақ болу керек. Сандық талдауда бір-біріне әсер ететін өзгермелілер ұғымымен жұмыс істеледі, қолданбалы математикалық статистика әдістерінің жиынтығы пайдаланылады.

Қорытынды тұжырымдау

ISBN 978-601-08-0758-7

Бұл зерттеудің мазмұнды нәтижелерін қысқаша түрде білдіретін мәлімдемелер, олар автордың алған жаңалығын тезистік формада көрсетеді. Әрбір аталған міндеттің шешімі қорытындыларда көрініс табуы тиіс. Бұл кезеңнің негізгі міндеті – алынған нәтижелерді басқа зерттеушілердің нәтижелерімен салыстыруға және практикалық қызметте қолдануға мүмкіндік беретін, жалпыға қолжетімді және түсінікті формада ұсыну.

Сондықтан кез келген ғылыми зерттеуге төмендегідей талаптар қойылады: тақырыптың өзектілігі, оның тереңірек зерттеуге қызығушылығы мен маңыздылығы; жүргізілген зерттеудің жарияланған тақырыпқа сәйкестігі; жұмыстың құрылымының айқындылығы, рәсімделу грамоталығы; логикалық реттелуі, материалды баяндаудың тереңдігі мен толықтығы; жұмыста келтірілген дәлелдердің сенімділігі; жұмыс нәтижелерінің нақты баяндалуы; қорытындылардың дәлелділігі; зерттеу нәтижелерін оқыту және тәрбиелеу практикасында қолдану мүмкіндігі.

Әдебиеттер тізімі:

1. Burns and Grove's The Practice of Nursing Research: Appraisal, Synthesis, and Generation of Evidence 2017г.)

2. Руководство для высших медицинских колледжей в вопросах реализации программы прикладного бакалавриата, Нур-Султан, 2019 г

3.https://studref.com/380464/meditsina/nauchnye_issledovaniya_sestrinskom_dele 4. https://moluch.ru/archive/110/26991/

ISBN 978-601-08-0758-7

СЕСТРИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И СЕСТРИНСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Стратула Р., 3 курс, специальность «Лечебное дело»
КГП на ПХВ «Высший Жамбылский медицинский колледж»
Научный руководитель Бешли Оглы Хусеин Биналиевич ,
преподователь специальных дисциплин

Аннотация: *В статье рассматриваются состояние и перспективы развития сестринского образования и исследований в Казахстане. Анализируются ключевые этапы подготовки медсестер, включая среднее профессиональное, высшее и последипломное обучение, а также программы повышения квалификации. Особое внимание уделено внедрению доказательной медицины и участию казахстанских специалистов в международных проектах. Выявлены основные проблемы, такие как нехватка кадров, ограниченные исследовательские ресурсы и недостаточная мотивация к научной деятельности. В статье предложены пути решения существующих вызовов с акцентом на усиление государственной поддержки и международного сотрудничества.*

Введение

Современная система здравоохранения Казахстана активно развивается, уделяя большое внимание подготовке высококвалифицированных специалистов. Одним из приоритетных направлений является развитие сестринского дела и научных исследований в этой области. Сестринское образование и исследования служат основой для повышения качества медицинских услуг и соответствия международным стандартам.

Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения»

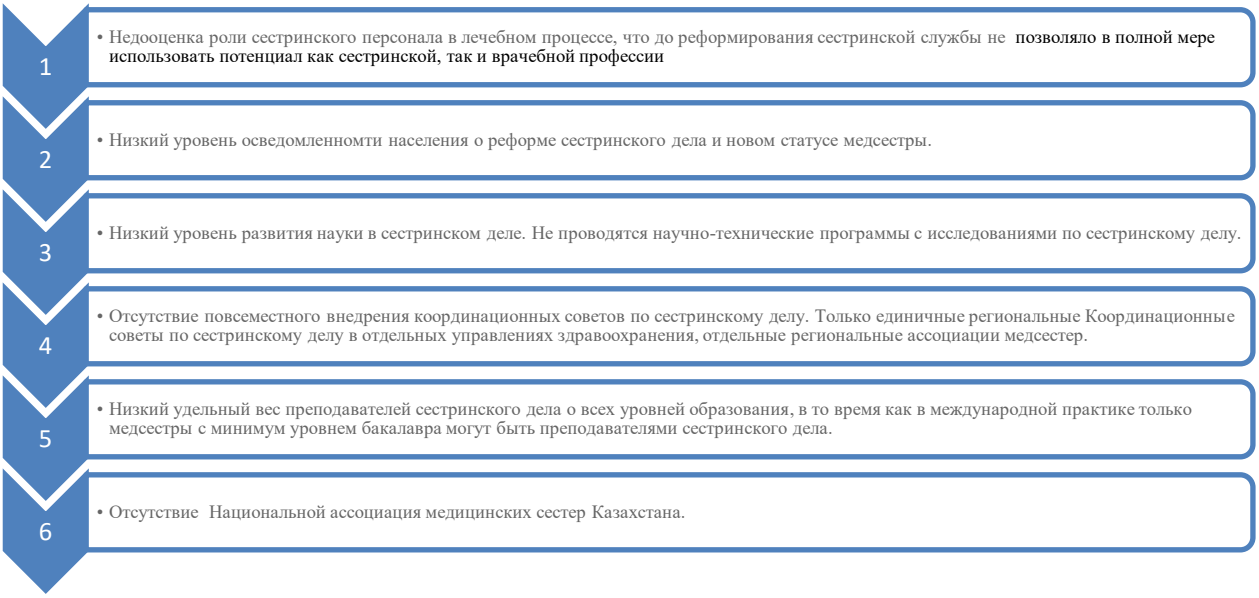
Статья 127 «Сестринская деятельность»

Медицинская сестра – специалист с техническим и профессиональным медицинским образованием в области сестринского дела, осуществляющий сестринский уход самостоятельно или под супервизией медицинской сестры расширенной практики или врача.

Медицинская сестра расширенной практики – специалист с послесредним или высшим образованием в области сестринского дела, осуществляющий расширенные функции в рамках сестринского ухода.

Существовавшие барьеры в развитии сестринской службы в РК

ISBN 978-601-08-0758-7



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ СЕСТРИНСКО СЛУБЫ В РК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА 2020-2025 ГОДЫ

Мероприятия по повышению статуса и роли медицинских сестер.

Делегирование СМР ряда функций и расширение роли и задач специалистов сестринского дела.

Внедрение клинических сестринских руководств и СОП. Комплекс мер по управлению и развитию СМР.

Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК

клиническое сестринское руководство – документ, содержащий научно доказанные рекомендации для сестринского персонала по уходу за пациентами, предполагающий использование профилактических, диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий в ведении пациентов;

сестринский уход – комплекс медицинских услуг, оказываемых медицинскими сестрами и медицинскими сестрами расширенной практики лицам всех возрастов, групп и сообществ, больным или здоровым, включающий в себя пропаганду здоровья, профилактику болезней и уход за больными, инвалидами и умирающими людьми.

ЗАКОН «ОБ ОБРАЗОВАНИИ» ОТ 27 ИЮЛЯ 2007 ГОДА (ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 2015 ГОДА)

21-1 Высший колледж – учебное заведение, реализующее интегрированные модульные образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования

38-1) прикладной бакалавриат – послесреднее образование, образовательные программы которого направлены на подготовку кадров с присуждением квалификации «прикладной бакалавр»;

ISBN 978-601-08-0758-7

38-2) прикладной бакалавр – квалификация, присуждаемая лицам, освоившим образовательные программы послесреднего образования;

ДОРОЖНАЯ КАРТА «ТРИЕДИНСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ПРАКТИКИ В СЕСТРИНСКОМ ДЕЛЕ» ДО 2025 ГОДА

Актуализация нормативно-правовых актов для специалистов сестринского дела

Проведение анализа трудоустройства выпускников медицинских и высших медицинских колледжей

Проведение результата оценки знаний и навыков выпускников медицинских и высших медицинских колледжей

Анализ исследовательских работ в сестринском деле с публикацией в периодических журналах

Внедрение института наставничества

Развитие профессиональных сестринских ассоциаций для поднятия престижа профессии



УТВЕРЖДАЮ
Министр здравоохранения
Республики Казахстан
А. Гиният
2022 года № 100

План организационных мероприятий (дорожная карта)
Вид документа: Поручение Президента Республики Казахстан № 21-01-25.65 от 29 июня 2021 года.
Содержание поручения: необходимо сформировать новую генерацию медицинских сестер и братьев. Для этого нужно последовательно повышать уровень их профессиональной подготовки и сделать сестринское дело престижным.
Промежуточный срок контроля: 1 раз в полгода (до 10 числа месяца, следующего за отчетным).
Конечный срок исполнения: декабрь 2023 года.
Ответственный государственный орган – исполнитель: Министерство здравоохранения Республики Казахстан.

Дорожная карта «Триединство образования, науки и практики в сестринском деле» на 2022-2023 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Форма завершения	Срок исполнения	Индикаторы исполнения	Ответственное за контроль должностное лицо государственного органа / организации
Этап 1. Организационно-подготовительная работа						
1.1.	Совершенствование сестринской службы					

Состояние и перспективы сестринского образования

В Казахстане система подготовки медсестер проходит несколько этапов:

Среднее профессиональное образование: реализуется в медицинских колледжах и готовит специалистов для практической деятельности на уровне первичной медицинской помощи.

Высшее образование: на базе бакалавриата готовятся специалисты, способные участвовать в управлении и исследованиях. Вузы предлагают также магистратуру и докторантуру для повышения уровня подготовки.

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации: регулярные курсы и тренинги позволяют медсестрам соответствовать требованиям времени и внедрять новые подходы к уходу за пациентами.

Гармонизация образовательных программ с международными стандартами, такими как Европейская рамка квалификаций, способствует интеграции казахстанских специалистов в глобальное сообщество.

Сестринские исследования в Казахстане

Научные исследования в области сестринского дела развиваются для обеспечения качественной и эффективной медицинской помощи. Основные направления исследований включают:

- внедрение доказательной медицины в практику;

ISBN 978-601-08-0758-7

- оптимизацию методов ухода за пациентами;
- исследование психоэмоционального состояния медсестер и предотвращение профессионального выгорания;
- разработку инновационных подходов к сестринскому обучению и практике.

Важную роль в развитии исследований играют магистерские и докторские программы, стимулирующие подготовку научных кадров и проведение актуальных исследований. В рамках международных проектов казахстанские специалисты обмениваются опытом с коллегами из других стран, что способствует развитию новых методологий в здравоохранении.

Проблемы и пути решения

Несмотря на достижения, в системе сестринского образования и исследований Казахстана имеются вызовы:

- недостаток преподавательских кадров и ресурсов для научной работы;
- ограниченное участие в международных исследовательских проектах;
- необходимость усиления мотивации для проведения научных исследований среди медсестер.

Для решения этих проблем требуется государственная поддержка, расширение международного сотрудничества, а также внедрение программ по популяризации научной деятельности среди медицинского персонала.

Выводы:

Сестринское образование и исследования в Казахстане находятся в стадии активного развития. Внедрение современных образовательных технологий и проведение научных исследований способствует повышению качества медицинских услуг. В будущем ожидается дальнейшее развитие интеграции с международными стандартами и усиление роли научной работы в медицинской практике.

Список литературы

1. Аманжолов, Е. С. Современные подходы к подготовке специалистов в области сестринского дела. — Алматы: КазНМУ, 2021.
2. Ермакова, Л. В. Доказательная медицина и ее внедрение в практическое здравоохранение. — Астана: Научное издательство, 2022.
3. Жумадилова, Г. Р. Проблемы и перспективы развития сестринского дела в Казахстане // Медицинская наука Казахстана. — 2023. — № 2. — С. 45–50.
4. Комитет по охране общественного здоровья МЗ РК. Программа развития здравоохранения на 2021–2025 годы. — Астана, 2021.
5. Назарова, С. К. Международное сотрудничество в подготовке медсестер: опыт Казахстана // Вестник медицины и образования. — 2022. — № 4. — С. 31–35.

ISBN 978-601-08-0758-7

АУРУЛАРДЫ БАСҚАРУ БАҒДАРЛАМАСЫ АЯСЫНДА МЕЙІРГЕРДІҢ РӨЛІ

Эрназарова А., 1 курс, мамандық «МІҚБ»
Жоғары медициналық колледж «Интердент»
Ғылыми жетекші Реймбаева Б.М., МІ арнайы пәндер оқытушысы

Созылмалы жұқпалы емес аурулар (бұдан әрі- СЖЕА) дамыған елдерде жоғары, мезгілсіз өлім-жітім мен мүгедектіктің негізгі себебі болып табылатын, қазіргі заманғы денсаулық сақтау саласының ең өзекті мәселелерінің бірі болып отыр. Көптеген эпидемиологиялық зерттеулер мәліметтері бойынша жүрек-қан тамыр және созылмалы жұқпалы емес аурулардың дамуына мынадай факторлардың әсері бар екендігі даусыз және дәлелденген. Олар шылым шегу, гипертония, артық салмақ, қанда глюкоза мен холестериннің жоғарылауы, ішімдікке салыну, төмен дене белсенділігі. Созылмалы жұқпалы емес аурулардың қауіп факторын және дамуын біріншілік медико-санитарлық көмек көрсету арқылы ескерту медицина қызметкерлерінің жұмысының негізгі бағыты болып табылады.

Мейіргерлердің бірінші рөлі – аурудың деңгейін және сипатын дұрыс бағалау. Олар пациенттің ауруын, оның ауырлығын, себептерін және әсер етуші факторларын зерттей отырып, нақты ақпарат жинайды. Бұл ақпарат ауруды басқару стратегиясын әзірлеу үшін өте маңызды. Мейіргерлер ауруды басқару бағдарламасының негізі ретінде пациенттер үшін жеке жоспарларды әзірлейді. Бұл жоспарлар пациенттің қажеттіліктері мен жағдайына байланысты әртүрлі медициналық шараларды қамтиды, соның ішінде дәрі-дәрмек қабылдау, физиотерапия, психологиялық қолдаулар. Ауруды басқару бағдарламасында мейіргерлер дәрі-дәрмектердің дұрыс тағайындалуын, мөлшерлеуін және пациенттердің оларды қабылдауын бақылауға жауапты. Олар пациенттерге дәрілердің жанама әсерлері туралы ақпарат береді, қажеттілік болса, медициналық дәрігерге хабарлайды. Ауруға шалдыққан пациенттер көбіне психологиялық қиындықтарға тап болады. Мейіргерлер пациенттермен тиімді қарым-қатынас орната отырып, олардың психологиялық жағдайын жақсартуға көмектеседі. Олар ауру туралы білім беріп, пациенттердің сұрақтарына жауап бере отырып, оларды эмоционалды қолдайды.Мейіргерлер ауруды басқару бағдарламасы шеңберінде пациенттерге денсаулықтарын сақтау, ауруларды алдын алу және басқару туралы ақпарат береді. Бұл білім пациенттердің өздерінің денсаулықтарына жауапкершілікпен қарауына көмектеседі. Ауруды басқару бағдарламасы көпсалалы командалық жұмысты талап етеді. Мейіргерлер дәрігерлер, физиотерапевтер, психотерапевтер және басқа да медициналық қызметкерлермен бірге жұмыс істей отырып, пациенттің емдеу жоспарын іске асыруда маңызды рөл атқарады.

Пациенттердің медициналық сауаттылық деңгейін арттыруда мейіргер жетекші рөл атқарады. Пациенттерді оқыту процесінде мейіргерлер

ISBN 978-601-08-0758-7

пациенттің жағдайын бірнеше айға дейін, кейін және одан кейін бағалайды, оқытудың тиімділігін бағалау жүйесін әзірлейді. Мейіргер пациенттің ақпаратты қабылдауға дайындығын ескереді, оны оқу процесіне тартады, оны өз алдына мақсат қоюға және өзін-өзі бағалауға ынталандырады, әртүрлі режимдерді, рецепттер мен ұсыныстарды орындауға байланысты қиындықтарды жеңуге үйретеді. Ауруларды басқару бағдарламасын енгізу-пациент пен медициналық ұйымның өзара әрекеттесуіне, олардың рөлі мен жауапкершілігіне жаңа көзқараспен қарауға мүмкіндік береді.

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің № ҚР ДСМ-305/2020 бұйрығы бойынша «Кеңейтілген практика мейіргері» пациент пен отбасы мүшелерінің жалпы күтім және ауруды басқару рәсімдеріне оқытуы ұйымдастырады, тиімділігін мониторингтейді, бақылайды және диспансерлік науқастар мен карттарға патронаж жасайды. Сондықтан, орта медицина қызметкерлері арасында кәсіби біліктілік деңгейін көтеру қажет. Пациентті оқыту бағдарламаларына баса назар аудару қажет. Зерттеулерге сүйене келе көбіне ауру ағымына, асқынуларға негізгі бағыт аударылады. Бірақ, бұл ең алдымен пациент диспансерлік есепке тұрғаннан соң ауру ағымы бойынша медицина қызметкерлерінің пациентті оқыту, үйрету, меңгеру секілді құзыреттіліктерін дамытуды қажет етеді. Мейіргерлердің тәуелсіз функцияларына мынадай іс-шаралар жатады: дәрігерге дейінгі тексеру (соның ішінде амбулаториялық пациенттің профилактикалық нәтижелерін медициналық картаға жазу), қызмет көрсететін халықтың денсаулық жағдайына қатысты ақпараттық (компьютерлік) деректер базасының жеке жазбаларын жүргізу, тұрғындардың денсаулық сақтауға деген қажеттілігін зерттеу және осы іс-шараларды өткізу жөніндегі бағдарламаны әзірлеу. Аурудың ерте және жасырын түрлерін анықтау, әлеуметтік маңызды аурулар, инфекциялық емес аурулардың қауіп-қатер факторларын бақылау.

Ауруларды басқару бағдарламасы (АББ) мейіргерлер жұмысындағы негізгі құрал болып табылады, ол халық арасында қант диабетінен кейінгі ықтимал асқынулардың алдын алуға бағытталған:

Біріншіден, пациенттердің өзін-өзі басқаруына, олардың құқықтары мен мүмкіндіктерін кеңейтуге және денсаулығын нығайтуға баса назар аударылады. Бұл стационарда болу уақытының қысқаруына, амбулаториялық қызметтердің көбеюіне негіз болады.

Екіншіден , бұрынғыға қарағанда білім беру әдістері өте көп, дәстүрлі бетпе-бет түсіндіру, сондай-ақ әртүрлі технологиялық құралдарды пайдалану жатады. Соңғы жылдары интернетке негізделген білім беруге, сондай-ақ пациенттер үшін мобильді технологияны пайдалануға ерекше көңіл бөлінді. Тиімділікті арттыру үшін әртүрлі клиникалық салаларда әртүрлі әдістерді сынау маңызды. Оңтайлы әдістердің бірін пайдалана отырып пациенттердің аурулары туралы білімін кеңейтуге мүмкіндік береді.

ISBN 978-601-08-0758-7

Үшіншіден , пациенттерді АББ бойынша оқытуда мейіргерлер мен басқа денсаулық сақтау мамандарын дұрыс күтім мен білім беру шешімдерін енгізуге шақырады.

Төртіншіден , бұл пациенттің денсаулығына байланысты мәселелерін түсінуге, өкілеттілікке ие пациент өзінің бар білімін, түсінуге, шешім қабылдауға және проблемаларды шешуге, сондай-ақ өзінің денсаулығы мен емі үшін әрекет етуге қабілеттілігін арттыруға итермелейді. Тіпті өте күрделі клиникалық жағдайларда да пациенттердің өздері әрекет етуге және денсаулығы мен күтімін жақсарту үшін белгілі бір күшке ие болады.

Мейіргер пациентті ауруын басқару үшін тиімді оқыту әдісін таңдай алуы қажет. Пациентпен кездескен сайын оған туындаған мәселелерді шешуге көмектесіп, сұрақтарға жауап беріп, дер кезінде сауатты кеңес беру керек. Пациенттер көбінесе өз әрекеттерінің дұрыстығына күмәнданады және өзіне деген сенімділікті оңай жоғалтады. Олардың жоғалған сенімін қалпына келтіру үшін мейіргерлер ынталандыру және жылы қарым- қатынас орната білу қажет.Сөйлескен кезде тыңдай білу және оларға қызығушылық танытатыныңызды сезіну маңызды. Мейіргер әр түрлі тақырыптарда салауатты өмір салтын қалыптастыру, тұқым қуалайтын бейімділігі бар аурудың даму қаупін азайту, негізгі күтім мәселелері, қант диабетінің асқынуын болдырмау, осы ауруға арналған тамақтану және пациенттердің физикалық белсенділігі туралы әңгімелер жүргізеді. Дұрыс ұйымдастырылған мейіргерлік күтім ерекше рөл атқарады және емдеу процесін ұйымдастыруда оң әсер етеді. Мейіргер қант диабетімен ауыратын пациенттерге қант диабеті мектебіне барудың қажеттілігі мен маңыздылығы туралы кеңес беруі керек. Мектептің негізгі мақсаты қант диабетімен ауыратын пациенттерді өзін-өзі бақылау әдістерін қолдана отырып, емдеуді өмірдің нақты жағдайларына бейімдеу, аурудың жедел және созылмалы асқынуларының алдын алу болып табылады. Мектептің негізгі мақсатына сәйкес:

- ✓ әзірленген құрылымдық бағдарламалар бойынша қант диабетімен ауыратын пациенттерді оқытуды ұйымдастырады;
- ✓ өзін-өзі бақылау және қант диабеті асқынуларының алдын алу бойынша бастапқы және қайталама оқу циклдарын жүргізеді;
- ✓ қант диабетімен ауыратын пациенттердің білім деңгейін бақылайды;
- ✓ мектеп қызметінің тиімділігіне талдау жасайды;
- ✓ өз қызметін қант диабетімен ауыратын пациенттерге мамандандырылған көмек көрсетумен айналысатын басқа бөлімшелер мен мамандардың жұмысымен үйлестіру .

Сондай-ақ АББ қажетті уақытта өзіне-өзі көмек көрсету мақсатында медицина қызметкерлері яғни, қызмет көрсетушілердің және пациенттердің белгілі бір топтары арасында коммуникациялар орнатуға арналған. Сондықтан пациент асқынуларға жол бермей, өз ауруын басқаруды үйренеді.

ISBN 978-601-08-0758-7

Қорыта келгенде, ауруды басқару бағдарламасындағы мейіргердің рөлі ауруды тек емдеумен шектелмейді, сонымен қатар, пациенттерге толыққанды қамқорлық көрсету, олардың физикалық, психологиялық және әлеуметтік қажеттіліктерін ескере отырып, жан-жақты қолдау көрсету болып табылады. Мейіргерлердің кәсібилігі мен жауапкершілігі пациенттердің денсаулығын жақсартуға және өмір сапасын арттыруға септігін тигізеді.

Әдебиеттер тізімі:

1. Государственной программы развития здравоохранения «Денсаулық» на 2016-2019 гг. № 176 от 15 января 2016 года
2. Приказ МЗ РК №211 от 01 апреля 2013 года «О внедрении Программы управления хроническими неинфекционными заболеваниями в пилотных регионах»
3. Global Burden of Disease Collaborative Network. Global Burden of Disease Study 2019. Results. Institute for Health Metrics and Evaluation. 2020
4. Chevreul K., Brigham K., Bouché C. The burden and treatment of diabetes in France // Global Health. 2014. Vol. 10. P.6.
5. Woodward A., Wallymahmed M., Wilding J., Gill G. Improved glycaemic control an unintended benefit of a nurse-led cardiovascular risk reduction clinic. Diab Med 2015; 22(9):1272–74.
6. Греков И.Г. Высокотехнологичные сестринские клинические манипуляции в лечебных отделениях ЛПУ // Главная медицинская сестра. 2005. № 9. С. 35-47; № 10. С. 55-69.
7. Голенков А. В., Марков Д. С., Воропаева Л. А., Аверин А. В., Спиридонова Т. К. Организация центра здоровья на базе городской детской клинической больницы. Заместитель главного врача: лечебная работа и медицинская экспертиза. 2012; 11: 18–25.

ISBN 978-601-08-0758-7

МЕДИЦИНАДАҒЫ ЗЕРТТЕУЛЕРДІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Валиева Гулфира Касимжановна,«Мейіргер ісі» 2 курс студенті
ҚОҒАМДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ БАСҚАРМАСЫНЫҢ
ШЖҚ «ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ» КМК
Жетекшісі: Естемесова Айгул Ибраевна
«Мейіргер ісі негіздері» пәні оқытушысы, магистр

Аннотация: *Бұл мақалада медицина саласының мәні мен маңызы, оның адам денсаулығын сақтау мен нығайтудағы рөлі қарастырылады. Денсаулықты анықтау тек ауру мен физикалық ақаулардың болмауы ғана емес, сонымен қатар физикалық, психикалық және әлеуметтік әл-ауқаттың жағдайы ретінде түсінілетіні атап өтілген. Қоғамдық денсаулық жеке адамның ғана емес, тұтастай қоғамның денсаулық жағдайын зерттейтін сала ретінде анықталады. Аурулардың қауіп факторлары мен олардың даму ықтималдығы, сондай-ақ медициналық зерттеулердің мақсаты мен міндеттері, ауруларды алдын алу және емдеу әдістерін жетілдіру туралы сөз қозғалады. Медициналық зерттеулердің маңыздылығы олардың жаңа ғылыми білімдер алуға, тиімді әдістерді дамытуға және жалпы халықтың денсаулығын жақсартуға ықпал етуі арқылы айқындалады. Ауырсыну механизмдерін түсіну, олардың пайда болуына әсер ететін факторларды анықтау және тиімді емдеу әдістерін қолдану, денсаулықты сақтаудың маңызды құрамдас бөлігі болып табылады.*

Медицина (лат. medicine: medicus — дәрігерлік, емдік) — адамдардың денсаулығын сақтау мен нығайту, сырқаттарды емдеу мен аурудың алдын алу, денсаулық және жұмысқа қабілеттілік жағдайында (барысында), адамзат қоғамында ұзақ өмір сүруге жетуді көздейтін тәжірибелік іс-әрекеттің және ғылыми білімдердің жүйесі.

Денсаулық – ауру мен физикалық ақаулардың болмауы ғана емес, сонымен қатар толық физикалық, психикалық және әлеуметтік әл-ауқат жағдайы. Адамның денсаулығын биологиялық (іштен туа біткен және жүре пайда болған сырқат белгілеріне қарап) және әлеуметтік факторларды ескере отырып, кешенді түрде анықтайды. Әртүрлі клиникалық пәндерге қарағанда қоғамдық денсаулық жеке алынған индивидумдардың емес, ұйымдардың денсаулық жағдайын оқиды. Бұнда өмір жағдайы, өндірістік қатынас экономикалық кезеңдер жағдайын анықтаушы болып табылады.

Сонымен қоғамдық денсаулық бір уақытта әлеуметтік, тәрбиелік, биологиялық, геофизикалық және т.б. факторлардың комплекстік әсерімен сипатталады. Бұл факторлардың көбісі қауіп факторы ретінде анықталуы мүмкін. Аурудың қауіп факторлары дегеніміз не?

Қауіпті факторлар - аурулардың даму мүмкіншілігін жоғарылататын, олардың асқынуын және жағымсыз аяқталуын тудыратын өндірістік және

ISBN 978-601-08-0758-7

қоршаған ортаның әлеуметтік, экологиялық, генетикалық, биологиялық, тәртіптік сипаттағы потенциалды қауіпті факторлар.

Адамдар ауырғанда олар ем алу үшін медициналық орталықтарға келеді. Ол ауруларды білу үшін медициналық зерттеулерден өткізіледі.

Медициналық зерттеулердің мақсаты мен міндеттері

Медициналық зерттеулер мақсаты - адам денсаулығын жақсарту, аурулардың алдын алу және жаңа емдеу әдістерін әзірлеу. Міндеттері қатарында қауіп факторларын анықтау, диагностика мен емдеу тәсілдерін жақсарту, сондай-ақ ғылыми негізделген қағидаларды әзірлеу бар.



Медицинаның зерттеу пәні ретінде адам организмінің қалыпты және патология жағдайында құрылымы мен тіршілік етуі; халық денсаулығы жағдайына әлеуметтік және табиғи ортаның әсері; адам аурулары (олардың себептерін, пайда болу механизмін, белгілерін), аурудың алдын алу, түрлерін анықтау және емдеу тәсілдері мен құралдарын пайдалану туралы мәселелері зерттеледі. Медицина адамтанумен бірегей байланыста бола тұра жаратылыстану мен қоғамдық ғылымдардың барлық түрлерінің жетістіктерін ескереді. Медицинаның зерттеу мәселелерінің шеңбері адам өмірінің сан қырлы көріністерін қамтиды. Бұл медицинаны денсаулық туралы және адамның жеке басының және қоғамдық өмір сүру жағдайы туралы ғылымның нақты жүйесіне айналдырады.

Медициналық зерттеулердің маңызы тоқтала кетсек: жаңа білімдер бұған медициналық зерттеулер арқылы адам денсаулығы мен ауруларына қатысты жаңа ғылыми білімдер алынады.Тиімді әдістербұл зерттеулер қажетті емдеу, диагностика және алдын алу тәсілдерін дамытуға мүмкіндік береді.Денсаулықты жақсарту бұл зерттеулердің нәтижелері адам өмірінің сапасын арттыруға және жалпы халық денсаулығын жақсартуға қызмет етеді. Ол ауырулардың алдын алып жаңа емдеу әдістерін әзірлеп, ауырудың алдын алу шараларын іздестіру. Яғни ауыру пайда болу механизмдерін түсіну, олардың дамуын әсер ететін факторларды анықтайды және тиімді сонымен қатар қауыпсіз емдеу әдістерін яғни дәрі-дәрмектер мен терапиялық түрінде емдеу және денсаулық сақтау шараларын вакцинациялармен профилактикалық әдістерді анықтау.



Зерттеулердің түрлері мен әдістері Медициналық зерттеулер қамтиды: клиникалық, эпидемиологиялық, биологиялық, халық

ISBN 978-601-08-0758-7

денсаулығы зерттеулері.Зерттеу әдістері: тәжірибелік, сауалнама, бақылау, жасанды модельдеу, деректерді талдау.Жаңа технологияларЗаманауи зерттеу әдістері мен технологиялар үнемі дамып, жетілдіріліп отырады.

Медициналық зерттеулердің түрлері мен бағыттары

Медицинада жаңа ғылыми ашылымдарға жету үшін түрлі бағыттағы зерттеулер жүргізіледі. Бұл зерттеулер клиникалық, іргелі, трансляциялық, персонализацияланған, биотехнологиялық, бағдарламаланған және алдын алу медицинасы бағыттарында жүргізіледі. Клиникалық зерттеулер диагностика ол клиникалық зерттеулер аурулардың диагностикасы мен емдеу әдістерін жетілдіруге бағытталған.Емдеу бұл жаңа дәрі-дәрмектер мен емдік әдістемелерді тестілеу мақсатында жүргізіледі.Профилактика ол ауру пайда болмас бұрын оның алдын алу жұмыстары жүргізіледі.

Қорытынды

Негізгі медициналық зерттеулер келсек биологиялық негізі бұл ауруларды және ағзаның қалыпты жұмысын түсіну үшін жүргізіледі. Әдіснамалық зерттеулер ол жаңа зерттеу әдістемелерін, технологияларды және құралдарды дамыту. Ол аурудың пайда болу себептері мен дамуын анықтау. Адам өмір салты өздігінен қалыптаспайды, ал салауатты өмір салтын өмір сүру барысында мақсатты түрде қалыптасады. Қазіргі уақытта денсаулықты сақтау сақтау 53-55%-ға салауатты өмір салтын тәуелді болды екен. Бұдан салауатты өмір салтын ұстанудың қаншалықты маңызды екендігі анық. Сонымен қатар медициналық зерттеулердің адам өмірінде алатын орны ерекше зор. Себебі медициналық зерттеулер арқылы көптеген ауыр аурулардың алдын алып, адам өмірін құтқарады және медицина саас өздеріне жаңа әдіс пен тәжірибе жинайды.

Зертханалық зерттеулер нәтижелерін тікелей клиникалық тәжірибеге ендіру. Маңызды медициналық ашылымдарды тезірек пайдалануға жол ашу. Ғалымдар, дәрігерлер және пациенттер арасындағы байланысты нығайту.

Қолданылған әдебиеттер:

1. https://gamma.app/docs/-waf6jkdm7bgao5y
2. %D0%B8%D0%BD%D0%B0
3. https://stud.kz/referat/show/41244
4. https://kk.wikipedia.org/wiki/



КГП на ПХВ «Государственный
высший медицинский колледж
им. Д.Калматаева» УЗ ОА
г. Семей - 2024г.

ISBN 978-601-08-0758-7